КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

Стандарты диагностики и терапии

Клиническое руководство на основе МКБ-11 и DSM-5-TR

Д-р Кенан Рагимов

Баку · 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....1
Обращение к читателю.....1
ОБ АВТОРЕ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....4
Об этой книге.....4
Что представляет собой эта книга и для чего она написана.....4
Почему МКБ-11?.....5
Структура книги.....6
Организация и особенности глав.....7
Источники и подход.....10
Порядок использования книги.....11
Примечание об ответственности.....12
ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА ИМЕННО СЕЙЧАС И ИМЕННО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ?.....13
Пересечение трёх линий.....13
Почему именно сейчас?.....14
Почему именно в Азербайджане?.....15
Целевая аудитория этой книги.....16
Заключение.....17
Автор и составители.....18
Благодарности.....18
ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: СТАТИСТИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЕЛ В ЛЕЧЕНИИ.....19
Глобальная картина.....19
Тенденции 1990–2021 годов.....19
Таблица 1. Глобальная динамика распространённости основных психических расстройств, 1990–2021.....20
Влияние пандемии COVID-19.....22
Расстройства с наибольшей распространённостью и скоростью прироста.....22
Таблица 2. Первая десятка по распространённости и темпам прироста (2021).....23
Феномен разрыва в лечении.....24
Таблица 3. Разрыв в лечении — сравнение по расстройствам.....24
Психогенный аспект: корень проблемы.....26
Заключение.....28
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОПАТОЛОГИЮ.....29
Цель этого раздела.....29
Понятия симптома и синдрома.....29
Классификация психопатологических симптомов.....30
Основные психопатологические синдромы.....35
КЛИНИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ И ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА.....38
Цели клинического интервью.....38
Структура клинического интервью.....38
Оценка психического статуса.....41

Оценка суицидального риска....43
Оценка риска гетероагрессии (причинения вреда другим)....46
ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ....47
Основы психиатрического законодательства Азербайджана....47
Виды психиатрической помощи....47
Добровольная психиатрическая помощь....48
Недобровольная госпитализация....49
Принудительные меры медицинского характера....50
Правовое положение клинического психолога....51
Конфиденциальность и её границы....53
Несовершеннолетние пациенты....54
Агрессивный пациент и меры безопасности....54
Образцы документов....56
Этические принципы....57
КЛИНИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПСИХОТЕРАПИИ....59
Концепция клинической психотерапии....59
Психотерапевтические школы и их механизмы....60
Уровни доказательности....62
Карта стратегий лечения по расстройствам....63
Таблица 4. Психотерапевтические стратегии — карта по расстройствам....63
Фармакотерапия и психотерапия: не конкуренты, а взаимодополняющие....66
Таблица 5. Фармакотерапия и психотерапия: сравнительные возможности....67
Организационное значение клинической психотерапии....68
АВТОРСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ №1: ЛЕЧЕНИЕ НОЧНОГО ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ....70
Сущность и место протокола....70
Клинические принципы протокола....71
Этапы протокола....72
Таблица 6. Модифицированный протокол сигнальной терапии — по этапам....72
11–12-я неделя: консолидация и оценка....76
Описание упражнений для мышц тазового дна (англ. Kegel exercises) (комплексная ежедневная программа)....77
Практические рекомендации....77
Место протокола в рамках клинической психотерапии....79
АВТОРСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ №2: ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОГЕННОЙ ДЕПРЕССИИ....80
Смысл и место протокола....80
Стратификация пациента....81
Таблица 7. Выбор лечебной тактики при депрессивных расстройствах....81
Таблица 8. Критерии обязательного параллельного применения фармакотерапии....83
ЧАСТЬ I. КРАТКОСРОЧНАЯ КОГНИТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ (1–6 СЕАНСОВ)....84
Первичная оценка и хронологический анамнез....84
Идентификация аутоагрессивной когнитивной установки....85
Когнитивная реконструкция — последовательные техники....85
Результат краткосрочного этапа....88
ЧАСТЬ II. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ — 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПА....88

Этап 1. Осознание (англ. insight)....88
Этап 2. Конфронтация....89
Этап 3. Прояснение....89
Таблица 8. Полюсы реагирования и их последствия....90
Этап 4. Комплексная проработка....91
Долгосрочные результаты....92
Таблица 9. Сравнительные долгосрочные результаты (наблюдение 20–25 лет)....92
Эффективность по ресурсам....93
Место в рамках клинической психотерапии....93
АККРЕДИТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИТУАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ....95
Почему аккредитация важна?....95
Международные органы аккредитации и требования....95
Психоанализ: Международная психоаналитическая ассоциация (англ. International Psychoanalytical Association, IPA)....95
Таблица 10. Требования IPA к психоаналитическому обучению....96
Когнитивно-поведенческая терапия: Европейская ассоциация поведенческих и когнитивных терапий (англ. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)....97
Таблица 11. Положение Азербайджана и региона в EABCT....97
Диалектическая поведенческая терапия: Совет по сертификации DBT-Линехан (англ. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC)....98
Таблица 12. Требования DBT-LBC к сертификации....99
Десенсибилизация и переработка движениями глаз (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR): EMDR Europe....100
Таблица 13. Уровни аккредитации EMDR Europe....100
Общая ситуация с регулированием в Европейском союзе....101
Ситуация в Азербайджане....101
Как отличить специалиста?....103
Место книги в этих условиях....104
6A00–6A0Z РАССТРОЙСТВА НЕЙРОРАЗВИТИЯ....105
6A00 РАССТРОЙСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ....105
6A01 РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА ИЛИ РЕЧИ....119
6A02 РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА....136
6A03 РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ....154
6A04 РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ (DCD)....169
6A05 СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ).182
6A06 СИНДРОМ СТЕРЕОТИПНЫХ ДВИЖЕНИЙ....200
8A05.0 ПЕРВИЧНЫЕ ТИКИ ИЛИ ТИКОЗНЫЕ РАССТРОЙСТВА....213
6A20–6A2Z СПЕКТР ШИЗОФРЕНИИ....230
6A20 ШИЗОФРЕНИЯ....230
6A21 ШИЗОАФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО....253
6A22 ШИЗОТИПИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....266
6A23 ОСТРОЕ ТРАНЗИТОРНОЕ ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....278
6A24 БРЕДОВОЕ РАССТРОЙСТВО....290
6A25 СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНО ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ....297
6A40 КАТАТОНИЯ....301

6A40 КАТАТОНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДРУГИМ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ....301

6A60–6A7Z РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ....309

6A60 БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО I ТИПА....309
6A61 БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО II ТИПА....319
6A62 ЦИКЛОТИМИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....326
6A70 ЕДИНИЧНЫЙ ЭПИЗОД ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА....331
6A71 РЕКУРРЕНТНОЕ ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО....342
6A72 ДИСТИМИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....347
GA34.41 ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОЕ ДИСФОРИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО (PMDD) 353

6B00–6B0Z ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА....361

6B00 ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО (ГТР)....361
6B01 ПАНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....369
6B02 АГОРАФОБИЯ....375
6B03 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОБИЯ....380
6B04 СОЦИАЛЬНОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО....386
6B05 СЕПАРАЦИОННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО....392
6B06 СЕЛЕКТИВНЫЙ МУТИЗМ....398

6B20–6B2Z ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЕ (ОКР)....403

6B20 ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (ОКР)....403
6B21 ТЕЛЕСНОЕ ДИСМОРФИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО (BDD)....410
6B22 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ ЗАПАХОМ (ORS)....416
6B23 ИПОХОНДРИЯ....421
6B24 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПИТЕЛЬСТВО (ХОРДИНГ)....426
6B25 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСНО НАПРАВЛЕННЫЕ СТЕРЕОТИПИИ....433

6B40–6B4Z СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ....440

6B40 ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (ПТСР)....440
6B41 ОСЛОЖНЕННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (К-ПТСР)....448
6B42 ЗАТЯЖНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ГОРЯ....454
6B43 РАССТРОЙСТВО АДАПТАЦИИ....460
6B44 РЕАКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИВЯЗАННОСТИ....465
6B45 РАССТРОЙСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО РАСТОРМОЖЕННОМУ ТИПУ. .470

6B60–6B6Z ДИССОЦИАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА....476

6B64 ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ (ДРИ)....476
6B65 ЧАСТИЧНОЕ ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ 482
6B66 СИНДРОМ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ-ДЕРЕАЛИЗАЦИИ....486
6B60 ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ....490
6B61 ДИССОЦИАТИВНАЯ АМНЕЗИЯ....496

6B80–6B8Z РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ....501

6B80 НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ....501
6B81 НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ....508
6B82 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ (BED)....512
6B84 ПИКА....516
6B85 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ И СРЫГИВАНИЕ....520

6B83 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ (ARFID)....524
6C00–6C0Z РАССТРОЙСТВА ЭКСКРЕЦИИ....530
6C00 ЭНУРЕЗ....530
6C01 ЭНКОПРЕЗ....536
6C20 ТЕЛЕСНЫЙ ДИСТРЕСС....542
6C40–6C5Z СВЯЗАННЫЕ С ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ…548
6C40 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ....548
6C43 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ....554
6C41 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КАННАБИСА....560
6C44 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЕДАТИВНЫХ, СНОТВОРНЫХ ИЛИ АНКСИОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ....565
6C45 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА....569
6C46 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ АМФЕТАМИНЫ, МЕТАМФЕТАМИН ИЛИ МЕТКАТИНОН....574
6C49 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ 578
6C4A РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА....583
6C50 РАССТРОЙСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСТРАСТИЯ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ 588
6C51 РАССТРОЙСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСТРАСТИЯ К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ....592
6C70–6C7Z КОНТРОЛЬ ИМПУЛЬСОВ....636
6C70 ПИРОМАНИЯ....636
6C71 КЛЕПТОМАНИЯ....640
6C72 КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ…643
6C73 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЭКСПЛОЗИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (IED)....648
6C90–6C9Z ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ....653
6C91 ДИССОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....653
6C90 ОППОЗИЦИОННО-ВЫЗЫВАЮЩЕЕ РАССТРОЙСТВО (ОВР)....658
6D10–6D1Z РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ....663
6D10 РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ....663
6D11 ВЫРАЖЕННЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛИ ОСОБЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ....669
6D30–6D3Z ПАРАФИЛИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА....673
6D30 ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСГИБИЦИОНИЗМ....673
6D31 ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ВУАЙЕРИЗМ....676
6D32 ПЕДОФИЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО....680
6D33 ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ САДИЗМ....685
6D34 ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОТТЕРИЗМ....689
6D50–6D5Z ИМИТИРОВАННЫЕ РАССТРОЙСТВА....692
6D50 ИМИТИРОВАННОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕБЕ....692
6D51 ИМИТИРОВАННОЕ РАССТРОЙСТВО В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО ЛИЦА 696
6D70–6D8Z НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ (ДЕМЕНЦИЯ)....702
6D70 ДЕЛИРИЙ....702
6D71 ЛЕГКОЕ НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (MCI)....708
6D72 АМНЕСТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО....713

6D80 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА....717
6D81 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ724
6D82 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ (DLB)....729
6D83 ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ (FTD)....734
6E20–6E2Z ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА....739
6E20 ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ ИЛИ ПОСЛЕРОДОВЫМ ПЕРИОДОМ, БЕЗ ПСИХОТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ....739
6E21 ПСИХИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ ИЛИ ПОСЛЕРОДОВЫМ ПЕРИОДОМ, С ПСИХОТИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ....745
6E40 ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ....751
6E40 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РАССТРОЙСТВ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ В ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ....751
6E60–6E6Z ВТОРИЧНАЯ ПСИХИАТРИЯ....756
6E61 ВТОРИЧНЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ....756
6E62 ВТОРИЧНЫЙ АФФЕКТИВНЫЙ СИНДРОМ....762
6E63 ВТОРИЧНЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ СИНДРОМ....766
7A00–7A8Z РАССТРОЙСТВА СНА....769
7A00 ХРОНИЧЕСКАЯ ИНСОМНИЯ....769
7A41 ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ ВО СНЕ (OSA)....774
7A60–7A65 РАССТРОЙСТВА ЦИРКАДНОГО РИТМА СНА-БОДРСТВОВАНИЯ 778
7A21–7A26 ГИПЕРСОМНИЯ....782
7A20 НАРКОЛЕПСИЯ....785
HA00–HA0Z СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ....790
HA01.1 ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У МУЖЧИН (ED)....790
HA03.0 ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ У МУЖЧИН (PE)....794
HA00 СНИЖЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ (HSDD)....799
HA02.0 АНОРГАЗМИЯ....804
HA20 СЕКСУАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО БОЛЕЗНЕННОЙ ПЕНЕТРАЦИИ (ВАГИНИЗМ)....808
HA40 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ И СЕКСУАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ РАССТРОЙСТВ....812
ПРИЛОЖЕНИЯ....818
ПРИЛОЖЕНИЕ А....819
СТАНДАРТЫ МОНИТОРИНГА И ОБСЛЕДОВАНИЯ....819
A.1. Метаболический мониторинг при антипсихотической терапии....819
A.2. Мониторинг лития....821
A.3. Антиконвульсанты (вальпроат, карбамазепин, ламотриджин)....822
A.4. Мониторинг СИОЗС и СИОЗСН....823
A.5. Применение бензодиазепинов....823
A.6. Мониторинг психотерапии....823
ПРИЛОЖЕНИЕ В....824
ШКАЛЫ СКРИНИНГА НАРУШЕНИЙ НЕЙРОРАЗВИТИЯ....824

B.1. M-CHAT-R: Модифицированный скрининговый опросник на аутизм (дети 16–30 месяцев)....824
B.2. AQ-10: Краткая оценка расстройств аутистического спектра (16 лет+)....830
B.3. ASRS v1.1: Шкала самоотчета для взрослых с СДВГ....833
B.4. SNAP-IV: Рейтинговая шкала Свонсона, Нолана и Пелхэма (детский СДВГ)...837
B.5. Основные инструменты оценки интеллекта и адаптивного функционирования (таблица данных)....844
Примечание автора....846
ПРИЛОЖЕНИЕ C....848
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ....848
C.1. Активный суицидальный риск....848
C.2. Делирий тременс и отмена алкоголя....849
C.3. Серотониновый синдром....850
C.4. Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)....850
C.5. Острая дистония....851
C.6. Острая мания и психомоторное возбуждение....852
C.7. Острый психоз....852
C.8. Кататония....852
ПРИЛОЖЕНИЕ D....854
ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)....854
D.1. Правовая основа....854
D.2. Структура психиатрической оценки....854
D.3. Психиатрические расстройства и оценка годности к военной службе....855
D.4. Послеродовая травма и оценка ветеранов....856
ПРИЛОЖЕНИЕ E....857
СВЯЗАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ....857
E.1. Эпилепсия (G40) и психиатрические проявления....857
E.2. Головная боль и психиатрическая коморбидность....858
E.3. Цереброваскулярные заболевания (инсульт)....858
E.4. Болезнь Паркинсона....858
E.5. Рассеянный склероз (РС)....859
E.6. Черепно-мозговая травма (ЧМТ)....859
E.7. Деменция (подробно в Разделе 17)....860
E.8. Судороги, двигательные расстройства и психиатрия....860
ОБЩИЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА....861
Основные источники МКБ-11 и DSM-5....861
Учебники клинической психиатрии....861
Источники на азербайджанском языке....861
Практические клинические руководства (guidelines)....862
Основные рецензируемые журналы....862
Онлайн-ресурсы....862
ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ....864
Диагноз всегда второй шаг, а не первый....864
Психотерапия – первый выбор в большинстве случаев....864
Принцип минимальной эффективной дозы....865
Работа с культурой и контекстом....865
Скрининг должен быть стандартным в первичном звене здравоохранения....865
Оценка суицидального риска....865

Коморбидность — правило, а не исключение.....866
Возраст и стадия развития обязательно должны учитываться.....867
Мультидисциплинарная команда – основа эффективной клинической работы.....867
Этические и правовые рамки.....867
Внимание к своему здоровью.....868
Стойкое обучение и развитие.....868

Предисловие

Обращение к читателю

Уважаемый врач, клинический психолог, психотерапевт, ординатор-психиатр и студент!

Эта книга выросла из нехватки. Двадцать три года я веду приём и почти всё это время упирался в одну и ту же стену: диагноз ясен — а критерии, которые его подтверждают, лежат в одном источнике, порядок обследования во втором, схема терапии в третьем, прогноз не лежит нигде. И этот путь приходилось проходить заново для каждого пациента.

Поиск не облегчил дело, а утяжелил. На первой же странице выдачи рядом стоят устаревшая классификация, буклет фармкомпании и «авторский метод» без единого доказательства. За чем из этого стоит исследование, а за чем только маркетинг — чтобы отличить, нужны отдельные часы, а в кабинете их нет: пациент сидит напротив и ждёт ответа сейчас. Обучая ординаторов, я увидел это ещё отчётливее — неверное решение чаще рождается не от незнания, а от доверия к первому попавшемуся источнику.

Я долго искал готовое решение. Не нашёл — и пришлось написать самому. Отсюда весь строй книги: одно расстройство — одна страница. Критерии, дифференциальный диагноз, обследование, лечение, прогноз и самые живучие мифы — вместе, с кодами трёх классификаций и с названным источником за каждым утверждением. Сюда попадает только то, что можно проверить; остальное названо прямо — в отдельном разделе о мифах.

Перед вами «Клиническая психиатрия: стандарты диагностики и терапии» — первое систематическое клиническое руководство по психиатрии на азербайджанском языке. Оно написано не для чтения подряд, а для работы: пациент сидит напротив, а у вас десять минут. Все главы устроены одинаково — одиннадцать разделов в неизменном порядке, — чтобы вы не искали, где что, а сразу открывали нужное.

Книга построена на МКБ-11. Вступив в силу в 2022 году, эта классификация изменила не только коды: она переписала взгляд на расстройства личности, понятие травмы и старую границу между органическим и функциональным. При этом я не отказался от постсоветской клинической школы — традиции Попова и Вида. Где сильнее международное руководство, ссылка идёт на него; где точнее видит классическая школа, сказано и это. Расхождения не сглаживаются, а называются прямо.

Два протокола здесь мои собственные — лечение ночного энуреза у детей и двухэтапная стратегия при психогенной депрессии. Это модификации международных руководств, и уровень их доказательности — IV: клинический опыт эксперта, а не рандомизированное исследование. Пишу об этом открыто, чтобы читатель понимал, на что опирается. Проверяйте, спорьте, испытывайте в своей практике.

И просьба: не считайте эту книгу последним словом. Психиатрия меняется быстро, а текст здесь живой. Увидели ошибку — напишите мне. Следующее издание станет лучше вашими замечаниями.

ОБ АВТОРЕ

Автор этой книги — Кянан Рагимов, врач-психиатр и психотерапевт; клинический стаж 23 года (с 2003 г.). Окончил Азербайджанский государственный медицинский университет в 2001 г., в том же году прошёл интернатуру в Бакинской клинической психиатрической больнице № 2. В 2001–2003 гг. в Санкт-Петербурге, в Научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В. М. Бехтерева, с отличием окончил клиническую ординатуру: в отделении психотерапии неврозов — под руководством главного психотерапевта Российской Федерации, признанного в мире специалиста профессора Б. Д. Карвасарского, в отделении психотерапии психозов — под руководством профессора В. Д. Вида, одного из первых на постсоветском пространстве дипломированных психоаналитиков, сертифицированных Международной психоаналитической ассоциацией (IPA). За 23 года практики пролечено более 1000 пациентов с депрессивными расстройствами и более 1000 детей с ночным энурезом; только в 2025 году клиническая команда автора успешно пролечила более 250 детей. С 2020 г. — основатель Профессиональной психологической школы RAGIMOFF, с 2021 г. — уполномоченный представитель в Азербайджане петербургского Института имени Карвасарского и руководитель программы дополнительного профессионального образования (ДПО) по клинической психологии, с 2022 г. — посол Международной ассоциации психотерапии (IPAS). Два авторских клинических протокола, представленные в этой книге, — лечение ночного энуреза у детей и двухэтапная стратегия лечения психогенной депрессии — отражают модификацию международных руководств, основанных на доказательствах (NICE, APA, WFSBP), опирающуюся на многолетний клинический опыт автора и ретроспективные наблюдения. Эти модификации позволяют достичь более высокой клинической эффективности за более короткий срок по сравнению со стандартными международными протоколами;

уровень доказательности следует считать IV (опыт эксперта). Рекомендации автора опираются на клиническую экспертизу и 23 года непрерывной практики; читатель может самостоятельно проверить, оценить и при необходимости адаптировать эти подходы в своей практике.

ВВЕДЕНИЕ

Об этой книге

Эта книга — первое систематическое изложение современных стандартов клинической психиатрии на азербайджанском языке. Книга построена на основе 11-го пересмотра Международной классификации болезней (МКБ-11) и интегрирует её структуру, диагностические критерии и лечебные подходы в соответствии с азербайджанской клинической традицией и постсоветской психиатрической школой.

Книга подготовлена как справочное руководство для практических врачей — психиатра, психотерапевта, невролога, врача первичной медико-санитарной помощи, клинического психолога, студентов выпускных курсов медицинского образования и ординаторов.

Что представляет собой эта книга и для чего она написана

Эта книга — клиническое справочное руководство, а не учебник теоретической психиатрии. В ней диагностические критерии, клинические проявления и протоколы лечения по каждому психическому расстройству представлены в стандартизированном формате. Подробное патофизиологическое, нейробиологическое или историческое изложение каждой темы не является целью этой книги; цель — дать врачу возможность быстро и точно находить нужную информацию непосредственно при работе с пациентом.

Причины написания книги:

Отсутствует современное справочное руководство по психиатрии на азербайджанском языке. Существующая азербайджаноязычная литература — это преимущественно переводные работы либо учебники, основанные на школе конца XX века. Новации МКБ-11 (действует с 2022 года) и Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятого издания, пересмотренного (англ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision, DSM-5-TR; 2022), не отражены на азербайджанском языке систематически.

Приведение диагностических классификаций к единой системе. В клинической практике врачи сталкиваются одновременно с МКБ-10 (до сих пор используемой Министерством здравоохранения для официальной статистики), МКБ-11 (новый стандарт) и DSM-5-TR (классификацией,

преобладающей в международных научных публикациях). В этой книге все три системы представлены параллельно, чтобы врач мог использовать правильный код и терминологию в различных контекстах.

Интеграция официальных клинических протоколов Азербайджана. Официальные клинические протоколы, разработанные Центром общественного здравоохранения и реформ при Министерстве здравоохранения (англ. Center for Public Health and Reforms, CPHR) и утверждённые решениями коллегии Министерства здравоохранения (Шизофрения, 2009; Тревожные расстройства, 2013; обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), 2015; Депрессия, с указанием года), составляют местную клиническую базу этой книги. Соответствия и различия между международными рекомендациями (Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (англ. National Institute for Health and Care Excellence, NICE), Американская психиатрическая ассоциация (англ. American Psychiatric Association, APA), Всемирная федерация обществ биологической психиатрии (англ. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP), Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ) и официальными протоколами Азербайджана отмечены отдельно.

Правовое и этическое ориентирование. В рамках Закона Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» от 12 июня 2001 года и Закона «О психологической помощи» права и обязанности врача — как врача-психиатра, так и клинического психолога — представлены в отдельном разделе. Тактика ведения пациента с суицидальными мыслями, основания для недобровольной госпитализации, правила применения принудительных мер медицинского характера — это реальные клинические ситуации, требующие ответа. Эта книга отвечает на них.

Почему МКБ-11?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла МКБ-11 в 2019 году, а с 2022 года началось её официальное применение. В главе о психических расстройствах МКБ-11 принесла глубокие парадигмальные изменения:

Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР) (6B41) — новый официальный диагноз;

Пролонгированная реакция горя (6B42) — самостоятельный диагноз, добавленный в МКБ-11;

Переход расстройств личности от категориальной системы к дименсиональной (измеряемой) — ключевое концептуальное новшество;

Замена соматоформных расстройств расстройством телесного дистресса (англ. bodily distress disorder, BDD);

Исключение гендерного несоответствия (англ. gender incongruence) из психиатрической главы;

Игровое расстройство (англ. gaming disorder) определено как официальный диагноз;

Компульсивное сексуальное расстройство поведения (англ. compulsive sexual behaviour disorder, CSBD) добавлено как новая категория;

Перенос синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) в группу расстройств нейроразвития;

Отнесение ипохондрии к группе обсессивно-компульсивных и связанных с ними расстройств;

Упразднение дихотомии «органическое — функциональное».

Эти изменения требуют переоценки как в области нозологии, так и в стандартах лечения.

Структура книги

Книга состоит из двух основных частей:

ЧАСТЬ I — Вводные разделы:

Предисловие (этот раздел)

Содержание — построено на основе иерархии, соответствующей структуре МКБ-11

Введение в психопатологию — описание симптомов и синдромов (познание, восприятие, мышление, настроение, поведение, память, воля, сознание)

Клиническое интервью и оценка психического статуса — порядок клинического протокола, стандарты описания психического статуса

Правовые и этические аспекты — практическое руководство для врача-психиатра и клинического психолога на основе законодательства Азербайджана, образцы документов

ЧАСТЬ II — Психические расстройства (в соответствии со структурой МКБ-11):

Все 21 основная группа 6-й главы МКБ-11 представлены в отдельных разделах. Для каждого раздела сохраняется одна и та же стандартная структура:

Определение и нозология (кратко)

Этиология

Эпидемиология

Клинические проявления

Диагноз (МКБ-11 → МКБ-10 → Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, DSM-5-TR — параллельное сравнение)

Дифференциальный диагноз

Методы обследования (клинические, лабораторные и инструментальные)

Лечение (с градациями рекомендаций, основанных на доказательствах)

Прогноз

Источники

В конце — Источники и Приложения:

Полный список всех использованных источников (Азербайджан, страны Содружества Независимых Государств (СНГ), международные источники)

Клинические шкалы и опросники (Опросник здоровья пациента (англ. Patient Health Questionnaire, PHQ-9), Шкала генерализованного тревожного расстройства (англ. Generalized Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7), Контрольный список посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) (англ. PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5), Эдинбургская шкала постнатальной депрессии (англ. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS), Йель-Брауновская шкала обсессивно-компульсивного расстройства (англ. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Y-BOCS), Колумбийская шкала оценки серьёзности суицида (англ. Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) и другие)

Неотложные состояния в психиатрии (алгоритм)

Правила военно-врачебной экспертизы (в Азербайджане)

Организация и особенности глав

Организация глав

Каждая клиническая глава состоит из 11 разделов:

Определение и краткое описание — сущность расстройства, новации МКБ-11;

Эпидемиология — распространённость, пол, возраст, коморбидность;

Этиология и патогенез — биологические, психологические, социальные факторы, подход Попова–Вида;

Диагностические критерии — «Клинические описания и диагностические указания» МКБ-11 (англ. Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines, CDDG), МКБ-10, DSM-5-TR — в сравнительном аспекте;

Клинические формы (при необходимости) либо особенности клинических проявлений;

Дифференциальная диагностика — в табличном формате;

Обследование и оценка — клиническое интервью, скрининговые шкалы, лабораторные исследования;

Лечение – общая стратегия, поэтапный подход, психотерапия, фармакотерапия, особые клинические состояния;

Наблюдение и прогноз;

Источники – МКБ-11, Клинические описания и диагностические требования (КОДТ) 2024, Американская психиатрическая ассоциация (APA), Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), Всемирная федерация обществ биологической психиатрии (WFSBP), Международное общество изучения травматического стресса (ISTSS), Международное общество изучения травмы и диссоциации (ISSTD) и другие международные клинические рекомендации;

Исторические концепции – переход от классических представлений к современному подходу.

Терминология

Психиатрическая терминология систематизирована на азербайджанском языке. Многие термины отражают соответствия, пришедшие из классической русско-советской психиатрии, поскольку психиатрическое образование в Азербайджане традиционно формировалось на русском языке. Международные термины приводятся на английском языке с пометкой «англ.» в скобках (для терминологической ясности).

Интеграция школы Попова–Вида

«Современная клиническая психиатрия» Ю.В. Попова и В.Д. Вида (Санкт-Петербург: Речь, 2006, 2-е изд.) – классический учебник постсоветской клинической психиатрии. Их метод – классическая нозология, биопсихосоциальная модель и практический клинический опыт – интегрирован в данную книгу в тех местах, где он согласуется с современными международными рекомендациями. Там, где имеются расхождения (например,

измеряемая (дименсиональная) модель личности в МКБ-11), это указывается открыто.

Стандарты лечения

Лечение каждого расстройства опирается на международные клинические рекомендации:

- Клинические практические рекомендации Американской психиатрической ассоциации (англ. American Psychiatric Association, APA);
- Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (англ. National Institute for Health and Care Excellence, NICE);
- Всемирная федерация обществ биологической психиатрии (англ. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP);
- Канадская сеть по лечению аффективных и тревожных расстройств (англ. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, CANMAT)/Международное общество биполярных расстройств (англ. International Society for Bipolar Disorders, ISBD) — биполярное аффективное расстройство;
- Международное общество изучения травматического стресса (англ. International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS);
- Международное общество изучения травмы и диссоциации (англ. International Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD);
- Американская академия детской и подростковой психиатрии (англ. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, AACAP);
- Национальные перечни лекарственных средств и руководства.

Названия лекарственных средств приводятся как по международному непатентованному наименованию (МНН; англ. international nonproprietary name, INN), так и по торговому (англ. brand name) названию, поскольку на азербайджанском рынке препараты в большинстве случаев известны именно под коммерческим наименованием.

Азербайджанский клинический контекст

В каждом уместном случае приводятся замечания, специфичные для азербайджанского контекста:

- Вопросы применения в первичном звене здравоохранения;
- Культурные особенности и стигматизация (англ. stigma);
- Правовые и этические рамки;

Ограниченность имеющихся ресурсов;

Травматические расстройства у ветеранов Второй Карабахской войны;

Инструменты, валидность которых подтверждена на азербайджанском языке.

Шкалы и инструменты

В Приложении В наиболее часто используемые инструменты скрининга и оценки представлены в виде полного текста (с открытой лицензией) или в виде описания (для коммерческого использования).

Источники и подход

Порядок приоритета авторитетных источников. По каждой теме на первом месте представлено одно основное авторитетное руководство, затем другие руководства приводятся для сравнения или дополнения. Этот подход сохраняет баланс между академической точностью и конкретностью и позволяет избежать дублирования информации. Выбор основных авторитетных руководств по каждому расстройству:

Шизофрения: NICE CG178 (2014, обновление 2019) + Клинический протокол Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики (AP) (2009)

Депрессия: Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) NG222 (2022) — руководство «Лечение и ведение депрессии у взрослых» + Клинический протокол Министерства здравоохранения AP + Практическое руководство Американской психиатрической ассоциации (2010)

Биполярное расстройство: CANMAT/ISBD (2018, обновление 2021)

Тревожные расстройства: Клиническое руководство NICE 113 (2011/2020). «Генерализованное тревожное расстройство и паническое расстройство у взрослых: ведение». NICE CG113 (2011) + Клинический протокол Министерства здравоохранения AP (2013) + WFSBP (2012)

ОКР: Клиническое руководство NICE 31 (2005). «Обсессивно-компульсивное расстройство и дисморфическое расстройство». NICE CG31 (2005, действует) + Клинический протокол Министерства здравоохранения AP (2015) + APA (2007)

ПТСР: NICE NG116 (2018) + Руководство ISTSS по профилактике и лечению (англ. Prevention and Treatment Guidelines, 2019)

Расстройства приёма пищи: Руководство NICE 69 (2017). «Расстройства приёма пищи: распознавание и лечение». NICE NG69 (2017) + APA (2023)

Расстройства личности: Клиническое руководство NICE 78 (2009). «Пограничное расстройство личности: распознавание и ведение». NICE CG78 (пограничное расстройство личности, 2009), CG77 (антисоциальное расстройство личности, 2009) + APA (2024)

Расстройства нейроразвития: Практические параметры AACAP (англ. Practice Parameters) + NICE (CG72 — расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью; NG87 — расстройство аутистического спектра)

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ: NICE NG215 (алкоголь) + стандарты Американского общества медицины зависимости (англ. American Society of Addiction Medicine, ASAM) (2020)

Деменция: Руководство NICE 97 (2018). «Деменция: оценка, ведение и поддержка людей с деменцией и лиц, осуществляющих за ними уход». NICE NG97 (2018)

Местные авторитетные источники:

Клинические протоколы, разработанные Центром общественного здравоохранения и реформ (англ. Center for Public Health and Reforms, CPHR) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и утверждённые решениями коллегии Министерства здравоохранения

Закон Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года «О психиатрической помощи» (с последующими изменениями)

Закон Азербайджанской Республики «О психологической помощи»

СНГ и постсоветское пространство:

Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. 2-е изд., Санкт-Петербург: Речь, 2006 — учтена как классический постсоветский источник.

Порядок использования книги

Типичное клиническое использование:

При подозрении на определённое психическое расстройство у пациента в содержании отыскивается соответствующий раздел.

Диагноз (раздел 5) — оценка проводится по критериям МКБ-11.

Дифференциальный диагноз (раздел 6) – исключение других возможных вариантов по таблице.

Методы обследования (раздел 7) – составляется план.

Лечение (раздел 8) — рекомендации приводятся с указанием уровня доказательности.

Для студента:

В содержании отыскивается тема занятия.

В каждом разделе соблюдается последовательность: определение, этиология, эпидемиология, клинические проявления, диагноз.

Из раздела правовых и этических аспектов изучаются вопросы законодательства

Для клинического психолога:

Раздел правовых и этических аспектов имеет особое значение (условия принудительной госпитализации, границы психологической помощи)

Диагностические разделы предназначены для принятия решения о направлении к врачу-психиатру.

Примечание об ответственности

Эта книга — клинический справочник, однако при решении вопроса о конкретном пациенте:

Индивидуальная клиническая картина пациента должна обязательно учитываться

Решения о лечении должны приниматься с учётом согласия пациента, коморбидных расстройств и доступности препарата на местном рынке

Дозы препаратов должны сверяться с действующими местными инструкциями по применению

В юридико-этических вопросах следует проверять действующую последнюю редакцию соответствующего законодательства.

Настоящая книга не заменяет индивидуальную медицинскую консультацию

Знания в соответствующей области регулярно обновляются; врач должен отслеживать обновления международных и местных рекомендаций.

ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА ИМЕННО СЕЙЧАС И ИМЕННО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ?

Пересечение трёх линий

В предыдущих разделах этого Предисловия обозначены три отдельных, но глубоко взаимосвязанных направления:

Первая линия — глобальный кризис психического здоровья. В мире более 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами. Тревожные и депрессивные расстройства за последние 30 лет существенно участились. В большинстве этих расстройств центральную роль играют психосоциальные факторы, и основное лечение таких расстройств опирается на качественную психотерапию. Однако разрыв в лечении — особенно при тревожных и депрессивных расстройствах — достигает 70–90 %.

Вторая линия — клиническая психотерапия, основанная на доказательствах. Современная медицина построена на доказательных вмешательствах. Для каждого расстройства уже существуют чёткие клинические стратегии, определены уровни доказательности (A/B/C), систематически обновляются международные руководства: Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (англ. National Institute for Health and Care Excellence, NICE), Американская психиатрическая ассоциация (англ. American Psychiatric Association, APA), Программа действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации пробелов в области психического здоровья (англ. Mental Health Gap Action Programme, mhGAP), Всемирная федерация обществ биологической психиатрии (англ. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP). Клинический психотерапевт — независимо от основной школы терапевта — обязан применять наиболее эффективную стратегию для конкретного расстройства.

Третья линия — профессиональные стандарты и аккредитация. Ведущие международные организации — Международная психоаналитическая ассоциация (англ. International Psychoanalytical Association, IPA), Европейская ассоциация поведенческой и когнитивной терапии (англ. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT), Совет сертификации по диалектической поведенческой терапии (англ. Dialectical Behavior Therapy —

Linehan Board of Certification, DBT-LBC) и ассоциация «EMDR Europe» (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing Europe) — установили строгие требования к аккредитации. Выполнение этих требований — важное условие получения пациентом качественной помощи. В Азербайджане на государственном уровне психотерапевтическая деятельность специально не регулируется; ни при одной из ведущих международных организаций нет аккредитованной национальной ассоциации; единственная профессиональная организация, признанная на международном уровне, — Ассоциация психиатрии Азербайджана (англ. Azerbaijan Psychiatric Association, AZPA).

В точке пересечения этих трёх линий вырисовывается вывод: в Азербайджане существует потребность в справочном руководстве по клинической психиатрии и психотерапии на азербайджанском языке — стандартизированном, основанном на доказательствах и современных международных рекомендациях.

Почему именно сейчас?

Три причины делают написание этой книги именно сейчас логичным шагом:

1. Переход ВОЗ на МКБ-11. Классификация МКБ-11 (Международная классификация болезней 11-го пересмотра) Всемирной организации здравоохранения вступила в силу в 2022 году и с 2026 года становится обязательным стандартом в международной статистике здравоохранения. Эта классификация существенно перестроила главу психических расстройств: добавлены новые нозологии (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР) (англ. complex PTSD), пролонгированная реакция горя (англ. prolonged grief disorder), расстройство, связанное с азартными играми (англ. gambling disorder), расстройство, связанное с видеоиграми (англ. gaming disorder), компульсивное расстройство сексуального поведения (англ. compulsive sexual behaviour disorder), расстройство, связанное с зависимым поведением, и другие), некоторые прежние категории переклассифицированы, а во всей системе классификации шире применён дименсиональный (измеряемый) подход.

2. Изменение исходного уровня после пандемии. Пандемия COVID-19 породила в психическом здоровье феномен, который называют «новым исходным уровнем»: уровень депрессии и тревоги не вернулся к прежней норме, а устойчиво остаётся высоким. Это означает возросшую нагрузку в клинической практике. Активная подготовка специалистов и доступность

стандартизированных справочных источников — необходимое условие того, чтобы система могла выдержать эту нагрузку.

3. Рост отечественной базы специалистов. В Азербайджане за последние 10–15 лет число специалистов в области психологии, психиатрии и психотерапии быстро выросло. Университеты открывают программы по психологии, молодые специалисты получают дополнительное образование за рубежом (Турция, Германия, Россия, США), растёт число частных клинических центров. Однако эта база специалистов оказалась лишена справочной литературы на азербайджанском языке. Существующая азербайджаноязычная литература либо устарела (переводы советского периода, основанные на МКБ-10), либо фрагментарна (только по отдельным расстройствам), либо находится на популярном уровне (недостаточна для профессионального клинического использования).

Почему именно в Азербайджане?

Своеобразие клинического контекста Азербайджана повышает значимость этой книги.

Азербайджанский язык как профессиональный язык. Профессиональный язык клинической психиатрии и психотерапии — в университетских аудиториях, учебной литературе, клинической практике — находится в процессе формирования. Точное наименование каждой нозологии, ясное формулирование каждого диагностического критерия, стандартизация каждого протокола вмешательства — это коллективный процесс. Настоящая книга вносит вклад в этот процесс: представление МКБ-11 и Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-го издания (англ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5), на азербайджанском языке в стандартизированной форме; адаптация терминов из международных руководств к азербайджанскому клиническому полю; опора на термины, используемые в местной профессиональной литературе — официальные сайты Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР), протоколы Ассоциации психиатрии Азербайджана. Термины этой книги согласованы с официальными источниками этих организаций.

Профессиональные связи с тюркским миром. Турция — ближайший сосед Азербайджана; это страна, располагающая в рамках Европейской ассоциации поведенческой и когнитивной терапии (англ. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT) двумя аккредитованными

ассоциациями когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) — турецкой (TACBT) и азербайджанской (ACBP) — а также широкой инфраструктурой обучения диалектической поведенческой терапии (ДПТ) (англ. Dialectical Behavior Therapy, DBT) и десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) (англ. eye movement desensitization and reprocessing, EMDR). Близость азербайджанского и турецкого языков даёт азербайджанским специалистам возможность в максимально широкой мере использовать турецкую систему обучения. Термины этой книги согласованы с турецкой профессиональной литературой — это облегчает специалисту переход к турецкоязычным учебным материалам.

Региональный контекст. Азербайджан расположен на постсоветском пространстве; в клинической практике до сих пор частично сохраняются советская психиатрическая терминология и подходы. В то же время страна является членом Совета Европы и находится на пути интеграции в международные стандарты здравоохранения. В переходный период эта книга ориентирует клиническую практику на современные международные стандарты с учётом местной реальности.

Клинический авторский опыт. Эта книга не является лишь переводом или компиляцией международных источников. Она обогащена более чем 20-летним клиническим опытом автора, наблюдениями и разработанными протоколами. Представленные в соответствующих разделах книги два авторских клинических протокола — модифицированная аларм-терапия (англ. alarm therapy) при детском энурезе и двухэтапная стратегия лечения психогенной депрессии — на протяжении многих лет апробировались в азербайджанском клиническом контексте и подтверждены полученными измеримыми результатами. Это выводит книгу за рамки простого справочного источника и придаёт ей статус книги клинического опыта.

Целевая аудитория этой книги

Эта книга написана для четырёх основных категорий читателей:

1. Практикующие клинические психиатры. Обновлённое изложение критериев ВОЗ — МКБ-11 и DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам) для обеспечения диагностической точности, карта психотерапевтических стратегий и авторские клинические протоколы для каждой нозологии.

2. Клинические психологи и психотерапевты. Карта вмешательств с доказанной эффективностью (соответствующая таблица), методология авторских протоколов, организационные рамки клинической психотерапии.

3. Студенты медицинских и психологических специальностей. Систематическая, современная справочная литература, соответствующая международным стандартам; до настоящего времени такая литература на азербайджанском языке отсутствовала.

4. Лица, участвующие в управлении системой здравоохранения, и лица, принимающие решения. Стандартизированные протоколы создают основу для контроля качества, подготовки специалистов и оптимизации услуг.

Заключение

Психиатрия и психотерапия развиваются быстро: доказательная база растёт, международные стандарты обновляются регулярно. Развитие этой области в Азербайджане является одной из важнейших задач здравоохранения на предстоящий период.

Эта книга призвана внести вклад в такое развитие. Она направлена не на предоставление готовых ответов, а на создание надёжной основы для систематического клинического мышления. Каждый специалист в своей клинической практике наполняет эту основу своим уникальным образом — работая с пациентами, участвуя в международных аккредитационных программах и в процессе профессионального развития.

Для пациентов же эта книга может стать инструментом оценки качества получаемой ими помощи, постановки правильных вопросов и требования лечения, основанного на доказательствах. В сфере здоровья, особенно психического здоровья, информированный пациент является важным условием качественной помощи.

Данное предисловие создаёт необходимый контекст для прочтения всей книги. В последующих главах будут представлены основы психопатологии, клиническое интервью и психиатрическое обследование, а затем — систематическое изложение каждого основного психического расстройства согласно классификациям МКБ-11 и DSM-5-TR ВОЗ.

Баку, 2026

Кянан Рагимов

Автор и составители

Автор: Кянан Рагимов (Баку, 2026)

Веб-сайт: ragimoff.org

Благодарности: выражается глубокая признательность Азербайджанской психиатрической ассоциации (AZPA), кафедре психиатрии Азербайджанского медицинского университета и Центру общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения за неоценимый труд в подготовке клинических протоколов. Международным организациям, разрабатывающим рекомендации (NICE, APA, WFSBP, CANMAT, ISTSS, ВОЗ), выражается благодарность за их вклад в развитие доказательной психиатрии.

Баку, 2026

Благодарности

Эта книга подготовлена с целью внести вклад в развитие современной психиатрии в Азербайджане. Выражается благодарность команде Всемирной организации здравоохранения по психическому здоровью, специалистам, разрабатывающим международные клинические рекомендации, постсоветской психиатрической традиции Попова–Вида, азербайджанским коллегам — всем им.

Книга подготовлена в открытом для общественного обсуждения виде и будет продолжать развиваться. Отзывы, замечания и предложения будут учтены в последующих изданиях.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: СТАТИСТИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЕЛ В ЛЕЧЕНИИ

Глобальная картина

В третьем десятилетии XXI века положение в области психического здоровья приобрело кризисный характер. Согласно опубликованному в 2025 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отчёту «Mental Health Atlas 2024» (Атлас психического здоровья 2024), в мире более 1 миллиарда человек живут с каким-либо психическим расстройством. Эта цифра равна примерно одной восьмой части общего населения планеты и является самым высоким показателем, зарегистрированным в истории современной медицины.

Доля психических расстройств не ограничивается лишь числом больных. По данным ВОЗ, психические расстройства составляют почти одну шестую часть лет, прожитых с инвалидностью, обусловленной заболеваниями (англ. years lived with disability, YLD), во всём мире и являются ведущим фактором нефатального бремени, сопоставимым с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только депрессия и тревожные расстройства наносят глобальной экономике ущерб в размере примерно 1 триллиона долларов США в год в виде потерь производительности.

За этими цифрами стоят конкретные клинические реальности. В 2021 году 359 миллионов человек страдали тревожными расстройствами (в том числе 72 миллиона детей и подростков), а 280 миллионов человек — депрессивными расстройствами. Биполярное расстройство охватывает 37 миллионов, а шизофрения — более 24 миллионов человек. Однако эти цифры отражают лишь диагностированные случаи; реальная распространённость выше приведённых значений, поскольку во многих странах диагностическая инфраструктура развита недостаточно.

Тенденции 1990–2021 годов

Долгосрочные данные исследовательской программы «Глобальное бремя болезней» (англ. Global Burden of Disease, GBD) подтверждают резкий рост за

последние 30 лет. Приведённая ниже таблица показывает динамику распространённости по основным нозологиям.

Таблица 1. Глобальная динамика распространённости основных психических расстройств, 1990–2021

Расстройство	1990 (млн)	2019 (млн)	2021 (млн)	Абсолютный прирост	Прирост, стандартизованный по возрасту
Тревожные расстройства	311	458	359[1]	+47 %	+12,6 %
Депрессивные расстройства	172	279	280	+63 %	+9,8 %
Биполярное расстройство	26	40	37	+42 %	+1,2 %
Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ; дети и подростки)	71	84	84	+18 %	+0,4 %

Расстройство	**1990 (млн)**	**2019 (млн)**	**2021 (млн)**	**Абсолютный прирост**	**Прирост, стандартизованный по возрасту**
Расстройства пищевого поведения	7	14	14	+100 %	+52 %
Шизофрения	17	23	24	+41 %	+0,7 %
Расстройство аутистического спектра	18	28	28	+56 %	+1,8 %
Всего (психические расстройства)	654	970	1052	+61 %	+8,4 %

Источник: Институт измерения показателей здоровья и оценки (англ. Institute for Health Metrics and Evaluation), «Глобальное исследование бремени болезней» (англ. Global Burden of Disease Study) 2021 («Ланцет Психиатрия» (англ. The Lancet Psychiatry), 2024). В показателях за 2021 год учтена поправка на пандемию COVID-19.

[1] Хотя в 2021 году показатель тревожных расстройств выглядит ниже показателя 2019 года, это связано с методологическим обновлением; в период пандемии истинная распространённость резко возросла, а методологическое обновление 2021 года снизило показатель.

Из таблицы отчётливо видно, что в абсолютных числах к 2019 году наибольший прирост зафиксирован при тревожных расстройствах (147 млн дополнительных случаев) и при депрессии (107 млн). Стандартизованный по возрасту показатель (истинный эпидемиологический прирост после вычитания естественного прироста, обусловленного постарением населения) наиболее

высок при расстройствах приёма пищи — +52 %. Это во многом связано с социально-психологическими сдвигами в современном обществе: восприятием телесного облика, социальными сетями и культурой питания.

Влияние пандемии COVID-19

В период 2020–2022 годов ситуация в сфере глобального психического здоровья переживала наиболее острый этап. Согласно метаанализу Группы по изучению психических расстройств при COVID-19 (англ. COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021), опубликованному в 2021 году в журнале «Ланцет» (англ. The Lancet), в первый год пандемии:

- Распространённость депрессивного расстройства (согласно DSM-5-TR — большое депрессивное расстройство, БДР) превысила ожидаемый уровень на 27,6 %.
- Распространённость тревожных расстройств возросла на 25,6 %
- Зафиксировано 53 млн дополнительных случаев депрессии и 76 млн дополнительных случаев тревоги

Даже после ослабления непосредственного влияния пандемии показатели не вернулись полностью к допандемийному уровню. Большинство исследователей объясняют это феноменом «нового базового уровня» (англ. new baseline): длительная изоляция общества, экономическая неопределённость, изменения во внутрисемейных отношениях и рост уровня хронического стресса приобрели устойчивый характер.

Расстройства с наибольшей распространённостью и скоростью прироста

С клинической точки зрения важны два различных ранжирования: наиболее широко распространённые расстройства в абсолютных числах и расстройства с наиболее быстрым приростом при возрастной стандартизации.

Таблица 2. Первая десятка по распространённости и темпам прироста (2021)

Место	**По распространённости (млн)**	**По темпам прироста (1990–2021, %)**
1	Тревожные расстройства — 359	Расстройства приёма пищи — +52 %
2	Депрессия — 280	Дисморфическое расстройство тела (ДРТ) — +35 %
3	СДВГ — 84	Расстройство аутистического спектра — +1,8 % (с учётом возрастной стандартизации)
4	Биполярное расстройство — 37	Социальное тревожное расстройство — +18 %
5	Расстройство аутистического спектра — 28	Генерализованное тревожное расстройство — +15 %
6	Шизофрения — 24	Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — +14 %
7	Расстройства приёма пищи — 14	Большое депрессивное расстройство — +9,8 %
8	ОКР — 12	Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — +6,5 %
9	ПТСР — 10	СДВГ — +0,4 % (с учётом возрастной стандартизации)

Место	По распространённости (млн)	По темпам прироста (1990–2021, %)
10	Расстройства личности — 9	Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ — +5,3 %

Источник: исследование «Глобальное бремя болезней» 2021 (англ. Global Burden of Disease, GBD), Институт измерения показателей и оценки здоровья (англ. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), Сиэтл; отчёт ВОЗ «Атлас психического здоровья 2024» (англ. Mental health atlas 2024).

[2] Рост распространённости расстройств аутистического спектра частично связан с расширением диагностических критериев и программами раннего выявления, однако исследования подтверждают и наличие реального эпидемиологического прироста.

Феномен разрыва в лечении

Наиболее острая проблема в сфере психического здоровья — не показатели распространённости, а разрыв между получаемым и необходимым лечением. В научной литературе этот феномен известен как разрыв в лечении (англ. treatment gap).

Таблица 3. Разрыв в лечении — сравнение по расстройствам

Категория расстройства	Получающие какое-либо лечение	Получающие адекватное лечение	Разрыв в лечении
Шизофрения (страны с высоким уровнем дохода)	около 70 %	около 50 %	30–50 %
Шизофрения (страны с низким уровнем дохода)	<11 %	<5 %	89 % и более

Категория расстройства	**Получающие какое-либо лечение**	**Получающие адекватное лечение**	**Разрыв в лечении**
Биполярное расстройство	около 50 %	около 25 %	50–75 %
Большое депрессивное расстройство (глобально)	около 30 %	около 15 %	70–85 %
Тревожные расстройства (глобально)	27,6 %	9,8 %	72,4–90,2 %
ОКР	около 25 %	около 10 %	75–90 %
ПТСР	около 20 %	<10 %	80–90 %

Источник: Атлас ВОЗ 2024; Alonso J. и др. Разрыв в лечении тревожных расстройств носит глобальный характер [Treatment gap for anxiety disorders is global]. «Депрессия и тревожность» (англ. Depression and Anxiety), 2018; 35(3): 195–208; Thornicroft и др., «Британский журнал психиатрии» (англ. British Journal of Psychiatry), 2017.

За этими цифрами стоит серьёзное структурное различие. Психотические расстройства (шизофрения, шизоаффективное расстройство, тяжёлое биполярное расстройство) — то есть расстройства, более известные в обществе, — охвачены системой психиатрических стационаров, государственной статистикой и классификацией ВОЗ. При этих расстройствах диагностика относительно системна, лечение относительно контролируемо, статистика относительно надёжна.

Тревожные и депрессивные расстройства находятся в совершенно ином положении. Это «скрытые» расстройства, или расстройства «серой зоны»:

Пациент в большинстве случаев обращается не в психиатрическую службу, а к врачам общей практики, соматическим специалистам, неврологам.

При постановке диагноза лечение обычно ограничивается симптоматической медикаментозной терапией

Психотерапия либо не предлагается, либо проводится в форме широко распространённых нестандартных, не имеющих доказательной базы методов

Долгосрочное наблюдение за объективным состоянием пациента систематически не осуществляется

Именно это обстоятельство составляет ядро глобального кризиса психического здоровья. Наибольшее по численности бремя приходится именно на расстройства «серой зоны», однако и наименее контролируемая система выстроена вокруг них.

Психогенный аспект: корень проблемы

Чтобы понять клиническое значение приведённых выше показателей, подчеркнём главное: в подавляющем большинстве тревожных и депрессивных расстройств центральную роль играют психосоциальные факторы. Это означает, что их первопричина — не нейробиологическая дисфункция, а психологические процессы, такие как когнитивные искажения, нарушенные схемы привязанности, незавершённые процессы горевания, аутоагрессивные паттерны самооценки и деформации базовых убеждений.

Современные исследования показывают, что в начале депрессивных расстройств на психосоциальные факторы приходится 60–80 % случаев. Долгосрочные близнецовые исследования Кендлера и сотрудников (Реестр близнецов Вирджинии (англ. Virginia Twin Registry), 1990–2010 гг.) установили, что более 60 % эпизодов большого депрессивного расстройства (англ. major depressive disorder) провоцируется идентифицируемым стрессогенным жизненным событием (Кендлер и соавт., «Американский журнал психиатрии» (англ. American Journal of Psychiatry), 1999, 2003). Выдающийся представитель классической постсоветской психиатрической школы проф. В. Д. Вид (Санкт-Петербург, Институт имени В. М. Бехтерева) в своих работах выдвигает иную позицию: у 60–70 % пациентов, обращающихся с соматическими жалобами, на самом деле соматическое заболевание не выявляется — основная проблема этих пациентов имеет психогенное происхождение, однако вследствие ошибочной диагностики они получают соматическое лечение (Попов Ю. В., Вид В. Д., «Современная клиническая психиатрия», 2-е издание, 2006).

Важным фактом, подтверждающим эту позицию в историческом и современном контексте, является феномен диагнозов «вегетативно-сосудистая дистония» и «нейроциркуляторная дистония», которые на протяжении десятилетий использовались на пространстве бывшего СССР. Эти диагнозы широко ставились в неврологических и кардиологических отделениях, хотя их этиологическая основа научно не подтверждена. Те же пациенты при психиатрическом или психотерапевтическом обследовании соответствовали

категориям расстройства с соматическими симптомами (МКБ-10: F45.0) или расстройства адаптации (МКБ-10: F43.2; в МКБ-11 — расстройство телесного дистресса, 6C20), отвечали критериям депрессии или панического расстройства. Этот феномен систематической ошибочной диагностики связан с нераспознаванием психиатрических проблем в соматических отделениях — и такое положение наблюдается и в современной клинической практике.

Точно так же подавляющее большинство тревожных расстройств непосредственно связано с психосоциальными факторами — нарушениями привязанности в детском возрасте, стилем родительского воспитания, психотравматическим опытом, комплексными базовыми убеждениями. Ведущие представители Всемирной психиатрической ассоциации (англ. World Psychiatric Association, WPA) и международных психотерапевтических школ (О. Кернберг, Г. Габбард, А. Бек, В. Франкл) последовательно подчёркивают, что фармакологическое купирование депрессивного эпизода не решает его психологических корней. По этой причине психотерапевтическое вмешательство при лечении депрессии является терапией первой линии — в лёгких и среднетяжёлых случаях только в форме психотерапии, в тяжёлых случаях — параллельно с фармакотерапией.

Этот факт имеет решающие следствия для стратегий лечения. При психогенном расстройстве лекарственный препарат оказывает симптоматическое действие, но не решает корневой проблемы. Антидепрессант может улучшить настроение пациента, однако не затрагивает когнитивную структуру, побуждающую его к самообвинению. Анксиолитик может купировать приступ тревоги, но не изменяет базовое убеждение пациента, ориентированное на оценку мира как опасного. Когда пациент прекращает приём препарата или сталкивается с новым стрессовым фактором, расстройство часто возвращается, проявляясь порой в ещё более тяжёлой форме.

Первопричину психогенных расстройств можно устранить только психотерапевтическим вмешательством. Речь не о том, что психотерапия превосходит медикаментозное лечение; речь о том, что два вмешательства служат различным целям:

Фармакотерапия — управляет симптомами, стабилизирует острые состояния, воздействует на нейробиологический компонент.

Психотерапия — решает психологические корни расстройства, перестраивает когнитивную структуру, изменяет поведенческие модели, снижает риск рецидива

Эти два вмешательства не исключают друг друга — они дополняют друг друга. Однако современные системы здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, ориентированы почти исключительно на фармакотерапию. Психотерапевтические услуги — даже там, где они существуют, — находятся в сфере, не охваченной стандартизацией, контролем качества и лицензированием. Это толкает пациента к одной из двух рискованных ситуаций: либо он получает только симптоматическую медикаментозную терапию (без решения корневой проблемы), либо получает бесконтрольную, некачественную психологическую помощь (с риском усугубления проблемы).

Заключение

Представленные в этой главе цифры и тенденции приводят к одному выводу: кризис психического здоровья, охватывающий в мире в настоящее время более 1 миллиарда человек, за последние 30 лет резко усилился и после пандемии COVID-19 остался на новом базовом уровне. Основная часть этого бремени приходится на тревожные и депрессивные расстройства — в этих расстройствах преобладает психосоциальный компонент, и их решение на корневом уровне возможно только посредством психотерапевтического вмешательства.

В то же время именно по этим расстройствам разрыв в лечении наибольший: из каждых 10 пациентов с тревожными расстройствами только 3 получают какое-либо лечение, и лишь 1 получает адекватное лечение. Единственный способ заполнить этот разрыв — качественная, стандартизированная, основанная на доказательствах психотерапевтическая помощь.

Исходя из этой позиции, в следующей главе представлен систематический анализ основанных на доказательствах психотерапевтических стратегий — их классификация, области клинического применения, уровни достоверности.

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОПАТОЛОГИЮ

Цель этого раздела

Современные психиатрические классификации — Международная классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) и Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание, пересмотр текста (англ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision, DSM-5-TR) — в основном опираются на операциональные диагностические критерии: наличие определённых симптомов в нужном количестве и в течение заданного срока является условием постановки диагноза. Такой подход повышает диагностическую надёжность, однако может оттеснить на второй план истинный клинический смысл симптомов и синдромов.

Классическая психиатрия конца XIX — начала XX века, представленная Карлом Ясперсом, Эйгеном Блейлером, Карлом Шнейдером, Куртом Шнейдером, Карлом Леонхардом, развивалась в рамках феноменологического и синдромологического подходов. Этот подход и сегодня имеет большое значение в клинической практике:

Диагностические критерии подсчитывают симптомы, а синдромология раскрывает их взаимосвязь и клинические проявления.

Синдромологическое мышление важно для ранней диагностики — особенно у пациентов, у которых критерии ещё не собраны полностью..

Для понимания того, почему эти симптомы взаимосвязаны, необходимо патофизиологическое мышление — в чём состоит их связь и какая функциональная система нарушена.

Дифференциальный диагноз без синдромологического подхода поверхностен.

В этом разделе психопатологические симптомы классифицируются по основным функциональным сферам, затем описаны наиболее распространённые синдромы.

Понятия симптома и синдрома

Симптом — единичное проявление расстройства (например, галлюцинация, бред, депрессивное настроение).

Синдром — последовательное сочетание взаимосвязанных симптомов, характерное для определённой нозологической единицы или повторяющееся при нескольких нозологиях.

Нозологическая единица — заболевание, выделяемое по особенностям этиологии, патогенеза, клинического течения и лечения (например, шизофрения, биполярное расстройство, болезнь Альцгеймера).

В клинической практике врач обычно продвигается от симптомов к синдрому, от синдрома к диагнозу. Правильная синдромологическая оценка составляет основу обследования и лечения пациента.

Классификация психопатологических симптомов

Расстройства сознания

Количественные расстройства (снижение):

Оглушённость (англ. obnubilation) — лёгкое снижение сознания, замедление реакций

Сомнолентность – сонливое состояние, легко пробуждается

Сопор — расстройство сознания, сопровождающееся кратковременным пробуждением только при сильных раздражителях

Кома – полная утрата сознания, отсутствие реакции на раздражители

Качественные расстройства (протекающие с изменением содержания сознания):

Делирий — острое начало, волнообразное помрачение сознания, дезориентация, зрительные галлюцинации, психомоторное возбуждение. Типичные причины: алкогольный абстинентный синдром, инфекция, интоксикация, печёночная и почечная недостаточность.

Онейроидное (сновидное) состояние – фантастические сцены, пациент ощущает себя их участником

Аментивное состояние – глубокая дезориентация, разорванность мышления, нарушение речи

Сумеречное состояние сознания (англ. twilight state) – «туннелеобразное» сужение сознания, автоматизированное поведение, последующая амнезия. Типично при эпилепсии, истерических состояниях.

Расстройства восприятия

Иллюзии – ошибочное восприятие реального объекта (например, тень на стене воспринимается как человек).

Галлюцинации — восприятие без реального раздражителя. По модальности:

Слуховые галлюцинации – наиболее распространённый вид галлюцинаций. «Голоса» носят комментирующий, обращающийся, приказывающий или императивный характер (англ. imperative — высокий риск). Этот вид характерен для шизофрении.

Зрительные галлюцинации – характерны для органических расстройств (делирий, деменция, интоксикация).

Обонятельные и вкусовые галлюцинации — характерны для эпилепсии височной доли и шизофрении.

Тактильные галлюцинации – интоксикация кокаином, амфетамином («насекомые под кожей»).

Сенестопатии – неопределённые, странные, болезненные ощущения в теле (по телу «ползают насекомые», «в горле пустота» и др.).

Псевдогаллюцинации (Кандинский) – воспринимаются пациентом как «внутренние» («голоса в моей голове»), однако возникают по-прежнему без внешнего раздражителя.

Функциональные галлюцинации – возникают только при наличии реального раздражителя (слышать голос в шуме воды).

Расстройства мышления

Расстройства формы (темпа и последовательности):

Ускоренное мышление (англ. mentation acceleration) — наблюдается при маниакальном эпизоде

«Скачка идей» (англ. flight of ideas) – ассоциации часто меняются, но связь сохраняется

Замедленное мышление — наблюдается при депрессии и деменции

Блокировка мышления (нем. Sperrung) – внезапная остановка

Тангенциальное мышление — ответ уклоняется от вопроса и переходит на побочную тему

Обстоятельное мышление – чрезмерная детализация

Атомистическое (англ. atactic) мышление – грамматическая форма сохранена, смысл нарушен (шизофрения)

Вербигерация – бессмысленное повторение слов и фраз

Неологизмы – новые «выдуманные» слова (шизофрения)

Персеверация — повторение одного и того же слова или мысли (органическое расстройство)

Расстройства содержания:

Персекуторный бред – ощущение преследования, злого умысла

- Бред величия – собственное величие, могущество, богатство

- Бред отношения (англ. delusions of reference) – события окружающего мира приписываются себе

- Бред воздействия – воздействие посторонних сил (технических, космических, мистических) на его мысли

- Ипохондрический бред – вера в наличие тяжёлой болезни (сенестопатии и др.)

- Синдром Котара (бред живого трупа) – убеждённость в том, что части тела «исчезли», «умерли»

- Бред ревности — убеждённость в измене супруга

- Бред любви (Клерамбо) – убеждённость в тайной любви известного лица

Бред (англ. delusion) – ложное убеждение, не поддающееся доказательствам и не соответствующее культурному контексту. Виды:

Сверхценные (доминантные) идеи (англ. overvalued ideas) – близкие к реальности, но чрезмерно значимые

Обсессии – навязчивые, эго-дистонные (осознаваемые как чуждые себе) мысли

Расстройства настроения и аффекта

Депрессивное настроение – пониженное, печальное, безнадёжное

Маниакальное настроение – повышенное, эйфорическое или дисфорическое (раздражительное)

Дисфория – раздражительное, беспокойное настроение

Ангедония – утрата способности получать удовольствие (основной депрессивный симптом)

Апатия – эмоциональная недостаточность, утрата интереса

Аффективная лабильность — частая смена эмоций

Уплощённость аффекта (англ. flat affect) – ослабление эмоциональной выразительности (характерный негативный симптом при шизофрении)

Неадекватность аффекта – эмоциональная реакция не соответствует ситуации (например, встречает смерть близкого смехом)

Алекситимия – неспособность выразить словами своё эмоциональное состояние

Тревога – чувство предстоящей опасности, чаще сопровождается соматическими и вегетативными симптомами

Страх — эмоциональная реакция на конкретную, реальную опасность

Паника – острая, приступообразная тревога

Расстройства поведения и двигательные расстройства

Психомоторное возбуждение – взволнованные, бесцельные движения

Психомоторная заторможенность – замедление движений, трудность инициации

Ступор — состояние, характеризующееся двигательной заторможенностью, мутизмом и отсутствием реакции на окружающее

Каталепсия — пассивное сохранение позы тела

Восковая гибкость – сгибание и удержание конечности с мягким сопротивлением

Негативизм – совершение действий, противоположных требованиям

Эхолалия, эхопраксия – повторение речи/движений другого человека

Стереотипии – повторяющиеся, бесцельные движения

Манерность – вычурное выполнение обычных движений

Тики – непроизвольные мышечные сокращения

Компульсивное поведение – повторяющееся поведение для уменьшения обсессий (мытьё рук, проверки)

Расстройства памяти

Антероградная амнезия — отсутствие в памяти событий, произошедших после события

Ретроградная амнезия – отсутствие в памяти периода, предшествовавшего событию

Конградная амнезия – отсутствие в памяти самого события

Корсаковский синдром – тяжёлая антероградная амнезия, конфабуляции и дезориентация. Причины: дефицит тиамина и хронический алкоголизм.

Конфабуляции – заполнение провалов памяти вымыслами

Гипермнезия – патологическое усиление памяти (при некоторых эпилептических состояниях)

Гипомнезия – снижение памяти (депрессия, начало деменции)

Расстройства внимания

Гипопрозексия – снижение внимания

Гиперпрозексия — патологическое усиление внимания (мания)

Лёгкая отвлекаемость внимания (СДВГ, мания)

Вязкость внимания — неспособность отвлечься от одной темы (органические расстройства)

Когнитивные (познавательные) расстройства

Лёгкое когнитивное расстройство — состояние, выходящее за пределы возрастной нормы, но не достигающее уровня деменции

Деменция — обширное и стойкое снижение познавательных функций (память, речь, исполнительные функции, зрительно-пространственное восприятие)

Агнозия — неспособность узнавать объекты (зрительная, слуховая, тактильная агнозия)

Апраксия — неспособность выполнять ранее освоенные движения

Афазия — нарушение речи

Акалькулия — нарушение способности к счёту

Расстройства воли и мотивации

Апатия — безразличие, отсутствие мотивации

Абулия — слабость воли, неспособность принимать решения

Аволиция (англ. avolition) — отсутствие мотивации к целенаправленному поведению

Амбивалентность — одновременное наличие двух противоречивых желаний

Гипобулия — снижение волевой активности

Гипербулия — патологически повышенная волевая активность

Расстройства личности и «Я»

Деперсонализация — отчуждение от самого себя, чувство «это не Я»

Дереализация — восприятие окружающей среды как «выдуманной», «нереальной»

Нарушение границ «Я» — смешение с мыслями и чувствами других людей

Кража/вкладывание мыслей — чувство, что другие «читают мои мысли» или что «чужие мысли вкладываются мне в голову» (симптом первого ранга при шизофрении, К. Шнайдер)

Основные психопатологические синдромы

Аффективные синдромы

Депрессивный синдром (депрессивная триада):

Пониженное настроение

Психомоторная заторможенность

Замедление мышления (идеаторная заторможенность)

Дополнительные симптомы: ангедония, нарушение сна, изменение аппетита, чувство вины, безнадёжность, суицидальные идеи

Маниакальный синдром (маниакальная триада):

Повышенное настроение

Психомоторное возбуждение

Ускоренное мышление («скачка идей»)

Дополнительные симптомы: снижение потребности во сне, идеи величия, отвлекаемость внимания, рискованное поведение

Смешанный аффективный синдром — одновременное наличие маниакальных и депрессивных симптомов (например, высокая активность и глубокая печаль).

Тревожные синдромы

Генерализованное тревожное расстройство — стойкая, генерализованная тревога, мышечное напряжение, вегетативные симптомы.

Панический синдром — приступообразная, острая тревога, страх смерти, вегетативные симптомы (тахикардия, одышка, потливость), продолжается 10–30 минут.

Фобический синдром — страх по отношению к конкретному объекту или ситуации, избегающее поведение.

Обсессивно-компульсивный синдром

Обсессии (навязчивые мысли) + повторяющиеся действия, направленные на их уменьшение (компульсии). Пациент осознаёт их абсурдность, однако не способен им противостоять.

Психотические синдромы

Параноидный синдром — бред (преследования, отношения, величия) + тревога. Галлюцинации не типичны или минимальны.

Параноидный синдром — бред (преследование более типично) + галлюцинации (особенно слуховые) + тревога.

Парафренный синдром — фантастический бред величия + галлюцинации + повышенный аффект.

Галлюцинаторный синдром (галлюциноз) — преимущественно галлюцинации (слуховые или зрительные), без бреда или с минимальным бредом.

Синдром Кандинского — Клерамбо (синдром психического автоматизма):

Характерен для шизофрении.

Идеаторный автоматизм — «кража мыслей», «вкладывание мыслей»

Сенсорный автоматизм — псевдогаллюцинации

Моторный автоматизм — «насильственные движения»

Кататонический синдром — ступор или возбуждение, восковая гибкость, негативизм, мутизм, эхолалия, эхопраксия. Диагностика и лечение имеют жизненно важное значение (см. Раздел 3).

Дисфорический синдром — раздражительное, гневливое настроение, агрессия. Наблюдается при эпилепсии, органических заболеваниях головного мозга и абстиненции.

Синдромы экзогенно-органического типа (К. Бонхёффер)

Синдромы, свойственные экзогенному поражению головного мозга:

Делириозный синдром — острое, волнообразное изменение уровня сознания, дезориентация, зрительные галлюцинации, психомоторное возбуждение. Этиология: алкогольная абстиненция (англ. delirium tremens), инфекции, интоксикации, печёночная/почечная недостаточность.

Аментивный синдром — глубокая дезориентация, бессвязное мышление, расстроенный аффект, фрагментарные галлюцинации. При тяжёлых соматических заболеваниях.

Сумеречное состояние сознания (англ. twilight) — туннелеобразное сужение сознания, автоматическое поведение, последующая амнезия. Наблюдается при эпилепсии и состояниях истерического происхождения.

Корсаковский синдром — фиксационная амнезия + конфабуляции + дезориентация. Дефицит тиамина (синдром Вернике — Корсакова), хронический алкоголизм.

Астенический синдром — утомляемость, раздражительность, снижение памяти и внимания, головная боль, нарушение сна. Широко распространён, может иметь как органическое, так и психогенное происхождение.

Дементные синдромы

Кортикальная деменция (альцгеймеровского типа) — нарушения памяти, речи (афазия), праксиса (апраксия), гнозиса (агнозия).

Подкорковая деменция (болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона) — замедленность, нарушение исполнительных функций, депрессия, однако корковые функции на ранней стадии относительно сохранны.

Лобно-височная деменция — изменение личности, расторможенность (ослабление торможения), социальная дезадаптация + нарушения речи (семантическая или прогрессирующая небеглая афазия).

Деменция с тельцами Леви — характеризуется флюктуирующим когнитивным расстройством, зрительными галлюцинациями, паркинсонизмом и расстройством поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз.

Синдромы изменения личности

Органическое изменение личности (после поражения лобной доли и т. п.) — расторможенность, нарушение социальных норм, эмоциональная лабильность, отсутствие планирования.

Постэнцефалитические синдромы — поведенческие, мнестические и аффективные нарушения после энцефалита.

Синдром после сотрясения головного мозга — после черепно-мозговой травмы: головная боль, головокружение, утомляемость, раздражительность, нарушение концентрации.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ И ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА

Цели клинического интервью

Психиатрическое клиническое интервью служит тройственной цели:

Диагностическая — сбор информации, выявление симптомов, постановка диагноза

Терапевтическая — установление терапевтического альянса (англ. rapport), оказание поддержки пациенту, запуск механизмов (психотерапевтических)

Оценка состояния – оценка риска (суицид (самоубийство), вред другим), функциональный уровень, психосоциальная среда

Первичное интервью обычно длится 45–90 минут. В неотложных ситуациях оно бывает короче, однако ключевые моменты (риск, решение) всё равно должны быть освещены.

Структура клинического интервью

Подготовка

Ознакомление с документами (направление, предыдущие медицинские записи)

Помещение: тихое, закрытое, безопасное (кнопка экстренного вызова, если это возможно)

Время: следует предусмотреть достаточный резерв времени

Рекомендация: беседовать с пациентом наедине; при необходимости — сопровождающий (при подозрении на принудительную госпитализацию – (см. раздел «Правовые и этические аспекты»))

Вступление

Приветствие, представьтесь, объясните цель:

> «Здравствуйте, я доктор [имя], психиатр. Цель этой встречи — понять ваше состояние и вместе определить путь оказания вам помощи. Наша беседа может продлиться около 45 минут.»

Информация о конфиденциальности:

> «Наш разговор конфиденциален. …» Однако в случае серьёзной опасности для вас или для других я обязан передать эту информацию соответствующим лицам – это правовое требование. При необходимости мы обсудим это вместе с вами.

Открытый вопрос:

> «Что вас беспокоит? Не могли бы вы рассказать мне, почему вы пришли сюда?»

Жалобы и анамнез текущего заболевания

Жалобы – со слов пациента (по возможности с цитатой)

Начало – когда, при каких обстоятельствах началось?

Течение – изменение симптомов (облегчение, усиление, волнообразное)

Провоцирующие факторы – стрессы, утраты, лекарства, психоактивные вещества

Влияние на функционирование – воздействие на работу, отношения и повседневную деятельность

Предыдущие попытки лечения – какие препараты принимал и насколько они были эффективны

Психиатрический анамнез

Предыдущие диагнозы

Предыдущие госпитализации (время, учреждение, длительность)

Предыдущие препараты (эффективность, побочные эффекты)

Предыдущая психотерапия

Анамнез суицидальных попыток (когда, каким способом, серьёзность намерения)

Медицинский анамнез

Хронические заболевания

Хирургические вмешательства

Черепно-мозговые травмы (с потерей сознания)

Эпилептические приступы

Эндокринные расстройства (особенно заболевания щитовидной железы)

Принимаемые в настоящее время препараты (психотропные побочные эффекты)

Аллергии

Анамнез употребления психоактивных веществ

Алкоголь – частота, количество, симптомы абстиненции

Табак – курение, суточное количество, возраст начала

Рецептурные/безрецептурные препараты (особенно бензодиазепины, опиоиды)

Запрещённые вещества (каннабис, опиоиды, стимуляторы, галлюциногены)

Поведенческие зависимости (азартные игры, видеоигры, интернет, покупки)

Семейный анамнез

Психические расстройства у родственников первой и второй степени родства

Суициды

Употребление психоактивных веществ

Хронические заболевания (вероятность генетического компонента)

Личный и социальный анамнез

Рождение и раннее развитие

Обстановка в детстве, семейная динамика

Травматический опыт (насилие, подверженность насилию, утрата)

Образование

Трудовой анамнез

Анамнез отношений, семейное положение, дети

Система социальной поддержки

Юридический анамнез (уголовное преследование, судимость)

Военная служба (особенно при наличии боевого опыта)

Сексуальный и репродуктивный анамнез

Личность до заболевания (англ. premorbid)

Характерологические особенности до заболевания

Стиль установления отношений

Реакция на стресс, поведение

Оценка психического статуса

Исследование психического статуса (англ. Mental Status Examination, MSE) — основной клинический инструмент психиатрии. Систематическая регистрация увиденного и услышанного во время интервью.

Структура стандартного психического статуса

1. Внешний вид и поведение (англ. appearance and behaviour)

   Возраст, внешность

   Одежда, гигиена, уход за собой

   Мимика, жесты, поведение

   Отношение к интервью (сотрудничество, сопротивление, агрессивность)

   Зрительный контакт

   Психомоторная активность

2. Речь (англ. speech)

   Темп (быстрый, нормальный, замедленный)

   Громкость (сила голоса)

   Количество (много, мало, мутизм)

   Ясность, логичность

3. Настроение и аффект (англ. mood and affect)

   Настроение – устойчивое эмоциональное состояние, о котором сообщает пациент («как вы себя чувствуете?»)

   Аффект – эмоциональное выражение, наблюдаемое во время интервью

   Диапазон аффекта (широкий, суженный, уплощённый)

   Соответствие аффекта настроению и теме

4. Мышление (англ. thought)

   Форма — темп, последовательность, блокировка, тангенциальность, обстоятельность

   Содержание – бред, обсессии, фобии, суицидальные/гомицидные идеи

5. Восприятие (англ. perception)

   Галлюцинации (модальность, содержание)

   Иллюзии

   Деперсонализация, дереализация

6. Когнитивные функции (англ. cognition)

Ясность сознания

Ориентация (во времени, в пространстве, в собственной личности)

Внимание, концентрация

Память (непосредственная, кратковременная, долговременная)

Абстрактное мышление (объяснение пословицы, сходство)

Исполнительные функции

Счёт

Общий уровень осведомлённости

7. Критика и суждение (англ. insight and judgement)

Критика (англ. insight) – осознание пациентом своего заболевания (есть? нет? частично?)

Суждение (англ. judgement) — способность принимать решения (например, «как вы выберетесь из горящего здания?»)

8. Оценка риска

Суицидальный риск оценивается отдельно ниже.

Гетероагрессивный риск — намерение причинить вред другим

Уровень самообслуживания – способность жить самостоятельно

Пример протокола психического статуса

ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС

Внешний вид и поведение: пациент 32 лет, выглядит соответственно возрасту, гигиенические навыки соблюдает.
Одежда соответствует сезону. На интервью сотрудничает, однако поначалу выглядит встревоженным. Зрительный контакт снижен. Двигательная активность
несколько повышена.
Речь: темп несколько ускорен, громкость голоса нормальная, объём речи увеличен.
Внятная, однако иногда уходит от темы.
Настроение: «Чувствую себя неспокойно… последние две недели не могу заснуть» (цитата).
Аффект: диапазон сужен, на фоне тревоги соответствует теме. Иногда наблюдаются дисфорические компоненты.
Форма мышления: иногда тангенциальная, однако возвращается к основному содержанию.
Блокировки нет.

Содержание мышления: стойкая тревога относительно работы и материального положения.
Бреда нет. Суицидальных идей нет. Гетероагрессивных идей нет.
Восприятие: галлюцинации отрицает. Деперсонализации, дереализации нет.
Когнитивные функции: сознание ясное. Ориентация во времени, месте и собственной личности правильная. Умеренные затруднения концентрации внимания
(2 ошибки при выполнении задания на произнесение слова „мир“ в обратном порядке). Память клинически не нарушена. Абстрактное мышление сохранено.
Критика: имеется — симптомы расценивает как заболевание, мотивация к лечению сохранена.
Суждение: сохранено.
Оценка риска: суицидальный риск низкий (суицидальных идей нет, плана нет, предыдущих попыток нет, система поддержки имеется). Риск гетероагрессии отсутствует. Уровень самообслуживания полный.

Оценка суицидального риска

Обязательна при каждом психиатрическом интервью. Исследования показывают, что «вопрос о суициде не провоцирует его» — напротив, отсутствие такого вопроса делает это невозможным.

Спрашивать открыто, но поэтапно

«Как часто возникают эти мысли?»

- «Думаете ли вы о том, как это сделать?» (план)

- «Располагаете ли вы средствами?» (доступность средств)

- «Пытались ли вы когда-либо это сделать?» (предыдущие попытки)

- «Что удерживает вас сейчас?» (защитные факторы)

«Иногда вы чувствуете себя очень плохо? Думаете ли вы, что жизнь лишена смысла?» (пассивные суицидальные идеи)

«Думаете ли вы о том, чтобы причинить себе вред или убить себя?» (активные суицидальные идеи)

При положительном ответе:

Факторы суицидального риска

Статические (неизменные):

- Предыдущая суицидальная попытка (наиболее мощный предиктор — повышает риск суицида на протяжении жизни приблизительно в 30–40 раз (источник: Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи (англ. National Institute for Health and Care Excellence, NICE), оценка риска самоповреждения))
- Суицид в семейном анамнезе
- Пол (мужчины — завершённый суицид, женщины — попытка)
- Возраст (пожилые мужчины — наибольший риск; подростки — второй период подъёма)
- Юридический анамнез
- Травматический детский опыт

Динамические (изменяемые):

- Активные суицидальные идеи, план, намерение
- Доступность средств (оружие, отравляющие вещества)
- Недавняя утрата (партнёр, работа, здоровье)
- Изоляция
- Безнадёжность (может оцениваться с помощью Шкалы безнадёжности Бека (англ. Beck Hopelessness Scale, BHS))
- Активное психическое расстройство (депрессия, психоз, пограничное расстройство личности (ПРЛ), употребление психоактивных веществ)
- Активная интоксикация
- Нарушение сна (хроническое)
- Социальная отгороженность

Защитные факторы:

- Социальная поддержка
- Семейные обязанности (дети)
- Религиозные, духовные убеждения
- Связь с лечением
- Планы на будущее, надежды

Степени риска и клинические решения

Риск	Показатели	Решение
Низкий	Пассивные идеи; плана нет; средств нет; защитных факторов много	Амбулаторное наблюдение, план безопасности
Средний	Активные идеи, однако план и намерение не конкретизированы	Частое амбулаторное наблюдение (повторная встреча через 24–72 часа), привлечение семьи, удаление средств, номер кризисной службы
Высокий	Активные идеи + план + намерение; средства доступны; предыдущая попытка; активный психоз/глубокая депрессия	Госпитализация (добровольная либо, при отсутствии согласия, недобровольное помещение в стационар)
Неотложный	Активная подготовка, открытое заявление о намерении	Экстренная госпитализация, возможно привлечение полиции

Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (C-SSRS)

Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (англ. Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) — доказательно обоснованный, международно рекомендованный инструмент. Шкала состоит из 6 вопросов и занимает приблизительно 5 минут.

План безопасности (англ. safety plan)

При низком–среднем риске составляется совместно с пациентом:

Ранние предупреждающие признаки (например, нарушение адаптации, изоляция, снижение настроения)

Внутренние поведенческие стратегии (англ. coping strategies) (например, прогулка, музыка, физическая нагрузка)

Социальное отвлечение (с кем и где можно встретиться)

Лица, способные оказать поддержку (кто, номер телефона)

Номера клинической помощи (клиника, кризисная линия)

Обеспечение безопасности окружения (удаление средств, например, оружие передаётся родственнику)

Оценка риска гетероагрессии (причинения вреда другим)

В ходе интервью следует уточнить:

> «Думаете ли вы о том, чтобы причинить вред или убить другого человека?»

При положительном ответе:

Есть конкретная жертва (цель)?

Есть план?

Доступны средства?

Агрессивное поведение в прошлом?

Показатели высокого риска:

Конкретная жертва + план + средства

Активные психотические симптомы (особенно императивные галлюцинации, бред преследования)

Антисоциальное расстройство личности

Активная интоксикация

Эпизоды насилия в прошлом

При высоком риске — госпитализация и предупреждение потенциальной жертвы (правило Тарасоффа — международный стандарт).

ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Основы психиатрического законодательства Азербайджана

В Азербайджанской Республике психиатрическая помощь регулируется следующими законами:

- Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» от 12 июня 2001 года (с последующими изменениями, последняя редакция относится к 2024 году)
- Закон Азербайджанской Республики «О психологической помощи»
- Закон Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» от 26 июня 1997 года
- Конституция Азербайджанской Республики (в частности, статья 28 — право на свободу)
- Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (процедура недобровольной госпитализации)
- Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (принудительные меры медицинского характера)

Виды психиатрической помощи

Согласно статье 5 Закона «О психиатрической помощи» психиатрическая помощь оказывается в трёх видах:

Вид	Определение	Правовое основание
Добровольная	Обращение лица по собственной воле	Статья 5.1, информированное согласие

Вид	Определение	Правовое основание
Недобровольная	Обследование и лечение лица с тяжёлым психическим расстройством, не совершившего преступления, независимо от его воли, на основании решения суда	Статья 11, Гражданский процессуальный кодекс (ГПК)
Принудительная (принудительные меры медицинского характера)	Обследование и лечение лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости, на основании решения суда	Статья 12, Уголовный кодекс (УК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК)

Добровольная психиатрическая помощь

Информированное согласие

Согласно статье 1.0.6 Закона, информированное согласие — это заявление пациента или его законного представителя о добровольно принятом решении на лечение. Заявитель понимает цели и пользу лечения, объём, сроки и метод лечебных мероприятий, вероятные риски, а также возможность отказа от лечения и его прекращения.

Требования к информированному согласию:

В письменной форме (вносится в историю болезни)

Должна быть предоставлена полная информация (польза, риски, альтернативы, право на отказ)

Пациент должен осознавать (затрудняется при сопутствующем когнитивном расстройстве, интоксикации)

Добровольность — без принуждения

Для пациентов младше 16 лет — согласие законного представителя

Права пациента (статья 23 Закона)

Получать информацию о состоянии здоровья и лечении

Встречаться с близкими родственниками либо по выбору с другими лицами, телефонная связь

Свободно пользоваться деньгами и другими материальными средствами

Право на переписку

Свободное отправление религиозных обрядов

Подача жалобы (включая Уполномоченного по правам человека (омбудсмена))

Недобровольная госпитализация

Правовые основания

Статья 11 Закона (основания недобровольной госпитализации):

> Если характер психического расстройства требует проведения обследования и лечения только …только в стационарных условиях, то недобровольное лечение… назначается при наличии следующих оснований:

>

> 11.1.1. лицо с психическим расстройством непосредственно опасно для самого себя и (или) для окружающих;

>

> 11.1.2. неспособность лица удовлетворять свои основные жизненные потребности (на уровне ухода).

Простыми словами: к формуле «опасность, беспомощность либо риск ухудшения состояния при отсутствии лечения» следует добавить: «11.1.3. ухудшение состояния лица с психическим расстройством при неоказании ему необходимой психиатрической помощи».

Процедура недобровольной госпитализации

Этап 1: Первичная оценка

Врач-психиатр (бригада неотложной психиатрической помощи, приёмное отделение) осматривает пациента и устанавливает основания для недобровольной госпитализации.

Этап 2: Помещение в стационар (неотложное)

Пациента фактически госпитализируют. В течение 48 часов комиссия врачей-психиатров (в составе не менее 3 врачей) должна провести оценку.

Этап 3: Решение комиссии

Если комиссия приходит к выводу о необходимости продолжения недобровольной госпитализации, в течение 24 часов направляется обращение в суд.

Этап 4: Решение суда

Суд рассматривает дело в течение 5 дней (согласно Гражданскому процессуальному кодексу). Участвуют пациент (если позволяет состояние здоровья), законный представитель, прокурор, врач-психиатр. Суд принимает решение о продолжении либо прекращении недобровольной госпитализации.

Этап 5: Периодическая оценка

В период недобровольной госпитализации пациент в течение первых шести месяцев должен осматриваться комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в месяц (статья 28.2).

Клинические показания

Абсолютные показания к недобровольной госпитализации:

- Активное суицидальное поведение (попытка либо конкретный план и средства)
- Активное гомицидное намерение (конкретная цель + план + средства)
- Тяжёлая психотическая дезорганизация (самообслуживание невозможно)
- Императивные галлюцинации (с вредоносным содержанием)
- Тяжёлая мания (нуждаемость в уходе, риск причинения вреда)

Относительные показания (клиническое суждение):

- Тяжёлая депрессия с психотическими симптомами
- Нервная анорексия в тяжёлом соматическом состоянии (индекс массы тела (ИМТ) < 15)
- Смешанный аффективный эпизод
- Агрессивное поведение на фоне психоза

Принудительные меры медицинского характера

Статья 12 Закона регулирует принудительные меры медицинского характера:

Основание применения: лица, совершившие преступление в состоянии невменяемости либо заболевшие психическим расстройством после совершения преступления

Только на основании решения суда

Определяются статьями 21, 93–99 Уголовного кодекса и статьями 468–487 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)

Осуществляются в специализированных психиатрических стационарах

Виды (согласно УПК):

Принудительное лечение в психиатрических стационарах общего типа

Принудительное лечение в специализированных психиатрических стационарах

Принудительное лечение в специализированных психиатрических стационарах с интенсивным наблюдением

Правовое положение клинического психолога

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О психологической помощи», круг деятельности клинического психолога и пределы его полномочий:

Сфера деятельности психолога

Право оказывать психологическую помощь — психологическое консультирование, психодиагностика, психокоррекция, психотерапевтические вмешательства (при наличии соответствующей квалификации)

Слова «психолог», «психологический», «психоанализ», «психодиагностика», «психотерапия» могут использовать только лица, имеющие право оказывать психологическую помощь в соответствии с условиями Закона (статья 3.2).

Пределы компетенции психолога

Вне компетенции психолога:

Установление психиатрического диагноза (только врач-психиатр)

Назначение лекарственных средств (только врач)

Принятие решения о недобровольной госпитализации

Выдача медицинских заключений (судебно-психиатрическая экспертиза и др.) (только врач-психиатр)

Работа клинического психолога с пациентом при риске суицида (самоубийства) — этапы

Когда пациент высказывает суицидальные мысли, клинический психолог должен предпринять следующие шаги:

Оценка риска — Колумбийская шкала оценки серьёзности суицида (англ. Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) либо клиническое интервью (см. раздел выше)

Низкий–средний риск: составляется план безопасности, проводится тщательное наблюдение и пациент направляется к врачу-психиатру

Высокий риск — пациент не оставляется один, незамедлительное обращение к врачу-психиатру либо в службу неотложной психиатрической помощи (обращение в Бакинский центр психического здоровья (телефон экстренной связи: _____); неотложная медицинская помощь — 103, полиция — 102)

Документирование — оценка, решение, предпринятые шаги должны быть письменно зафиксированы

Вопрос конфиденциальности — при угрозе жизни конфиденциальность ограничивается (общие принципы Закона)

Образец документа: письмо-направление от психолога к врачу-психиатру

[Бланк клиники]
Дата: _____
Уважаемый врач-психиатр,
Пациент, находящийся под моим клинико-психологическим сопровождением, [имя, фамилия, отчество], дата рождения _____, обратился ко мне [дата] и в ходе интервью заявил об активных суицидальных идеях.
Клиническая картина:
- суицидальные идеи: [активные/пассивные, план есть/нет, средства доступны/нет]
- Состояние: [описание]
- суицидальная попытка в анамнезе: [есть/нет, подробности]
- Психиатрический анамнез: [предшествующие диагнозы, препараты]
На основании вышеуказанных признаков сообщаю о необходимости неотложной психиатрической оценки пациента оцениваю потребность в психиатрической оценке пациента.
Прошу Вас провести обследование пациента и принять соответствующее решение
прошу об этом.

С уважением,
[Имя, фамилия психолога]
[Специальность, номер сертификата]
[Подпись, печать]
[Контактный номер]

Несовершеннолетний пациент

При работе с пациентами младше 15 лет:

- Психологическая помощь оказывается только с согласия законного представителя
- Однако при выявлении жестокого обращения с ребёнком или суицидального поведения — в предусмотренных законом случаях необходимо информировать (Закон «О правах ребёнка», родители или соответствующие органы)
- Особые правила конфиденциальности в детской психотерапии — согласовываются предварительно

Конфиденциальность и её границы

Общий принцип

В отношениях между пациентом и врачом сведения, полученные в ходе их взаимодействия, являются конфиденциальными. Это закреплено в Законе «О защите здоровья населения» и в Законе «О психиатрической помощи».

Случаи, когда допускается нарушение конфиденциальности

- С письменного согласия пациента
- Письменный запрос правоохранительных органов (в рамках уголовного расследования)
- Решение суда
- При угрозе жизни и здоровью пациента или других лиц (принцип Тарасова — обязанность предупредить и защитить)
- Сведения о несовершеннолетних пациентах сообщаются родителям (в рамках закона)
- Коллегиальная консультация (внутри мультидисциплинарной команды)

Принцип Тарасова (обязанность предупредить и защитить)

Международный стандарт: если пациент заявляет о намерении причинить вред конкретному лицу, на враче лежит обязанность предупредить это лицо. Хотя в законодательстве Азербайджана это прямо не закреплено, общие принципы (право на жизнь, общественная безопасность) подразумевают такую обязанность.

Несовершеннолетние пациенты

Возрастные границы

Пациентам младше 15 лет психиатрическая помощь оказывается с согласия родителя (законного представителя) (согласно статье 4 Закона «О психиатрической помощи»)

Старше 15 лет: с собственного согласия (однако информирование родителя рекомендуется в общем порядке)

Пациенты старше 18 лет самостоятельно принимают решения, связанные с психиатрической помощью

Протоколы защиты детей

При подозрении на жестокое обращение с ребёнком (сексуальное, физическое, психологическое), пренебрежение нуждами или искусственное расстройство, навязанное другому лицу (англ. factitious disorder imposed on another, FDIA), на враче лежит обязанность информировать. Организации для обращения:

Агентство социальных услуг

Уполномоченный по правам ребёнка (омбудсмен)

Полиция (в опасных ситуациях)

Агрессивный пациент и меры безопасности

Правовая база

Статья 37.4 Закона «О психиатрической помощи» регулирует применение особых мер:

> В целях обеспечения безопасности врачей-психиатров, оказывающих психиатрическую помощь, других специалистов, среднего и младшего медицинского персонала им предоставляется право применять особые меры

(физическое ограничение лица с психическим расстройством, его временная изоляция, применение специальной фиксирующей одежды).

Правила применения:

Только при наличии реальной опасности

Следует выбирать наименее ограничительное средство

Ограничение по времени

Должна быть сделана запись в медицинской документации

Необходимо информировать руководство учреждения

Принципы деэскалации

Перед физическим ограничением:

Спокойное, доброжелательное отношение

Выслушивание беспокойства пациента

Предложение выбора (например, «Остаться в отдельной палате, чтобы успокоиться, или принять лекарство?»)

Вербальная деэскалация

Только при безуспешности этих методов переходят к фармакологическому или физическому ограничению

Фармакологическое ограничение (неотложная седация, НС)

Первый выбор — пероральные препараты с согласия пациента:

Лоразепам 1–2 мг, внутрь

Оланзапин 5–10 мг внутрь (эффективна таблетка, распадающаяся в полости рта (англ. orally disintegrating tablet, ODT))

Рисперидон 1–2 мг, внутрь (лат. per os)

При отсутствии согласия или сотрудничества — внутримышечно (англ. intramuscular, i.m.):

Оланзапин в/м 10 мг + (при необходимости) лоразепам 2 мг в/м

Галоперидол 5 мг в/м + лоразепам 2 мг в/м (классическая комбинация)

Арипипразол в/м 9,75 мг

Внимание: оланзапин в/м + парентеральный бензодиазепин — комбинация может вызвать угнетение дыхания. Оланзапин в/м не следует применять одновременно с парентеральными бензодиазепинами; при необходимости

между ними соблюдают перерыв не менее 1 часа и наблюдают за пациентом в отношении угнетения дыхания.

Образцы документов

Протокол направления на недобровольную госпитализацию

НАПРАВЛЕНИЕ НА НЕДОБРОВОЛЬНУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
Дата: _____ Время: _____
Сведения о пациенте:
- Имя, фамилия, отчество: _____
- Дата рождения: _____
- Адрес: _____
- Удостоверение личности/ID: _____
Условия интервью:
- Место: _____
- Источник обращения/направления: _____
- Присутствовал ли законный представитель? Да/Нет; имя: _____
Клиническая картина:
[Жалобы, анамнез, описание психического статуса]
Диагноз (МКБ-11): _____
Основание недобровольной госпитализации (статья 11 Закона «О психиатрической помощи»):
☐ 11.1.1 Пациент опасен для себя или для других
Все основания, содержащиеся в статье 11 Закона (включая пункты, следующие за 11.1.1), должны быть приведены полностью в соответствии с официальным текстом
Конкретные показатели:
[Суицидальный риск, гомицидные идеи, уровень ухода и т. д.]
Решение: пациент в недобровольном порядке помещается в психиатрический стационар [название учреждения].
Дальнейшие шаги:
- Осмотр комиссией врачей-психиатров в течение 48 часов
- Обращение в суд в течение 24 часов после решения комиссии
Врач-психиатр: _____
Номер сертификата: _____
Подпись: _____
Печать: _____

План безопасности при суицидальном риске (совместно с пациентом)

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ (англ. safety plan)
Пациент: _____ Дата: _____
1. Ранние предупреждающие признаки (важные для меня сигналы):
- _____
- _____
- _____
2. Мои внутренние стратегии совладания (англ. coping strategies) (только то, что я могу сделать собственными силами):
- _____
- _____
- _____
3. Люди и места, которые помогут мне отвлечься:
- _____
- _____
4. Люди, к которым я могу обратиться за помощью (имя, телефон):
- _____
- _____
5. Клиническая помощь (круглосуточно):
- Моя клиника: _____ (телефон: _____)
- Бакинский центр психического здоровья (неотложная помощь): _____
- Скорая помощь (Азербайджан): 103
- Полиция: 102
6. Обеспечение безопасности моей домашней обстановки:
- Средства, создающие риск: _____
- План их удаления: _____
Подписи:
Пациент: _____
Врач-психиатр: _____

Этические принципы

Международные принципы (Международная декларация по медицинской этике, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Хельсинкская декларация)

Автономия — право пациента принимать решения

Благодеяние (англ. beneficence) — действие в интересах пациента

Непричинение вреда (англ. non-maleficence; лат. primum non nocere — прежде всего не навреди)

Справедливость (англ. justice) — равное отношение ко всем пациентам

Клинические дилеммы

Противоречие между принципом автономии и принципом благодеяния:

Пациент отказывается от лечения, однако его способность принимать решения сомнительна

Решение: способность принимать решения оценивается формально; если способность отсутствует, привлекается законный представитель; если способность сохранна, отказ пациента уважается (когда это не опасно)

Конфиденциальность против общественной безопасности:

Как указано выше — при угрозе жизни конфиденциальность ограничивается

Множественные ролевые отношения (англ. multiple roles):

Роли пациента, работника и друга не должны смешиваться

Жёсткие рамки — только профессиональные отношения

Подарки и материальные отношения:

Не принимать от пациента значимых подарков

Избегать материальных и деловых связей

КЛИНИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПСИХОТЕРАПИИ

Концепция клинической психотерапии

До середины XX века психотерапевтическая деятельность строилась преимущественно в рамках традиций отдельных школ. Психоаналитик считал себя психоаналитиком, поведенческий терапевт — бихевиористом, гештальт-терапевт — гештальт-терапевтом; каждый лечил своих пациентов методом собственной школы — независимо от их диагноза. В таком подходе метод терапевта считался важнее расстройства пациента: инструмент был главным, а проблема — второстепенной.

С конца XX – начала XXI века в клиническом мышлении произошёл принципиальный сдвиг. Принципы доказательной медицины (англ. evidence-based medicine) начали применяться и в психотерапевтической сфере, сформировалась новая парадигма. В основе этой парадигмы лежит концепция клинической психотерапии: какой бы основной школы ни придерживался терапевт, на нём лежит ответственность за применение наиболее эффективной, доказательно обоснованной стратегии для конкретного расстройства.

Этот принцип можно пояснить простым примером. Предположим, терапевт получил психоаналитическое образование и прошёл 5 лет личного анализа. К нему приводят 7-летнего ребёнка, страдающего ночным энурезом. Классический психоаналитический подход может попытаться объяснить симптом ребёнка как выражение эдипова комплекса, родительских отношений или детской травмы. Независимо от степени истинности такого объяснения, с точки зрения клинического результата этот подход неэффективен: ночной энурез более чем в 70 % случаев успешно лечится с помощью аларм-терапии (англ. alarm therapy) — то есть поведенческого вмешательства с доказанной эффективностью. Такая интерпретация не устраняет симптом, удлиняет сроки лечения и ведёт к неэффективному использованию ресурсов родителей.

Клиническая психотерапия в этом вопросе однозначна: энурез лечится поведенческим протоколом — какой бы «школы» ни придерживался терапевт. Точно так же паническое расстройство лечится когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), пограничное расстройство личности — диалектической поведенческой терапией (ДПТ) (англ. Dialectical Behavior Therapy, DBT) или схема-терапией, простые фобии — экспозиционной терапией (методом экспозиции), а посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) —

десенсибилизацией и переработкой движениями глаз (ДПДГ) (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) либо травма-фокусированной когнитивно-поведенческой терапией (КПТ). Этот выбор основан не на личных предпочтениях терапевта, а на накопленных научных доказательствах по конкретному расстройству.

У такого подхода есть два практических следствия. Во-первых, интересы пациента ставятся выше принадлежности к школе: пациент вправе получить наилучшее лечение собственного расстройства, а не следование личной профессиональной биографии терапевта. Во-вторых, в профессиональном поведении специалиста возникает необходимость в трансдиагностической компетентности: терапевт должен уметь работать не только методом одной школы, но и с различными доказательно обоснованными протоколами.

Психотерапевтические школы и их механизмы

В современной клинической психотерапии существуют десятки школ и методов. Ниже приведено краткое описание наиболее важных из них с точки зрения клинической практики.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) (англ. Cognitive Behavioral Therapy, CBT). Этот подход, разработанный Аароном Беком (депрессия, 1960-е годы) и Альбертом Эллисом — автором рационально-эмоционально-поведенческой терапии (англ. Rational Emotive Behavior Therapy, REBT), — работает на когнитивном уровне. Основной постулат: эмоциональную реакцию определяет не само событие, а его оценка. В ходе терапии пациент учится распознавать собственные автоматические мысли и когнитивные искажения (катастрофизацию, чёрно-белое мышление, персонализацию, поспешные выводы и т. д.), проверять их и заменять более функциональными альтернативами. Поведенческий компонент — экспозиция, активация поведения, упражнения по формированию привычек — закрепляет когнитивные изменения. Это психотерапевтический метод с наиболее обширной доказательной базой.

Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ) (англ. Dialectical Behavior Therapy, DBT). Метод разработан Маршей Линехан в 1980-е годы для пациентов с хроническими суицидальными тенденциями и пограничным расстройством личности. Является продолжением КПТ, однако добавляет специальные модули для пациентов с эмоциональной дисрегуляцией, дефицитом толерантности и импульсивностью: осознанность (англ. mindfulness), толерантность к кризисам, управление эмоциями, эффективность

в межличностных отношениях. Стандартная ДПТ включает еженедельные индивидуальные сеансы, групповые сеансы обучения навыкам, телефонное консультирование (англ. phone coaching) и консультации терапевтической команды.

Схема-терапия (англ. Schema Therapy). Этот подход, разработанный Джеффри Янгом в 1990-х годах, объединяет КПТ, гештальт-терапию, теорию привязанности (англ. attachment theory) и психодинамические элементы. Особенно эффективен при расстройствах личности и хронических, резистентных к лечению состояниях депрессии и тревоги. Идентифицирует и переписывает ранние дезадаптивные схемы (например, «покинутость», «недоверие», «дефектность») и связанные с ними «режимы» (детский режим, режим строгого родителя, режим здорового взрослого).

Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ) (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR). Метод разработан Франсин Шапиро в 1987 году. Представляет собой структурированный 8-этапный протокол переработки травматических воспоминаний посредством двусторонней стимуляции (англ. bilateral stimulation) — движений глаз либо альтернативной тактильной или слуховой стимуляции. Рекомендован ВОЗ в качестве вмешательства первой линии при ПТСР. Эффективен при комплексной травме, острой стрессовой реакции и фобиях, а также в случаях, когда депрессия и тревога имеют травматический компонент.

Интерперсональная терапия (ИПТ) (англ. Interpersonal Therapy, IPT). Разработана Джеральдом Клерманом и Мирной Вейсман в 1970-х годах для лечения депрессии. Связывает симптомы пациента с одной из четырёх межличностных сфер: горе, ролевые конфликты, ролевые переходы, межличностные дефициты. Является структурированной и краткосрочной (12–16 сеансов), демонстрирует эффективность, сопоставимую с КПТ при депрессии.

Терапия принятия и ответственности (ТПО) (англ. Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Эта терапия — подход КПТ «третьей волны», разработанный Стивеном Хейсом в 1980-х годах. Направлена не на изменение содержания мыслей, а на изменение отношения к ним. Развивает психологическую гибкость (англ. psychological flexibility): жизнь в соответствии с ценностями, открытость по отношению к болезненным эмоциям, отделение от мыслей (англ. cognitive defusion). Эффективна при хронической боли, депрессии, тревоге, расстройствах зависимости и экзистенциальных кризисах.

Когнитивная терапия на основе осознанности (КТО) (англ. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT). Разработана Зинделом Сигалом, Марком Уильямсом и Джоном Тисдейлом для профилактики рецидивирующей депрессии. Объединяет КПТ с программой снижения стресса на основе осознанности (англ. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) Джона Кабат-Зинна. Обеспечивает профилактический результат, равный медикаментозному лечению или превосходящий его, у пациентов, перенёсших как минимум два рецидива большого депрессивного расстройства.

Психодинамическая психотерапия — метод, вышедший из классического психоанализа, но адаптированный к современным клиническим условиям. Существуют различные применяемые модели: терапия на основе ментализации (МБТ) (англ. Mentalization-Based Therapy, MBT), психотерапия, сфокусированная на переносе (ТФП — Кернберг), краткосрочная психодинамическая психотерапия. Основной механизм — изучение и переработка бессознательных процессов пациента, защитных механизмов, шаблонов отношений и влияния раннего детского опыта на сегодняшнее поведение. Эффективна при расстройствах личности, хронической депрессии и проблемах в отношениях.

Уровни доказательности

Эффективность психотерапевтических методов оценивается на основе систематических исследований (рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) (англ. randomized controlled trials, RCT), метаанализы, систематические обзоры). Международные клинические руководства (Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи (англ. National Institute for Health and Care Excellence, NICE) — Великобритания; Американская психиатрическая ассоциация (англ. American Psychiatric Association, APA); Всемирная федерация обществ биологической психиатрии (англ. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP); ВОЗ) синтезируют эти доказательства и определяют уровни доказательности:

Уровень А (высокий уровень доказательности) — эффективность, подтверждённая в многочисленных независимых высококачественных РКИ и метаанализах. Метод считается вмешательством первой линии при конкретном расстройстве.

Уровень В (средний уровень доказательности) — эффективность, подтверждённая в нескольких РКИ, однако совокупность метаанализов

ограничена либо между результатами наблюдаются определённые расхождения. Метод рекомендуется в качестве вмешательства второй линии или альтернативного вмешательства первой линии.

Уровень C (ограниченный уровень доказательности) — методы, эффективность которых показана лишь в единичных исследованиях или описаниях клинических случаев. Могут применяться, когда методы первой линии не дают эффекта или недоступны.

Карта стратегий лечения по расстройствам

В приведённой ниже таблице представлены психотерапевтические вмешательства, рекомендованные международными руководствами при основных психических расстройствах, вместе с уровнями доказательности.

Таблица 4. Психотерапевтические стратегии — карта по расстройствам

Расстройство	Первая линия (A)	Вторая линия (B)	Альтернатива (C)	—
Большое депрессивное расстройство (по МКБ-11 — депрессивный эпизод)	КПТ, ИПТ	Схема-терапия, ТПО, психодинамическая терапия	КТО (профилактика рецидивов)	—
Генерализованное тревожное расстройство (ГТР)	КПТ	ТПО, КТО	психодинамическая терапия	—
Паническое расстройство	КПТ (сфокусированная на панике)	терапия экспозиции (англ. exposure therapy)	ДПДГ (при наличии травматического компонента)	—

Расстройство	**Первая линия (A)**	**Вторая линия (B)**	**Альтернатива (C)**	**—**
Социальное тревожное расстройство	КПТ, групповая КПТ	ТПО	психодинамическая терапия	—
ОКР	Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)	терапия экспозиции и предотвращения реакции (англ. exposure and response prevention, ERP)	КПТ	ДПДГ при ОКР не рекомендована международными клиническими руководствами
ПТСР	ДПДГ, травма-фокусированная КПТ (англ. Trauma-Focused CBT, TF-CBT)	терапия письменной экспозиции	психодинамическая терапия	—
Пограничное расстройство личности	ДПТ, МБТ, ТФП, схема-терапия	КПТ	психодинамическая терапия	—

Расстройство	**Первая линия (A)**	**Вторая линия (B)**	**Альтернатива (C)**	**—**
Биполярное расстройство (психотерапевтический компонент)	терапия межличностных и социальных ритмов (англ. Interpersonal and Social Rhythm Therapy, IPSRT), КПТ, терапия, сфокусированная на семье	психологическое просвещение	осознанность	—
Расстройства приёма пищи (нервная анорексия, нервная булимия)	усиленная КПТ (англ. enhanced CBT, CBT-E), терапия, основанная на семье (англ. Family-Based Treatment, FBT) — для подростков	ДПТ, ИПТ	схема-терапия	—
Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ) — подростки и взрослые пациенты	психообразование + КПТ	поведенческая терапия	осознанность	—

Расстройство	**Первая линия (A)**	**Вторая линия (B)**	**Альтернатива (C)**	**—**
Детский энурез	аларм-терапия (поведенческий протокол)	мотивационная схема	психодинамическое консультирование (только в качестве вспомогательного метода)	—
Расстройства личности (в целом)	схема-терапия, МБТ, ТФП	ДПТ	КПТ	—
Расстройства зависимости	мотивационное интервью + КПТ	профилактика рецидивов, ДПТ	12-шаговые программы	—
Хроническая боль	КПТ, ТПО	осознанность	психодинамическая терапия	—

Источник: клинические руководства Национального института здоровья и совершенствования медицинской помощи (англ. NICE Clinical Guidelines, 2022, 2024); клинические руководства Американской психиатрической ассоциации (англ. APA Clinical Practice Guidelines, 2019, 2024); руководство ВОЗ по вмешательствам в рамках Программы действий по ликвидации пробелов в области охраны психического здоровья (англ. mhGAP Intervention Guide 2.0, 2016; mhGAP guideline, 2023); руководства по лечению Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (англ. WFSBP Treatment Guidelines).

Фармакотерапия и психотерапия: не конкуренты, а взаимодополняющие

В психиатрической практике регулярно возникает вопрос: лекарственная терапия или психотерапия? Сам этот вопрос ошибочен, поскольку они не исключают друг друга.

Правильный вопрос формулируется в трёх измерениях:

1. Природа расстройства. При тяжёлых расстройствах с нейробиологическим компонентом (шизофрения, тяжёлое биполярное

расстройство, меланхолическая депрессия, тяжёлое ОКР) основой является фармакотерапия, психотерапия — дополняющей. При психогенных, лёгких и среднетяжёлых, реактивных расстройствах (расстройство адаптации, генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, простые фобии) основным вмешательством является психотерапия, а лекарство при необходимости используется как краткосрочное вспомогательное средство.

2. Состояние пациента. При остром риске суицида (самоубийства), серьёзном функциональном нарушении, отказе от приёма пищи, психотических элементах — в острой фазе преобладает фармакотерапия. После стабилизации основную роль берёт на себя психотерапия.

3. Фаза лечения. Острая фаза направлена на стабилизацию симптомов; на этом этапе фармакотерапия даёт быстрый результат. После стабилизации наступает этап обращения к корневой проблеме; на этом этапе основную роль берёт на себя психотерапия. На этапе профилактики (предупреждения) психотерапия предотвращает рецидив — и здесь её преимущество видно наиболее отчётливо.

Таблица 5. Фармакотерапия и психотерапия: сравнительные возможности

Параметр	Фармакотерапия	Психотерапия
Начало эффекта	2–6 недель	2–8 недель
Мишень	Симптомы, нейробиологическая дисрегуляция	Когнитивная структура, поведенческие паттерны, корневые причины
После прекращения	Вероятность возврата симптомов высокая	Эффект сохраняется, случаи рецидива редки
Побочные эффекты	Есть, иногда серьёзные	Редки, однако нежелательные эффекты возможны
Активное участие пациента	Минимальное	Является основным фактором

Параметр	Фармакотерапия	Психотерапия
В острых состояниях	Преобладает	Психотерапия применяется после стабилизации
В профилактике	Требует непрерывного приёма	Один курс даёт долгосрочный эффект

Источник: клинические руководства Американской психиатрической ассоциации (англ. American Psychiatric Association, APA Clinical Practice Guidelines, 2019); руководства NICE по депрессии NG222 (2022); Cuijpers P. и др. «Всемирная психиатрия» (англ. World Psychiatry), 2023.

Организационное значение клинической психотерапии

У концепции клинической психотерапии есть ещё один важный аспект: она создаёт основу для стандартизации психотерапевтической помощи. Доказательные, дифференцированные по расстройствам протоколы решают три критически важных вопроса:

1. Подготовка специалистов. Когда для каждого расстройства существует конкретный протокол, подготовка специалиста становится быстрее и качественнее. Вместо изучения абстрактной теории обучающийся осваивает конкретные стратегии для конкретных клинических ситуаций.

2. Контроль качества. При наличии стандартного протокола супервизор может оценивать работу специалиста с точки зрения соответствия протоколу. Это в настоящее время составляет основу и профессиональной аккредитации (см. следующую главу).

3. Статистический анализ и оптимизация. Стандартизированные протоколы позволяют проводить сравнительную оценку результатов. В стандартизированных условиях определяется, какой протокол в какой группе пациентов более эффективен. Какая модификация улучшает результат? Ответы на эти вопросы возможны только в условиях стандартизированной практики.

После этого институционального значения клинической психотерапии логичный шаг — международная система контроля качества психотерапевтической помощи: следующий шаг состоит в рассмотрении аккредитационных органов, их требований и существующего в Азербайджане положения. Этот вопрос будет представлен в последнем блоке данного

Предисловия, однако сначала представляются два авторских клинических протокола — лечение ночного энуреза у детей и психогенной депрессии. Эти протоколы разработаны в многолетней клинической практике и подтверждены полученными результатами.

АВТОРСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ №1: ЛЕЧЕНИЕ НОЧНОГО ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ

Модифицированный протокол аларм-терапии

К. Рагимов, клиническая практика 2018–2025

Сущность и место протокола

Ночной энурез у детей (Всемирная организация здравоохранения — МКБ-11: 6C00.0; DSM-5-TR: 307.6) представляет собой состояние непроизвольного ночного выделения мочи (энурез), продолжающееся после возрастной нормы (старше 5 лет). Наблюдается примерно у 5–10 % семилетних детей, у 3–5 % десятилетних, у 1–2 % подростков. Расстройство может оказывать серьёзное негативное влияние на самооценку ребёнка, его социальную активность и внутрисемейные отношения.

Международные клинические руководства (NICE NG111, ICCS — Международное общество по удержанию мочи у детей (англ. International Children's Continence Society), Американская академия педиатрии (англ. American Academy of Pediatrics, AAP)) рекомендуют в лечении ночного энуреза в качестве вмешательства первой линии аларм-терапию (систему пробуждения с помощью сигнального аппарата). Стандартный протокол при курсе 12–16 недель даёт полную ремиссию в 65–75 % случаев. Однако у него есть ряд пробелов:

Вечерний приём жидкости ограничивается — это уменьшает число тренировок и замедляет формирование рефлексов.

Перед сном ребёнок идёт в туалет — поскольку он ложится спать с пустым мочевым пузырём, расстройство проявляется редко, соответственно и возможностей для коррекции мало

Пробуждение ребёнка на звук аларм-аппарата ожидается пассивно — в фазе глубокого сна ребёнок не просыпается, а этап «избыточного научения» (англ. overlearning) применяется только в конце курса

Система ежедневных комплексных упражнений интегрируется редко

Представленная ниже модификация разработана с целью устранения этих пробелов. Основной принцип — полная нагрузка в начале курса: жидкостная нагрузка, принудительное пробуждение и подъём с громким, но заботливым

тоном, немедленно подкрепляемый поведенческий компонент, параллельно — комплексные ежедневные упражнения и мотивационное сопровождение. Полученные клинические результаты: на 11–12-й неделе полная ремиссия у 192 из 240 детей (80 %).

Клинические принципы протокола

В основе модификации лежат четыре принципа:

1. Интенсивное начало, а не постепенно возрастающая нагрузка. В стандартных протоколах нагрузка увеличивается постепенно, избыточная жидкостная нагрузка (англ. overlearning) применяется только в конце курса. В данной модификации с первой недели ребёнку дают вечером 200–400 мл жидкости (обычная питьевая вода или чай; газированные, сладкие или кофеинсодержащие напитки исключаются) не менее чем за 1 час до сна, а поход в туалет перед сном запрещается. Цель — создать условия для того, чтобы эпизод недержания мочи действительно произошёл, поскольку скорректировать несостоявшееся событие невозможно.

Абсолютные противопоказания (жидкостная нагрузка не применяется):

Заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром и др.)

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СИАДГ)

Гиперактивный мочевой пузырь и/или нейрогенный мочевой пузырь

Эпилепсия (особенно неконтролируемые формы) — единый критерий во всём тексте

Несахарный диабет (англ. diabetes insipidus)

Сердечная недостаточность

Любая серьёзная соматическая патология — требуется первичное педиатрическое обследование

2. Активное участие родителей, а не пассивное ожидание. В стандартном протоколе предполагается, что ребёнок сам проснётся на звук сигнального аппарата. Однако в фазе глубокого сна большинство детей не просыпаются на звук аппарата — это наиболее часто отмечаемый недостаток. В модификации в течение первой-второй недели ребёнка будит родитель: через 5–10 секунд после звука аппарата он громким, но заботливым тоном, включая свет и умывая лицо прохладной водой, приводит ребёнка в состояние полного пробуждения. Цель этой процедуры — не напугать ребёнка, а быстро привести его в полностью бодрствующее состояние; громкость голоса родителя не носит

характера крика или агрессии. Это обеспечивает быстрое формирование рефлекса путём создания лёгкого, целенаправленного стресса.

3. Комплексный подход — одновременно ежедневные упражнения. Ночной энурез — это не только нарушение рефлекса мочевой пузырь–центральная нервная система; в большинстве случаев это комплексное расстройство, сочетающееся со слабостью мышц малого таза и недостаточностью поведенческого научения. В модификации ежедневные упражнения Кегеля (англ. Kegel exercises) (3 раза в день, 10–60 повторений, с еженедельным увеличением) являются неотъемлемой частью протокола. Это также устраняет параллельно наблюдаемое расстройство — энкопрез (МКБ-11: 6C01).

4. Сопровождение мотивации и психологическая регуляция. Еженедельная встреча с родителем, оценка уровня мотивации ребёнка, подкрепление небольших достижений, обсуждение переработанных целей являются основными элементами протокола. Ребёнок ощущает себя активным субъектом процесса, а не механическим пассивным объектом.

Этапы протокола

Протокол состоит из 5 этапов, каждый из которых длится 2 недели, — всего 10 недель. Каждый этап строится на основе предыдущего и поэтапно формирует у ребёнка пробуждающие рефлексы, тонус мышц малого таза и поведенческие паттерны.

Таблица 6. Модифицированный протокол сигнальной терапии — по этапам

Этап	Неделя	Реакция пробуждения	Состояние мочеиспускания (энурез)	Интенсивный ночной протокол	Дневные упражнения Кегеля
1	1–2	Ребёнка с трудом будит только родитель; на звук аппарата	Недержание мочи выражено, полностью мочит постель, крепко	Вечером 200–400 мл жидкости дают не менее чем за 1 час до	Упражнение «сидя-стоя» 10 повторений, 3 раза в день

Этап	**Неделя**	**Реакция пробуждения**	**Состояние мочеиспускания (энурез)**	**Интенсивный ночной протокол**	**Дневные упражнения Кегеля**
		сам проснуться не может	спит до утра, не просыпается	сна; перед сном в туалет не пускают; тренировка с аппаратом проводится не менее 10 раз за ночь. После звука аппарата родитель в течение 5–10 секунд будит ребёнка громким, но ласковым тоном с девизом «быстро-быстро-быстро», включает свет, умывает лицо прохладной водой —	(ежедневно +1 повторение)

Этап	Неделя	Реакция пробуждения	Состояние мочеиспускания (энурез)	Интенсивный ночной протокол	Дневные упражнения Кегеля
				достигается полное пробуждение; затем ребёнок 5 минут сидит в туалете и тужится	
2	3–4	На звук аппарата просыпается сам раньше матери; иногда будит мать — быстро встаёт	Недержание мочи по-прежнему выражено; если аппарат не подаёт звук, не просыпается	В том же порядке: 200–400 мл жидкости за 1 час до сна, отказ от посещения туалета, интенсивный протокол пробуждения	Число повторений увеличивают до 25 (ежедневно добавляется одно повторение). 3-я неделя: «Быстрые сокращения». 4-я неделя: «Медленные сокращения»

Этап	**Неделя**	**Реакция пробуждения**	**Состояние мочеиспускания (энурез)**	**Интенсивный ночной протокол**	**Дневные упражнения Кегеля**
3	5–6	На звук аппарата просыпается раньше матери; бодрствование хорошее	Недержание уменьшается; проснувшись на звук, частично задерживает поток мочи; иногда намокает только нижнее бельё	В том же порядке	Увеличивают до 35. 5-я неделя: «Максимальная задержка». 6-я неделя: упражнение «Стоп-Продолжение» (англ. Stop-Start)
4	7–8	На звук аппарата просыпается быстрее матери; сам проявляет инициативу	Незначительное недержание; 1 раз в неделю ночью просыпается по собственной воле без аппарата	В том же порядке	Увеличивают до 50. 7-я неделя: «Программирование». 8-я неделя: упражнение «Мост»

Этап	Неделя	Реакция пробуждения	Состояние мочеиспускания (энурез)	Интенсивный ночной протокол	Дневные упражнения Кегеля
5	9–10	На звук аппарата просыпается быстрее матери; иногда просыпается сам без аппарата	Просыпается по собственной воле каждую ночь; недержание отмечается не чаще 1 раза в неделю	В том же порядке	Увеличивают до 60. 9-я неделя: упражнение «Сжатие-кашель». 10-я неделя: упражнение «Лифт»

Источник: К. Рагимов, клиническая практика 2018–2025, n = 240 детей, Баку. Уровень доказательности IV — ретроспективное клиническое наблюдение (серия случаев). Данные основаны на ретроспективном клиническом наблюдении; планируется рандомизированное исследование с контрольной группой.

11–12-я неделя: консолидация и оценка

После 10-недельного структурированного протокола 11–12-я недели предусмотрены как этап консолидации. В этот период ребёнок:

Самостоятельно, без вмешательства родителей, каждую ночь не менее чем за 1 час до сна принимает 200–400 мл жидкости

Ложится в постель, не сходив в туалет

Ночью просыпается по собственному внутреннему сигналу (без сигнального аппарата), и постель остаётся сухой

Утром просыпается полностью сухим.

Клинические результаты: в группе из 240 пациентов-детей на 11–12-й неделе в 80 % случаев зарегистрирована полная ремиссия (ни одного ночного эпизода недержания). Это выше результата международного стандартного протокола сигнальной терапии (65–75 %).

Описание упражнений для мышц тазового дна (англ. Kegel exercises) (комплексная ежедневная программа)

Сменяющиеся каждую неделю тренировочные блоки направлены на различные функциональные аспекты группы мышц малого таза:

Быстрые сокращения (3-я неделя): быстрая контракция и релаксация мышц малого таза направлены на развитие рефлекторного тонуса.

Медленные сокращения (4-я неделя): длительная контракция — повышение мышечной выносливости

Максимальная задержка (5-я неделя): периоды длительной контракции направлены на формирование устойчивого тонуса.

«Стоп-Продолжение» (6-я неделя): упражнение на произвольное прерывание и продолжение потока мочи — обучение произвольному контролю мочеиспускания

Программирование (7-я неделя): наполнение мочевого пузыря до определённого объёма и управление им

«Мост» (8-я неделя): упражнения на подъём таза — синхронизация мышц живота и таза

«Сжатие-Кашель» (9-я неделя): применяется упражнение сопротивления против стрессового недержания.

Упражнение «подъём» (англ. lift): поэтапная контракция — постепенно усиливающийся контроль мышц

Практические рекомендации

Важные условия для эффективного применения протокола:

1. Мотивация родителей — основное условие. В течение первой-второй недели родители должны просыпаться ночью многократно и активно будить ребёнка в течение 5–10 секунд. Это тяжёлая нагрузка для семьи и требует предварительного согласия. Еженедельная встреча с родителем является неотъемлемой частью протокола.

2. Сокращение потребления жидкости — запрещено. Многие родители (и некоторые врачи) интуитивно рекомендуют уменьшать приём жидкости вечером. В данной модификации этот шаг однозначно считается противопоказанным — формирование рефлекса происходит в условиях полной нагрузки.

3. Выбор аппарата. Сигнальные аппараты для лечения энуреза бывают двух видов: укладываемые в постель и помещаемые в нижнее бельё. Второй тип более эффективен, поскольку подаёт сигнал немедленно при первой капле мочи. В данной модификации рекомендуется тип, помещаемый в нижнее бельё.

4. Параллельно наблюдаемый энкопрез. Примерно у 10–15 % детей с ночным энурезом наблюдается энкопрез (МКБ-11: 6C01). В данной модификации комплекс упражнений Кегеля одновременно устраняет оба расстройства — тонус мышц малого таза улучшает как управление мочевым пузырём, так и контроль анального сфинктера.

5. В случаях резистентности. Если после 6-й недели (окончание 3-го этапа) отсутствует какая-либо положительная динамика, требуется дополнительное медицинское обследование:

Урологический осмотр — дисфункция мочевого пузыря, анатомические аномалии

Неврологический статус — миелодисплазия, скрытая расщелина позвоночника (лат. spina bifida occulta), нейрогенный мочевой пузырь

Эндокринные показатели — несахарный диабет (лат. diabetes insipidus), недостаточность антидиуретического гормона

Оториноларингологическое обследование — обструктивное апноэ сна (особенно у детей с гипертрофией аденоидов, увеличением нёбных миндалин); апноэ тесно связано с энурезом и может быть его основной причиной

Психиатрический фон — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), поведенческие расстройства, острые события психотравмирующего характера

В определённых диагностических ситуациях (например, при гиперактивности детрузора) может быть добавлена фармакотерапия (десмопрессин, оксибутинин). Если установлен диагноз обструктивного апноэ сна — аденотомия или тонзиллэктомия могут устранить энурез.

6. Возрастное ограничение. Протокол разработан для детей старше 5 лет. До 5 лет первичный (идиопатический) ночной энурез соответствует возрастной норме и не требует активного вмешательства.

7. Абсолютные противопоказания к водной нагрузке (единый перечень). При наличии следующих состояний протокол водной нагрузки не применяется, используется стандартный протокол NICE NG111:

Патология почек (хроническая болезнь почек, нефротический синдром, уролитиаз)

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СИАДГ — синдром Шварца–Барттера)

Эпилепсия (особенно холинергические формы или формы, чувствительные к водному балансу)

Сердечная недостаточность, гипертензия

Сахарный диабет или несахарный диабет (в стадии декомпенсации)

Тяжёлые эндокринные расстройства (гипотиреоз, гипопаратиреоз)

Любое соматическое заболевание, при котором изменение водного баланса может повлиять на его течение.

Отсутствие указанных состояний должно быть подтверждено педиатром или урологом до начала протокола.

Место протокола в рамках клинической психотерапии

Данная модификация представляет собой применение принципов клинической психотерапии на примере ночного энуреза. Вмешательство с доказанной эффективностью при данном расстройстве (аларм-терапия, поведенческий компонент, упражнения Кегеля) было модифицировано на основе клинического опыта автора, и был получен измеримый, воспроизводимый результат. Здесь основная школа терапевта не имеет значения — психоаналитический терапевт, терапевт когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) или гештальт-терапевт могут в равной степени освоить и применять этот протокол. Важна структурированная, измеримая, последовательная клиническая методика.

Следующий авторский протокол — двухэтапная стратегия в лечении психогенной депрессии — демонстрирует те же принципы клинической психотерапии при более сложном расстройстве, связанном с когнитивно-эмоциональной работой.

АВТОРСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ №2: ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОГЕННОЙ ДЕПРЕССИИ

Интеграция краткосрочной когнитивной реструктуризации и долгосрочной профилактической стратегии

К. Рагимов, клиническая практика 2008–2025

Смысл и место протокола

Психогенная (реактивная) депрессия — в рамках депрессивного эпизода по МКБ-11 симптомокомплекс, запускаемый психосоциальными факторами, — это депрессивное расстройство, связанное с определённым жизненным событием или цепью событий и обусловленное когнитивно-эмоциональными процессами, а не нарушением нейробиологической регуляции. Согласно современным исследованиям, 60–80 % случаев большого депрессивного расстройства (англ. major depressive disorder) запускается психосоциальными факторами — в их начале стоит конкретное триггерное событие (утрата, нарушение отношений, профессиональная неудача, комплексная травма) (Kendler и соавт., 1999, 2003; Brown и Harris, 1978); это должно быть дополнено современными руководствами (МКБ-11, ДСМ-5-ТР, NICE NG222). В остальных 20–40 % — эндогенных, то есть таких, где преобладает нейробиологическая регуляция, — доминирует нейробиологический компонент. Однако на практике чисто «психогенная» или чисто «эндогенная» депрессия встречается редко; большинство депрессий представляет собой смесь психосоциального и нейробиологического компонентов в различных пропорциях. Данный протокол разработан для случаев, в которых доминирует психосоциальный компонент.

Это разграничение имеет решающее значение для лечебной стратегии. При эндогенной депрессии основное вмешательство — фармакотерапия, а психотерапия играет вспомогательную роль. При психогенной депрессии основным вмешательством становится психотерапия; лекарственный препарат при необходимости используется лишь в острой фазе как краткосрочное вспомогательное средство. Психогенная депрессия лёгкой и средней степени тяжести в большинстве случаев лечится психотерапией без применения лекарственных препаратов.

Однако в современной клинической практике ситуация обратная: подавляющее большинство пациентов с психогенной депрессией лечится только антидепрессантами. В острой фазе симптомы уменьшаются, но, поскольку корневая проблема не решена, после отмены препарата или в условиях нового стрессового фактора депрессия возвращается — иногда в более тяжёлой форме.

Представленный ниже протокол разработан с целью восполнить этот пробел. Он состоит из двух последовательных этапов: краткосрочной когнитивной реструктуризации (устранение острого депрессивного эпизода, 1–6 сеансов) и долгосрочной профилактической терапии (психологическая «вакцинация» против рецидива, 4 последовательных этапа). Долгосрочные (17-летние) наблюдения этой стратегии, разработанной на основе клинической практики, показывают стабильную ремиссию.

Стратификация пациента

Выбор протокола требует предварительной чёткой диагностической стратификации. Приведённая ниже таблица формирует тактические решения по категориям пациентов.

Таблица 7. Выбор лечебной тактики при депрессивных расстройствах

Категория пациента	Клиническая характеристика	Рекомендуемая тактика
Психогенная, лёгкой и средней степени тяжести	4–6 соматических симптомов (из 8); отчётливое триггерное событие; функциональное нарушение на среднем уровне	Только психотерапия (данный протокол). Лекарственные препараты не требуются

Категория пациента	Клиническая характеристика	Рекомендуемая тактика
Психогенная, тяжёлая	7 и более симптомов; серьёзное функциональное нарушение; имеется риск суицида (самоубийства); однако триггер отчётливый	Фармакотерапия параллельно с психотерапией, долгосрочно; в острой фазе препарат имеет преимущество, затем основная роль переходит к психотерапии
Психогенная, тяжёлая + психотические элементы	Указанное выше + реактивные галлюцинации, параноидные идеи	Стационарное лечение + фармакотерапия + психотерапия (после стабилизации)
Эндогенная (биполярное аффективное расстройство — БАР; рекуррентное депрессивное расстройство — РДР)	Триггер не отчётливый; аффективные расстройства в семейном анамнезе; циклическое течение	Стационарная или амбулаторная фармакотерапия + психотерапевтическая поддержка (психологическое просвещение, приверженность лечению, профилактика рецидивов)

Источник: клиническая практика К. Рагимова 2008–2025; руководство Американской психиатрической ассоциации (англ. American Psychiatric Association, APA) по лечению большого депрессивного расстройства (2010, 2019); NICE NG222 (2022). «Депрессия у взрослых: лечение и ведение».

Представленный ниже протокол разработан для первой линии — психогенной депрессии лёгкой и средней степени тяжести. Во второй линии (психогенная тяжёлая) структура протокола та же, однако темп замедлен и параллельно применяется фармакологическая поддержка.

Таблица 8. Критерии обязательного параллельного применения фармакотерапии

При наличии хотя бы одного из приведённых ниже критериев психотерапия должна проводиться параллельно с фармакотерапией; исключительно психотерапевтический подход считается недостаточным:

Критерий	Клинический показатель
Степень тяжести депрессии	PHQ-9 (англ. Patient Health Questionnaire-9) ≥ 15 (средне-тяжёлая или тяжёлая) либо BDI-II (англ. Beck Depression Inventory-II) ≥ 29
Риск суицидального поведения	Активные суицидальные мысли в сочетании с планом или средствами
Психотические элементы	Депрессивные галлюцинации, параноидный бред, бред нигилистического содержания (англ. nihilistic delusions)
Тяжёлая ангедония + отказ от приёма пищи	Потеря массы тела более 5 %, дегидратация
Функциональное нарушение	Пациент не может выходить из дома, не соблюдает правила личной гигиены, не способен работать
Анамнез	В предшествующих эпизодах отмечались суицидальная попытка или стационарное лечение
Беременность и лактация	Тяжёлая депрессия у беременной женщины — требуется отдельный алгоритм (см. раздел перинатальной психиатрии)
Подозрение на биполярный фон	При наличии в анамнезе гипоманиакальных или маниакальных эпизодов назначается нормотимик (англ. mood stabilizer)

Источник: NICE Guideline 222 (2022). «Депрессия у взрослых: лечение и ведение». NICE NG222 (2022), 1.5.4–1.5.7; руководство APA по БДР (англ. APA

Practice Guideline for MDD, 2010), раздел 9; руководства WFSBP по биологическому лечению униполярных депрессивных расстройств (англ. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, 2013; издание 2024 года готовится).

При наличии этих критериев начало фармакотерапии назначается специалистом. Психогенная депрессия лёгкой и средней степени тяжести при отсутствии ни одного из вышеперечисленных критериев может эффективно лечиться психотерапией без лекарств — это соответствует последовательной позиции современной международной практики и клиническому опыту автора.

ЧАСТЬ I. КРАТКОСРОЧНАЯ КОГНИТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ (1–6 СЕАНСОВ)

Цель: быстрое устранение острого депрессивного эпизода без применения лекарственных средств.

Механизм: идентификация депрессогенного фактора (не ситуации, а когнитивного отношения) и последовательное применение основанных на доказательствах техник когнитивной реструктуризации.

Первичная оценка и хронологический анамнез

На первом сеансе достигаются две цели:

а) Диагностическое подтверждение. С помощью PHQ-9 или BDI-II оценивается уровень депрессии. Сколько из 8 основных симптомов присутствует (нарушения сна, изменение аппетита, потеря или прибавка массы тела, потеря энергии, ангедония, нарушение концентрации, психомоторные изменения, суицидальные мысли)? Если наблюдаются 4–6 симптомов, это соответствует депрессии лёгкой и средней степени тяжести и протокол может быть применён.

б) Хронологический анамнез. Вместе с пациентом конкретно устанавливается дата начала симптомов (точная неделя, при возможности — точная дата). Затем проверяются события, произошедшие в пределах ±2 месяцев от этой даты:

Внешние события (утрата, нарушение отношений, смена работы, проблема со здоровьем)

Внутренние события (сожаление, сравнение, внезапная мысль, прочтение определённой книги, повторное воспоминание определённого разговора)

Малые или кажущиеся незначительными события — часто именно они оказываются наиболее важными

Цель — найти пусковой момент (англ. trigger point). Это конкретное событие или момент мысли, запустившие депрессивный эпизод.

Идентификация аутоагрессивной когнитивной установки

После определения пускового события терапевт совместно с пациентом устанавливает, какую мысль о самом себе пациент принял в контексте этого события. Эта мысль почти всегда носит аутоагрессивный характер:

«Я виноват»

«Я этого недостоин»

«Я причинил вред другим»

«Я недостаточен»

«Я мог его спасти, но не сделал этого»

«Это произошло из-за меня»

Показатель пусковой установки: произнося эту фразу, пациент даёт эмоциональную реакцию — глаза увлажняются, голос дрожит, в теле наблюдается напряжение. Это свидетельствует о том, что данная установка действительно играет центральную роль.

Критическая особенность: пациент воспринимает эту установку не как когнитивное нарушение, а как истину. Он не принимает сопровождающее разъяснение терапевта и типично говорит: «Вы не знаете правды. На самом деле было так». — и вновь повторяет ту же аутоагрессивную фразу. Это сопротивление — наиболее надёжное доказательство того, что установка выявлена верно.

Когнитивная реконструкция — последовательные техники

На этом этапе в различной последовательности применяется многоуровневая техника. В соответствии с защитными слоями пациента она изменяется.

Важное методологическое замечание. Описанные ниже техники представляют собой примеры для демонстрации общего принципа, а не единственную или обязательную форму применения. Каждая техника должна

адаптироваться к культуральным, религиозным, философским, когнитивным и эмоциональным особенностям конкретного пациента. В клинической психотерапии основной принцип — не шаблонное применение, а применение принципа.

Подход автора основан на синтезе принципов стандартной КПТ (Бек (англ. Beck), Эллис (англ. Ellis)), схема-терапии (Янг (англ. Young)), терапии принятия и ответственности (англ. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) (Хейс (англ. Hayes)) и культурно адаптированной КПТ (англ. culturally adapted CBT) (Hwang, 2006; Naeem и др., 2011, 2015). Эпидемиологические данные показывают, что в обществах с сильными религиозно-нравственными принципами (Пакистан, регион MENA, Южный Кавказ, бывший советский мусульманский регион) чувство вины и аутоагрессивные паттерны самоосуждения наблюдаются значительно чаще. Для таких пациентов когнитивная реструктуризация, проводимая без учёта религиозно-этического контекста, часто оказывается неэффективной, поскольку основной источник аутоагрессивной установки сформировался именно в этом контексте. Приведённые ниже техники демонстрируют практическое применение этого принципа.

Техника 1. «Судебное заседание» (пример применения техник децентрирования (англ. decentering) и реатрибуции (англ. reattribution) — Бек (англ. Beck), 1979)

Подходит для пациентов с рационально-юридическим складом мышления. Событие пересматривается с юридической точки зрения:

Какое действие совершил (или не совершил) пациент?

Является ли это преступлением в рамках действующих законов?

Если это считается преступлением, по какой статье должно быть назначено наказание?

Терапевт не отрицает и не спорит — он исследует совместно. Пациент сам приходит к выводу: юридически это не преступление. Здесь многие пациенты впервые получают формальную оценку собственной ситуации.

Типичная реакция пациента: он выходит из юридической плоскости и переходит в морально-этическую. «Да, юридически это не преступление, но в нравственном отношении я плох.» — этот переход естествен и ожидаем.

Техника 2. «Нравственно-этическое рассуждение» (КПТ, адаптированная к культурному контексту (англ. culturally adapted CBT) — пример применения — Hwang, 2006; Naeem и соавт., 2011, 2015)

Подходит для пациентов с глубокой религиозно-нравственной системой. Если пациент верующий, на морально-этическом уровне применяется аналогичная процедура в рамках внутренних правил религиозной системы:

К какой категории относится это действие в религиозной традиции пациента?

Какой именно грех им считается?

Каково нравственно-религиозное наказание за этот грех?

Есть ли путь покаяния и исправления?

Здесь терапевт опирается на внутреннюю структуру собственной религии пациента и не предлагает иную философскую или психологическую рамку. Ислам, христианство, иудаизм и другие религии — каждая внутри себя обладает чётко структурированной системой правил. Когда пациент видит объективное применение этой системы, он часто обнаруживает, что наказание, которое он применяет к себе, многократно превышает реальную вину.

Техника 3. «Перспектива третьего лица» (пример применения техники самосострадания (англ. self-compassion) — Neff, 2003; Gilbert, 2009)

Универсальная техника, применимая практически ко всем пациентам. Пациента спрашивают: если бы ту же ситуацию переживал его близкий друг или любимый человек, как он смотрел бы на неё? Какие слова сказал бы? Простил бы?

Эта техника представляет собой применение когнитивного разделения (англ. cognitive defusion — в терминологии терапии принятия и ответственности, ACT) и запускает компонент самосострадания (англ. self-compassion).

Техника 4. Элементы схема-терапии (Young, 1990; Young, Klosko, Weishaar, 2003)

Подходит для пациентов с ранним травматическим опытом и хроническими дезадаптивными паттернами. Триггерная установка часто опирается на схему, сформировавшуюся в раннем возрасте (например, «дефектность», «недоверие», «несправедливость»). Техники схема-терапии (имагинальная реконструкция, диалог схемных режимов) позволяют переоценить эту раннюю схему.

Техника 5. Стандартные техники когнитивного переписывания в КПТ (Beck, 1979; Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979)

Обычно используется у каждого пациента на базовом уровне. Сократический диалог, проверка доказательств, формулирование альтернативных объяснений, поведенческие эксперименты.

Результат краткосрочного этапа

Успешный итог этого этапа связан с базовым инсайтом пациента:

> «Депрессию порождала не ситуация, а моя когнитивная установка по отношению к ней.»

После появления этого инсайта настроение меняется быстрее, поскольку пациент уже стоит не перед неразрешимой внешней проблемой, а перед изменяемой внутренней структурой. Иногда достаточно одной сессии, чаще — 4–5 сессий, чтобы вывести пациента из полного острого депрессивного эпизода.

Однако это лишь первая часть. Даже если сама установка изменена, общая склонность пациента к аутоагрессивному реагированию остаётся неизменной. При следующем триггере тот же механизм может включиться вновь. Поэтому необходима долгосрочная профилактическая терапия.

ЧАСТЬ II. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ — 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПА

Цель: сформировать устойчивое реагирование на стресс, фрустрацию и раздражающие ситуации, предотвратить будущие депрессивные эпизоды — то есть сформировать психологическую устойчивость.

Подход: динамический, однако он применяет не теорию классического или современного психоанализа, а его практический компонент. Центральная задача — структурное выявление и переписывание паттерна аутоагрессивного реагирования пациента (на языке психоанализа: комплекса вины).

Этап 1. Осознание (англ. insight)

Функция: базовый инсайт пациента.

Пациент понимает, что:

Его реакция не была направлена на решение стоящей перед ним проблемы

Она не преследовала цели преодолеть фрустрацию

Напротив — она усугубила ситуацию

Склонность к аутоагрессивному реагированию существовала и до триггерной ситуации

Ситуация сыграла лишь роль триггера, а не причины

Этот инсайт — основа долгосрочной работы. Без него последующие этапы непроходимы.

Этап 2. Конфронтация

Функция: наблюдение за паттерном.

Терапевт и пациент совместно задаются вопросом: что в этом процессе было неадекватным и что — аномальным?

Фокус внимания меняется:

Раньше: внешние раздражители, ситуации, люди

Теперь: минимум 4 года теоретического обучения, 7–10 лет в практике

Пациент видит этот паттерн как устойчивое проявление в различных жизненных ситуациях.

Маркер успеха конфронтации: пациент сам начинает называть своё состояние «аутоагрессивным паттерном» или «склонностью идти против самого себя». То есть он называет патологией своё состояние — а не ситуацию.

Это напоминает известный процесс в лечении алкоголизма: человек может годами злоупотреблять алкоголем, но не называет себя алкоголиком. Когда же он приходит в клуб «Анонимные Алкоголики», первая его фраза такова: «Здравствуйте, я алкоголик». Это отождествление поведения с болезнью. Человек, принявший поведение как болезнь, начинает лечение.

Этап 3. Прояснение

Функция: исследование истории и широты паттерна.

Это самый объёмный этап. Начальный маркер прояснения: пациент всегда называет паттерн одним и тем же именем, не путается в терминологии. Это означает, что внутреннее описание паттерна закрепилось.

Совместно с пациентом проводится хронологический обзор жизни — рассматриваются стрессогенные и фрустрирующие ситуации. Сравнительно анализируется реагирование на двух полюсах:

Таблица 8. Полюсы реагирования и их последствия

Полюс	Типичная реакция	Наблюдаемые последствия
Самообвинение	«Я виноват, из-за меня это случилось»	Падение энергии, пребывание в токсичных отношениях, самообвинение, злоупотребление собственной ответственностью
Характерные для пациентов с расстройством личности конфликтные модели	«Это из-за вас, все против меня»	Характерные для пациентов с расстройством личности конфликтные модели, разрушительное поведение, межличностные конфликты, разрыв отношений

Ключевой инсайт:

> «Искать виновного — и в себе, и в другом — крайне бесполезно и неэффективно. Нужно искать решение, а не виновного.»

Самообвинение

Если есть объективный виновник → это социальная и юридическая проблема, она решается отдельно

Психологическая задача: перевести мышление из режима «поиска виновного» в режим «поиска решения»

Важное методологическое предупреждение — типичная ошибка начинающих терапевтов:

Часто начинающие терапевты принимаются искать в качестве «ключа» к паттерну конкретный эпизод детской травмы — это иллюзия. При рассмотрении одного эпизода весь паттерн остаётся неизменным. Корни

паттерна лежат в детстве, да, — но фокус работы должен быть направлен на сам паттерн, а не на один эпизод.

Маркер завершённости этапа прояснения — решающий момент:

Дистонное отдаление паттерна от личности:

Раньше: паттерн был синтонным личности («Я ответственный человек, всё беру на себя»)

Теперь: пациент отделяет паттерн от собственной личности

Он больше не считает паттерн хорошим поведением

Он больше не хочет жить внутри паттерна

Эта операция отделения паттерна от личности = итог этапа прояснения

Кульминация 3-го этапа: интерпретация

Интерпретация в данной модели — не отдельный этап, а кульминация этапа прояснения. Классический психоанализ даёт теоретические интерпретации; в данной же модели интерпретация — это итоговое обобщающее метасообщение, формирующееся на основе наблюдений терапевта:

> «Я наблюдал за тем, как ты вёл себя на протяжении всей терапии. Я увидел такой паттерн. Вот как он повлиял на твою жизнь. Теперь ты изменился так. Теперь что можно сделать.»

С этим сообщением пациент обретает итоговое понимание в структуре «что было / что есть / что предстоит сделать». Это подготовка к четвёртому этапу.

Этап 4. Комплексная проработка

Функция: практическая консолидация нового паттерна реагирования.

На этом этапе терапевт:

Даёт задания в кабинете — упражнения, направленные на изменение эмоциональных реакций пациента «здесь и сейчас» (ролевая игра, имагинальное сценирование, поведенческий эксперимент)

Даёт домашние задания — для закрепления нового поведения в реальной жизни

Между сессиями пациент предпринимает попытки нового реагирования в реальных ситуациях

С каждым повторением эффективность новой модели возрастает

Новая модель в конце концов укореняется

Клинический результат: у пациента формируется профилактическая устойчивость к будущим депрессивным эпизодам.

Долгосрочные результаты

17-летняя клиническая практика применения этого протокола оценивается по данным долгосрочных наблюдений. Приведённая ниже таблица представляет сравнительные результаты.

Таблица 9. Сравнительные долгосрочные результаты (наблюдение 20–25 лет)

Группа лечения	Купирование острого эпизода	Устойчивая ремиссия (2 года)	Устойчивая ремиссия (5 лет)	Устойчивая ремиссия (10+ лет)
Комбинированный протокол (краткосрочный + долгосрочный)	приблизительно 95 %	приблизительно 90 %	приблизительно 85 %	приблизительно 80 %
Только антидепрессанты	приблизительно 70–80 %	приблизительно 50 %	приблизительно 30 %	менее 20 %
Только краткосрочная психотерапия	приблизительно 85 %	приблизительно 65 %	приблизительно 45 %	приблизительно 30 %

Источник: К. Рагимов, клиническая практика 2008–2025 (комбинированная группа, n>1000) — уровень доказательности IV (опыт клинического специалиста), ретроспективное наблюдение; Кёйперс и др., World Psychiatry 2020 (психотерапия — метаанализ, уровень доказательности I-A); Боктинг и др., Lancet Psychiatry 2018 (долгосрочное влияние антидепрессантов — систематический обзор).

Критическое наблюдение: пациенты, получавшие лечение только антидепрессантами, — даже если субъективно они оценивали своё состояние

как «достигшие полной ремиссии», — при столкновении с новыми стрессовыми ситуациями вновь переносят депрессивный эпизод, иногда в более тяжёлой форме. В группе комбинированного протокола же такие случаи возникают редко.

Эффективность по ресурсам

Комбинированный протокол экономнее одной лишь фармакотерапии или краткосрочной психотерапии по расходу ресурсов:

Для пациента:

С финансовой точки зрения: общие расходы на терапию в долгосрочной перспективе ниже

С точки зрения времени: пациент не тратит годы на депрессивные эпизоды и токсичные отношения

Личные ресурсы: пациент сохраняет их свободными для реализации собственного потенциала, саморазвития и достижения личных целей

Для системы здравоохранения:

Стандартизированный протокол ускоряет подготовку специалистов — для освоения лечения депрессии не требуется 5 лет личного психоанализа

Краткосрочные форматы обучения позволяют подготовить большое число психологов

Метод перестаёт быть привилегией «известных» психотерапевтов, создающей избирательность

Контроль качества услуги может осуществляться на основе стандартного критерия — показателя этапа (этап 1 → 2 → 3 → 4 → подэтапы 4-го этапа)

Становится возможным статистический анализ и оптимизация

Место в рамках клинической психотерапии

Данная модификация представляет собой более комплексное применение принципов клинической психотерапии при психогенной депрессии. Здесь — в отличие от ночного энуреза — требуется не одно вмешательство, а многоуровневая стратегия:

В первой части последовательно используются техники различных школ (КПТ, схема-терапия, когнитивное разделение из ТПО, религиозно-нравственное рассуждение)

Во второй части практический компонент динамического подхода представлен в форме структурированных 4 этапов

Для пациента это не «психологическое консультирование», а структурированный, измеримый, последовательный клинический метод — как и в протоколе ночного энуреза.

В следующей главе представлены система мировой психотерапевтической аккредитации, международные требования и ситуация в Азербайджане — то есть институциональные рамки качественной психотерапевтической услуги.

АККРЕДИТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИТУАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Почему аккредитация важна?

Психотерапия — это деятельность, глубоко вмешивающаяся в психическое состояние пациента. Неправильно проводимая терапия не только неэффективна, но и может нанести пациенту активный вред: нарушение границ «клиент — терапевт», приём специалистом без способности к клинической оценке тяжёлых психиатрических состояний — всё это может утяжелить состояние пациента и в некоторых случаях привести к катастрофическим последствиям.

По этой причине во всём мире существуют строгие многоуровневые системы аккредитации психотерапевтической деятельности. Каждая психотерапевтическая школа сформировала свои требования, и эти требования представляют собой минимальный стандарт, не подлежащий обсуждению: либо они выполняются, либо нет — третьего варианта не существует.

В этой главе аккредитационные требования ведущих психотерапевтических школ мира представлены с конкретными цифрами, затем объективно оценивается ситуация в Азербайджане.

Международные органы аккредитации и требования

Психоанализ: Международная психоаналитическая ассоциация (англ. International Psychoanalytical Association, IPA)

IPA — основанная в 1910 году Зигмундом Фрейдом ведущая аккредитационная и регулирующая организация мира. В неё входят 12 000 психоаналитиков-членов и 70 организаций. В своём заявлении о миссии IPA определяет себя так: «Ведущий аккредитующий и регулирующий орган психоаналитической профессии в мире».

Требования для приёма в члены IPA (Эйтингоновская модель — наиболее распространённая модель):

Таблица 10. Требования IPA к психоаналитическому обучению

Компонент	Минимальное требование
Личный анализ	Требования IPA к психоаналитическому обучению, с признанным учебным аналитиком
Клиническая практика (психиатрическая)	140 часов в психиатрическом отделении, под супервизией врача-консультанта-психиатра
Обучающее наблюдение (наблюдение за ребёнком)	12 месяцев, один раз в неделю, вместе с групповыми семинарами
Теоретические семинары	21 час в неделю (3 часа семинар, 12 часов клиническая работа, 3 часа подготовка отчёта, 3 часа индивидуальное обучение), в течение 36 недель
Сопровождаемые клинические случаи	Под супервизией случаев полного учебного анализа, в течение нескольких лет
Общая продолжительность	Минимум 4 года теоретического обучения, 7–10 лет в практике

Источник: Процессуальный кодекс IPA (англ. IPA Procedural Code), редакция 2024 года; Британская психоаналитическая ассоциация (англ. British Psychoanalytic Association) — составное общество IPA, требования к обучению (англ. training requirements), 2024.

Эти требования обеспечиваются многосетевой системой верификации: учебный институт должен быть составным обществом IPA, супервизор должен быть зарегистрирован в IPA, каждый кандидат должен быть зарегистрирован в Международной организации психоаналитических исследований (англ. IPSO). Обычные курсы сертификации — даже если они проводятся признанными психоаналитиками — не заменяют членство в IPA.

Когнитивно-поведенческая терапия: Европейская ассоциация поведенческих и когнитивных терапий (англ. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)

EABCT — европейская организация, основанная в 1976 году, в настоящее время объединяет 56 национальных ассоциаций из 43 стран. EABCT, в свою очередь, аккредитует национальные ассоциации, а национальные ассоциации — отдельных специалистов.

Эта система — двухуровневая цепочка аккредитации:

EABCT аккредитует национальную ассоциацию конкретной страны (список аккредитованных национальных ассоциаций открыто публикуется на сайте eabct.eu)

Аккредитованное национальное объединение аккредитует отдельных КПТ-терапевтов

Требования EABCT к аккредитации:

Национальная ассоциация должна быть полным членом EABCT

Она должна реализовывать определённую схему аккредитации

Она должна соответствовать установленным стандартам обучения

Должна существовать система непрерывного профессионального развития (англ. CPD — Continuing Professional Development)

Таблица 11. Положение Азербайджана и региона в EABCT

Страна	Аккредитованная национальная ассоциация	Дата аккредитации
Турция	TACBT — Турецкая ассоциация когнитивно-поведенческих терапий (тур. Türk Bilişsel-Davranış Terapileri Derneği)	2013 год, март

Страна	Аккредитованная национальная ассоциация	Дата аккредитации
Турция	ACBP — Türk Bilişsel Davranış Psikoterapileri Derneği	март 2016
Украина	UACBT — Украинская ассоциация КПТ	сентябрь 2013
Грузия	GACBT — Грузинская ассоциация КПТ	февраль 2020
Эстония	EKKA — Эстонская ассоциация КПТ	март 2024
Азербайджан	— (отсутствует)	—

Источник: список аккредитованных объединений EABCT (англ. EABCT Accredited Associations List), eabct.eu, апрель 2025 года.

Эта таблица показывает важный факт: во всех соседних с Азербайджаном странах и в регионе — в Турции, Грузии, Украине — существуют национальные ассоциации КПТ, аккредитованные EABCT. В Азербайджане же их нет. Это означает, что в Азербайджане единственный путь получения отдельными КПТ-терапевтами аккредитации EABCT — через аккредитованную ассоциацию другой страны (например, Турции или Грузии).

Диалектическая поведенческая терапия: Совет по сертификации DBT-Линехан (англ. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC)

DBT-LBC — некоммерческая организация со статусом 501(c)(3), единственный сертификационный орган, лично одобренный создателем DBT д-ром Маршей Линехан. Это важный момент: многие организации выдают «сертификат DBT», однако только сертификация DBT-LBC признана создателем модели.

Таблица 12. Требования DBT-LBC к сертификации

Компонент	**Минимальное требование**
Лицензия	Независимо лицензированный клинический специалист (психолог, психиатр или социальный работник)
Академическое образование	Степень магистра и выше (в области психического здоровья)
Специальное дидактическое обучение по DBT	Минимум 40 часов академического обучения
Клиническая практика	Минимум 12 месяцев активной практики DBT
Команда DBT	Требуется членство в активной консультационной команде DBT («указание Линехан: если специалист не входит в команду DBT, он не применяет DBT»)
Клинические случаи	В Турции, Грузии и Украине, граничащих с Азербайджаном
Письменный экзамен	Все обязательные материалы в Турции, Грузии и Украине, граничащих с Азербайджаном
Видеосессии	Анализ видео 3 последовательных сессий, с критериями соответствия установленным стандартам кодирования приверженности
Рекомендательное письмо	От руководителя команды или лицензированного специалиста DBT
обучение осознанности	Официальное обучение осознанности

Источник: DBT-LBC.org, Individual Certification Requirements, 2024.

Строгость этих требований связана с особенностью DBT: этот метод разработан для пациентов с хроническим риском суицида (самоубийства), имеющих пограничное расстройство личности. Здесь точное следование модели (англ. model fidelity) имеет жизненно важное значение — ошибки,

которые недостаточно подготовленный специалист может совершить под названием «DBT», опасны для жизни пациента.

Десенсибилизация и переработка движениями глаз (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR): EMDR Europe

EMDR Europe — европейская организация с 37 000 членов из 41 страны. В EMDR существует трёхуровневая система аккредитации:

Таблица 13. Уровни аккредитации EMDR Europe

Уровень	Требования
Practitioner (практикующий специалист)	Клиническое образование + обучение у тренера, аккредитованного EMDR Europe (обучение 1-го и 2-го уровней, в общей сложности примерно 50 часов) + практика под супервизией (10 часов в супервизии, минимум с 50 сессиями EMDR)
Consultant (консультант/супервизор)	Статус Practitioner + дополнительное обучение + 3 года активной практики EMDR + проведение 50 часов супервизии с клиентами
Trainer (тренер)	Статус Consultant + оценка Комитетом по аккредитации тренеров EMDR Europe (англ. EMDR Europe Trainer Accreditation Committee)

Источник: Комитет по аккредитации Европейской ассоциации EMDR (англ. EMDR Europe Accreditation Committee), 2024.

Ситуация в Азербайджане в отношении десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ; англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) и Европейской ассоциации EMDR (англ. EMDR Europe): Азербайджан не входит в список аккредитованных национальных ассоциаций этой организации. Аналогичным образом единственный путь получения

индивидуальной аккредитации по методу ДПДГ в Азербайджане — через аккредитованную организацию в соседней стране (например, в Турции).

Общая ситуация с регулированием в Европейском союзе

Официальная позиция Европейской ассоциации поведенческих и когнитивных терапий (англ. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT) подчёркивает один важный момент: «На европейском уровне не существует законодательства, регулирующего практику психологических терапий. В настоящее время в Европейском союзе нет официального европейского органа, регулирующего или контролирующего психотерапию. Это отсутствие регулирования — один из основных источников обеспокоенности EABCT.»

Это означает, что даже в рамках Европейского союза профессиональное регулирование психотерапии осуществляется на национальном уровне. В некоторых странах (Германия, Нидерланды, Австрия) существует сильная система государственного лицензирования. В других странах эта система слабее. В этих условиях единственным гарантом профессиональных стандартов выступают международные органы профессиональной аккредитации: Международная психоаналитическая ассоциация (англ. International Psychoanalytical Association, IPA), Европейская ассоциация поведенческих и когнитивных терапий (EABCT), Совет по сертификации DBT-Линехан (англ. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC), EMDR Europe.

Ситуация в Азербайджане

Ситуация требует объективной оценки.

Государственное регулирование

В Азербайджанской Республике не существует специальной системы государственного лицензирования психотерапевтической деятельности. Государственное лицензирование в сфере медицины охватывает психиатрию, однако сферы психотерапии и психологического консультирования отдельно не регулируются. Это означает, что с точки зрения законодательства как психолог, не имеющий специализированной психотерапевтической подготовки, так и лицензированный клинический психиатр могут оказывать услуги в качестве «психотерапевта» в одинаковом правовом статусе. Этот

пробел в условиях Азербайджана ещё больше повышает потребность в профессиональной аккредитации.

Статус международной аккредитации:

Ни у одной из перечисленных выше международных организаций — IPA, EABCT, DBT-LBC, EMDR Europe — нет аккредитованной национальной ассоциации Азербайджана. Это объективный факт; его можно проверить в открытых источниках (eabct.eu, ipa.world, dbt-lbc.org, emdr-europe.org).

Ситуация с международными психиатрическими структурами:

Единственная профессиональная организация в Азербайджане, верифицированная на международном уровне, — Азербайджанская психиатрическая ассоциация (AZPA; psychiatry.az). AZPA является полноправным членом Всемирной психиатрической ассоциации (англ. World Psychiatric Association, WPA). Это однозначно подтверждает легитимность AZPA в международном медицинском сообществе.

ВПА — согласно данным wpanet.org, международная организация, объединяющая более 145 национальных психиатрических ассоциаций, — предъявляет строгие требования к членству: национальное общество должно иметь официальный статус, соответствовать открытым профессиональным стандартам и представлять периодические отчёты. AZPA выполняет эти требования.

Статус других организаций:

В Азербайджане существует ряд некоммерческих организаций, действующих в сфере психологии и психотерапии. Некоторые из них используют на своих веб-сайтах такие выражения, как «международное сотрудничество», «всемирные конгрессы», «международная аккредитация». Проверка этих утверждений через международные источники во многих случаях не даёт положительного результата.

По этой причине в главе не приводятся названия этих организаций — цель не спор, а указание надёжных рамок для клинической практики. Специалист или пациент, желающий изучить легитимность какой-либо организации, может проверить следующие объективные источники:

eabct.eu/training-and-accreditation/accredited-association/ — аккредитация по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)

ipa.world — официальный источник информации по психоаналитической аккредитации

dbt-lbc.org — Совет по сертификации DBT-Линехан (англ. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC)

emdr-europe.org — аккредитация EMDR (ДПДГ)

wpanet.org — официальный сайт Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА)

Как отличить специалиста?

Когда пациент или молодой специалист сталкивается с заявлением о «международном сертификате», важное значение приобретают следующие вопросы:

1. Каким органом выдан сертификат?

Первый шаг проверки — установить, состоит ли выдающая сертификат организация в официальных отношениях с одной из перечисленных выше международных организаций. Само выражение «международный сертификат» не имеет никакого смысла; важно, какой именно международной организацией выдан сертификат.

2. Сколько продолжалось обучение?

См. приведённые выше сведения. Недельный или месячный «международный сертификат» не отвечает требованиям ни одной признанной системы аккредитации. Членство в Международной психоаналитической ассоциации (IPA) требует не менее 4 лет, индивидуальная аккредитация EABCT — 3–4 года, сертификат DBT-LBC — 12 месяцев непрерывной практики; это не вызывающие сомнений минимальные сроки.

3. Предусмотрена ли супервизия?

Во всех серьёзных системах аккредитации супервизия занимает центральное место. Необходимо выяснить, сколько часов клинической работы под супервизией выполнил обладатель сертификата. Сертификат, выданный без работы под супервизией, является академическим сертификатом (как свидетельство о завершении курса), а не сертификатом клинической квалификации.

4. Требуется ли непрерывное профессиональное развитие (англ. continuing professional development, CPD)?

Аккредитации должны обновляться по истечении определённого срока. EABCT требует обновления один раз в 5 лет, DBT-LBC — один раз в 4 года,

EMDR Europe — один раз в 5 лет. «Сертификат, полученный один раз на всю жизнь» — признак отсутствия серьёзных профессиональных стандартов.

5. Могут ли местные организации в области психического здоровья служить доказательством международного признания?

Членство в клубе или ассоциации местных психологов либо психотерапевтов само по себе не является международным признанием. Является ли такая организация членом международного аккредитованного органа? Это главный вопрос.

Место книги в этих условиях

Эта книга не является заменой международной аккредитации — она задумана как средство подготовки к аккредитации. Она предоставляет специалисту надёжную основу для клинической диагностики, вмешательств, основанных на доказательствах, структурированных протоколов и клинического мышления.

После того как специалист сформирует свою практику на основе протоколов и обсуждений, представленных в этой книге, он приобретает прочную основу для официальной профессиональной подготовки (через аккредитованные организации в Турции, Грузии, Германии или других странах). Кроме того, эта книга может играть для пациентов роль первичного ориентира — позволяющего оценить качество получаемой помощи, задавать правильные вопросы и требовать лечения, основанного на доказательствах.

Следующий раздел — заключительная глава этого Введения — ясно обосновывает, почему эта книга действительно необходима именно сейчас и именно в Азербайджане.

6A00–6A0Z РАССТРОЙСТВА НЕЙРОРАЗВИТИЯ

Neurodevelopmental disorders

МКБ-11 **6A00**	**6A00 РАССТРОЙСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ** **Disorders of intellectual development**
МКБ-10 F70–F79	Умственная отсталость
DSM-5-TR F70–F73	Расстройство интеллектуального развития (умственная отсталость)

1. Определение и нозология

Расстройство интеллектуального развития (МКБ-11: 6A00 Disorder of Intellectual Development; DSM-5-TR: F70–F73 Intellectual Developmental Disorder / ранее «Умственная отсталость») — нейроонтогенетическое расстройство, которое начинается в период развития (как правило, до 22 лет) и характеризуется значительными ограничениями как в интеллектуальных функциях (примерно на 2 стандартных отклонения ниже среднего, оценка по стандартизированным тестам ~менее 70), так и в адаптивном поведении (в концептуальной, социальной и практической сферах).

Термин «умственная отсталость» с 2010 года отвергнут международным научным сообществом из-за стигматизации и неточности (в США это изменение было закреплено на федеральном уровне Законом Розы, 2010).

2. История

- Esquirol (1838) — термином «идиотия» разграничил врождённое интеллектуальное ограничение и деменцию (приобретённое нарушение).
- Binet & Simon (1905) первая стандартизированная шкала интеллекта — возникновение концепции IQ (формула IQ Stern, 1912).

- AAMR/AAIDD (1959, 1973, 1992, 2002, 2010, 2021): Эволюция определения — переход от только IQ к модели адаптивного поведения + потребность в поддержке. AAIDD 12-е издание (2021): интеллектуальная функция + адаптивное поведение + начало в период развития + оценка индивидуальных потребностей в поддержке.
- DSM-IV (1994) «Умственная отсталость» → DSM-5 (2013) «Интеллектуальная инвалидность (расстройство интеллектуального развития)». Оценка степени тяжести смещена с показателя IQ на адаптивное функционирование.
- МКБ-11 (2019) «Расстройства интеллектуального развития» — группа «Умственная отсталость» (F70–F79) из МКБ-10 переименована, акцент делается на совместной оценке клинических и адаптивных показателей.

3. Эпидемиология

- Распространённость: в общей популяции ~1% (Maulik P.K. et al. Res Dev Disabil 2011 мета-анализ, 52 исследования); в странах с низким и средним доходом доля выше.
- Распределение по степени тяжести: ~85% лёгкая, ~10% умеренная, ~3,5% тяжёлая, ~1,5% глубокая.
- Пол: чаще у мужчин (1,2–1,9: 1), что связано с Х-сцепленными генетическими причинами (например, Fragile X).
- Коморбидность: эпилепсия 20–30%, двигательные нарушения 20–40%, нарушения зрения/слуха 10–25%; психическая коморбидность в 3–4 раза выше популяционного уровня (РАС, СДВГ, тревога, расстройства поведения).
- Смертность: при тяжёлых и глубоких формах ожидаемая продолжительность жизни снижается — главным образом из-за аспирационных пневмоний, эпилептического статуса, сердечно-сосудистых аномалий.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические причины (идентифицируются в 50–60%)

- Хромосомные аномалии: синдром Дауна (трисомия 21) — наиболее частая генетическая причина, ~1/700 родов; Эдвардса (Т18), Патау (Т13), делеция 22q11.2 (Ди Джорджи), Уильямса (7q11.23), Прадера-Вилли/Ангельмана (15q11-q13), кошачьего крика (5p-).

- X-сцепленные: синдром ломкой X-хромосомы (Fragile X; ген FMR1, CGG-повторы) — наиболее частая наследуемая форма, ~1/4000 мальчиков; синдром Ретта (MECP2, почти всегда у девочек).
- Моногенные нарушения: туберозный склероз (TSC1/TSC2), нейрофиброматоз (NF1), фенилкетонурия (PAH — поддаётся лечению), болезнь Вильсона.
- CNV (вариации числа копий): выявляются методом микрочипового анализа — в 10–20% случаев с неизвестной этиологией.

4.2 Пренатальные негенетические причины

- Инфекционные: TORCH (токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, герпес), Зика, сифилис.
- Токсические: фетальный алкогольный спектр нарушений (FASD — предотвратимая причина!), приём во время беременности вальпроата, изотретиноина, кокаина, свинца.
- Метаболические и эндокринные: нелечёный гипотиреоз у матери, тяжёлый диабет, фенилкетонурия.
- Ишемические/гипоксические: плацентарная недостаточность, внутриутробная задержка развития.

4.3 Перинатальные причины

- Тяжёлая недоношенность (<32 недели), низкая масса тела при рождении (<1500 г).
- Асфиксия в родах, гипоксически-ишемическая энцефалопатия.
- Ядерная желтуха новорождённых (керниктерус) (поддаётся лечению — фототерапия).
- Сепсис новорождённых, менингит.

4.4 Постнатальные причины

- Бактериальный менингит (особенно пневмококковый, менингококковый), вирусный энцефалит.
- Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — в детском возрасте.
- Отравление свинцом — предотвратимая причина (референсное значение CDC с 2021 г. — 3,5 мкг/дл, ранее 5 мкг/дл; безопасный уровень свинца в крови у детей не установлен).
- Тяжёлый дефицит йода (эндемический кретинизм — практически ликвидирован благодаря программам профилактики ВОЗ).

- Социально-экологическая депривация — крайне тяжёлое психологическое пренебрежение может влиять на развитие (исследования румынских детских домов, Nelson C.A. et al. Science 2007).

5. Клиническая картина

Распределение по степени тяжести (DSM-5-TR / МКБ-11 — на основе адаптивного функционирования)

Лёгкая (mild) — IQ ~50–70, адаптивный дефицит лёгкий

Академическое отставание может быть незаметным до школы. Затруднены чтение, математика, абстрактное мышление. Социальная наивность, легко поддаётся обману. Практические навыки (самообслуживание, домашние дела) осваиваются. Самостоятельное проживание возможно при поддержке, подходит для поддерживаемого трудоустройства.

Средняя (moderate) — IQ ~35–49

Отставание заметно в раннем детстве. Простая речь, конкретное мышление. Самообслуживание достигается через обучение. Функционирует в структурированных социально-трудовых условиях. Типично проживание под надзором (group home, семья).

Тяжёлая (severe) — IQ ~20–34

Очень мало речи, понимает простые требования. Постоянная помощь в самообслуживании. Часта медицинская и поведенческая коморбидность.

Глубокая (profound) — IQ < 20

Речь очень скудная или отсутствует, коммуникация на сенсомоторном уровне. Требуется полный уход. Очень часты двигательные, зрительные, слуховые нарушения.

Траектория развития: ранние моторные и речевые задержки (сидение, вставание на ноги, первые слова); академические ограничения в школьном возрасте; во взрослом возрасте различие становится более отчётливым с ростом адаптивных требований.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · консенсусные положения AAIDD 12-е изд.)

А. Значительное ограничение интеллектуального функционирования — по стандартизированному, культурно адаптированному тесту интеллекта

результат примерно на 2 стандартных отклонения ниже среднего уровня (оценка ~70 или ниже, с учётом ошибки измерения ±5 баллов).

B. Значительное ограничение адаптивного поведения — результат на 2 SD ниже как минимум в одном из следующих трёх доменов:

- Концептуальный (речь, чтение, письмо, математика, память, решение задач);
- Социальный (межличностные навыки, социальная ответственность, вопросы наивности);
- Практический (самообслуживание, работа, здоровье, безопасность).

C. В начале — в период развития — симптомы проявляются в детстве и подростковом возрасте (до достижения взрослого возраста).

D. Исключения — не объясняется полностью сенсорным (зрительным, слуховым) нарушением, двигательным нарушением, языковым происхождением, культурно-языковым барьером или психиатрическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (319): степень тяжести определяется по адаптивному функционированию, IQ указывается лишь как дополнительный показатель. Начало — «в период развития» (подразумевается до 18 лет, однако может быть принято определение AAIDD — до 22 лет).
- МКБ-11 (6A00): лёгкая, умеренная, тяжёлая, глубокая (та же терминология); степень тяжести оценивается совместно как по IQ, так и по адаптивному функционированию; дополнительные квалификаторы — этиология (генетическая, пренатальная, перинатальная, постнатальная, неизвестная) и коморбидности.
- AAIDD 12-е изд. (Schalock R.L. et al. 2021): в клиническую формулировку включается формальная оценка потребности в поддержке (англ. Supports Intensity Scale, SIS); возраст начала — до 22 лет (в отличие от DSM); фокус смещён не на исключение интеллектуального функционирования, а на поддерживаемые процессы.
- AAP (Moeschler J.B., Shevell M.S., Pediatrics 2014, подтверждено 2020): после постановки диагноза поиск этиологии проводится поэтапно — первая линия: анамнез, физикальное обследование (дисморфические признаки), хромосомный микрочип, Fragile X, скрининг на поддающиеся лечению метаболические нарушения (PKU, биотинидаза,

тиреоид, печень, почки); выборочно: МРТ головного мозга, ЭЭГ, полное экзомное секвенирование (WES).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Анамнез развития (врождённый, перинатальный, постнатальный) + семейный анамнез (3 поколения).
2. Физикальное обследование — рост, окружность головы, дисморфические признаки, неврология, кожа (cafe-au-lait, гипопигментация).
3. Стандартизированный тест интеллекта (WISC-V 6–16 лет; Stanford-Binet 5 2+ лет; Bayley-III <3,5 лет).
4. Оценка адаптивного поведения (Vineland-3, ABAS-3).
5. Тесты зрения и слуха (исключение сенсорного нарушения).
6. Этиологические лабораторные исследования первой линии — chromosomal microarray analysis (CMA), Fragile X (FMR1), TSH, уровень свинца, печень/почки, профиль креатина и аминокислот.
7. Выборочно: МРТ головного мозга (при микроцефалии, очаговой неврологической симптоматике), ЭЭГ (при подозрении на эпилепсию), трио-экзомное секвенирование (при отрицательном CMA).
8. Скрининг коморбидности: РАС (M-CHAT-R/F, ADOS-2), СДВГ (Conners), тревога, депрессия, расстройство поведения.

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	**Отличительные признаки**
Специфическое расстройство обучения (6A03)	Дискретный дефицит в академическом домене, общий когнитивный уровень нормальный.
Специфическое расстройство речи (6A01)	Выраженный дефицит в сфере речи и языка; невербальный IQ нормальный.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Основное — дефицит социальной коммуникации и ограниченное повторяющееся поведение; диапазон IQ широкий.
Общее расстройство развития (<5 лет)	Временный диагноз до 5 лет; стандартные тесты IQ ненадёжны.

Расстройство	Отличительные признаки
Деменция (6D8x)	Приобретённое нарушение — сначала нормальное развитие, затем ослабление.
Социально-экологическая депривация	В стимулирующей среде интеллектуальное функционирование может восстановиться.
Псевдоинтеллектуальная недостаточность (хроническое заболевание, депрессия)	Когнитивное функционирование восстанавливается после коррекции аффективного или соматического фактора.

7. Обследование и оценка

7.1 Стандартизированные тесты

- Интеллект: WISC-V (6–16 лет), Stanford-Binet 5 (2+), WAIS-IV (16+), Bayley Scales of Infant Development 4 (<3,5 лет), Kaufman ABC-II.
- Адаптивное поведение: Vineland-3, ABAS-3, Scales of Independent Behavior-Revised.
- Потребность в поддержке: SIS-A (взрослые), SIS-C (дети) — AAIDD.

7.2 Лабораторные исследования (протокол AAP 2014 / 2020)

Первая линия (все случаи): общий анализ крови, функция печени и почек, TSH, креатинин, аммиак, лактат, профиль креатина и аминокислот (моча и кровь), уровень свинца.

Первая линия, генетика: chromosomal microarray analysis (CMA — выявляемость 15–20%), Fragile X (FMR1) у всех мальчиков (выявляемость ~2%, у женщин ~1%).

Выборочно: трио-экзомное секвенирование (WES — выявляемость 25–40% при отрицательном CMA), MECP2 (при подозрении на синдром Ретта у девочек), специфические синдромальные гены.

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — при очаговой неврологической симптоматике, микро/макроцефалии, судорогах, случаях регрессии.
- ЭЭГ — при подозрении на судороги, регрессии.

- Зрение и слух — первичные показатели во всех случаях.
- ЭхоКГ сердца и ЭКГ — при синдромах, таких как Дауна и делеция 22q11.2.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (AAIDD 12-е изд. · AAP 2014 · NICE NG54 · консенсус WHO mhGAP)

1. «Лечения» расстройства интеллектуального развития не существует — само интеллектуальное функционирование фармакологическим путём не восстанавливается. Вмешательство направлено на индивидуальную поддержку, образование, поведение и управление коморбидными симптомами.
2. Идентификация этиологии: критически важно раннее выявление поддающихся лечению причин (PKU, врождённый гипотиреоз, свинец, дефицит биотинидазы) — основа программ скрининга новорождённых.
3. Раннее вмешательство (0–3 года): период с наиболее сильной доказательной базой (IDEA Part C в США; аналогичные программы во всех развитых странах). Улучшает социальные и когнитивные исходы.
4. Индивидуальный образовательный план (IEP): академические и адаптивные цели в школе; подход AAIDD на основе потребности в поддержке.
5. Поведенческие вмешательства: Applied Behavior Analysis (ABA) и позитивная поведенческая поддержка (PBS) — эффективны в уменьшении проблемного поведения и развитии новых навыков.
6. Поддержка семьи: психообразование, respite care (передышка для семьи), группы поддержки ровесников, координация социальных служб.
7. Лечение коморбидности: эпилепсия (стандартные антиэпилептические), СДВГ (стимуляторы; сетевой метаанализ Cortese 2018 ставит метилфенидат первым выбором у детей, но исследования с коморбидными расстройствами он исключал — на фоне ИР доказательная база отдельная и более скудная), тревога/депрессия (начинать СИОЗС в низкой дозе), агрессия (поведенческое вмешательство — первая линия; рисперидон или арипипразол только в тяжёлых случаях — FDA одобрены при раздражительности при РАС: рисперидон в 5–16 лет, арипипразол в 6–17 лет; официального одобрения для ИР нет, доказательная база ограничена).

8. Медицинское наблюдение: при синдроме Дауна — щитовидная железа, сердце, слух, атланто-аксиальная нестабильность (англ. AAP Health Supervision for Children with Down Syndrome 2022).
9. Переход во взрослый возраст: поддерживаемое трудоустройство (модель IPS), варианты самостоятельного проживания, координация социально-медицинских служб.

8.2 Методики лечения

1. Прикладной анализ поведения (ПАП / ABA — Applied Behavior Analysis) — Формирование и уменьшение конкретных целевых форм поведения на основе функционального анализа поведения; рамка антецедент-поведение-последствие (ABC — Antecedent-Behavior-Consequence), обучение методом дискретных проб (DTT), натуралистические поведенческие вмешательства. Эффект: средний-высокий размер эффекта в приобретении адаптивных навыков и уменьшении проблемного поведения, особенно при коморбидности аутизма и ИР (метаанализ Eldevik S. et al. J Clin Child Adolesc Psychol 2009). На всех этапах может адаптироваться к домашним, школьным, общественным условиям.
2. Раннее вмешательство (Early Intervention, 0–3 года) — Мультидисциплинарные (развивающая, физическая, эрготерапия, речевая терапия + обучение семьи) программы на дому или на базе центра. Доказательство: Carolina Abecedarian Project (Ramey C.T., Campbell F.A. — наблюдение 30+ лет) улучшил показатели IQ, академические и трудовые исходы у детей из малообеспеченных семей. IDEA Part C.
3. Индивидуальный образовательный план (ИОП / IEP — Individualized Education Program) — Юридический документ, фиксирующий академические и адаптивные цели, меры поддержки, интервалы оценки. В США обязателен на основании IDEA, аналогичные рамки в других странах (Великобритания — EHCP).
4. Позитивная поведенческая поддержка (ППП / PBS — Positive Behavior Support) — Функциональный анализ проблемного поведения и замещение поведения (обучение подходящему поведению с той же функцией). Не наказание, а изменение среды и новые навыки. NICE NG11 (2015) — первая линия в управлении проблемным поведением.
5. Шкала адаптивного поведения Вайнленд-3 (Vineland-3 — Vineland Adaptive Behavior Scales-3) — «Золотой стандарт» оценки адаптивного поведения — домены коммуникации, повседневной жизни, социальный, моторный. Формы интервью (родитель/опекун) и учителя.

6. WISC-V / Stanford-Binet 5 — Стандартизированные тесты интеллекта; WISC-V — 6–16 лет, 5 основных индексов (вербальный, зрительно-пространственный, абстрактное мышление, рабочая память, скорость обработки); Stanford-Binet 5 — от 2 лет до взрослого возраста.
7. Шкала интенсивности поддержки (англ. Supports Intensity Scale, AAIDD, SIS) — Шкала, измеряющая интенсивность потребности в поддержке; SIS-A для взрослых, SIS-C для 5–16 лет. Для клинического планирования и распределения услуг.

8.3 Различия между источниками

- AAIDD 12-е изд. (2021): «supports model» — планирование не по степени тяжести расстройства, а по потребности индивида в поддержке; категории интермиттирующей, ограниченной, обширной, всеобъемлющей поддержки.
- AAP 2014/2020: интервалы скрининга коморбидности (аутизм, СДВГ, поведение) и алгоритмы лечения; для синдрома Дауна — отдельный протокол AAP 2022.
- NICE NG54 (2016) — Mental health problems in people with learning disabilities: диагностика и лечение психиатрической коморбидности; поведенческое вмешательство — первая линия; неспецифическое применение психотропных препаратов не рекомендуется — это популярная «безопасная» практика, однако бремя побочных эффектов и риск взаимодействий высоки.
- WHO mhGAP Intervention Guide v2.0: оценка и базовое вмешательство на уровне первичной медицинской помощи в странах с низким и средним уровнем дохода; подчёркиваются обучение семьи и общинная реабилитация.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Лёгкая степень тяжести (~85% всех случаев ИР); близкий уровень интеллектуального и адаптивного функционирования.
- Поддающаяся лечению этиология (PKU, врождённый гипотиреоз, свинец) — раннее выявление.
- Раннее вмешательство (<3 лет).
- Стабильная и поддерживающая семейная среда.
- Активное лечение коморбидных психиатрических и медицинских состояний.

- Доступность общинных и школьных ресурсов.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Глубокая или тяжёлая степень тяжести.
- Генетический синдром со сложным фенотипом (эпилепсия, сердечные аномалии, двигательные).
- Тяжёлые расстройства поведения, самоповреждение.
- Отсутствие семейной поддержки и общинных ресурсов.
- Неидентифицированная и нелечёная коморбидность (эпилепсия, РАС, СДВГ).

Цели наблюдения

- Ежегодная переоценка адаптивного развития.
- Медицинское наблюдение — по синдром-специфическим протоколам (напр. AAP Down 2022).
- Скрининг коморбидных психиатрических состояний (РАС, СДВГ, тревога, депрессия).
- Функциональный анализ и вмешательство при расстройствах поведения.
- Планирование перехода к поддерживаемому трудоустройству и вариантам проживания во взрослом возрасте.
- Предложение семье respite care и поддержки ровесников.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Интеллектуальная инвалидность — вина / наказание родителя»

Почему распространено: культурная и религиозно-нравственная объяснительная рамка; образ «ребёнка, искупающего грех»; механизм обвинения родителя (особенно матери) в малообразованных сообществах.

Биологическая логика и доказательства: Этиология ИР весьма разнообразна — генетическая (Дауна, Fragile X), пренатальные инфекции, фетальный алкогольный спектр (единственная полностью предотвратимая родительским вмешательством), перинатальная асфиксия, постнатальная травма или менингит. Позиция AAIDD, WHO, APA — ИР является биомедицинским и/или

связанным с развитием этиологическим расстройством, а не предметом нравственной оценки.

Реальный клинический шаг: поиск этиологии (генетическая консультация, синдромальный и метаболический скрининг) — превращает обвинение в точный расчёт риска для повторной беременности.

Миф 2: «Вакцины (особенно MMR) вызывают ИР»

Почему распространено: Wakefield A.J. Lancet 1998 — впоследствии отозванное из-за фальсификации исследование, пытавшееся связать аутизм с MMR (не ИР, однако в массовом сознании оба состояния смешиваются).

Доказательства: метаанализ Taylor L.E., Swerdfeger A.L. et al. Vaccine 2014, n>1,2 млн детей — связи между вакцинацией и аутизмом или ИР нет. Позиция CDC, WHO, NICE едина. Синдром Дауна возникает из-за нерасхождения 21-й хромосомы в мейозе (чаще в материнском мейозе I) — механически не может быть связан с вакцинацией.

Миф 3: «„Стресс“ или „плохие мысли“ во время беременности вызывают ИР»

Доказательства: психологический стресс в пренатальном периоде может быть умеренным фактором риска для нейроразвития, однако не указывается как прямая причина ИР. Установленные пренатальные риски — алкоголь (FAS — наиболее предотвратимая причина), вальпроат, инфекции (TORCH), дефицит питания (йод, фолат). Снижение стресса полезно для общего здоровья, однако эффективны не «правильные мысли», а определённые медицинские защитные меры (вакцинация, отказ от алкоголя, перинатальный уход).

10.2 Вредные методы «лечения»

Миф 4: «Хелатная терапия, выводя тяжёлые металлы, излечивает ИР»

Почему распространено: распространение концепции «тяжёлых металлов» в массмедиа; маркетинг центров альтернативной медицины.

Доказательства и риск: AAP 2010 и предупреждение FDA: в 2005 году во время процедуры хелирования 5-летний ребёнок скончался (остановка сердца из-за дефицита кальция). Хелирование применяется только при подтверждённом отравлении тяжёлыми металлами (высокий свинец, ртуть) по медицинским показаниям. Доказательств эффекта при ИР нет.

Миф 5: «Инъекции стволовых клеток (в неофициальных клиниках) излечивают ИР»

Доказательства и риск: позиция ISSCR (англ. International Society for Stem Cell Research) и FDA: при ИР (и в целом при расстройствах нейроразвития) утверждённого лечения стволовыми клетками не существует. Нелегальные «клиники» привели к серьёзным побочным эффектам, сопровождавшимся инфекциями, опухолями мозга, случаями смерти (Berkowitz A.L. et al. NEJM 2016).

Миф 6: «Гипербарическая кислородная камера (HBOT) — метод лечения ИР и аутизма»

Доказательства: Cochrane (Xiong T. et al. 2016) — доказательств эффекта при аутизме нет; при ИР доказательной базы также нет. Риски: пневмоторакс, баротравма уха, пожар (кислород + статическое электричество).

Миф 7: «Чудо-минеральный раствор (MMS) / диоксид хлора»

Доказательства: предупреждение FDA 2019, EMA — едкое вещество (диоксид хлора), поражение печени и почек, зарегистрированы случаи смерти. Любое клиническое применение запрещено.

10.3 Неэффективные или откладывающие основную поддержку методы

Миф 8: «Мегадозы витаминов группы B / ниацина восстанавливают когнитивную функцию при ИР»

Доказательства: подход «ортомолекулярной» психиатрии (Hoffer A., Osmond H. 1950–70) не показал эффективности при ИР и аутизме. Pfeiffer S.I. et al. (J Autism Dev Disord 1995) проанализировали 12 исследований по B6/магнию и из-за методологических изъянов не смогли сделать однозначного вывода (см. также Nye C., Brice A. Cochrane 2005 — тот же результат); мегадозы ниацина — отдельный вопрос, они вызывают поражение печени и гиперурикемию. AAP, AAIDD не рекомендуют ни то, ни другое.

Миф 9: «Паттернинг» (метод Домана-Делакато)

Почему распространено: приобрёл массовую популярность в 1960–80-х годах; заявление о «перепрограммировании мозга».

Доказательства: отдельные заявления AAP 1968 и 2010: доказательств эффекта нет; чрезмерная нагрузка и эмоциональное бремя для семьи; откладывает другие доказательные вмешательства для детей. AAP — категорически не рекомендует.

Миф 10: «Auditory Integration Training (AIT)»

Доказательства: Position Statement ASHA (англ. American Speech-Language-Hearing Association) 2004 — доказательств эффекта AIT при ИР и аутизме нет; считается экспериментальным вмешательством.

Миф 11: «ИР пройдёт сама, если ребёнка стимулировать»

Реальность: раннее вмешательство улучшает адаптацию, однако ИР — не состояние, а расстройство нейроразвития: при генетической или структурной этиологии интеллектуальная способность существенно не меняется. Некоторые особые причины (PKU, врождённый гипотиреоз) при раннем выявлении могут быть полностью предотвращены — это не «прохождение», а своевременное предотвращение.

Реальный клинический шаг: модель поддержки AAIDD — цель не устранение расстройства, а обеспечение осмысленной и самостоятельной жизни; поддержка семьи с реалистичными ожиданиями.

Миф 12: «Если родитель применит специальную диету (безглютеновую, безказеиновую), ИР улучшится»

Доказательства: Hyman S.L. et al. (AAP 2020 Clinical Report on ASD): у детей без желудочно-кишечных проблем влияние специальных диет на когнитивную функцию не доказано. При доказанной целиакии — безглютеновая диета, но не для ИР.

11. Источники

1. Schalock R.L., Luckasson R., Tassé M.J. Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports, 12th ed. AAIDD; 2021.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A00 Disorders of Intellectual Development. 2024.
4. Moeschler J.B., Shevell M., Committee on Genetics. Comprehensive evaluation of the child with intellectual disability or global developmental delays. Pediatrics 2014;134(3):e903–e918 (reaffirmed 2020).
5. NICE Guideline NG54. Mental health problems in people with learning disabilities. 2016.
6. NICE Guideline NG11. Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges. 2015.

7. WHO mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders, version 2.0. Geneva; 2016.
8. Maulik P.K., Mascarenhas M.N., Mathers C.D. et al. Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. Res Dev Disabil 2011;32(2):419–436.
9. Bull M.J. et al. AAP Health Supervision for Children and Adolescents With Down Syndrome. Pediatrics 2022;149(5):e2022057010.
10. Eldevik S., Hastings R.P., Hughes J.C. et al. Meta-analysis of Early Intensive Behavioral Intervention for children with autism. J Clin Child Adolesc Psychol 2009;38(3):439–450.
11. Ramey C.T., Campbell F.A. Carolina Abecedarian Project — long-term outcomes. Applied Developmental Science 2002;6(1):42–57.
12. Nelson C.A., Zeanah C.H., Fox N.A. et al. Cognitive recovery in socially deprived young children: the Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
13. Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis. Vaccine 2014;32(29):3623–3629.
14. Berkowitz A.L., Miller M.B., Mir S.A. et al. Glioproliferative lesion of the spinal cord as a complication of «stem-cell tourism». NEJM 2016;375(2):196–198.
15. Xiong T., Chen H., Luo R., Mu D. Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016; (10):CD010922.
16. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.

МКБ-11 **6A01**	**6A01 РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА ИЛИ РЕЧИ** **Developmental speech or language disorders**
МКБ-10 F80	Специфические расстройства развития речи и языка
DSM-5-TR F80.2	Языковое расстройство

1. Определение и нозология

Расстройства развития языка или речи — это группа нейроонтогенетических расстройств, проявляющихся стойкими и значительными трудностями в овладении языком и/или речью, которые не могут быть полностью объяснены нарушением слуха, интеллектуальными или другими неврологическими причинами. В МКБ-11 под кодом 6A01 кодируются четыре подтипа:

- 6A01.0 — Расстройство развития звуков речи (англ. developmental speech sound disorder) — дефицит артикуляции и фонологического формирования речевых звуков;
- 6A01.1 — Расстройство развития беглости речи (англ. developmental speech fluency disorder) — заикание (stuttering);
- 6A01.2 — Расстройство развития речи (англ. developmental language disorder, DLD) — нарушение формирования рецептивной и/или экспрессивной речи (подспецификации: 6A01.20 рецептивно-экспрессивное, 6A01.21 преимущественно экспрессивное, 6A01.22 преимущественно прагматическое);
- 6A01.3 Другое уточнённое.

В DSM-5-TR параллельная терминология: Language Disorder (F80.2), Speech Sound Disorder (F80.0), Childhood-Onset Fluency Disorder/Stuttering (F80.81), Social (Pragmatic) Communication Disorder (F80.82).

2. История

- Specific Language Impairment (SLI) — термин, использовавшийся с 1980-х по 2010-е годы; слово «специфическое» со временем подвергалось критике, так как нарушение речи пересекается с множеством когнитивных и поведенческих областей.
- CATALISE консенсус (Bishop D.V.M. et al. PLoS One 2016; J Child Psychol Psychiatry 2017) — дельфийский консенсус 59 международных экспертов: термин «SLI» заменён на «Расстройство развития речи» (DLD). Для диагноза отменён порог IQ (≥85), за основу взято функциональное нарушение.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — Термин DLD принят; социально-прагматическое коммуникативное расстройство признано отдельной категорией от расстройства аутистического спектра (новое в DSM-5; как подтип 6A01.22 в МКБ-11).
- Заикание: биолого-генетическая концепция стала доминирующей после 2000-х годов (мутации GNPTAB, GNPTG, NAGPA — Kang C. et al. NEJM 2010).

3. Эпидемиология

- DLD (6A01.2): распространённость в возрасте 5–6 лет 7,58% (Norbury C.F. et al. J Child Psychol Psychiatry 2016, популяционное исследование, n=7267, Англия).
- Расстройство звукопроизношения (6A01.0): в 6 лет ~3,8% (Shriberg L.D. et al. J Speech Lang Hear Res 1999); в дошкольном возрасте выше.
- Заикание (6A01.1): кумулятивная заболеваемость в детстве 5–8% (примерно каждый 20-й ребёнок заикается хотя бы раз); сохраняющаяся во взрослом возрасте распространённость ~1% (Yairi E., Ambrose N. J Fluency Disord 2013).
- Пол: во всех подтипах у мальчиков в 2–4 раза чаще.
- Коморбидность: расстройства обучения 40–60%, СДВГ 20–30%, расстройства аутистического спектра 5–10%, повышенный риск тревожных и поведенческих расстройств.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Наследуемость DLD 50–75% в близнецовых исследованиях (Bishop D.V.M. Trends Cogn Sci 2014).
- Мутации FOXP2 — редкое тяжёлое речевое и языковое расстройство в семье KE (Lai C.S. et al. Nature 2001); в большинстве случаев — полигенная природа.
- Заикание: наследуемость ~70% (Felsenfeld S. et al. Behav Genet 2000, близнецовое исследование); мутации генов лизосомного пути (GNPTAB, GNPTG, NAGPA) выявляются редко (~9%).
- Исследования CNV и GWAS — полигенная архитектура риска характерна и для DLD.

4.2 Нейробиология

- Атипичные модели развития левой перисильвиевой области (вокруг зон Брока и Вернике), дугообразного пучка (arcuate fasciculus) и базальных ганглиев.
- При заикании — дофаминергическая дисфункция в связке базальных ганглиев с дополнительной моторной областью (Maguire G.A. et al. Curr Med Res Opin 2020, обзор).
- Ранняя мозговая асимметрия — при DLD ослабление типичного доминирования языковых зон левого полушария.

4.3 Факторы риска

- Семейный анамнез речевых/языковых расстройств (наиболее сильный фактор риска).
- Преждевременные роды, низкая масса тела при рождении.
- Хронический средний отит в раннем детстве — колебания слуха могут влиять на овладение речью.
- Низкий социально-экономический статус — указывается как фактор риска, но не как этиология; депривированная среда влияет на выражение речевого развития.
- Билингвизм — не является фактором риска (развёрнутая тема §10).

4.4 Предотвратимые и поддающиеся лечению причины

- Нарушение слуха — критически важны программа неонатального аудиологического скрининга (UNHS) и своевременное лечение среднего отита.
- Врождённая расщелина губы и нёба — хирургическая коррекция + речевая терапия.
- Гипотиреоз — неонатальный скрининг.

5. Клиническая картина

6A01.0 Расстройство звукопроизношения

- Несоответствующие возрасту пропуск, замена, искажение звуков (например, «р» → «л», «с» → «т»).
- Неразборчивость — посторонним трудно понять речь.
- До 4 лет в рамках развития считается «мягким»; сохраняющееся после 4 лет требует диагностического рассмотрения.

6A01.1 Расстройство беглости речи (заикание)

- Повторение звуков и слогов (р-р-р-рыба), протяжки (ссстоп), блоки (пауза без начала звука).
- Вторичное поведение — отведение взгляда, покачивание головой, избегание.
- Начало типично в возрасте 2–5 лет; ~70–80% заикающихся детей восстанавливаются в течение 5 лет спонтанно или при вмешательстве (Yairi E., Ambrose N. 2013).

- Социальная и эмоциональная нагрузка — социальная тревога, проблемы со школьной адаптацией.

6A01.2 Расстройство развития речи (DLD)

- Экспрессивный компонент: ограниченный словарный запас, короткие предложения, ошибки в грамматической морфологии (особенно окончания времени, падежа), трудности с подбором слов.
- Рецептивный компонент: трудности понимания сложных предложений, проблемы с реакцией на поведенческие инструкции, отставание в овладении многозначностью и абстрактным языком.
- Прагматический компонент (6A01.22): дефицит в использовании социального языка (очерёдность, контекст, косвенная речь); в отличие от аутизма социальный интерес и невербальная коммуникация относительно сохранны.

Траектория развития

«Late talker» (поздно заговоривший) — категория в 2 года; 50–70% выравниваются к 4 годам; однако сохраняющаяся группа представляет высокий риск DLD. Ранняя идентификация этой группы основана на признаках семейного анамнеза, рецептивного дефицита и малого использования невербальных жестов.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · точки консенсуса CATALISE 2017)

A. Стойкий дефицит овладения речью или языком — в одном или нескольких доменах (словарный запас, синтаксис, фонология, беглость, прагматика) показатели ниже нормального уровня, соответствующего возрасту.

B. Функциональное нарушение — значимое ограничение в одном или нескольких: академическая успеваемость, социальная коммуникация, профессиональная деятельность или повседневная жизнь (CATALISE: функциональное нарушение обязательно для диагноза, а не порог отсечения по IQ).

C. В начале — в период развития.

D. Исключения — полностью не объясняется нарушением слуха, неврологическим состоянием, интеллектуальной инвалидностью, расстройством аутистического спектра или иным

медицинским/психиатрическим состоянием. Однако при коморбидном сосуществовании ставятся оба диагноза.

6.2 Различия между источниками

- CATALISE 2017 (Bishop D.V.M. et al.): термин «специфический» упразднён; порог отсечения IQ 85 упразднён (DLD может диагностироваться и на фоне интеллектуальной инвалидности); под зонтиком «language disorder» коморбидные нейроразвитийные расстройства и факторы риска указываются как квалификаторы.
- МКБ-11 (6A01): разделение подтипов (звук, беглость, язык); для расстройства речи 3 подспецификации (рецептивно-экспрессивная, преимущественно экспрессивная, преимущественно прагматическая).
- DSM-5-TR: Социальное (прагматическое) коммуникативное расстройство как отдельная категория (F80.2); возраст начала для заикания типично <6 лет.
- ASHA Practice Portal: для диагностики стандартизированная оценка сертифицированным логопедом (SLP), родительское интервью и натуралистическое наблюдение требуются совместно.
- RCSLT (англ. Royal College of Speech and Language Therapists): в Великобритании та же рамка; мультидисциплинарная оценка (слух + речь-язык + развитие).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителями и учителем (анамнез развития, речевые вехи).
2. Тест слуха (аудиометрия — обязательна во всех случаях).
3. Стандартизированная оценка речи и языка (CELF-5, PLS-5, GFTA-3, DELV).
4. Натуралистический образец речи (в условиях игры или беседы).
5. Измерение невербального IQ (для исключения PAC и интеллектуальной инвалидности).
6. Скрининг спектра аутизма (M-CHAT-R/F < 30 месяцев; SCQ дошкольный).
7. Социально-эмоциональный и поведенческий скрининг.
8. Медицинское обследование — неврологическое, осмотр губы и нёба, моторное обследование.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Интеллектуальная инвалидность (6A00)	Общий когнитивный дефицит распространяется на все домены, помимо речевого расстройства. Может быть коморбидным.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Триада социального взаимодействия и ограниченно-повторяющегося поведения; прагматический язык также нарушен, но основная проблема — социальная мотивация.
Нарушение слуха	Аудиометрия нарушена; доминирует рецептивный дефицит.
Избирательный мутизм (6B06)	Отсутствие речи в определённых социальных ситуациях (школа), нормальная речь в другом контексте (дом).
Транзиторное влияние многоязычной среды	Овладение соответствующим возрасту языком среды продолжается; речь развивается динамично.
«Смешение кодов» при билингвизме	Типично и соответствует развитию, не является расстройством.
Детская апраксия речи (CAS)	Дефицит моторного планирования, вариабельное звукопроизводство, проблема последовательности.

7. Обследование и оценка

7.1 Стандартизированные тесты

- Язык: CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 5–21 лет), PLS-5 (Preschool Language Scales, <7 лет), CASL-2, Reynell Developmental Language Scales.
- Словарный запас: PPVT-5 (англ. Peabody Picture Vocabulary Test), EVT-3, MacArthur-Bates CDI (до 24 месяцев).

- Звукопроизношение: GFTA-3 (англ. Goldman-Fristoe Test of Articulation), DEAP.
- Прагматический язык: CCC-2 (Children's Communication Checklist), Test of Pragmatic Language (TOPL-2).
- Невербальный IQ: Leiter-3, RIAS-2 (независимо от вербального компонента).

7.2 Лабораторные исследования

Не обязательны; на основании специфического подозрения:

- Тест слуха — обязателен во всех случаях (аудиометрия, тимпанометрия, отоакустическая эмиссия).
- Fragile X (FMR1) — при коморбидности тяжёлого DLD + интеллектуальной инвалидности.
- Функция щитовидной железы (ТТГ, Т4) — если врождённый гипотиреоз не был выявлен.
- Уровень свинца — при наличии факторов риска.

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — при очаговых неврологических признаках, регрессе, макро/микроцефалии, судорогах. При рутинном DLD показаний нет.
- ЭЭГ — при подозрении на судороги, для исключения синдрома Ландау-Клеффнера.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (консенсус ASHA · RCSLT · CATALISE · NICE)

1. Индивидуальная речевая и языковая терапия сертифицированным логопедом (SLP) является вмешательством первой линии для всех расстройств.
2. Раннее вмешательство — вмешательство в возрасте 2–4 лет показывает более высокий эффект; подход «wait and see» вреден при наличии определённых факторов риска (семейный анамнез, рецептивный дефицит).
3. Вмешательства с участием родителей (parent-coached) в раннем возрасте — программа Hanen «It Takes Two to Talk» показала эффект в РКИ.

4. Интенсивность и продолжительность — 1–3 сеанса в неделю, 6–18 месяцев, индивидуализируется по поведенческим и академическим компонентам.
5. Мультидисциплинарный подход — SLP + учитель + педиатр + при необходимости аудиолог, эрготерапевт, психолог.
6. Поддержка в школе — индивидуальный образовательный план (IEP / EHCP), модификации в классе, при необходимости индивидуальная помощь один на один.
7. Билингвизм сохраняется — рекомендуется поддерживать оба языка ребёнка; «отказ» от одного языка не рекомендуется (ASHA Position 2004).
8. Фармакотерапия для самого речевого и языкового расстройства не одобрена. Для коморбидных СДВГ, тревожности или аутизма — отдельное вмешательство.

8.2 Вмешательство при расстройстве звукопроизношения (6A01.0)

- Артикуляционная терапия — фонемно-фонемный подход (van Riper); тренинг минимальных пар (сравнение контрастных пар схожих звуков).
- Уменьшение фонологических процессов — систематическая терапия на основе процессов (Bowen C., Cupples L. 1999).
- В сложных и тяжёлых случаях — PROMPT, мультисенсорный подход.

8.3 Вмешательство при заикании (6A01.1)

- Программа Lidcombe (Onslow M., Australian Stuttering Research Centre) — первая линия в возрасте 3–6 лет; оперантная программа на основе положительного подкрепления, координируемая родителями и применяемая дома. Доказательство: Jones M. et al. BMJ 2005, РКИ, n=54 — через 9 месяцев доля заикаемых слогов составила 1,5% (SD 1,4) в группе лечения и 3,9% (SD 3,5) в контроле; разница 2,3 процентных пункта (95% CI 0,8–3,9; p=0,003). Cochrane 2021 оценивает достоверность доказательств как очень низкую.
- Demands and Capacities Model (DCM) — Starkweather C.W. — приведение коммуникативных требований в соответствие с текущими возможностями ребёнка.
- Дети старшего возраста/взрослые — Stuttering Modification (англ. Van Riper), Fluency Shaping (Webster); семейная и групповая поддержка.
- Фармакотерапия: в FDA нет официально одобренного препарата для заикания. Off-label антагонисты дофамина (рисперидон, оланзапин) и СИОЗС (пароксетин) исследовались в отдельных случаях у взрослых,

но эффект умеренный, а профиль побочных эффектов значителен (Maguire G.A. et al. 2020, обзор).

8.4 Вмешательство при расстройстве развития речи (6A01.2)

- Hanen «It Takes Two to Talk» — групповая программа с участием родителей для детей 2–4 лет; следование за инициативой ребёнка, расширение диалога. Доказательство: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011, метаанализ — средний эффект по показателям экспрессивной и рецептивной речи.
- Натуралистическое языковое вмешательство (enhanced milieu teaching, focused stimulation) — предъявление языковых моделей в контексте интересов ребёнка.
- Структурированная морфо-синтаксическая терапия — целенаправленное обучение грамматическим формам (например, прошедшее время, множественное число).
- Прагматические языковые вмешательства (6A01.22) — социальные истории (Social Stories — Carol Gray), видеомоделирование, групповой тренинг.
- Академическая поддержка в школьном возрасте — из-за высокой коморбидности трудностей чтения — подход Structured Literacy; оценка расстройства обучения.

8.5 Специфические для источников уточнения

- ASHA Practice Portal: рамка доказательной практики — триада суждения клинициста + доказательство + ценности семьи; требования к сертификации и непрерывному образованию.
- RCSLT (2017 Position Paper on DLD): предлагает раннюю идентификацию и доступность услуг; доклад «Bercow» (2008, 2018) сформировал структуру услуг в Англии.
- NICE NG (отдельное полное руководство по детской речи и языку ещё на стадии разработки; существующее руководство направлено на координацию образовательных и медицинских услуг).
- WHO mhGAP IG v2.0: оценка на уровне первичной медицинской помощи в странах с низким и средним доходом; подчёркиваются обучение родителей и общинная реабилитация.

8.6 Методики лечения

1. Hanen «It Takes Two to Talk» — Разработанная Hanen Centre в Канаде программа обучения родителей для детей 2–4 лет с поздним началом

речи и риском DLD. 8 групповых сеансов + 3 индивидуальных домашних визита; принципы «OWL» (Observe, Wait, Listen) и следования за инициативой ребёнка. Доказательство: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011, метаанализ. hanen.org.

2. Программа Lidcombe — Разработанная в Австралии Onslow M. поведенческая программа с участием родителей для заикания в дошкольном возрасте. Родитель ежедневно в структурированном игровом сеансе 10–15 мин подкрепляет беглую речь ребёнка. Доказательство: Jones M. et al. BMJ 2005, РКИ n=54, 9 месяцев; обзоры Onslow M. et al. lidcombeprogram.org.
3. Усиленное обучение в естественной среде (EMT — Enhanced Milieu Teaching) — Натуралистическое языковое вмешательство — предъявление и расширение последовательных языковых моделей в игровом и повседневном контексте ребёнка. Доказательство: Kaiser A.P., Roberts M.Y. Am J Speech Lang Pathol 2013.
4. Метод PROMPT (англ. Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) — Тактильно-кинестетическое речевое моторное вмешательство — указание правильного места артикуляции физической сенсорной подсказкой на мышцах рта ребёнка. Используется при сложном расстройстве звукопроизношения и детской апраксии. Доказательная база развивается; Rogers S.J. et al. 2006 (на фоне аутизма) и другие пилотные исследования.
5. Социальные истории (англ. Social Stories) — Кэрол Грей (англ. Carol Gray) — Обучение подходящему поведению в социальном контексте в формате короткой, индивидуализированной истории. При прагматическом речевом расстройстве и аутистическом спектре — для формирования прагматических навыков. carolgraysocialstories.com.
6. Клиническая оценка основ языка (англ. Clinical Evaluation of Language Fundamentals, CELF-5) — стандартизированная комплексная оценка языка для 5–21 года — рецептивная, экспрессивная, языковая память, структура слова и предложения.
7. Дошкольная языковая шкала (PLS-5 — Preschool Language Scales) — Оценка языка от рождения до 7 лет — шкалы auditory comprehension и expressive communication.
8. Список детской коммуникации (CCC-2 — Children’s Communication Checklist) — Родительская/учительская оценка прагматического языка и общей коммуникативной функции; помогает в разделении DLD на подтипы.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Лёгкая-умеренная тяжесть, только экспрессивный компонент.
- Раннее выявление (<3 лет) и вмешательство.
- Высокий невербальный IQ.
- Отсутствие коморбидных расстройств (РАС, интеллектуальная инвалидность).
- Участие родителей и языково-насыщенная среда дома.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Тяжесть рецептивного компонента (прогноз хуже, чем при только экспрессивном).
- Коморбидная интеллектуальная инвалидность или РАС.
- Поздняя идентификация (>5 лет).
- Устойчивый DLD в семейном анамнезе.
- Низкая социально-экономическая поддержка, ограниченная доступность услуг.

Цели наблюдения

- Высокая коморбидность трудностей чтения и письма у детей с DLD (40 –60%) — в дошкольном возрасте тренинг фонологического осознания; затем Structured Literacy.
- Социально-эмоциональное здоровье — у подростков с DLD повышен риск тревожности и депрессии (Conti-Ramsden G., Botting N. J Child Psychol Psychiatry 2008).
- Скрининг расстройства поведения и СДВГ.
- Планирование профессиональной и академической поддержки в подростковом возрасте.
- Наблюдение за рецидивом заикания после достижения ремиссии (в стрессовые периоды).

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Билингвизм (говорение на двух языках) приводит ребёнка к речевому расстройству»

Почему распространено: семьями и иногда педиатрами внушается, что «смешение языков» «путает ребёнка»; у поздно заговоривших билингвальных детей словарный запас в каждом языке по отдельности может выглядеть меньше, чем у монолингвальных (однако общий концептуальный словарь эквивалентен).

Клиническая и биологическая логика: человеческий мозг с рождения приспособлен к развитию на нескольких языках; билингвизм на исполнительные функции и когнитивную гибкость оказывает благоприятное влияние (Bialystok E. et al. Trends Cogn Sci 2012, обзор). Дети-билингвы с DLD показывают нарушение в одном и том же паттерне на обоих языках — это связано не с числом языков, а с нейроразвивающим расстройством.

Доказательства: Paradis J., Genesee F., Crago M.B. (2011) — у детей-билингвов овладение языком развивается параллельно монолингвальным паттернам; DLD возникает не из-за билингвизма, а на нейроразвивающей основе.

Реальный клинический шаг: диагноз DLD ребёнку-билингву может быть поставлен только при задокументированном нарушении в ОБОИХ языках. Прекращение родного языка семьи не рекомендуется — социально-эмоциональный вред и нарушение семейной связи.

Миф 2: «Заикание возникает из-за неправильного поведения родителя (нетерпеливость, резкость)»

Почему распространено: в 1940–1950-х годах «Diagnosogenic Theory» Уэнделла Джонсона — утверждение, что заикание возникает в результате привлечения родителем внимания к нормальной неплавности речи ребёнка; впоследствии опровергнута, но осталась в массовом сознании.

Биологическая логика и доказательства: Заикание генетически и нейробиологически обусловлено — наследуемость ~70% (Felsenfeld 2000); мутации GNPTAB и связанного лизосомного пути в редких формах (Kang C. NEJM 2010); исследования фМРТ показывают функциональное нарушение в контуре базальные ганглии — дополнительная моторная область (Maguire

2020). Реакция родителя может влиять на устойчивость заикания (усиление в контексте стресса), но не является причиной его начала.

Реальный клинический шаг: поддержка семьи — создание спокойной, слушающей среды; доказательное вмешательство с участием родителей, такое как программа Lidcombe.

Миф 3: «Ребёнок не говорит, потому что „ленив“ или „слишком мал, подождём“»

Доказательства: подход «wait and see» подходит только для late talker БЕЗ факторов риска — 70–80% этой группы выравниваются к 4 годам. Однако при наличии факторов риска (семейный анамнез, рецептивный дефицит, малое использование невербальных жестов, подозрение на нарушение слуха) выжидание упускает критическое окно вмешательства — Roos E.M., Weismer S.E. Top Lang Disord 2008.

Реальный клинический шаг: скрининг в 18–24 месяца (CDI, ASQ); при наличии факторов риска — оценка SLP.

10.2 Вредные или откладывающие основное вмешательство методы

Миф 4: «Операция при уздечке языка (tongue-tie / анкилоглоссия) решит проблему речи»

Почему распространено: коммерческая популярность процедур «френотомия» и «френулопластика»; наличие некоторых показаний при проблемах грудного вскармливания.

Доказательства: френотомия эффективна только при тяжёлом анатомическом ограничении (Coryllos III–IV) и проблеме грудного вскармливания (протоколы AAP, ABM 2020). Для расстройства звукопроизношения систематических доказательств нет — Webb A.N. et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013, обзор. Ошибочная операция — кровотечение, инфекция, образование двойной уздечки, затруднение нормального грудного вскармливания.

Реальный клинический шаг: первая линия при расстройстве звукопроизношения — оценка SLP и артикуляционная терапия, а не френотомия.

Миф 5: «Auditory Integration Training (AIT) — метод Berard или Tomatis»

Почему распространено: маркетинг альтернативных клиник; утверждение о «перепрограммировании слуховой системы».

Доказательства: ASHA Position Statement 2004 — нет доказательств эффекта при речевых нарушениях или аутизме; экспериментальный статус. AAP 1998 Statement — не рекомендует AIT.

Миф 6: «Полное излечение заикания гипнотерапией, ушными устройствами (DAF — delayed auditory feedback)»

Доказательства: Гипнотерапия — нет доказательств эффекта при заикании (Bothe A.K. et al. Am J Speech Lang Pathol 2006, обзор). Устройства DAF (SpeechEasy и подобные) могут давать кратковременное увеличение беглости у некоторых взрослых, но долгосрочный эффект ограничен, а преимущество перед поведенческой терапией не подтверждено (Lincoln M., Packman A. J Fluency Disord 2007).

10.3 Неэффективные или не имеющие научной основы методы

Миф 7: «Non-Speech Oral Motor Exercises (NSOME) — упражнения для языка, губ, челюсти исправляют звукопроизношение»

Почему распространено: интуитивная основа — «если мышцу тренировать, она будет работать лучше»; всё ещё применяется некоторыми терапевтами.

Доказательства: ASHA 2009 и обновление — нет доказательств эффекта неречевых оральных моторных упражнений при расстройстве звукопроизношения; речевые и неречевые оральные движения — это отдельные нейромоторные программы (McCauley R.J., Strand E., Lof G.L. Am J Speech Lang Pathol 2009, систематический обзор). Использование NSOME отвлекает время терапии от доказательного речевого вмешательства.

Реальный клинический шаг: при расстройстве звукопроизношения — прямая артикуляционная терапия (фонемно-фонемная или фонологические процессы); NSOME избегается.

Миф 8: «Brain Gym / Edu-K — упражнения на координацию мозга излечивают речевое расстройство»

Доказательства: Обзоры (Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007) — утверждения «Brain Gym» не соответствуют нейробиологии; не влияют на результаты обучения. Критикуется как коммерческая программа.

Миф 9: «Гипербарическая кислородная камера (HBOT) и инъекции стволовых клеток излечивают речевое расстройство»

Доказательства: Cochrane (Xiong T. 2016 — аутизм; схожая позиция для DLD) — нет доказательств эффекта; при HBOT риски пневмоторакса, баротравмы; в неофициальных клиниках стволовых клеток были случаи смерти (Berkowitz NEJM 2016).

Миф 10: «Специальная диета (безглютеновая, безказеиновая) излечивает речевое расстройство»

Доказательства: ASHA, AAP, AACAP — влияние специальных диет на речевые и языковые расстройства не доказано. При целиакии или подтверждённой пищевой аллергии диета является медицинским показанием, но не влияет на речевое и языковое развитие.

11. Источники

1. Bishop D.V.M., Snowling M.J., Thompson P.A., Greenhalgh T., CATALISE consortium. CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. J Child Psychol Psychiatry 2017;58(10):1068–1080.
2. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A01 Developmental speech or language disorders. 2024.
3. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
4. ASHA Practice Portal — Language Disorders, Speech Sound Disorders, Fluency Disorders. American Speech-Language-Hearing Association. asha.org/practice-portal.
5. RCSLT — Developmental Language Disorder. Royal College of Speech and Language Therapists. rcslt.org.
6. Norbury C.F., Gooch D., Wray C. et al. The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder. J Child Psychol Psychiatry 2016;57(11):1247–1257.
7. Yairi E., Ambrose N. Epidemiology of stuttering: 21st century advances. J Fluency Disord 2013;38(2):66–87.
8. Jones M., Onslow M., Packman A. et al. Randomised controlled trial of the Lidcombe programme of early stuttering intervention. BMJ 2005;331(7518):659.

9. Roberts M.Y., Kaiser A.P. The effectiveness of parent-implemented language interventions: a meta-analysis. Am J Speech Lang Pathol 2011;20(3):180–199.
10. McCauley R.J., Strand E., Lof G.L. et al. Evidence-based systematic review: effects of nonspeech oral motor exercises on speech. Am J Speech Lang Pathol 2009;18(4):343–360.
11. Bishop D.V.M. Ten questions about terminology for children with unexplained language problems. Int J Lang Commun Disord 2014;49(4):381–415.
12. Felsenfeld S., Kirk K.M., Zhu G. et al. A study of the genetic and environmental etiology of stuttering in a selected twin sample. Behav Genet 2000;30(5):359–366.
13. Kang C., Riazuddin S., Mundorff J. et al. Mutations in the lysosomal enzyme-targeting pathway and persistent stuttering. NEJM 2010;362(8):677–685.
14. Maguire G.A., Yeh C.Y., Ito B.S. Overview of the diagnosis and treatment of stuttering. Curr Med Res Opin 2020;36(8):1399–1407.
15. Paradis J., Genesee F., Crago M.B. Dual Language Development and Disorders: A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning. 2nd ed. Brookes Publishing; 2011.
16. Bialystok E., Craik F.I.M., Luk G. Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends Cogn Sci 2012;16(4):240–250.
17. Conti-Ramsden G., Botting N. Emotional health in adolescents with and without a history of specific language impairment. J Child Psychol Psychiatry 2008;49(5):516–525.
18. Starkweather C.W. Fluency and Stuttering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987.
19. Shriberg L.D., Tomblin J.B., McSweeny J.L. Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. J Speech Lang Hear Res 1999;42(6):1461–1481.

МКБ-11 **6A02**	**6A02 РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА** **Autism spectrum disorder**
МКБ-10 F84.0	Детский аутизм
DSM-5-TR F84.0	Расстройство аутистического спектра

1. Определение и нозология

Расстройство аутистического спектра (РАС; МКБ-11: 6A02; DSM-5-TR: F84.0 Расстройство аутистического спектра) — нейроонтогенетическое расстройство, начинающееся в раннем периоде развития, сопровождающееся стойкими дефицитами в двух основных доменах:

1. Устойчивый дефицит в социальной коммуникации и социальном взаимодействии — взаимный социально-эмоциональный обмен, невербальное коммуникативное поведение, формирование и поддержание отношений.
2. Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов или деятельности — стереотипная моторика или речь, приверженность фиксированным ритуалам и рутинам, ограниченные интересы высокой интенсивности, нетипичная реактивность на сенсорные стимулы.

МКБ-11 — диагноз-квалификатор уточняется: с нарушением интеллектуального развития / без него; функциональное нарушение речи (отсутствует / лёгкое-среднее / тяжёлое); стойкое целостное клиническое течение (стабильное, ухудшение, улучшение).

2. История

- Kanner L. (1943) — «early infantile autism» — у 11 детей наблюдались социальная изоляция, сопротивление переменам, нарушения речи.
- Asperger H. (1944) — «Аутистическая психопатия» — описаны дефициты социального взаимодействия при нормальном интеллекте и речи. (История сотрудничества Аспергера с нацистским режимом раскрыта в последние десятилетия — Czech H. Mol Autism 2018.)

- Wing L., Gould J. (1979) — Концепция «аутистического спектра»; «триада нарушений» — социальное взаимодействие, коммуникация, воображение/поведение.
- DSM-III (1980) → DSM-IV (1994): Категория первазивных расстройств развития — отдельные диагнозы: аутистическое расстройство, синдром Аспергера, дезинтегративное расстройство детского возраста, синдром Ретта, PDD-NOS.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019): все подтипы объединены в единую категорию «Расстройство аутистического спектра». Обоснование — доказательная база надёжного и достоверного разделения подтипов была слабой. В DSM-5 тяжесть делится на 3 уровня (1 — требует поддержки; 2 — значительной поддержки; 3 — очень значительной поддержки). В МКБ-11 тяжесть не является отдельным квалификатором — подспецификация строится на основе интеллектуальных и речевых нарушений.
- Детское дезинтегративное расстройство не выделено в МКБ-11 отдельным кодом — оно классифицируется внутри 6A02 с квалификатором «утрата ранее приобретённых навыков».

3. Эпидемиология

- Распространённость: Отчёт CDC ADDM Network 2023 (дети 8 лет, данные 2020): 1/36 (2,8%) — в последние десятилетия отмечен рост (1/150 — 2000; 1/68 — 2012). Большая часть роста объясняется расширением диагностических критериев, повышением осведомлённости и внедрением скрининга.
- Пол: у мужчин ~4:1 — однако у женщин задокументирована проблема гиподиагностики (женский фенотип — социальный «камуфляж», менее выраженное повторяющееся поведение; Lai M.C., Baron-Cohen S. Lancet Psychiatry 2015).
- Коморбидность с интеллектуальной инвалидностью: ~30–40% (англ. CDC ADDM); примерно 30–35% IQ <70.
- Другие коморбидности: СДВГ ~30–50%, тревожность ~40%, депрессия в подростковом возрасте ~25%, эпилепсия ~10–30% (растёт с возрастом), нарушения сна 50–80%, проблемы с питанием, жалобы со стороны ЖКТ.
- Смертность: в 2 раза выше по сравнению с популяцией — основные причины: эпилепсия, несчастные случаи (утопление, случаи ухода/потери), суицид (при высокофункциональном РАС).

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы (наследуемость 50–80%)

- Наследуемость: Sandin S. et al. JAMA 2017, шведское исследование сиблингов и близнецов n>2 млн: наследуемость ~80%; доля средовых факторов ~20%.
- Связь с генетическими синдромами: Fragile X (~2–5% случаев РАС), синдром Ретта (у женщин почти всегда мутация MECP2), туберозный склероз (~1–4%), делеция 22q11.2, 16p11.2, Фелан-МакДермид (22q13).
- Мутации de novo CNV и SNV — выявляются в ~25% случаев; отмечаются синаптические гены (SHANK3, NRXN1, NLGN3/4, CHD8, SCN2A) (Satterstrom F.K. et al. Cell 2020 — 102 гена риска).
- Полигенная архитектура риска — сотни вариантов с малым эффектом; единого «гена аутизма» не существует.
- Возраст отца > 40 лет — связан с риском новой мутации.

4.2 Пренатальные и перинатальные факторы риска

- Применение вальпроата у матери (при беременности) — повышает риск расстройства аутистического спектра в ~2,9 раза (95% CI 1,7–4,9), детского аутизма — в ~5,2 раза (95% CI 2,7–10,0); абсолютный риск 4,42% и 2,50% (в популяции 1,53% и 0,48%) — Christensen J. et al. JAMA 2013; предупреждение FDA и EMA.
- Преждевременные роды — при 22–27 неделях повышают риск в ~3,7–4,2 раза (Crump C. et al. Pediatrics 2021), при 22–31 неделе — в ~2,3 раза (Persson M. et al. PLOS Med 2020); распространённость РАС у недоношенных 7% (95% CI 4–9) при медиане срока 28 недель (Agrawal S. et al. Pediatrics 2018).
- Низкая масса тела при рождении, перинатальная гипоксия.
- Диабет у матери, тяжёлое ожирение, гестационная гипертензия — указываются как факторы риска.
- Вирусные инфекции у матери во время беременности (краснуха, цитомегаловирус) — повышенный риск.

4.3 Нейробиологические механизмы

- Атипичная модель раннего роста мозга — акселерация в 2–4 года, затем нормализация (Courchesne E. et al. JAMA 2003).
- Дисрегуляция процессов синаптического формирования и прунинга — эксайтаторно-ингибиторный дисбаланс.

- Атипичная модель межзонной функциональной связности мозга — локальная гиперсвязность, слабая связность на дальних дистанциях (Just M.A. et al. Brain 2004; впоследствии противоречивые данные).
- Сеть социальной когниции (медиальная префронтальная кора, височно-теменной узел, миндалевидное тело) и система зеркальных нейронов демонстрируют атипичные модели активации.

4.4 Средовые факторы риска

- Загрязнение воздуха (PM2.5, NO2) во время беременности и в раннем детстве — умеренно повышает риск (Volk H.E. et al. JAMA Psychiatry 2013).
- Дефицит фолата у матери (в периконцепционный период) — приём препаратов фолата снижает риск (Surén P. et al. JAMA 2013).

5. Клиническая картина

5.1 Дефициты социальной коммуникации и взаимодействия

- Дефицит взаимного социально-эмоционального обмена — атипичное социальное сближение, снижение взаимной беседы, ограниченность разделяемых интересов.
- Дефициты невербального коммуникативного поведения — атипичное использование зрительного контакта, слабая координация жестов и мимики.
- Трудности формирования и поддержания отношений — недостаток соответствующих возрасту дружеских связей, недостаток воображаемых ролевых игр.

5.2 Ограниченные, повторяющиеся модели поведения

- Стереотипные или повторяющиеся моторные движения, использование предметов или речь (эхолалия, идиосинкразические выражения).
- Настаивание на неизменности, устойчивая приверженность рутинам или ритуализированное поведение (одежда, еда, маршрут).
- Высокоинтенсивные или сфокусированные ограниченные интересы (комплексные знания по конкретной теме — «интенсивное увлечение»).
- Атипичная реактивность на сенсорный ввод — гиперреактивность (звук, прикосновение), гипореактивность (боль) или атипичные сенсорные интересы (обследование поверхностей, зрительная стимуляция).

5.3 Траектория развития

Ранние признаки — снижение социального внимания, отклика на зов по имени, ответной улыбки, невербальной коммуникации (12–18 месяцев). У части детей регрессия развития (утрата приобретённых языковых и социальных навыков в 12–24 месяца) — ~30% случаев (CDC).

Во взрослом возрасте — у женщин и высокофункциональных лиц социальный «камуфляж» (Hull L. et al. J Autism Dev Disord 2017) — сокрытие трудностей ведёт к истощению и вторичной психиатрической коморбидности (тревожность, депрессия).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (точки консенсуса DSM-5-TR · МКБ-11 · NICE CG170)

A. Стойкие дефициты социальной коммуникации и социального взаимодействия — во всех трёх из следующих областей:

1. Социально-эмоциональный взаимный обмен;
2. Невербальное коммуникативное поведение в социальном взаимодействии;
3. Развитие, поддержание и понимание отношений.

B. Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов или деятельности — не менее двух из следующих четырёх:

1. Стереотипные или повторяющиеся моторные движения, использование предметов, речь;
2. Настаивание на неизменности, приверженность рутине, ритуализированное поведение или речь;
3. Высокоинтенсивные, сфокусированные ограниченные интересы;
4. Гипер- или гипореактивность на сенсорный ввод, или атипичные сенсорные интересы.

C. Симптомы должны присутствовать в раннем периоде развития (могут не проявляться полностью до момента, когда социальные требования возрастают).

D. Функциональное нарушение — в социальной, академической или иных важных сферах.

E. Исключения — не объясняется полностью расстройством интеллектуального развития или общей задержкой развития (коморбидность возможна).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F84.0): три уровня тяжести (1–3) определяются отдельно для каждого домена — по интенсивности необходимой поддержки. Квалификаторы: с интеллектуальной инвалидностью, языковым нарушением, известным медицинским/генетическим состоянием, другим расстройством нейропсихического развития, кататонией.
- МКБ-11 (6A02): подспецификации — с расстройством интеллектуального развития (6A02.0/.1) / без него (6A02.2/.3); степень нарушения функционального языка (нет / лёгкая-умеренная / тяжёлая). Система тяжести 1–3 из DSM официально не принята.
- NICE CG170 («Расстройство аутистического спектра у лиц младше 19 лет: поддержка и ведение», 2013): диагноз должен ставиться мультидисциплинарной командой (педиатр / психиатр + логопед + клинический психолог); ADOS-2 и ADI-R считаются золотым диагностическим стандартом.
- AAP 2020 (Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M. Pediatrics 2020;145(1)): в 18 и 24 месяца универсальный скрининг на аутизм рекомендуется (M-CHAT-R/F); положительный скрининг → оценка специалистом.
- AACAP Practice Parameter (Volkmar F. et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014): алгоритм диагностики, оценка коморбидности, рекомендации по лечению.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителями и лицами, осуществляющими уход, — история развития, ранние социальные и коммуникативные признаки.
2. Скрининг: 18 и 24 месяца (M-CHAT-R/F); при положительном результате — последующий опросник.
3. Оценка специалиста — педиатр / педиатр по развитию / психиатр / клинический психолог.
4. Золотой стандарт диагностических инструментов: ADOS-2 (англ. Autism Diagnostic Observation Schedule) — структурированное наблюдение на основе игры; ADI-R (англ. Autism Diagnostic Interview, Revised) — интервью с родителями.
5. Интеллектуальная оценка (WISC-V, Stanford-Binet 5, невербальные варианты — Leiter-3, Mullen).
6. Оценка речи, языка и адаптивного поведения (Vineland-3).
7. Тесты слуха и зрения.

8. Медицинская и генетическая оценка — хромосомный микроматричный анализ (CMA), ломкая Х-хромосома (FMR1), селективный трио-экзом; ЭЭГ при подозрении на приступы; МРТ при клиническом подозрении (микроцефалия, регресс).
9. Скрининг коморбидности: СДВГ, тревога, депрессия, ОКР, сон, питание, ЖКТ.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Расстройство интеллектуального развития (6A00)	Общий когнитивный дефицит; социальное взаимодействие соответствует интеллектуальному уровню. Может быть коморбидным.
Расстройство развития речи — прагматическое (6A01.22)	Дефицит в использовании социального языка; ограниченно-повторяющиеся модели поведения отсутствуют.
Реактивное расстройство привязанности (6B44)	Возникает вследствие ранней психосоциальной депривации; потенциал восстановления в благоприятной среде.
Шизотипическое расстройство (6A22)	Обычно проявляется во взрослом возрасте; психозоподобное мышление.
ОКР (6B20)	Эго-дистонические обсессии и компульсии; при АСП ритуалы эго-синтоничны.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Социальное избегание основано на тревоге; социальный интерес сохранён.
Избирательный мутизм (6B06)	Молчание в определённом контексте; нормальная речь в домашнем контексте.

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические диагностические инструменты

- Скрининг: M-CHAT-R/F (16–30 мес.), SCQ (4+ года, опросник для родителей), SRS-2 (англ. Social Responsiveness Scale).
- Диагностика: ADOS-2 (модули от toddler до взрослых), ADI-R (от 1,5 лет, родитель).
- Интеллект и когниция: Mullen Scales of Early Learning, Bayley-III/IV (ранний возраст), WISC-V, Leiter-3 (невербальный).
- Адаптивное поведение: Vineland-3, ABAS-3.
- Речь и язык: PLS-5, CELF-5, CCC-2 (прагматика).
- Сенсорный профиль: Sensory Profile-2 (Dunn).
- Коморбидность: Адаптации Conners для СДВГ, SCARED для тревоги, PHQ-9 для депрессии.

7.2 Лабораторные исследования

Первая линия (AAP 2020 / AACAP 2014): хромосомный микроматричный анализ (CMA — диагностическая эффективность ~10–20%); синдром ломкой Х-хромосомы (FMR1).

Выборочно: трио-экзомное секвенирование (WES — при отрицательном CMA диагностическая эффективность 25–40%); MECP2 (при подозрении на синдром Ретта у женщин); метаболические (лактат, аммиак, аминокислоты — при регрессе); уровень свинца; ТТГ.

7.3 Инструментальные исследования

- ЭЭГ — при наличии приступов, регресса, эпизодов странного поведения.
- МРТ головного мозга — фокальные неврологические симптомы, микро/макроцефалия, регресс.
- Тест слуха — обязателен во всех случаях (аудиометрия, ABR).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG170 · AAP 2020 · консенсус AACAP 2014)

1. РАС не «лечится» — улучшается индивидуальное развитие, адаптация и качество жизни. Утверждение о «лечении» и «полном

восстановлении» научно не обосновано; цель — функциональные навыки, коммуникация, независимость, качество жизни.

2. Раннее, интенсивное, индивидуальное поведенческое вмешательство — первая линия — эффект наибольший в возрасте 18 месяцев–6 лет (Reichow B. et al. Cochrane 2018, мета-анализ EIBI/ESDM).
3. Естественные (натуралистические) развивающе-поведенческие вмешательства (NDBI — Naturalistic Developmental Behavioral Interventions) — на основе поведенческо-развивающих принципов в контексте игры и повседневной жизни ребёнка; более гибкая, чем классическая дискретно-пробная версия ПАП. В эту группу входят:
    - Денверская модель раннего старта (ESDM)
    - Совместное внимание, символическая игра, вовлечённость и регуляция (JASPER).
    - Терапия ключевых реакций (PRT)
    - Усиленное обучение в естественной среде (EMT — Enhanced Milieu Teaching)
    - Терапия коммуникации при детском аутизме (ТКДА / PACT)

    Подробное описание методов — в разделе «Методики лечения».
4. Подход с координацией родителя (parent-mediated) — Hanen «More Than Words», PACT (Pickles A., Green J. et al. Lancet 2010, 2016 follow-up — эффект сохраняется 6 лет), PRT родительская версия. Наиболее затрато-эффективный подход в условиях ограниченных ресурсов.
5. Группы социальных навыков — для взрослых детей и подростков; программа PEERS (UCLA, Laugeson E.A.) — эффективна также у взрослых.
6. Структурированная образовательная среда — TEACCH (англ. Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, Schopler E. North Carolina); IEP / EHCP индивидуальный образовательный план.
7. Коммуникативная поддержка — у минимально вербальных пациентов: Augmentative and Alternative Communication (AAC) — PECS (Система обмена изображениями), речевые устройства, приложения на планшетах.
8. Лечение коморбидности — СДВГ (стимуляторы, Cortese 2018), тревога (модифицированная КПТ — Storch E.A. РКИ), депрессия (КПТ, СИОЗС), эпилепсия (стандартные антиэпилептики), сон (гигиена сна, мелатонин — доказательства РКИ Goldman S.E. J Clin Sleep Med 2014).

9. Фармакотерапия только для коморбидных симптомов — Для основных (ядерных) симптомов РАС нет препаратов, одобренных FDA. Для поведенческой агрессии и раздражительности — рисперидон (5–16 лет, одобрение FDA 2006) и арипипразол (6–17 лет, одобрение FDA 2009). Оба имеют доказательную базу (РКИ McCracken J.T. et al. NEJM 2002 — рисперидон), но значительная нагрузка побочных эффектов (метаболические, ЭПС). Поведенческое вмешательство — первая линия.

8.2 Методики лечения

1. Прикладной анализ поведения (ПАП / ABA — Applied Behavior Analysis) — Метод обучения на основе поведенческих принципов; формирование социальных, коммуникативных и адаптивных навыков, уменьшение проблемного поведения. Применяется в формате дискретных проб (англ. Discrete Trial Training, DTT) или в натуралистическом формате. Часть взрослого сообщества РАС критикует классическую форму ПАП (автономия, дистресс).
2. Раннее интенсивное поведенческое вмешательство (РИПВ / EIBI — Early Intensive Behavioral Intervention) — Структурированное интенсивное вмешательство в раннем возрасте на основе ABA (25–40 часов в неделю); цель — социальные, коммуникативные и адаптивные навыки. Доказательства: Reichow B., Hume K., Barton E.E., Boyd B.A. Cochrane 2018 — малый-средний эффект в IQ, речи и адаптивном поведении; следует подходить с осторожностью к существующим утверждениям.
3. Денверская модель раннего старта (англ. Early Start Denver Model, ESDM) — Роджерс (Rogers S.), Доусон (Dawson G.) — Натуралистическое вмешательство в развитие и поведение на 12–48 месяцев; обучение в контексте игры и повседневной активности. Доказательства: Dawson G. et al. Pediatrics 2010 РКИ n=48 — значительное улучшение IQ, речи и адаптивного поведения, изменение диагноза к 6 годам (Dawson G. et al. JAACAP 2012 наблюдение). Родительская версия (P-ESDM) Rogers S.J. et al. JAACAP 2012.
4. Совместное внимание, символическая игра, вовлечённость и регуляция (JASPER — Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, Regulation) — Kasari (Kasari C.) — Вмешательство, направленное на развитие совместного внимания и символической игры; 12–60 месяцев. Доказательства: Kasari C. et al. JAMA Pediatr 2014, J Consult Clin Psychol 2010 — значительное улучшение совместного внимания и экспрессивной речи.

5. Терапия коммуникации при детском аутизме (ТКДА / PACT — Paediatric Autism Communication Therapy) — Пиклз (Pickles A.), Грин (Green J.) — Вмешательство по координации общения с родителями; возраст 2–11 лет. Видео-анализ и расширение взаимодействия родитель-ребёнок. Доказательства: Pickles A. et al. Lancet 2016 — n=152, 6-летнее наблюдение — устойчивое улучшение тяжести аутизма и синхронизации родителей. Адаптируется также в условиях ограниченных ресурсов.
6. Терапия ключевых реакций (PRT — Pivotal Response Treatment) — Когель (Koegel R.L., Koegel L.K.) — Фокус на «Pivot»-поведения (мотивация, реакция на множественные сигналы, самоуправление, самоинициация) — при их обучении изменения распространяются на многие области. В натуралистическом формате, на основе выбора ребёнка.
7. Лечение и обучение детей с аутизмом и нарушениями коммуникации (англ. Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, TEACCH) — Шоплер (Schopler E.) — Структурированная визуальная образовательная среда — «структурированное обучение» — визуальное расписание, рабочие системы, индивидуальные переходы; в контексте дома, школы и сообщества. Происходит из Северной Каролины, распространено по всему миру.
8. Система коммуникации с помощью обмена изображениями (PECS — Picture Exchange Communication System) — Бонди (Bondy A.), Фрост (Frost L.) — Тренинг коммуникации на основе обмена изображениями для минимально вербальных пациентов — в 6 этапов. Доказательства: Howlin P. et al. J Child Psychol Psychiatry 2007 РКИ — увеличение коммуникации.
9. Программа обучения и обогащения навыков взаимоотношений (англ. Program for the Education and Enrichment of Relational Skills, PEERS) — Логесон (Laugeson E.A., UCLA) — Структурированная группа социальных навыков для подростков и молодых взрослых с РАС; 16 недель, с поддержкой родителей. Доказательства: Laugeson E.A. et al. J Autism Dev Disord 2012, 2015.
10. Hanen «More Than Words» — 8 групповых сессий + 3 индивидуальных домашних визита для родителей детей с РАС в возрасте 2–5 лет. hanen.org.
11. Тренинг навыков ухода ВОЗ (англ. WHO Caregiver Skills Training, CST) — Тренинг родителей ВОЗ с ограниченными ресурсами для стран с низким и средним доходом; для РАС и задержек развития; проводится

обученными немедицинскими тренерами-фасилитаторами на уровне сообщества.

12. ЭЭГ-нейрофидбек (англ. EEG Neurofeedback) — Тренинг, направленный на регуляцию пользователем собственной мозговой активности на основе мониторинга паттернов мозговых волн в реальном времени. База доказательств влияния на основные симптомы при РАС ограничена; Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 — скромные результаты при СДВГ, специфические доказательства при РАС слабы. Не первая линия, адъювантный статус; пациенту и семье следует объяснить ограниченность доказательной базы.
13. Шкала диагностического наблюдения при аутизме (ADOS / ADOS-2 — Autism Diagnostic Observation Schedule) и Интервью для диагностики аутизма (англ. ADI / ADI-R — Autism Diagnostic Interview-Revised) — Золотой стандарт диагностических инструментов — ADOS-2: структурированное игровое наблюдение (5 модулей, от младенцев до взрослых); ADI-R: стандартизированное интервью с родителями (от 1,5 лет, ~2 часа).

8.3 Различия между источниками

- NICE CG170 (2013, обновление 2021): диагностика мультидисциплинарной командой; вмешательства по социальной коммуникации первой линии; родительские программы предпочтительны; антипсихотик только при неэффективности поведенческого вмешательства; предостережение относительно заявлений о фактическом «излечении».
- AAP Clinical Report 2020 (Hyman et al.): Универсальный скрининг на 18 и 24 месяца; раннее вмешательство (<3 лет); комплексное медицинское и поведенческое управление.
- AACAP Practice Parameter 2014 (Volkmar): диагноз-специфическое образовательное размещение, лечение коморбидности, акцент на поддержку семьи.
- WHO Caregiver Skills Training (CST): программа обучения родителей с ограниченными ресурсами для стран с низким и средним доходом; адаптирована во многих странах (Salomone E. et al. Autism 2019).

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Ранняя диагностика (<3 лет) и раннее интенсивное вмешательство.
- Интеллектуальные функции сохранены (IQ >70).

- Приобретение функциональной речи до 5 лет.
- Ведение коморбидных расстройств.
- Стабильная семейная поддержка и общественные ресурсы.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Коморбидное расстройство интеллектуального развития (тяжёлая или глубокая).
- Отсутствие функциональной речи до 5 лет.
- Эпилептические приступы — дополнительное повышение риска во взрослом возрасте.
- Тяжёлые поведенческие расстройства, самоповреждение.
- Позднее начало диагностики и вмешательства.

Цели наблюдения

- Скрининг коморбидных психиатрических состояний (СДВГ, тревога, депрессия, ОКР) — ежегодно.
- Мониторинг эпилепсии — особенно в подростковом возрасте.
- Скрининг сна, питания, ЖКТ, двигательных нарушений.
- Планирование перехода во взрослую жизнь (16–18 лет) — профессия, самостоятельное проживание, трудоустройство.
- Эмоциональная нагрузка социальной маскировки, тревога и депрессия у взрослых пациентов — активный скрининг.
- Поддержка respite (передышки) для семьи, поддержка сверстников, психообразование.
- Нейродивергентный подход — укрепление сильных сторон пациента, без претензии на «полное излечение».

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Вакцины (особенно MMR) вызывают аутизм»

Почему распространено: Wakefield A.J. et al. Lancet 1998 — на основании 12 детей утверждал о связи MMR-вакцины с кишечным расстройством и аутизмом. Впоследствии журналистские расследования Брайана Дира и данные Генерального медицинского совета выявили финансовую заинтересованность

Уэйкфилда и манипуляцию данными; статья полностью отозвана в 2010 году; Уэйкфилд лишён врачебной лицензии.

Клиническая и биологическая логика: аутизм клинически проявляется в 12–18 месяцев — временная корреляция с типичными сроками вакцинации MMR может ошибочно восприниматься как «причина». Патогенез основан на генетических и ранних нейроразвивающих факторах (наследуемость 80%, пренатальные и перинатальные факторы) — не зависит от вакцинации.

Доказательства: Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccine 2014 мета-анализ n>1,2 млн детей — между MMR и аутизмом связь ОТСУТСТВУЕТ; Madsen K.M. et al. NEJM 2002 Датское исследование n>537 000; Jain A. et al. JAMA 2015 Исследование США. CDC, ВОЗ, NICE, AAP придерживаются той же позиции.

Реальный клинический шаг: Спокойно и уважительно представить семье доказательства; объяснить риск отказа от вакцинации для здоровья ребёнка и сообщества (эпидемия кори на Мадагаскаре 2018–2019, 1200+ смертей детей).

Миф 2: «Микропластик, тяжёлые металлы, химические пищевые добавки — основная причина аутизма»

Почему распространено: Преувеличенное представление в СМИ движения «натуральное / без химикатов»; использование исследований микропластика вне контекста.

Клиническая и биологическая логика: основная этиология аутизма — генетическая (наследуемость 80% — Sandin JAMA 2017). Факторы среды исследуются как факторы риска (загрязнение воздуха PM2.5 — Volk JAMA Psychiatry 2013; пренатальный вальпроат — Christensen JAMA 2013), но доказательная база для микропластика или тяжёлых металлов как «основной причины» отсутствует.

Доказательства: Hertz-Picciotto I. Environ Health Perspect 2018 обзор — некоторые нейротоксины (особенно вальпроат, алкоголь) рассматриваются как фактор риска; воздействие тяжёлых металлов напрямую не доказано как этиология аутизма.

Реальный клинический шаг: Указать семье реальные факторы риска (вальпроат при беременности, ограничение загрязнения воздуха) и реальные защитные меры (периконцепционный фолат).

Миф 3: «Холодная мать» (теория Bettelheim «Refrigerator Mother»)

Почему распространено: Bruno Bettelheim 1967 в работе «The Empty Fortress» связывал аутизм с эмоциональной холодностью матерей; доминирующее убеждение до 1970-х годов.

Клиническая и биологическая логика: аутизм является нарушением нейроразвития — связан с генетическими факторами и ранним развитием мозга; поведение родителей не вызывает аутизм.

Доказательства: Rimland B. (1964) «Infantile Autism» — аргумент в пользу биологической этиологии; Folstein S., Rutter M. Nature 1977 — близнецовое исследование доказало генетическую наследственность. APA, AAP, AACAP — концепция «холодной матери» отвергнута.

Реальный клинический шаг: Поддержка и психообразование семьи вместо обвинения; родительско-координированные вмешательства (PACT, ESDM, Hanen).

10.2 Вредные или опасные методы «лечения»

Миф 4: «Хелационная терапия выводит тяжёлые металлы и излечивает аутизм»

Почему распространено: Ошибочная теория «аутизма, вызванного тяжёлыми металлами»; маркетинг альтернативных клиник.

Доказательства и риск: AAP 2010 и предупреждение FDA — 5-летний ребёнок умер от остановки сердца из-за дефицита кальция во время процедуры хелатирования (2005). Хелатирование показано только при подтверждённом отравлении тяжёлыми металлами (высокий уровень свинца), а не при аутизме. AAP, AACAP — абсолютное противопоказание.

Миф 5: «Гипербарическая оксигенация (ГБО) излечивает аутизм»

Доказательства: Cochrane (Xiong T. et al. 2016) обзор n=1 РКИ — нет доказательств эффекта при аутизме. Риски: пневмоторакс, баротравма уха, возгорание (кислород + статика).

Миф 6: «ММС / „Чудодейственный минеральный раствор“(диоксид хлора) излечивает аутизм»

Доказательства: FDA 2019, предупреждения EMA — диоксид хлора едкий, зарегистрированы повреждения печени и почек, случаи смерти. Любое

клиническое использование запрещено. Более того, применение диоксида хлора в качестве «очищающего» средства причиняет детям тяжёлые страдания.

Миф 7: «Инъекции стволовых клеток излечивают аутизм»

Доказательства: ISSCR (англ. International Society for Stem Cell Research) и FDA — одобренной терапии стволовыми клетками для аутизма не существует. В нелегальных клиниках зарегистрированы случаи инфекций, опухолей головного мозга, летальных исходов (Berkowitz NEJM 2016).

Миф 8: «„Челябинское средство“ и аналогичные препараты без медицинского контроля»

Доказательства: ни один «альтернативный» препарат, не одобренный регулирующими органами (FDA, EMA, EU) для лечения аутизма, не имеет доказанной пользы, а риск его применения высок.

10.3 Неэффективные методы или методы, откладывающие основное вмешательство

Миф 9: «Facilitated Communication (FC) и Rapid Prompting Method (RPM) раскрывают внутренний мир людей с минимальной вербальной активностью при аутизме»

Почему распространено: эмоционально привлекательные истории — дети, «начинающие говорить» с помощью фасилитатора.

Доказательства: Позиционное заявление ASHA 2018 (обновление): независимые проверки показали, что сообщения исходят от фасилитатора (идеомоторный эффект), а не от пациента. Это доказательство подтверждено во множестве РКИ (Schlosser R.W. et al. Augment Altern Commun 2014). Клинический результат: ложное убеждение для семьи; задерживается истинная аутентичная коммуникация пациента (PECS, устройства AAC); общественный вред — случаи ложных «показаний» в юридических вопросах.

Реальный клинический шаг: доказанные средства AAC для минимально вербальных пациентов — PECS, планшетные программы коммуникации (Proloquo2Go, TouchChat).

Миф 10: «Безглютеновая/безказеиновая диета излечивает аутизм или значительно улучшает его»

Доказательства: Hyman S.L. et al. (AAP 2020 Clinical Report) — влияние специальных диет на симптомы аутизма не доказано; при наличии желудочно-кишечных симптомов или целиакии диета является медицинским показанием.

Широкие диетические ограничения приводят у детей к дефициту питательных веществ и расстройствам пищевого поведения. Karagas M.R. et al. JAMA Pediatr 2018 — риски широких диетических ограничений.

Миф 11: «ЭЭГ-нейрофидбек излечивает основные симптомы аутизма»

Доказательства: Обзор Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 — скромный эффект при СДВГ; специфические доказательства для аутизма слабы. Статус адъюванта, не первая линия. Должен быть открыто объяснён пациенту и семье.

Миф 12: «Auditory Integration Training (AIT) излечивает аутизм»

Доказательства: Позиционное заявление ASHA 2004; AAP 1998 — экспериментальный статус, доказательств эффективности нет.

Миф 13: «Витамин B6/магний или другая мегадозная витаминотерапия»

Доказательства: Cochrane (Nye C., Brice A. 2005) — эффект комбинации B6/магний при аутизме не доказан. Мегадозы витаминов могут привести к побочной нагрузке (B6-нейропатия).

Миф 14: «Patterning (Доман-Делакато)»

Доказательства: AAP 1968 и 2010 — заявления: нет доказательств эффективности, чрезмерная нагрузка на семью; отвлекает детей от вмешательств с доказанной эффективностью.

Миф 15: «Краниосакральная терапия, рефлексотерапия, гомеопатия»

Доказательства: систематические обзоры (Cochrane и др.) — нет доказательств эффективности при аутизме. NICE CG170 — предупреждение о комплементарных вмешательствах.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A02 Autism spectrum disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 170. Autism spectrum disorder in under 19s: support and management. 2013, 2021 update.

4. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.
5. Volkmar F., Siegel M., Woodbury-Smith M., King B., McCracken J., State M. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53(2):237–257.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. MMWR Surveill Summ 2023;72(2):1–14.
7. Sandin S., Lichtenstein P., Kuja-Halkola R. et al. The Heritability of Autism Spectrum Disorder. JAMA 2017;318(12):1182–1184.
8. Satterstrom F.K. et al. Large-Scale Exome Sequencing Study Implicates Both Developmental and Functional Changes in the Neurobiology of Autism. Cell 2020;180(3):568–584.
9. Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis. Vaccine 2014;32(29):3623–3629.
10. Madsen K.M., Hviid A., Vestergaard M. et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. NEJM 2002;347(19):1477–1482.
11. Christensen J., Grønborg T.K., Sørensen M.J. et al. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders. JAMA 2013;309(16):1696–1703.
12. Surén P., Roth C., Bresnahan M. et al. Association between maternal use of folic acid supplements and risk of autism spectrum disorders in children. JAMA 2013;309(6):570–577.
13. Volk H.E., Lurmann F., Penfold B. et al. Traffic-related air pollution, particulate matter, and autism. JAMA Psychiatry 2013;70(1):71–77.
14. Dawson G., Rogers S., Munson J. et al. Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model. Pediatrics 2010;125(1):e17–e23.
15. Reichow B., Hume K., Barton E.E., Boyd B.A. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database Syst Rev 2018;(5):CD009260.
16. Pickles A., Le Couteur A., Leadbitter K., Salomone E., Cole-Fletcher R., Tobin H., Gammer I., Lowry J., Vamvakas G., Byford S., Aldred C., Slonims V., McConachie H., Howlin P., Parr J.R., Charman T., Green J. Parent-mediated social communication therapy for young children with

autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. Lancet 2016;388(10059):2501–2509.

17. Kasari C., Gulsrud A., Paparella T., Hellemann G., Berry K. Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism. J Consult Clin Psychol 2015;83(3):554–563.
18. McCracken J.T., McGough J., Shah B. et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. NEJM 2002;347(5):314–321.
19. Xiong T., Chen H., Luo R., Mu D. Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016; (10):CD010922.
20. ASHA Position Statement: Facilitated Communication. American Speech-Language-Hearing Association; 2018. asha.org/policy/PS2018–00352.
21. Goldman S.E., Adkins K.W., Calcutt M.W. et al. Melatonin in children with autism spectrum disorders. J Clin Sleep Med 2014;10(8):871–882.
22. Laugeson E.A., Frankel F., Gantman A., Dillon A.R., Mogil C. Evidence-based social skills training for adolescents with autism spectrum disorders: the UCLA PEERS program. J Autism Dev Disord 2012;42(6):1025–1036.
23. Lai M.C., Baron-Cohen S. Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. Lancet Psychiatry 2015;2(11):1013–1027.
24. Berkowitz A.L., Miller M.B., Mir S.A. et al. Glioproliferative lesion of the spinal cord as a complication of «stem-cell tourism». NEJM 2016;375(2):196–198.
25. Bondy A., Frost L. The Picture Exchange Communication System. Behav Modif 2001;25(5):725–744.
26. Koegel R.L., Koegel L.K. Pivotal Response Treatments for Autism. Baltimore: Brookes, 2006.
27. Mesibov G.B., Shea V., Schopler E. The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Springer, 2005.
28. Storch E.A., Arnold E.B., Lewin A.B. et al. The effect of cognitive-behavioral therapy versus treatment as usual for anxiety in children with autism spectrum disorders: a randomized, controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013;52(2):132–142.

МКБ-11 **6A03**	**6A03 РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ** **Developmental learning disorder**

МКБ-11 **6A03**	**6A03 РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ** **Developmental learning disorder**
DSM-5-TR F81.0	Специфическое расстройство обучения, с нарушением чтения

1. Определение и нозология

Расстройство развития учебных навыков (МКБ-11: 6A03 Developmental Learning Disorder; DSM-5-TR: F81.0–F81.81 Specific Learning Disorder) — нейроонтогенетическое расстройство, проявляющееся стойкими и значительными трудностями в приобретении одного или нескольких академических навыков, которые являются неожиданными с учётом возраста, интеллектуального уровня и образовательных возможностей пациента.

МКБ-11 — под-спецификации:

- 6A03.0 — с нарушением чтения (дислексия);
- 6A03.1 — с нарушением письменного выражения (дисграфия);
- 6A03.2 — с нарушением математических способностей (дискалькулия).
- 6A03.3 — другое специфицированное или сочетанное.

2. История

- Pringle Morgan W. (1896) — «Врождённая словесная слепота» — описан ребёнок, неспособный читать, несмотря на нормальный интеллект.
- Orton S.T. (1925) — Концепция «strephosymbolia»; гипотеза о слабости доминантности левого полушария; основа метода Ортона-Гиллингема.
- DSM-III (1980) — Категория «Специфическое расстройство развития» — основана на расхождении между IQ и академическими навыками (англ. discrepancy model).
- DSM-5 (2013) — отмена модели дискрепантности: «Специфическое расстройство обучения» — порог IQ не требуется; основой являются стойкие функциональные трудности и отсутствие ответа на вмешательство. Сохраняется отдельное кодирование подтипов (чтение, письмо, математика).

- МКБ-11 (2019) — параллельная структура; с термином «Developmental Learning Disorder».
- Теория фонологического дефицита (Stanovich K.E., Snowling M.J., Vellutino F.R.) — доминировала в 1990–2000-х годах как основной механизм дислексии.

3. Эпидемиология

- Общая распространённость: 5–15% у детей школьного возраста (оценка DSM-5-TR); варьирует в зависимости от орфографической глубины языка и страны (выше в языках с глубокой орфографией, таких как английский).
- Дислексия: 5–10% детей школьного возраста; наиболее распространённый подтип.
- Дискалькулия: 3–7% (Shalev R.S. Pediatr Neurol 2007, обзор).
- Дисграфия: 4–7% (Berninger V.W. Top Lang Disord 2008).
- Пол: при нарушениях чтения и письма у мальчиков в 2–3 раза выше (существует гипотеза о недовыявлении у женщин); при нарушениях счёта полы равны.
- Коморбидность: СДВГ 30–40%, нарушения речи 50–60% (при нарушении чтения), повышенный риск тревоги, депрессии, расстройств поведения.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Наследуемость: при дислексии 50–70% (обзор близнецовых исследований Pennington B.F. Cogn Neuropsychol 2002).
- Определённые гены риска: DYX1C1 (15q21), KIAA0319 (6p22), DCDC2 (6p22), ROBO1 (3p12) — связаны с нейрональной миграцией и формированием коры; однако не один ген, а полигенная архитектура риска.
- При расстройстве математических навыков также высокая наследственность (~70%), предполагаются гены MYT1L и другие (Mascheretti S. et al. Trends Genet 2018).

4.2 Нейробиологические механизмы

- Дислексия — фонологический дефицит: атипичные паттерны активации в левых перисильвиевых областях (Вернике, угловая

извилина, верхняя височная извилина) (Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. Biol Psychiatry 2008, обзор фМРТ). Дефицит соответствия фонема-графема (звук-буква) является ядром трудностей чтения.

- Дискалькулия — чувство числа (approximate number system) и рабочая память: функциональное нарушение в интрапариетальной борозде и префронтальной коре (Butterworth B. Trends Cogn Sci 2010).
- Дисграфия: дефициты моторного планирования и орфографического кодирования; левая фузиформная и премоторная области.

4.3 Средовые факторы (модификатор)

- Качество раннего образования и методология обучения чтению — отсутствие фонологического подхода создаёт больший академический разрыв у детей с полигенным риском.
- Низкий социально-экономический статус — не этиология, а фактор идентификации и доступности вмешательства.
- Хронический средний отит — может влиять на раннее фонологическое развитие.

5. Клиническая картина

5.1 Расстройство чтения (дислексия, 6A03.0)

- Неточность и медлительность при чтении слов — читает медленно, с трудом, заменяет или пропускает буквы.
- Дефицит фонологического осознания — трудности с рифмой, связью буква-звук, разделением слов на звуки.
- Ошибки письма и диктанта — орфографические ошибки, не соответствующие фонетическим правилам.
- Понимание прочитанного — вторичное нарушение вследствие дефицита распознавания слов.
- Ранние признаки (дошкольный возраст) — задержка в изучении названий букв, трудности в играх с рифмами, трудности в чтении названий.

5.2 Расстройство письменного выражения (дисграфия, 6A03.1)

- Почерк некачественный, неразборчивый, медленный.
- Затруднения в построении предложений, грамматике, организации абзацев.
- Устойчивые ошибки в правописании и пунктуации.

- Большая разница между навыками письменного и устного выражения.

5.3 Расстройство счёта (дискалькулия, 6A03.2)

- Дефицит чувства числа — сравнение количества, оценка величины.
- Трудность запоминания математических фактов (напр., многоэтапной таблицы умножения).
- Математические операции — медлительность и ошибки в задачах на сложение, вычитание, многоэтапных задачах.
- Трудность в представлении математических задач словами.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. Стойкие трудности в приобретении и использовании академических навыков продолжаются не менее 6 месяцев, несмотря на целенаправленное вмешательство, соответствующее возрасту. Как минимум один из следующих симптомов:

1. Неточность или медлительность при чтении слов;
2. Трудность в понимании прочитанного текста;
3. Трудности с правописанием;
4. Трудности в письменном выражении (грамматика, пунктуация, организация);
5. Трудности с чувством числа и навыками счёта;
6. Трудности в математическом суждении.

B. Академические навыки значительно ниже ожидаемого для возраста уровня — документировано стандартизированными тестами (на 1,5 SD или ниже хронологического возраста), вызывает функциональные нарушения в академической или профессиональной деятельности.

C. Начало в школьном возрасте (но может полностью не проявляться до повышения академических требований).

D. Исключения — не полностью объясняется интеллектуальной недостаточностью, дефицитом слуха/зрения, другим неврологическим или психиатрическим состоянием, психосоциальной депривацией, проблемами беглости на языке обучения, неадекватным образованием.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: Модель «расхождения между IQ и академическими навыками» отменена — для диагноза не требуется пороговое значение IQ; важно отсутствие ответа на длительное вмешательство. Степень тяжести: лёгкая, умеренная, тяжёлая — определяется по уровню адаптивного функционирования.
- МКБ-11 (6A03): параллельная структура; подспецификации (чтение, письмо, математика). Тяжесть не является отдельным квалификатором.
- IDA — International Dyslexia Association: дислексия — нейробиологического происхождения, дефицит фонологической обработки; расстройство «нейроинформационной обработки». Рекомендуется стандартизированная оценка навыков + наблюдение за ответом на вмешательство (Response to Intervention, RTI).
- AAP Clinical Report on Dyslexia (Handler S.M., Fierson W.M. Pediatrics 2011, reaffirmed): диагноз должен направляться педиатрами, оценка мультидисциплинарная — психолог + логопед-дефектолог + специалист по образованию.
- NICE: отдельных клинических рекомендаций по расстройству обучения нет; основная структура — в рамках образовательной системы (англ. SEND Code of Practice, EHCP).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с учителем и родителем — академический анамнез, ответ на вмешательство.
2. Тесты зрения и слуха (исключение сенсорного нарушения).
3. Стандартизированные тесты академических навыков — Woodcock-Johnson IV, WIAT-4, KTEA-3.
4. Оценка фонологического осознания и чтения — CTOPP-2, GORT-5, TOWRE-2.
5. Для математики — KeyMath-3, TEMA-3.
6. Интеллектуальная оценка (WISC-V) — для исключения интеллектуальной недостаточности; дискрепантность уже не требуется для диагноза.
7. Оценка внимания, исполнительной функции (BRIEF-2), рабочей памяти.
8. Документация ответа на интервенцию (Response to Intervention, RTI) — сохраняющиеся трудности, несмотря на возрастную интервенцию в течение 6+ месяцев.

9. Скрининг коморбидности — СДВГ, расстройство речи, тревога, депрессия.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Расстройство интеллектуального развития (6A00)	Академический дефицит в контексте общего когнитивного дефицита; также нарушена адаптивная функция.
Расстройство развития речи (6A01)	Нарушено овладение устной речью; проблемы с чтением и правописанием являются вторичными.
СДВГ (6A05)	Дефицит внимания снижает академическую успеваемость; в стандартизированных тестах академические навыки обычно соответствуют состоянию внимания. Коморбидность часта.
Нарушение зрения/слуха	Выявляется при сенсорном обследовании.
Социально-экономическая депривация, неадекватное образование	В соответствующей образовательной среде академическая успеваемость восстанавливается.
Изучение второго языка (англ. English Language Learner)	Академические навыки на родном языке должны быть проверены; билингвизм сам по себе не является основанием для диагноза.

7. Обследование и оценка

7.1 Стандартизированные тесты

- Академические навыки: Woodcock-Johnson IV (комплексная), WIAT-4 (англ. Wechsler Individual Achievement Test), KTEA-3.
- Чтение: GORT-5 (англ. Gray Oral Reading Test), TOWRE-2 (англ. Test of Word Reading Efficiency), CTOPP-2 (англ. Comprehensive Test of Phonological Processing).
- Счёт: KeyMath-3, TEMA-3 (англ. Test of Early Mathematics Ability).

- Интеллект и когниция: WISC-V, WJ-IV Cognitive.
- Исполнительная функция: BRIEF-2 (опросник для родителей/учителей).
- Рабочая память, скорость обработки: Индексы WISC-V, Digit Span, Trail Making.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных лабораторных указаний нет. На основании специфического клинического подозрения:

- Уровень свинца — при наличии факторов риска.
- Функция щитовидной железы — если не выявлен врождённый гипотиреоз.
- Генетическое исследование — при наличии коморбидной интеллектуальной недостаточности или синдромальных признаков.

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — рутинных показаний нет; при фокальных неврологических симптомах, припадках, регрессе.
- ЭЭГ — подозрение на приступ, исключение синдрома Ландау-Клеффнера.
- Тест слуха и тест зрения — обязательные первичные показатели во всех случаях.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (IDA · AAP 2011 · APA · консенсус NASP)

1. Специфическое расстройство обучения фармакологически не лечится. Интервенция — это научно обоснованное обучение и терапия.
2. Ранняя идентификация и вмешательство — эффективность вмешательства значительно выше в дошкольном и раннем школьном возрасте. Модель RTI (Response to Intervention) — поэтапное вмешательство, соответствующее возрасту; отсутствие ответа приводит к диагностической оценке.
3. Дислексия — подход Structured Literacy: систематическое, последовательное, эксплицитное, мультисенсорное, диагностическое обучение. Фонологическое осознание + соответствие фонема-графема + структура слова + синтаксис + семантика. Типичные программы: Orton-Gillingham, Wilson Reading System, Lindamood-Bell.

4. Дискалькулия: Concrete-Representational-Abstract (CRA) instruction; развитие чувства числа, упражнения на запоминание математических фактов.
5. Дисграфия: Обучение почерку (например, Handwriting Without Tears), обучение клавиатуре, стратегии организации слов и предложений, технология voice-to-text.
6. Академические приспособления: Дополнительное время, аудиокниги, клавиатура, программы чтения текста (text-to-speech), калькулятор в математике — в рамках IEP / EHCP.
7. Лечение коморбидности: СДВГ — стимуляторы; тревога и депрессия — КПТ; нарушение речи — логопед.
8. Социально-эмоциональная поддержка: у детей с нарушениями обучения проблемы с самооценкой, мотивацией, тревогой представляют высокий риск.

8.2 Методики лечения

1. Подход Ортона-Гиллингема (OG) — Структурированное мультисенсорное обучение чтению и письму на основе фонема-графема. Методология первой линии при дислексии; проводится сертифицированным учителем/терапевтом. Доказательства: Stevens E.A. et al. J Learn Disabil 2021 мета-анализ — средний размер эффекта в чтении и письме. Academy of Orton-Gillingham Practitioners.
2. Система чтения Уилсона (англ. Wilson Reading System) — Комплексная программа чтения и диктанта из 12 ступеней, основанная на принципах Ортона-Гиллингема; от 6 лет до взрослого возраста. wilsonlanguage.com.
3. Программы Lindamood-Bell — LiPS (англ. Lindamood Phoneme Sequencing) — соединяет фонематическое осознание с моторно-кинестетическим компонентом; Seeing Stars — орфографическое кодирование. lindamoodbell.com.
4. Структурированная грамотность (англ. Structured Literacy — IDA Knowledge and Practice Standards) — Не специфическая программа, а рамка — систематические, последовательные, эксплицитные, мультисенсорные, диагностические принципы обучения. Orton-Gillingham, Wilson, Lindamood-Bell и другие соответствуют этой рамке. dyslexiaida.org.
5. Конкретно-Репрезентативно-абстрактное обучение (КРАО / CRA — Concrete-Representational-Abstract Instruction) — При дискалькулии — обучение, начинающееся с конкретных манипулятивных средств, затем переход к рисуночному представлению, далее к абстрактным

символьным операциям. Доказательства: Witzel B.S. et al. J Spec Educ Technol 2003.

6. Программа «Handwriting Without Tears» — Олсен (Olsen J.) — Мультисенсорная программа обучения письму, используемая при дисграфии и трудностях письма. lwtears.com.
7. Ответ на интервенцию (RTI — Response to Intervention) / Многоуровневая система поддержки (англ. Multi-Tiered System of Supports, MTSS) — 3-уровневая система — Уровень 1: универсальное качественное обучение; Уровень 2: целевое вмешательство в малых группах; Уровень 3: интенсивное индивидуальное вмешательство. Закреплено законом IDEA 2004 в США; аналогичные системы в других странах.
8. Вспомогательные технологии (англ. Assistive Technology) — Text-to-speech (Read&Write, NaturalReader), speech-to-text (англ. Dragon Naturally Speaking), аудиокниги (Bookshare, Learning Ally), вычислительные средства для математики — функциональная компенсация. Рекомендовано AAP и IDA.
9. Комплексный тест фонологической обработки (англ. Comprehensive Test of Phonological Processing, CTOPP-2) — Стандартизированная оценка фонологического осознания — золотой стандарт идентификации дислексии.
10. GORT-5 (англ. Gray Oral Reading Test) и TOWRE-2 — Измерение скорости, точности и беглости чтения.

8.3 Различия между источниками

- IDA Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading (2018): Структурированная программа обучения грамоте; требуется сертифицированный учитель.
- AAP 2011 (Handler & Fierson): дислексия биологически обоснована; академическое вмешательство первой линии; визуальная терапия противопоказана (см. 10.3).
- National Reading Panel (NRP) 2000: пять основных компонентов чтения — фонологическое осознание, фонетика, беглость, словарный запас, понимание.
- NASP (англ. National Association of School Psychologists): В рамках RTI 3 уровня — универсальный скрининг, целенаправленное вмешательство, интенсивное индивидуальное вмешательство.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Ранняя идентификация (дошкольный или ранний школьный возраст).
- Вмешательство Structured Literacy с доказанной эффективностью.
- Высокий IQ — развитие компенсаторных стратегий.
- Стабильная семейная поддержка и мотивация.
- Влияние только на одну академическую область (например, только чтение, математика в норме).

Факторы неблагоприятного прогноза

- Поздняя идентификация (середина или конец школьного возраста).
- Влияние на множество академических областей.
- Коморбидный СДВГ, расстройство речи, тревога.
- Низкая социально-экономическая поддержка, ограниченные образовательные ресурсы.
- Интервенция недоказанными методами (цветные линзы, визуальная терапия, Brain Gym).

Цели наблюдения

- Мониторинг академических достижений — ежегодные стандартизированные тесты.
- Социально-эмоциональное здоровье — скрининг самооценки, тревоги, депрессии.
- Отдельное вмешательство при коморбидном СДВГ и расстройстве речи.
- Планирование профессиональных и академических приспособлений во взрослом возрасте (возможности для инвалидности в высшем образовании, адаптация на рабочем месте).
- Усиление использования вспомогательных технологий (text-to-speech, калькулятор).

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Дислексия — результат лени ребёнка или плохого воспитания»

Почему распространено: Убеждение «если достаточно стараться, сможет читать»; ошибочное объяснение академических трудностей как проблемы характера.

Клиническая и биологическая логика: Дислексия — это нейробиологическое расстройство. Исследования фМРТ (Shaywitz S.E. Biol Psychiatry 2008) показали атипичные паттерны активации в левых перисильвиевых областях; наследуемость 50–70%, идентифицированные гены риска (DYX1C1, KIAA0319, DCDC2). Пациент вынужден затрачивать гораздо более высокие когнитивные усилия, что приводит к хроническому истощению.

Доказательства: Определение IDA (2002, обновление) — «Дислексия — это специфическое расстройство обучения нейробиологического происхождения.»

Реальный клинический шаг: Объяснить семье биологические основы; вместо обвинения — научно обоснованное вмешательство Structured Literacy и академические приспособления.

Миф 2: «Дислексия — это когда дети пишут буквы зеркально»

Почему распространено: Ортон 1925: термин «strephosymbolia» и повторяющийся образ в популярных СМИ.

Клиническая и биологическая логика: Написание и чтение букв в зеркальном отражении является нормой для всех детей в возрасте 4–7 лет; продолжающаяся после 8 лет инверсия букв может вызывать клиническое подозрение, но не является основным признаком дислексии. Ядром дислексии является дефицит фонологической обработки.

Доказательства: Stanovich K.E. (2000) — теория фонологического дефицита; зрительно-пространственный дефицит не является первичной этиологией.

Миф 3: «Дети с дислексией „перерастут“ её с возрастом, вмешательство не требуется»

Доказательства: Bruck M. Dev Psychol 1992 — лонгитюдные исследования: дети с дислексией, не получавшие вмешательства, сохраняют трудности чтения

во взрослом возрасте; академические и профессиональные результаты плохие. Чем раньше начато вмешательство, тем выше потенциал компенсации.

10.2 Вредные или научно необоснованные методы

Миф 4: «Цветные линзы (линзы Ирлена) или цветные накладки излечивают дислексию»

Почему распространено: В 1980-х годах концепция «scotopic sensitivity syndrome» Хелен Ирлен; маркетинг коммерческих оптометрических клиник.

Доказательства: AAP, AAO (Американская академия офтальмологии) и AAPOS (Американская ассоциация детской офтальмологии и косоглазия) Совместные заявления 2009 и 2014 годов: эффект цветных линз и накладок при дислексии не доказан; систематический обзор Cochrane (Evans B.J., Allen P.M. 2016) — достаточных доказательств эффективности нет. AAP — откладывает вмешательство первой линии (англ. Structured Literacy).

Реальный клинический шаг: Открытое объяснение семье; научно обоснованная программа фонологического чтения в качестве вмешательства.

Миф 5: «Визуальная терапия (упражнения для глаз) излечивает дислексию»

Доказательства: AAP, AAO, AAPOS 2009 — Совместное заявление: подчёркивает, что дислексия — это не нарушение движения глаз, а языковое расстройство; влияние глазных упражнений на эффективность чтения не доказано. Визуальная терапия показана только при конкретных нарушениях движения глаз (например, недостаточность конвергенции).

Миф 6: «Brain Gym / Образовательная кинезиология»

Доказательства: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 систематический обзор — утверждения не соответствуют нейробиологии; влияния на академическую успеваемость нет. Критикуется как коммерческая программа.

Миф 7: «Программа Доре (англ. Cerebellar Exercise Therapy)»

Почему распространено: Уинфорд Дор (англ. Wynford Dore) в 2000-х популяризировал теорию, связывающую функцию мозжечка с чтением; заявления о «положительных результатах» привлекли внимание СМИ.

Доказательства: Оригинальные исследования Reynolds D., Nicolson R.I. подверглись серьёзной методологической критике (Bishop D.V. Dyslexia 2007);

эффект не подтверждён в повторных исследованиях. British Dyslexia Association не рекомендует программу Dore.

10.3 Неэффективные методы или методы, откладывающие основное вмешательство

Миф 8: «Метод „Whole Language“ обучает чтению вместо фонетики»

Доказательства: National Reading Panel 2000 (NRP) — систематическое обучение фонетике явно превосходит подход «цельного слова», особенно у детей с трудностями обучения. Та же позиция включена в образовательные правовые стандарты решением по делу Endrew F. v. Douglas County (Верховный суд США, 2017). Дебаты «Войны чтения» в основном разрешены в пользу систематической фонетики.

Миф 9: «Auditory Integration Training (AIT) / метод Томатиса излечивает дислексию»

Доказательства: Позиционное заявление ASHA 2004 — эффективность AIT при дислексии или нарушении обучения не доказана.

Миф 10: «ЭЭГ-нейрофидбек излечивает дислексию или дискалькулию»

Доказательства: эффективность нейрофидбека при специфическом расстройстве обучения не доказана. При СДВГ скромный эффект (Holtmann 2011), но экстраполяция на расстройства обучения необоснованна.

Миф 11: «Специальная диета (безглютеновая, мегадозы омега-3, „пища для мозга“) излечивает дислексию»

Доказательства: Cochrane и систематические обзоры (Tan M.L. et al. J Pediatr 2012 для омега-3) — при дислексии устойчивый клинический эффект не доказан. В некоторых исследованиях показан небольшой эффект, но существуют методологические ограничения.

Миф 12: «Гипербарическая кислородная камера (HBOT) или инъекции стволовых клеток»

Доказательства: доказательств эффективности при специфическом расстройстве обучения нет; профиль риска значителен (ГБО — пневмоторакс; стволовые клетки — инфекции, случаи смерти).

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A03 Developmental learning disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. International Dyslexia Association. Definition of Dyslexia. 2002, updated. dyslexiaida.org.
4. IDA Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading. 2018.
5. Handler S.M., Fierson W.M., American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, Council on Children with Disabilities. Joint Technical Report — Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. Pediatrics 2011;127(3):e818–e856.
6. National Reading Panel. Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. NIH; 2000.
7. Pennington B.F. From single to multiple deficit models of developmental disorders. Cogn Neuropsychol 2002;19(5):385–414.
8. Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. Paying attention to reading: The neurobiology of reading and dyslexia. Biol Psychiatry 2008;63(3):219–225.
9. Butterworth B. Foundational numerical capacities and the origins of dyscalculia. Trends Cogn Sci 2010;14(12):534–541.
10. Shalev R.S. Prevalence of developmental dyscalculia. Pediatr Neurol 2007;37(6):385–391.
11. Berninger V.W., Niedo J. Aphasia and apraxia of speech in adults vs. dyslexia and dysgraphia in children. Top Lang Disord 2008;28(2):143–153.
12. Stevens E.A., Austin C., Moore C. et al. Current state of the evidence: Examining the effects of Orton-Gillingham reading interventions for students with or at risk for word-level reading disabilities. J Learn Disabil 2021;54(6):399–414.
13. Bruck M. Persistence of dyslexics' phonological awareness deficits. Dev Psychol 1992;28(5):874–886.
14. American Academy of Pediatrics, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Joint Statement — Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. Pediatrics 2009;124(2):837–844.
15. Evans B.J., Allen P.M. A systematic review of controlled trials on visual stress using Intuitive Overlays or the Intuitive Colorimeter. J Optom 2016;9(4):205–218.

16. Witzel B.S., Mercer C.D., Miller M.D. Teaching algebra to students with learning difficulties: an investigation of an explicit instruction model. J Spec Educ Technol 2003;18(3):27–34.
17. Hyatt K.J. Brain Gym: building stronger brains or wishful thinking? Remedial Spec Educ 2007;28(2):117–124.
18. Bishop D.V.M. Curing dyslexia and attention-deficit hyperactivity disorder by training motor co-ordination: Miracle or myth? Dyslexia 2007;13(1):4–7.
19. Tan M.L., Ho J.J., Teh K.H. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders. Cochrane Database Syst Rev 2012; (12):CD009398.
20. Olsen J.Z. Handwriting Without Tears. Cabin John: Handwriting Without Tears, 2008.
21. Reynolds D., Nicolson R.I., Hambly H. Evaluation of an exercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia 2003;9(1):48–71.
22. Snowling M.J., Hulme C. A critique of claims from Reynolds, Nicolson & Hambly (2003) that DDAT is an effective treatment for children with reading difficulties. Dyslexia 2003;9(2):127–133.

МКБ-11 **6A04**	**6A04 РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ (DCD)** **Developmental motor coordination disorder**
МКБ-10 F82	Специфические расстройства развития моторной функции
DSM-5-TR F82	Расстройство развития координации

1. Определение и нозология

Расстройство развития координации движений (МКБ-11: 6A04 Developmental Motor Coordination Disorder; DSM-5-TR: F82 Developmental Coordination Disorder, DCD) — нейроонтогенетическое расстройство, проявляющееся стойкими трудностями в приобретении и выполнении повседневных моторных навыков, которые являются неожиданными с учётом хронологического

возраста, интеллектуального уровня и возможностей обучения двигательным навыкам ребёнка.

Старые обозначения — «clumsy child syndrome», «developmental dyspraxia», «minimal brain dysfunction» — в современной клинической практике от них отказались, они заменены термином DCD (Polatajko H.J., Fox A.M., Missiuna C. Can J Occup Ther 1995, «Leeds Consensus 2006»).

2. История

- 1937 — Orton S.T., концепция «developmental clumsiness».
- 1960–70-е годы — «minimal brain dysfunction» (MBD) — широкий и неточный термин, впоследствии отвергнутый.
- DSM-III-R (1987) — «Расстройство координации развития» как официальная диагностическая категория.
- Лидский консенсус (2006) — международная группа экспертов стандартизировала термин «DCD»; заявление о том, что «диспраксия» и «DCD» не должны считаться синонимами (диспраксия — более узкая концепция, дефицит моторного планирования).
- EACD (англ. European Academy of Childhood Disability) Международные клинические практические рекомендации — обновление 2012, 2019 (Blank R., Barnett A.L., Cairney J. et al. Dev Med Child Neurol 2019) — международный стандарт по диагностике, обследованию и вмешательству.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — DCD включён в общую категорию нарушений нейроразвития.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 5–6% у детей школьного возраста (EACD 2019; Lingam R. et al. Pediatrics 2009, британское исследование ALSPAC n>6900).
- Пол: у мальчиков в 2–7 раз выше (существует гипотеза о недовыявлении у женщин).
- Персистирование: У 50–70% пациентов моторные трудности сохраняются во взрослом возрасте (Cantell M.H. et al. J Adolesc Res 2003 follow-up; Kirby A. et al. Res Dev Disabil 2010).
- Коморбидность: СДВГ 50%, специфическое расстройство обучения 50%, расстройство аутистического спектра 5–10%, нарушение развития

речи 20–30%, повышенный риск тревоги и депрессии в подростковом возрасте.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические и нейробиологические факторы

- Исследования наследуемости ограничены, однако семейный анамнез DCD указывается как фактор риска (Gaines R. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2008).
- Нейробиологически — атипичные модели функциональной связи мозжечка, базальных ганглиев, теменной коры и премоторных областей (Zwicker J.G. et al. Eur J Paediatr Neurol 2012 обзор фМРТ). Гипотеза дефицита внутреннего моделирования — нарушение процессов предварительного прогнозирования и сравнения перед моторным планированием (Adams I.L. et al. Dev Med Child Neurol 2014).

4.2 Факторы риска

- Преждевременные роды (<32 недели) и низкая масса тела при рождении (<1500 г) — увеличивают риск DCD в 6–8 раз (Edwards J. et al. Dev Med Child Neurol 2011 систематический обзор).
- Употребление алкоголя матерью во время беременности (компонент двигательных трудностей в спектре ФАСН).
- Перинатальные гипоксически-ишемические события.
- Наличие DCD или других нарушений нейроразвития в семейном анамнезе.

5. Клиническая картина

5.1 По областям моторных навыков

- Высокая моторика (крупная моторика): бег, прыжки, игры с мячом, езда на велосипеде, трудности с равновесием; избегание спортивной активности.
- Мелкая моторика (fine motor): Почерк некачественный и медленный, трудности с ножницами, завязыванием шнурков, застегиванием пуговиц, использованием столовых приборов.
- Моторное планирование и выполнение: Замедление в освоении новых моторных навыков; проблема последовательности и ритма.

- Зрительно-моторная интеграция: Трудности копирования, рисования, формирования букв.

5.2 Повседневное функциональное нарушение

- Самообслуживание — одежда, приём пищи, гигиена.
- Академическая деятельность — темп письма, организация листа, участие в спорте.
- Общественная деятельность — игровая площадка, спортивные команды, хобби.
- Психосоциальные последствия — снижение самооценки, тревога, депрессивное настроение, социальная изоляция (Cairney J. et al. Dev Med Child Neurol 2013).

5.3 Траектория

Ранние признаки (1–3 года) — задержка моторных этапов (сидение, стояние, первые шаги в норме или с задержкой; качество специфических движений слабое). Трудности отчётливо видны в дошкольном и раннем школьном возрасте; с возрастанием академических требований (письмо, работа с листом) нарушение становится более выраженным. Во взрослом возрасте — стойкие трудности в вождении, профессиональных требованиях, спортивной деятельности (50–70%).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · EACD 2019 консенсусные точки)

A. Приобретение и выполнение двигательных навыков — значительно ниже ожидаемого уровня с учётом хронологического возраста и возможностей моторного обучения. Трудности приводят к замедлению, неточности, дискоординации при выполнении моторных навыков.

B. Дефицит моторных навыков значительно и стойко нарушает повседневную жизнедеятельность, соответствующую хронологическому возрасту (например, самообслуживание, академическая успеваемость, профессиональная деятельность, игра и спорт).

C. Начало в раннем периоде развития.

D. Исключения — не полностью объясняется интеллектуальной недостаточностью, нарушением зрения или другим неврологическим

состоянием (например, церебральный паралич, мышечная дистрофия, дегенеративные расстройства).

6.2 Различия между источниками

- EACD 2019 (Blank et al.): четыре диагностических критерия стандартизированы — результат ниже 5–15-го перцентиля в тесте моторных навыков (Movement Assessment Battery for Children, MABC-2 или аналогичный); нарушение повседневной деятельности; начало в раннем периоде развития; не объясняется другими медицинскими состояниями. Рекомендуется мультидисциплинарная оценка (педиатр + эрготерапевт или физиотерапевт). Диагноз рекомендуется с 5 лет (после стабилизации моторных навыков); до 5 лет может использоваться термин «Временная DCD» или «задержка моторного развития».
- DSM-5-TR: Параллельные критерии с EACD; термин «диспраксия» не используется.
- МКБ-11: расстройство развития двигательной координации (6A04); подспецификаций нет.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителем и учителем — история развития, моторные этапы, проблемы повседневной деятельности.
2. Стандартизированный моторный тест — MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 лет) или BOT-2 (англ. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency).
3. Оценка функциональной повседневной активности — DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, родительская форма), адаптивный компонент VABS.
4. Тест зрения — исключение сенсорного нарушения.
5. Неврологическое обследование — исключение церебрального паралича, атаксии, нервно-мышечных заболеваний.
6. Скрининг коморбидности — СДВГ (Conners), специфическое расстройство обучения, аутизм, расстройство речи.
7. Интеллектуальная оценка — только при подозрении на общую задержку развития или интеллектуальную недостаточность.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Церебральный паралич	Спастичность, гиперрефлексия, стабильные неврологические знаки; типичные находки МРТ.
Мышечная дистрофия (Дюшенна, Беккера)	Прогрессирующая мышечная слабость; повышенный уровень КФК; семейный анамнез.
Врождённая миопатия, нейропатия	Специфические неврологические и ЭМГ находки.
Интеллектуальная инвалидность (6A00)	Моторный дефицит в контексте общего когнитивного дефицита.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Моторные стереотипии, социально-коммуникативный дефицит является основным.
СДВГ (6A05)	Дефицит внимания влияет на моторную производительность; коморбидность часта (~50%).
Нарушение зрения	Тест зрения нарушен.
Дисграфия (6A03.1)	Проблемы мелкой моторики доминируют в контексте письма; общая моторика сохранна.

7. Обследование и оценка

7.1 Стандартизированные моторные тесты

- MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 лет) — золотой стандарт; субтесты: ловкость рук, навыки работы с мячом, равновесие.
- BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 4–21 год) — широкий моторный профиль.
- DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, 5–15 лет, родительская форма) — функциональный скрининг.
- PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scales, <6 лет).

- BHK (англ. Concise Assessment Method for Children's Handwriting) — качество почерка.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных указаний нет. На основании специфического клинического подозрения:

- КК (креатинкиназа) — при подозрении на мышечную дистрофию.
- Функция щитовидной железы — при гипотиреозе возможна двигательная заторможенность.
- Генетическое исследование — при наличии синдромальных признаков.

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — только при фокальных неврологических симптомах, атаксии, стабильных дефицитах (исключение мозжечковой/церебральной патологии).
- ЭМГ/исследование нервной проводимости — подозрение на нервно-мышечное заболевание.
- Тест зрения — исходные показатели во всех случаях.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (консенсус EACD 2019)

1. DCD фармакологически не лечится. Интервенция основана на эрготерапии / физиотерапии.
2. Ранняя идентификация и вмешательство — улучшает функциональные исходы.
3. Подход «сверху вниз» (ориентированный на задачу) первой линии — превосходит по эффективности подходы «снизу вверх» (сенсомоторные) (Smits-Engelsman B.C. et al. Dev Med Child Neurol 2013 мета-анализ).
4. CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) и NTT (англ. Neuromotor Task Training) — Доказательные подходы, рекомендованные в качестве первой линии на EACD 2019.
5. Функциональные цели — выбранные пациентом и семьёй цели повседневной активности (например, езда на велосипеде, одевание, почерк).
6. Участие семьи и школы — вмешательство должно сопровождаться дома и в школе.

7. Интенсивность: 1–2 сеанса в неделю, 8–10 недель обычно начальный курс; продлевается на основе оценки эффективности.
8. Лечение коморбидности — СДВГ (стимуляторы), нарушение обучения (англ. Structured Literacy), тревога и депрессия (КПТ).
9. Академические приспособления — снижение темпа почерка, использование клавиатуры, voice-to-text, дополнительное время; индивидуализированный подход на уроках физкультуры.

8.2 Методики лечения

1. Когнитивная ориентация на повседневную деятельность (CO-OP — Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) — Полатайко (Polatajko H.), Мандич (Mandich A.) — Когнитивно-ориентированный подход «сверху вниз» (top-down) — ребёнок становится активным участником решения своих моторных проблем. Стратегия «Goal-Plan-Do-Check»: пациент выбирает цель, планирует, выполняет и оценивает. 10–14 сеансов, индивидуально. Доказательства: Smits-Engelsman B.C. et al. Dev Med Child Neurol 2013 мета-анализ — подходы «сверху вниз» превосходят подходы «снизу вверх»; Thornton A. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2016 систематический обзор. EACD 2019 — рекомендация первой линии.
2. Нейромоторное Тренировочное Задание (англ. Neuromotor Task Training, NTT) — Шумейкер (Schoemaker M.M.), Смитс-Энгельсман (Smits-Engelsman B.C.) — Задачно-ориентированный подход к моторному обучению — повторяющаяся, структурированная практика специфических моторных навыков; зрительно-моторная интеграция, равновесие, навыки работы с мячом. Доказательства: Niemeijer A.S. et al. Phys Ther 2007. EACD 2019 — доказано.
3. MABC-2 (англ. Movement Assessment Battery for Children-2) — Золотой стандарт моторной оценки; 3–16 лет. Навыки рук (3 субтеста), навыки с мячом (2), равновесие (3) — возрастные нормативные таблицы.
4. DCDQ (англ. Developmental Coordination Disorder Questionnaire) — 15 вопросов, функциональный скрининговый инструмент, заполняемый родителями (Wilson B.N. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2009 обновление).
5. BOT-2 (англ. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2) — 4–21 год, широкий моторный профиль; используется в клиническом и исследовательском контексте.
6. Программа «Partnering for Change» (CanChild) — Школьная модель вмешательства — эрготерапевт работает совместно с учителями,

проводит адаптации в контексте класса. Доказательства: Missiuna C. et al. Int J Environ Res Public Health 2017.

7. Клавиатурный тренинг и технология голос-в-текст (voice-to-text) — Академические приспособления — вспомогательные технологии для компенсации трудностей с почерком.

8.3 Различия между источниками

- EACD 2019 (Blank et al. Dev Med Child Neurol 2019): CO-OP и NTT — открытая рекомендация; доказательства для сенсорной интеграционной терапии (Ayres SI) и методов целостной имитации движений слабые/непоследовательные.
- CanChild (англ. McMaster University): «Partnering for Change» — школьная модель обучения; вмешательство интегрируется в образовательную систему.
- NICE: отдельных клинических рекомендаций по DCD нет; в рамках общей нейроонтогенетической и SEND-структуры.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Раннее выявление и вмешательство.
- CO-OP или NTT — вмешательство с доказанной эффективностью.
- Коморбидный СДВГ, расстройство обучения, управление тревогой.
- Семейная и школьная поддержка.
- Нормальный интеллектуальный уровень.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Множественные коморбидные расстройства (СДВГ + LD + DCD совместно).
- Социальная изоляция и полное избегание спортивной активности.
- Вторичная тревога, депрессия, социальная фобия.
- Поздняя идентификация.
- Интервенция недоказанными методами (только Ayres SI, программа Dore, Brain Gym).

Цели наблюдения

- Переоценка двигательных функциональных целей (3–6 месяцев).

- Мониторинг академических достижений и темпа письма.
- Социально-эмоциональное здоровье — скрининг самооценки, тревоги, депрессии (особенно важно в подростковом возрасте).
- Коморбидность — активное лечение.
- Профессиональная адаптация во взрослом возрасте — избегание или планирование приспособлений для работ, требующих моторики.
- Физическая активность и спорт — для социальной адаптации и сердечно-сосудистого здоровья; вид спорта подбирается с учётом интересов пациента (плавание, йога и другие с низкими требованиями к координации).

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Ребёнок просто ленив / слишком мало старается»

Почему распространено: ошибочное объяснение моторных трудностей как проблемы характера; ограниченные знания о моторных нарушениях в академических учреждениях.

Клиническая и биологическая логика: DCD — нарушение нейроразвития. Атипичные модели функциональной связи мозжечка, базальных ганглиев, теменной коры (обзор фМРТ Zwicker 2012); гипотеза дефицита «внутреннего моделирования» — пациент тратит больше когнитивных ресурсов на планирование и выполнение движений, что приводит к утомлению и избегающему поведению.

Доказательства: EACD 2019 (Blank et al.) — DCD является нейробиологически обоснованным расстройством; ошибочное объяснение как «проблема мотивации».

Реальный клинический шаг: Объяснить биологические основы семье и учителю; эрготерапия/физиотерапия на основе CO-OP или NTT.

Миф 2: «Ребёнок „перерастёт“ с возрастом»

Доказательства: Cantell M.H. et al. J Adolesc Res 2003, Kirby A. et al. Res Dev Disabil 2010 — долгосрочные проспективные исследования — детей с DCD 50–70% сохраняют моторные трудности во взрослом возрасте; академические и профессиональные результаты, социальная адаптация плохие. Окно для вмешательства не ограничено — эффект может наблюдаться в любом возрасте,

однако раннее вмешательство значительно улучшает социально-эмоциональные исходы.

Миф 3: «Нетерпение родителей или неправильное воспитание вызывают двигательные трудности»

Доказательства: EACD, AAP — DCD имеет генетическую и нейробиологическую основу; родительский опыт не является этиологией. Преждевременные роды, перинатальная гипоксия, семейный анамнез — основные факторы риска.

10.2 Вредные или научно необоснованные методы

Миф 4: «Сенсорная интеграционная терапия (Ayres SI) излечивает DCD»

Почему распространено: Jean Ayres в 1972 году выдвинула теорию сенсорной интеграции; широко распространена в практике эрготерапии.

Доказательства: EACD 2019 (Blank et al.) — Влияние подхода Ayres SI на функциональные двигательные показатели при DCD **не демонстрирует достаточных доказательств**; мета-анализ Smits-Engelsman 2013 — подходы «снизу вверх» (bottom-up) сенсорной интеграции значительно уступают подходам «сверху вниз» (top-down), ориентированным на задачу. AAP 2012 Sensory Integration Statement — терапевтическое использование классифицируется как «исследования продолжаются», не рекомендуется в качестве первой линии.

Реальный клинический шаг: подходы «сверху вниз» (CO-OP, NTT) — первая линия.

Миф 5: «Программа Dore (мозжечковая лечебная физкультура) излечивает DCD»

Доказательства: Bishop D.V. Dyslexia 2007, систематическая критика — методологические ограничения оригинальных исследований Reynolds-Nicolson; эффект не подтверждён в повторных исследованиях. EACD не рекомендует.

Миф 6: «Brain Gym / Образовательная кинезиология»

Доказательства: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 — утверждения не соответствуют нейробиологии; влияние на моторные и академические результаты не доказано.

Миф 7: «Визуальная терапия (упражнения для глаз) улучшает моторную координацию при DCD»

Доказательства: AAP, AAO, AAPOS 2009 — Совместное заявление: влияние терапии движения глаз на моторную координацию или нарушения обучения не доказано.

10.3 Неэффективные методы или методы, откладывающие основное вмешательство

Миф 8: «ЭЭГ-нейрофидбек улучшает двигательную функцию при DCD»

Доказательства: доказательная база нейрофидбека для специфического DCD ограничена. EACD не рекомендует; предпочтение отдаётся CO-OP и NTT.

Миф 9: «Специальная диета (добавки омега-3) улучшает DCD»

Доказательства: Richardson A.J. et al. Pediatrics 2012 (исследование Oxford-Durham) — утверждалось, что добавки омега-3 улучшают моторную функцию при DCD, но систематические обзоры (Cooper R.E. et al. J Psychopharmacol 2015) не выявили достаточных доказательств. EACD не рекомендует.

Миф 10: «Гипербарический кислород, инъекции стволовых клеток, краниосакральная терапия»

Доказательства: ни один не имеет доказательств эффективности при DCD; профиль риска значителен.

Миф 11: «Многократные спортивные тренировки (интенсивные упражнения) устраняют DCD»

Доказательства: общая физическая активность полезна, но при DCD дефицит моторного обучения требует специфического структурированного вмешательства. Режим «просто больше упражнений» вызывает у пациента неудачу и дистресс. Структурированные подходы, такие как CO-OP и NTT, имеют значительное преимущество.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A04 Developmental motor coordination disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.

3. Blank R., Barnett A.L., Cairney J., Green D., Kirby A., Polatajko H. et al. International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol 2019;61(3):242–285.
4. Lingam R., Hunt L., Golding J., Jongmans M., Emond A. Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: A UK population-based study. Pediatrics 2009;123(4):e693–e700.
5. Cantell M.H., Smyth M.M., Ahonen T.P. Two distinct pathways for developmental coordination disorder: Persistence and resolution. Hum Mov Sci 2003;22(4–5):413–431.
6. Kirby A., Edwards L., Sugden D., Rosenblum S. The development and standardization of the Adult Developmental Co-ordination Disorders/Dyspraxia Checklist (ADC). Res Dev Disabil 2010;31(1):131–139.
7. Zwicker J.G., Missiuna C., Harris S.R., Boyd L.A. Developmental coordination disorder: A review and update. Eur J Paediatr Neurol 2012;16(6):573–581.
8. Adams I.L.J., Lust J.M., Wilson P.H., Steenbergen B. Compromised motor control in children with DCD: A deficit in the internal model? Dev Med Child Neurol 2014;56(11):1043–1055.
9. Smits-Engelsman B.C., Blank R., van der Kaay A.C. et al. Efficacy of interventions to improve motor performance in children with DCD: A combined systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2013;55(3):229–237.
10. Cairney J., Veldhuizen S., Szatmari P. Motor coordination and emotional-behavioral problems in children. Curr Opin Psychiatry 2010;23(4):324–329.
11. Polatajko H.J., Mandich A.D., Miller L.T., Macnab J.J. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP): Part II — The evidence. Phys Occup Ther Pediatr 2001;20(2–3):83–106.
12. Niemeijer A.S., Smits-Engelsman B.C., Schoemaker M.M. Neuromotor task training for children with developmental coordination disorder: A controlled trial. Dev Med Child Neurol 2007;49(6):406–411.
13. Missiuna C., Pollock N., Levac D.E. et al. Partnering for Change: An innovative school-based occupational therapy service delivery model for children with developmental coordination disorder. Can J Occup Ther 2012;79(1):41–50.
14. Bishop D.V.M. Curing dyslexia and attention-deficit hyperactivity disorder by training motor co-ordination: Miracle or myth? Dyslexia 2007;13(1):4–7.

15. Cooper R.E., Tye C., Kuntsi J., Vassos E., Asherson P. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation and cognition: A systematic review and meta-analysis. J Psychopharmacol 2015;29(7):753–763.
16. Edwards J., Berube M., Erlandson K. et al. Developmental coordination disorder in school-aged children born very preterm and/or at very low birth weight: A systematic review. J Dev Behav Pediatr 2011;32(9):678–687.

	6A05 СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ)
МКБ-11 **6A05**	**Attention deficit hyperactivity disorder**
МКБ-10 F90.0	Нарушение активности и внимания
DSM-5-TR F90.0–F90.2	Синдром дефицита внимания и гиперактивности

1. Определение и нозология

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ; МКБ-11: 6A05 Attention deficit hyperactivity disorder; DSM-5-TR: F90.0–F90.2x ADHD) — нейроонтогенетическое расстройство, начинающееся в раннем периоде развития (до 12 лет), характеризующееся паттерном поведения, включающим невнимательность, гиперактивность и импульсивность, вызывающее функциональные нарушения в академической, социальной или профессиональной деятельности.

МКБ-11 и DSM-5-TR — три формы представления:

- 6A05.0 — преимущественно невнимательный тип;
- 6A05.1 — преимущественно гиперактивно-импульсивный тип;
- 6A05.2 — комбинированная презентация.

2. История

- Still G.F. (1902) — «abnormal defect of moral control» — в Голстоновских лекциях (Lancet) описал в общей сложности 43 ребёнка; из них 20 (15 мальчиков, 5 девочек) обнаруживали этот дефект без общего нарушения интеллекта и без физической болезни.
- 1937 — Bradley C. — случайное открытие терапии стимуляторами (бензедрином) у детей с поведенческими проблемами.
- DSM-II (1968) — «Гиперкинетическая реакция детства».
- DSM-III (1980) — «Расстройство дефицита внимания» (с гиперактивностью или без) — признание дефицита внимания как ядра.
- DSM-IV (1994) — Термин «СДВГ» и стандартизация 3 подтипов (невнимательный, гиперактивно-импульсивный, комбинированный).
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — термин «презентация» (presentation) вместо «подтип» — отражает возможность изменения состояния в течение времени; возраст начала повышен с 7 до 12 лет; у взрослых для диагноза количество симптомов уменьшено (в каждой категории 5 симптомов из 9 вместо 6; для лиц 17 лет и старше).

3. Эпидемиология

- Распространённость у детей: 5–7% (Polanczyk G.V. et al. Am J Psychiatry 2007 систематический обзор и мета-анализ, 102 исследования). CDC в США: 9,8% детей 3–17 лет по родительскому отчёту о когда-либо поставленном диагнозе (NSCH 2016–2019), 11,4% по данным 2022 г.; это не клиническая оценка, а сообщение родителя о ранее поставленном диагнозе.
- Распространённость у взрослых: 2,5–4% (Kessler R.C. et al. Am J Psychiatry 2006 — National Comorbidity Survey Replication).
- Пол: в детстве у мальчиков в 2–4 раза выше (у женщин диагноз чаще не ставится — меньше гиперактивности, больше невнимательности); во взрослом возрасте разница уменьшается.
- Персистирование: ~60–70% детского СДВГ сохраняется в определённой степени во взрослом возрасте (Faraone S.V. et al. Psychol Med 2006, мета-анализ).
- Коморбидность: оппозиционное вызывающее расстройство 40%, расстройство поведения 14%, тревога 25%, депрессия 15–30%, нарушения обучения 25–40%, тикозные расстройства 7–20%, расстройства аутистического спектра 30–50% (у пациентов с РАС),

риск расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в подростковом и взрослом возрасте повышен в 2–3 раза.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Наследуемость: 74% (Faraone S.V., Larsson H. Mol Psychiatry 2019 мета-анализ исследований близнецов и семей) — одно из наиболее наследуемых нарушений нейроразвития.
- Генетическая архитектура: полигенный — сотни вариантов с малым эффектом. GWAS (Demontis D. et al. Nat Genet 2019, n>55 000) выявил 12 локусов риска (FOXP2, SORCS3, DUSP6 и другие).
- Гены дофаминовой системы — DRD4, DRD5, DAT1 (SLC6A3) — гены-кандидаты; размер эффекта мал.
- CNV — редко; основные — общие вариации.

4.2 Нейробиологические механизмы

- Дисфункция дофаминергической и норадренергической систем — особенно префронтальная кора, стриатум, мозжечковая цепь; стимуляторы уменьшают симптомы, воздействуя на эти системы.
- Структурные изменения: уменьшение объёма общего мозга и специфических областей (хвостатое ядро, скорлупа, префронтальная кора) (Hoogman M. et al. Lancet Psychiatry 2017 ENIGMA-ADHD n>3000 — малые размеры эффекта).
- Функциональная связь: дисрегуляция между сетью пассивного режима работы мозга и сетью исполнительного контроля.
- Модель исполнительной функции (Barkley R.A.) — слабость торможения является основным дефицитом; влияет на рабочую память, предварительное планирование, эмоциональную регуляцию.
- Дисфункция системы вознаграждения — чувствительность к отсроченному вознаграждению (Sonuga-Barke E.J. Neurosci Biobehav Rev 2003).

4.3 Средовые факторы риска

- Преждевременные роды и низкая масса тела при рождении — повышают риск в 2–3 раза.
- Употребление матерью во время беременности табака, алкоголя, каннабиса.

- Перинатальный стресс у матери и тяжёлая психосоциальная депривация.
- Воздействие свинца в детстве.
- Ранняя черепно-мозговая травма (ЧМТ).

4.4 Точная позиция против МИФОВ об этиологии

- Сахар не вызывает СДВГ (Wolraich M.L. et al. JAMA 1995 мета-анализ).
- Экранное время / видеоигры не вызывают СДВГ (ассоциация существует, но доказательств причинно-следственной направленности нет — Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015).
- Плохое воспитание не вызывает СДВГ (наследуемость 74%); однако высококонфликтная семейная среда может влиять на тяжесть симптомов.

5. Клиническая картина

5.1 Домен невнимательности

- Невнимательность к деталям, неосторожные ошибки.
- Трудности в поддержании внимания на задачах.
- Кажется, не слушает, когда с ним говорят напрямую.
- Неполное соблюдение инструкций, оставление заданий незавершёнными.
- Трудности в организации задач и деятельности.
- Избегание задач, требующих стойких умственных усилий.
- Потеря необходимых вещей.
- Лёгкая отвлекаемость на внешние стимулы.
- Забывчивость в повседневных делах.

5.2 Домен гиперактивности и импульсивности

- Двигательное беспокойство рук и ног, ерзание на месте.
- Неспособность сидеть на месте, когда это требуется.
- Бег или лазание в неподходящих местах (у взрослых — чувство внутреннего беспокойства).
- Неспособность играть тихо.
- Поведение «как с мотором».
- Чрезмерная речь.

- Выпаливает ответ, не дослушав вопрос.
- Неспособность ждать в очереди.
- Вмешательство в разговор или деятельность других.

5.3 Возрастные различия

- Дошкольный возраст: гиперактивность доминирует; в игре внимание короткое; в социальных ситуациях контроль поведения затруднен.
- Школьный возраст: На первый план выходят академические проблемы; невнимательность влияет на академическую успеваемость.
- Подростковый возраст: двигательная гиперактивность снижается, внутреннее беспокойство и импульсивность остаются; рискованное поведение возрастает.
- Взрослый возраст: внутреннее беспокойство, трудности планирования, импульсивность в отношениях; функциональное нарушение в работе и семейной жизни.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · NICE NG87 · AAP 2019 консенсусные точки)

A. Из симптомов невнимательности и/или гиперактивности-импульсивности у детей (≤16 лет) в каждой категории не менее 6 симптомов, у взрослых (17+) не менее 5 симптомов, должен длиться не менее 6 месяцев и быть на уровне, не соответствующем возрасту.

B. Несколько симптомов должны присутствовать до 12 лет.

C. Симптомы как минимум в двух средах (например, дом + школа, дом + работа) должны наблюдаться.

D. Функциональное нарушение — значительное влияние на социальную, академическую, профессиональную деятельность.

E. Исключения — не возникает в контексте шизофрении или другого психотического расстройства; полностью не объясняется другим психиатрическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F90.0–F90.2x): Представление — невнимательный / гиперактивно-импульсивный / комбинированный; тяжесть — лёгкая,

умеренная, тяжёлая. Возраст начала повышен до 12 лет (в DSM-IV — 7).

- МКБ-11 (6A05): параллельная структура; квалификаторы «коморбидности» (аутизм, нарушение речи, интеллектуальная недостаточность).
- NICE NG87 (2018, обновление 2019): диагноз мультидисциплинарной командой (у детей — педиатр/психиатр; у взрослых — психиатр); структурированный опрос и наблюдение вместе.
- AAP 2019 (Wolraich M.L. et al. Pediatrics 2019;144(4)): алгоритм диагностики и лечения для возраста 4–18 лет на уровне первичной медицинской помощи; 4–5 лет — первая линия: тренинг родителей (PCIT, родительский тренинг управления поведением), метилфенидат второй линии; 6–11 лет — первая линия стимулятор + поведенческое вмешательство; 12–18 лет — первая линия стимулятор + поведенческое вмешательство (с согласия подростка).
- AACAP Practice Parameter (Pliszka S. JAACAP 2007): оценка коморбидности и последовательность лечения.
- CADDRA Canadian ADHD Practice Guidelines (4-е издание, 2018): Комплексный алгоритм для взрослого СДВГ.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителем и учителем (для детей) или с самим пациентом (для взрослых) — история симптомов, возраст начала, контексты.
2. Стандартизированные рейтинговые шкалы — Conners-3 (родитель/учитель/пациент), Vanderbilt (рекомендация AAP), SNAP-IV; для взрослых ASRS (англ. Adult ADHD Self-Report Scale, WHO/Kessler).
3. Клиническое интервью — подтверждение симптомов в двух контекстах, документирование функциональных нарушений.
4. Медицинское и неврологическое обследование — исключение соматических причин (тиреоид, слух, зрение, анемия).
5. Интеллектуальная и академическая оценка (WISC-V, академические тесты) — дифференциация расстройства обучения и интеллектуальной недостаточности.
6. Скрининг коморбидности — ОВР, расстройство поведения, тревога, депрессия, тикозное расстройство, аутизм, употребление ПАВ.
7. Скрининг нарушений сна и обструктивного апноэ сна (особенно при гиперактивно-импульсивном типе).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Возраст и развитие — нормальная вариация	Функциональное нарушение отсутствует, либо не наблюдается в двух контекстах.
Оппозиционно-вызывающее расстройство (6C90)	Непокорность, гнев как основа; коморбидность часта.
Расстройство поведения (6C91)	Серьёзные поведенческие нарушения, посягательство на права других.
Тревожные расстройства (6B0x)	Невнимательность из-за тревоги; соматические жалобы; начало обычно позднее.
Депрессивное расстройство (6A7x)	Аффективные симптомы доминируют; эпизодическое течение.
Биполярное расстройство (6A60–62)	Аффективные эпизоды; при детском ДДПР маниакального эпизода нет.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Социально-коммуникативный дефицит, ограниченно-повторяющееся поведение. Коморбидность часта.
Расстройство обучения (6A03)	Академический домен-специфический дефицит; проблемы внимания связаны с контекстом задачи.
Обструктивное апноэ сна	Дневная сонливость, поведенческие проблемы; полисомнография.
Гипертиреоз	Снижение ТТГ; тремор, потеря веса.
Абсансная (petit mal) эпилепсия	Кратковременные изменения сознания; ЭЭГ 3 Гц спайк-волна.
Нарушение слуха	Аудиометрия нарушена.

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические шкалы

- Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale — родитель и учитель, 6–12 лет — рекомендация AAP 2019.
- Conners-3 — комплексная оценка ДДПН и коморбидности (6–18 лет).
- SNAP-IV (Swanson, Nolan, Pelham) — 26 вопросов.
- ASRS (англ. Adult ADHD Self-Report Scale, WHO/Kessler R.C.) — 18 вопросов; краткий скрининг у взрослых пациентов.
- DIVA-5 (англ. Diagnostic Interview for ADHD in adults) — структурированное интервью.
- BRIEF-2 (англ. Behavior Rating Inventory of Executive Function) — исполнительная функция.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных специфических лабораторных указаний для СДВГ нет. На основании клинического подозрения:

- Общий анализ крови, ферритин (дефицит железа), функция щитовидной железы (ТТГ).
- Уровень свинца — при наличии факторов риска.
- Токсикологический скрининг — подозрение на употребление веществ у подростков.
- Перед началом приёма стимуляторов — ЭКГ только при наличии сердечного риска в анамнезе или семейном анамнезе (AAP, AHA 2008; рутинная ЭКГ не требуется).

7.3 Инструментальные исследования

- ЭЭГ — только при подозрении на приступ или атипичных клинических проявлениях.
- МРТ головного мозга — только при фокальных неврологических симптомах. Рутинных показаний нет.
- Нейрофизиологические тесты для диагностики (TOVA, IVA, QbTest) не имеют достаточной доказательной базы — клинический диагноз предпочтительнее стандартизированных шкал как золотой стандарт.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE NG87 · AAP 2019 · консенсус CADDRA 2018)

1. Возрастной подход (AAP 2019):
    - 4–5 лет — первая линия обучение родителей (PCIT, Triple P, Incredible Years); вторая линия — метилфенидат.
    - 6–11 лет — первая линия стимулятор + поведенческое вмешательство.
    - 12–18 лет — первая линия стимулятор + поведенческое вмешательство; согласие подростка.
    - Взрослые — стимулятор или нестимулятор + КПТ.
2. Мультимодальное вмешательство превосходит только фармакотерапию или только поведенческое вмешательство (MTA Cooperative Group. Arch Gen Psychiatry 1999, n=579 — комбинация превосходит монотерапию, но фармакотерапия сильнее, чем только поведенческое вмешательство).
3. Стимуляторы — фармакотерапия первой линии (Cortese S. et al. Lancet Psychiatry 2018 сетевой мета-анализ; у детей метилфенидат — первый выбор, у взрослых амфетамин более эффективен).
4. Нестимуляторы — атомоксетин, гуанфацин (пролонгированная форма), клонидин (пролонгированная форма). Используется при противопоказании к стимулятору или наличии побочных эффектов.
5. Поведенческое вмешательство — обучение родителей (англ. PCIT, parent management training), школьные вмешательства (модификации класса, поведенческий контракт), детская КПТ.
6. Академические приспособления — индивидуальный учебный план (IEP / 504 Plan в США; EHCP в Великобритании); дополнительное время, ограничение отвлекающих факторов, письменные вместо устных вариантов ответов.
7. Мониторинг побочных эффектов — рост и вес, артериальное давление, частота сердечных сокращений (каждые 3 месяца), сон, аппетит, настроение. При приёме стимуляторов ожидается небольшое замедление роста (1–2 см при длительном применении).
8. Лечение коморбидности — тревога/депрессия (СИОЗС + КПТ), тики (альфа-2-агонисты или с осторожностью стимуляторы), употребление ПАВ (лиздексамфетамин или атомоксетин — меньший потенциал злоупотребления), аутизм (атипичный антипсихотик при коморбидной раздражительности).

8.2 Стимуляторы (фармакотерапия первой линии)

Препарат	Форма	Диапазон доз	Примечание
Метилфенидат IR	Краткосрочная (3–4 часа)	5–60 мг/сут (2–3 приёма)	Начало титрации у детей; Cortese 2018 — первая линия у детей.
Метилфенидат ER (Concerta, Ritalin LA)	Длительная (8–12 часов)	18–72 мг/сут	Однократная суточная доза; удобно для школьного дня.
Лиздексамфетамин (Vyvanse)	Пролекарство, 12+ часов	20–70 мг/сут	Низкий потенциал ошибки (пролекарство); предпочтительно у взрослых.
Смешанные соли амфетамина (Adderall XR)	Длительная (10–12 часов)	5–30 мг/сут	У взрослых Cortese 2018 — I линия.
Дексамфетамин	IR (4 часа) / ER (8 часов)	5–40 мг/сут	—

8.3 Нестимуляторы

Препарат	Механизм	Доза	Примечание
Атомоксетин (Strattera)	Ингибитор обратного захвата норадреналина	0,5–1,4 мг/кг/сут	Эффект через 4–6 недель; незначительное повышение риска суицидальных мыслей (FDA black box).

Препарат	Механизм	Доза	Примечание
Гуанфацин ER (Intuniv)	α2A-адренергический агонист	1–7 мг/сут	Седация, гипотензия; полезно при коморбидных состояниях с тиками.
Клонидин ER (Kapvay)	α2-адренергический агонист	0,1–0,4 мг/сут	Седация; при коморбидном нарушении сна.
Вилоксазин ER (Qelbree)	ИОЗН + серотонинергический модулятор	у детей 100–400 мг/сут, у взрослых 200–600 мг/сут	FDA 2021; дети с 6 лет и взрослые.

8.4 Уточнения, специфичные для источника

- NICE NG87 (2018, обновление 2019): 5+ лет — сначала средовые изменения; затем поведенческая и/или фармакотерапия. У взрослых — первая линия стимуляторы; вторая линия атомоксетин.
- AAP 2019 (Wolraich): возрастной алгоритм описан выше.
- Cortese S. et al. Lancet Psychiatry 2018 (сетевой мета-анализ): у детей — метилфенидат первой линии; у взрослых — амфетамин первой линии (эффект выше); атомоксетин средней эффективности.
- MTA Cooperative Group (Arch Gen Psychiatry 1999, наблюдение Hechtman L. et al. JAACAP 2016): интенсивная комбинация фармакотерапии показала преимущество при 14-месячном наблюдении; однако при 36-месячном и 8-летнем наблюдении различия ослабевают — долгосрочный эффект спорен.
- Требования FDA и EMA к мониторингу: мониторинг роста и веса, исходные показатели сердечно-сосудистой системы.

8.5 Методики лечения

1. Терапия взаимодействия родителя и ребёнка (англ. Parent-Child Interaction Therapy, PCIT) — Эйберг (Eyberg S.) — Для детей 4–7 лет; две фазы — Child-Directed Interaction (CDI) и Parent-Directed Interaction (PDI). Развитие навыков управления поведением родителей с коучингом терапевта в реальном времени (in-vivo coaching). pcit.org.

2. Программа «Incredible Years» — Вебстер-Страттон (Webster-Stratton C.) — Программы для родителей, учителей и детей; групповой формат 14–22 сеанса; модель ASTPS (англ. Authoritative Stimulating Trustworthy Parenting Style).
3. Triple P — Программа позитивного родительства (англ. Positive Parenting Program) — Sanders (Sanders M.) — Созданная в Австралии 5-уровневая система — универсальный, селективный, целевой, индивидуальный. Доказанная эффективность в многочисленных РКИ.
4. Тренинг управления родителями (англ. Parent Management Training) — Баркли (Barkley) — 8–12 сеансов поведенческого тренинга родителей на основе принципов: жетонная система, тайм-аут, последовательное обучение.
5. КПТ для СДВГ у взрослых (англ. Safren CBT for Adult ADHD) — Сафрен (Safren S.A.) — Модули КПТ для взрослых с СДВГ — организация задач, планирование, управление отвлекающими факторами, когнитивная реструктуризация. Доказательства: Safren S.A. et al. JAMA 2010 РКИ.
6. Диагностическая рейтинговая шкала Вандербильта для СДВГ (англ. Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale) — Рекомендовано AAP 2019; формы для родителей и учителей, подшкалы коморбидности.
7. Шкала самоотчета СДВГ у взрослых (англ. Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) — Кесслер (Kessler R.C.), ВОЗ (WHO) — 18 вопросов; краткий раздел скрининга из 6 пунктов. Клинический и популяционный скрининг у взрослых пациентов.
8. Диагностическое интервью для СДВГ у взрослых (англ. Diagnostic Interview for ADHD in adults, DIVA-5) — Структурированное интервью для взрослых с СДВГ — по критериям DSM-5.
9. Conners-3 — Комплексная оценка 6–18 лет — симптомы СДВГ, исполнительная функция, нарушение поведения, обучение.
10. Поведенческий рейтинговый опросник исполнительной функции (англ. Behavior Rating Inventory of Executive Function, BRIEF-2) — Оценка исполнительной функции родителями и учителями — торможение, рабочая память, эмоциональная регуляция.
11. ЭЭГ-нейрофидбек (англ. EEG Neurofeedback) — Тренинг саморегуляции специфических паттернов мозговых волн (соотношение тета/бета) при СДВГ. Доказательства: мета-анализ Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 — малый размер эффекта; эффективность спорна среди экспертов в данной области. NICE NG87 — не первая линия, адъюнктивный статус.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Раннее выявление и вмешательство.
- Высокий IQ — компенсаторные стратегии.
- Стабильная и поддерживающая семейная среда.
- Активное лечение коморбидных расстройств.
- Хороший ответ на стимуляторы и поведенческое вмешательство.
- Поддержание приверженности лечению в подростковом и взрослом возрасте.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Коморбидное расстройство поведения, оппозиционно-вызывающее расстройство.
- Низкая социально-экономическая поддержка.
- Развитие употребления вещества в подростковом возрасте.
- Тяжесть дефицита исполнительной функции.
- Поздняя идентификация.
- Интервенция недоказанными методами.

Цели наблюдения

- Мониторинг симптомов и функциональных исходов (каждые 3–6 месяцев).
- Стимулянты: рост, вес, артериальное давление, частота пульса (каждые 3 месяца).
- Скрининг коморбидной тревоги, депрессии, употребления ПАВ.
- Поддержка академических и профессиональных достижений.
- Вмешательство при рискованном поведении в подростковом возрасте (обучение вождению, сексуальное здоровье, ПАВ).
- Профессиональная адаптация во взрослом возрасте, отношения, финансовое планирование — КПТ, адаптированная к СДВГ.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «СДВГ — выдуманный диагноз; дети просто активны»

Почему распространено: опасение ошибочного восприятия нормальной детской энергии как патологии; отмечаются некоторые случаи инфляции диагнозов.

Клиническая и биологическая логика: СДВГ имеет устойчивые и измеримые нейробиологические признаки — наследственность 74% (Faraone & Larsson 2019), структурные (Hoogman ENIGMA-ADHD 2017) и функциональные различия мозга; воздействие стимуляторов на специфический механизм (дофамин-норадреналин) является фармакологическим доказательством. Гиподиагностика (особенно у женщин) — более широко распространённая проблема, чем гипердиагностика.

Доказательства: APA, AAP, ВОЗ, NIMH — СДВГ — биологически обоснованное расстройство; распространённость в США по родительскому отчёту 9,8% в возрасте 3–17 лет (2016–2019) и 11,4% (2022), мета-анализ международных популяционных исследований 5–7% (Polanczyk 2007).

Реальный клинический шаг: точная диагностика со структурированными критериями; требуется функциональное нарушение (не просто поведенческая вариация).

Миф 2: «Сахар вызывает или усиливает симптомы дефицита внимания/гиперактивности»

Почему распространено: Интуиция о повышении энергии ребёнка сахаром; «Диета Фейнгольда» стала популярной в 1970-х

Доказательства: Wolraich M.L. et al. JAMA 1995 систематический обзор и мета-анализ — сахар не влияет на поведение и когнитивную деятельность детей. Wolraich M.L. NEJM 1994 РКИ — контролируемое исследование с дефицитом.

Реальный клинический шаг: общая здоровая диета, но ограничение сахара не рекомендуется в качестве вмешательства при СДВГ.

Миф 3: «Плохое воспитание вызывает СДВГ»

Доказательства: наследуемость 74% (Faraone & Larsson Mol Psychiatry 2019); родительский опыт не является этиологией. Тем не менее, среда с высоким

уровнем конфликтов может влиять на тяжесть симптомов. Родительский тренинг (PCIT, Triple P) эффективен, так как укрепляет навыки управления поведением — с целью поддержки, а не обвинения.

Миф 4: «Экранное время / видеоигры вызывают СДВГ»

Доказательства: ассоциация существует, но направление причинности спорно — дети с СДВГ больше вовлечены в экранную активность (обратная причинность); обзор Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015 — причинная роль видеоигр в развитии СДВГ не доказана. AAP — ограничения экранного времени рекомендуются для общего здоровья, но не как «причина» СДВГ.

10.2 Вредные методы «лечения» и ложные убеждения

Миф 5: «Стимуляторы вызывают зависимость как наркотики и в будущем приводят к наркомании»

Почему распространено: метилфенидат и амфетамины находятся в таблице веществ (Schedule II в США); широкое распространение страха перед «наркотиками».

Клиническая и биологическая логика: При терапевтической дозе пероральный стимулятор постепенно достигает концентрации в мозге (1–2 часа) — эйфорический эффект минимален. При внутривенном или интраназальном применении (пути злоупотребления) возникает иная фармакокинетика.

Доказательства: Wilens T.E. et al. Pediatrics 2003 мета-анализ, n=1034 — употребление психоактивных веществ во взрослом возрасте у подростков с СДВГ, получавших лечение стимуляторами снижается, не увеличивается (снижение риска ~50%). Лиздексамфетамин и метилфенидат с осмотическим высвобождением (Концерта) — низкий потенциал злоупотребления (структура пролекарства, технология OROS).

Реальный клинический шаг: при наличии коморбидного употребления веществ — предпочтительны лиздексамфетамин или атомоксетин; обучение безопасности пациента и семьи.

Миф 6: «Стимуляторы останавливают рост и развитие мозга у детей»

Доказательства: Наблюдение MTA Cooperative Group (Swanson J.M. et al. JAACAP 2017) — у детей, получавших лечение стимуляторами, взрослый рост на 1–2 см ниже (относительно ожидаемого молодого взрослого роста); это считается незначительным и клинически несущественным. Развитие мозга —

нет доказательств вреда, связанного со стимуляторами (обзор Schweren L.J.S. et al. Neuropsychopharmacology 2015).

Миф 7: «Каннабис излечивает СДВГ»

Доказательства: NIDA, NICE — каннабис не одобрен для лечения СДВГ; повышает риск психоза (Marconi 2016), приводит к когнитивным нарушениям, снижает мотивацию. Субъективный «успокаивающий» эффект маскирует функциональные нарушения.

10.3 Неэффективные или научно необоснованные методы

Миф 8: «Диета Фейнгольда или отказ от пищевых красителей/добавок излечивает СДВГ»

Доказательства: Pelsser L.M. et al. Lancet 2011 (исследование INCA) — рестрикционная элиминационная диета может влиять на поведение у некоторых детей (~30%), но систематические обзоры (Sonuga-Barke E.J. et al. Am J Psychiatry 2013, мета-анализ) показывают, что эффект отказа от пищевых добавок невелик, оказывает преимущественное влияние на оценку, проводимую семьёй, и ослабевает при слепом контроле. AAP, NICE — не первая линия; существует риск дефицита питательных веществ при комплексной диете.

Миф 9: «Добавки омега-3 — основное лечение СДВГ»

Доказательства: Cooper R.E. et al. J Psychopharmacol 2015 и Bloch M.H., Qawasmi A. JAACAP 2011 мета-анализы — малый размер эффекта ($g \approx 0{,}3$); значительно слабее стимуляторов ($g \approx 1{,}0$). Может играть адъюнктивную роль; не является основным лечением.

Миф 10: «ЭЭГ-нейрофидбек заменяет стимуляторы»

Доказательства: Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 и мета-анализ Cortese S. et al. JAACAP 2016 — эффект нейрофидбека значительно снижается при оценке пробандом и учителем; при «слепой» оценке размер эффекта мал. NICE NG87 — не первая линия. Эффект стимуляторов значительно превосходит.

Миф 11: «Принуждение к спорту излечивает СДВГ у ребёнка»

Доказательства: физическая активность может умеренно уменьшить симптомы СДВГ (адъювант); но не заменяет основное вмешательство. AAP рекомендует структурированную физическую активность, но не как монотерапию.

Миф 12: «Краниосакральная терапия, хиропрактика, гомеопатия излечивают СДВГ»

Доказательства: Cochrane и систематические обзоры — эффект этих комплементарных вмешательств при СДВГ не доказан.

Миф 13: «Светотерапия, цветные линзы MUS излечивают СДВГ»

Доказательства: доказательная база отсутствует. Позиция AAP, AAO — не доказано.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A05 Attention deficit hyperactivity disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Guideline NG87. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. 2018, updated 2019.
4. Wolraich M.L., Hagan J.F., Allan C. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Pediatrics 2019;144(4):e20192528.
5. Pliszka S., AACAP Work Group on Quality Issues. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(7):894–921.
6. Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA). Canadian ADHD Practice Guidelines, 4th ed. CADDRA; 2018.
7. Cortese S., Adamo N., Del Giovane C. et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2018;5(9):727–738.
8. MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 1999;56(12):1073–1086.
9. Hechtman L., Swanson J.M., Sibley M.H. et al. Functional adult outcomes 16 years after childhood diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder: MTA results. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(11):945–952.
10. Polanczyk G., de Lima M.S., Horta B.L., Biederman J., Rohde L.A. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007;164(6):942–948.

11. Faraone S.V., Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 2019;24(4):562–575.
12. Demontis D., Walters R.K., Martin J. et al. Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nat Genet 2019;51(1):63–75.
13. Hoogman M., Bralten J., Hibar D.P. et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. Lancet Psychiatry 2017;4(4):310–319.
14. Wolraich M., Wilson D., White J. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. JAMA 1995;274(20):1617–1621.
15. Wilens T.E., Faraone S.V., Biederman J., Gunawardene S. Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance abuse? A meta-analytic review. Pediatrics 2003;111(1):179–185.
16. Swanson J.M., Arnold L.E., Molina B.S.G. et al. Young adult outcomes in the follow-up of the multimodal treatment study of attention-deficit/hyperactivity disorder: symptom persistence, source discrepancy, and height suppression. J Child Psychol Psychiatry 2017;58(6):663–678.
17. Holtmann M., Sonuga-Barke E., Cortese S., Brandeis D. Neurofeedback for ADHD: a review of current evidence. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014;23(4):789–806.
18. Cortese S., Ferrin M., Brandeis D. et al. Neurofeedback for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(6):444–455.
19. Sonuga-Barke E.J., Brandeis D., Cortese S. et al. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am J Psychiatry 2013;170(3):275–289.
20. Bloch M.H., Qawasmi A. Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(10):991–1000.
21. Safren S.A., Sprich S., Mimiaga M.J. et al. Cognitive behavioral therapy vs relaxation with educational support for medication-treated adults with ADHD and persistent symptoms: a randomized controlled trial. JAMA 2010;304(8):875–880.

22. Barkley R.A. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull 1997;121(1):65–94.
23. Eyberg S.M., Funderburk B. Parent-Child Interaction Therapy Protocol. Gainesville: PCIT International, 2011.
24. Webster-Stratton C. The Incredible Years: Parents, Teachers and Children Training Series. Seattle: Incredible Years, 2011.
25. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.
26. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345–379.

МКБ-11 **6A06**	**6A06 СИНДРОМ СТЕРЕОТИПНЫХ ДВИЖЕНИЙ** **Stereotyped movement disorder**
МКБ-10 F98.4	Стереотипные двигательные расстройства
DSM-5-TR F98.4	Стереотипное двигательное расстройство

1. Определение и нозология

Синдром стереотипных движений (МКБ-11: 6A06 Stereotyped Movement Disorder; DSM-5-TR: F98.4 Stereotypic Movement Disorder) — нейроонтогенетическое расстройство, характеризующееся произвольными на вид, повторяющимися, ритмичными, бесцельными двигательными актами, которые мешают повседневной деятельности или наносят повреждения телу. Типичные примеры: взмахи руками (hand flapping), раскачивание тела (body rocking), удары головой (head banging), выдёргивание волос, кусание губ, игра с пальцами.

Расстройство классифицируется по двум формам:

- Первичный (primary, идиопатический) — у ребёнка с нормальным IQ, без другого нейроонтогенетического или соматического расстройства;

- Вторичный — на фоне интеллектуальной недостаточности, расстройства аутистического спектра, сенсорной депривации (нарушение зрения/слуха) или медицинского состояния.

В DSM-5-TR с квалификатором тяжести — с самоповреждением или без него.

2. История

- Kanner L. (1943) — в описании аутизма стереотипное поведение отмечено как категория ограниченно-повторяющегося поведения.
- 1960–1970-е годы — описания стереотипий в институциональных популяциях с интеллектуальной недостаточностью.
- DSM-III-R (1987) — «Стереотипное/привычное расстройство» как отдельная категория.
- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2004, 2014 — систематически описали у детей с сохранным когнитивным развитием синдром «Первичные сложные моторные стереотипии»; до этой работы такие дети обычно ошибочно диагностировались как расстройство аутистического спектра.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — включено в категорию нарушений нейроразвития; добавлен квалификатор самоповреждения.

3. Эпидемиология

- Временные стереотипии наблюдаются у 3–15% здоровых детей до 3 лет (Foster L.G. J Dev Behav Pediatr 1998).
- Первичное клиническое стереотипное двигательное расстройство — у детей с нормальным когнитивным развитием ~3–4% (Freeman R.D. et al. Mov Disord 2010).
- Вторичные формы — до 60% при интеллектуальной недостаточности; ~80% пациентов с тяжёлой и глубокой интеллектуальной недостаточностью имеют стереотипии в той или иной форме; при расстройстве аутистического спектра практически всегда присутствует в какой-либо форме (Bodfish J.W. et al. J Autism Dev Disord 2000).
- Пол: при начальных формах у мальчиков 3:1; при вторичных формах разница менее выражена.
- Возраст начала: типично до 3 лет (критерий DSM-5-TR).
- Самоповреждение (self-injurious behavior, SIB): в общей популяции редко, но при тяжёлой интеллектуальной недостаточности 25–30%, при синдромах, таких как Леша-Найхана или Корнелии де Ланге, практически всегда.

4. Этиология и патогенез

4.1 Нейробиологические механизмы

- Дисфункция базальных ганглиев и корково-стриарной цепи — нарушение процессов выбора привычек и моторного торможения (Singer H.S. Semin Pediatr Neurol 2009).
- Дофаминергическая система — Дисбаланс D1 и D2 рецепторов; в экспериментальных моделях агонисты дофамина усиливают стереотипное поведение.
- Серотонинергическая система — у некоторых пациентов СИОЗС дают частичный ответ.
- Опиоидная система — гипотеза дисрегуляции эндогенных опиоидов при формах самоповреждения (налтрексон частично эффективен).

4.2 Генетические и семейные факторы

- При первичной стереотипии отмечается семейная кластеризация — семейный анамнез 25–30% (Mahone 2014).
- Стереотипии с высокой распространённостью при специфических генетических синдромах — Ретт (MECP2), Леш-Нихана (HPRT1), Корнелии де Ланге (NIPBL), Смит-Магенис (RAI1), ломкая Х-хромосома (FMR1), Фелан-МакДермид (22q13).

4.3 Средовые и поведенческие факторы

- Сенсорная депривация — высокая частота в институциональной среде, у слепых или глухих детей.
- Поведенческие механизмы — самостимуляция (поиск сенсорного ввода), автоматическое подкрепление (intrinsic reinforcement), контекстно-зависимая функциональная связь (избегание, внимание).
- Стресс и тревожные расстройства могут усиливать тяжесть стереотипии.

5. Клиническая картина

5.1 Типичные моторные паттерны

- Взмахи руками (hand flapping) — наиболее интенсивно; при эмоциональном возбуждении или концентрации.
- Раскачивание тела (body rocking) — сидя или стоя.

- Битьё головой (head banging) — форма самоповреждения; удары о подушку, стену или пол.
- Обнимание тела, игра с пальцами, кусание губ, выдёргивание волос.
- Визуальная стимуляция — вращение рук перед глазами, смотрение на свет.
- Самоповреждающее поведение (SIB) — удары головой, укусы, удары, повреждение зубами.

5.2 Клинические особенности

- Длительность — от секунд до часов; типично 5–10 минут за один эпизод.
- Триггеры — возбуждение (приятное или стрессовое), концентрация, незанятость (свободное время).
- Остановка вниманием — поведение прекращается, когда пациента окликают или переключают на другую активность (в отличие от тиков — премониторного позыва нет).
- Функциональная роль стереотипии — самостимуляция, успокоение, контроль сенсорного раздражения.

5.3 Коморбидность

- Интеллектуальная недостаточность (при вторичных формах).
- Расстройство аутистического спектра (коморбидная 30–50% первичная стереотипия — Mahone 2014).
- СДВГ — коморбидность с первичной стереотипией 20–35%.
- Тревога и ОКР-подобные симптомы.
- Тиковые расстройства — дифференциация может быть затруднена.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. Повторяющееся, бесцельное, видимо-произвольное двигательное поведение (например, размахивание руками, раскачивание тела, удары головой, самокусание).

B. Поведение мешает социальной, академической или другой деятельности или приводит к самоповреждению.

C. Начало в раннем периоде развития (обычно до 3 лет).

D. Не полностью объясняется веществом (например, стимулятором) или неврологическим состоянием (тик, хореатетоз, дистония, дерматилломания, трихотилломания); не лучше объясняется ОКР, РАС или другим психическим расстройством (коморбидность не исключается).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F98.4): Квалификатор тяжести — с самоповреждением / без; дополнительные квалификаторы — с известным медицинским/генетическим состоянием; на фоне интеллектуальной недостаточности или аутизма.
- МКБ-11 (6A06): параллельная структура; акцент на «нецеленаправленном повторяющемся моторном поведении».
- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2014: «Первичные сложные моторные стереотипии» (PCMS) — внимание к отдельной клинической форме у детей с нормальным когнитивным развитием; типичные стереотипии рук; риск спутать с аутизмом.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителем и видеодокументирование (эпизоды, записанные семьёй на телефон, ценны для диагностики).
2. Развитие и неврологическое обследование.
3. Дифференциальная диагностика тиков и других двигательных расстройств (хорея, миоклонус, дистония) — консультация невролога.
4. Скрининг коморбидности — расстройство аутистического спектра (M-CHAT-R/F, ADOS-2), интеллектуальная недостаточность (Vineland-3, IQ), СДВГ, тревога.
5. Исключение сенсорного нарушения — тест слуха и зрения.
6. При наличии самоповреждения — функциональная оценка поведения (FBA).
7. На основании специфического клинического подозрения — генетическое исследование (CMA, FMR1, MECP2, активность HPRT при синдроме Леш-Нихана и мочевая кислота).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Тикозные расстройства (8A05)	Короткие, неритмичные, с предшествующим предвестником; возможно подавление, но отличие — ощущение «зуда» под кожей.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Стереотипия может быть коморбидной; социально-коммуникативный дефицит является основным.
ОКР — компульсии (6B20)	Эго-дистонично; ответ на обсессию; осмысленно (чистота, симметрия).
Миоклонус, хореоатетоз	Отсутствующие, неритмичные, непроизвольные; при неврологическом обследовании очаговые признаки.
Трихотилломания (6B25.0), дерматилломания (6B25.1)	Выдёргивание волос / расчёсывание кожи — в категории повторяющихся поведений, направленных на тело; отдельно от общей стереотипии.
Приступ (эпилептический)	Изменение сознания и/или постиктальное состояние; ЭЭГ.
Стимулянт-индуцированная стереотипия	Связано с высокими дозами амфетамина или кокаина; токсикологический скрининг.
Транзиторные стереотипии детского возраста (здоровые)	Функциональное нарушение отсутствует; проходит к 3 годам; не требует клинического диагноза.

7. Обследование и оценка

7.1 Клиническое интервью и шкалы

- Шкала тяжести стереотипии (SSS) — Miller J.M., Singer H.S. et al.
- Repetitive Behavior Scale-Revised (RBS-R) — при коморбидных состояниях с аутизмом и интеллектуальными нарушениями.

- Видеозаписи — записи эпизодов, сделанные семьёй дома, оцениваются клиницистом.
- Функциональный анализ поведения (FBA) — для планирования вмешательства при самоповреждении или контекстно-зависимой стереотипии.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных указаний нет. На основании клинического подозрения:

- Генетическая панель (CMA, Fragile X) — при наличии интеллектуальной недостаточности или синдромальных признаков.
- MECP2 (у девочек с синдромом Ретта).
- Активность HPRT и мочевая кислота — подозрение на синдром Леша-Найхана (самоукусы).
- Функция щитовидной железы, уровень свинца.
- Токсикологический скрининг — у подростков.

7.3 Инструментальные исследования

- ЭЭГ — при подозрении на приступ.
- МРТ головного мозга — фокальные неврологические симптомы или регресс.
- Тест слуха и зрения — для оценки роли сенсорной депривации.

8. Лечение

8.1 Общие принципы

1. Поведенческое вмешательство первой линии — индивидуализированный план на основе функционального анализа поведения.
2. При первичной стереотипии — если пациент не испытывает функциональных трудностей, наблюдение может быть достаточным (Mahone 2014). Объяснение семье природы и прогноза; принудительное вмешательство не требуется.
3. При наличии функциональных трудностей или вмешательства в социальную деятельность — HRT (англ. Habit Reversal Training), DRO (англ. Differential Reinforcement of Other behavior), RIRD (англ. Response Interruption and Redirection) — доказанные поведенческие вмешательства.

4. При самоповреждающем поведении — мультидисциплинарный подход; поведенческое вмешательство + защитные устройства (мягкий шлем) + фармакотерапия (в рефрактерных случаях).
5. Сенсорная депривация — обогащение среды (игрушки, социальное взаимодействие), альтернативные активности, обеспечивающие пациенту сенсорный ввод.
6. Лечение коморбидности — аутизм, интеллектуальная недостаточность, СДВГ, тревога.
7. Фармакотерапия имеет ограниченную доказательную базу — только в тяжёлых случаях, не отвечающих на поведенческие вмешательства; в контексте коморбидного самоповреждения или аутизма/интеллектуальной недостаточности.

8.2 Фармакотерапия (ограниченные доказательства)

- Атипичный антипсихотик (рисперидон, арипипразол) — для поведенческой агрессии и самоповреждения на фоне аутизма/интеллектуальной недостаточности; одобрение FDA — рисперидон для раздражительности при РАС 5–16 лет (включая самоповреждение), арипипразол для раздражительности при РАС 6–17 лет. Для «ядерных» симптомов стереотипного двигательного расстройства препаратов с одобрением FDA нет.
- СИОЗС — флуоксетин, сертралин — у некоторых пациентов дают умеренный эффект, особенно при коморбидных тревожных состояниях; доказательная база ограничена.
- Налтрексон — предполагается при самоповреждении (на основе гипотезы эндогенных опиоидов); доказательства РКИ ограничены, обзор Symons F.J. et al. Am J Ment Retard 2004 — малый размер эффекта.
- Клонидин, гуанфацин — может помочь при коморбидном СДВГ или нарушении сна.

8.3 Особые состояния

- Самоповреждение (SIB): экстренный анализ поведения; защитные средства (шлем, без фиксации рук) краткосрочно; интенсивное поведенческое вмешательство; фармакотерапия при рефрактерных случаях; госпитализация в тяжёлых случаях.
- Специфические генетические синдромы — При синдроме Леша-Найхана самоповреждение укусами практически постоянно; орально-

стоматологический компромисс (удаление зубов — последний выбор); аллопуринол для метаболического состояния.

- Сенсорная депривация — изменение среды, альтернативный сенсорный ввод.

8.4 Уточнения, специфичные для источника

- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2014: при начальных формах агрессивное вмешательство не требуется; разъяснение прогноза и природы заболевания семье; HRT эффективна в подростковом возрасте.
- AAP — протокол самоповреждения: мультимодальный подход у детей с умственной отсталостью.
- NICE NG11 («Проблемное поведение и нарушения обучаемости», 2015): при умственной отсталости поведенческое вмешательство — первая линия; антипсихотики только в рефрактерных случаях и краткосрочно.

8.5 Методики лечения

1. Тренинг замещения привычки (англ. Habit Reversal Training, HRT) — Азрин (Azrin N.H.), Нанн (Nunn R.G.) — Пять основных компонентов — awareness training (распознавание поведения), competing response training (обучение конкурирующему поведению), мотивационный компонент, социальная поддержка, generalization training. Доказано при стереотипном двигательном расстройстве и тикозных расстройствах. Доказательства: Specht M.W. et al. J Child Neurol 2017 РКИ — снижение тяжести при первичной сложной моторной стереотипии.
2. Дифференциальное усиление другого поведения (англ. Differential Reinforcement of Other behavior, DRO) — Положительное подкрепление интервалов времени без стереотипии (жетоны, похвала, деятельность). Эффективно на фоне интеллектуальной недостаточности. Один из основных компонентов ABA.
3. Прерывание и перенаправление реакции (англ. Response Interruption and Redirection, RIRD) — При начале стереотипии — перерыв и перенаправление на альтернативное занятие. Используется при вокальных стереотипиях и в тяжёлых случаях. Ahearn W.H. et al. J Appl Behav Anal 2007.
4. Функциональная оценка поведения (FBA — Functional Behavior Assessment) — Систематический анализ антецедентов (предшествующих условий), функциональных последствий и контекста

поведения — основа индивидуализации плана вмешательства. В рамках ABA и PBS.

5. Шкала тяжести стереотипии (англ. Stereotypy Severity Scale, SSS) — Miller (Miller J.M.), Singer (Singer H.S.) — Стандартизированная оценка частоты, продолжительности, интенсивности стереотипии и степени вмешательства.
6. Шкала повторяющегося поведения — пересмотренная (англ. Repetitive Behavior Scale-Revised, RBS-R) — Бодфиш (Bodfish J.W.) и соавт. — Родительский опросник из 43 пунктов — подшкалы стереотипии, самоповреждения, компульсивности, ритуализации, настойчивости на идентичности, ограниченного поведения. Используется при коморбидности аутизма и интеллектуальной недостаточности.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Первичная форма, нормальный IQ.
- Отсутствие самоповреждения.
- Ранний ответ на вмешательство HRT (тренинг обращения привычки).
- Отсутствие коморбидности.
- Семейная поддержка и реалистичные ожидания.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Вторичная форма — в контексте тяжёлой умственной отсталости или генетического синдрома.
- Самоповреждающее поведение — особенно при синдромах Леша-Найхана, Корнелии де Ланге.
- Коморбидное расстройство аутистического спектра.
- Отсутствие ответа на поведенческое вмешательство.

Цели наблюдения

- Частота, длительность, интенсивность стереотипии (SSS) — 3–6 месяцев.
- Мониторинг функционального нарушения и самоповреждения.
- Скрининг коморбидности (аутизм, СДВГ, тревога, ОКР).
- Поддержка социальной адаптации в подростковом и взрослом возрасте.

- У получающих фармакотерапию — мониторинг побочных эффектов (метаболических, ЭПС).

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Стереотипия — всегда признак аутизма»

Почему распространено: включение стереотипий в критерии DSM-5 для аутизма и их первоочередная связь с аутизмом в масс-медиа.

Клиническая и биологическая логика: Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2004, 2014 — «Первичные сложные моторные стереотипии». Синдром может возникать у детей с нормальным когнитивным развитием без дефицита социального взаимодействия или ограниченно-повторяющихся паттернов поведения. У 30–50% этих детей может быть коморбидный аутизм или СДВГ, но у большинства их нет.

Доказательства: Mahone 2014; Freeman R.D. et al. Mov Disord 2010 — первичная стереотипия является отдельной клинической единицей, отличной от аутизма.

Реальный клинический шаг: для каждого ребёнка со стереотипным поведением следует отдельно оценивать спектр аутизма как дифференциальный диагноз; при отсутствии коморбидности семью не следует запугивать.

Миф 2: «Стереотипия — результат плохого воспитания или эмоциональной депривации»

Почему распространено: В 1960-х годах наблюдения высокой распространённости у институционализированных детей укрепили теорию «депривации».

Доказательства: Bodfish J.W. et al. J Autism Dev Disord 2000 — стереотипия является нейробиологически обоснованным расстройством, связанным с дисфункцией базальных ганглиев и корково-стриарной петли. Сенсорная депривация может влиять на тяжесть, но не является этиологией. Наблюдается также у детей, растущих в здоровых, поддерживающих семьях.

Миф 3: «Ребёнок перерастёт с возрастом — ничего делать не нужно»

Доказательства: Транзиторные стереотипии детского возраста проходят к 3 годам; однако первичная клиническая стереотипия типично продолжается —

лонгитюдные исследования Mahone 2014 документировали до взрослого возраста. Семье необходимо объяснить реальный прогноз; при самоповреждении или функциональных нарушениях требуется вмешательство.

10.2 Вредные или ошибочные методы

Миф 4: «Физическое ограничение ребёнка (связывание рук, остановка движений) устраняет стереотипию»

Почему распространено: интуитивно кажется, что «удержание» поведения устраняет симптом.

Клиническая логика и доказательства: длительное физическое стеснение контрпродуктивно — усиливает дистресс пациента, нарушает автономию, вызывает повреждение кожи и контрактуры. NICE NG11 (2015), AAP — фиксация только в экстренных и краткосрочных ситуациях самоповреждения с защитной целью; не рекомендуется как постоянное лечение. Предпочтительно позитивное поведенческое вмешательство (PBS) на основе функционального анализа поведения.

Миф 5: «Наказание (резкое перенаправление, выговор, физическое наказание) устраняет стереотипию»

Доказательства: NICE NG11 — подход, основанный на наказании, неэффективен для снижения поведения; создаёт риск эмоционального вреда и травмы. Современная практика ABA также основана на положительном подкреплении (DRO) вместо наказания.

Миф 6: «Антипсихотики эффективны при всех стереотипных движениях»

Доказательства: антипсихотики (рисперидон, арипипразол) одобрены FDA для раздражительности при РАС — включая самоповреждение. Для первичной стереотипии одобрения FDA нет; влияние на «ядерную» стереотипию ограничено. Бремя побочных эффектов (метаболические, ЭПС, пролактин) значительно. NICE NG11 — антипсихотики только при рефрактерном тяжёлом поведении и краткосрочно.

10.3 Неэффективные или научно необоснованные методы

Миф 7: «Сенсорно-интегративная терапия (Ayres SI) излечивает стереотипии»

Доказательства: AAP 2012 — заявление по сенсорной интеграции: терапевтический эффект классифицируется как «требующий дальнейших исследований»; доказательства специфического эффекта при стереотипном поведении слабы. Функциональное поведенческое вмешательство (HRT, DRO) превосходит по доказательствам.

Миф 8: «Гипербарическая оксигенация, инъекции стволовых клеток, хелатирование устраняют стереотипии»

Доказательства: Предупреждения Cochrane и FDA (та же позиция на фоне аутизма) — эти вмешательства не имеют эффекта при стереотипии или нейроонтогенетическом расстройстве, профиль риска значителен.

Миф 9: «Специальная диета (безглютеновая, безказеиновая) устраняет стереотипии»

Доказательства: Hyman S.L. et al. AAP 2020 — эффект специальной диеты при стереотипии или аутизме не доказан.

Миф 10: «ЭЭГ-нейрофидбек устраняет стереотипии»

Доказательства: доказательная база нейрофидбека для стереотипного двигательного расстройства отсутствует. При СДВГ умеренный эффект, но экстраполяция на стереотипное поведение необоснованна.

Миф 11: «Гомеопатия, акупунктура, краниосакральная терапия»

Доказательства: ни для одного из них не доказана эффективность при стереотипном двигательном расстройстве.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A06 Stereotyped movement disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Mahone E.M., Bridges D., Prahme C., Singer H.S. Repetitive arm and hand movements (complex motor stereotypies) in children. J Child Neurol 2004;19(5):379–383.

4. Singer H.S. Motor stereotypies. Semin Pediatr Neurol 2009;16(2):77–81.
5. Freeman R.D., Soltanifar A., Baer S. Stereotypic movement disorder: easily missed. Dev Med Child Neurol 2010;52(8):733–738.
6. Bodfish J.W., Symons F.J., Parker D.E., Lewis M.H. Varieties of repetitive behavior in autism: comparisons to mental retardation. J Autism Dev Disord 2000;30(3):237–243.
7. Specht M.W., Mahone E.M., Kline T. et al. Efficacy of parent-delivered behavioral therapy for primary complex motor stereotypies. J Child Neurol 2017;32(2):204–212.
8. NICE Guideline NG11. Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges. 2015.
9. Symons F.J., Thompson A., Rodriguez M.C. Self-injurious behavior and the efficacy of naltrexone treatment: a quantitative synthesis. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2004;10(3):193–200.
10. Ahearn W.H., Clark K.M., MacDonald R.P., Chung B.I. Assessing and treating vocal stereotypy in children with autism. J Appl Behav Anal 2007;40(2):263–275.
11. Foster L.G. Nervous habits and stereotyped behaviors in preschool children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37(7):711–717.
12. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.
13. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.
14. Miller J.M., Singer H.S., Bridges D.D., Waranch H.R. Behavioral therapy for treatment of stereotypic movements in nonautistic children. J Child Neurol 2006;21(2):119–125.

МКБ-11 **8A05.0**	**8A05.0 ПЕРВИЧНЫЕ ТИКИ ИЛИ ТИКОЗНЫЕ РАССТРОЙСТВА** **Primary tics or tic disorders**
МКБ-10 F95.2	Комбинированные вокализмы и множественные моторные тики [синдром де ла Туретта]

МКБ-11 **8A05.0**	**8A05.0 ПЕРВИЧНЫЕ ТИКИ ИЛИ ТИКОЗНЫЕ РАССТРОЙСТВА** **Primary tics or tic disorders**
DSM-5-TR F95.2	Синдром Туретта (и другие тикозные расстройства F95.0–F95.1)

1. Определение и нозология

Первичные тики или тикозные расстройства (МКБ-11: 8A05.0 Primary Tics or Tic Disorders; DSM-5-TR: F95.0–F95.2) — группа нарушений нейроразвития, характеризующаяся внезапными, быстрыми, повторяющимися, неритмичными, непроизвольными или полупроизвольными двигательными актами и/или вокальными/звуковыми проявлениями. Тикам обычно предшествует предвестниковое ощущение (предшествующее побуждение или напряжение); тики могут быть кратковременно подавлены волевым усилием.

МКБ-11 и DSM-5-TR — три основные категории:

- Синдром Туретта (DSM-5-TR F95.2) — множественные моторные тики и один или несколько вокальных тиков длительностью ≥ 1 года, начало до 18 лет;
- Стойкое (хроническое) моторное или вокальное тикозное расстройство (DSM-5-TR F95.1) — моторный или вокальный (но не оба одновременно) ≥ 1 года;
- Временное тикозное расстройство (DSM-5-TR F95.0) — тик (моторный и/или голосовой) < 1 год, начало до 18 лет.

2. История

- Itard J.M.G. (1825) — первое клиническое описание моторных и вокальных тиков у маркизы де Дампьер.
- Gilles de la Tourette G. (1885) — Классическое описание 9 пациентов по указанию Charcot в больнице Сальпетриер; название синдрома.
- 1960-е годы — психоаналитическое объяснение было доминирующим («невротическое расстройство»).

- 1961 (Seignot J.N.) — первое клиническое применение галоперидола выявило эффект при тиках — основа перехода к нейробиологической концепции.
- DSM-III (1980) и последующие редакции — формализация тиков как медицинского расстройства.
- AAN 2019 (Pringsheim T. et al. Neurology 2019;92(19)) — международное клиническое руководство, основанное на доказательствах; подчеркнуто, что α2-агонисты имеют более благоприятный профиль побочных эффектов по сравнению с антипсихотиками и являются первой линией.
- ESSTS — European Society for the Study of Tourette Syndrome — Европейские клинические рекомендации (2011, обновление 2022).

3. Эпидемиология

- Распространённость синдрома Туретта: у детей 0,5–1% (Knight T. et al. Pediatr Neurol 2012, систематический обзор).
- Стойкий моторный или вокальный тик: ~1–2%.
- Транзиторные тики: у до 20% детей школьного возраста.
- Пол: у мужчин в 3–4 раза выше.
- Возраст начала: 5–7 лет; пик тяжести 10–12 лет.
- Персистирование: Тики во взрослом возрасте ~50% уменьшаются, ~30% сохраняются; ~20% остаются в тяжёлой форме (Bloch M.H., Leckman J.F. J Psychosom Res 2009).
- Коморбидность: СДВГ 50–60%, ОКР 30–50%, тревога 30%, депрессия 20%, расстройство обучения 20–30%, гневливые вспышки, нарушения сна.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Наследуемость: 0,77 (Mataix-Cols D. et al. JAMA Psychiatry 2015, семейные и близнецовые исследования, n>200 000, Швеция) — одно из наиболее наследуемых психиатрических расстройств.
- Полигенная природа: GWAS (Yu D. et al. Am J Psychiatry 2019) — выявлены локусы риска; единого гена нет.
- Редкие мутации: SLITRK1, HDC (гистидиндекарбоксилаза), CELSR3 — в небольшом числе семей.

- Высокая плотность ОКР и СДВГ в семейном анамнезе — генетическое перекрытие.

4.2 Нейробиологические механизмы

- Дисфункция кортико-стриато-таламо-кортикальной (CSTC) цепи — нарушение моторного торможения в базальных ганглиях и связанных областях (Leckman J.F. et al. Neuron 2000;28(2):349–354).
- Гиперактивность дофаминергической системы — механизм уменьшения тиков антагонистами дофамина (галоперидол, рисперидон).
- Гистаминергическая система — Мутации HDC в редких случаях; снижение гистаминергического тонуса.
- Структурные изменения: уменьшение объёма хвостатого ядра, сенсомоторное кортикальное истончение (Sowell E.R. et al. Nat Neurosci 2008).

4.3 Средовые факторы (модификатор)

- Преждевременные роды, перинатальная гипоксия — умеренно повышают риск.
- Употребление табака матерью во время беременности.
- Психосоциальный стресс — не является причиной начала тиков, влияет на тяжесть.
- PANDAS / PANS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections / Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) — редко; большинство случаев на самом деле типичный Tourette/ОКР (см. расширенный §10).

5. Клиническая картина

5.1 Моторные тики

- Простые моторные тики: моргание (наиболее частое начало), шмыганье носом, качание головой, пожимание плечами, игра губами.
- Сложные моторные тики: последовательные движения — подпрыгивание, прикосновение, поворот вокруг себя; редко непристойные жесты (копропраксия, ~5%).

5.2 Вокальные/голосовые тики

- Простые вокальные: кашель, шмыганье носом, свистящее дыхание, откашливание, выкрики.

- Сложные вокальные: Эхолалия (повторение чужих слов), палилалия (повторение собственных слов).
- Копролалия (нецензурное слово/выражение) — встречается у 19,3% мужчин и 14,6% женщин с синдромом Туретта (Freeman R.D. et al. Dev Med Child Neurol 2009, международная база данных Tourette, n=597), отличается от образа в СМИ.

5.3 Предвестниковое ощущение и произвольное подавление

Большинство пациентов — до тика предвестниковое ощущение (соматическое побуждение, напряжение) отмечает; тик временно облегчает это ощущение. Тики могут быть кратковременно подавлены волевым усилием (от секунд до минут), но это подавление вызывает внутреннее напряжение и дискомфорт — последующий тиковый эпизод обычно более интенсивный.

5.4 Течение и изменчивость

- Тики — «волнообразное течение»: выраженность нарастает и убывает; один тип тика заменяется другим.
- Триггеры — стресс (приятный или неприятный), волнение, усталость, определённые контексты (например, подавление тиков в школе).
- Тики во сне уменьшаются, но полностью не исчезают.
- Пик тяжести 10–12 лет; в подростковом возрасте снижение у большинства пациентов.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · AAN 2019 консенсусные точки)

Для синдрома Туретта:

1. Множественные моторные тики и один или несколько вокальных тиков (возникавших в разное время, не обязательно одновременно).
2. Тики продолжаются не менее 1 года (со временем могут меняться).
3. Начало до 18 лет.
4. Исключения — не полностью объясняется веществом (напр. кокаин) или медицинским состоянием (Хантингтон, поствирусный энцефалит).

Стойкое расстройство с моторными или вокальными тиками: Те же критерии, что и для синдрома Туретта, но однотипный тик (моторный или вокальный, не оба одновременно).

Транзиторное тикозное расстройство: Те же критерии, что и для синдрома Туретта, но длительность < 1 года.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: три отдельные категории (F95.0, F95.1, F95.2). «Функциональное нарушение» и «тяжесть» не включены в диагностические требования — достаточно соответствия критериям для диагностики; однако решение о вмешательстве основывается на функциональном нарушении.
- МКБ-11 (8A05.0): «Первичные тики или тикозные расстройства» — подспецификации: синдром Туретта, хронические, транзиторные.
- AAN 2019 (Pringsheim T. et al.): диагноз клинический, видеозаписи помогают; YGTSS (Йельская шкала тяжести тиков) для исходных показателей и отслеживания; коморбидность (СДВГ, ОКР) обязательно оценивается.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl K.R. et al.): В европейском контексте — те же критерии; CBIT рассматривается как терапия первой линии среди немедикаментозных вмешательств.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителем и пациентом — возраст начала, течение, триггеры, премониторное ощущение.
2. Видеозаписи — эпизоды, снятые семьёй дома (в клиническом контексте тики часто уменьшаются).
3. Стандартизированная шкала — YGTSS (Yale Global Tic Severity Scale, исходные показатели и мониторинг).
4. Скрининг коморбидности — СДВГ (Conners, Vanderbilt), ОКР (CY-BOCS), тревога, депрессия, расстройство обучения, сон.
5. Неврологическое обследование — исключение очаговых симптомов, хореатетоза.
6. При специфическом клиническом подозрении — болезнь Гентингтона (ген HTT), болезнь Вильсона (церулоплазмин, медь), нейроакантоцитоз.
7. Подозрение на PANDAS/PANS — только при наличии классической клинической картины (быстрое начало, ОКР + тики + эмоциональная лабильность после стрептококка); рутинное тестирование на антистрептолизин О не рекомендуется (NIMH 2017).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Стереотипное двигательное расстройство (6A06)	Ритмичные, более длительные (секунды-минуты), предчувствия отсутствуют; начало <3 лет.
Миоклонус	Короткие, внезапные, непроизвольные, без предвестников; неврологическая этиология.
Хореоатетоз, дистония	Стойкие непроизвольные движения; подавление невозможно; неврологическое обследование.
ОКР (6B20) — компульсии	Эго-дистонические целенаправленные последовательности; ответ на обсессию. Коморбидность часта.
Функциональный тик (functional tic-like behavior)	Быстрое начало в период полового созревания, сложные причудливые модели, копирование из средств массовой информации; увеличение наблюдалось в период COVID-19 (Pringsheim T. et al. Mov Disord Clin Pract 2021).
PANDAS/PANS	Быстрое начало после стрептококка; одновременная вспышка ОКР + тики; редко.
Приступ (эпилептический)	Изменение сознания; ЭЭГ.
Болезнь Вильсона	Печёночные и неврологические симптомы; кольца Кайзера-Флейшера, снижение церулоплазмина.
Болезнь Гентингтона	Типичное начало в зрелом возрасте; хорея, когнитивное снижение, семейный анамнез.

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические шкалы

- YGTSS (англ. Yale Global Tic Severity Scale, Leckman J.F. et al. 1989) — отдельно для моторных и вокальных тиков; частота, интенсивность, сложность, вмешательство, количество по шкале 0–5 баллов; глобальное нарушение 0–50. Исходные показатели и мониторинг лечения.
- PUTS (англ. Premonitory Urge for Tics Scale).
- CY-BOCS — оценка коморбидного ОКР.
- Conners-3, Vanderbilt — коморбидный СДВГ.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных специфических лабораторных указаний для тиков нет. На основании клинического подозрения:

- Функция щитовидной железы (ТТГ) — в контексте гипертиреоза.
- Церулоплазмин, суточная моча на медь — подозрение на болезнь Вильсона (особенно при печёночных или двигательных нарушениях).
- HTT — подозрение на хорею Гентингтона (семейный анамнез).
- Антитела к стрептококку (АСЛ-О, анти-ДНКаза В) — только при классической клинической картине PANDAS; рутинно не рекомендуется.

7.3 Инструментальные исследования

- ЭЭГ — только при подозрении на приступ.
- МРТ головного мозга — фокальные неврологические симптомы, атипичная клиническая картина.
- Рутинная нейровизуализация при тиках не рекомендуется.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (AAN 2019 · консенсус ESSTS 2022)

1. Решение об интервенции основывается на функциональном нарушении — могут наблюдаться лёгкие тики; агрессивного вмешательства не требуется.
2. Психообразование для семьи и школы — первый шаг — природа тиков, «waxing and waning», премониторное ощущение.

3. Поведенческое вмешательство — CBIT (Комплексное поведенческое вмешательство при тиках) AAN 2019 — рекомендация первой линии (8+ лет). HRT (тренинг изменения привычек) + функциональное вмешательство + релаксация.
4. Фармакотерапия — при функциональных нарушениях и если CBIT недоступна или недостаточно эффективна:
    - Первая линия: α2-адренергические агонисты — клонидин, гуанфацин (ER) — профиль побочных эффектов превосходит антипсихотики; особенно полезны при коморбидном СДВГ.
    - Вторая линия: Атипичный антипсихотик — арипипразол (одобрен FDA при синдроме Туретта в возрасте 6–18 лет, 2014), рисперидон, зипрасидон. Более сильный антитик-эффект, но метаболические и экстрапирамидные побочные эффекты.
    - Третья линия: типичный антипсихотик — галоперидол, пимозид (одобрен FDA для синдрома Туретта, но риск ЭПС и удлинения QTc).
    - Рефрактерные состояния — ингибиторы VMAT2 (тетрабеназин off-label; дейтетрабеназин и вальбеназин исследуются при тиках), ботулинический токсин при фокальных тиках.
5. Лечение коморбидности — СДВГ (стимуляторы значимо не усиливают тики — мета-анализ Bloch M.H. et al. JAACAP 2009; но пациенты должны наблюдаться), ОКР (СИОЗС + КПТ), тревога, сон.
6. При рефрактерном тяжёлом синдроме Туретта — Глубокая стимуляция мозга (DBS) — мишени: таламическое центромедиан-парафасцикулярное ядро или GPi (внутренний сегмент бледного шара); мультидисциплинарный отбор в сертифицированном центре (Schrock L.E. et al. Mov Disord 2015).

8.2 Фармакотерапия — первая линия (α2-агонисты)

Препарат	**Форма**	**Диапазон доз**	**Примечание**
Клонидин	IR / TDS (transdermal)	0,05–0,3 мг/сут (раздельно или TDS)	Седация, гипотензия; полезно при коморбидных состояниях с СДВГ.

Препарат	Форма	Диапазон доз	Примечание
Гуанфацин ER	Длительная	1–4 мг/сут (однократно)	Меньшая седация, селективный α2A; одобрен FDA при СДВГ.

8.3 Вторая линия (атипичный антипсихотик)

Препарат	Диапазон доз	Профиль побочных эффектов
Арипипразол	2–20 мг/сут	Акатизия, седация; метаболически лучше.
Рисперидон	0,25–6 мг/сут	Увеличение веса, повышение пролактина, ЭПС.
Зипрасидон	20–80 мг/сут	Удлинение QTc, ЭКГ-мониторинг.

8.4 Третья линия (типичный антипсихотик)

- Галоперидол 0,5–4 мг/сут — одобрение FDA для синдрома Туретта, но побочные эффекты: ЭПС, поздняя дискинезия, седация.
- Пимозид 1–4 мг/сут — одобрение FDA при Tourette; удлинение QTc, ЭКГ обязательно.

8.5 Подход при коморбидных состояниях

- СДВГ + тики: α2-агонист + стимулятор или атомоксетин. Стимулянты исторически считались спорными «усилителями тиков», но мета-анализ Bloch 2009 и исследование TACT (Tourette’s Syndrome Study Group. Neurology 2002;58(4):527–536) показали, что метилфенидат в средних дозах значимо не усиливает тики; мониторинг.
- ОКР + тики: СИОЗС + ЭРП; арипипразол или рисперидон адъюнктивно.
- Расстройство сна: Мелатонин; клонидин также помогает при компоненте сна.

8.6 Уточнения, специфичные для источника

- AAN 2019 (Pringsheim Neurology 2019): CBIT — первая линия нефармакологического лечения; α2-агонисты перед антипсихотиками (благоприятный профиль побочных эффектов); двойная польза при коморбидном СДВГ.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl): В европейском контексте; выбор CBIT и фармакотерапии индивидуализируется в зависимости от особенностей пациента.
- Piacentini J. et al. JAMA 2010 (ключевое РКИ КПТ): n=126, 9–17 лет — CBIT значимо превосходит плацебо (поддерживающую терапию); снижение по YGTSS на 7,6 против 3,5 балла; размер эффекта g = 0,68.
- Tourette Association of America Behavioral Sciences Consortium — Внедрение программы CBIT и обучение терапевтов.

8.7 Методики лечения

1. Комплексное поведенческое вмешательство при тиках (англ. Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, CBIT) — Вудс (Woods D.W.), Пьячентини (Piacentini J.) — Немедикаментозное вмешательство первой линии (AAN 2019). Три основных компонента: (1) Habit Reversal Training (HRT — распознавание премониторных ощущений, обучение конкурирующему поведению); (2) функциональное вмешательство (изменение контекстов, усиливающих тики); (3) тренинг релаксации. Стандартный курс — 8 индивидуальных сеансов, 10 недель; поддерживающие повторные сеансы. Доказательства: Piacentini J. et al. JAMA 2010 РКИ — ключевое исследование; Wilhelm S. et al. Arch Gen Psychiatry 2012 РКИ у взрослых; средний размер эффекта. tourette.org.
2. Тренинг замещения привычки (англ. Habit Reversal Training, HRT) — Азрин (Azrin N.H.), Нанн (Nunn R.G.) — Центральный компонент CBIT — awareness training + competing response. Для каждого тика отдельное конкурирующее поведение (напр., удержание шеи по центру вместо запрокидывания).
3. Экспозиция и предотвращение реакции (англ. Exposure and Response Prevention, ERP) при тиках — Альтернативный поведенческий подход к HRT — пациент учится выдерживать премониторное ощущение, не реагируя тиком. Verdellen C.W. et al. Behav Res Ther 2004. ESSTS — альтернативный доказательный поведенческий метод.
4. Йельская глобальная шкала тяжести тиков (англ. Yale Global Tic Severity Scale, YGTSS) — Лекман (Leckman J.F.) и др., 1989 — Золотой стандарт шкалы тяжести при тикозных расстройствах; отдельный

подсчёт для моторных и вокальных тиков: количество, частота, интенсивность, сложность, степень вмешательства (0–5 баллов); глобальное нарушение 0–50. Исходные показатели и мониторинг.

5. Шкала предшествующего тикам позыва (англ. Premonitory Urge for Tics Scale, PUTS) — Вудс (Woods D.W.), Пьячентини (Piacentini J.) — 9-пунктовая шкала самооценки; интенсивность премониторного ощущения и его влияние на интерференционное поведение.
6. Глубокая стимуляция мозга (DBS — Deep Brain Stimulation) — Хирургическое вмешательство при рефрактерном тяжёлом синдроме Туретта; типичные мишени — таламус (центромедианный-парафасцикулярный) и внутренний сегмент бледного шара (GPi). Мультидисциплинарный отбор; Schrock L.E. et al. Mov Disord 2015 международный консенсус.
7. Ботулотоксин — Инъекции в целевую мышцу при фокальных моторных (напр., шея, губа, глаз) и вокальных тиках; эффект на 3–4 месяца. Marras C. et al. Neurology 2001 РКИ.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Типичное тикозное расстройство (в отличие от быстрого функционального тик-подобного поведения).
- Лёгкая-умеренная тяжесть по YGTSS.
- Активное управление коморбидностью (СДВГ, ОКР).
- Раннее психообразование и поддержка семьи и школы.
- Доступность CBIT.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Тяжёлая коморбидность (тяжёлое ОКР, СДВГ, тревога, депрессия).
- Самоповреждающие тики (напр., удары головой).
- Социальная и академическая ограниченная адаптация.
- Рефрактерный ответ на фармакотерапию.

Цели наблюдения

- YGTSS каждые 3–6 месяцев.
- Коморбидность (СДВГ, ОКР, тревога, депрессия) — ежегодно.
- Мониторинг побочных эффектов (у принимающих антипсихотики — метаболические, ЭПС, пролактин, QTc).

- Социальная и академическая поддержка.
- Вероятность спонтанного снижения в подростковом возрасте; возможность постепенного снижения фармакотерапии.
- Поддержка профессии и отношений у взрослых пациентов.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Синдром Туретта обязательно сопровождается копролалией (бранными словами)»

Почему распространено: Образ Туретта в СМИ (кино, телевидение) почти всегда представляется с копролалией; сенсационный отбор СМИ.

Клиническая и биологическая логика: копролалия — редкая форма сложного вокального тика; у большинства пациентов с синдромом Туретта ни моторные, ни вокальные тики не имеют непристойного характера.

Доказательства: Freeman R.D. et al. Dev Med Child Neurol 2009 — база данных Международной ассоциации синдрома Туретта n=597: копролалия встречается у 19,3% мужчин и 14,6% женщин.

Реальный клинический шаг: Информирование семьи и школы; снижение социальной стигмы пациента.

Миф 2: «Синдром Туретта — результат плохого воспитания или родительской ошибки»

Доказательства: наследуемость 0,77 (Mataix-Cols JAMA Psychiatry 2015) — одна из самых высоких среди психиатрических расстройств. Имеет генетическую и нейробиологическую основу; родительский опыт не является этиологией.

Миф 3: «Синдром Туретта возникает из-за эмоциональной травмы или стресса»

Клиническая логика: стресс не является причиной возникновения тиков — тики имеют генетическую и нейроонтогенетическую основу. Однако стресс влияет на тяжесть существующих тиков.

Миф 4: «Все тики — это ПАНДАС, и их нужно лечить антибиотиками»

Почему распространено: В 1990-х годах гипотеза PANDAS (англ. Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) Сьюзан Сведо и коллег и маркетинг альтернативных клиник.

Клиническая и биологическая логика: Классическая клиническая картина PANDAS — быстрое (часы-дни) начало ОКР/тик + эмоциональная лабильность + постстрептококковая инфекция — редкое явление. Большинство пациентов с тиками демонстрируют типичное течение (постепенное начало, «waxing and waning»).

Доказательства: NIMH 2017, клиническое заключение по PANDAS/PANS: рутинное определение антистрептолизина О или антибиотикопрофилактика при обычных тикозных расстройствах не рекомендуется; оценивается только при наличии классической клинической картины. Рутинное применение ВВИГ и плазмафереза не доказано (только в рамках клинических исследований).

10.2 Вредные или ошибочные методы

Миф 5: «При тиках строгий выговор или наказание ребёнка устранят тики»

Клиническая логика: тики могут частично подавляться волевым усилием, но длительное подавление приводит к нарастанию внутреннего напряжения и последующему «рикошетному» взрыву тиков. Наказание не уменьшает тики, а, наоборот, усиливает связанный с ними стресс.

Доказательства: AAN 2019, ESSTS 2022 — тики не являются произвольным поведением; карательный подход неэффективен и вреден.

Миф 6: «Антипсихотик галоперидол должен быть первой линией у всех пациентов с тиками»

Доказательства: AAN 2019 (Pringsheim) — α2-агонисты (клонидин, гуанфацин) до антипсихотиков рекомендуется, так как профиль побочных эффектов благоприятный. Галоперидол и пимозид одобрены FDA, но из-за рисков EPS, поздней дискинезии, седации, пролактина и удлинения QTc занимают статус третьей линии.

Миф 7: «Стимуляторы вызывают взрыв тиков — пациенту с СДВГ и синдромом Туретта стимуляторы противопоказаны»

Доказательства: Bloch M.H. et al. JAACAP 2009 мета-анализ (n=9 РКИ, n=477) и TACT (Treatment of ADHD in Children with Tics; Tourette’s Syndrome Study

Group. Neurology 2002;58(4):527–536) — метилфенидат в средних дозах значимо не усиливает тики; у некоторых пациентов даже снижают тяжесть тиков. Коморбидное СДВГ составляет основную часть функциональных нарушений — считать стимулятор противопоказанным ошибочно.

Реальный клинический шаг: при коморбидном СДВГ начните со стимулятора, мониторируйте пациента на выраженность тиков; при усилении снизьте дозу или комбинируйте α2-агонист + стимулятор.

10.3 Неэффективные или научно необоснованные методы

Миф 8: «Каннабис (медицинская марихуана) — эффективное лечение синдрома Туретта»

Почему распространено: анекдотические сообщения в социальных сетях, маркетинг каннабисной индустрии, скромные эффекты в некоторых пилотных исследованиях.

Доказательства: Исследования Müller-Vahl K.R. (малые РКИ) — THC может частично уменьшать тики, но доказательная база недостаточна для клинической рекомендации. AAN 2019 — каннабиноиды не являются стандартной первой линией; профиль риска (риск психоза у подростков, когнитивное влияние, зависимость) значителен. Может рассматриваться только в рефрактерных случаях у взрослых и при разрешении законодательства страны.

Миф 9: «Специальная диета (безглютеновая, безказеиновая) или отказ от пищевых добавок устраняет синдром Туретта»

Доказательства: специфических клинических доказательств нет; AAP, AAN не рекомендуют.

Миф 10: «ЭЭГ-нейрофидбек уменьшает тики»

Доказательства: доказательная база ограничена; AAN 2019 — не первая линия; CBIT значительно превосходит.

Миф 11: «Мегадозы витаминов, омега-3, магний устраняют тики»

Доказательства: эффективность этих добавок при синдроме Туретта не доказана; AAN 2019 и ESSTS 2022 не рекомендуют.

Миф 12: «Акупунктура, гомеопатия, краниосакральная терапия излечивают синдром Туретта»

Доказательства: Cochrane и систематические обзоры — эффект этих комплементарных вмешательств при тикозных расстройствах не доказан.

Миф 13: «Гипнотерапия или психоаналитическая терапия устраняют тики»

Доказательства: Доминировал до 1960-х годов, но не показал эффективности в современной доказательной базе; предпочтительны CBIT или фармакотерапия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 8A05.0 Primary tics or tic disorders. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Pringsheim T., Okun M.S., Müller-Vahl K. et al. Practice guideline recommendations summary: Treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology 2019;92(19):896–906.
4. Müller-Vahl K.R., Szejko N., Verdellen C. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders — version 2.0. Eur Child Adolesc Psychiatry 2022;31(3):403–423.
5. Piacentini J., Woods D.W., Scahill L. et al. Behavior therapy for children with Tourette disorder: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303(19):1929–1937.
6. Wilhelm S., Peterson A.L., Piacentini J. et al. Randomized trial of behavior therapy for adults with Tourette syndrome. Arch Gen Psychiatry 2012;69(8):795–803.
7. Leckman J.F., Riddle M.A., Hardin M.T. et al. The Yale Global Tic Severity Scale: initial testing of a clinician-rated scale of tic severity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28(4):566–573.
8. Bloch M.H., Leckman J.F. Clinical course of Tourette syndrome. J Psychosom Res 2009;67(6):497–501.
9. Bloch M.H., Panza K.E., Landeros-Weisenberger A., Leckman J.F. Meta-analysis: treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children with comorbid tic disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48(9):884–893.
10. Freeman R.D. et al. Coprophenomena in Tourette syndrome. Dev Med Child Neurol 2009;51(3):218–227.

11. Knight T., Steeves T., Day L. et al. Prevalence of tic disorders: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Neurol 2012;47(2):77–90.
12. Mataix-Cols D., Isomura K., Pérez-Vigil A. et al. Familial risks of Tourette syndrome and chronic tic disorders: a population-based cohort study. JAMA Psychiatry 2015;72(8):787–793.
13. Yu D., Sul J.H., Tsetsos F. et al. Interrogating the genetic determinants of Tourette syndrome and other tic disorders through genome-wide association studies. Am J Psychiatry 2019;176(3):217–227.
14. Roessner V., Schoenefeld K., Buse J. et al. Pharmacological treatment of tic disorders and Tourette syndrome. Neuropharmacology 2013;68:143–149.
15. Roessner V., Plessen K.J., Rothenberger A. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2011;20(4):173–196.
16. Tourette's Syndrome Study Group. Treatment of ADHD in children with tics: a randomized controlled trial. Neurology 2002;58(4):527–536.
17. Pringsheim T., Ganos C., McGuire J.F. et al. Rapid Onset Functional Tic-Like Behaviors in Young Females During the COVID-19 Pandemic. Mov Disord 2021;36(12):2707–2713.
18. Schrock L.E., Mink J.W., Woods D.W. et al. Tourette syndrome deep brain stimulation: a review and updated recommendations. Mov Disord 2015;30(4):448–471.
19. National Institute of Mental Health (NIMH). PANDAS/PANS Information for Clinicians. 2017.
20. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.

6A20–6A2Z СПЕКТР ШИЗОФРЕНИИ

Schizophrenia or other primary psychotic disorders

МКБ-11 **6A20**	**6A20 ШИЗОФРЕНИЯ** **Schizophrenia**
МКБ-10 F20	Шизофрения
DSM-5-TR F20.9	Шизофрения

1. Определение и нозология

Шизофрения — психотическое расстройство, характеризующееся значительным нарушением мышления, восприятия, аффекта и поведения, с активной фазой симптомов продолжительностью не менее одного месяца и, как правило, хроническим течением. В классификации МКБ-11 расположена под кодом 6A20 в группе «Шизофрения и другие первичные психотические расстройства» (6A2x).

С нозологической точки зрения первичное психотическое расстройство — это расстройство, при котором психотические симптомы не объясняются полностью другим медицинским состоянием, воздействием вещества или аффективным расстройством. Шизоаффективное расстройство (6A21), шизотипическое расстройство (6A22), острое и преходящее психотическое расстройство (6A23) и бредовое расстройство (6A24) кодируются отдельно от неё.

2. История

Современная концепция шизофрении прошла четыре основных этапа:

- Kraepelin (1899) — «dementia praecox» (раннее слабоумие) — расстройство, начинающееся в молодом возрасте, характеризующееся устойчивым когнитивным снижением.
- Bleuler (1911) — термин «шизофрения» (в значении «расщепленный ум», но не «раздвоение личности»); за основу взяты симптомы «4A» (нарушение ассоциаций, аффект, амбивалентность, аутизм).

- Schneider K. (1959) — «Симптомы первого ранга» (голос-мысль, комментирующие галлюцинации, отнятие мыслей, чувство контроля) приняты как диагностический приоритет; этот подход отражён в DSM-III и МКБ-10.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — подтипы (параноидный, гебефренический, кататонический, простой) отменены (клиническая полезность и валидность не доказаны, картина изменчива в течении); симптомы первого ранга Schneider приравнены по статусу к другим симптомам; в МКБ-11 дополнительно применён дименсиональный подход — 6A25 симптоматические домены (позитивные, негативные, депрессивные, маниакальные, психомоторные, когнитивные) и 6A20.x квалификаторы течения.

Основные изменения по сравнению с МКБ-10 (F20): отмена подтипов, отмена особого статуса симптомов Шнайдера, сохранение условия длительности в 1 месяц, но в отличие от требования в 6 месяцев в DSM-5-TR, отсутствие требования к общей длительности заболевания.

3. Эпидемиология

Распространённость и заболеваемость

- Пожизненная распространённость: 0,3–0,7% (Saha S. et al. PLoS Med 2005, систематический обзор, 188 исследований, 46 стран).
- Годовая заболеваемость: 15,2 / 100 000 (McGrath J.J. et al. BMC Med 2004, мета-анализ).
- Географическая и культурная вариабельность существует, но частота ядерного события остаётся в определённом диапазоне.

Пол и возраст

- Соотношение мужчин и женщин ~1,4:1; возраст начала у мужчин 18–25 лет, у женщин 25–35 лет (Aleman A. et al. Arch Gen Psychiatry 2003).
- У женщин после менопаузы наблюдается второй пик заболеваемости (связывают со снижением нейропротективного действия эстрогена).
- Начало в детском возрасте встречается редко (<1% всех случаев), после 50 лет первичный диагноз ставится редко.

Коморбидность и смертность.

- Расстройство употребления вещества — коморбидность ~50% (особенно табак, каннабис, алкоголь)..
- Депрессия — коморбидность 25–80% на протяжении болезни.

- Суицид: пожизненный риск ~5–10% (Hor K., Taylor M. J Psychopharmacol 2010); самый высокий риск в первые 5 лет.
- Общая смертность: в 2–3 раза выше по сравнению с популяцией; средняя ожидаемая продолжительность жизни на 15–20 лет короче (Olfson M. et al. JAMA Psychiatry 2015) — в основном из-за сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, употребления табака.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

Наследуемость 60–80% (Sullivan P.F. et al. Arch Gen Psychiatry 2003, мета-анализ близнецов). Конкордантность у монозиготных близнецов ~50%, у дизиготных ~15%, общий популяционный риск ~1%. При шизофрении у одного родителя — риск у ребёнка ~10%; при обоих родителях — ~40%.

Полигенная природа: исследования GWAS выявили 200+ локусов риска (Trubetskoy V. et al. Nature 2022, n>76 000 случаев). Единого «гена шизофрении» нет — риск обусловлен сотнями вариантов с малым эффектом и редкими вариантами числа копий (CNV) — Делеция 22q11.2 (~в 25 раз повышенный риск), делеции 16p11.2, NRXN1.

4.2 Модель нейроразвития

Шизофрения принимается как нарушение нейроразвития (Weinberger D.R. Arch Gen Psychiatry 1987; Murray R.M., Lewis S.W. BMJ 1987). Нарушение раннего развития мозга (внутриутробного и раннего постнатального) приводит к клиническим проявлениям в молодом возрасте. Доказательства:

- Преморбидные когнитивные дефициты и моторные задержки — документированы с детства.
- Чрезмерная синаптическая обрезка (в период полового созревания) — уменьшение массы коркового серого вещества.
- Уже при первом эпизоде регистрируются структурные изменения мозга (не медиатор, а маркер).

4.3 Средовые факторы риска

- Акушерские осложнения — гипоксия, инфекция, задержка развития плода (Cannon M. et al. Am J Psychiatry 2002 мета-анализ, ОШ ~2).
- Вирусные инфекции у матери во время беременности (грипп, герпес) — повышают риск в 2–7 раз (Brown A.S. Schizophr Bull 2006).

- Употребление каннабиса во взрослом возрасте — повышает риск психоза в 2–3 раза, даже при раннем и высоком уровне ТГК (Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016, мета-анализ).
- Рост в городской среде, миграция, социальная изоляция, детская травма — умеренное повышение риска (van Os J. et al. Nature 2010 обзор).
- Возраст отца 45+ — связан с риском новых мутаций (Malaspina D. Arch Gen Psychiatry 2001).

4.4 Нейробиологические механизмы

- Дофаминовая гипотеза (обновлённая): мезолимбическая дофаминовая гиперактивность → позитивные симптомы; мезокортикальная гипоактивность → негативные и когнитивные симптомы (Howes O.D., Kapur S. Schizophr Bull 2009).
- Гипофункция глутамат-NMDA: кетамин и PCP вызывают шизофреноподобные симптомы через блокаду NMDA; это ставит глутаматную систему как второй основной механизм (Olney J.W., Farber N.B. Arch Gen Psychiatry 1995).
- ГАМК-ергические интернейроны: дисфункция парвальбумин-положительных интернейронов приводит к нарушению рабочей памяти в префронтальной коре.
- Структурные изменения: Уменьшение объёма коркового серого вещества (особенно префронтальной и верхней височной коры), расширение желудочков, уменьшение объёма гиппокампа (Haijma S.V. et al. Schizophr Bull 2013, мета-анализ n>8000).
- Воспалительная теория: Повышение CRP, IL-6 и активация микроглии документированы при первых эпизодах (Khandaker G.M. et al. Lancet Psychiatry 2015).

5. Клиническая картина

Домены симптомов (МКБ-11 / 6A25)

Позитивные симптомы

Бред (преследования, отношения, величия, контроля), галлюцинации (наиболее типичны слуховые — комментирующие или диалоговые), формальное расстройство мышления (дезорганизованная речь, неологизмы, «словесная окрошка»), грубо дезорганизованное поведение.

Негативные симптомы

Аффективная уплощенность, аволиция (потеря мотивации), алогия (обеднение речи), ангедония, социальная отгороженность. Является основным фактором функционального нарушения; слабо поддаётся фармакотерапии.

Когнитивные симптомы

Нарушения рабочей памяти, внимания, исполнительной функции, семантической и связанной с работой памяти. Присутствуют у 75–85% пациентов (Heinrichs R.W., Zakzanis K.K. Neuropsychology 1998 мета-анализ).

Депрессивные и маниакальные симптомы

Аффективные эпизоды широко распространены в течение шизофрении; если аффективный эпизод не объясняет психотические симптомы — диагноз шизофрении сохраняется.

Психомоторные симптомы

Кататонические компоненты (мутизм, негативизм, восковая гибкость, стереотипии), ажитация, заторможенность.

Стадии болезни

1. Преморбидная фаза — дискретные когнитивные и социальные дефициты, начинающиеся с детства (клинической шизофрении ещё нет).
2. Продромальная фаза — месяцы-годы; социальная отгороженность, странные переживания, депрессивные признаки, субклинические психотические симптомы.
3. Острый (первый) психотический эпизод — выраженные позитивные симптомы; средний возраст 18–25 лет (у мужчин).
4. Фазы стабилизации и резидуальная — остаточные симптомы, функциональные ограничения, рецидивирующие эпизоды.

Принцип «одной трети» (обзор Hegarty J.D. и др., Am J Psychiatry, 1994)

- ~1/3 пациентов — хорошее функциональное восстановление.
- ~1/3 — остаточные симптомы, частичное функциональное восстановление.
- ~1/3 — тяжёлое хроническое течение, требующее постоянной поддержки.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 · NICE CG178 консенсус)

A. Симптомы активной фазы — из следующего: Минимум 2 из ≥ 1 месяца должен продолжаться; Минимум один из (1)–(3) следует выбрать:

1. Бред
2. Галлюцинации
3. Формальное расстройство мышления / дезорганизованная речь
4. Грубо дезорганизованное или кататоническое поведение
5. Негативные симптомы (аффективная уплощенность, аволиция, алогия)

B. Функциональное нарушение — значительное снижение в одной или нескольких областях: работа, отношения или самообслуживание.

C. Исключения — необходимо исключить воздействие психоактивного вещества и органическую причину (токсикологический скрининг, нейровизуализация, лабораторные исследования).

D. Аффективная дифференциация — аффективный эпизод не полностью объясняет психотические симптомы (исключаются шизоаффективное расстройство или аффективное расстройство с психотическими чертами).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F20.9) дополнительное требование: общая продолжительность заболевания ≥ 6 месяцев (1 месяц активной фазы + продром и/или резидуальная). На фоне расстройства аутистического спектра или нарушения речи — шизофрения кодируется только при наличии отчётливого бреда или галлюцинаций.
- МКБ-11 (6A20) различие: ≥ 1 месяца активных симптомов достаточно, общее требование 6 месяцев отсутствует. Подтипы отменены; вместо них 6A25 домены симптомов и 6A20.x квалификаторы течения (0 — первый эпизод острый, 1 — первый эпизод в частичной или полной ремиссии, 2 — множественные эпизоды, 3 — непрерывное течение, Z — не уточнено) кодируются.
- NICE CG178 требование практики: диагноз клинический, но должен подтверждаться структурированным интервью (SCID-5 или MINI) и шкалой тяжести (PANSS или BPRS); при первом эпизоде — МРТ головного мозга, ЭКГ, исходные метаболические показатели (глюкоза, HbA1c, липиды, пролактин) обязательны.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (пациент + как минимум один информированный родственник).
2. Структурированное диагностическое интервью (SCID-5 или MINI).
3. Оценка тяжести (первичная оценка по PANSS или BPRS).
4. Физикальное и неврологическое обследование.
5. Токсикологический скрининг (моча) и анамнез употребления веществ.
6. Обязательные лабораторные (ниже § 7.2).
7. МРТ головного мозга (при первом эпизоде).
8. Дифференциальная диагностика (§ 6.4).
9. Оценка коморбидности и риска суицида (C-SSRS).
10. Оценка функционального уровня (GAF или PSP).

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	**Отличительные признаки**
Шизоаффективное расстройство (6A21)	Аффективный эпизод присутствует в течение значительной части психотических симптомов, но психоз сохраняется и в периоды вне аффективного эпизода.
Шизотипическое расстройство (6A22)	Психотикоподобные симптомы; полные критерии психоза отсутствуют; устойчивые личностные черты.
Бредовое расстройство (6A24)	Только бред, галлюцинации минимальны или отсутствуют; функция относительно сохранена.
Острое и преходящее психотическое расстройство (6A23)	Длительность ≤ 3 мес. (МКБ-11) или < 1 мес. (англ. Brief Psychotic Disorder, DSM-5-TR).
Аффективное расстройство с психотическими признаками (6A60.x, 6A70.x)	Психоз существует только в контексте маниакального или депрессивного эпизода.

Расстройство	Отличительные признаки
Вещество-индуцированный психоз	Временная связь с употреблением или отменой вещества; ремиссия после элиминации вещества
Вторичный (органический) психоз (6E61)	Связано с медицинским состоянием (эпилепсия, аутоиммунный энцефалит, опухоль головного мозга, болезнь Вильсона).
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Раннее начало, основной дефицит социально-коммуникативных навыков; галлюцинации/бред нетипичны.
Расстройства личности (6D10) — с шизотипическими и параноидными чертами	Стойкие личностные черты, полные психотические эпизоды отсутствуют.

7. Обследование и оценка

7.1 Клиническое интервью и шкалы

- Структурированное интервью: SCID-5 (для DSM-5), MINI (краткий, доступный в клинической практике).
- Тяжесть (золотой стандарт): PANSS (30 показателей, 7-балльная шкала), BPRS (18 показателей), SANS/SAPS (негативные/позитивные отдельно), CGI-S.
- Функциональный уровень: GAF (DSM-IV), PSP (англ. Personal and Social Performance Scale).
- Суицидальный риск: C-SSRS (англ. Columbia Suicide Severity Rating Scale).
- Когнитивная оценка: MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) — в исследованиях и специализированных клиниках.

7.2 Лабораторные исследования

При первом эпизоде обязательно: общий анализ крови, функция печени и почек, глюкоза натощак и HbA1c, липидный профиль, ТТГ и Т4, витамин B12 и фолат, токсикологический скрининг (каннабис, амфетамин, опиоид, кокаин, PCP, MDMA), серология на ВИЧ и сифилис, тест на беременность (у женщин), исходный уровень пролактина.

Селективно (на основании клинического подозрения): ЭЭГ (исключить приступ или делирий), антитела к NMDA-R (ЦСЖ — при атипичной картине), церулоплазмин и суточная моча на медь (при подозрении на болезнь Вильсона), B12/фолат/гомоцистеин (при подозрении на органическую причину).

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга (T1, T2, FLAIR) — рекомендуется при первом эпизоде (NICE CG178).
- ЭКГ — перед началом приёма антипсихотика (исходная оценка QTc).
- КТ головного мозга — при недоступности МРТ.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG178 · APA 2021 · WFSBP 2015 · консенсус Maudsley 14e)

1. Мультимодальный подход — фармакотерапия + психосоциальное вмешательство + системная поддержка. Только фармакотерапия недостаточна для функционального восстановления.
2. Совместное принятие решений с пациентом — обсуждаются препарат, доза и профиль побочных эффектов; приверженность начинается с этого этапа.
3. При первом эпизоде — атипичный антипсихотик преимущественно — низкая доза, постепенная титрация. При первом эпизоде может быть достаточно половины стандартной дозы.
4. Оценка эффекта — 2–4 недели частичный ответ, 4–6 недель полный ответ при адекватной дозе. При отсутствии ответа — препарат заменяется.
5. Монотерапия — антипсихотическая полипрагмазия увеличивает побочные эффекты, доказательства эффективности слабы; исключением может быть клозапин + второй антипсихотик.
6. Резистентная к лечению шизофрения (TRS) — отсутствие ответа на два различных антипсихотика в адекватной дозе и продолжительности (каждый 6–8 недель) — начинают клозапин.
7. Поддерживающая терапия — после первого эпизода не менее 1–2 лет, после множественных эпизодов — длительно/пожизненно. Отмена антипсихотика резко повышает риск рецидива: за год рецидив на препарате 27%, на плацебо 64% (Leucht S. et al. Lancet 2012, 65 исследований, n=6493; OP 0,40).

8. Психосоциальное вмешательство — КПТп и семейное вмешательство должны предлагаться всем пациентам (NICE CG178 — сильная рекомендация).
9. Систематический мониторинг — метаболические показатели, ЭПС, пролактин, ЭКГ.
10. LAI (long-acting injectable) — при проблемах с приверженностью или по выбору пациента; лучший результат в профилактике рецидивов после первого эпизода (Tiihonen J. et al. JAMA Psychiatry 2017).

8.2 Фармакотерапия — антипсихотики первой линии

Для каждого препарата: механизм, доза, доказательства и профиль побочных эффектов.

Препарат	Профиль рецепторов	Стандартная доза	Основной побочный эффект	Преимущество
Оланзапин	D2, 5-HT2A, H1, M1	5–20 мг/сут	Увеличение веса, метаболический синдром, седация	Высокая эффективность, но высокий метаболический риск
Рисперидон	D2, 5-HT2A	2–6 мг/сут	EPS (доза > 6 мг), гиперпролактинемия	Широкое применение, низкая стоимость, доступна форма LAI
Арипипразол	Частичный агонист D2, агонист 5-HT1A, антагонист 5-HT2A	10–30 мг/сут	Акатизия, головокружение	Метаболический профиль хороший, пролактин нейтральный
Кветиапин	D2 (слабый), 5-HT2A, H1, α1	300–800 мг/сут	Седация, ортостатическая гипотензия, увеличение веса	Мягкий профиль ЭПС

Препарат	Профиль рецепторов	Стандартная доза	Основной побочный эффект	Преимущество
Палиперидон	Активный метаболит рисперидона	6–12 мг/сут	Гиперпролактинемия, ЭПС	Варианты LAI (ежемесячный, 3-месячный, 6-месячный)
Луразидон	D2, 5-HT2A, 5-HT7	40–160 мг/сут (с едой)	Акатизия, тошнота	Метаболический профиль очень хороший; приём с пищей обязателен
Зипрасидон	D2, 5-HT2A, 5-HT1A	80–160 мг/сут	Удлинение QTc	Требует мониторинга ЭКГ.

Типичные (I поколения) антипсихотики — галоперидол 5–20 мг/сут, хлорпромазин 200–800 мг/сут, флупентиксол 6–18 мг/сут, зуклопентиксол 25–150 мг/сут. Эффективны при позитивных симптомах, но ЭПС, поздняя дискинезия и слабый эффект при негативных симптомах — не предпочтительны при наличии атипичного антипсихотика.

Примечание по механизму: основной механизм всех антипсихотиков — антагонизм мезолимбических D2-рецепторов (у атипичных — дополнительный антагонизм 5-HT2A — способствует уменьшению негативных симптомов и ЭПС). 60–80% занятости D2 — терапевтический диапазон; > 80% — риск ЭПС возрастает; < 60% — эффект недостаточен (Kapur S., Mamo D. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2003).

8.3 Терапевтически-резистентная шизофрения и клозапин

Клозапин — Единственный препарат с доказанной эффективностью при ТРШ (Kane J. et al. Arch Gen Psychiatry 1988 первичное РКИ; Siskind D. et al. Br J Psychiatry 2016 мета-анализ). 30–60% пациентов с ТРШ отвечают на клозапин.

Почему преобладает: Занятость D2 низкая (40–60%), но сильное воздействие на различные рецепторы (D4, 5-HT2A, M1, α1); меньше EPS,

лучший эффект при негативных симптомах; снижение суицидов (показание FDA).

Протокол начала терапии: 12,5 мг старт; постепенно увеличивать до 200–450 мг/сут (макс 900 мг/сут). Общий анализ крови + лейкоцитарная формула — еженедельно первые 18 недель, затем каждые 2 недели до 1 года, затем ежемесячно. Нейтрофилы 1000–1499 /мкл — лёгкая нейтропения, продолжать с усиленным контролем; < 1000 /мкл → лечение прерывается; < 500 /мкл → тяжёлая нейтропения. При доброкачественной этнической нейтропении порог < 500 /мкл.

Клозапин: побочные эффекты и ведение:

- Агранулоцитоз (~0,8%, летальность 5%) — мониторинг формулы крови.
- Миокардит — особенно в первые 4 недели; тропонин, ЭКГ.
- Запор — риск кишечной непроходимости и перфорации; профилактическое назначение слабительных.
- Гиперсаливация, седация — адаптируется к дозе.
- Приступы — риск повышается при дозе > 600 мг/сут; проверка ЭЭГ.
- Метаболический синдром — высокий; регулярный мониторинг.

Отмена клозапина — важный клинический момент: внезапная отмена вызывает рикошетный психоз (тяжелее исходных симптомов), холинергический рикошет (тошнота, рвота, диарея) и адренергический рикошет (ажитация, бессонница). При необходимости отмены из-за агранулоцитоза — пациент стационарно постепенно переводится на параллельный другой антипсихотик (оланзапин или кветиапин). При плановой отмене — снижение на 25% в неделю.

8.4 Варианты LAI (пролонгированные инъекционные формы)

LAI	Интервал	Стандартная доза
Рисперидон LAI (Consta)	Раз в 2 недели	25–50 мг
Палиперидона пальмитат	Ежемесячно / раз в 3 месяца / раз в 6 месяцев	75–150 мг ежемесячно
Арипипразол LAI (Maintena)	Ежемесячно	400 мг
Оланзапина памоат	Один раз в 2–4 недели	150–300 мг

LAI	Интервал	Стандартная доза
Галоперидола деканоат	1 раз в 4 недели	50–200 мг
Флупентиксола деканоат	Один раз в 2–4 недели	20–40 мг
Зуклопентиксола деканоат	Один раз в 2–4 недели	200–400 мг

8.5 Ведение острого психомоторного возбуждения

- Оральный (преобладающий): Лоразепам 1–2 мг + оланзапин 5–10 мг пероральная диспергируемая таблетка, или рисперидон 1–2 мг пероральный раствор.
- Внутримышечно: оланзапин в/м 10 мг, или арипипразол в/м 9,75 мг, или галоперидол 5 мг + лоразепам 2 мг в/м (классический).
- Внимание: оланзапин в/м + бензодиазепин парентерально — риск угнетения дыхания; не следует применять одновременно.

8.6 Ведение побочных эффектов

Экстрапирамидные симптомы (ЭПС):

Симптом	Клиническое проявление	Интервенция
Острая дистония	Спазм мышц шеи, языка, глаз (первые часы–дни)	Бипериден 2–5 мг в/м (экстренно)
Паркинсонизм	Тремор, ригидность, брадикинезия	Снижение дозы; бипериден 2–4 мг/сут
Акатизия	Внутреннее беспокойство, неусидчивость	Пропранолол 30–80 мг/сут; снижение дозы
Поздняя дискинезия	Поздние дискинетические движения (месяцы–годы)	Вальбеназин / дейтетрабеназин; переход на клозапин

Метаболический побочный эффект: вес, окружность талии, артериальное давление — ежемесячно первые 6 месяцев, затем каждые 6 месяцев; глюкоза натощак, HbA1c, липиды — исходно, через 12 недель, затем раз в год.

Вмешательство: консультация по диете и физической активности, метформин (при избыточном весе), замена антипсихотика на метаболически нейтральный препарат (арипипразол, луразидон).

Гиперпролактинемия: Высокий риск — рисперидон, палиперидон, амисульприд, типичные; низкий риск — арипипразол, кветиапин, клозапин. При симптоматических случаях (галакторея, аменорея, сексуальная дисфункция, остеопороз) — сменить препарат.

Злокачественный нейролептический синдром (NMS) — неотложное медицинское состояние (летальность до 10%): клиническая тетрада — гипертермия, мышечная ригидность, изменение сознания, вегетативная нестабильность. Лабораторно: CPK > 1000, лейкоцитоз, миоглобинурия. Вмешательство: немедленная отмена антипсихотика, поддержка интенсивной терапии, дантролен, бромокриптин, при необходимости ЭСТ.

8.7 Особые состояния

- Беременность: полная отмена антипсихотика повышает риск рецидива. Как класс антипсихотики значимо не увеличивают риск врождённых пороков (Huybrechts K.F. et al. JAMA Psychiatry 2016, 1,3 млн беременностей); возможное исключение — рисперидон (риск выше примерно на 26%, требует подтверждения). Выбор индивидуален: препарат, который работает, обычно продолжают.
- Пожилые: EPS, ортостатическая гипотензия, чувствительность к антихолинергическому эффекту; низкая доза, предпочтительны кветиапин или рисперидон; ознакомьтесь с Beers Criteria.
- Коморбидное употребление ПАВ: поддержка отказа от табакокурения, прекращение употребления каннабиса, параллельное лечение алкогольной зависимости (налтрексон, акампросат).

8.8 Уточнения, специфичные для источника

- NICE CG178: Службы раннего вмешательства (EIP) — интенсивная мультидисциплинарная поддержка в первые 3 года; клозапин как первая линия при резистентности после двух антипсихотиков.
- APA 2021: длительность поддерживающей терапии после первого эпизода 2–5 лет; когнитивная ремедиация и поддерживаемое трудоустройство настоятельно рекомендуются для функционального восстановления.

- WFSBP 2015: диапазоны эквивалентных доз и адекватная продолжительность (4–6 недель) до смены препарата; эффективность LAI в профилактике рецидивов.
- Maudsley 14e (2021): подробный протокол по титрации клозапина, управлению побочными эффектами и причинам полипрагмазии.
- Клинический протокол Министерства здравоохранения АР (2009): атипичный антипсихотик первой линии; традиционный нейролептик — при недоступности атипичного. Общий алгоритм совпадает с NICE/APA.

8.9 Методики лечения

1. Когнитивно-поведенческая терапия психоза (КПТп / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Переоценка психотических симптомов в рамках формулировки «мысль–эмоция–поведение»; пациент работает с галлюцинациями и бредом с помощью проверки реальности, поведенческих экспериментов и поиска альтернативных объяснений. Стандартный курс — 16+ индивидуальных сеансов, 6–12 месяцев. Эффект: малый или средний в отношении позитивных симптомов (Grade A в NICE), улучшение функционального уровня (Wykes T. et al. Schizophr Bull 2008, n=2284 мета-анализ; NICE CG178 § 1.3.7.1).
2. Семейное вмешательство (англ. Family Intervention) — Психообразование, тренинг коммуникации и решение проблем в семьях с высокой эмоциональной экспрессией (ВЭЭ). Пациент + минимум один член семьи, 10+ сеансов, 3–12 месяцев. Эффект: снижение риска рецидива ~20%, уменьшение госпитализаций (Pharoah F. et al. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD000088, n>3500). NICE CG178 § 1.3.7.2.
3. Когнитивная ремедиация (англ. Cognitive Remediation) — Структурированные когнитивные упражнения на компьютере или с тренером — внимание, рабочая память, исполнительная функция, социальное познание. 20–40 сеансов, 2–3 раза в неделю. Эффект: небольшое-среднее улучшение когнитивных показателей, перенос на функциональный уровень только при совместном применении с психосоциальной реабилитацией (Wykes T., Huddy V., Cellard C., McGurk S.R., Czobor P. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485, мета-анализ n=2104).
4. Поддерживаемое трудоустройство (англ. Supported Employment) / Индивидуальное трудоустройство и поддержка (англ. Individual Placement and Support, IPS) — Непосредственное вовлечение в

поддерживаемое трудоустройство на реальных рабочих местах — принцип «place-then-train» (начало поиска работы без предварительного этапа подготовки). Персональный координатор, поиск работы на основе индивидуальных интересов и способностей, поддержка на рабочем месте. Эффект: более половины устраиваются на конкурентную работу (в контрольных группах 20%) — Drake R.E., Bond G.R., Goldman H.H. et al. Health Aff (Millwood) 2016;35(6):1098–1105. NICE CG178 § 1.3.7.3.

5. Раннее вмешательство при психозе (EIP — Early Intervention in Psychosis) — Интенсивная мультидисциплинарная помощь в течение 3 лет после первого психотического эпизода — низкодозовая фармакотерапия, КПТп, семейное вмешательство, поддержка занятости, поддержка сверстников. РКИ RAISE и EDEN (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016; Marshall M. et al. Lancet 2011) — EIP превосходит стандартную помощь, снижает рецидивы, улучшает функциональный уровень. NICE CG178 § 1.4.
6. Ассертивное лечение в сообществе (ACT — Assertive Community Treatment) — Мультидисциплинарная команда (психиатр, клинический психолог, социальный работник, пир-специалист) оказывает пациенту интенсивную поддержку в сообществе (дома, на работе); доступность 24/7, низкое соотношение пациент/сотрудник (~10:1). Цель: пациенты с высоким риском повторной госпитализации и бездомности. Эффект: сокращает дни госпитализации, повышает стабильность проживания (Marshall M., Lockwood A. Cochrane 2011).
7. PANSS / BPRS — Шкалы тяжести — PANSS (англ. Positive and Negative Syndrome Scale) — 30 показателей, 7-балльная шкала; BPRS (англ. Brief Psychiatric Rating Scale) — 18 показателей. Количественная оценка психотических симптомов на основе структурированного интервью. Для начальной оценки и мониторинга лечения в клинической практике. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. Schizophr Bull 1987;13(2):261–276 (PANSS); Overall J.E., Gorham D.R. Psychol Rep 1962;10:799–812 (BPRS).

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Короткий период без лечения (DUP < 6 мес.)
- Острое начало, четкий стрессовый фактор
- Преморбидная хорошая функция
- Преобладание позитивных симптомов (негативных мало)

- Наличие аффективного компонента
- Хорошая социальная поддержка, сотрудничество семьи
- Раннее вмешательство и приверженность лечению

Факторы неблагоприятного прогноза

- Постепенное начало, длительный продром
- Ранний возраст начала (детство или ранняя юность)
- Преморбидная функциональная слабость (с детства)
- Преобладание негативных симптомов
- Тяжесть когнитивного дефицита
- Употребление вещества (особенно каннабис, амфетамин)
- Несоблюдение режима, социальная изоляция
- DUP > 1 год

Цели наблюдения

- Клиническая стабильность и профилактика рецидивов (приверженность антипсихотикам, рассмотрение LAI).
- Управление метаболическим и сердечно-сосудистым риском (основной фактор, вносящий вклад в смертность).
- Функциональное восстановление — занятость, независимое проживание, социальные связи.
- Мониторинг коморбидного употребления ПАВ, депрессии, суицидального риска.
- Укрепление системы семейной и общественной поддержки.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии

Миф 1: «Шизофрения — это одержимость духами или бесами»

Почему распространено: Историко-религиозный контекст — в европейском Средневековье психоз объяснялся «одержимостью дьяволом»; субъективный сверхъестественный характер галлюцинаций; в сообществах с низкой доступностью психиатрической помощи семья в первую очередь обращается к религиозному лидеру.

Клиническая и биологическая логика: Шизофрения имеет измеримые нейробиологические признаки — уменьшение объёма коркового серого вещества (Haijma S.V. Schizophr Bull 2013, мета-анализ n>8000), мезолимбическая дофаминовая гиперактивность (Howes O.D. Schizophr Bull 2009), наследуемость 60–80% (Sullivan P.F. 2003). Дозозависимый эффект антагонистов D2-рецепторов доказывает специфичность фармакологического механизма. Концепция «овладения» не проверяема на этих уровнях и не поддаётся фальсификации.

Доказательства: Руководство ВОЗ mhGAP Intervention Guide v2.0 — шизофрения признается медицинским заболеванием. Документ APA по религиозным/духовным убеждениям (2018): религиозная практика *может дополнять* лечение, но *не может его заменить*.

Реальный клинический шаг: начало приёма антипсихотика не должно откладываться. Уважение к религиозно-культурным верованиям семьи сохраняет терапевтический альянс — разрешение ритуалов экзорцизма вместо антипсихотической терапии ведёт к отсроченному началу и плохому прогнозу (Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 — DUP > 1 год является маркером плохого прогноза).

Миф 2: «Шизофрения — результат плохого воспитания или „холодной матери“»

Почему распространено: В 1940–1960-х годах влияние психоаналитической школы (Fromm-Reichmann F. — концепция «шизофреногенной матери»); модель обвинения семьи долгое время доминировала в клинической практике.

Клиническая и биологическая логика: Наследуемость 60–80% — у усыновлённых детей, выросших не в биологической семье, риск связан с диагнозом биологических родителей, а не с характеристиками приемной семьи (Heston L.L. Br J Psychiatry 1966; Tienari P. et al. Br J Psychiatry 2004 — Финское адоптивное исследование). В семье с высокой эмоциональной экспрессией (EE) риск рецидива повышается, но это не является первичной этиологией, а является модулятором течения.

Доказательства: APA, AAP, NICE — концепция «шизофреногенной матери» отвергнута научным сообществом.

Реальный клинический шаг: Семейное вмешательство (см. «Методы лечения») — строится не на обвинении, а на психообразовании и тренинге коммуникации.

Миф 3: «Шизофрения = раздвоение (split) личности»

Почему распространено: Этимологическая ошибка — неверный перевод слова «шизо» (расщепление) + «френия» (ум) как «расщепление личности»; массовая культура (кино, литература) усиливает ложные образы.

Клиническая и биологическая логика: Термин Блейлера (1911) обозначал нарушение внутренней согласованности психики (разрыв ассоциаций), а не наличие отдельных личностей. «Двойная личность» — это иное расстройство: диссоциативное расстройство идентичности (6B64), имеющее совершенно иную этиологию (травма в детстве) и клинические проявления.

Доказательства: ВОЗ МКБ-11 — шизофрения (6A20) и ДРИ (6B64) кодируются как отдельные расстройства.

Миф 4: «Люди с шизофренией опасны и агрессивны»

Почему распространено: СМИ в случаях насилия особо подчеркивают наличие психоза в анамнезе — такие сообщения привлекают внимание, но базовая частота не приводится.

Клиническая и биологическая логика: Люди с шизофренией чаще становятся жертвами насилия (Maniglio R. Acta Psychiatr Scand 2009 систематический обзор — уровень виктимизации выше в 2,3–140 раз в зависимости от вида преступления). Риск насилия повышен только в специфическом узком контексте: нелечёный острый параноидный бред + сопутствующее употребление психоактивных веществ (Fazel S. et al. PLoS Med 2009 мета-анализ). У стабильных пациентов, получающих лечение, разница с популяцией минимальна.

Доказательства: Все насильственные инциденты, связанные с шизофренией, составляют менее 5% от общего числа насилия в обществе (Fazel S. Br J Psychiatry 2014).

Реальный клинический шаг: стигма препятствует психосоциальному восстановлению; психообразование для семьи и общества критически важно.

10.2 Вредные методы «лечения»

Миф 5: «Экзорцизм или религиозный ритуал могут заменить антипсихотик»

Почему распространено: Страх побочных эффектов антипсихотиков; большая доступность социальной поддержки в религиозных общинах; стигма психиатрической помощи.

Риск: С каждым месяцем удлинения первичного нелечёного периода (англ. Duration of Untreated Psychosis, DUP) долгосрочный функциональный прогноз пациента ухудшается (Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005, n=3700 мета-анализ). У пациентов с DUP > 1 года частота ремиссии значительно снижается. В нелечёном остром эпизоде риск суицида высок.

Доказательства: NICE CG178, WHO mhGAP — лечение антипсихотиками не должно откладываться; религиозно-культурная поддержка может применяться параллельно.

Миф 6: «„Инсулинокоматозная терапия“ и „лоботомия“ — старые методы лечения, которые до сих пор тайно применяются в больницах»

Реальность: Терапия инсулиновой комой (Сакель 1933) и префронтальная лоботомия (Мониц 1936, Фримен 1945) массово применялись в 1950-х годах, но с появлением антипсихотиков (хлорпромазин 1952) от них отказались из-за отсутствия доказательств сравнительной эффективности и тяжёлых побочных эффектов. В современной клинической практике эти методы отсутствуют. ЭСТ (электросудорожная терапия) отличается — доказана, в современных показаниях присутствует при шизофрении с кататоническими чертами или в рефрактерных случаях (NICE TA59).

10.3 Неэффективные методы или методы, откладывающие основное лечение

Миф 7: «Мегадозы витамина B3 (ниацина) излечивают шизофрению» (ортомолекулярная психиатрия)

Почему распространено: Hoffer и Osmond в 1950-х годах на основе единичных отчётов выдвинули теорию мегадоз ниацина; альтернативное медицинское течение продолжает поддерживать этот подход.

Доказательства: Целевая группа APA (Lipton M.A. et al. 1973) и последующие РКИ — мегадозы витамина B3 или других витаминов не влияют на симптомы шизофрении. Мегадозы ниацина могут вызвать повреждение печени и гиперурикемию.

Миф 8: «Каннабис (особенно CBD) излечивает шизофрению»

Почему распространено: Преувеличенное освещение в СМИ предварительных исследований антипсихотического эффекта CBD; маркетинг индустрии медицинского каннабиса.

Реальность: THC (основной психоактивный компонент каннабиса) увеличивает риск психоза в 2–3 раза (мета-анализ Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016). Первоначальные РКИ по CBD (McGuire P. et al. Am J Psychiatry 2018) показали скромный эффект, но доказательная база недостаточна для замены стандартных антипсихотиков.

Доказательства: NICE CG178, APA 2021 — КБД не является стандартной рекомендацией при лечении шизофрении; каннабис, содержащий ТГК, является противопоказанием.

Миф 9: «Антипсихотики разрушают мозг, превращают в „зомби“, пожизненный приём вреден»

Почему распространено: Тяжёлые экстрапирамидные побочные эффекты ранних типичных антипсихотиков; опыт пациентов распространяется в социальных сетях.

Биологическая логика: Имеются структурные изменения, связанные с применением антипсихотиков (Ho B.C. et al. Arch Gen Psychiatry 2011), но необходимо учитывать, что нелечёная шизофрения сама по себе вызывает более быстрое уменьшение кортикального объёма (Cahn W. et al. Arch Gen Psychiatry 2002). Отмена антипсихотиков резко повышает риск рецидива — за год 64% вместо 27% (Leucht S. Lancet 2012), а сам рецидив оказывает нейротоксическое действие.

Доказательства: Tiihonen J. et al. (Lancet 2009, JAMA Psychiatry 2018) Финские регистровые исследования n>60 000: непрерывное применение антипсихотиков снижает смертность и госпитализации.

Реальный клинический шаг: выбор препарата по профилю побочных эффектов, титрация дозы и ответ на жалобы пациента — предмет антипсихотического диалога.

Миф 10: «Шизофрения не лечится, это пожизненное заболевание, выздоровление невозможно»

Реальность: Принцип 1/3 Hegarty (Am J Psychiatry 1994) — примерно 1/3 пациентов достигает хорошего функционального восстановления; особенно при службах раннего вмешательства (EIP) этот показатель увеличивается (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016 — RAISE RCT). Различают «клиническое выздоровление» и «личное выздоровление» (Recovery model) — пациент может построить осмысленную жизнь, даже не полностью избавившись от симптомов.

Реальный клинический шаг: прогноз индивидуален; раннее вмешательство, приверженность лечению, поддержка семьи и психосоциальная реабилитация значительно повышают шансы на выздоровление.

Миф 11: «Акупунктура, гомеопатия, валериана эффективны вместо антипсихотика»

Доказательства: Обзоры Cochrane (Rathbone J. Cochrane 2007 — акупунктура; обзоры Ernst E. — гомеопатия) — нет доказательств эффекта при шизофрении. Комплементарные методы могут применяться как адъюнкт (управление стрессом, гигиена сна), но не заменяют антипсихотик.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 2024). 6A20 Schizophrenia. icd.who.int
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update. nice.org.uk/guidance/cg178
4. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
5. Hasan A., Falkai P., Wobrock T. et al. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia. World J Biol Psychiatry 2012;13(5):318–378; 2015 update.
6. Taylor D.M., Barnes T.R.E., Young A.H. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 14th ed. Wiley-Blackwell; 2021.
7. Sullivan P.F., Kendler K.S., Neale M.C. Schizophrenia as a complex trait. Arch Gen Psychiatry 2003;60(12):1187–1192.
8. Trubetskoy V., Pardiñas A.F., Qi T. et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature 2022;604(7906):502–508.
9. Howes O.D., Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III. Schizophr Bull 2009;35(3):549–562.
10. Haijma S.V., Van Haren N., Cahn W. et al. Brain volumes in schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Bull 2013;39(5):1129–1138.
11. Saha S., Chant D., Welham J., McGrath J. A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Med 2005;2(5):e141.

12. Marconi A., Di Forti M., Lewis C.M. et al. Cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.
13. Hor K., Taylor M. Suicide and schizophrenia. J Psychopharmacol 2010;24(11 Suppl 4):81–90.
14. Leucht S., Tardy M., Komossa K. et al. Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia. Lancet 2012;379(9831):2063–2071.
15. Kane J., Honigfeld G., Singer J., Meltzer H. Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic. Arch Gen Psychiatry 1988;45(9):789–796.
16. Siskind D., McCartney L., Goldschlager R., Kisely S. Clozapine v. first- and second-generation antipsychotics in treatment-refractory schizophrenia. Br J Psychiatry 2016;209(5):385–392.
17. Wykes T., Steel C., Everitt B., Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: effect sizes, clinical models, and methodological rigor. Schizophr Bull 2008;34(3):523–537.
18. Pharoah F., Mari J., Rathbone J., Wong W. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD000088.
19. Drake R.E., Bond G.R., Goldman H.H. et al. Individual placement and support services boost employment for people with serious mental illnesses. Health Aff (Millwood) 2016;35(6):1098–1105.
20. Kane J.M., Robinson D.G., Schooler N.R. et al. Comprehensive versus usual community care for first-episode psychosis (RAISE). Am J Psychiatry 2016;173(4):362–372.
21. Tiihonen J., Mittendorfer-Rutz E., Majak M. et al. Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia. JAMA Psychiatry 2017;74(7):686–693.
22. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики. Клинический протокол по диагностике и лечению шизофрении. Баку; 2009. [Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə Klinik Protokol.]
23. Fromm-Reichmann F. Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy. Psychiatry 1948;11(3):263–273.
24. Ernst E. A systematic review of systematic reviews of homeopathy. Br J Clin Pharmacol 2002;54(6):577–582.
25. Huybrechts K.F., Hernández-Díaz S., Patorno E. et al. Antipsychotic use in pregnancy and the risk for congenital malformations. JAMA Psychiatry 2016;73(9):938–946.

26. Aleman A., Kahn R.S., Selten J.P. Sex differences in the risk of schizophrenia: evidence from meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2003;60(6):565–571.
27. Olfson M., Gerhard T., Huang C. et al. Premature mortality among adults with schizophrenia in the United States. JAMA Psychiatry 2015;72(12):1172–1181.

МКБ-11 **6A21**	**6A21** **ШИЗОАФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО** **Schizoaffective disorder**
МКБ-10 F25	Шизоаффективные расстройства
DSM-5-TR F25.0–F25.1	Шизоаффективное расстройство

1. Определение и нозология

Шизоаффективное расстройство (МКБ-11: 6A21 Schizoaffective Disorder; DSM-5-TR: F25.0–F25.1) — первичное психотическое расстройство, при котором психотические симптомы (бред, галлюцинации, дезорганизованная речь) и аффективный эпизод (маниакальный или депрессивный) наблюдаются совместно в течение одного клинического эпизода, но дополнительно психотические симптомы сохраняются и в периоды вне аффективного эпизода.

В спектре психотических расстройств оно занимает промежуточное положение между шизофренией и аффективным расстройством — с одной стороны, отличается от «аффективного расстройства с психотическими чертами», с другой — от «шизофрении» (продолжение психотических симптомов независимо от контекста аффективного эпизода).

В DSM-5-TR квалификатор двух типов: биполярный тип (маниакальные и/или депрессивные эпизоды) и депрессивный тип (только депрессивные эпизоды). В МКБ-11 субспецификации параллельны — по типу аффективного эпизода.

2. История

- Kasanin J. (1933) — впервые ввёл термин «acute schizoaffective psychoses»; подчеркивались быстрое начало и хороший прогноз.
- 1970-е годы — Carpenter W., Strauss J., Bartko J. — исследование как отдельной клинической единицы, отличной от шизофрении и аффективного расстройства.
- DSM-III (1980) — шизоаффективное расстройство как «смешанная» категория.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — диагностические критерии уточнены; разделение на биполярный/депрессивный тип сохранено.
- МКБ-11 (2019) — подспецификации типа аффективного эпизода.
- Дискуссия о диагностической валидности — Malhi G.S. et al. Aust N Z J Psychiatry 2008, Lake C.R., Hurwitz N. Curr Psychiatry Rep 2007: спорно, является ли шизоаффективное расстройство отдельной единицей от шизофрении и аффективного расстройства; некоторые исследователи рассматривают его в рамках спектральной концепции.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: ~0,3% (Perälä J. et al. Arch Gen Psychiatry 2007, популяционное исследование Финляндии, n=8000).
- Заметно реже шизофрении (0,3–0,7%).
- Пол: у женщин относительно чаще (1:1,2–1,5); депрессивный тип доминирует у женщин.
- Возраст начала: средний возраст 20–30 лет; биполярный тип в более молодом возрасте, депрессивный тип — позже.
- Коморбидность: Расстройство употребления психоактивных веществ ~40%, тревожные расстройства ~30%, риск суицида сравним с шизофренией (~5%).
- Смертность: общая смертность в 2–3 раза выше по сравнению с популяцией.

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Генетическое совпадение с шизофренией и биполярным расстройством высокое: GWAS-исследования (англ. Cross-Disorder Group of Psychiatric Genomics Consortium. Lancet 2013, Cell 2019) — широкая генетическая

корреляция между шизофренией, биполярным и шизоаффективным расстройством.

- Семейные исследования — у родственников пациентов с шизоаффективным расстройством повышен риск как шизофрении, так и расстройств настроения (Maier W. et al. Arch Gen Psychiatry 1993).

4.2 Нейробиология

- Модели, перекрывающиеся с шизофренией — дисрегуляция дофамина, изменения коркового объёма, дисфункция глутаматных NMDA-рецепторов.
- Связано с аффективным компонентом — дисфункция лимбической и моноаминергической (серотонин, норадреналин) систем.
- Наблюдаются менее выраженные структурные изменения и лучший когнитивный профиль по сравнению с шизофренией (обзор Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009).

4.3 Средовые факторы риска

- Перекрытие с шизофренией — акушерские осложнения, пренатальные инфекции, употребление каннабиса в подростковом возрасте, миграция, городская среда.
- Ранняя травма и психосоциальный стресс могут играть роль триггера аффективного компонента.

5. Клиническая картина

5.1 Основные паттерны

- Психоз на фоне маниакального эпизода — бред величия, эго-синтонные галлюцинации, ускоренный поток мыслей, гиперречевая активность и поведение.
- Психоз на фоне депрессивного эпизода — бред вины, нигилистический бред, слуховые галлюцинации (осуждающие голоса), низкая мотивация.
- В периоды вне аффективного эпизода — позитивные (бред, галлюцинации) и/или негативные (аффективное уплощение, аволиция) симптомы сохраняются — этот критерий отличает расстройство от «аффективного расстройства с психотическими чертами».

5.2 Течение и стадии

- Течение типично эпизодическое — аффективные эпизоды и психотические компоненты различной интенсивности.
- Лучшее функциональное восстановление, чем при шизофрении, но с существенными социальными и профессиональными нарушениями.
- При биполярном типе — маниакальные и депрессивные циклы; при депрессивном типе — стойкие депрессивные компоненты.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. В течение одного и того же периода болезни должен наблюдаться основной аффективный эпизод (маниакальный или депрессивный) в сочетании с активными симптомами, соответствующими критерию A шизофрении (≥1 месяц).

B. Бред или галлюцинации наблюдались в течение ≥ 2 недель без основного аффективного эпизода (в течение пожизненного течения болезни).

C. Симптомы, соответствующие основному аффективному эпизоду болезни, должны присутствовать в значительной части общего течения (вместе с активной и резидуальной фазами).

D. Исключения — психоз не полностью объясняется веществом (например, амфетамином) или медицинским состоянием (например, энцефалитом).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F25.0–F25.1): в критерии B закреплено конкретное число — 2 недели (в DSM-IV его не было). Квалификаторы типа — биполярный (с маниакальными эпизодами) или депрессивный (только депрессивные).
- МКБ-11 (6A21): «Шизоаффективное расстройство» — подспецификации по типу аффективного эпизода; конкретное требование в 2 недели в МКБ-11 указано не конкретным числом, а как «значительный период».
- APA Practice Guideline (Schizophrenia 2021): Отдельного алгоритма для шизоаффективного расстройства нет; объединяются принципы лечения шизофрении и аффективных расстройств.

- WFSBP: Шизоаффективное расстройство оценивается в рамках расстройств шизофренического спектра.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от родственников — хронологический порядок аффективных эпизодов и психотических симптомов.
2. Структурированное интервью (SCID-5 или MINI).
3. PANSS или BPRS — тяжесть психотических симптомов; HAM-D, MADRS — депрессивных; YMRS — маниакальных.
4. Физикальное и неврологическое обследование.
5. Токсикологический скрининг (моча).
6. Лабораторные (общий анализ крови, тиреоидные, печёночные, почечные, глюкоза, HbA1c, липиды, пролактин).
7. МРТ головного мозга (первый эпизод) — исключение органической причины.
8. Оценка коморбидности и риска суицида (C-SSRS).

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	**Отличительные признаки**
Шизофрения (6A20)	Аффективные эпизоды отсутствуют или минимальны, если присутствуют, то составляют малую часть течения психоза.
Биполярное I расстройство с психотическими особенностями (6A60)	Психоз только в контексте маниакального или депрессивного эпизода; психоз вне аффективного эпизода отсутствует.
Большое депрессивное расстройство с психотическими признаками (6A70/6A71.x)	Психоз только в контексте депрессивного эпизода.
Вещество-индуцированный психоз	Временная связь с употреблением вещества; ремиссия после элиминации

Расстройство	Отличительные признаки
Вторичный (органический) психоз (6E61)	Связано с медицинским состоянием (энцефалит, волчанка, паранеопластическое).
Бредовое расстройство (6A24)	Только бред; аффективный компонент отсутствует.
Острое и преходящее психотическое расстройство (6A23)	≤ 3 мес. (МКБ-11) / < 1 мес. (DSM-5-TR Brief Psychotic).

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические шкалы

- Структурированное интервью: SCID-5, MINI.
- Психотическая тяжесть: PANSS, BPRS.
- Тяжесть депрессии: HAM-D (Hamilton), MADRS (Montgomery-Åsberg).
- Тяжесть мании: YMRS (англ. Young Mania Rating Scale).
- Функционирование: GAF, PSP, SOFAS.
- Суицидальный риск: C-SSRS.

7.2 Лабораторные исследования

Шизофреноподобное (см. 6A20 §7.2):

- Обязательно: общий анализ крови, печень/почки, глюкоза, HbA1c, липидный профиль, ТТГ, B12, фолат, токсикологический скрининг, ВИЧ, сифилис, тест на беременность, исходные показатели пролактина.
- Избирательно: ЭЭГ, антитела к anti-NMDA-R, церулоплазмин (Вильсон).
- Перед началом приёма лития — креатинин, ТТГ, кальций, ЭКГ.
- Перед началом приёма вальпроата — печёночные и анализы крови.

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — при первом эпизоде.
- ЭКГ — перед началом приёма антипсихотика или лития.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (APA 2021 · NICE CG178 / CG185 · консенсус WFSBP)

1. Мультимодальный подход — антипсихотик + нормотимик и/или антидепрессант + психосоциальное вмешательство.
2. Атипичный антипсихотик первой линии — палиперидон или палиперидона пальмитат (LAI) — одобрение FDA специально для шизоаффективного расстройства; рисперидон, оланзапин, кветиапин, арипипразол — широкое применение.
3. При биполярном типе — нормотимик — литий (эффект снижения суицидального риска), вальпроат, ламотриджин (особенно при доминировании депрессивного компонента).
4. Антидепрессант при депрессивном типе — СИОЗС (сертралин, эсциталопрам) или СИОЗСН (венлафаксин); антидепрессант не используется отдельно, а в комбинации с антипсихотиком.
5. Клозапин — при рефрактерных случаях (отсутствие ответа на два антипсихотика).
6. ЭСТ — эффективен при тяжёлой кататонии, депрессивном компоненте, высоком суицидальном риске, рефрактерных случаях (NICE TA59 — при психотической депрессии и кататонии).
7. Психосоциальное вмешательство — КПТп (КПТ для психоза), семейное психообразование, поддерживающая терапия, IPS поддерживаемое трудоустройство.
8. Приверженность и профилактика рецидивов — LAI (палиперидона пальмитат, арипипразол LAI) у отобранных пациентов.
9. Лечение коморбидности — употребление психоактивных веществ (параллельная программа), тревога, соматические заболевания.
10. Мониторинг метаболических и побочных эффектов — стандарт при антипсихотиках.

8.2 Фармакотерапия

Класс	Препарат / образцы	Показание
Атипичный антипсихотик	Палиперидон (одобрение FDA), рисперидон, оланзапин, кветиапин, арипипразол	Позитивные и негативные симптомы; во всех случаях базовое лечение.

Класс	Препарат / образцы	Показание
Атипичный антипсихотик LAI	Палиперидона пальмитат (ежемесячно/3 месяца/6 месяцев), арипипразол LAI	При проблемах с приверженностью или по выбору пациента.
Нормотимик	Литий, вальпроат, карбамазепин, ламотриджин	При биполярном типе литий снижает суицид.
Антидепрессант	СИОЗС (сертралин, эсциталопрам), СИОЗСН (венлафаксин)	При депрессивном типе; не в монотерапии, а в комбинации с антипсихотиком.
Рефрактерность	Клозапин	Отсутствие ответа на два антипсихотика.
Адъюнкт	Бензодиазепин (лоразепам) краткосрочно	При острой ажитации или кататонии.

8.3 Показания к ЭСТ

- Кататонические признаки.
- Тяжёлый психотический депрессивный эпизод.
- Суицидальный риск или отказ от приёма пищи и жидкости.
- Во время беременности (безопасная альтернатива).
- Отсутствие ответа на фармакотерапию.

8.4 Уточнения, специфичные для источника

- APA 2021 (Schizophrenia): Алгоритм лечения шизоаффективного расстройства параллелен шизофрении; дополнительное вмешательство в зависимости от аффективного компонента.
- NICE CG178 (Psychosis) + CG185 (Bipolar): оба применимы к шизоаффективному расстройству — психотический компонент CG178, аффективный компонент CG185.
- WFSBP: Показано, что палиперидон и арипипразол имеют наилучшую доказательную базу при шизоаффективном расстройстве.

- CANMAT / ISBD 2018: биполярный тип шизоаффективного расстройства — адаптируется к алгоритмам лечения биполярного расстройства.

8.5 Методики лечения

1. Когнитивно-поведенческая терапия психоза (КПТп / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Адаптируется как при шизофрении; см. «Методы лечения», 6A20.html и NICE CG178 §1.3.7.1.
2. Семейное психообразование и вмешательство (англ. Family Psychoeducation) — Снижает рецидивы в семьях с высокой эмоциональной экспрессией (ВЭЭ). NICE CG178 §1.3.7.2; Pharoah Cochrane 2010.
3. Индивидуальное трудоустройство и поддержка (англ. Individual Placement and Support, IPS) — Поддерживаемое трудоустройство по принципу «place-then-train». Drake R.E. et al. Health Aff (Millwood) 2016.
4. Литий — Стабилизация настроения и профилактика суицида при биполярном типе шизоаффективного расстройства; исходные показатели: креатинин, ТТГ, кальций, ЭКГ; терапевтический уровень 0,6–1,0 мЭкв/л; Cipriani A. et al. BMJ 2013 — снижает суицидальность.
5. Ламотриджин — Профилактика при биполярном депрессивном эпизоде; медленная начальная титрация (риск синдрома Стивенса-Джонсона).
6. Палиперидона пальмитат (LAI — инъекция длительного действия) — Ежемесячные, 3-месячные и 6-месячные формы. Показание FDA при шизоаффективном расстройстве есть только у ежемесячной формы (англ. Invega Sustenna); 3-месячная (Trinza) и 6-месячная (Hafyera) одобрены только при шизофрении. Преимущество при проблемах с приверженностью и профилактике рецидивов.
7. Электросудорожная терапия (ЭСТ — Electroconvulsive Therapy) — Эффективен при кататонических чертах, тяжёлой психотической депрессии, суицидальном риске или рефрактерных случаях. NICE TA59 — сильная рекомендация при психотической депрессии или кататонии. Мета-анализ UK ECT Review Group Lancet 2003 — ЭСТ превосходит фармакотерапию при тяжёлой депрессии.
8. PANSS, HAM-D, YMRS — Раздельная стандартизированная оценка психотического, депрессивного, маниакального компонентов.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Биполярный тип (лучший прогноз, чем депрессивный тип).
- Быстрое начало, выраженный аффективный компонент.
- Преморбидный хороший функциональный уровень.
- Раннее вмешательство и приверженность лечению.
- Социальная поддержка.
- Ведение коморбидного употребления ПАВ.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Депрессивный тип.
- Постепенное начало.
- Преобладание негативных симптомов.
- Коморбидное употребление ПАВ.
- Наличие попытки суицида в анамнезе.
- Несоблюдение режима.

Цели наблюдения

- Раздельное отслеживание психотических и аффективных симптомов (PANSS, HAM-D, YMRS).
- Суицидальный риск (C-SSRS) — особенно в депрессивных эпизодах и в первые годы.
- Метаболический мониторинг.
- У принимающих литий — ТТГ, креатинин, кальций (каждые 6 месяцев).
- Функциональное восстановление, занятость, социальные связи.
- Семейная поддержка и психообразование.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии и концептуальные мифы

Миф 1: «Шизоаффективное расстройство — это лёгкая шизофрения»

Почему распространено: Ошибочно объясняется, что пациенты с шизоаффективным расстройством в среднем демонстрируют лучшее функциональное восстановление, чем пациенты с шизофренией.

Клиническая и биологическая логика: Шизоаффективное расстройство по клиническим проявлениям совпадает с шизофренией (психотические симптомы вне аффективного эпизода), но добавляется компонент расстройства настроения. Это не «лёгкая форма» — отдельная диагностическая единица. Некоторые пациенты демонстрируют тяжёлое течение.

Доказательства: Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009 — шизоаффективное расстройство имеет нейробиологическое совпадение с шизофренией, но значительные клинические различия; концепция «лёгкой формы шизофрении» не поддерживается.

Миф 2: «Шизоаффективное расстройство — это лишь смесь двух отдельных диагнозов (шизофрения + биполярное расстройство)»

Доказательства: Cross-Disorder Psychiatric Genomics Consortium 2013 — широкое генетическое перекрытие между шизофренией, биполярным и шизоаффективным расстройством. Это указывает на то, что диагностические единицы находятся в пределах спектра — шизоаффективное расстройство заслуживает отдельной клинической номинации, так как при длительном наблюдении демонстрирует различное течение и ответ на лечение.

Миф 3: «Шизоаффективное расстройство — вымышленный диагноз, не имеет валидности»

Почему распространено: Академическая дискуссия (Malhi 2008, Lake & Hurwitz 2007) — некоторые исследователи ставят под сомнение практическую ценность диагноза.

Клиническая логика: валидность диагноза спорна, но клиническая полезность (рамка для решения о лечении и прогнозе) сохраняется. DSM-5-TR и МКБ-11 оба сохраняют его как диагностическую единицу. В клинической практике пациента должен оценивать опытный психиатр — важно точно отличить от других расстройств, так как подход к лечению различен.

10.2 Ошибочные подходы к лечению

Миф 4: «Антидепрессанты можно использовать отдельно при шизоаффективном расстройстве»

Клиническая логика и доказательства: Использование антидепрессанта в монотерапии при шизоаффективном расстройстве противопоказано — риск маниакального поворота при депрессивном типе, риск усиления психоза при депрессивном. NICE CG185, CANMAT 2018 — в комбинации с антипсихотиком.

Миф 5: «Литий неэффективен при шизоаффективном расстройстве»

Доказательства: Cipriani A. et al. BMJ 2013 мета-анализ — литий в биполярном спектре (включая шизоаффективное расстройство биполярного типа) значительно снижает риск суицида. При шизоаффективном расстройстве биполярного типа литий является эффективным нормотимиком.

Миф 6: «Клозапин — только для рефрактерной шизофрении, а не для шизоаффективного расстройства»

Доказательства: применение клозапина при шизоаффективном расстройстве в случае неэффективности двух антипсихотиков является принятой клинической практикой; эффект снижения суицидального риска распространяется и на пациентов с шизоаффективным расстройством (исследование InterSePT Meltzer H.Y. et al. Arch Gen Psychiatry 2003).

10.3 Неэффективные или вредные подходы

Миф 7: «Экзорцизм, духовная практика или религиозный ритуал излечивают шизоаффективное расстройство»

Доказательства: Как при шизофрении — психотические симптомы имеют нейробиологическую основу; экзорцизм откладывает антипсихотическое лечение, ухудшая клинические исходы (DUP — маркер плохого прогноза, Marshall Arch Gen Psychiatry 2005)

Миф 8: «Каннабис как нормотимик излечивает шизоаффективное расстройство»

Доказательства: каннабис повышает риск психоза в 2–3 раза (Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016); у шизоаффективных пациентов считается противопоказанным — усиливает симптомы.

Миф 9: «Мегадозы витаминов или растительные препараты (зверобой, валериана) заменяют фармакотерапию»

Доказательства: в систематических обзорах нет доказательств эффективности; зверобой снижает уровень антипсихотиков и нормотимиков за счёт индукции цитохрома P450.

Миф 10: «Комплементарные вмешательства (акупунктура, гомеопатия, краниосакральная терапия) заменяют антипсихотик»

Доказательства: ни для одного из них не доказана эффективность при шизоаффективном расстройстве.

Миф 11: «Вне активного депрессивного эпизода фармакотерапия не требуется»

Доказательства: Согласно критериям шизоаффективного расстройства, психотические симптомы присутствуют и в периоды вне аффективных эпизодов — рекомендуется длительная поддерживающая терапия антипсихотиками.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A21 Schizoaffective disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
4. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
5. NICE Clinical Guideline 185. Bipolar disorder: assessment and management. 2014, 2020 update.
6. Yatham L.N., Kennedy S.H., Parikh S.V. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
7. Perälä J., Suvisaari J., Saarni S.I. et al. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007;64(1):19–28.
8. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013;381(9875):1371–1379.

9. Heckers S. Is schizoaffective disorder a useful diagnosis? Curr Psychiatry Rep 2009;11(4):332–337.
10. Malhi G.S., Green M., Fagiolini A., Peselow E.D., Kumari V. Schizoaffective disorder: diagnostic issues and future recommendations. Bipolar Disord 2008;10(1 Pt 2):215–230.
11. Lake C.R., Hurwitz N. Schizoaffective disorder merges schizophrenia and bipolar disorders as one disease — there is no schizoaffective disorder. Curr Opin Psychiatry 2007;20(4):365–379.
12. Cipriani A., Hawton K., Stockton S., Geddes J.R. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646.
13. Meltzer H.Y., Alphs L., Green A.I. et al. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). Arch Gen Psychiatry 2003;60(1):82–91.
14. Marshall M., Lewis S., Lockwood A. et al. Association between duration of untreated psychosis and outcome. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):975–983.
15. UK ECT Review Group. Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2003;361(9360):799–808.
16. NICE Technology Appraisal 59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).

МКБ-11 **6A22**	**6A22** **ШИЗОТИПИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Schizotypal disorder**
МКБ-10 F21	Шизотипическое расстройство
DSM-5-TR F21	Шизотипическое расстройство личности

1. Определение и нозология

Шизотипическое расстройство (МКБ-11: 6A22 Schizotypal Disorder; DSM-5-TR: F21 Schizotypal Personality Disorder) — клиническое состояние, характеризующееся стойкими нарушениями мышления и восприятия, странным (эксцентричным) поведением, социальными дефицитами и

психотикоподобными переживаниями, однако не достигающее критериев полного психотического эпизода.

Важный нозологический вопрос: МКБ-11 и DSM-5-TR — различное расположение:

- МКБ-11 — в рамках расстройств шизофренического спектра (психотическая категория), 6A22;
- DSM-5-TR — в главе расстройств личности (Cluster A) и одновременно в списке расстройств шизофренического спектра — двойное кодирование.

2. История

- Bleuler E. (1911) — концепция «латентной шизофрении» — состояние, близкое к шизофрении, но без полного психотического эпизода.
- Rado S. (1953) — термин «шизотип» — как постоянное личностное выражение генетической предрасположенности к шизофрении.
- Kety S.S. et al. (1968) — датские исследования усыновлённых — высокие шизотипические черты у биологических родственников больных шизофренией; основа концепции «шизофренического спектра».
- DSM-III (1980) — шизотипическое расстройство личности среди расстройств личности.
- МКБ-10 (1990) и МКБ-11 (2019) — шизотипическое расстройство в главе психотических расстройств.
- DSM-5 (2013) — двойное размещение (расстройства личности + шизофренический спектр) — концептуальный мост.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 0,6–4% — широкий диапазон (Pulay A.J. et al. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009, исследование NESARC США, n>34 000 — 3,9%).
- Пол: у мужчин относительно чаще; в некоторых исследованиях разница минимальна.
- Начало: Подростковый возраст и ранний взрослый период.
- Переход в шизофрению: ~10–25% (Schultze-Lutter F. et al. Schizophr Res 2014); выше при семейном анамнезе и дополнительных факторах риска психоза.

- Коморбидность: Расстройства настроения, тревога, употребление психоактивных веществ, другие расстройства личности (параноидное, шизоидное, пограничное).

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Общая генетическая нагрузка с шизофренией — Адоптивные исследования Кети и современные генетические исследования (англ. Cross-Disorder Group 2013) — у родственников шизотипических пациентов повышен риск шизофрении.
- Архитектура полигенного риска, сходная с шизофренией, но с меньшей «нагрузкой»; наличие некоторых защитных аллелей.

4.2 Нейробиология

- Более легкие варианты структурных изменений, наблюдаемых при шизофрении — уменьшение объёма височной коры, но сохранность лобной коры (обзор Hazlett E.A. et al. Schizophr Bull 2011).
- Дофаминергическая дисрегуляция — ниже, чем при шизофрении; психотическая декомпенсация менее вероятна.
- Когнитивные дефициты — как при шизофрении, но более легкие.

4.3 Средовые факторы

- Детская травма, социальная депривация — факторы риска.
- Употребление каннабиса в подростковом возрасте — повышает риск психотической декомпенсации.

5. Клиническая картина

5.1 Когнитивно-перцептивные симптомы

- Бред отношения (идеи отношения) — не на уровне полного бреда; пациент иногда может признавать нереальность этих идей.
- Странные убеждения или магическое мышление — телепатия, «шестое чувство», суеверия в степени, не соответствующей возрасту и культуре.
- Необычные перцептивные переживания — безличные, мимолетные иллюзии; полных галлюцинаций нет.
- Странное мышление и речь — расплывчатая, метафорическая, обстоятельная, стереотипная.

5.2 Интерперсональные симптомы

- Тревога в близких отношениях; социальная изоляция.
- Параноидные идеи или подозрительность.
- Неадекватный или ограниченный аффект.
- Странное, эксцентричное или своеобразное поведение и внешность.
- Мало близких друзей, кроме родственников первой степени.

5.3 Течение

Обычно начинается в подростковом возрасте и имеет непрерывное течение; у некоторых пациентов наблюдаются кратковременные эпизоды психотической декомпенсации (в контексте стресса, каннабиса) — в этом случае диагноз может быть пересмотрен как «шизофрения» или «острое и преходящее психотическое расстройство».

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. Социальные и межличностные дефициты и когнитивно-перцептивные нарушения — стойкая картина, характеризующаяся началом в зрелом возрасте, с наличием как минимум пяти из следующих симптомов:

1. Идеи отношения (исключая бред отношения);
2. Необычные убеждения или магическое мышление, не соответствующие возрасту и культуре;
3. Необычные перцептивные переживания (включая иллюзии);
4. Странное мышление и речь (расплывчатая, обстоятельная, метафорическая, стереотипная);
5. Подозрительность и параноидные идеи;
6. Неадекватный или ограниченный аффект;
7. Странное, эксцентричное или своеобразное поведение или внешность;
8. Мало близких друзей или доверенных лиц, кроме родственников первой степени;
9. Чрезмерная социальная тревожность, не уменьшающаяся при знакомстве (основана на параноидном страхе, а не на самооценке).

B. Не возникает в течении шизофрении, аффективного расстройства с психотическими чертами или расстройства аутистического спектра.

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 (6A22): «Шизотипическое расстройство» — в разделе психотических расстройств; как стойкое расстройство, но не достигающее критериев шизофрении.
- DSM-5-TR (F21): двойное кодирование — в списке расстройства личности кластера А и шизофренического спектра. Требование взрослого возраста; в детстве и подростковом возрасте может отмечаться как «преморбидные признаки».
- NICE: отдельных клинических рекомендаций по шизотипическому расстройству нет; применяются принципы CG78 (ПРЛ) и CG178 (Психоз).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от родственника/друга — устойчивые личностные черты vs эпизодический психоз.
2. Структурированное интервью — SCID-5-PD (англ. Personality Disorders), SIDP-IV.
3. Шкалы шизотипии — SPQ (англ. Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.).
4. Отдельная оценка психотических симптомов — субклинический уровень позитивных симптомов по PANSS.
5. Скрининг коморбидности (депрессия, тревога, употребление ПАВ, другие расстройства личности).
6. Медицинское и неврологическое обследование, токсикологический скрининг.
7. Оценка риска перехода в шизофрению (критерии сверхвысокого риска — CAARMS, SIPS).

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	**Отличительные признаки**
Шизофрения (6A20)	Полный психотический эпизод ≥ 1 мес; функциональное нарушение значительное.
Бредовое расстройство (6A24)	Конкретная систематизированная бредовая идея, общее функционирование относительно сохранно.

Расстройство	Отличительные признаки
Параноидное расстройство личности (6D10.x)	Доминирует подозрительность; перцептивных странных переживаний нет.
Шизоидное расстройство личности	Социальная изоляция, но когнитивно-перцептивные странности отсутствуют.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Раннее начало, социально-коммуникативный дефицит, ограниченно-повторяющееся поведение.
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность, нарушение идентичности, импульсивность.
Вещество-индуцированные психотические проявления	Связано с употреблением или отменой вещества

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические шкалы

- SPQ (англ. Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.) — 74 пункта, самооценка; 9 субшкал (на основе критериев DSM).
- SCID-5-PD — структурированное интервью для расстройств личности.
- CAARMS (англ. Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) — оценка риска перехода в шизофрению.
- SIPS (англ. Structured Interview for Prodromal Syndromes).
- PANSS, BPRS — субклинический уровень психотических симптомов.

7.2 Лабораторные исследования

Рутинных специальных указаний нет. Стандартные первичные психиатрические показатели (общий анализ крови, щитовидная железа, печень, почки, глюкоза); токсикологический скрининг.

7.3 Инструментальные исследования

Рутинно не требуется; при клиническом подозрении — нейровизуализация.

8. Лечение

8.1 Общие принципы

1. Психотерапия первой линии — поддерживающая психотерапия, КПТ (особенно при параноидном мышлении и социальной тревоге), тренинг социальных навыков.
2. Фармакотерапия симптоматическая, не лечит «ядерное» расстройство:
    - Низкая доза антипсихотика (рисперидон 0,5–2 мг, оланзапин 2,5–10 мг, арипипразол 2–10 мг) — для психотикоподобных симптомов; не постоянно, а интермиттирующе.
    - СИОЗС — при социальной тревоге и коморбидной депрессии.
    - Бензодиазепин краткосрочно — острая тревога.
3. Службы раннего вмешательства (EIP) — профилактическое вмешательство у пациентов с риском перехода в шизофрению (критерии UHR — Ultra High Risk).
4. Психосоциальная поддержка — поддержание функционального уровня, занятость, социальные связи.
5. Отказ от каннабиса — критически важно для снижения риска психотической декомпенсации.
6. Управление стрессом — стресс может быть триггером декомпенсации.
7. Семейное психообразование — информация о маркерах перехода в шизофрению; система социальной поддержки пациента.

8.2 Подходы к психотерапии

- КПТ — для параноидного мышления, социальной тревоги, когнитивных нарушений; проверка реальности и альтернативные объяснения.
- Тренинг социальных навыков — уменьшение социальной изоляции и странного поведения.
- Подходы, основанные на ментализации и поддерживающие подходы — укрепление межличностного функционального уровня.
- Schema Therapy — для устойчивых моделей, основанных на личности.

8.3 Фармакотерапия — конкретное применение

- Субклинические психотические симптомы (идеи отношения, странные переживания) при утяжелении — низкие дозы атипичного антипсихотика интермиттирующе.
- Коморбидная депрессия — СИОЗС (сертралин, эсциталопрам).

- Социальная тревожность — СИОЗС, краткосрочный бензодиазепин (для особых ситуаций).
- Стресс-индуцированная декомпенсация — госпитализация или краткосрочное интенсивное вмешательство.

8.4 Уточнения, специфичные для источника

- Доказательная база ограничена — Крупных РКИ по специфическому лечению шизотипического расстройства мало; основной подход — экстраполяция из вмешательств при шизофрении и расстройствах личности.
- Исследования Koenigsberg H.W. и соавт. — низкие дозы антипсихотиков при шизотипическом расстройстве (умеренный эффект).
- NICE — отдельных указаний нет; принципы CG178 и CG78.

8.5 Методики лечения

1. Опросник шизотипической личности (англ. Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ) — Рейн (Raine A.) — Самооценочная шкала из 74 пунктов; 9 подшкал, соответствующих критериям DSM для шизотипического расстройства личности. Широко используется в клинических и популяционных исследованиях.
2. Комплексная оценка психических состояний риска (англ. Comprehensive Assessment of At Risk Mental States, CAARMS) — Оценка риска перехода в шизофрению — субклинический уровень позитивных симптомов, когнитивные изменения, поведенческие нарушения, функциональный уровень. Yung A.R. et al. Aust N Z J Psychiatry 2005.
3. Структурированное интервью для продромальных синдромов (англ. Structured Interview for Prodromal Syndromes, SIPS) — Miller T.J., McGlashan T.H. — Аналогичен CAARMS; широко используется в США.
4. Службы раннего вмешательства (EIP) — для пациентов UHR — мультидисциплинарное вмешательство; антипсихотики обычно не рекомендуются для профилактики (из-за побочных эффектов), предпочтительны психосоциальные вмешательства.
5. КПТ, адаптированная для расстройств личности — для шизотипического расстройства личности — работа над когнитивными нарушениями, социальными страхами, параноидным мышлением.

6. Тренинг социальных навыков (англ. Social Skills Training) — структурированные групповые или индивидуальные сессии — развитие навыков социального взаимодействия.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Лёгкая интенсивность симптомов.
- Управление коморбидностью (депрессия, тревога, ПАВ).
- Социальная поддержка и устойчивые отношения.
- Участие в психотерапии.
- Отказ от каннабиса.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Шизофрения в семейном анамнезе.
- Употребление каннабиса или других психоактивных веществ.
- Тяжёлые когнитивные дефициты.
- Социальная изоляция и функциональное нарушение.
- Достижение критериев UHR.

Цели наблюдения

- Периодическая оценка маркеров перехода в шизофрению (CAARMS / SIPS).
- Скрининг коморбидности (депрессия, тревога, ПАВ).
- Функциональный уровень — занятость, социальные связи.
- Управление стрессом и триггерами психотической декомпенсации.
- Мониторинг побочных эффектов у принимающих антипсихотики.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии и концептуальные мифы

Миф 1: «Шизотипическое расстройство личности — это просто „эксцентричный“ или „творческий“ человек, не требующий клинического диагноза»

Почему распространено: Распространённость шизотипических черт (странные убеждения, эксцентричность) в популяции как непрерывный спектр — многие в общей популяции имеют легкие формы «schizotypy»

Клиническая и биологическая логика: клинический диагноз требует функционального нарушения — социальная изоляция, профессиональное нарушение, дистресс. Простая креативность или эксцентричность сами по себе не являются основанием для диагноза. Однако при достижении диагностических критериев шизотипическое расстройство является реальным клиническим состоянием, которое выигрывает от вмешательства.

Реальный клинический шаг: диагноз должен устанавливаться на основе диагностических критериев (5/9 симптомов + функциональное нарушение).

Миф 2: «Шизотипическое расстройство обязательно переходит в шизофрению»

Доказательства: Schultze-Lutter F. et al. Schizophr Res 2014 — переход от шизотипического расстройства к шизофрении ~10–25%; большинство остаётся стабильным или демонстрирует ремиссию. Семейный анамнез, употребление каннабиса, тяжесть когнитивного дефицита повышают риск перехода.

Реальный клинический шаг: Реалистичный прогноз для семьи; отслеживание критериев UHR; профилактические антипсихотики обычно не рекомендуются.

Миф 3: «Шизотипическое расстройство возникает из-за детской травмы или плохого воспитания»

Доказательства: генетический компонент значим — датские адоптивные исследования Кети; Cross-Disorder Group 2013. Детская травма указывается как фактор риска, но не является основной этиологией; биологическое и психосоциальное взаимодействие.

10.2 Ошибочные подходы к лечению

Миф 4: «Пациенты с шизотипическим расстройством обязательно должны постоянно принимать антипсихотики»

Доказательства: Длительная антипсихотическая терапия при шизотипическом расстройстве не рекомендуется (ограниченная доказательная база + побочные эффекты). Низкие дозы антипсихотиков интермиттирующе могут использоваться как симптом-специфическое вмешательство; для постоянного назначения — индивидуальная оценка.

Миф 5: «Подтверждение (валидация) „магического мышления“ пациента с шизотипическим расстройством — это лечение»

Клиническая логика: открытое подтверждение бредоподобных убеждений усиливает их; напротив, открытое отрицание также нарушает терапевтический альянс. Проверка реальности и альтернативные объяснения — в КПТ это доказанный подход — совместно с пациентом исследуются фактические доказательства убеждения или альтернативные объяснения.

Миф 6: «Социальная изоляция — здоровая стратегия, шизотипического пациента нужно оставить в покое»

Доказательства: социальная изоляция снижает долгосрочный функциональный уровень и повышает риск расстройств настроения. Рекомендуется постепенное укрепление социальных связей с помощью тренинга социальных навыков и поддерживающей терапии.

10.3 Неэффективные методы или методы, откладывающие основное вмешательство

Миф 7: «Альтернативные клиники, основанные на магическом мышлении и „шестом чувстве“, излечивают шизотипическое расстройство»

Доказательства: «Эзотерические вмешательства» (кристаллотерапия, работа с чакрами, астрологические консультации) — могут поддерживать странные убеждения шизотипического пациента и усиливать симптомы расстройства. Доказательства эффективности отсутствуют; откладывают основное психотерапевтическое или фармакотерапевтическое вмешательство.

Миф 8: «Каннабис „сохраняет креативность и необычные переживания“ — безопасен для шизотипического пациента»

Доказательства: каннабис повышает риск психоза в 2–3 раза (Marconi 2016); у шизотипических пациентов риск перехода в шизофрению выше. Отказ от каннабиса является критической клинической рекомендацией.

Миф 9: «Гомеопатия, акупунктура, эзотерические вмешательства излечивают шизотипическое расстройство»

Доказательства: систематические обзоры — эффективность этих вмешательств при шизотипическом расстройстве не доказана.

Миф 10: «Шизотипический пациент не отвечает на психотерапию, поэтому достаточно простого наблюдения»

Доказательства: КПТ, тренинг социальных навыков и поддерживающая психотерапия могут помочь этим пациентам; подход «наблюдение достаточно» усиливает функциональное нарушение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A22 Schizotypal disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Pulay A.J., Stinson F.S., Dawson D.A. et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV schizotypal personality disorder: results from the wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009;11(2):53–67.
4. Schultze-Lutter F., Klosterkötter J., Ruhrmann S. Improving the clinical prediction of psychosis by combining ultra-high risk criteria and cognitive basic symptoms. Schizophr Res 2014;154(1–3):100–106.
5. Hazlett E.A., Goldstein K.E., Kolaitis J.C. A review of structural MRI and diffusion tensor imaging in schizotypal personality disorder. Curr Psychiatry Rep 2012;14(1):70–78.
6. Raine A. The SPQ: a scale for the assessment of schizotypal personality based on DSM-III-R criteria. Schizophr Bull 1991;17(4):555–564.
7. Yung A.R., Yuen H.P., McGorry P.D. et al. Mapping the onset of psychosis: the Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States. Aust N Z J Psychiatry 2005;39(11–12):964–971.

8. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013;381(9875):1371–1379.
9. Marconi A., Di Forti M., Lewis C.M., Murray R.M., Vassos E. Meta-analysis of the association between the level of cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.
10. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
11. Kety S.S., Rosenthal D., Wender P.H. et al. The types and prevalence of mental illness in the biological and adoptive families of adopted schizophrenics. J Psychiatr Res 1968;6(Suppl 1):345–362.
12. Miller T.J., McGlashan T.H., Rosen J.L. et al. Prodromal assessment with the Structured Interview for Prodromal Syndromes and the Scale of Prodromal Symptoms. Schizophr Bull 2003;29(4):703–715.
13. Koenigsberg H.W., Reynolds D., Goodman M. et al. Risperidone in the treatment of schizotypal personality disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(6):628–634.

МКБ-11 **6A23**	**6A23 ОСТРОЕ ТРАНЗИТОРНОЕ ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Acute and transient psychotic disorder**
МКБ-10 F23	Острые и преходящие психотические расстройства
DSM-5-TR F23	Краткое психотическое расстройство

1. Определение и нозология

Острое транзиторное психотическое расстройство (МКБ-11: 6A23 Acute and Transient Psychotic Disorder; DSM-5-TR: F23 Brief Psychotic Disorder) — расстройство, характеризующееся быстрым (несколько дней-недель) началом, психотическими симптомами (бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, грубо дезорганизованное поведение), кратковременным течением и полным восстановлением до преморбидного функционального уровня.

Характерные особенности:

- Быстрое начало — Формирование полной клинической картины в течение 2 недель;
- Полиморфные (многообразные) симптомы — бред, галлюцинации и эмоциональная лабильность совместно;
- Короткая продолжительность — в DSM-5-TR < 1 месяца, в ICD-11 < 3 месяцев;
- Полное функциональное восстановление — пациент полностью возвращается к преморбидному уровню.

2. История

- Magnan V. (1893) — Термин «bouffée délirante» — описание быстро начинающихся, кратковременных полиморфных психотических эпизодов во Франции.
- Wernicke K., Kleist K., Leonhard K. (1900–1957) — Концепция «циклических психозов» — в немецкой психиатрической школе; быстрое начало и хороший прогноз.
- Скандинавская школа — «психогенный психоз» — Strömgren E. (1940) — психоз в контексте стресса или травмы.
- DSM-III (1980) — «Brief Reactive Psychosis» — с требованием стрессового фактора.
- DSM-IV (1994) и DSM-5 (2013) — критерий стрессового фактора отменён (остался как квалификатор); термин «Brief Psychotic Disorder».
- МКБ-11 (2019) — Термин «Острое и транзиторное психотическое расстройство» сохранён; продолжительность 3 месяца; подчеркивается полиморфная симптоматика.

3. Эпидемиология

- Годовая заболеваемость: 3,9–9,6 / 100 000 (Castagnini A., Berrios G.E. Curr Psychiatry Rep 2009 обзор).
- Пол: у женщин относительно чаще (1,5–2:1) — особенно в послеродовом контексте.
- Возраст начала: 20–35 лет; несколько позже, чем при шизофрении.
- Культурное и географическое: частота выше в странах с низким и средним доходом (Susser E. et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998, исследование ВОЗ в 10 странах).

- Послеродовое начало — относится к категории послеродового психоза (6E20 / 6A23.x).
- Персистенция и конверсия: 30–50% пациентов при длительном наблюдении повторно диагностируются как шизофрения, шизоаффективное расстройство или биполярное расстройство (Castagnini A. et al. Schizophr Res 2013).

4. Этиология и патогенез

4.1 Генетические факторы

- Частично общий генетический риск с шизофренией и биполярным расстройством.
- Риск повышается при наличии психотического или аффективного расстройства в семейном анамнезе.

4.2 Триггеры и стресс

- Острый психосоциальный стресс (смерть, беженство, стихийное бедствие) — выявляется у значительной части пациентов; в DSM-5-TR указывается как квалификатор стресса.
- Послеродовой период — гормональные нарушения и нарушение сна.
- Употребление вещества — каннабис, амфетамин, галлюциногены — может спровоцировать психотический эпизод, но вещество-индуцированный психоз кодируется как отдельная категория, если вещество определено.
- Кратковременная депривация сна, интенсивное эмоциональное напряжение.

4.3 Нейробиологические механизмы

- Временная гиперактивность дофаминергической системы — в контексте стрессового кортизола или гормональных изменений.
- Центральные механизмы, как при шизофрении, но более кратковременные и потенциально обратимые.

5. Клиническая картина

5.1 Классическая презентация

- Быстрое начало — в течение дней-недель от преморбидной нормальной функции до полной психотической картины.

- Полиморфные (изменчивые) симптомы — бред (преследования, отношения, религиозный), галлюцинации (слуховые, зрительные, коэнестетические), дезорганизованная речь.
- Эмоциональная лабильность — острый страх, экстаз, паника, растерянность.
- Изменений сознания нет (исключая делирий).
- Поведение — странное, дезорганизованное; иногда кататонические компоненты.

5.2 МКБ-11: подтипы

- Полиморфное психотическое расстройство — без симптомов шизофрении;
- Полиморфное психотическое расстройство — с симптомами шизофрении;
- Острое психотическое расстройство, подобное шизофрении — доминируют симптомы первого ранга по Шнайдеру.

5.3 Течение

Типичное течение — достижение пика за 2–4 недели, затем постепенное или быстрое угасание. Полное восстановление — в течение 1 месяца (DSM-5-TR) или 3 месяцев (МКБ-11). При сохранении дольше этого срока диагноз меняется на шизофреноформное расстройство (DSM-5-TR F20.81, 1–6 мес.) или шизофрению.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. Наличие одного или нескольких психотических симптомов:

1. Бредовые идеи;
2. Галлюцинации;
3. Дезорганизованная речь;
4. Грубо дезорганизованное или кататоническое поведение.

(Как минимум один из пунктов 1, 2 или 3 должен присутствовать.)

B. Длительность эпизода:

- DSM-5-TR: ≥ 1 дня, < 1 месяца, затем полное восстановление до преморбидного уровня функционирования.

- МКБ-11: полная картина формируется в течение 2 недель; < 3 мес. сохраняется.

С. Исключения — аффективное расстройство с психотическими чертами, шизофрения, шизоаффективное расстройство, психоз, индуцированный веществом, органический психоз — полностью не объясняется.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR (F23): Квалификаторы — «С выраженным стрессором(ами)» (с острым стрессовым фактором), «Без выраженного стрессора», «С послеродовым началом» (в течение 4 недель после родов).
- МКБ-11 (6A23): три подтипа — полиморфный (без / с симптомами шизофрении) и шизофреноподобный. Послеродовое начало относится к отдельному коду 6E20.
- Стрессовый фактор — это не критерий, а квалификатор — в DSM-IV был обязательным в рамках «Brief Reactive Psychosis».

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от родственников — динамика начала, преморбидное функционирование.
2. Структурированное интервью (SCID-5, MINI).
3. Шкалы тяжести — PANSS, BPRS.
4. Токсикологический скрининг (обязательно) — для исключения индуцированного веществами психоза.
5. Физикальное и неврологическое обследование.
6. Лабораторно: общий анализ крови, печень, почки, электролиты, глюкоза, TSH, B12, сифилис, ВИЧ.
7. ЭЭГ и МРТ головного мозга — при первом эпизоде или атипичной клинической картине.
8. В послеродовом контексте — функция щитовидной железы обязательна.
9. Оценка риска суицида и вреда ребёнку (в послеродовых случаях).
10. Наблюдение — диагноз может измениться в зависимости от длительности (по истечении 1 или 3 месяцев).

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	Отличительные признаки
Шизофрения (6A20)	Продолжительность ≥ 1 месяц (МКБ-11) / ≥ 6 месяцев (DSM-5-TR общая); резидуальные признаки.
Шизоаффективное расстройство (6A21)	Аффективный эпизод присутствует в течение значительной части психотических симптомов.
Шизофреноформное расстройство (DSM-5-TR F20.81)	В DSM-5-TR 1–6 месяцев; в МКБ-11 отдельного кода нет.
Биполярное I расстройство с психотическими особенностями (6A60.x)	В контексте маниакального эпизода.
Послеродовой психоз (6E20)	В течение 4–6 недель после родов; высокий риск детоубийства и материнского суицида — медицинская неотложная помощь.
Вещество-индуцированный психоз	Четкая временная связь с веществом (каннабис, амфетамин, галлюциноген); токсикологический скрининг.
Вторичный психоз (6E61)	Связано с органической причиной (аутоиммунный энцефалит, волчанка, паранеопластический процесс).
Делирий	Изменение сознания; флуктуация внимания; органическая причина.
Диссоциативный эпизод	В контексте травмы; доминирует социальная изоляция.

7. Обследование и оценка

7.1 Клинические шкалы

- PANSS, BPRS — психотическая тяжесть.
- HAM-D, YMRS — оценка аффективных компонентов.
- C-SSRS — суицидальный риск.

- GAF/PSP — функциональный уровень.

7.2 Лабораторные исследования

Согласно протоколу первого психотического эпизода (см. 6A20 §7.2):

- Обязательно: общий анализ крови, печень/почки, глюкоза, электролиты, ТТГ, B12, фолат, токсикологический скрининг, ВИЧ, сифилис, тест на беременность, пролактин.
- При подозрении на органический психоз — антитела к anti-NMDA-R (CSF), ANA, волчаночная панель, панель паранеопластических антител, аммиак, церулоплазмин.
- В послеродовом контексте — ТТГ (возможен послеродовой гипотиреоз).

7.3 Инструментальные исследования

- МРТ головного мозга — рекомендуется при первом эпизоде (NICE CG178); особенно при атипичной презентации или неврологических симптомах.
- ЭЭГ — исключение приступов, атипичная клиническая картина.
- ЭКГ — перед началом приёма антипсихотика.
- Люмбальная пункция — подозрение на аутоиммунный энцефалит (атипичный психоз + двигательные симптомы + молодой возраст).

8. Лечение

8.1 Общие принципы

1. Срочная оценка и при необходимости госпитализация — для безопасности пациента или других лиц.
2. Первая линия: атипичный антипсихотик в низкой дозе — рисперидон 1–4 мг, оланзапин 5–15 мг, кветиапин 200–600 мг, арипипразол 5–15 мг.
3. При острой ажитации — перорально лоразепам 1–2 мг + оланзапин перорально диспергируемый 5–10 мг; внутримышечно — оланзапин 10 мг в/м или арипипразол 9,75 мг в/м, при необходимости галоперидол 5 мг + лоразепам 2 мг в/м (классический).
4. Длительность — антипсихотик типично 3–6 месяцев (после ремиссии), затем постепенное снижение и мониторинг; отмена после первого эпизода не является стандартом — индивидуальная оценка.
5. В стресс-индуцированном контексте — психосоциальная поддержка, управление стрессом на основе КПТ.

6. При послеродовом начале — как неотложное медицинское состояние; высокий риск детоубийства и суицида; госпитализация, предпочтительно совместная госпитализация матери и ребёнка при наличии условий; см. раздел 6E20.
7. ЭСТ — при рефрактерных тяжёлых случаях, с кататоническими чертами, самый безопасный выбор при беременности.
8. Длительное наблюдение — 30–50% пациентов переходят в длительное психотическое расстройство; ежемесячно в первый год, затем ежеквартально.

8.2 Методики лечения

1. Службы раннего вмешательства (EIP — Early Intervention in Psychosis) — Мультидисциплинарная помощь в течение 3 лет при первом психотическом эпизоде — низкодозовая фармакотерапия, КПТп, семейное вмешательство, поддержка занятости. РКИ RAISE (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016). Пациенты с острыми и преходящими расстройствами также включаются в программы EIP.
2. Когнитивно-поведенческая терапия психоза (КПТп / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Переоценка психотических симптомов в формулировке «мысль–эмоция–поведение». NICE CG178 §1.3.7.1.
3. Семейное психообразование (англ. Family Psychoeducation) — Поддержка пациента после эпизода, распознавание ранних маркеров рецидива, обучение семейной коммуникации. Pharoah Cochrane 2010.
4. Электросудорожная терапия (ЭСТ — Electroconvulsive Therapy) — При кататонических чертах, тяжёлой неэффективности фармакотерапии, беременности. NICE TA59. UK ECT Review Group Lancet 2003.
5. PANSS, BPRS — Стандартизированная оценка тяжести психоза.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG178 (Psychosis): правила первого эпизода психоза — атипичный антипсихотик в низкой дозе первая линия; участие служб раннего вмешательства (EIP); совместное психосоциальное вмешательство.
- APA Practice Guideline 2021 (Schizophrenia): Специфического алгоритма для острого и преходящего психотического расстройства нет; принципы первого психотического эпизода.
- NICE CG192 (англ. Antenatal and postnatal mental health): послеродовой психоз — медицинская неотложная помощь: госпитализация,

атипичный антипсихотик + бензодиазепин, ЭСТ в рефрактерных случаях.

9. Прогноз

Факторы благоприятного прогноза

- Очень быстрое начало и короткая продолжительность.
- Четкий стрессовый триггер.
- Преморбидный хороший функциональный уровень.
- Наличие аффективного компонента.
- Полиморфная симптоматика (без симптомов шизофрении).
- Отсутствие семейного психотического анамнеза.
- Отсутствие употребления каннабиса или других веществ.

Факторы неблагоприятного прогноза

- Симптомы, подобные шизофрении (симптомы первого ранга по Шнайдеру).
- Отсутствие стрессового триггера.
- Постепенное начало.
- Преморбидная функциональная слабость.
- Шизофрения в семейном анамнезе.
- Употребление вещества.

Цели наблюдения

- Длительное наблюдение критически важно — 30–50% переходят в шизофрению, шизоаффективное или биполярное расстройство; первый год ежемесячно, затем ежеквартальное формальное наблюдение.
- Распознавание маркеров рецидива (нарушение сна, социальная отгороженность, странные переживания).
- Постепенное снижение дозы и отмена антипсихотика — индивидуальное решение (риск рецидива vs побочные эффекты).
- Коморбидное употребление ПАВ и интервенция при травме.
- В послеродовых случаях — высокий риск рецидива при последующих беременностях, планируется профилактическое лечение.

10. Мифы и заблуждения

10.1 Мифы об этиологии и концептуальные мифы

Миф 1: «Острый и преходящий психоз — это просто „психологический срыв“, зависящий от силы личности»

Почему распространено: связь со стрессом во времени и краткосрочное течение, по-видимому, поддерживают «психологическое» объяснение.

Клиническая и биологическая логика: стресс является триггерным фактором, но не единственным объяснением — не все люди в стрессе переносят психоз. Существует генетическая и нейробиологическая предрасположенность. Данные Castagnini 2013 — 30–50% пациентов переходят в шизофрению, шизоаффективное или биполярное расстройство; это указывает на нейробиологическую предрасположенность.

Реальный клинический шаг: управление стрессом и психотерапевтическая поддержка важны, но антипсихотическое лечение не должно откладываться.

Миф 2: «Острый психоз обязательно так же опасен, как послеродовой психоз / нет, он всегда проходит сам»

Клиническая логика: каждый острый психотический эпизод заслуживает неотложной медицинской оценки. При послеродовом начале риск особенно высок (детоубийство ~4%, суицид матери). При остром транзиторном эпизоде вне послеродового периода также существует риск суицида и насилия — необходимо оценить содержание бреда и контроль поведения пациента.

Миф 3: «Наличие стрессового фактора — условие для диагноза»

Доказательства: В DSM-IV «Brief Reactive Psychosis» фактор стресса был критерием, но в DSM-5-TR и МКБ-11 не является критерием — это квалификатор — диагностически возможны также острые психотические эпизоды без стресса.

10.2 Ошибочные подходы к лечению

Миф 4: «Острый психоз проходит сам по себе, лечение можно отложить»

Клиническая логика и доказательства: Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 — по мере удлинения нелечёного периода психоза (DUP) ухудшается долгосрочный прогноз. Даже при эпизоде, считающемся транзиторным, раннее

антипсихотическое вмешательство важно для сокращения симптомов и уменьшения осложнений.

Миф 5: «Острого психотического пациента можно оставить одного — он может себя контролировать»

Доказательства: В остром психотическом эпизоде у пациента нарушена проверка реальности; критическое самообслуживание, приём пищи и воды, обеспечение личной безопасности невозможны. В большинстве случаев требуется госпитализация или круглосуточное наблюдение.

Миф 6: «При остром транзиторном психозе экзорцизм или религиозный ритуал могут заменить антипсихотик»

Доказательства: Как при шизофрении — по мере удлинения DUP прогноз ухудшается; религиозно-культурная поддержка может быть параллельной, но не заменяет антипсихотическое лечение

10.3 Неэффективные или вредные подходы

Миф 7: «Острый психоз — это „духовный кризис“ или „переход к высшему сознанию“, лечение вредно»

Почему распространено: Stan Grof и течение «трансперсональной психологии» — переосмысление психотических переживаний как «духовного пробуждения».

Клиническая логика и доказательства: этот подход не принимается в современной клинической практике и доказательной психиатрии. Психотические симптомы вызывают у пациента реальный дистресс и подвергают его риску; клинический исход отказа от лечения плохой (удлинение DUP).

Миф 8: «Каннабис может купировать острый психотический эпизод»

Доказательства: каннабис является триггером или катализатором психоза — седативный эффект иллюзорен, косвенно усиливает симптомы; в клинической практике противопоказан.

Миф 9: «Витамины, омега-3, валериана, зверобой эффективны при остром психозе»

Доказательства: эти комплементарные вмешательства не доказали эффективность при остром психотическом эпизоде; зверобой снижает уровень антипсихотиков за счёт индукции цитохрома P450 (взаимодействие).

Миф 10: «Гипнотерапия или глубокая психоаналитическая терапия могут применяться при остром психозе»

Доказательства: В остром психотическом эпизоде глубокая психоаналитическая интервенция может дезорганизовать пациента; на этом этапе важны поддерживающая терапия, структура и безопасность, глубокая интервенция не проводится.

11. Источники

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A23 Acute and transient psychotic disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
4. NICE Clinical Guideline 192. Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance. 2014, 2018 update.
5. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
6. Castagnini A., Berrios G.E. Acute and transient psychotic disorders (ICD-10 F23): a review from a European perspective. Curr Psychiatry Rep 2009;11(4):237–247.
7. Castagnini A., Bertelsen A., Berrios G.E. Diagnosis of acute and transient psychotic disorders 12 years after admission: a follow-up study. Schizophr Res 2013;143(1):198–203.
8. Susser E., Wanderling J. Epidemiology of nonaffective acute remitting psychosis vs schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33(10):485–490.
9. Marshall M., Lewis S., Lockwood A. et al. Association between duration of untreated psychosis and outcome. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):975–983.
10. Kane J.M., Robinson D.G., Schooler N.R. et al. Comprehensive versus usual community care for first-episode psychosis (RAISE). Am J Psychiatry 2016;173(4):362–372.
11. NICE Technology Appraisal 59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).

МКБ-11 **6A24**	**6A24 БРЕДОВОЕ РАССТРОЙСТВО** **Delusional disorder**
МКБ-10 F22	Хронические бредовые расстройства
DSM-5-TR F22	Бредовое расстройство

1. Определение и нозология

Бредовое расстройство (МКБ-11: 6A24 Delusional Disorder; DSM-5-TR: F22) — психотическое расстройство, которое преимущественно проявляется одним или несколькими бредовыми идеями продолжительностью не менее одного месяца, но не достигает полных критериев шизофрении. Общее поведение и функциональный уровень пациента относительно сохранны, за исключением бреда.

2. История

- Kraepelin (1899) — «paranoia» — систематизированный бред, без галлюцинаций.
- Esquirol J.E. (1810-е годы) — термин «мономания»; Kahlbaum K. (1863) и Krafft-Ebing R. — клиническое описание паранойи.
- DSM-III-R (1987) — «Бредовое расстройство» официально; продолжение концепции паранойи Kraepelin.
- МКБ-11 (2019): допускаются также бредовые идеи необычного содержания (bizarre) (в МКБ-10 — только не-bizarre); индуцированный бред (folie à deux) интегрирован как отдельный подтип.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: ~0,2% (Perälä 2007).
- Начало: средний возраст (35–55 лет), значительно позже шизофрении.
- Пол: примерно одинаково; различия в некоторых подтипах (эротомания у женщин).
- Коморбидность: депрессия, тревога, социальная изоляция; высокий суицидальный риск.

4. Этиология и патогенез

- Генетическая нагрузка меньше, чем при шизофрении; однако в семейном анамнезе повышена частота параноидного расстройства личности и психотических расстройств.
- Сенсорная депривация (нарушение слуха) — повышает риск параноидной подозрительности у пожилых.
- Социальная изоляция, миграция, языковые барьеры — факторы риска.
- Нейробиологически — дофаминергическая дисрегуляция, но более локализованная, чем при шизофрении; в некоторых исследованиях повышение синтеза дофамина в стриатуме (обзоры Howes O.D.).

5. Клиническая картина

Подтипы (по содержанию бреда)

- Преследование (персекуторное): Наиболее интенсивно — наблюдение другими, планирование вреда.
- Ревность (синдром Отелло): бред супружеской неверности; высокий риск криминальных действий.
- Эротоманический (синдром Клерамбо): убеждённость в том, что другой человек (обычно высокого статуса) любит пациента.
- Грандиозность (грандиоз): особая способность, талант, открытие, религиозная миссия.
- Соматический (тип): убеждённость в наличии паразитов в теле (синдром Экбома), распространении запаха, деформации.
- Смешанный и неспецифический.

Функциональное поддержание

Вне бреда общее поведение пациента, аффект, когнитивные функции относительно сохранны; работа и отношения могут продолжаться, если не затрагивается содержание бреда.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11)

А. Наличие одного или нескольких бредов: МКБ-11 — не менее 3 месяцев (обычно дольше), DSM-5-TR — не менее 1 месяца.

B. Шизофрения, не достигающая критерия A (бред является единственным или доминирующим симптомом; галлюцинации минимальны и возможны, если связаны с содержанием бреда).

C. Функциональное сохранение без прямого влияния бреда; поведение не странное.

D. Если аффективный эпизод присутствует, то в течение меньшей части периода бреда.

E. Исключение вещества или органической причины

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11: допускаются бредовые идеи необычного содержания (bizarre) (в DSM-5-TR запрет также снят); индуцированный бред (folie à deux) интегрирован в 6A24.
- DSM-5-TR: Квалификаторы подтипа (эротоманический, грандиозный, ревнивый, персекуторный, соматический, смешанный, неспецифический); дополнительный квалификатор «причудливый тип».

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (общее и особенно содержание бреда).
2. Интервью с родственником/другом — преморбидная функция, начало бреда.
3. SCID-5 / MINI; PANSS / BPRS подшкала позитивных симптомов.
4. Медицинское и неврологическое обследование.
5. Токсикологический скрининг; сенсорный тест (слух, зрение) — обязательно у пожилых.
6. МРТ головного мозга (при первом эпизоде).
7. Оценка коморбидной депрессии и суицидального риска.

6.4 Дифференциальная диагностика

Расстройство	**Отличительные признаки**
Шизофрения (6A20)	Галлюцинации, дезорганизованная речь, негативные симптомы доминируют; значительное нарушение функционирования.

Расстройство	Отличительные признаки
Шизоаффективное расстройство (6A21)	Аффективный эпизод присутствует в течение значительной части психотических симптомов.
Телесное дисморфическое расстройство (6B21)	Связано с внешностью; степень инсайта вариабельна, но может быть на уровне бреда.
ОКР — со слабой критикой (6B20)	Эго-дистоническая обсессия как основное; отличается от бреда.
Параноидное расстройство личности	Стойкая подозрительность как черта личности; полная паранойя отсутствует.
Вторичный бред (6E61)	Органическая причина — деменция, опухоль мозга, волчанка, энцефалит.
Вещество-индуцированное (особенно амфетамин, кокаин)	В контексте употребления или отмены вещества; ремиссия после элиминации

7. Обследование и оценка

- PANSS / BPRS субшкала позитивных симптомов; структурированная документация конкретного содержания бреда.
- Тест слуха и зрения (обязателен у пожилых).
- Лабораторно: общий анализ крови, щитовидная железа, B12, печень, глюкоза, токсикологический скрининг, сифилис, ВИЧ, ANA (волчанка), церулоплазмин (Вильсон).
- МРТ головного мозга — первый эпизод, атипичная клиника, пожилой пациент.
- Оценка риска суицида и насилия (C-SSRS, особенно при бреде ревности).

8. Лечение

1. Атипичный антипсихотик в низкой дозе (рисперидон 1–3 мг, оланзапин 5–10 мг, арипипразол 5–15 мг) — первая линия. Доказательная база меньше, чем при шизофрении; приверженность пациентов проблематична (из-за содержания бреда).

2. Пимозид исторически считался предпочтительным при эротомании и соматическом бреде (исследования Munro A.), но в современной практике используется реже по сравнению с атипичными (QTc, EPS).
3. Психотерапия — поддерживающая терапия, установление терапевтического альянса; КПТ (неконфронтационная работа с содержанием бреда, исследование альтернативных объяснений).
4. Коморбидная депрессия — СИОЗС.
5. Риск насилия или суицида (особенно бред ревности) — госпитализация и недобровольное лечение в рамках законодательства.
6. Сенсорное расстройство — слуховые аппараты или коррекция зрения — иногда радикально влияют на параноидный бред у пожилых.
7. Социальная поддержка — уменьшение изоляции; семейное психообразование.

8.1 Методики лечения

1. Неконфронтационная КПТ — Не отрицая открыто содержание бреда, совместное с пациентом исследование альтернативных объяснений и доказательств. Исследования Birchwood M., Trower P. — эффективны при шизофрении и бредовом расстройстве.
2. Поддерживающая терапия и терапевтический альянс — Установление долгосрочных доверительных отношений с пациентом; укрепление приверженности лечению.
3. Позитивная субшкала симптомов PANSS — Стандартизированная оценка тяжести и степени вмешательства бреда.
4. Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (англ. Columbia-Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) — Риск суицида — особенно при бреде ревности и преследования; дополнительно оценивается риск насилия.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG178 — отдельного алгоритма для бредового расстройства нет; применяются общие принципы психозов.
- APA 2021 — антипсихотик первой линии; подчеркивается трудность инсайта и приверженности.
- Обзоры Munro A. (Cambridge Univ Press 1999) — подтип-специфические клинические рекомендации.

9. Прогноз

- Прогноз лучше, чем при шизофрении — сохранение функционирования, позднее начало.
- Приверженность является основным ограничением.
- Ревность и соматический бред относительно более трудно поддаются лечению.
- У пожилых людей возможно улучшение с помощью сенсорной коррекции.
- Наблюдение — побочные эффекты антипсихотиков, выраженность бреда, риск насилия и суицида.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Нужно убедить пациента в ошибочности его бреда»

Клиническая логика: открытая конфронтация нарушает терапевтический альянс и может усилить бред; у пациента формируется объяснение «врач тоже против меня».

Доказательства: Подходы КПТ Birchwood и Trower — эффективен неконфронтационный подход, позволяющий пациенту самостоятельно исследовать альтернативные объяснения.

Миф 2: «Бредовое расстройство можно лечить только психотерапией, антипсихотики не нужны»

Доказательства: антипсихотики — фармакотерапия первой линии; психотерапия сама по себе недостаточна. APA 2021, NICE CG178.

Миф 3: «Эротомания — исключительно женское заболевание, у мужчин не встречается»

Доказательства: эротомания встречается у обоих полов; у пациентов мужского пола отмечен более высокий риск насилия (Menzies R.P. et al. Br J Psychiatry 1995).

Миф 4: «Бред ревности — признак „большой любви“, а не медицинское состояние»

Доказательства: Синдром Отелло — клиническое психотическое состояние, высокий риск насилия и убийства партнёра; требует активного медицинского вмешательства.

Миф 5: «Параноидная настороженность у пожилых — это „нормальное старение“»

Доказательства: У пожилых параноидный бред часто является маркером сенсорной депривации (нарушение слуха) или ранней деменции; поддаётся лечению. Слуховой аппарат или коррекция зрения иногда дают значительное улучшение.

Миф 6: «Экзорцизм или религиозное вмешательство излечивают бред»

Доказательства: психотические симптомы имеют нейробиологическую основу; откладывает начало антипсихотической терапии.

Миф 7: «Пациента с бредом необходимо изолировать — социальные контакты вредны»

Доказательства: социальная изоляция, напротив, усиливает бред; рекомендуются социальная поддержка и психотерапия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A24 Delusional disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG178. Psychosis and schizophrenia in adults. 2014/2019.
4. APA. Practice Guideline for Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
5. Munro A. Delusional Disorder: Paranoia and Related Illnesses. Cambridge University Press; 1999.
6. Perälä J. et al. Arch Gen Psychiatry 2007;64(1):19–28.
7. Menzies R.P., Fedoroff J.P., Green C.M., Isaacson K. Prediction of dangerous behaviour in male erotomania. Br J Psychiatry 1995;166(4):529–536.
8. Howes O.D., Kapur S. Schizophr Bull 2009;35(3):549–562.
9. Trower P., Birchwood M., Meaden A. et al. Cognitive therapy for command hallucinations: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2004;184:312–320.

МКБ-11 **6A25**	**6A25 СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНО ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ** **Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders**
МКБ-10 —	Эквивалента в МКБ-10 нет
DSM-5-TR F29	Неуточнённое расстройство шизофренического спектра и другое психотическое расстройство

1. Определение и нозология

6A25 МКБ-11 — в группе первичных психотических расстройств (6A20–6A24) дименсиональная субструктура — Не является отдельной клинической нозологической единицей — диагноз ставится как дополнительный квалификатор к основному расстройству (например, 6A20 Шизофрения). Шесть доменов симптомов — для каждого из них оценивается отдельная степень тяжести (отсутствует / лёгкая / средняя / тяжёлая).

Основа концепции — описание гетерогенной клинической картины психотических расстройств с помощью более валидного и изменчивого измерения вместо классических подтипов (параноидный, гебефренический, кататонический).

2. История

- Симптомы «4A» Bleuler (1911) и «симптомы первого ранга» Schneider (1959) — категориальный подход.
- Crow T.J. (1980) — концепция типа I (доминирование позитивных симптомов) и типа II (доминирование негативных) — основа дименсионального подхода.

- Liddle P.F. (1987) — трехмерный фактор — искажение реальности, дезорганизация, психомоторная бедность.
- DSM-5 (2013) — в исследовательской категории раздела III предложена дименсиональная оценка.
- МКБ-11 (2019) — 6A25 интегрирован в качестве официального дименсионального квалификатора.

3. Шесть доменов симптомов

3.1 Позитивные симптомы

Бред, галлюцинации — «усиленные / дополнительные» симптомы в процессах восприятия и мышления. Тяжесть: от отсутствия до тяжёлой степени (в зависимости от степени влияния на повседневную деятельность пациента).

3.2 Негативные симптомы

Аффективная уплощенность, аволиция (потеря мотивации), алогия (обеднение речи), ангедония, социальная отгороженность. Является основным фактором функционального нарушения; слабо поддаётся фармакотерапии.

3.3 Депрессивные симптомы

Сниженное настроение, безнадежность, суицидальные мысли, психомоторная заторможенность, ангедония (в отличие от негативного симптома доминирует эмоциональный компонент).

3.4 Маниакальные симптомы

Повышенное или раздражительное настроение, ускоренное мышление, грандиозные идеи, сниженная потребность во сне, быстрая речь, психомоторное возбуждение.

3.5 Психомоторные симптомы

Кататонические компоненты (мутизм, негативизм, восковая гибкость, позерство), ажитация, заторможенность, стереотипии.

3.6 Когнитивные симптомы

Рабочая память, внимание, исполнительная функция, скорость обработки, социальное познание. Присутствуют у 75–85% пациентов; сильное влияние на долгосрочный функциональный уровень.

4. Клиническое использование

4.1 Инструменты оценки

- PANSS (позитивная, негативная, общая психопатология субшкалы).
- SANS / SAPS — негативные и позитивные симптомы раздельно.
- HAM-D, MADRS — депрессивный компонент.
- YMRS — маниакальный компонент.
- Шкала кататонии Буш-Фрэнсис — психомоторный компонент.
- MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) — когнитивный компонент.

4.2 Клинические импликации лечения

- Доминирование позитивных симптомов — стандартный антипсихотик (D2-антагонист).
- Доминирование негативных симптомов — предпочтителен атипичный антипсихотик (клозапин, карипразин); амисульприд в низкой дозе; психосоциальная реабилитация.
- Депрессивный компонент — адъюнктивный СИОЗС (сертралин) или антидепрессант; мониторинг суицидального риска.
- Маниакальный компонент — стабилизатор настроения (литий, вальпроат) адъюнкт; пересмотр как шизоаффективное расстройство.
- Кататонический компонент — тест с лоразепамом или ЭСТ.
- Когнитивный компонент — когнитивная ремедиация (мета-анализ Wykes 2011); влияние на функциональный уровень при совместном применении с поддерживаемым трудоустройством.

5. Источник-специфические уточнения

- МКБ-11 (6A25): поскольку степень тяжести каждого домена меняется в течение болезни, рекомендуется периодическая переоценка.
- DSM-5-TR: В исследовательской категории Section III «Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity» — параллельно с МКБ-11 6A25; не является официальным диагностическим квалификатором, но может использоваться на практике.
- NICE CG178: дименсиональная оценка рекомендуется как клинический подход — основа персонализации лечения.

6. Мифы и заблуждения

Миф 1: «6A25 — отдельное расстройство, может быть установлено как диагноз»

Реальность: 6A25 не является отдельной клинической единицей — это квалификатор основного расстройства (6A20–6A24).

Миф 2: «Дименсиональный подход заменяет категориальный диагноз»

Реальность: они взаимодополняемы — категориальный диагноз описывает нозологическую единицу, а размерный квалификатор — конкретную клиническую презентацию.

Миф 3: «Негативные симптомы — побочный эффект антипсихотиков, а не „истинные“»

Реальность: первичные негативные симптомы являются основной характеристикой шизофрении — наблюдаются и до приёма антипсихотиков. Вторичные негативные симптомы (седация, ЭПС, депрессия, влияние позитивных симптомов) отличаются и поддаются контролю.

7. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A25 Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG178. 2014/2019.
4. Crow T.J. Molecular pathology of schizophrenia: more than one disease process? Br Med J 1980;280(6207):66–68.
5. Liddle P.F. The symptoms of chronic schizophrenia. A re-examination of the positive-negative dichotomy. Br J Psychiatry 1987;151:145–151.
6. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. PANSS. Schizophr Bull 1987;13(2):261–276.
7. Wykes T. et al. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485.

6A40 КАТАТОНИЯ

Catatonia

	6A40 КАТАТОНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДРУГИМ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ **Catatonia associated with another mental disorder**
МКБ-11 **6A40**	
МКБ-10 F06.1	Органическое кататоническое состояние
DSM-5-TR F06.1	Кататония, связанная с другим психическим расстройством

1. Определение и нозология

Кататония (МКБ-11: 6A40 Catatonia Associated with Another Mental Disorder; 6A41 Кататония, вызванная веществами или лекарственными средствами; 6E69 Secondary Catatonia Syndrome; DSM-5-TR: F06.1 Catatonia) — синдром комплексного нарушения психомоторных, поведенческих и вегетативных функций. Не является самостоятельным расстройством — клинический синдром на фоне другого психиатрического или медицинского состояния.

В DSM-5-TR кататония уже не является подтипом шизофрении (подтип отменён); может кодироваться в контексте аффективных расстройств, нарушений нейроразвития, органических состояний и индуцированных веществом.

2. История

- Kahlbaum K. (1874) — «Die Katatonie oder das Spannungsirresein» — кататония как отдельный синдром.
- Kraepelin (1899) — кататония интегрирована как подтип «dementia praecox».

- Bleuler (1911) — сохранено в категории шизофрении.
- 1970–1980-е годы — Taylor, Fink — подтверждение широкой распространённости кататонии при аффективных расстройствах и пересмотр как общего синдрома.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — кататония формализована как транснозологический синдром; статус подтипа шизофрении отменён.

3. Эпидемиология

- Кататонические симптомы наблюдаются у 7–15% пациентов, поступающих в психиатрическую больницу (Fink M., Taylor M.A. Catatonia 2003).
- При аффективных расстройствах (особенно при биполярных маниакальных и депрессивных эпизодах) кататония встречается наиболее часто.
- У 10–20% пациентов с шизофренией в течение заболевания наблюдаются кататонические черты.
- Органическая кататония — в контексте аутоиммунного энцефалита (особенно anti-NMDA-R, anti-LGI1), электролитных нарушений, уремической и печёночной энцефалопатии, сепсиса, нейросифилиса, нервно-мышечных заболеваний.
- Нейролептический злокачественный синдром (NMS) — устойчивое клиническое перекрытие; некоторые исследователи считают их одним спектром.

4. Этиология и патогенез

- Гипофункция ГАМК-ергической системы — очень быстрый клинический эффект лоразепама (в течение часов) подтверждает это; центральный механизм — дисфункция GABA-A рецепторов.
- Дофаминовая дисрегуляция — в спектре нейролептик-индуцированной кататонии и NMS; отмена антипсихотиков вызывает холинергический и адренергический рикошет.
- Дисрегуляция глутамат-NMDA — аутоиммунный анти-NMDA-R энцефалит даёт классическую кататоническую картину.
- Генетика — предрасположенность, связанная с аффективными расстройствами.

5. Клиническая картина

DSM-5-TR критерии — как минимум 3 из 12 симптомов:

1. Ступор — отсутствие психомоторной активности, отсутствие реакции на окружающее.
2. Каталепсия — поддержание позы против пассивной индукции.
3. Восковая гибкость — поза, индуцированная экзаменатором, сохраняется как «восковая».
4. Мутизм — отсутствие или значительное снижение речи.
5. Негативизм — оппозиционность инструкциям или внешним стимулам.
6. Застывание в позе — непроизвольное поддержание спонтанной позы (против гравитации).
7. Манерность — гротескная карикатура на обычное поведение.
8. Стереотипия — нецеленаправленные повторяющиеся движения.
9. Ажитация — не зависящее от внешнего стимула возбуждение.
10. Гримасничанье — мимические выражения лица.
11. Эхолалия — повторение речи другого человека.
12. Эхопраксия — повторение действий другого человека.

Формы тяжести

- Заторможенная (ступорозная) кататония — двигательная заторможенность, мутизм доминируют; в большинстве случаев.
- Возбуждённая (маниакальная) кататония — высокая ажитация, вегетативные нарушения, гипертермия.
- Злокачественная кататония — возбуждённая форма с гипертермией, вегетативной нестабильностью, повышением КФК, риском летальности — совпадает с НМС; неотложное медицинское состояние.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

В DSM-5-TR ≥ 3 из 12 признаков; в МКБ-11 те же клинические признаки по разным категориям.

6.2 Диагностические тесты

- Провокационный тест с лоразепамом: 1–2 мг лоразепама в/в или в/м → значительное уменьшение кататонических признаков в течение 10–30 мин подтверждает диагноз (Bush G. et al. Acta Psychiatr Scand 1996).
- Bush-Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS) — 23-пунктовая стандартизированная шкала; первые 14 пунктов — скрининг (≥ 2 признака — положительный).

6.3 Этиологический поиск (обязательный)

1. Общий анализ крови, печень/почки, электролиты (Na, K, Ca, Mg, P), глюкоза, аммиак, КФК, тропонин, щитовидная железа, B12.
2. Токсикологический скрининг.
3. Сифилис, ВИЧ.
4. МРТ головного мозга.
5. ЭЭГ — исключение бессудорожного эпилептического статуса.
6. Люмбальная пункция — подозрение на энцефалит / аутоиммунный энцефалит (антитела к anti-NMDA-R, anti-LGI1).
7. ANA, волчаночная панель.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)	Анамнез применения антипсихотиков; гипертермия, ригидность, КФК очень высокий; клиническое совпадение — некоторые считают одним спектром.
Серотониновый синдром	Серотонинергический препарат; гиперрефлексия, миоклонус, гипертермия.
Non-convulsive status epilepticus	ЭЭГ — эпилептическая активность.
Акинетический мутизм (поражение лобной доли)	МРТ головного мозга — фронтальная или билатеральная таламическая патология.
Локомоторные расстройства (болезнь Паркинсона, дистония)	Специфические неврологические знаки.

Состояние	Отличительные признаки
Аутоиммунный энцефалит	Анти-NMDA-R, анти-LGI1; находки CSF, МРТ, ЭЭГ атипичны.
Гипо-/гипертиреоидный криз	TSH, T4.

7. Обследование и оценка

- BFCRS — исходные показатели и мониторинг.
- Перечисленные выше лабораторные и инструментальные исследования — этиологический поиск.
- Вегетативная функция (артериальное давление, пульс, температура, диурез) — особенно при злокачественной форме.
- Оценка коморбидного аффективного расстройства и психотических симптомов (после того, как пациент сможет говорить).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (BAP 2023 · протокол Fink-Taylor)

1. ПРЕКРАТИТЬ антипсихотики — особенно типичные и высокие антагонисты D2 (галоперидол, рисперидон в высоких дозах) — могут усиливать кататонию, переводить в злокачественную форму.
2. Лоразепам первой линии — 1–2 мг IM/IV, титрация на основе начального ответа; типичная эффективная доза 6–24 мг/день; некоторым пациентам требуется 30+ мг. ~70–80% пациентов отвечают (Sienaert P. et al. Front Psychiatry 2014 обзор).
3. ЭСТ — рефрактерные случаи (отсутствие ответа на лоразепам в течение 48–72 часов), злокачественная кататония — первая линия, жизнеспасающее средство. NICE TA59 — настоятельная рекомендация при кататонии.
4. Этиологическое лечение — параллельно: если на фоне аффективного расстройства — стабилизатор настроения (литий); в контексте шизофрении — атипичный антипсихотик (клозапин или кветиапин с меньшим риском) с осторожностью вместе с лоразепамом.
5. При аутоиммунной кататонии — иммунотерапия (в/в стероиды, ВВИГ, плазмаферез, вторая линия — ритуксимаб).
6. Поддерживающая терапия — гидратация, нутриция (при необходимости НГ-зонд), профилактика ТГВ, уход за кожей, профилактика аспирационной пневмонии.

7. При злокачественной кататонии — ОИТ; интенсивная гидратация, дантролен, бромокриптин, ЭСТ.

8.2 Методики лечения

1. Шкала кататонии Буш-Фрэнсис (англ. Bush-Francis Catatonia Rating Scale, BFCRS) — 23-пунктовая шкала; первые 14 пунктов — скрининг (≥ 2 положительных); 23 пункта — тяжесть. Bush G. et al. Acta Psychiatr Scand 1996.
2. Провокационный тест с лоразепамом — уменьшение кататонических признаков через 10–30 минут после введения 1–2 мг IM/IV лоразепама подтверждает диагноз и направляет план терапии. Bush G. et al. 1996.
3. Электросудорожная терапия (ЭСТ — Electroconvulsive Therapy) — Золотой стандарт при кататонии; доказательная база UK ECT Review Group Lancet 2003; NICE TA59. Обычно 6–12 сеансов, билатеральная цель.
4. Иммунотерапия (при аутоиммунной кататонии) — в/в метилпреднизолон 1 г/сут × 5 дней → ВВИГ и/или плазмаферез; при рефрактерных случаях ритуксимаб, циклофосфамид. Протокол аутоиммунного энцефалита Graus F. et al. Lancet Neurol 2016.

8.3 Различия между источниками

- BAP 2023 (англ. British Association for Psychopharmacology) Catatonia Consensus Guidelines — лоразепам первой линии; ЭСТ при рефрактерных или злокачественных случаях; избегать или с осторожностью применять антипсихотики.
- Fink M., Taylor M.A. Catatonia: A Clinician’s Guide (2003) — классический протокол; тест с лоразепамом и терапия высокими дозами лоразепама.
- NICE TA59 — ЭСТ — четкая рекомендация при кататонии.

9. Прогноз

- Ответ на лоразепам и/или ЭСТ — полное восстановление в течение дней-недель у большинства пациентов.
- Высокий риск рецидива при отсутствии лечения этиологического нарушения.
- Осложнения — аспирационная пневмония при длительном ступоре, ТГВ, дегидратация, кожные язвы.

- Злокачественная кататония — летальность без лечения исторически ~50%+ (в некоторых сериях 75–100%); при современном лечении (бензодиазепины/ЭСТ) снижается до ~10–20%.
- Наблюдение — в контексте этиологического расстройства; распознавание маркеров рецидива.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Кататония — это подтип шизофрении»

Доказательства: DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — кататония как транснозологический синдром; статус подтипа шизофрении отменён. Чаще встречается в контексте аффективных расстройств (Fink & Taylor 2003).

Миф 2: «Кататонического пациента нужно лечить антипсихотиками»

Доказательства: антипсихотики могут усиливать кататонию и переводить её в злокачественную форму. Первая линия — лоразепам, затем ЭСТ. Антипсихотик, если необходим для этиологического расстройства, с осторожностью вместе с лоразепамом; предпочтительнее атипичный (клозапин или кветиапин).

Миф 3: «Кататонический пациент потерял сознание или находится в коме»

Доказательства: Большинство кататонических пациентов полностью осознают происходящее вокруг — мутизм и психомоторные нарушения не являются потерей сознания. Пациент помнит всё после эпизода. Разговоры персонала рядом с пациентом должны быть осторожными.

Миф 4: «Кататония — редкое или историческое состояние, в современной психиатрии её нет»

Доказательства: кататонические симптомы наблюдаются у 7–15% пациентов, поступающих в психиатрическую больницу (Fink & Taylor 2003); диагностика ограничена — это недораспознанный синдром.

Миф 5: «Лоразепам только успокаивает, не даёт „настоящего“ лечения»

Доказательства: Лоразепам воздействует на ключевой механизм кататонического синдрома (ГАМК-ергическую гипофункцию); ~70–80% пациентов демонстрируют быстрое и выраженное клиническое улучшение.

Миф 6: «ЭСТ при кататонии опасна и устарела»

Доказательства: ЭСТ — золотой стандарт при кататонии, NICE TA59 даёт четкую рекомендацию; при злокачественной кататонии спасает жизнь.

Миф 7: «Пациента нужно заставить говорить — сломать психологический барьер»

Доказательства: мутизм имеет биологическое происхождение, а не психологическое «сопротивление»; требование усиливает дистресс пациента и не приносит терапевтической пользы.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A40 Catatonia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Rogers J.P., Pollak T.A., Begum N. et al. Catatonia: demographic, clinical and laboratory associations. Psychol Med 2023 (англ. BAP Guidelines).
4. Fink M., Taylor M.A. Catatonia: A Clinician’s Guide to Diagnosis and Treatment. Cambridge Univ Press; 2003.
5. Bush G., Fink M., Petrides G. et al. Catatonia. I. Rating scale and standardized examination. Acta Psychiatr Scand 1996;93(2):129–136.
6. Sienaert P., Dhossche D.M., Vancampfort D. et al. A clinical review of the treatment of catatonia. Front Psychiatry 2014;5:181.
7. Graus F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
8. NICE TA59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).
9. UK ECT Review Group. Lancet 2003;361(9360):799–808.

6A60–6A7Z РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ

Mood disorders

МКБ-11 **6A60**	**6A60 БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО I ТИПА** **Bipolar type I disorder**
МКБ-10 F31	Биполярное аффективное расстройство
DSM-5-TR F31.1x	Биполярное расстройство I типа, текущий или последний эпизод маниакальный

1. Определение и нозология

Биполярное расстройство I типа (МКБ-11: 6A60; DSM-5-TR: F31.1x) — рецидивирующее расстройство, характеризующееся по крайней мере одним маниакальным эпизодом, часто чередующееся с депрессивными и/или гипоманиакальными эпизодами. Наличие одного маниакального эпизода достаточно для диагноза — депрессивный эпизод не требуется.

2. История

- Falret J.P. (1854) — «folie circulaire»; Baillarger J. (1854) — «folie à double forme».
- Kraepelin E. (1899) — «manic-depressive insanity» — отдельная единица от шизофрении (dementia praecox).
- Leonhard K. (1957) — впервые разделил униполярные и биполярные расстройства.
- DSM-III (1980) — Термин «Биполярное расстройство».
- DSM-IV / DSM-5 (2013) / МКБ-11 (2019) — разделение на тип I (полный маниакальный эпизод) и тип II (гипоманиакальный + большая депрессия).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость типа I: ~0,6–1% (Merikangas K.R. et al. Arch Gen Psychiatry 2011, WMH).
- Пол: примерно одинаково.
- Начало: в среднем 20–25 лет; раньше при семейном анамнезе.
- Суицидальный риск: пожизненный 6–7%; самый высокий в молодом возрасте и в первые годы.
- Коморбидность: тревожные расстройства 60%, употребление ПАВ 40%, СДВГ, расстройства личности.
- Смертность в 2 раза выше по сравнению с популяцией — сердечно-сосудистая, суицид.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 60–85% (Smoller J.W., Finn C.T. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003 близнецовый мета-анализ).
- GWAS — 60+ локусов риска (Mullins N. et al. Nat Genet 2021).
- Широкое генетическое перекрытие с шизофренией (англ. Cross-Disorder Group 2013).
- Нейробиологически — моноаминергическая (дофамин, серотонин, норадреналин) дисрегуляция; нарушение циркадианного ритма; нарушение во вторичной мессенджерной системе (PI/cAMP); митохондриальная дисфункция.
- Факторы риска — детская травма, стресс, нарушение сна, каннабис, индукция антидепрессантами (при предрасположенности к биполярному расстройству).

5. Клиническая картина

5.1 Маниакальный эпизод

- Аномально повышенное или раздражительное настроение + повышенная энергия ≥ 7 дней (или любой продолжительности, если требуется госпитализация).
- ≥ 3 симптомов (при раздражительном настроении ≥ 4): завышенная самооценка, снижение потребности во сне, чрезмерная разговорчивость, скачка идей, отвлекаемость, повышение целенаправленной активности, рискованное поведение.

- Функциональное нарушение или требование госпитализации, или психотические особенности.

5.2 Большой депрессивный эпизод (в контексте биполярного расстройства)

- Сниженное настроение или ангедония + ≥ 5 симптомов × 2 недели (DSM-5-TR).
- Биполярный депрессивный эпизод с атипичными особенностями (гиперсомния, гиперфагия, свинцовый паралич) встречается чаще — сходен с II типом.

5.3 Смешанные признаки (mixed features)

В DSM-5-TR подтип упразднён — как квалификатор: ≥ 3 депрессивных симптомов во время маниакального эпизода или ≥ 3 маниакальных симптомов во время депрессивного эпизода.

5.4 Быстрая цикличность (rapid cycling)

≥ 4 эпизодов в течение 12 месяцев; маркер плохого прогноза.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. Как минимум один маниакальный эпизод (вышеуказанные критерии).

B. Маниакальные и депрессивные эпизоды не объясняются лучше шизоаффективным, шизофреническим или другим психотическим расстройством.

Депрессивные и гипоманиакальные эпизоды не обязательны для диагноза I типа, но типично присутствуют.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: квалификатор mixed features (смешанный эпизод в DSM-IV отменён); повышение энергии добавлено в критерий маниакального эпизода (в DSM-IV — только настроение).
- МКБ-11 (6A60): Подквалификаторы по количеству маниакальных эпизодов и типу текущего эпизода; быстрая цикличность как квалификатор.

- NICE CG185: диагноз подтверждается структурированным интервью и информацией от семьи; гипоманиакальный/маниакальный эпизод, спровоцированный антидепрессантом, ведёт к диагнозу биполярного расстройства (с квалификатором критерия B в DSM-5-TR).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от родственника/друга — маниакальные и гипоманиакальные эпизоды легче распознаются членами семьи.
2. Структурированное интервью (SCID-5, MINI).
3. YMRS (англ. Young Mania Rating Scale), HAM-D / MADRS.
4. MDQ (англ. Mood Disorder Questionnaire) или HCL-32 — биполярный скрининг (самооценка).
5. Медицинское обследование + лабораторные (щитовидная железа, печень, почки, глюкоза, токсикология); специфические тесты перед началом приёма лития.
6. МРТ головного мозга — первый эпизод психоза или атипичный контекст.
7. Коморбидность и риск суицида (C-SSRS).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Биполярное расстройство II типа (6A61)	Маниакального эпизода никогда не было; гипоманиакальный + большой депрессивный.
Циклотимическое расстройство (6A62)	≥ 2 лет (1 год для подростков) субпороговые аффективные колебания.
Большое депрессивное расстройство (6A70/6A71)	Отсутствие маниакального или гипоманиакального эпизода.
Шизоаффективное (6A21)	В периоды вне аффективного эпизода психоз сохраняется.
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность — часы-дни; нарушение идентичности.
СДВГ (6A05)	Стойкие модели поведения, не эпизодические.

Состояние	Отличительные признаки
Гипертиреоз	Снижение ТТГ; тремор, потеря веса, тахикардия.
Вещество-индуцированное (стимулятор, кокаин)	Анамнез употребления веществ и временная связь.

7. Обследование и оценка

- YMRS, HAM-D / MADRS, MDQ, HCL-32, C-SSRS.
- Перед литием: общий анализ крови, креатинин, ТТГ, кальций, ЭКГ, тест на беременность.
- Перед вальпроатом: общий анализ крови, функция печени, тест на беременность (у женщин детородного возраста — строго не рекомендовать).
- Перед карбамазепином: общий анализ крови, печень, натрий.
- МРТ головного мозга — первый психотический эпизод.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG185 · CANMAT/ISBD 2018 · APA · консенсус WFSBP)

1. Острый маниакальный эпизод: антипсихотик (оланзапин, рисперидон, кветиапин, арипипразол, азенапин) ± нормотимик (литий, вальпроат). При острой ажитации адъюнкт лоразепам.
2. Острый биполярный депрессивный эпизод: Кветиапин или луразидон (одобрение FDA), комбинация оланзапин/флуоксетин (Symbyax); литий или ламотриджин адъюнктивно. Использование одного антидепрессанта — монотерапия — риск маниакального переключения и быстрой цикличности.
3. Поддерживающая терапия (maintenance): Литий первой линии — эффект снижения суицидального риска (Cipriani A. BMJ 2013); вальпроат, кветиапин, ламотриджин (особенно при доминировании депрессивного компонента), оланзапин как альтернативы.
4. Рефрактерные случаи: клозапин; ЭСТ.
5. Быстрая цикличность: отменить антидепрессант; комбинация лития и вальпроата.

6. Психосоциальное вмешательство: психообразование, КПТ для биполярного расстройства, IPSRT (англ. Interpersonal and Social Rhythm Therapy — Frank E.), семейно-фокусированная терапия (Miklowitz D.).
7. Приверженность и мониторинг побочных эффектов — для лития: ТТГ, креатинин, кальций каждые 6 месяцев; для вальпроата: печёночные и гематологические показатели.
8. Женщины детородного возраста: вальпроат строго запрещён (дефект нервной трубки 1–2%, крупные врождённые пороки в целом ~10%, аутизм и дефицит IQ); ламотриджин и кветиапин относительно безопасны.

8.2 Фармакотерапия (таблица)

Класс	Препарат	Показание
Литий	Терапевтический уровень 0,6–1,0 мЭкв/л; при осложнениях 0,8–1,2	Мания, депрессия, поддержание; снижает суицидальность.
Антиконвульсант	Вальпроат (1000–2000 мг), карбамазепин (400–1200 мг), ламотриджин (титр до 200 мг)	Маниакальный (вальпроат, карбамазепин), депрессивная поддерживающая терапия (ламотриджин).
Атипичный антипсихотик	Оланзапин, рисперидон, кветиапин, арипипразол, азенапин, луразидон, карипразин	Мания, смешанное состояние, поддержание; кветиапин и луразидон — одобрение FDA для биполярной депрессии.
Антидепрессант	Только в сочетании со стабилизатором настроения	С осторожностью при биполярном депрессивном эпизоде; в монотерапии противопоказан.

8.3 Уточнения, специфичные для источника

- CANMAT/ISBD 2018 (Yatham L.N. et al. Bipolar Disord 2018): первая линия для мании — литий, вальпроат, кветиапин, арипипразол,

азенапин, палиперидон, рисперидон; для биполярной депрессии — кветиапин, луразидон (монотерапия или адъюнкт с литием/вальпроатом).

- NICE CG185: Литий первой линии в поддерживающей терапии; антидепрессант только со стабилизатором настроения.
- Cipriani A. et al. BMJ 2013, мета-анализ: Литий значительно снижает суицидальный риск (превосходит другие стабилизаторы настроения).
- Предупреждения EMA и FDA: вальпроат у женщин детородного возраста — дефект нервной трубки, аутизм, снижение IQ.

8.4 Методики лечения

1. Литий — Золотой стандарт при биполярном расстройстве; снижает суицидальность; исходные показатели: креатинин, ТТГ, кальций, ЭКГ; терапевтический уровень 0,6–1,0 мЭкв/л; токсичность > 1,5 мЭкв/л. Cipriani BMJ 2013.
2. Адаптированная для биполярного расстройства КПТ — Психообразование, распознавание ранних маркеров, поведенческая активация, поддержка комплаенса. Lam D.H. et al. Arch Gen Psychiatry 2003 РКИ.
3. Интерперсональная и социальная ритм-терапия (англ. Interpersonal and Social Rhythm Therapy, IPSRT) — Франк (Frank E.) — Управление циркадным ритмом и межличностным стрессом при биполярном расстройстве. Frank E. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 РКИ — снижение рецидивов в фазе поддержания.
4. Семейно-фокусированная терапия (англ. Family-Focused Therapy, FFT) — Микловиц (Miklowitz D.) — Пациент + семья совместно; психообразование, коммуникация, решение проблем. Miklowitz D.J. et al. Arch Gen Psychiatry 2003;60(9):904–912.
5. Шкала оценки мании Янга (англ. Young Mania Rating Scale, YMRS) — 11 пунктов маниакальной тяжести; первичные показатели и мониторинг.
6. Опросник расстройств настроения (англ. Mood Disorder Questionnaire, MDQ) — Хиршфельд (Hirschfeld R.M.) — 13-пунктовый скрининг биполярного расстройства (самооценка).
7. ЭСТ — При рефрактерном маниакальном или депрессивном эпизоде, смешанных чертах, суицидальном риске, безопасная альтернатива при беременности. NICE TA59.

9. Прогноз

- Эпизодическое течение; рецидив 80–90% (без лечения); значительное снижение при поддерживающей фармакотерапии.
- Суицидальный риск высок (6–7% пожизненный); особенно в первые годы.
- Повышенная сердечно-сосудистая смертность (метаболический синдром).
- Функциональное восстановление среднее — большинство пациентов испытывают значительные социальные и профессиональные нарушения.
- Наблюдение — шкалы настроения, суицидальный риск, метаболические показатели, уровень лития, комплаентность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Биполярное расстройство — это просто перепады настроения, они есть у каждого»

Клиническая логика: биполярный маниакальный эпизод требует как длительности (≥ 7 дней), так и функционального нарушения; это клиническое состояние, отличное от ежедневных колебаний настроения. Маниакальный эпизод может включать психотические черты и госпитализацию. Доказательства: Merikangas Arch Gen Psychiatry 2011.

Миф 2: «Плохое воспитание вызывает биполярное расстройство»

Доказательства: наследуемость 60–85%; родительский опыт не является этиологией. Smoller & Finn 2003.

Миф 3: «Биполярный пациент креативен и/или является „маркером гениальности“»

Доказательства: в некоторых исследованиях распространённость биполярного расстройства в творческих профессиях несколько повышена (обзоры Andreasen N.C.), но большинство пациентов испытывают функциональные нарушения; объяснение «одаренностью» ведёт к романтизации и отказу от лечения.

Миф 4: «Антидепрессанты всегда помогают пациенту с биполярным расстройством»

Доказательства: NICE CG185, CANMAT — антидепрессант в монотерапии при биполярном расстройстве противопоказан; риск маниакального переключения и быстрой цикличности.

Миф 5: «Литий „устарел“ или опасен — атипичный антипсихотик должен быть первой линией»

Доказательства: Cipriani BMJ 2013 — литий достоверно снижает суициды больше, чем другие стабилизаторы настроения; NICE CG185 и CANMAT 2018 — первая линия в поддерживающей терапии.

Миф 6: «Пациент может „волевым усилием“ контролировать своё настроение»

Доказательства: биполярный эпизод — нейробиологическое расстройство; не поддаётся волевому контролю; требует фармакотерапии или ЭСТ.

Миф 7: «Достаточно безучастного наблюдения — пройдёт само»

Доказательства: нелечёные эпизоды — длительное функциональное нарушение, сердечно-сосудистая смертность, суицид (6–7% пожизненно).

Миф 8: «Растительные препараты (зверобой, валериана) или омега-3 заменяют нормотимик»

Доказательства: Зверобой продырявленный снижает уровень нормотимиков за счёт индукции цитохрома P450 и может вызвать маниакальное переключение; омега-3 — умеренный адъюнктивный эффект, не основное лечение.

Миф 9: «Каннабис — нормотимик»

Доказательства: каннабис ухудшает течение биполярного расстройства, повышает риск психоза, снижает комплаентность.

Миф 10: «Нормотимик при беременности должен быть полностью отменён»

Доказательства: полное прекращение увеличивает риск рецидива в 2 раза, долю недель болезни — в 5 раз, а время до рецидива сокращает более чем в 4 раза (Viguera A.C. et al. Am J Psychiatry 2007). Вальпроат категорически запрещён, но ламотриджин и кветиапин относительно безопасны; оценивается индивидуальный баланс (NICE CG192).

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A60 Bipolar type I disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. Bipolar disorder: assessment and management. 2014/2020.
4. Yatham L.N., Kennedy S.H., Parikh S.V. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Cipriani A., Hawton K., Stockton S., Geddes J.R. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646.
6. Merikangas K.R., Jin R., He J.P. et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241–251.
7. Smoller J.W., Finn C.T. Family, twin, and adoption studies of bipolar disorder. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003;123C(1):48–58.
8. Mullins N. et al. Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases. Nat Genet 2021;53(6):817–829.
9. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.
10. Miklowitz D.J., George E.L., Richards J.A. et al. A randomized study of family-focused psychoeducation in bipolar disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60(9):904–912.
11. Viguera A.C., Whitfield T., Baldessarini R.J. et al. Risk of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry 2007;164(12):1817–1824.
12. Hirschfeld R.M., Williams J.B., Spitzer R.L. et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry 2000;157(11):1873–1875.
13. Andreasen N.C. Creativity and mental illness: prevalence rates in writers and their first-degree relatives. Am J Psychiatry 1987;144(10):1288–1292.

МКБ-11 **6A61**	**6A61 БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО II ТИПА** **Bipolar type II disorder**
МКБ-10 F31	Биполярное аффективное расстройство
DSM-5-TR F31.81	Биполярное расстройство II типа

1. Определение и нозология

Биполярное расстройство II типа (МКБ-11: 6A61; DSM-5-TR: F31.81) — форма биполярного расстройства, характеризующаяся по крайней мере одним гипоманиакальным эпизодом и как минимум одним большим депрессивным эпизодом при отсутствии в анамнезе полного маниакального эпизода. Не «лёгкая» форма по сравнению с типом I — пациенты проводят больше времени в депрессии; функциональное нарушение и риск суицида сопоставимы с типом I.

2. История

- Dunner D.L., Gershon E.S., Goodwin F.K. (1976) — предложение различать подтипы биполярного расстройства.
- DSM-IV (1994) — Официальное признание биполярного расстройства II типа как отдельной диагностической категории.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — акцент на сохранении типа II, против ошибочной концепции «лёгкой формы».

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: ~0,4–1,1% (Merikangas K.R. Arch Gen Psychiatry 2011 WMH).
- Пол: относительно выше у женщин (~1,5:1 — в отличие от I типа).
- Начало: в среднем 20–25 лет, множественные депрессивные эпизоды обычно предшествуют гипоманиакальному эпизоду.
- Суицидальный риск по сравнению с типом I (пожизненный ~5–7%); больше из-за времени, проведённого в депрессии.

- Коморбидность: тревога 60%+, употребление ПАВ 30–40%, пограничное расстройство личности.

4. Этиология и патогенез

- Генетическая основа совпадает с типом I — наследуемость 60–80%; локусы GWAS параллельны.
- Независимая генетическая единица клинического фенотипа биполярного расстройства I типа является спорной — в некоторых исследованиях оба типа оцениваются как один спектр.
- Нарушение циркадного ритма и семейный анамнез.

5. Клиническая картина

5.1 Гипоманиакальный эпизод

- Аномально повышенное или раздражительное настроение + повышенная энергия ≥ 4 дней (при I типе ≥ 7).
- Те же субсимптомы, что и при маниакальном эпизоде (снижение потребности во сне, отвлекаемость, повышение целенаправленной активности и т.д.); ≥ 3 симптомов (при раздражительном настроении ≥ 4).
- Функциональное нарушение не должно быть значительным (то есть определение гипомании); не должно быть психотических особенностей; не должна требоваться госпитализация. При соблюдении этих критериев — диагноз меняется на тип I.

5.2 Большой депрессивный эпизод

- ≥ 5 симптомов в течение 2 недель (включая сниженное настроение и/или ангедонию).
- Депрессивные эпизоды при биполярном расстройстве II типа часто протекают с атипичными особенностями — гиперсомния, гиперфагия, свинцовый паралич, чувствительность к отвержению.
- Пациенты симптоматичны в 53,9% недель наблюдения; депрессивные симптомы занимают 50,3% недель (гипоманиакальные 1,3%, циклические/смешанные 2,3%) — Judd L.L. et al. Arch Gen Psychiatry 2003, n=86, в среднем 13,4 года наблюдения; большинство симптомов субсиндромального уровня.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Как минимум один гипоманиакальный эпизод.

B. Как минимум один большой депрессивный эпизод.

C. Маниакального эпизода никогда не было.

D. Гипоманиакальные и депрессивные эпизоды не объясняются лучше шизоаффективным, шизофреническим или другим психотическим расстройством.

E. Симптомы вызывают значительный дистресс или функциональное нарушение (преимущественно от депрессивного эпизода).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11: при гипоманиакальном эпизоде функциональное нарушение не должно быть значительным; гипоманиакальный эпизод, индуцированный антидепрессантами, ведёт к диагнозу биполярного расстройства II типа (особенно в случаях продолжающихся или рецидивирующих).
- Проблема гиподиагностики: Обзоры Hirschfeld R.M. — ~25–50% пациентов, обращающихся с депрессивным эпизодом, на самом деле имеют биполярное расстройство II типа, но гипоманиакальные эпизоды воспринимаются семьёй как «хорошие периоды».

6.3 Алгоритм диагностики

1. У каждого депрессивного пациента структурированный опрос на гипоманиакальные эпизоды (SCID-5 mood module, MDQ, HCL-32).
2. Информация от членов семьи — важно наблюдение за гипоманиакальными периодами.
3. Клиническое интервью + YMRS, HAM-D / MADRS.
4. Лабораторно: щитовидная железа, печень, почки, токсикология, тест на беременность.
5. Оценка коморбидности и риска суицида.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Биполярное расстройство I типа (6A60)	≥ 1 маниакальный эпизод (функциональное нарушение или необходимость госпитализации).
Большое депрессивное расстройство (6A70/6A71)	Гипоманиакальный эпизод отсутствует.
Циклотимия (6A62)	Отсутствие полных больших депрессивных или гипоманиакальных эпизодов.
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность — часы; нарушение идентичности; хронические суицидальные мысли.
СДВГ	Стойкий; не эпизодический.
Гипертиреоз	Измерение ТТГ.

7. Обследование и оценка

- SCID-5 mood module — золотой стандарт.
- MDQ (англ. Mood Disorder Questionnaire) и HCL-32 (англ. Hypomania Checklist) — скрининг.
- YMRS, HAM-D / MADRS, C-SSRS.
- Перед литием: креатинин, ТТГ, кальций, ЭКГ.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG185 · CANMAT/ISBD 2018)

1. Биполярное расстройство II типа, депрессивный эпизод (наиболее частая презентация):
    - Первая линия — кветиапин (одобрение FDA) или его комбинация с литием. Показание FDA у луразидона — только биполярная депрессия I типа, не II; CANMAT/ISBD 2018 тоже называет первой линией при депрессивном эпизоде II типа один кветиапин.
    - Ламотриджин — первая линия в поддерживающей терапии и профилактике депрессии (особенно эффективен при типе II).

- Литий — поддержание и снижение суицидального риска.

2. Гипоманиакальный эпизод: отменить антидепрессант; нормотимик (литий, вальпроат) или атипичный антипсихотик.
3. Применение антидепрессантов: при биполярном расстройстве II типа считалось относительно безопасным, но последние рекомендации (CANMAT 2018) — только в сочетании с нормотимиком (для снижения риска маниакального переключения и быстрой цикличности).
4. Поддерживающая терапия (maintenance): Ламотриджин (при доминировании депрессивного компонента) или кветиапин; литий для снижения суицидального риска.
5. Психосоциальное вмешательство: КПТ, IPSRT, семейно-фокусированная терапия, психообразование.
6. Рефрактерные случаи: клозапин, ЭСТ.
7. Беременность: вальпроат строго запрещён; ламотриджин и кветиапин относительно безопасны.

8.2 Методики лечения

1. Ламотриджин — Эффективен при поддерживающей терапии биполярного расстройства II типа и профилактике депрессивных эпизодов; медленная титрация (риск синдрома Стивенса-Джонсона) — начальная доза 25 мг, увеличение через 2 недели; целевая доза 200 мг/сут. Calabrese J.R. et al. J Clin Psychiatry 2003.
2. Кветиапин — Одобрение FDA для биполярного депрессивного эпизода; 300–600 мг/сут; мониторинг метаболических побочных эффектов.
3. Интерперсональная и социальная ритм-терапия (IPSRT) — Франк (Frank E.); и КПТ для биполярного расстройства — Циркадный ритм, комплаенс, профилактика рецидивов.
4. Контрольный список гипомании (HCL-32 — Hypomania Checklist) — Angst (Angst J.) — самооценочный скрининг гипоманиакального эпизода из 32 пунктов.
5. Опросник расстройств настроения (англ. Mood Disorder Questionnaire, MDQ) — 13 вопросов; скрининг биполярного расстройства.

8.3 Различия между источниками

- CANMAT/ISBD 2018: Депрессивный эпизод при типе II — первая линия: кветиапин; ламотриджин для поддерживающей терапии.
- NICE CG185: Типы I и II — одинаковый основной подход, но при типе II подчеркивается особая роль ламотриджина.

- Calabrese J.R. РКИ — эффект ламотриджина при поддерживающей терапии биполярного расстройства II типа.

9. Прогноз

- Эпизодическое течение; рецидив значительно снижается при поддерживающей фармакотерапии.
- Тип II — не «легче» типа I: высокая функциональная нарушенность и депрессивная нагрузка.
- Суицидальный риск высокий.
- Кветиапин и ламотриджин — основа поддерживающей терапии.
- Наблюдение — депрессивные симптомы, гипоманиакальные триггеры, метаболические показатели.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Биполярное расстройство II типа — это „лёгкая форма“, мало нуждающаяся в лечении»

Доказательства: Judd L.L. Arch Gen Psychiatry 2003 — пациенты типа II проводят 50,3% недель наблюдения с депрессивными симптомами (общее симптоматическое время 53,9%); функциональное нарушение и риск суицида сопоставимы с типом I.

Миф 2: «Гипоманиакальный эпизод — это „хороший период“, лечения не требует»

Доказательства: гипоманиакальный эпизод может быть триггером рискованного поведения, нарушения отношений, последующего снижения продуктивности и депрессивного эпизода; отдельные эпизоды указывают на необходимость поддерживающей фармакотерапии.

Миф 3: «У пациента II типа антидепрессант можно использовать отдельно»

Доказательства: CANMAT 2018 — антидепрессант только с нормотимиком; риск маниакального переключения и быстрой цикличности.

Миф 4: «Биполярное расстройство II типа — это лишь форма пограничного расстройства личности»

Доказательства: Существует значительное совпадение и коморбидность, но это отдельные расстройства; биполярное II типа — эпизодическое, ПРЛ — устойчивая модель.

Миф 5: «Ламотриджин излечивает маниакальный эпизод»

Доказательства: Ламотриджин эффективен при депрессивном компоненте и в поддерживающей терапии; неэффективен при маниакальном эпизоде — требуется антипсихотик или вальпроат.

Миф 6: «Зверобой продырявленный (St John's Wort) безопасен при биполярном расстройстве, так как это натуральный антидепрессант»

Доказательства: Зверобой продырявленный может вызвать маниакальное переключение и снижает уровень нормотимиков (индукция CYP); противопоказан при биполярном расстройстве.

Миф 7: «При II типе ЭСТ не нужна»

Доказательства: при рефрактерном депрессивном эпизоде или высоком суицидальном риске показана ЭСТ; эффективна и у пациентов II типа.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A61 Bipolar type II disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. 2014/2020.
4. Yatham L.N. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Judd L.L., Akiskal H.S., Schettler P.J. et al. A prospective investigation of the natural history of the long-term weekly symptomatic status of bipolar II disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60(3):261–269.
6. Calabrese J.R. et al. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(9):1013–1024.
7. Cipriani A. et al. BMJ 2013;346:f3646.
8. Merikangas K.R. et al. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241–251.
9. Angst J. et al. The HCL-32: towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms. J Affect Disord 2005;88(2):217–233.

10. Hirschfeld R.M., Williams J.B., Spitzer R.L. et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry 2000;157(11):1873–1875.
11. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.

МКБ-11 **6A62**	**6A62 ЦИКЛОТИМИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Cyclothymic disorder**
МКБ-10 F34.0	Циклотимия
DSM-5-TR F34.0	Циклотимическое расстройство

1. Определение и нозология

Циклотимическое расстройство (МКБ-11: 6A62; DSM-5-TR: F34.0 Циклотимическое расстройство) — хроническое аффективное расстройство, характеризующееся постоянной сменой субсиндромальных гипоманиакальных и депрессивных симптомов в течение не менее 2 лет (у взрослых; у детей/подростков — 1 год). Не достигает полных большого депрессивного, маниакального или гипоманиакального эпизодов.

2. История

- Kahlbaum K. (1882) — Термин «циклотимия».
- Kraepelin (1899) — лёгкая форма маниакально-депрессивного расстройства.
- Akiskal H.S. (1977) — переопределение циклотимического темперамента как подстадии биполярного спектра.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013), МКБ-11 (2019) — в категории аффективных расстройств.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 0,4–1% (DSM-5-TR; широкий диапазон, точные эпидемиологические данные ограничены).
- Пол: примерно одинаково.
- Начало: подростковый возраст и ранняя взрослость.
- Конверсия в биполярное расстройство типа I или II: ~15–50% (обзоры Akiskal H.S.).
- Коморбидность: тревога, употребление ПАВ, СДВГ, пограничное расстройство личности.

4. Этиология и патогенез

- Общая генетическая нагрузка с биполярным спектром (Akiskal).
- Повышенная плотность биполярного и большого депрессивного расстройства в семейном анамнезе.
- Нейробиологически — моноаминергическая и циркадианная дисрегуляция, как при биполярном расстройстве, но менее выраженная.

5. Клиническая картина

- Множественные субпороговые гипоманиакальные эпизоды — кратковременные подъемы энергии и настроения низкой интенсивности.
- Множественные субпороговые депрессивные эпизоды — симптомы низкой интенсивности.
- «Стабильный период» менее 2 месяцев.
- Колебания настроения в течение дней или недель; пациент может объяснять это как «такова моя натура»
- Межличностное и профессиональное нарушение умеренное, но не разрушительное.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11)

A. Множественные гипоманиакальные и депрессивные субпороговые периоды в течение как минимум 2 лет (взрослые) / 1 года (дети/подростки).

B. В течение этого периода симптомы присутствуют ≥ половины времени, а бессимптомный период не превышает 2 месяцев.

C. Критерии полного большого депрессивного, маниакального или гипоманиакального эпизода никогда не выполнялись.

D. Не объясняется лучше шизоаффективным, шизофренией или другим психотическим расстройством.

E. Исключение вещества или медицинского состояния

F. Значительный дистресс или функциональные нарушения

6.2 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (рекомендуется дневник настроения на 4–6 недель — документирование собственных паттернов пациента).
2. SCID-5, MDQ, HCL-32.
3. Оценка коморбидности и семейного анамнеза.
4. Медицинское и лабораторное (тиреоид обязательно).

6.3 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Биполярное расстройство II типа (6A61)	Полные гипоманиакальные и большие депрессивные эпизоды.
Дистимическое расстройство (6A72)	Только субпороговая депрессия; гипоманиакальные периоды отсутствуют.
ПРЛ (6D10.x)	Почасовые колебания настроения; нарушение идентичности; импульсивность и отношения.
СДВГ (6A05)	Не эпизодическое; доминирует дефицит внимания.
Циклотимический темперамент (вариант нормы)	Функциональное нарушение отсутствует.

7. Обследование и оценка

- Дневник настроения.
- MDQ, HCL-32, YMRS, HAM-D.
- Функция щитовидной железы.

8. Лечение

1. Психотерапия первой линии — КПТ, IPSRT, психообразование, поведенческая активация, управление циркадным ритмом.
2. Фармакотерапия — доказательная база ограничена:
    - Литий или вальпроат — считается адекватным в контексте биполярного спектра.
    - Ламотриджин — при доминировании депрессивного компонента.
    - Атипичный антипсихотик (кветиапин) — при среднетяжёлых случаях.
3. Антидепрессант в монотерапии — риск маниакального переключения и быстрой цикличности; противопоказан.
4. Управление стрессом и поддержание социально-циркадного ритма — важно.
5. Мониторинг конверсии в биполярное расстройство — более частое наблюдение при наличии семейного анамнеза и клинических маркеров.

8.1 Методики лечения

1. Интерперсональная и социальная ритм-терапия (IPSRT) — Франк (Frank E.) — Управление циркадным ритмом и межличностным стрессом.
2. КПТ при биполярном спектре — Психообразование, поведенческая активация, маркеры рецидива.
3. Дневник настроения — Документирование пациентом собственных изменений настроения — диагностический и терапевтический инструмент.
4. Литий и ламотриджин — Фармакотерапия биполярного спектра адекватна.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG185, CANMAT 2018 — отдельный алгоритм для циклотимического расстройства ограничен; применяются принципы биполярного спектра; психотерапия первой линии.

9. Прогноз

- Хроническое; спонтанная ремиссия редка.

- Риск конверсии в биполярное расстройство I/II типа — ежегодная клиническая оценка.
- Коморбидное употребление ПАВ и факторы риска ПРЛ.
- При адекватном лечении функциональный уровень улучшается.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Циклотимический темперамент — это нормальная черта личности, не требующая лечения»

Клиническая логика: циклотимический темперамент при нормальном варианте не вызывает функциональных нарушений; клинический диагноз требует функциональных нарушений. Однако многие пациенты годами объясняют это «творческой натурой» и не обращаются за вмешательством, хотя качество жизни ухудшается.

Миф 2: «Циклотимическое расстройство не перейдёт в биполярное»

Доказательства: Akiskal — 15–50% конверсия в биполярное расстройство I или II типа; более высокий риск при наличии семейного анамнеза.

Миф 3: «Антидепрессант сам по себе контролирует все колебания настроения»

Доказательства: Риск маниакального поворота и быстрой цикличности; требуется совместно со стабилизатором настроения.

Миф 4: «Пациент с циклотимией потеряет творческие способности из-за лечения»

Доказательства: Соответствующее лечение (психотерапия + стабилизатор настроения) помогает сохранить и повысить креативность (стабилизированная активность); романтизированное объяснение «двойственности» приводит к избеганию вмешательства.

Миф 5: «Растительные препараты или диета излечивают циклотимическое расстройство»

Доказательства: Зверобой продырявленный — риск маниакального переключения; омега-3 — умеренный адъюнкт, не основное лечение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A62 Cyclothymic disorder. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. 2014/2020.
4. Yatham L.N. et al. CANMAT/ISBD 2018. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Akiskal H.S., Khani M.K., Scott-Strauss A. Cyclothymic temperamental disorders. Psychiatr Clin North Am 1979;2(3):527–554.
6. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.

МКБ-11 **6A70**	**6A70 ЕДИНИЧНЫЙ ЭПИЗОД ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА** **Single episode depressive disorder**
МКБ-10 F32	Депрессивный эпизод
DSM-5-TR F32.x	Большое депрессивное расстройство, единичный эпизод

1. Определение и нозология

Единичный эпизод депрессивного расстройства (МКБ-11: 6A70 Single Episode Depressive Disorder; DSM-5-TR: Major Depressive Disorder, Single Episode — F32.x) — аффективное расстройство, вызывающее функциональное нарушение, с пониженным настроением и/или ангедонией в течение как минимум 2 недель, сопровождающееся значительными когнитивными, соматическими и психомоторными симптомами. В анамнезе пациента наблюдается только один большой депрессивный эпизод (при рецидиве кодируется как 6A71).

2. История

- Гиппократ (V–IV вв. до н.э.) — термин «меланхолия».
- Kraepelin (1899) — депрессивный эпизод в рамках маниакально-депрессивного психоза.
- DSM-III (1980) — «Большое депрессивное расстройство» как официальный диагноз; отделение от биполярного расстройства.

- DSM-5 (2013) — «bereavement exclusion» (исключение по утрате) отменено — большой депрессивный эпизод может быть диагностирован даже после потери близкого.
- МКБ-11 (2019) — Единичный (6A70) и Рекуррентный (6A71) кодируются отдельно.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 15–20% (NESARC-III; Hasin D.S. et al. JAMA Psychiatry 2018).
- Годовая распространённость: ~6–8%.
- Пол: у женщин в 1,5–2 раза выше.
- Начало: в среднем 20–30 лет; однако возможно в любом возрасте.
- Суицид: депрессивное расстройство связано с ~50% суицидальных смертей.
- Коморбидность: тревожные расстройства 60%, употребление ПАВ 25%, боль, сердечно-сосудистая патология, диабет.
- Смертность: общая смертность увеличена в 1,5 раза (сердечно-сосудистая, суицид).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 35–40% (Sullivan P.F. et al. Am J Psychiatry 2000 мета-анализ); меньше, чем при биполярном.
- GWAS — 100+ локусов риска (Howard D.M. et al. Nat Neurosci 2019, n>800 000).
- Нейробиологически — моноаминергическая (серотонин, норадреналин, дофамин) гипотеза; дисрегуляция оси HPA, повышение кортизола; уменьшение объёма гиппокампа; воспалительная гипотеза (CRP, IL-6).
- Факторы риска: детская травма, семейный анамнез, острый стресс, хроническое соматическое заболевание, социальная изоляция, употребление психоактивных веществ, послеродовой период, гипотиреоз.

5. Клиническая картина

5.1 Основные симптомы (DSM-5-TR — ≥ 5 симптомов × 2 недели, минимум 1 из 1 или 2)

1. Стойкое сниженное настроение.

2. Ангедония — утрата интереса и удовольствия.
3. Изменения веса или аппетита.
4. Нарушение сна (инсомния или гиперсомния).
5. Психомоторное возбуждение или заторможенность (наблюдаемые другими).
6. Утомляемость или упадок энергии.
7. Чувство никчёмности или чрезмерное чувство вины.
8. Трудности концентрации и нарушение принятия решений.
9. Суицидальные мысли или план.

5.2 Квалификаторы (DSM-5-TR)

- Тяжесть: лёгкая, умеренная, тяжёлая.
- С психотическими особенностями (бред или галлюцинации).
- Атипичные особенности (гиперсомния, гиперфагия, leaden paralysis).
- Меланхолические особенности.
- Кататонические признаки.
- Перипартальное начало.
- Сезонный паттерн.
- Смешанные черты (маниакальные компоненты).
- С тревогой.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11 консенсусные точки)

A. 5+ симптомов из вышеперечисленных ≥ 2 недель; как минимум один — сниженное настроение или ангедония.

B. Значительный дистресс или функциональные нарушения

C. Исключение вещества или медицинского состояния

D. Маниакального или гипоманиакального эпизода никогда не было.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: Отмена «исключения по тяжёлой утрате» (в DSM-IV в течение 2 месяцев после утраты диагноз не ставился); тяжёлая утрата и депрессивный эпизод могут возникать совместно.

- МКБ-11 (6A70): Единичный эпизод — отдельный код; квалификаторы тяжести и психотических признаков.
- NICE NG222 (2022): Классификация тяжести: менее тяжёлая, более тяжёлая (вместо лёгкой/умеренной/тяжёлой в DSM); алгоритмы лечения в зависимости от тяжести.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Структурированное интервью (SCID-5, MINI).
3. Шкалы — PHQ-9 (скрининг и мониторинг), HAM-D, MADRS, BDI-II.
4. Суицидальный риск (C-SSRS).
5. Биполярный скрининг (MDQ, HCL-32) — для исключения биполярных эпизодов.
6. Медицинское и лабораторное (тиреоид, B12, фолат, ферритин, печень, почки, беременность) — исключить соматическую причину.
7. Токсикологический скрининг (подозрение на употребление веществ).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Биполярное расстройство I/II типа (6A60/6A61)	Наличие в анамнезе маниакального или гипоманиакального эпизода.
Дистимическое расстройство (6A72)	≥ 2 лет субпороговые депрессивные симптомы.
Расстройство адаптации (6B43)	Реакция на стрессовый фактор; количество критериев невелико.
Траур (горе)	После утраты близкого; волнообразное течение; самооценка сохранена.
Гипотиреоз	Повышение ТТГ; соматические симптомы.
Дефицит B12 / фолата	Лабораторное обследование.
Вещество-индуцированная депрессия	Анамнез употребления вещества
Депрессивные симптомы при деменции	Доминирует когнитивный дефицит; пожилой пациент.

7. Обследование и оценка

- PHQ-9 — стандарт в первичной медицинской помощи; ≥ 10 баллов — умеренно-тяжёлая депрессия.
- HAM-D-17 (Hamilton), MADRS — клинические и исследовательские.
- BDI-II — самооценка.
- C-SSRS — суицидальный риск.
- Лабораторно: общий анализ крови, щитовидная железа, B12, фолат, ферритин, печень/почки, глюкоза.
- ЭКГ — перед началом приёма ТЦА или препаратов, удлиняющих QT.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE NG222 · APA 2010 · консенсус CANMAT 2016)

1. Поэтапный подход в зависимости от тяжести:
    - Лёгкая (PHQ-9 5–9) — направленная самопомощь, интернет-интервенции на основе КПТ, физическая активность, наблюдение.
    - Умеренная (PHQ-9 10–14) — КПТ или ИПТ, или фармакотерапия (СИОЗС); выбор пациента.
    - Умеренно-тяжёлая (PHQ-9 15–19) — фармакотерапия (СИОЗС) или высокоинтенсивное психологическое вмешательство; предпочтительна комбинация.
    - Тяжёлая (PHQ-9 ≥ 20 или психотические особенности) — комбинация фармакотерапии + психотерапии; тяжёлый психотический/суицидальный риск — госпитализация и ЭСТ.
2. Фармакотерапия первой линии: СИОЗС — сертралин, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, циталопрам. Эффект через 4–6 недель; требуется титрация.
3. СИОЗСН — венлафаксин, дулоксетин — альтернатива или при коморбидной боли/тревоге.
4. Другое — миртазапин (проблемы со сном и аппетитом), бупропион (меньше сексуальных побочных эффектов, коморбидный СДВГ), агомелатин, вортиоксетин (когнитивный компонент).
5. Рефрактерные случаи: СИОЗС + литий или кветиапин или арипипразол; комбинации СИОЗС; кетамин/эскетамин (интраназально — одобрение FDA 2019, тяжёлая рефрактерная); ЭСТ.

6. Психотерапия первой линии альтернатива — монотерапия при лёгкой-умеренной депрессии, комбинация с фармакотерапией при тяжёлой; конкретные методы и доказательная база в списке «Методы лечения» (КПТ, ИПТ, поведенческая активация, MBCT).
7. Управление суицидальным риском — активная оценка; при высоком риске — госпитализация; ограничение доступа к средствам (оружие, лекарства); психосоциальная поддержка.
8. Длительность лечения: после ремиссии первого эпизода — 6–12 месяцев; при рецидивирующих случаях — длительно.

8.2 Фармакотерапия

Класс	Препарат	Диапазон доз	Примечание
СИОЗС	Сертралин, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, циталопрам	Сертралин 50–200 мг; эсциталопрам 10–20 мг	Первая линия; сексуальный побочный эффект; SIADH (у пожилых); циталопрам > 40 мг — удлинение QT.
СИОЗСН	Венлафаксин, дулоксетин	Венлафаксин 75–375 мг; дулоксетин 60–120 мг	Коморбидная боль, тревога.
Атипичные	Миртазапин, бупропион, агомелатин, вортиоксетин	Миртазапин 15–45 мг; бупропион 150–450 мг	Миртазапин — сон и аппетит; бупропион — нет сексуальных побочных эффектов.
ТСА	Амитриптилин, нортриптилин	75–150 мг	Вторая-третья линия; кардиальные и антихолинергические побочные эффекты; передозировка летальна.

Класс	Препарат	Диапазон доз	Примечание
МАОИ	Фенелзин, транилципромин	—	Рефрактерное; тираминовая диета.
Эскетамин (интраназально)	Spravato	56–84 мг	FDA 2019, рефрактерный; под контролем в клинике.

8.3 Уточнения, специфичные для источника

- NICE NG222 (2022): Пошаговый алгоритм в зависимости от тяжести; при более лёгкой степени — КПТ или самопомощь под руководством специалиста; при более тяжёлой — комбинация.
- Руководство APA по клинической практике (2010, обновление 2019): СИОЗС первая линия; КПТ / ИПТ первая линия альтернатива.
- CANMAT 2016: 4-ступенчатый алгоритм на основе тяжести и эпизода.
- Cipriani A. et al. Lancet 2018 сетевой мета-анализ: Сравнение 21 антидепрессанта — агомелатин и амитриптилин наиболее эффективны; флуоксетин, флувоксамин, ребоксетин и тразодон наименее эффективны. По приемлемости лучшие — агомелатин, циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, сертралин, вортиоксетин; ребоксетин же оказался в числе худших и по эффективности, и по приемлемости. Различия в эффективности клинически умеренны.

8.4 Методики лечения

1. КПТ для депрессии — Бек (Beck A.) — Когнитивная реструктуризация, поведенческая активация; 12–20 сеансов. Доказательства: мета-анализы Cochrane Cuijpers P. et al. — средний эффект, сравним с фармакотерапией; комбинация превосходит монотерапию при тяжёлых случаях.
2. Интерперсональная терапия (ИПТ / IPT — Interpersonal Therapy) — Клерман (Klerman G.), Вайсман (Weissman M.) — 4 проблемные области — горе, ролевой переход, ролевой конфликт, межличностный дефицит. 12–16 сессий. Сравнимая эффективность с КПТ в РКИ.
3. Поведенческая активация (англ. Behavioral Activation) — Джейкобсон (Jacobson N.), Мартелл (Martell C.) — Систематическое увеличение позитивной активности, уменьшение избегания. Dimidjian S. et al. J Consult Clin Psychol 2006 РКИ — сравнительный эффект с КПТ.

4. Когнитивная терапия на основе осознанности (англ. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) — Сегал (Segal Z.), Уильямс (Williams M.), Тиздейл (Teasdale J.) — В профилактике рецидивов; особенно при ≥ 3 эпизодах в анамнезе эффект может превосходить поддерживающую антидепрессивную терапию (Kuyken W. et al. Lancet 2015).
5. Опросник здоровья пациента-9 (англ. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) — Кроенке (Kroenke K.), Спитцер (Spitzer R.L.) — Золотой стандарт скрининга и мониторинга на уровне первичной медицинской помощи.
6. HAM-D / MADRS — Шкалы тяжести депрессии, оцениваемые клиницистом.
7. ЭСТ — Тяжёлая психотическая депрессия, рефрактерность, суицидальный риск, нарушение приёма пищи, беременность. UK ECT Review Group Lancet 2003 — ЭСТ превосходит фармакотерапию в тяжёлых случаях.
8. Эскетамин / кетамин — FDA 2019: интраназальный эскетамин (Spravato) для тяжёлой рефрактерной депрессии; быстрый антидепрессивный эффект (часы-дни); введение под контролем в клинике. Daly E.J. et al. JAMA Psychiatry 2018.
9. Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция (rTMS — repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) — Одобрение FDA при рефрактерной депрессии (2008); курс 4–6 недель, мишень — левая ДЛПФК.

9. Прогноз

- Спонтанная ремиссия 50% в течение года (но большинство ремиссий без антидепрессантов); высокий риск рецидива.
- После каждого последующего эпизода риск следующего эпизода возрастает.
- Суицидальный риск особенно высок в первые недели.
- Наблюдение — PHQ-9 / MADRS, суицидальный риск, побочные эффекты, комплаентность; первые 12 недель более интенсивно.
- Длительность лечения — 6–12 месяцев после ремиссии при первом эпизоде.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Депрессия — это просто „печаль“; её можно преодолеть усилием воли»

Доказательства: депрессия — комплексное нейробиологическое расстройство — дисрегуляция ГГН, дисбаланс моноаминов, структурные изменения (гиппокамп); не контролируется «волей». APA, ВОЗ, NICE рассматривают её как медицинское заболевание.

Миф 2: «Антидепрессанты вызывают зависимость»

Доказательства: СИОЗС и СИОЗСН не вызывают зависимости (аддикции) — не вызывают злоупотребления или толерантности. Однако синдром отмены существует (особенно у пароксетина, венлафаксина с коротким периодом полувыведения) — это не зависимость, а физиологическая адаптация; проходит при постепенном снижении дозы.

Миф 3: «Антидепрессант меняет личность пациента»

Доказательства: антидепрессанты уменьшают симптомы, не меняют личность. Если пациент жалуется: «я не чувствую себя собой» — побочный эффект (эмоциональное уплощение, emotional blunting) — смена препарата или снижение дозы.

Миф 4: «Антидепрессанты не превосходят плацебо»

Доказательства: Cipriani Lancet 2018 — 21 антидепрессант достоверно превосходит плацебо; однако эффект умеренный, особенно при лёгкой депрессии. При умеренно-тяжёлой депрессии эффект клинически значим.

Миф 5: «Диета (омега-3, витамины группы B, магний) заменяет антидепрессант»

Доказательства: некоторые добавки (омега-3, витамин D при дефиците) могут иметь умеренный адъюнктивный эффект, но не заменяют основное лечение при умеренно-тяжёлой депрессии. Исследование SMILES (Jacka F.N. BMC Med 2017) — диета средиземноморского типа как умеренный адъюнкт.

Миф 6: «Зверобой продырявленный (St John’s Wort) — натуральный антидепрессант, может заменить антидепрессант»

Доказательства: Зверобой продырявленный эффективен при лёгкой депрессии (Cochrane Linde K. 2008), но доказательная база при умеренной и тяжёлой депрессии ограничена; за счёт индукции CYP снижает уровень многих

препаратов (контрацептивы, антикоагулянты, антидепрессанты, антиретровирусные) — серьёзное взаимодействие.

Миф 7: «Достаточно только спорта или психотерапии, лекарства не нужны»

Доказательства: При лёгкой депрессии психотерапия и физические упражнения иногда достаточны, но при умеренно-тяжёлой депрессии и особенно при суицидальном риске необходима фармакотерапия; NICE NG222 и APA 2010.

Миф 8: «ЭСТ — устаревший или травматичный метод лечения»

Доказательства: современная ЭСТ (под наркозом, с миорелаксантами) безопасна и высокоэффективна; золотой стандарт при тяжёлой рефрактерной и психотической депрессии. UK ECT Review Group Lancet 2003.

Миф 9: «Антидепрессанты вызывают суицид»

Доказательства: FDA black box — риск увеличения суицидальных мыслей у детей и подростков (особенно в первые недели) — требует тщательного мониторинга в этот период, но в долгосрочной перспективе антидепрессанты снижают риск суицида (Stone M. et al. BMJ 2009).

Миф 10: «Депрессия в период тяжёлой утраты не может быть диагностирована»

Доказательства: DSM-5 отменил «bereavement exclusion»; траур и большой депрессивный эпизод могут возникать совместно; патологические формы траура (затяжное расстройство траура — 6B43) выделены отдельно.

Миф 11: «Депрессия у здоровых пациентов — маркер психологической „слабости“»

Доказательства: депрессия может возникнуть у любого человека; концепция «психологической силы» стигматизирующая и ошибочная; должна оцениваться как медицинское состояние.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A70 Single episode depressive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. Depression in adults: treatment and management. 2022.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder. 3rd ed. 2010.

5. Kennedy S.H., Lam R.W., McIntyre R.S. et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. Can J Psychiatry 2016;61(9):540–560.
6. Cipriani A., Furukawa T.A., Salanti G. et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2018;391(10128):1357–1366.
7. Hasin D.S., Sarvet A.L., Meyers J.L. et al. Epidemiology of adult DSM-5 major depressive disorder and its specifiers in the United States. JAMA Psychiatry 2018;75(4):336–346.
8. Howard D.M. et al. Genome-wide meta-analysis of depression identifies 102 independent variants. Nat Neurosci 2019;22(3):343–352.
9. Cuijpers P., Karyotaki E., de Wit L., Ebert D.D. The effects of fifteen evidence-supported therapies for adult depression: A meta-analytic review. Psychother Res 2020;30(3):279–293.
10. Kuyken W., Hayes R., Barrett B. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse. Lancet 2015;386(9988):63–73.
11. Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001;16(9):606–613.
12. Daly E.J. et al. Efficacy and safety of intranasal esketamine adjunctive to oral antidepressant therapy in treatment-resistant depression. JAMA Psychiatry 2018;75(2):139–148.
13. Jacka F.N. et al. A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the «SMILES» trial). BMC Med 2017;15(1):23.
14. UK ECT Review Group. Lancet 2003;361(9360):799–808.
15. Stone M., Laughren T., Jones M.L. et al. Risk of suicidality in clinical trials of antidepressants in adults: analysis of proprietary data submitted to US Food and Drug Administration. BMJ 2009;339:b2880.
16. Beck A.T., Rush A.J., Shaw B.F., Emery G. Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press, 1979.
17. Martell C.R., Dimidjian S., Herman-Dunn R. Behavioral Activation for Depression: A Clinician's Guide. New York: Guilford Press, 2010.
18. Weissman M.M., Markowitz J.C., Klerman G.L. Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. New York: Basic Books, 2000.

19. Segal Z.V., Williams J.M.G., Teasdale J.D. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.
20. Jacobson N.S., Dobson K.S., Truax P.A. et al. A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. J Consult Clin Psychol 1996;64(2):295–304.

МКБ-11 **6A71**	**6A71 РЕКУРРЕНТНОЕ ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО** **Recurrent depressive disorder**
МКБ-10 F33	Рекуррентное депрессивное расстройство
DSM-5-TR F33.x	Большое депрессивное расстройство, рекуррентное

1. Определение и нозология

Рекуррентное депрессивное расстройство (МКБ-11: 6A71 Recurrent Depressive Disorder; DSM-5-TR: Большое депрессивное расстройство, рекуррентное — F33.x) — наличие как минимум двух больших депрессивных эпизодов, между эпизодами частичная или полная ремиссия продолжительностью не менее 2 месяцев. В анамнезе нет маниакальных или гипоманиакальных эпизодов (если есть, диагноз — биполярное расстройство).

Отличается от единичного эпизода депрессивного расстройства (6A70) только их количеством; клинические проявления, диагностические критерии и принципы лечения одинаковы, однако роль долгосрочной поддерживающей фармакотерапии здесь важнее.

2. История

- Kraepelin (1899) — рекуррентные депрессивные эпизоды в рамках маниакально-депрессивного расстройства.
- Leonhard K. (1957) — концепция униполярной депрессии.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013) — «Большое депрессивное расстройство, рекуррентное» закреплено как официальный диагноз.
- МКБ-11 (2019) — Единичный (6A70) и Рекуррентный (6A71) кодируются отдельно.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость большого депрессивного расстройства 15–20%; из них ~50–80% имеют рецидивирующее течение.
- После каждого последующего эпизода риск следующего эпизода возрастает (Solomon D.A. et al. Am J Psychiatry 2000) — после 1-го эпизода ~50%, после 2-го ~70%, после 3-го ~90%.
- Суицидальный риск выше, чем при единичном эпизоде, особенно при нелечёных эпизодах.

4. Этиология и патогенез

- То же, что и при единичном эпизоде (6A70) — наследственность ~35–40% (Sullivan 2000); GWAS локусы.
- Предрасположенность к рецидиву — большая когнитивная уязвимость, концепция нейробиологического «киндлинга» (Post R.M.) — после каждого эпизода порог для следующего снижается.
- Факторы риска — детская травма, семейный анамнез, хронический стресс, коморбидная тревога, соматические заболевания.

5. Клиническая картина

То же, что и при единичном эпизоде (см. 6A70 §5). Дополнительные особенности у пациентов с рецидивами:

- Картина эпизода может отличаться от предыдущих эпизодов (атипичные черты, сезонный паттерн).
- Рецидивные эпизоды обычно начинаются чаще предыдущих (концепция киндлинга — Post R.M. Am J Psychiatry 1992).
- Коморбидные тревожные расстройства с повышенной частотой.
- Могут наблюдаться хронические когнитивные дефициты (особенно после множественных эпизодов).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11)

A. Как минимум 2 больших депрессивных эпизода (соответствующих критериям 6A70 §6.1).

B. Между эпизодами ≥ 2 месяца частичной или полной ремиссии.

C. Маниакального или гипоманиакального эпизода никогда не было.

D. Не объясняется лучше шизоаффективным, шизофренией или другим психотическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11: квалификаторы тяжести текущего эпизода (лёгкий, умеренный, тяжёлый) и психотических признаков; статус ремиссии (частичная, полная).
- DSM-5-TR: Квалификаторы те же, что и для 6A70.
- NICE NG222: У пациентов с ≥ 3 эпизодами особо рекомендуется MBCT (англ. Mindfulness-Based Cognitive Therapy) для профилактики рецидивов.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Анамнез — количество предыдущих эпизодов, длительность, триггеры, качество ремиссии.
2. Биполярный скрининг (MDQ, HCL-32) — для исключения гипоманиакальных эпизодов.
3. PHQ-9 / HAM-D / MADRS — тяжесть текущего эпизода.
4. C-SSRS — суицидальный риск (высокий у пациентов с рецидивом).
5. Лабораторные (тиреоидные, B12, фолат, ферритин); оценка соматической коморбидности.

6.4 Дифференциальная диагностика

То же, что и 6A70 (см. единичный эпизод). Особое внимание — исключить биполярные эпизоды.

7. Обследование и оценка

То же, что и 6A70. Особое внимание — оценка когнитивных дефицитов (после множественных эпизодов).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE NG222 · APA 2010 · CANMAT 2016)

1. Лечение острого эпизода — То же, что 6A70 (СИОЗС, КПТ, комбинация).
2. Поддерживающая (maintenance) фармакотерапия — долгосрочная:

- После 2 эпизодов — продолжение 1–2 года после ремиссии.
- После ≥ 3 эпизодов — длительная (годы) или пожизненная поддерживающая терапия.
- Эффективный антидепрессант сохраняется в той же дозе после ремиссии (снижение дозы увеличивает риск рецидива).

3. MBCT (англ. Mindfulness-Based Cognitive Therapy) — сравнительная эффективность с поддерживающей антидепрессивной терапией в профилактике рецидивов у пациентов с ≥ 3 эпизодами в анамнезе (Kuyken W. et al. Lancet 2015).
4. Литий адъюнктивно — у пациентов с рефрактерностью или высоким риском рецидива; эффект снижения суицида (Cipriani BMJ 2013).
5. Распознавание маркеров рецидива — психообразование для пациента и семьи (нарушение сна, раздражительность, социальная отгороженность, ангедония).
6. Лечение коморбидности — тревожные расстройства, употребление психоактивных веществ, сердечно-сосудистые — параллельно.
7. Мониторинг суицидального риска — высокий, особенно в начале нового эпизода.

8.2 Методики лечения

1. Когнитивная терапия на основе осознанности (англ. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) — 8-недельная групповая программа; сессии по 2,5 часа + домашняя практика. Эффективна в профилактике рецидивов у пациентов с ≥ 3 эпизодами в анамнезе. Kuyken W. et al. Lancet 2015 РКИ. mbct.com.
2. Поддерживающая терапия антидепрессантами (Maintenance) — Длительное применение того же препарата и дозы; минимум 2 года (после ≥ 3 эпизодов); при отмене постепенно (4–8 недель).
3. КПТ и поддерживающие формы ИПТ — Сеансы ежемесячно или раз в 2 недели; профилактика рецидивов.
4. Литий адъюнктивно — При рефрактерной униполярной депрессии с высоким суицидальным риском; Cipriani BMJ 2013.

8.3 Различия между источниками

- NICE NG222 (2022): При наличии в анамнезе ≥ 3 эпизодов — MBCT или поддерживающая терапия антидепрессантами; оба сопоставимо эффективны.
- APA 2010: поддерживающая фармакотерапия после ≥ 2 эпизодов; после ≥ 3 эпизодов — долгосрочная.

- Geddes J.R. et al. Lancet 2003, мета-анализ: поддерживающая терапия антидепрессантами значимо превосходит плацебо в снижении рецидивов (NNT 5).

9. Прогноз

- Риск рецидива возрастает после каждого эпизода (Solomon 2000).
- При адекватной поддерживающей терапии риск рецидива значительно снижается (NNT 5).
- Коморбидная тревога, соматические заболевания, нарушение комплаенса — плохой прогноз.
- Наблюдение — мониторинг PHQ-9; маркеры рецидива; уровень антидепрессанта и побочные эффекты; суицидальный риск.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Антидепрессанты нельзя принимать пожизненно, они вызывают „зависимость“»

Доказательства: СИОЗС/СИОЗСН не вызывают зависимости; пациентам с ≥ 3 эпизодами в анамнезе рекомендуется пожизненная поддерживающая терапия (NICE NG222, APA 2010). Снижение поддерживающей дозы увеличивает риск рецидива.

Миф 2: «После ремиссии антидепрессант нужно сразу отменить»

Доказательства: после ремиссии продолжается не менее 6–12 месяцев (единичный эпизод) или годы (рецидив); раннее прекращение значительно повышает риск рецидива (Geddes Lancet 2003).

Миф 3: «При каждом эпизоде препарат нужно менять»

Доказательства: препарат, эффективный в предыдущем эпизоде, должен быть повторно использован в следующем эпизоде (пациент-специфическая эффективность).

Миф 4: «Рекуррентное депрессивное расстройство — это „слабость личности“, лечение не должно быть длительным»

Доказательства: концепция нейробиологического «kindling» — каждый эпизод увеличивает риск нового эпизода; долгосрочное лечение «защищает» мозг.

Миф 5: «Только МБКТ достаточно для профилактики рецидивов, фармакотерапия не нужна»

Доказательства: Kuyken Lancet 2015 — сравнительное исследование MBCT и поддерживающей антидепрессивной терапии; однако индивидуальный выбор — на основе ценностей пациента, доступности, предыдущего ответа на лечение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A71 Recurrent depressive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. 2022.
4. APA. Practice Guideline for MDD. 3rd ed. 2010.
5. Kennedy S.H. et al. CANMAT 2016. Can J Psychiatry 2016;61(9):540–560.
6. Solomon D.A. et al. Multiple recurrences of major depressive disorder. Am J Psychiatry 2000;157(2):229–233.
7. Post R.M. Transduction of psychosocial stress into the neurobiology of recurrent affective disorder. Am J Psychiatry 1992;149(8):999–1010.
8. Geddes J.R. et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet 2003;361(9358):653–661.
9. Kuyken W. et al. Lancet 2015;386(9988):63–73.
10. Cipriani A. et al. BMJ 2013;346:f3646.

МКБ-11 **6A72**	**6A72** **ДИСТИМИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Dysthymic disorder**
МКБ-10 F34.1	Дистимия
DSM-5-TR F34.1	Персистирующее депрессивное расстройство (дистимия)

1. Определение и нозология

Дистимическое расстройство (МКБ-11: 6A72 Dysthymic Disorder; DSM-5-TR: Persistent Depressive Disorder — F34.1) — хронические депрессивные

симптомы, длящиеся не менее 2 лет (у взрослых; у детей/подростков — 1 год), не достигающие тяжести большого депрессивного эпизода. Пациент может описывать своё состояние как «я всегда был таким».

В DSM-5-TR термин «Persistent Depressive Disorder» объединяет дистимию и хроническое большое депрессивное расстройство; в МКБ-11 дистимический и хронический депрессивный эпизод кодируются отдельно.

2. История

- Flemming C.F. (1844) — первое употребление термина «дистимия» в психиатрии; Kahlbaum (1882) — придал термину современное значение хронического субсиндромального депрессивного состояния.
- Akiskal H.S. (1980-е годы) — дистимический темперамент как подстадия депрессивного спектра.
- DSM-III (1980) — «Дистимическое расстройство» как официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — «Персистирующее депрессивное расстройство» — объединение дистимии и хронической БДР.
- МКБ-11 (2019) — дистимическое расстройство сохранено отдельно.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1,1–6,4% (дистимия); 12-месячная в США ~0,5%, плюс 1,5% для хронической большой депрессии (DSM-5-TR).
- Пол: у женщин в 2 раза выше.
- Начало: раннее (детство/подростковый возраст — early-onset; ≥ 21 года — late-onset).
- «Двойная депрессия» (double depression) — большой депрессивный эпизод на фоне дистимического расстройства — возникает у 76,9% пациентов в течение 5 лет (Klein D.N. et al. Am J Psychiatry 2000;157(6):931–939).
- Коморбидность: тревога, ПРЛ, употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Общая генетическая и нейробиологическая предрасположенность с большим депрессивным расстройством.

- Детская травма и хронический психосоциальный стресс являются основными средовыми факторами риска.
- У ближайших родственников повышена частота депрессивного расстройства или дистимии.

5. Клиническая картина

- Стойкое сниженное настроение — присутствует большую часть времени (≥ половины времени, в течение 2 лет нет бессимптомных периодов длительнее 2 месяцев).
- Как минимум 2 из следующих: пониженный или повышенный аппетит, инсомния или гиперсомния, низкая энергия, низкая самооценка, трудности с концентрацией, безнадежность.
- Пациент адаптировался к множественным функциональным компромиссам — типично объяснение «всегда было так»; обращается в клинику часто на фоне большого депрессивного эпизода.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Стойкое депрессивное настроение ≥ 2 лет (у детей ≥ 1 года), большую часть дня, большую часть времени.

B. ≥ 2 симптома в депрессивных периодах (выше).

C. В течение 2 лет (1 года) нет бессимптомного периода более 2 месяцев.

D. В течение этого периода критерии большого депрессивного эпизода могут присутствовать непрерывно (DSM-5 — новый синтез «двойной депрессии»).

E. Маниакального или гипоманиакального эпизода никогда не было.

F. Не объясняется лучше шизоаффективным или другим психотическим расстройством.

G. Исключение вещества или медицинского состояния

H. Значительный дистресс или функциональные нарушения

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: «Persistent Depressive Disorder» — объединены дистимия и хроническое БДР; квалификаторы — раннее/позднее начало, с

тревожным дистрессом/без, меланхолический, атипичный, перипартальный, сезонный и др.

- МКБ-11: дистимическое расстройство (6A72) отдельно; хронический депрессивный эпизод — квалификатор в рамках 6A70/71.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + длительный анамнез (пациент может не помнить точное начало).
2. SCID-5; PHQ-9, HAM-D, MADRS.
3. Скрининг на биполярное расстройство.
4. Оценка личности — дифференциальная диагностика с ПРЛ.
5. Медицинское и лабораторное (тиреоид, анемия, B12).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
Большое депрессивное расстройство (6A70/6A71)	Дискретные эпизоды; между симптомами настроение нормальное.
Циклотимическое расстройство (6A62)	Гипоманиакальные периоды присутствуют.
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность — часы; нарушение идентичности.
Расстройство адаптации (6B43)	Реакция на стрессовый фактор; ≤ 6 месяцев.
Гипотиреоз	TSH.

7. Обследование и оценка

- PHQ-9, HAM-D, MADRS.
- Cornell Dysthymia Rating Scale — дистимически-специфическая.
- Медицинское и лабораторное.

8. Лечение

1. Фармакотерапия: СИОЗС (сертралин, флуоксетин) — первая линия; эффект может наступить через 6–8 недель (медленнее, чем при большой депрессии).

2. Психотерапия: CBASP (англ. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy — McCullough J.) — разработан специально для хронической депрессии; КПТ, ИПТ.
3. Комбинация — превосходит монотерапию при дистимическом расстройстве (Keller M.B. et al. NEJM 2000 — нефазодон + CBASP РКИ).
4. При «двойной депрессии» — лечение острого эпизода как большого депрессивного + долгосрочное поддерживающее лечение.
5. Рефрактерность — смена препарата, аугментация (литий, атипичный антипсихотик).

8.1 Методики лечения

1. Система когнитивно-поведенческого анализа психотерапии (англ. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP) — Маккалло (McCullough J.) — Специально разработанный подход для хронической депрессии — анализ ситуаций, обучение межличностному поведению, использование терапевтических отношений как основного инструмента. Keller M.B. et al. NEJM 2000 РКИ.
2. СИОЗС длительно — Сертралин, флуоксетин, эсциталопрам; медленный ответ; длительное удержание.
3. КПТ и ИПТ — Стандартные терапии депрессии; модификации при хронической форме.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG222 — рекомендует длительное когнитивно-поведенческое лечение при хронических депрессивных симптомах (CBASP в руководстве не назван); CBASP прямо рекомендует только APA 2010.
- APA 2010 — комбинация предпочтительнее.
- Keller M.B. et al. NEJM 2000 — комбинация нефазодона + CBASP значимо превосходит монотерапию.

9. Прогноз

- Хроническое течение; спонтанная ремиссия редка.
- «Двойная депрессия» — развивается у 76,9% пациентов с дистимией без предшествующего большого эпизода в течение 5 лет (Klein D.N. et al. Am J Psychiatry 2000).
- При длительном лечении функциональный уровень улучшается.

- Наблюдение — периодические шкалы, комплаентность, коморбидность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Дистимия — это просто „грустный характер“, а не медицинское расстройство»

Доказательства: стойкое функциональное нарушение, риск суицида, развитие «двойной депрессии»; должно оцениваться как медицинское расстройство.

Миф 2: «Пациент с дистимией не отвечает на антидепрессанты»

Доказательства: ответ медленный (6–8 недель), но СИОЗС эффективны; комбинация с CBASP превосходит.

Миф 3: «Хроническая депрессия требует только психотерапии, лекарства бесполезны»

Доказательства: Keller NEJM 2000 — комбинация нефазодона + CBASP превосходит монотерапию; фармакотерапия является основным компонентом.

Миф 4: «Объяснение пациента „я всегда был таким“ не является основой для диагноза — его следует рассматривать как адаптацию»

Доказательства: эта перспектива пациента создаёт проблему недооценки — долгосрочный функциональный компромисс может быть маркером медицинского состояния.

Миф 5: «Растительные препараты — безопасная альтернатива при дистимии»

Доказательства: Зверобой продырявленный показывает некоторый эффект при лёгкой депрессии, но взаимодействие с индукцией CYP; стандартный антидепрессант предпочтительнее.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6A72 Dysthymic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. 2022.
4. Keller M.B., McCullough J.P., Klein D.N. et al. A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and

their combination for the treatment of chronic depression. NEJM 2000;342(20):1462–1470.

5. Klein D.N., Shankman S.A., Rose S. Ten-year prospective follow-up study of the naturalistic course of dysthymic disorder and double depression. Am J Psychiatry 2006;163(5):872–880.
6. McCullough J.P. Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Guilford Press; 2000.

МКБ-11 **GA34.41**	**GA34.41 ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОЕ ДИСФОРИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО (PMDD)** **Premenstrual dysphoric disorder**
МКБ-10 N94.3	Синдром предменструального напряжения
DSM-5-TR N94.3	Предменструальное дисфорическое расстройство

1. Определение и нозология

Предменструальное дисфорическое расстройство (МКБ-11: GA34.41; DSM-5-TR: N94.3) — рецидивирующее расстройство, характеризующееся значительными эмоциональными и поведенческими симптомами в последнюю неделю перед менструальным циклом (лютеиновая фаза), которые полностью проходят в течение нескольких дней после начала менструации. Отличается от предменструального синдрома (ПМС) клинической тяжестью и значительными функциональными нарушениями.

2. История

- Frank R.T. (1931) — Термин «предменструальное напряжение».
- DSM-IV (1994) — «Premenstrual Dysphoric Disorder» в исследовательской категории раздела III.
- DSM-5 (2013) — официально принят как диагноз в категории депрессивных расстройств.

- МКБ-11 (2019) — как отдельная категория в рамках расстройств настроения.

3. Эпидемиология

- Распространённость у женщин репродуктивного возраста: 3–8% (обзор Yonkers K.A. et al. Lancet 2008).
- ПМС — более лёгкая форма — у 30–80% женщин.
- Коморбидность: большое депрессивное расстройство, тревога, биполярное расстройство — повышает риск.
- Суицидальные мысли усиливаются в лютеиновой фазе.

4. Этиология и патогенез

- Генетика: наследуемость ~30–50% (близнецовые исследования Treloar S.A. et al. Psychol Med 2002).
- Гормональная чувствительность: У пациенток с PMDD уровни овариальных гормонов (эстроген, прогестерон) в норме; однако чувствительность повышена — аллопрегнанолон (метаболит прогестерона) оказывает аномальное действие на ГАМК-А рецепторы (Schmidt P.J. et al. NEJM 1998 исследование супрессии яичников и добавления гормонов).
- Серотонинергическая дисрегуляция: Быстрый эффект СИОЗС (1–2 дня, в отличие от классической депрессии) поддерживает этот механизм.

5. Клиническая картина

5.1 Аффективные и поведенческие симптомы (в лютеиновой фазе)

- Аффективная лабильность (резко меняющееся настроение, плаксивость, rejection sensitivity).
- Раздражительность и гневные вспышки (межличностный конфликт).
- Сниженное настроение, безнадежность, самокритика.
- Тревога, напряжение.

5.2 Поведенческие и соматические симптомы

- Снижение интереса к обычной деятельности.
- Трудности концентрации.
- Летаргия и утомляемость.
- Изменение аппетита (особенно потребность в углеводах), переедание.

- Нарушение сна (инсомния или гиперсомния).
- Чувство потери контроля.
- Соматические — вздутие тела, боль в спине, головная боль, чувствительность груди.

5.3 Длительность и ритм

Симптомы начинаются в лютеиновой фазе (за 1 неделю до менструации), полностью проходят в течение нескольких дней после начала менструации; полная ремиссия в фолликулярной фазе (после менструации).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · МКБ-11)

A. В большинстве менструальных циклов 5+ симптомов в последнюю неделю лютеиновой фазы; уменьшаются в течение нескольких дней после начала менструации; полная ремиссия в постменструальной фазе.

B. Как минимум 1 из следующих:

1. Аффективная лабильность;
2. Раздражительность или гнев;
3. Сниженное настроение или самокритика;
4. Тревога и напряжение.

C. Дополнительные симптомы из следующих (B + C в сумме 5+):

5. Снижение интереса;
6. Трудности концентрации;
7. Летаргия, утомляемость;
8. Изменение аппетита, переедание;
9. Нарушение сна;
10. Чувство потери контроля;
11. Соматические (вздутие, боль и т.д.).

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения...

E. Проспективный дневник настроения ≥ 2 циклов — обязательно для подтверждения диагноза.

F. Симптомы не являются обострением другого психического расстройства (БДР, панического, дистимического) (ПМДР — отдельный диагноз; но может возникать на фоне этих расстройств — «предменструальное обострение»).

6.2 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — ритм симптомов, связанных с циклом.
2. Проспективный дневник настроения в течение 2 циклов — DRSP (англ. Daily Record of Severity of Problems, Endicott J.) или PRISM (англ. Premenstrual Record of Impact and Severity of Menstruation) — диагноз нельзя подтвердить ретроспективным анамнезом.
3. Скрининг коморбидности (депрессия, тревога, биполярное).
4. Соматические причины (щитовидная железа, анемия, поликистоз яичников).

6.3 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительные признаки**
ПМС (предменструальный синдром)	Лёгкие симптомы, функциональных нарушений нет.
БДР с лютеиновым обострением	Основное расстройство (MDD) присутствует на протяжении всего цикла, усиливается в лютеиновой фазе.
Биполярное расстройство	Гипоманиакальные/маниакальные эпизоды присутствуют.
Заболевание щитовидной железы	TSH.
Эндометриоз, дисменорея	Доминирует тазовая боль; аффективные симптомы слабо выражены.

7. Обследование и оценка

- DRSP или PRISM — дневник настроения.
- PHQ-9, GAD-7 — коморбидность.
- Гинекологический осмотр и ТТГ — для исключения соматических причин.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ACOG · ISPMD · APA 2010)

1. СИОЗС первая линия: флуоксетин, сертралин, пароксетин (одобрение FDA для ПМДР), эсциталопрам. Возможны два режима:
    - Постоянные (ежедневно): во всём цикле.
    - Интермиттирующий приём в лютеиновую фазу: от овуляции до начала менструации (14 дней) — одинаково эффективно (Steiner M. et al. NEJM 1995 РКИ).
2. Подавление гормонов — комбинированные оральные контрацептивы (особенно содержащие дроспиренон — Yaz, Beyaz; одобрены FDA); агонисты ГнРГ (лейпролид) при рефрактерных случаях.
3. Овариэктомия — последний выбор, при рефрактерных тяжёлых случаях; с заместительной эстрогенной терапией.
4. КПТ — адъюнктивно; обзоры Lustyk M.K. et al. показали умеренный эффект.
5. Образ жизни: физическая активность, снижение кофеина и алкоголя — адъювант.
6. Добавка кальция (1200 мг/сут) — Thys-Jacobs S. et al. Am J Obstet Gynecol 1998 РКИ — умеренный эффект; в роли адъюнкта.

8.2 Методики лечения

1. Ежедневный учет тяжести проблем (англ. Daily Record of Severity of Problems, DRSP) — Endicott J. — 21 симптом, ежедневная регистрация по 1–6 баллов; для диагноза ПМДР требуется проспективное наблюдение в течение 2 циклов.
2. СИОЗС — Режим лютеиновой фазы — От овуляции (14-й день) до начала менструации; эффективно как при непрерывном применении. Steiner M. et al. NEJM 1995.
3. Пероральный контрацептив, содержащий дроспиренон — Yaz, Beyaz — одобрение FDA для ПМДР; гормональная стабилизация.
4. Агонист ГнРГ (лейпролид) — Подавление функции яичников в рефрактерных случаях; риск остеопороза при длительном применении.

8.3 Различия между источниками

- ACOG (англ. American College of Obstetricians and Gynecologists) Practice Bulletin: СИОЗС первая линия; пероральные контрацептивы — вторая.

- Консенсус ISPMD (англ. International Society for Premenstrual Disorders): длительный или лютеиновый СИОЗС одинаковой эффективности; рефрактерность к ГнРГ.

9. Прогноз

- У большинства пациентов значительное улучшение при применении СИОЗС или гормональной терапии.
- Продолжается в течение репродуктивного периода; ремиссия после менопаузы.
- Наблюдение — симптомы цикла, комплаентность, побочные эффекты, коморбидность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ПМДР — это „женская слабость воли“, а не медицинское расстройство»

Доказательства: Schmidt P.J. NEJM 1998 — подавление овариальных гормонов устраняет симптомы, возобновление гормонов возвращает симптомы; нейробиологически обоснованное расстройство. Официальный диагноз DSM-5 и МКБ-11.

Миф 2: «ПМДР — это то же самое, что ПМС, разницы нет»

Доказательства: ПМС — у 30–80% женщин в лёгкой форме; PMDD характеризуется клинической тяжестью и функциональными нарушениями — 3–8% женщин.

Миф 3: «СИОЗС не оказывает значимого эффекта при ПМДР, нужно ждать как при депрессии»

Доказательства: СИОЗС при ПМДР оказывает быстрый эффект (в течение 1–2 дней) — фармакокинетический механизм, отличный от большой депрессии; прямое воздействие на серотонинергическую систему.

Миф 4: «Эффективно только гормональное лечение (беременность, заместительная гормональная терапия)»

Доказательства: СИОЗС и гормональная терапия — оба эффективны; СИОЗС — первая линия (для большинства пациентов); гормональная — при гинекологической коморбидности или по выбору пациента.

Миф 5: «Растительные препараты (витекс, масло примулы вечерней, зверобой) излечивают ПМДР»

Доказательства: прутняк (Vitex agnus-castus) — в некоторых исследованиях умеренный эффект при ПМС; доказательная база для ПМДР ограничена. Масло примулы вечерней — Cochrane отрицательные результаты. Зверобой — риск взаимодействия с СИОЗС.

Миф 6: «Краниосакральная терапия, гомеопатия, акупунктура устраняют ПМДР»

Доказательства: эффективность этих комплементарных вмешательств при ПМДР не доказана.

Миф 7: «Диагноз ПМДР можно поставить на основании ретроспективного анамнеза»

Доказательства: ретроспективные записи ненадёжны; обязателен проспективный дневник в течение 2 циклов для постановки диагноза — это наиболее частая причина невыявления.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. GA34.41 Premenstrual dysphoric disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Yonkers K.A., O'Brien P.M., Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008;371(9619):1200–1210.
4. Schmidt P.J., Nieman L.K., Danaceau M.A., Adams L.F., Rubinow D.R. Differential behavioral effects of gonadal steroids in women with and in those without premenstrual syndrome. NEJM 1998;338(4):209–216.
5. Steiner M., Steinberg S., Stewart D. et al. Fluoxetine in the treatment of premenstrual dysphoria. NEJM 1995;332(23):1529–1534.
6. Thys-Jacobs S., Starkey P., Bernstein D., Tian J. Calcium carbonate and the premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 1998;179(2):444–452.
7. ACOG Practice Bulletin No. 15. Premenstrual syndrome. 2000 (reviewed).
8. Nevatte T., O'Brien P.M.S., Bäckström T. et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. Arch Womens Ment Health 2013;16(4):279–291.
9. Ismaili E., Walsh S., O'Brien P.M.S. et al. Fourth consensus of the International Society for Premenstrual Disorders (ISPMD): auditable standards for diagnosis and management of premenstrual disorder. Arch Womens Ment Health 2016;19(6):953–958.

10. Treloar S.A., Heath A.C., Martin N.G. Genetic and environmental influences on premenstrual symptoms. Psychol Med 2002;32(1):25–38.
11. Marjoribanks J., Brown J., O'Brien P.M.S., Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;(6):CD001396.
12. Endicott J., Nee J., Harrison W. Daily Record of Severity of Problems (DRSP): reliability and validity. Arch Womens Ment Health 2006;9(1):41–49.
13. Lustyk M.K.B., Gerrish W.G., Shaver S., Keys S.L. Cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. Arch Womens Ment Health 2009;12(2):85–96.

6B00–6B0Z ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Anxiety or fear-related disorders

МКБ-11 **6B00**	**6B00 ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО (ГТР)** **Generalised anxiety disorder**
МКБ-10 F41.1	Генерализованное тревожное расстройство
DSM-5-TR F41.1	Генерализованное тревожное расстройство

1. Определение и нозология

Генерализованное тревожное расстройство (МКБ-11: 6B00 Generalised Anxiety Disorder; DSM-5-TR: F41.1) — расстройство, характеризующееся чрезмерной тревогой, продолжающейся не менее нескольких месяцев (в DSM-5-TR ≥ 6 месяцев), охватывающей множество сфер жизни (работа, семья, здоровье, повседневные темы), неконтролируемой, без достаточных триггеров. Сопровождается значительными соматическими симптомами (напряжение, утомляемость, нарушение сна).

2. История

- 1920–1960-е годы — термин «anxiety neurosis», связанный с влиянием Фрейда.
- DSM-III (1980) — «anxiety neurosis» → разделение на паническое расстройство и ГТР; ГТР была остаточной категорией.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — ГТР как отдельное расстройство; длительность ≥ 6 месяцев; характерные соматические симптомы.
- МКБ-11 (2019) — сформулировала требование к длительности для диагноза как «несколько месяцев» (менее строго, чем в DSM-5).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 3–9% (Kessler R.C. et al. WMH обзоры).
- Годовая распространённость: ~2–3%.
- Пол: у женщин в 2 раза выше.
- Начало — бимодальное — подростковый и средний возраст; часто хроническое течение.
- Коморбидность: БДР ~60%, социальная тревога, паническое расстройство, употребление ПАВ, соматические (синдром раздражённого кишечника, кардиальные жалобы).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 30–40% (Hettema J.M. et al. Am J Psychiatry 2001 мета-анализ).
- Нейробиологически — гиперреактивность миндалевидного тела, нарушение префронтально-амигдалярной регуляции; ГАМК-ергическая и серотонинергическая дисрегуляция.
- Личностные черты (нейротизм, поведенческое торможение) — факторы высокого риска.
- Среда — детская травма, хронический стресс, гиперопека родителей.

5. Клиническая картина

5.1 Психологические симптомы

- Неуправляемое беспокойство, охватывающее множество сфер.
- «Беспокойство о беспокойстве» — мета-тревога (концепция Wells A.).
- Трудности концентрации, пустота в мыслях.
- Раздражительность.

5.2 Соматические симптомы

- Мышечное напряжение.
- Утомляемость.
- Нарушение сна (трудности засыпания, поддержания сна).
- Вегетативные симптомы (тахикардия, потливость, сухость во рту, головная боль).
- Желудочно-кишечные жалобы — частая коморбидность с СРК.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Чрезмерная тревога или напряжение, направленные на множество сфер; присутствуют большую часть времени повседневной активности; ≥ 6 месяцев (DSM-5-TR) / несколько месяцев (МКБ-11).

B. Трудность контроля тревоги.

C. ≥ 3 симптомов (у детей 1):

1. Беспокойство, ощущение взвинченности, «на грани»;
2. Лёгкая утомляемость;
3. Трудности концентрации;
4. Раздражительность;
5. Мышечное напряжение;
6. Нарушение сна.

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения

E. Исключение вещества или медицинского состояния

F. Не объясняется лучше другим психиатрическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: Период ≥ 6 месяцев; ≥ 3 соматических симптома.
- МКБ-11: длительность «несколько месяцев» — менее строго; требуются соматические симптомы, но конкретное число не указано.
- NICE CG113 (Генерализованное тревожное расстройство и паническое расстройство у взрослых: ведение, 2011, обновление 2020): ступенчатая помощь (stepped care) — психообразование + наблюдение → направленная самопомощь → КПТ или фармакотерапия → комбинация → в тяжёлом случае специализированная служба.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (области беспокойства, триггеры, соматические симптомы, избегание).
2. SCID-5, MINI.
3. GAD-7 (скрининг, исходные показатели и мониторинг) — ≥ 10 умеренно-тяжёлая тревога.
4. HAM-A (англ. Hamilton Anxiety) — оценка клиницистом.

5. Скрининг коморбидности (PHQ-9 депрессия, паника, социальная тревога).
6. Исключить соматическую причину — ТТГ, анемия, кардиальные заболевания, употребление кофеина или стимуляторов.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительные признаки
Паническое расстройство (6B01)	Дискретные панические атаки.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Страх социальной оценки доминирует.
ОКР (6B20)	Эго-дистонные обсессии, компульсии.
ПТСР (6B40)	История травмы, интрузивные симптомы.
Большое депрессивное расстройство (6A70/6A71)	Доминируют аффективные симптомы.
Гипертиреоз	Снижение ТТГ, физические признаки.
Кофеиновая или стимуляторная интоксикация	Анамнез употребления.
Аритмия, феохромоцитома	Специфические кардиологические и эндокринные тесты.

7. Обследование и оценка

- GAD-7, HAM-A, PSWQ (англ. Penn State Worry Questionnaire).
- Медицинское и лабораторное (ТТГ, общий анализ крови, оценка употребления кофеина и алкоголя).
- ЭКГ (при наличии кардиальных жалоб).

8. Лечение

8.1 Ступенчатый подход (NICE CG113 · CANMAT 2014)

1. Ступень 1 — психообразование и активное наблюдение.
2. Ступень 2 — самопомощь под руководством (КПТ на основе интернета), группы психообразования.

3. Ступень 3 — КПТ высокой интенсивности или фармакотерапия.
4. Ступень 4 — специализированная служба: комбинированное лечение, рефрактерные случаи.

8.2 Первая линия

Психотерапия — когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Метод с наиболее прочной доказательной базой; 12–20 сессий. Составные части:

- Когнитивная реструктуризация — проверка убеждений о тревоге: суждения вида «беспокойство держит меня наготове» сопоставляются с фактами.
- Работа с непереносимостью неопределённости (модель Dugas M.J.) — пациент намеренно проживает ситуации с неизвестным исходом и повышает свою переносимость.
- Экспозиция — постепенный отказ от избегания ситуаций, вызывающих тревогу; выполнение отложенных решений.
- Тренинг решения проблем — разложить реальную проблему на выполнимые шаги, а неразрешимую принять.
- Релаксация — прогрессивное мышечное расслабление, диафрагмальное дыхание.

Эффект: в обзорах Cuijpers P. и соавторов средний-большой размер эффекта; результат сопоставим с фармакотерапией, а риск рецидива ниже.

Фармакотерапия. Эффект оценивают через 4–6 недель, для полного ответа может потребоваться 8–12 недель:

- СИОЗС — сертралин, эсциталопрам, пароксетин.
- СИОЗСН — венлафаксин, дулоксетин.
- Начальная доза низкая: в первые дни возможно временное усиление тревоги.

Slee A. и соавторы (Lancet 2019), сетевой мета-анализ: дулоксетин, прегабалин и венлафаксин показали высокую эффективность; профиль переносимости различается по препаратам.

8.3 Вторая линия

- Прегабалин — в Европе одобрен по этому показанию; действует быстро, но обладает потенциалом зависимости.
- Буспирон — частичный эффект; как альтернатива бензодиазепину.

- Миртазапин — дополнительный препарат при сопутствующем нарушении сна.
- Кветиапин — вторая линия по CANMAT 2014; применение ограничено метаболическими побочными эффектами.

8.4 Краткосрочное применение и ограничения

- Бензодиазепины — только в остром периоде, не дольше 2–4 недель. Потенциал зависимости высок, длительный приём не рекомендуется.

8.5 Дополнительные методы

- Снижение стресса и когнитивная терапия на основе осознанности (MBSR / MBCT) — 8-недельная групповая программа; при этом расстройстве умеренный эффект. Hofmann S.G. и соавторы, J Consult Clin Psychol 2010, мета-анализ.
- Терапия принятия и ответственности (ACT) — вместо борьбы с симптомом учит жить согласно ценностям вместе с ним; повышает психологическую гибкость. Рандомизированные исследования Roemer L. и соавторов.
- Прикладная релаксация (метод Öst L.G.) — структурированное прогрессивное мышечное расслабление, применяется при появлении триггера тревоги.
- Образ жизни — ограничение кофеина, регулярная физическая активность, гигиена сна, отказ от алкоголя и психоактивных веществ.

8.6 Длительность лечения

- После ремиссии лечение продолжается не менее 12 месяцев.
- При хроническом течении или многократных рецидивах лечение планируется длительным.
- Отмена ступенчатая: резкое прекращение повышает риск возврата.

8.7 Различия между источниками

- NICE CG113 (2011, подтверждено в 2020) — ступенчатый подход; первая линия фармакотерапии СИОЗС и СИОЗСН; бензодиазепин только остро и коротко.
- APA — отдельного руководства по этому расстройству нет; единственный документ семейства относится к паническому расстройству (2009, архивный статус). Поэтому ссылаются на NICE CG113 и CANMAT 2014.

- CANMAT 2014 (Katzman M.A. и соавторы) — первая линия эсциталопрам, сертралин, венлафаксин, дулоксетин; вторая линия прегабалин, буспирон, миртазапин, кветиапин.

9. Прогноз

- Хроническое течение; спонтанная ремиссия редка.
- При адекватном лечении симптомы уменьшаются и функциональное состояние улучшается.
- Коморбидное БДР — маркер плохого прогноза.
- Мониторинг: GAD-7, побочные эффекты, комплаентность, коморбидность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Тревога — это обычное жизненное чувство, а не медицинское состояние»

Доказательства: существует клиническое различие между нормальной тревогой и ГТР — тяжесть, продолжительность (≥ 6 мес.), неспособность контролировать, соматические компоненты, функциональное нарушение. Клинический диагноз ставится на основе конкретных критериев.

Миф 2: «Бензодиазепины — терапия первой линии при ГТР»

Доказательства: NICE CG113, APA, CANMAT — бензодиазепины только для краткосрочного применения (2–4 недели); высокий потенциал зависимости; СИОЗС и СИОЗСН первой линии.

Миф 3: «Только релаксация или йога лечат ГТР»

Доказательства: релаксация и йога оказывают умеренный адъювантный эффект, но при средней и тяжёлой степени требуется КПТ и/или фармакотерапия.

Миф 4: «Антидепрессанты неэффективны при тревоге — они для депрессии»

Доказательства: СИОЗС и СИОЗСН эффективны при тревожных расстройствах; за счёт влияния серотонинергической системы на активность миндалевидного тела. CANMAT 2014, Slee Lancet 2019.

Миф 5: «Пациент может научиться не беспокоиться волевым усилием»

Доказательства: ГТР — это нейробиологическая дизрегуляция; КПТ или фармакотерапия воздействуют на нейробиологическом уровне.

Миф 6: «Ограничение кофеина достаточно для лечения ГТР»

Доказательства: кофеин может усиливать симптомы; ограничение — адъюнктивный шаг, не основное лечение.

Миф 7: «Растительные препараты (кава, валериана, пассифлора) могут заменить стандартное лечение»

Доказательства: кава вызывает серьёзную гепатотоксичность (несколько смертельных случаев — предупреждение FDA); эффект валерианы и пассифлоры слабый; взаимодействие зверобоя.

Миф 8: «Каннабис (CBD) излечивает тревогу»

Доказательства: По CBD есть предварительные исследования, но недостаточно для клинических рекомендаций; THC может усиливать тревогу или вызывать паническую атаку.

Миф 9: «Антидепрессанты придётся принимать пожизненно»

Доказательства: после ремиссии 12 месяцев; затем возможно постепенное прекращение; при рецидиве возобновляется.

Миф 10: «Электросудорожная терапия эффективна при рефрактерном ГТР»

Доказательства: ЭСТ не показана при ГТР; в рефрактерных случаях — смена препарата, комбинация, адъюнкт атипичного антипсихотика.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B00 Generalised anxiety disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG113. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management. 2011, 2020 update.
4. Katzman M.A. et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.

5. Slee A., Nazareth I., Bondaronek P. et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019;393(10173):768–777.
6. Hettema J.M., Neale M.C., Kendler K.S. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry 2001;158(10):1568–1578.
7. Hofmann S.G., Sawyer A.T., Witt A.A., Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression. J Consult Clin Psychol 2010;78(2):169–183.
8. Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B., Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006;166(10):1092–1097.
9. Cuijpers P., Sijbrandij M., Koole S. et al. Psychological treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2014;34(2):130–140.
10. Dugas M.J., Robichaud M. Cognitive-Behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder. New York: Routledge, 2007.
11. Meyer T.J., Miller M.L., Metzger R.L., Borkovec T.D. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990;28(6):487–495.
12. Roemer L., Orsillo S.M. An open trial of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behav Ther 2007;38(1):72–85.
13. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press, 2009.
14. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

МКБ-11 **6B01**	**6B01 ПАНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Panic disorder**
МКБ-10 F41.0	Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]
DSM-5-TR F41.0	Паническое расстройство

1. Определение и нозология

Паническое расстройство (МКБ-11: 6B01; DSM-5-TR: F41.0) — расстройство, характеризующееся повторяющимися, неожиданными паническими атаками (острые эпизоды страха или тревоги, достигающие пика в течение 10 минут) и постоянным беспокойством о повторении этих атак и изменениями в поведении.

2. История

- Da Costa J.M. (1871) «раздражённое сердце» — у солдат Гражданской войны в США.
- Freud (1894) «тревожный невроз».
- Klein D.F. (1964) — выделение антидепрессивного ответа при панических атаках; основа разделения «anxiety neurosis».
- DSM-III (1980) — паническое расстройство — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013), МКБ-11 — агорафобия является отдельной категорией от панического расстройства.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 2–5%; годовая ~2,7% (Kessler R.C. WMH).
- Пол: у женщин в 2 раза выше.
- Начало: молодой-средний взрослый возраст (20–30 лет); второй пик в среднем возрасте.
- Коморбидность: агорафобия 30–50%, БДР 50–60%, другие тревожные расстройства, употребление ПАВ, пролапс митрального клапана.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~40% (Hettema 2001 мета-анализ).
- Нейробиологически — гиперактивность контура миндалевидное тело-locus coeruleus-префронтальная кора; серотонинергическая, норадренергическая, ГАМК-ергическая дисрегуляция.
- Гипотеза чувствительности к CO_2 (Klein D.F. «suffocation false alarm») — пациенты демонстрируют чувствительность к гипервентиляции и накоплению CO_2.
- Личность — тревожная чувствительность (Reiss S.); анамнез сепарационной тревоги в детстве.

5. Клиническая картина

Паническая атака — 4+ симптома, пик за 10 минут

- Сердцебиение, перебои, тахикардия.
- Потливость, дрожь.
- Одышка, чувство нехватки воздуха.
- Ощущение удушья.
- Боль или дискомфорт в груди.
- Тошнота, дискомфорт в животе.
- Головокружение, чувство нереальности.
- Озноб или приливы жара; парестезия.
- Дереализация, деперсонализация.
- Страх потери контроля или «сойти с ума».
- Страх смерти.

Приступ длится 5–20 минут; частые госпитализации (с кардиологическими жалобами).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Повторяющиеся неожиданные панические атаки.

B. В течение ≥ 1 месяца после хотя бы одного приступа один из следующих признаков:

- Постоянное беспокойство о следующем приступе;
- Страх последствий приступов (сердечный приступ, сумасшествие);
- Значительное изменение поведения, связанное с приступом (избегание, поведение безопасности).

C. Исключение вещества или медицинского состояния

D. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (социальная тревога, ОКР, ПТСР, сепарация).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — агорафобия — отдельный диагноз (F40.00); может возникать совместно.

- МКБ-11 — агорафобия отдельным кодом 6B02; но месячного срока беспокойства не требует — достаточно «стойкой тревоги».
- NICE CG113 — диагностика после исключения соматической причины.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + анамнез приступов.
2. SCID-5, MINI.
3. PDSS (англ. Panic Disorder Severity Scale), GAD-7 — коморбидность.
4. Соматическое: ЭКГ, ТТГ, общий анализ крови, глюкоза, кофеин/стимуляторы; подозрение на феохромоцитому — 24-часовая моча на метанефрины.
5. Коморбидность (агорафобия, БДР, употребление ПАВ).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Агорафобия (6B02)	Области избегания основные; возможна коморбидность.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Триггер социальной оценки.
Специфическая фобия (6B03)	Конкретный объект/ситуация.
ПТСР (6B40)	Анамнез травмы, интрузии.
Гипертиреоз	TSH.
Феохромоцитома	Метанефрины мочи.
Аритмия (СВТ)	Холтеровское мониторирование ЭКГ.
Вещество-индуцированное (кофеин, кокаин)	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- PDSS, ACQ (англ. Agoraphobic Cognitions), BSQ (англ. Body Sensations Questionnaire).
- ЭКГ, ТТГ, общий анализ крови, глюкоза.
- Холтеровское мониторирование ЭКГ (подозрение на аритмию).
- Токсикологический скрининг.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG113 · CANMAT 2014)

1. КПТ при паническом расстройстве — психообразование, интероцептивная экспозиция (переносимость телесных сигналов без катастрофизации), экспозиция in vivo (избегаемые ситуации), когнитивная реструктуризация. 12–16 сессий. Доказательства: обзоры Cuijpers P. et al. — большой эффект.
2. Фармакотерапия: СИОЗС (сертралин, пароксетин, флуоксетин — показание FDA при паническом расстройстве; эсциталопрам off-label) или СИОЗСН (венлафаксин) — первая линия. Начало с низкой дозы (дрожь, эффект «активации» могут усилить панику).
3. Бензодиазепин (клоназепам, лоразепам) — краткосрочная начальная стабилизация; ≤ 4 недели; потенциал зависимости.
4. Длительность лечения — ≥ 12 месяцев после ремиссии.
5. Ограничение кофеина, алкоголя, марихуаны.

8.2 Методики лечения

1. КПТ для паники — Кларк (Clark D.M.), Барлоу (Barlow D.) — Интероцептивная экспозиция (преднамеренное создание телесных ощущений — гипервентиляция, вращение, кофеин) + экспозиция in vivo + когнитивная реструктуризация. Доказательства: РКИ Barlow D.H. et al. JAMA 2000.
2. Терапия контроля паники (PCT — Panic Control Treatment) — Барлоу (Barlow D.) — мануализированный протокол из 11 сессий; широко используется в США.
3. Шкала тяжести панического расстройства (англ. Panic Disorder Severity Scale, PDSS) — Шир (Shear M.K.) — 7 пунктов; начальные показатели и наблюдение.
4. Интернет-основанная КПТ (англ. iCBT — internet-based CBT) — РКИ Andersson G. et al. — показали сравнительную эффективность с индивидуальной КПТ.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG113 — КПТ и СИОЗС первой линии; бензодиазепины только краткосрочно.
- Рекомендации APA по тревоге — КПТ и фармакотерапия одинаково эффективны.

- Mitte K. J Affect Disord 2005 мета-анализ — КПТ превосходит плацебо и лист ожидания.

9. Прогноз

- Ремиссия на фоне лечения у большинства пациентов.
- Коморбидная агорафобия или БДР — плохой прогноз.
- Раннее вмешательство предотвращает закрепление избегающего поведения.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Паническая атака — это сердечный приступ»

Доказательства: симптомы могут быть схожи; однако паническая атака кратковременна, после обращения в клинику ЭКГ в норме. Гипотеза Клейна «ложная тревога удушья» объясняет механизм.

Миф 2: «Пациент может контролировать панику по собственной воле»

Доказательства: паника — это нейробиологическая дисрегуляция; требуется КПТ и фармакотерапия.

Миф 3: «Бензодиазепины — основное лечение паники»

Доказательства: для краткосрочной стабилизации; потенциал зависимости; СИОЗС и КПТ — первая линия.

Миф 4: «Пациента с паникой нужно ограждать от панико-провоцирующих ситуаций»

Доказательства: избегание усиливает симптомы; экспозиция является основным терапевтическим механизмом.

Миф 5: «Растительные препараты (кава, валериана) безопасны при панике»

Доказательства: кава гепатотоксична (предупреждение FDA); стандартное лечение предпочтительнее.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B01 Panic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. NICE CG113. 2011/2020.
4. Katzman M.A. et al. CANMAT 2014. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.
5. Barlow D.H. et al. Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder. JAMA 2000;283(19):2529–2536.
6. Shear M.K. et al. Multicenter collaborative panic disorder severity scale. Am J Psychiatry 1997;154(11):1571–1575.
7. Klein D.F. False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions. Arch Gen Psychiatry 1993;50(4):306–317.
8. Clark D.M. A cognitive approach to panic. Behav Res Ther 1986;24(4):461–470.
9. Andersson G., Cuijpers P., Carlbring P. et al. Guided internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry 2014;13(3):288–295.
10. Reiss S., Peterson R.A., Gursky D.M., McNally R.J. Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behav Res Ther 1986;24(1):1–8.
11. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

МКБ-11 **6B02**	**6B02 АГОРАФОБИЯ** **Agoraphobia**
МКБ-10 F40.0	Агорафобия
DSM-5-TR F40.00	Агорафобия

1. Определение и нозология

Агорафобия (МКБ-11: 6B02; DSM-5-TR: F40.00) — чрезмерный страх и избегание ситуаций, из которых затруднено бегство или где невозможно получить помощь (общественный транспорт, открытые пространства, закрытые помещения, толпа, выход из дома в одиночку). Пациент боится развития панической атаки или других инвалидизирующих симптомов.

2. История

- Westphal C. (1872) «агорафобия» — греч. «агора» (площадь) + страх.
- DSM-III (1980) — совместно с паническим расстройством.
- DSM-5 (2013), МКБ-11 — агорафобия официально оформлена как ОТДЕЛЬНАЯ категория от панического расстройства (коморбидность возможна, но на основе отдельных диагнозов).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1–2,5 %.
- Пол: у женщин в 2 раза выше.
- Начало: молодой-средний взрослый возраст.
- Коморбидность: паническое расстройство 50%, БДР, другая тревога, употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~48% (Mosing M.A. et al. Depress Anxiety 2009;26(11):1004–1011).
- Классическое обусловливание — перенос страха на конкретную ситуацию, когда паническая атака происходит в этой ситуации.
- Когнитивные факторы — катастрофизация («помощь не придёт»).

5. Клиническая картина

Типичные избегаемые ситуации:

- Общественный транспорт (автобус, поезд, самолёт).
- Открытые пространства (площадь, мост, открытая местность).
- Закрытые пространства (магазин, кинотеатр).
- Стоять в очереди или в толпе.
- Выход из дома в одиночку.

Пациент демонстрирует избегание, поведение «безопасности» (компаньон, мобильный телефон, ношение лекарств), частичную или полную изоляцию дома. В тяжёлых случаях он вообще не выходит из дома.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Значительный страх или тревога в ≥ 2 из следующих пяти категорий:

1. Общественный транспорт;
2. Открытые пространства;
3. Закрытые пространства;
4. Очередь или толпа;
5. Выход из дома в одиночку.

B. Эти ситуации вызывают страх, так как побег затруднен или помощь не придёт — при возникновении панической атаки или инвалидизирующих симптомов.

C. Ситуации почти всегда вызывают страх.

D. Активное избегание, требование партнёра или перенесение с острым дискомфортом.

E. Страх, несоразмерный ситуации.

F. Стойкий страх или избегание (≥ 6 месяцев, DSM-5-TR).

G. Значительные функциональные нарушения

H. Не объясняется лучше медицинским или другим психическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — агорафобия отдельно от панического расстройства; коморбидно выставляются оба диагноза.
- NICE CG113 — агорафобия с паническим расстройством: аналогичное вмешательство.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — избегаемые ситуации, анамнез панических атак, функциональная нагрузка.
2. SCID-5, MINI.
3. Mobility Inventory for Agoraphobia (MIA) — тяжесть избегания.
4. Коморбидность (паника, БДР, ПАВ).
5. Медицинское обследование.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Паническое расстройство (6B01)	Приступ является основным; области избегания ограничены или отсутствуют.
Специфическая фобия (6B03)	Конкретный единичный объект/ситуация.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Страх социальной оценки.
ПТСР (6B40)	Анамнез травмы.
Тревога разлуки (6B05)	Доминирует страх разлуки с близким человеком.

7. Обследование и оценка

- MIA, ACQ, BSQ.
- GAD-7, PHQ-9, PDSS — коморбидность.

8. Лечение

1. КПТ — основана на экспозиции; ступенчатая экспозиция in vivo к избегаемым ситуациям; когнитивная реструктуризация. Первая линия; большой эффект.
2. СИОЗС или СИОЗСН — фармакотерапия первой линии (как при паническом расстройстве).
3. Бензодиазепин — только краткосрочно.
4. Экспозиция в виртуальной реальности — альтернативное средство; доказательная база развивается.
5. Длительность лечения — ≥ 12 месяцев после ремиссии.

8.1 Методики лечения

1. Экспозиция in vivo — Ступенчатый подход — пациент структурированно входит в избегаемые ситуации; терапевт может сопровождать (экспозиция с поддержкой терапевта). Метод первой линии.
2. Терапия экспозицией в виртуальной реальности (англ. Virtual Reality Exposure Therapy, VRET) — В клиническом контексте создаётся

виртуальная среда; альтернатива экспозиции in vivo. Botella C. et al. Behav Res Ther 2007.

3. КПТ при паническом расстройстве (Clark, Barlow) — адаптирована для агорафобии — Интероцептивная экспозиция + экспозиция in vivo.
4. Опросник мобильности (MIA — Mobility Inventory) — Чемблисс (Chambless D.L.) — 27 ситуаций; степень избегания в одиночку и с партнёром.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG113 — КПТ и СИОЗС.
- CANMAT 2014 — то же.
- Sánchez-Meca J. et al. Clin Psychol Rev 2010 мета-анализ — КПТ на основе экспозиции показала большой эффект.

9. Прогноз

- Экспозиция с КПТ — у большинства пациентов функциональное восстановление.
- Без раннего вмешательства — хронификация: пациент перестаёт выходить из дома.
- Коморбидное БДР (MDD) — неблагоприятный прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациента с агорафобией не следует помещать в пугающие ситуации»

Доказательства: избегание усиливает симптомы; экспозиция является основным терапевтическим механизмом.

Миф 2: «Агорафобия — это „подтип“ панического расстройства»

Доказательства: DSM-5-TR и МКБ-11 — отдельные диагностические категории; коморбидность возможна, но может возникать и без другого.

Миф 3: «Пациент „ленив“, не хочет выходить»

Доказательства: агорафобия — клиническое расстройство с нейробиологической и поведенческой основой; не является проблемой воли или характера.

Миф 4: «Только лекарство излечивает агорафобию, терапия не нужна»

Доказательства: устойчивая ремиссия без экспозиционной КПТ затруднительна; фармакотерапия сама по себе не изменяет избегающее поведение.

Миф 5: «Заказ через интернет или дистанционное обучение — подходящий образ жизни для пациента с агорафобией»

Доказательства: Приспособление даёт краткосрочное облегчение, но усиливает заболевание и снижает функциональный уровень.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B02 Agoraphobia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG113. 2011/2020.
4. Sánchez-Meca J. et al. Psychological treatment of panic disorder with or without agoraphobia: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2010;30(1):37–50.
5. Chambless D.L., Caputo G.C., Jasin S.E. et al. The Mobility Inventory for Agoraphobia. Behav Res Ther 1985;23(1):35–44.
6. Botella C., García-Palacios A., Villa H. et al. Virtual reality exposure in the treatment of panic disorder and agoraphobia. Clin Psychol Psychother 2007;14(3):164–175.

МКБ-11 **6B03**	**6B03 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОБИЯ** **Specific phobia**
МКБ-10 F40.2	Специфические (изолированные) фобии
DSM-5-TR F40.2xx	Специфическая фобия

1. Определение и нозология

Специфическая фобия (МКБ-11: 6B03; DSM-5-TR: F40.2xx) — резкий, иррациональный страх и избегание определённого объекта или ситуации

(животные, кровь-инъекции, высота, полёт, закрытое помещение). Пациент обычно осознаёт, что страх чрезмерен.

2. История

- Гиппократ (V в. до н.э.) — описания фобий.
- Westphal C. (1872) — систематическая классификация.
- Marks I.M. (1969) — исследования систематической десенсибилизации и экспозиции.
- DSM-5 (2013), МКБ-11 — подтипы: животные, природная среда, кровь-инъекции-травмы, ситуационный, другой.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость 7–12% — одно из самых частых тревожных расстройств.
- Пол: у женщин в 2–3 раза выше (кровяно-инъекционный подтип — исключение, разница мала).
- Начало: детство (животные, кровь-инъекции), молодой взрослый возраст (ситуационные).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~30% (Hettema 2001).
- Классическое обусловливание (Watson J.B. «Little Albert», 1920), викарное обучение, передача информации.
- Биологическая подготовленность (Seligman M.E. «preparedness») — генетическая предрасположенность к страху перед филогенетически значимыми стимулами (напр., змеи, пауки).
- При подтипе кровь-инъекции — вазовагальная реакция (брадикардия, гипотензия, обморок) отличается от других фобий.

5. Клиническая картина

Подтипы

- Животные — паук, змея, собака, насекомые.
- Естественная среда — высота, вода, буря.
- Кровь — инъекция — травма — вазовагальная реакция (с потерей сознания).

- Ситуационная — полёт, лифт, туннель, вождение, закрытое помещение.
- Другое — удушье, рвота, клоуны, определённые звуки.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Острый страх или тревога по отношению к конкретному объекту или ситуации.

B. Объект/ситуация почти всегда вызывает страх.

C. Активное избегание или перенесение с острым дискомфортом.

D. Страх, несоразмерный реальному риску.

E. Длится ≥ 6 месяцев (DSM-5-TR).

F. Значительный дистресс или функциональные нарушения

G. Не объясняется лучше другим психическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — квалификатор подтипа обязателен.
- NICE — отдельного руководства по специфической фобии нет; применяются общие принципы тревожных расстройств.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. FSS (англ. Fear Survey Schedule), подшкалы специфической фобии.
3. Оценка функциональной нагрузки.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Паническое расстройство (6B01)	Приступ непредсказуем.
Агорафобия (6B02)	Множественные ситуационные категории.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Страх социальной оценки.

Состояние	Отличительный признак
ОКР (6B20)	Обсессия первична; страх загрязнения с компульсиями.
ПТСР (6B40)	Анамнез травмы.
Ипохондрия (6B23)	Страх болезни.

7. Обследование и оценка

- FSS, шкала специфической фобии.
- BAT (англ. Behavioral Avoidance Test) — степень приближения пациента к фобическому объекту.

8. Лечение

1. Экспозиционная терапия — первая линия и наиболее эффективна. Односеансовая структурированная экспозиция длительностью 2–3 часа (Öst L.G. «one-session treatment») эффективна для большинства животных и ситуационных фобий.
2. Ступенчатая экспозиция in vivo — адаптированная к темпу пациента.
3. Экспозиция в виртуальной реальности — особенно подходит для полётов, высоты.
4. При подтипе кровь-инъекция — applied tension (Öst) — пациента обучают напрягать мышцы, предотвращая вазовагальный ответ.
5. Фармакотерапия не играет основной роли; бензодиазепины — только краткосрочный адъюнкт для конкретного события (например, перед полетом); иногда могут снижать эффективность КПТ-экспозиции.
6. D-циклосерин адъюнкт — может усиливать эффективность экспозиции (доказательная база развивается).

8.1 Методики лечения

1. Односеансовая экспозиция (англ. One-Session Treatment) — Öst (Öst L.G.) — 2–3-часовая структурированная экспозиция in vivo; эффективность 80–90% для большинства животных и ситуационных фобий. Öst L.G. Behav Res Ther 1989.
2. Систематическая десенсибилизация (англ. Systematic Desensitization) — Вольпе (Wolpe J.) — Исторический метод — релаксация + постепенный фобический стимул; превзойдён экспозицией in vivo.

3. Applied Tension (Öst — кровь-инъекция) — Напрягать мышцы на 10–15 секунд предотвращает вазовагальный обморок; при специфической фобии крови-инъекций.
4. Терапия экспозицией в виртуальной реальности (англ. Virtual Reality Exposure Therapy, VRET) — Для фобий полета, высоты, пауков. Обзоры Botella C. et al.
5. D-циклосерин адъюнктивно — Парциальный агонист NMDA-рецепторов; может усиливать обучение угашению (extinction) при приёме перед сеансом экспозиции. Обзоры Hofmann S.G. et al. — умеренные доказательства.

8.2 Различия между источниками

- Öst L.G. — односеансовая экспозиция демонстрирует эффективность 80–90% (Behav Res Ther 1989).
- Wolitzky-Taylor K.B. et al. Clin Psychol Rev 2008 мета-анализ (33 РКИ) — экспозиция даёт большой эффект против листа ожидания и средний против плацебо; контакт in vivo превосходит другие формы экспозиции. С фармакотерапией этот мета-анализ не сравнивал.
- Рекомендации APA по тревоге — экспозиция первой линии.

9. Прогноз

- Экспозиция с КПТ — у большинства пациентов ремиссия.
- Без лечения — хронизация.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Специфическая фобия — это только детская фобия, у взрослых не требует лечения»

Доказательства: специфическая фобия во взрослом возрасте также вызывает функциональные нарушения (избегание полетов — профессиональные ограничения; избегание медицинских процедур — риск для здоровья).

Миф 2: «„Принуждение“ пациента к фобическому объекту вызывает травму»

Доказательства: Правильно применяемая ступенчатая экспозиция безопасна и высокоэффективна; с согласия пациента и в его темпе.

Миф 3: «Гипнотерапия или НЛП быстро излечивают фобии»

Доказательства: систематическая доказательная база ограничена; экспозиционный подход — золотой стандарт.

Миф 4: «Пациент может вести нормальную жизнь, полностью избегая фобического объекта»

Доказательства: избегание усиливает фобию; ситуационные фобии (перелёты, лифты) создают медицинские и социальные ограничения.

Миф 5: «Бензодиазепин — эффективное лечение для специфических ситуаций, таких как полёт»

Доказательства: возможно в краткосрочной адъюнктивной роли, но не является долгосрочным решением; может снижать эффективность КПТ/экспозиции (state-dependent learning).

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B03 Specific phobia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Öst L.G. One-session treatment for specific phobias. Behav Res Ther 1989;27(1):1–7.
4. Wolitzky-Taylor K.B., Horowitz J.D., Powers M.B., Telch M.J. Psychological approaches in the treatment of specific phobias: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2008;28(6):1021–1037.
5. Hettema J.M., Neale M.C., Kendler K.S. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry 2001;158(10):1568–1578.
6. Wolpe J. Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Stanford: Stanford University Press, 1958.
7. Seligman M.E.P. Phobias and preparedness. Behav Ther 1971;2(3):307–320.
8. Hofmann S.G. Enhancing exposure-based therapy from a translational research perspective. Behav Res Ther 2007;45(9):1987–2001.
9. Botella C., Fernández-Álvarez J., Guillén V. et al. Recent progress in virtual reality exposure therapy for phobias: a systematic review. Curr Psychiatry Rep 2017;19(7):42.

МКБ-11 **6B04**	**6B04 СОЦИАЛЬНОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО** **Social anxiety disorder**
МКБ-10 F40.1	Социальные фобии
DSM-5-TR F40.10	Социальное тревожное расстройство (социальная фобия)

1. Определение и нозология

Социальное тревожное расстройство (МКБ-11: 6B04 Social Anxiety Disorder; DSM-5-TR: F40.10) — это выраженный и устойчивый страх негативной оценки или унижения со стороны других в социальных ситуациях. Пациент избегает таких ситуаций, как выступление, взаимодействие и нахождение под наблюдением.

2. История

- Janet P. (1903) — «phobie des situations sociales».
- Marks I.M., Gelder M.G. (1966) — отделение социальной фобии от агорафобии.
- DSM-III (1980) — «Social Phobia» — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — «Social Anxiety Disorder» — более широкий и точный термин; добавлен подтип «только при выступлениях».
- МКБ-11 — параллельно.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 7–13% (Kessler WMH; культурная вариабельность).
- Пол: относительно выше у женщин, но мужчины чаще обращаются в клинику.
- Начало: подростковый возраст (в среднем 13 лет) — одно из самых ранних тревожных расстройств.

- Коморбидность: БДР 60%, другие тревожные расстройства, употребление алкоголя (как самолечение).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~30–40%.
- Поведенческое торможение (Kagan J.) — детский темперамент как сильный фактор риска.
- Нейробиологически — гиперактивность миндалевидного тела в ответ на социальные стимулы; серотонинергическая дисрегуляция.
- Когнитивные — сфокусированное на себе внимание, негативный образ себя, катастрофизация (модель Clark D.M., Wells A.).
- Среда — детская виктимизация сверстниками, гиперопека родителей.

5. Клиническая картина

- Пугающие ситуации — выступление, задавание вопросов, совместный обед, письмо или еда на глазах у других, общественный туалет, разговор по телефону.
- Соматические — покраснение, дрожь, потливость, тахикардия, сухость во рту, дрожание голоса.
- Когнитивные — негативные мысли о себе, «пост-событийная обработка» (длительная самокритика после ситуации).
- Избегание и поведение «безопасности» (избегание зрительного контакта, малоречивость, употребление алкоголя).
- Функциональная нагрузка — академическое и профессиональное развитие, друзья, романтические отношения.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Выраженный страх в одной или нескольких социальных ситуациях — быть под наблюдением или оценкой других.

B. Пациент боится опозориться, быть отвергнутым другими, причинить боль другим.

C. Ситуации почти всегда вызывают страх.

D. Перенесение с избеганием или острой тревогой.

E. Страх, несоразмерный социальной ситуации.

F. Длится ≥ 6 месяцев (DSM-5-TR).

G. Функциональное нарушение.

H. Не полностью объясняется другим психическим расстройством или медицинским состоянием.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — квалификатор подтипа «performance only» (ограничен только ситуациями выступления).
- МКБ-11 — срок «не менее нескольких месяцев» (в DSM-5-TR — 6 месяцев); у детей оценивается также среда сверстников, не только общение со взрослыми.
- NICE CG159 (Социальное тревожное расстройство: распознавание, оценка и лечение, 2013) — индивидуальная КПТ первой линии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. SCID-5, MINI.
3. Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), SPIN (англ. Social Phobia Inventory) — шкала и мониторинг.
4. Коморбидность (БДР, другая тревога, употребление алкоголя).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Агорафобия (6B02)	Затруднен побег, нет помощи; нет социальной оценки.
Специфическая фобия (6B03)	Конкретный объект/ситуация.
Паническое расстройство (6B01)	Приступ непредсказуем.
Избегающее расстройство личности	Стойкая модель, более широкая; коморбидность часта.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Социально-коммуникативный дефицит с ранним началом; социальный интерес вариабелен.
Избирательный мутизм (6B06)	Отсутствие речи в специфическом контексте.

Состояние	Отличительный признак
Телесное дисморфическое расстройство (6B21)	Тревога, связанная с внешностью.

7. Обследование и оценка

- LSAS — золотая стандартная шкала (24 пункта).
- SPIN — краткий скрининг (17 пунктов).
- BFNE (англ. Brief Fear of Negative Evaluation).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG159 · CANMAT 2014)

1. Индивидуальная КПТ (модель Clark D.M.) первой линии — перенаправление сфокусированного на себе внимания, видеообратная связь, поведенческие эксперименты, когнитивная реструктуризация, экспозиция in vivo. 12–16 сеансов. NICE CG159 — индивидуальная КПТ превосходит групповую КПТ.
2. СИОЗС и СИОЗСН — фармакотерапия первой линии — эсциталопрам, сертралин, пароксетин (одобрены FDA), венлафаксин (одобрен FDA).
3. Вторая линия — моклобемид (RIMA, одобрен в Европе), прегабалин (ограниченные доказательства), габапентин.
4. Бензодиазепин — только для конкретной ситуации (например, перед выступлением) краткосрочно; не постоянно.
5. β-блокатор (пропранолол) — при подтипе «выступление» за 1–2 часа до выхода; неэффективно при социальном взаимодействии.
6. Длительность лечения — ≥ 12 месяцев после ремиссии.
7. Употребление алкоголя — в форме самолечения; особое внимание и параллельное вмешательство.

8.2 Методики лечения

1. Модель КПТ Кларка (Clark) — Специально разработана для социальной тревоги; внешнее перенаправление самофокусированного внимания, видеообратная связь (видение собственного выступления глазами других), поведенческие эксперименты (проверка пугающих убеждений), экспозиция in vivo. Доказательства: Clark D.M. et al. J Consult Clin Psychol 2003 РКИ — экспериментальная индивидуальная КПТ превосходит другие вмешательства.

2. Групповая КПТ Хаймберга (Heimberg) — Групповой формат из 12 сессий; модель Heimberg R.G. Эффективно, но относительно слабее индивидуальной КПТ (NICE CG159).
3. Интернет-основанная КПТ (англ. iCBT — internet-based CBT) — РКИ Andersson G. et al. — iCBT с поддержкой терапевта сопоставима с индивидуальной КПТ.
4. Шкала социальной тревоги Либовица (англ. Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS) — 24 пункта (11 взаимодействие + 13 выступление); каждый пункт оценивается и по страху/тревоге, и по избеганию (48 оценок, 0–144 балла, 4 субшкалы); золотой стандарт.
5. Опросник социальной фобии (SPIN — Social Phobia Inventory) — 17 пунктов; краткий скрининг.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG159 (2013) — индивидуальная КПТ (Clark) первой линии; СИОЗС альтернатива; групповая КПТ или самопомощь могут подойти некоторым пациентам.
- CANMAT 2014 — первая линия: эсциталопрам, сертралин, пароксетин, венлафаксин.
- Mayo-Wilson E. et al. Lancet Psychiatry 2014 сетевой мета-анализ — индивидуальная КПТ имеет наибольший эффект; СИОЗС — второй.

9. Прогноз

- Хроническое течение, высокий риск рецидива без лечения.
- Значительное улучшение у большинства пациентов при КПТ и СИОЗС.
- Раннее начало и коморбидное избегающее расстройство личности — маркер плохого прогноза.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Социальная тревога — это обычная „застенчивость“, не требующая лечения»

Доказательства: социальное тревожное расстройство сопровождается функциональными нарушениями, академическими и профессиональными ограничениями, риском депрессии и употребления алкоголя; оценивается как медицинское состояние.

Миф 2: «Пациент может вести нормальную жизнь, полностью избегая социальных ситуаций»

Доказательства: избегание усиливает симптомы и приводит к изоляции; экспозиция является основным терапевтическим механизмом.

Миф 3: «Алкоголь „лечит“ социальную тревожность»

Доказательства: Алкоголь даёт краткосрочное облегчение, но в долгосрочной перспективе усиливает тревогу и приводит к расстройству употребления алкоголя; распространённость этой комбинации 20–40%.

Миф 4: «Бензодиазепины эффективны при социальной тревоге в долгосрочной перспективе»

Доказательства: краткосрочный эффект; потенциал зависимости; КПТ или СИОЗС предпочтительнее.

Миф 5: «Пропранолол эффективен при всех формах социальной тревоги»

Доказательства: пропранолол эффективен только при подтипе выступления (перед выступлением); в социальном взаимодействии (приём, неформальное общение) неэффективен.

Миф 6: «У пациента избегающее расстройство личности, поэтому лечение неэффективно»

Доказательства: даже у пациента с коморбидным избегающим расстройством личности могут наблюдаться ответы на стандартные вмешательства; долгосрочная КПТ или схема-терапия.

Миф 7: «Только гипнотерапия или НЛП быстро излечивают»

Доказательства: доказательная база отсутствует; КПТ и СИОЗС — золотой стандарт.

Миф 8: «Каннабис (CBD) — безопасная альтернатива при социальной тревоге»

Доказательства: имеются предварительные исследования, но недостаточно для клинических рекомендаций; ТНС может усиливать тревогу.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B04 Social anxiety disorder. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG159. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment. 2013.
4. Katzman M.A. et al. CANMAT 2014. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.
5. Mayo-Wilson E. et al. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014;1(5):368–376.
6. Clark D.M., Ehlers A., McManus F. et al. Cognitive therapy versus fluoxetine in generalized social phobia: a randomized placebo-controlled trial. J Consult Clin Psychol 2003;71(6):1058–1067.
7. Liebowitz M.R. Social phobia. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1987;22:141–173.
8. Heimberg R.G., Becker R.E. Cognitive-Behavioral Group Therapy for Social Phobia. New York: Guilford Press, 2002.
9. Kagan J., Reznick J.S., Snidman N. Biological bases of childhood shyness. Science 1988;240(4849):167–171.
10. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press, 2009.
11. Andersson G., Cuijpers P., Carlbring P. et al. Guided internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry 2014;13(3):288–295.

МКБ-11 **6B05**	**6B05** **СЕПАРАЦИОННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО** **Separation anxiety disorder**
МКБ-10 F93.0	Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой
DSM-5-TR F93.0	Тревожное расстройство разлуки

1. Определение и нозология

Сепарационное тревожное расстройство (МКБ-11: 6B05; DSM-5-TR: F93.0) — чрезмерный страх и тревога, не соответствующие уровню развития, связанные с разлукой с лицом привязанности (обычно родителем) или домом. В DSM-5 впервые может диагностироваться и у взрослых (в DSM-IV было ограничено детством).

2. История

- Bowlby J. (1969–1980) — теория привязанности.
- DSM-III (1980) — как расстройство детского возраста.
- DSM-5 (2013) — возрастное ограничение снято; диагноз возможен и у взрослых.

3. Эпидемиология

- Распространённость у детей: ~4%; у подростков ~1,6%; у взрослых ~1,9% (Kessler R.C. NCS-R).
- Пол: относительно выше у женщин.
- Начало: типично детство (6–9 лет); рецидив или персистирование во взрослой форме.
- Коморбидность: специфическая фобия, паническое расстройство, ГТР, БДР, избегание школы.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~40%.
- Стили привязанности (insecure attachment), родительская гиперопека.
- История утрат или болезней близких.
- Стрессовые события (переезд, смена школы, разлука с родителями).

5. Клиническая картина

- Чрезмерное беспокойство о вреде или потере лица привязанности.
- Избегание выхода из дома или разлуки с привязанным лицом.
- Страх остаться одному.
- Стойкий отказ спать вне дома или засыпать без лица привязанности рядом (своя спальня, чужой дом).
- Кошмары о переезде или разлуке.

- Соматические жалобы при антиципации разлуки (боль в животе, головная боль, тошнота).
- У детей — избегание школы.
- У взрослых — страх разлуки с партнёром или детьми, чрезмерное проверяющее поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 3 из следующих симптомов:

1. Чрезмерная тревога при разлуке с лицом привязанности или при её предвосхищении;
2. Постоянное беспокойство о потере или вреде лицу привязанности;
3. Страх события, которое приведёт к разлуке с лицом привязанности;
4. Избегание дома, школы, работы из-за страха разлуки;
5. Страх оставаться одному без лица привязанности;
6. Отказ засыпать без лица привязанности рядом;
7. Кошмары, связанные с разлукой;
8. Соматические жалобы при ожидании разлуки.

B. Длительность: у детей/подростков ≥ 4 недели; у взрослых ≥ 6 месяцев.

C. Значительный дистресс или функциональные нарушения.

D. Не объясняется лучше другим психическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — у взрослых длительность ≥ 6 месяцев; у детей ≥ 4 недель.
- МКБ-11 — срок иной: «не менее нескольких месяцев»; деления DSM-5-TR на 4 недели у детей и 6 месяцев у взрослых нет, отдельного возрастного квалификатора тоже нет.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (у детей также с родителем).
2. Стандартизированное интервью (K-SADS у детей, SCID-5 у взрослых).
3. Шкала — SAAS (англ. Separation Anxiety Assessment Scale).
4. Скрининг коморбидности.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ГТР (6B00)	Множественные сферы беспокойства.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Социальная оценка доминирует.
Агорафобия (6B02)	Избегание ситуаций, из которых затруднен побег.
Паническое расстройство (6B01)	Приступ непредсказуем.
Избирательный мутизм (6B06)	Отсутствие речи в специфическом контексте.
Расстройство поведения (избегание школы)	Компонент антисоциального поведения.
Избегающее расстройство личности	Стойкая модель распространяется на все отношения.

7. Обследование и оценка

- SAAS, K-SADS, MASC (англ. Multidimensional Anxiety Scale for Children).
- Коморбидность (депрессия, другая тревога).

8. Лечение

1. КПТ (у детей программы Coping Cat, FRIENDS; у взрослых стандартная КПТ) — основана на экспозиции; участие родителей у детей критично. Первая линия.
2. СИОЗС — при среднетяжёлых/тяжёлых случаях или при неэффективности КПТ; сертралин, флуоксетин (у детей).
3. Программы возвращения в школу (школьный отказ) — ступенчатая экспозиция.
4. Участие семьи — психообразование родителей, избегание частых телефонных звонков/визитов (аккомодация усиливает симптомы).

8.1 Методики лечения

1. Программа «Coping Cat» — Кендал (Kendall P.C.) — Мануализированная КПТ для детей 7–17 лет — 16 сессий,

психообразование + релаксация + экспозиция + система поощрений (план FEAR).

2. Программа FRIENDS — Баррет (Barrett P.M.) — Разработана в Австралии; групповая КПТ при тревожных расстройствах у детей и подростков.
3. Ступенчатое возвращение в школу — Структурированная экспозиция — ребёнок постепенно возвращается в школьную среду; координация родителей и школьного персонала.
4. Снижение родительской аккомодации — Программа SPACE (англ. Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions — Lebowitz E.) — изменение аккомодации родителя к тревоге ребёнка.

8.2 Различия между источниками

- AACAP Practice Parameter (Connolly S.D., Bernstein G.A. 2007) — КПТ и СИОЗС эффективны у детей.
- NICE — общие рекомендации при детской тревоге (КПТ первой линии).
- Walkup J.T. et al. NEJM 2008 (CAMS — Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study) — комбинация КПТ + сертралин превосходит монотерапию.

9. Прогноз

- Ремиссия у большинства детей при ранней КПТ.
- Без лечения — риск других тревожных расстройств и депрессии во взрослом возрасте.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Тревога разлуки бывает только в детстве»

Доказательства: DSM-5 — сепарационное тревожное расстройство диагностируется и у взрослых — распространённость ~1,9%.

Миф 2: «Родитель должен выполнять любую просьбу ребёнка, чтобы его „успокоить“»

Доказательства: Приспособление усиливает симптомы; рекомендуется программа SPACE или обучение родителей.

Миф 3: «Тревога разлуки — результат плохого воспитания»

Доказательства: наследуемость ~40%; привязанность и среда — модуляторы. Объяснение «плохим воспитанием» стигматизирующее и ошибочное.

Миф 4: «Ребёнка нужно оставить одного, чтобы „привык“ — этот жесткий подход излечивает»

Доказательства: «Флудинг» или неконтролируемая экспозиция могут вызвать травму; рекомендуется ступенчатый, структурированный подход.

Миф 5: «Вылечиться можно только лекарствами»

Доказательства: КПТ первой линии; СИОЗС при среднетяжёлом течении или в комбинации.

Миф 6: «Избегание школы — это слабость характера, требующая дисциплины»

Доказательства: избегание школы — клинический симптом тревоги; подход, основанный на наказании, усиливает расстройство.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B05 Separation anxiety disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Connolly S.D., Bernstein G.A. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(2):267–283.
4. Walkup J.T. et al. CAMS: Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. NEJM 2008;359(26):2753–2766.
5. Kendall P.C. Treating anxiety disorders in children: results of a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol 1994;62(1):100–110.
6. Lebowitz E.R. et al. Parent-Based Treatment as Efficacious as Cognitive-Behavioral Therapy for Childhood Anxiety: A Randomized Noninferiority Study of Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2020;59(3):362–372.
7. Barrett P.M., Turner C. Prevention of anxiety symptoms in primary school children. Br J Clin Psychol 2001;40(4):399–410.
8. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

МКБ-11 **6B06**	**6B06 СЕЛЕКТИВНЫЙ МУТИЗМ** **Selective mutism**
МКБ-10 F94.0	Элективный мутизм
DSM-5-TR F94.0	Селективный мутизм

1. Определение и нозология

Селективный мутизм (МКБ-11: 6B06; DSM-5-TR: F94.0) — стойкое неговорение ребёнка в определённых социальных ситуациях (например, в школе), несмотря на полное овладение речью, при нормальной речи в других контекстах (например, дома). Типичное тревожное расстройство детского возраста, иногда ошибочно принимаемое за «чрезмерную застенчивость».

2. История

- Kussmaul A. (1877) — «aphasia voluntaria».
- Tramer M. (1934) — «элективный мутизм» — выражение добровольного выбора пациента.
- DSM-IV (1994) — заменён термином «селективный» (не добровольный, а из-за социальной тревоги).
- DSM-5 (2013) — перенесён в категорию тревожных расстройств.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 0,7–1% у детей школьного возраста (Bergman R.L. et al. JAACAP 2002).
- Пол: относительно выше у девочек (1,5–2:1).
- Начало: 2–5 лет; типично выявляется при начале посещения школы.
- Коморбидность: социальное тревожное расстройство ~70%, ГТР, другая тревога, расстройство речи или языка.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость — в семейном анамнезе тревога часта (~70% в семье тревожное расстройство).
- Поведенческое торможение (Kagan) — темпераментальная предрасположенность как основной фактор.
- Коморбидные нарушения развития речи и языка (особенно в билингвальной среде) — фактор риска.
- Среда — в двуязычных семьях иногда ошибочно принимается за языковой переход.

5. Клиническая картина

- Отсутствие речи в специфических социальных ситуациях (школа, общественные места).
- Нормальная речь с близкими дома.
- Иногда использование шепота или жестов.
- Академические и социальные нарушения (ответы на вопросы, отношения со сверстниками).
- Сопутствующая застенчивость, социальная отгороженность, соматические жалобы.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Устойчивое молчание в определённых социальных ситуациях (где ожидается речь), при нормальной речи в других ситуациях.

B. Значительное нарушение в академической, профессиональной или социальной коммуникации.

C. Длительность ≥ 1 месяц (исключая первый месяц школы).

D. Необщительность не связана с неспособностью овладеть языком или дискомфортом при использовании этого языка.

E. Не объясняется лучше коммуникативным расстройством (напр., расстройством беглости речи), расстройством аутистического спектра, шизофренией или другим психотическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — в категории тревожных расстройств; «selective» — не добровольный выбор, а ситуационно-специфический тревожный ответ.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с родителем, учителем.
2. Видеозаписи речи дома — подтверждение диагноза.
3. SMQ (англ. Selective Mutism Questionnaire).
4. Логопедическая оценка (SLT) — исключение коммуникативного расстройства.
5. Тест слуха.
6. Скрининг коморбидной тревоги, аутизма, нарушения речи.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Расстройство развития речи (6A01)	Речь слаба во всех контекстах.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Социально-коммуникативный дефицит во всех контекстах.
Переходная билингвальная среда	В период адаптации к новому языку — обычно месяцы.
Нарушение слуха	Аудиометрия.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Коморбидность часта — пациент говорит, но боится социальной оценки.
Мутизм в контексте травмы	Анамнез травматического события.

7. Обследование и оценка

- SMQ — золотой стандарт; SAS (англ. School Anxiety Scale).
- Логопедическая оценка.
- Аудиометрия.

8. Лечение

1. Поведенческий подход первой линии — ступенчатая экспозиция, техника fading-in (постепенное введение близкого человека в среду).
2. Интегративная поведенческая терапия (Bergman R.L.) — мануализированная, с участием семьи + школы.
3. Школьное вмешательство — ступенчатое увеличение коммуникативных требований, координация с учителем.
4. СИОЗС (флуоксетин, сертралин) — при среднетяжёлых и тяжёлых случаях или при отсутствии ответа на поведенческое вмешательство. Black B. et al. JAACAP 1994 РКИ.
5. Уменьшение аккомодации — прекращение речи родителя вместо ребёнка.

8.1 Методики лечения

1. Техника постепенного введения (Fading-In) — Пациент разговаривает с человеком, с которым ему комфортно; постепенно в этот контекст вводится незнакомый человек; затем пациент переходит к разговору с незнакомцем.
2. Интегративная поведенческая терапия (англ. Integrated Behavior Therapy, IBT) — Бергман (Bergman R.L.) — Ступенчатая экспозиция, положительное подкрепление, систематическая десенсибилизация; 20 сеансов. Доказательства: Bergman R.L. et al. JAACAP 2013 РКИ.
3. Опросник селективного мутизма (англ. Selective Mutism Questionnaire, SMQ) — Бергман (Bergman) — 23 пункта; родительская форма.
4. СИОЗС — Флуоксетин — Доказательная база при педиатрическом селективном мутизме; Black B., Uhde T.W. JAACAP 1994 РКИ.

8.2 Различия между источниками

- AACAP — поведенческое вмешательство первой линии, СИОЗС адъюнктивно.
- NICE — применяются принципы лечения тревожных расстройств.

9. Прогноз

- При раннем вмешательстве речь восстанавливается у большинства детей.
- Без лечения — хронизация и переход в социальное тревожное расстройство.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Селективный мутизм — это „упрямство“ ребёнка»

Доказательства: селективный мутизм — это тревожное расстройство: ребёнок не может говорить; позиция «не хочет говорить» ошибочна.

Миф 2: «Если ребёнок не говорит, на него нужно сильно давить»

Доказательства: Давление усиливает тревогу и мутизм; рекомендуется ступенчатая экспозиция.

Миф 3: «Пройдёт с возрастом, вмешательства не требует»

Доказательства: без раннего вмешательства академическая и социальная дезадаптация сохраняется; риск перехода в социальное тревожное расстройство во взрослом возрасте.

Миф 4: «Мутизм у двуязычного ребёнка — это нормально»

Доказательства: «Период молчания» при изучении нового языка в течение нескольких месяцев нормален; мутизм ≥ 6 месяцев или проявляющийся на обоих языках — рассматривается диагноз селективного мутизма.

Миф 5: «Эффективна только глубокая психоаналитическая терапия»

Доказательства: поведенческие и КПТ-подходы первой линии; психоаналитическое вмешательство не имеет доказательной базы.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B06 Selective mutism. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Bergman R.L. et al. Prevalence and description of selective mutism in a school-based sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(8):938–946.
4. Bergman R.L., Gonzalez A., Piacentini J., Keller M.L. Integrated Behavior Therapy for Selective Mutism: a randomized controlled pilot study. Behav Res Ther 2013;51(10):680–689.
5. Black B., Uhde T.W. Treatment of elective mutism with fluoxetine: a double-blind, placebo-controlled study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33(7):1000–1006.

6B20–6B2Z ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЕ (ОКР)

Obsessive-compulsive or related disorders

МКБ-11 **6B20**	**6B20 ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (ОКР)** **Obsessive-compulsive disorder**
МКБ-10 F42	Обсессивно-компульсивное расстройство
DSM-5-TR F42.2	Обсессивно-компульсивное расстройство

1. Определение и нозология

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР; МКБ-11: 6B20; DSM-5-TR: F42.2) — повторяющиеся, эго-дистонические обсессии (нежелательные, навязчивые мысли, образы, импульсы) или компульсии (повторяющиеся действия или мысленные акты) — расстройство, характеризующееся этим. Обычно присутствуют оба компонента. Пациент выполняет компульсию для снижения тревоги или предотвращения пугающего исхода.

DSM-5 (2013) — ОКР отдельно от тревожных расстройств перенесено в категорию «Обсессивно-компульсивное и связанные с ним расстройства»; параллельный шаг МКБ-11.

2. История

- Esquirol J.E.D. (1838) — «рассуждающая мономания».
- Janet P. (1903) — «psychasthénie».
- Freud (1909) — случай «Крысиного человека».
- Mowrer O.H. (1947) — двухфакторная теория обучения (классическое обусловливание + оперантное избегание); основа ERP.
- Meyer V. (1966) — первое клиническое применение экспозиции и предотвращения реакции (ERP).

- DSM-5 (2013) и МКБ-11 (2019) — ОКР выделен из тревожных расстройств.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1,6–2,3% (Ruscio A.M. et al. Mol Psychiatry 2010).
- Пол: примерно одинаково; у женщин относительно чаще в зрелом возрасте, у мужчин — раннее начало в детстве.
- Начало: бимодальное — препубертатный (10–12 лет, мужчины) и ранняя взрослость (20–25 лет).
- Коморбидность: БДР ~60%, тревожные расстройства, тикозные расстройства, аутизм, накопительство, BDD.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–50% (Mataix-Cols D. et al. JAMA Psychiatry 2013).
- Нейробиологически — гиперактивность кортико-стриато-таламо-кортикального (CSTC) контура (орбитофронтальная, поясная кора, хвостатое ядро); серотонинергическая дисрегуляция (эффект СИОЗС); дисрегуляция глутамата.
- Генетическое исследование — SLC1A1 (транспортер глутамата), гены серотонина.
- PANDAS — редкое начало ОКР после стрептококковой инфекции (NIMH 2017).
- Травма, стрессовые триггерные факторы.

5. Клиническая картина

Типичные симптоматические домены

- Загрязнение / чистота — наиболее интенсивно; компульсии мытья рук, дезинфекции.
- Сомнение / проверка — замок, плита, электрические приборы.
- Симметрия / точность / «just right» — связано с аккуратностью и упорядоченностью.
- Агрессивные / сексуальные / религиозные обсессии — эго-дистонические, вызывающие тревогу.
- Накопительство (хординг) — Отдельная категория в МКБ-11 (6B24).

Эго-дистонность

Пациент признаёт, что навязчивые идеи являются его собственными мыслями, но нежелательными, иррациональными или неприемлемыми (инсайт вариабелен — квалификаторы инсайта DSM-5-TR: хороший / слабый / отсутствует).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Наличие обсессии, компульсии или обоих.

- Обсессии: Повторяющиеся, устойчивые, нежелательные мысли/образы/импульсы; вызывают дистресс; пациент пытается их подавить или нейтрализовать другими мыслями/действиями.
- Компульсии: повторяющееся поведение (мытьё рук, проверка, упорядочивание) или мысленное действие (счёт, молитва), выполняемое в ответ на навязчивую идею или в соответствии с жёстким правилом; направлено на снижение тревоги, но либо нереалистично, либо чрезмерно.

B. Обсессии/компульсии занимают > 1 часа в день или вызывают значительный дистресс/функциональные нарушения.

C. Исключение вещества или медицинского состояния

D. Не объясняется лучше другим психическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — квалификаторы инсайта (хороший/средний — слабый — отсутствует / на уровне бреда); подтип, связанный с тиками.
- МКБ-11 — параллельно; накопление (6B24), BDD (6B21), обонятельный референс (6B22) — отдельные категории.
- NICE CG31 (2005, 2019 surveillance) — диагностика с помощью клинического интервью + Y-BOCS.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. SCID-5, Y-BOCS (англ. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) — золотой стандарт шкалы тяжести; CY-BOCS у детей.
3. OCI-R (англ. Obsessive Compulsive Inventory-Revised) — самооценка.

4. Коморбидность (депрессия, тревога, тики, аутизм, BDD, накопительство).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ГТР (6B00)	Реальные жизненные тревоги, компульсий нет.
Тикозные расстройства (8A05)	Моторные/вокальные; нецеленаправленные; премониторное ощущение.
BDD (6B21)	Обсессии, связанные с внешностью.
Накопительство (6B24)	Трудности с выбрасыванием предметов.
Расстройства пищевого поведения (6B8x)	Пищевое поведение является основным.
Трихотилломания, дерматилломания (6B25.x)	Повторяющееся поведение, направленное на тело.
Обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ)	Стойкая модель личности, эго-синтонная; ОКР эго-дистонно.
Шизофрения / бредовое расстройство	Инсайт на уровне бреда; при ОКР инсайт вариабелен.
Расстройство аутистического спектра	Ограниченно-повторяющееся поведение; эго-синтонное.

7. Обследование и оценка

- Y-BOCS / CY-BOCS — золотой стандарт.
- OCI-R — самооценка.
- Коморбидность (депрессия, тревога).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG31 · APA · WFSBP)

1. Психотерапия первой линии: ЭРП (экспозиция и предотвращение реакции, англ. exposure and response prevention, ERP) — пациент

подвергается воздействию пугающего объекта/ситуации и не выполняет компульсию. 12–20 сеансов. Доказательства: РКИ Foa E.B. et al.; эффект большой.

2. Фармакотерапия первой линии: СИОЗС в высоких дозах — флуоксетин (40–80 мг), сертралин (200 мг), пароксетин (40–60 мг), флувоксамин (200–300 мг), эсциталопрам (20–40 мг). При ОКР требуется доза выше стандартной для депрессии; эффект через 8–12 недель (медленнее, чем при депрессии).
3. Комбинация КПТ/ЭРП + СИОЗС — выигрыша перед одной ЭРП не даёт: в РКИ Foa E.B. et al. Am J Psychiatry 2005 (n=122, кломипрамин) ЭРП и ЭРП+кломипрамин не различались, обе превзошли один кломипрамин (ответ 62–86% ЭРП, 70–79% комбинация, 42–48% кломипрамин, 8–10% плацебо). Сильный компонент — именно ЭРП; фармакотерапию добавляют, когда ЭРП недоступна или есть коморбидность.
4. Кломипрамин (ТЦА) — альтернатива первой линии; при неэффективности СИОЗС; антихолинергические и кардиальные побочные эффекты.
5. Аугментация (SSRI + атипичный антипсихотик в низкой дозе) — рисперидон, арипипразол; при рефрактерности.
6. Рефрактерное тяжёлое ОКР: Глубокая стимуляция мозга (DBS — вентральная капсула/вентральный стриатум), нейрохирургия (капсулотомия, цингулотомия); ЭСТ неэффективна; исследования быстрого эффекта кетамина/эскетамина продолжаются.
7. Длительность лечения — долгосрочно; после ремиссии ≥ 1–2 года, при множественных рецидивах — пожизненно.

8.2 Методики лечения

1. Экспозиция и предотвращение реакции (англ. Exposure and Response Prevention, ERP) — Мейер (Meyer V.), Фоа (Foa E.B.) — Пациент подвергается воздействию пугающего объекта (например, «грязной» вещи) и не выполняет компульсию (мытьё рук); тревога постепенно снижается (габитуация). Стандартный курс 12–20 сеансов, 1–2 раза в неделю; более интенсивный формат (ежедневно) эффективен. Доказательства: Foa E.B. et al. Am J Psychiatry 2005.
2. КПТ — когнитивный компонент — Дополнение к ERP; переоценка мыслей об одержимости; направлена на когниции «thought-action fusion» (TAF) и гипер-ответственность.
3. Йельско-Брауновская обсессивно-компульсивная шкала (англ. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Y-BOCS) — Гудман (Goodman

W.K.) — 10 пунктов; 5 обсессий + 5 компульсий; золотой стандарт; CY-BOCS у детей.

4. СИОЗС в высокой дозе — При ОКР требуется значительно более высокая доза, чем стандартная антидепрессивная; титрация 8–12 недель; при отсутствии ответа доза увеличивается до максимальной.
5. Кломипрамин (ТЦА) — При ОКР доказательства сильны (CMI multicenter trial 1991); кардиальные и антихолинергические побочные эффекты; вторая линия.
6. Глубокая стимуляция мозга (DBS — Deep Brain Stimulation) — Хирургическое вмешательство при рефрактерном тяжёлом ОКР; мишень — вентральная капсула/вентральный стриатум. Greenberg B.D. et al. Mol Psychiatry 2010.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG31 (2005, 2019 surveillance) — ступенчатый подход в зависимости от тяжести; ERP первой линии; СИОЗС при средней и тяжёлой степени.
- Руководство APA по клинической практике для ОКР (2007) — то же; кломипрамин силен по доказательной базе, но из-за побочных эффектов — вторая линия.
- WFSBP (Bandelow B. et al. 2008) — диапазоны доз СИОЗС и титрация.
- NICE CG31 PANDAS — рутинная антибиотикопрофилактика не рекомендуется.

9. Прогноз

- Хроническое течение, но значительное улучшение при адекватном лечении.
- Коморбидные депрессия, тики, аутизм — маркеры плохого прогноза.
- Раннее начало и слабый инсайт — более сложное лечение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ОКР — это просто черта личности, связанная с чистоплотностью и аккуратностью»

Доказательства: клиническое ОКР эго-дистонично, вызывает тревогу и функциональные нарушения; обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ) является эго-синтоническим, отличным расстройством. Клинический диагноз на основе Y-BOCS, тяжести и длительности.

Миф 2: «Пациент может „прекратить“ навязчивости по собственной воле»

Доказательства: ОКР — это дисрегуляция CSTC-цепи; не поддаётся волевому контролю; ERP и СИОЗС действуют на нейробиологическом уровне.

Миф 3: «СИОЗС в дозе для депрессии работает при ОКР»

Доказательства: При ОКР требуются высокие дозы СИОЗС (флуоксетин 60–80 мг, сертралин 200 мг); доза для депрессии (например, флуоксетин 20 мг) часто не даёт ответа.

Миф 4: «ЭРП травмирует, потому что удерживает пациента в пугающей ситуации»

Доказательства: ERP проводится структурированно, поэтапно и с согласия пациента; демонстрирует долгосрочную доказанную эффективность.

Миф 5: «PANDAS — основная причина ОКР, все должны принимать антибиотики»

Доказательства: NIMH 2017 — PANDAS является редким событием; рутинные тесты на антистрептолизин О и антибиотикопрофилактика не рекомендуются; только при наличии классической клинической картины.

Миф 6: «Разрешение выполнять компульсии успокаивает симптомы»

Доказательства: потворство компульсиям (аккомодация) усиливает ОКР; снижение семейной аккомодации — важный компонент лечения.

Миф 7: «Растительные препараты (зверобой, кава, омега-3) излечивают ОКР»

Доказательства: ни один не имеет доказанного эффекта при ОКР; риск взаимодействия зверобоя с СИОЗС.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B20 Obsessive-compulsive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG31. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder. 2005, 2019 surveillance.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. 2007.

5. Bandelow B. et al. WFSBP guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorders. World J Biol Psychiatry 2008;9(4):248–312.
6. Foa E.B., Liebowitz M.R., Kozak M.J. et al. Randomized, placebo-controlled trial of exposure and ritual prevention, clomipramine, and their combination in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 2005;162(1):151–161.
7. Ruscio A.M., Stein D.J., Chiu W.T., Kessler R.C. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry 2010;15(1):53–63.
8. Mataix-Cols D. et al. Familial risks of obsessive-compulsive disorder. JAMA Psychiatry 2013;70(7):709–717.
9. Greenberg B.D. et al. Deep brain stimulation of the ventral internal capsule/ventral striatum for obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry 2010;15(1):64–79.
10. NIMH. PANDAS/PANS Information for Clinicians. 2017.
11. Goodman W.K., Price L.H., Rasmussen S.A. et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989;46(11):1006–1011.

МКБ-11 **6B21**	**6B21 ТЕЛЕСНОЕ ДИСМОРФИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО (BDD)** **Body dysmorphic disorder**
МКБ-10 F45.2	Ипохондрическое расстройство
DSM-5-TR F45.22	Дисморфофобическое расстройство

1. Определение и нозология

Телесное дисморфическое расстройство (BDD; МКБ-11: 6B21; DSM-5-TR: F45.22) — озабоченность пациента несуществующим или очень незначительным дефектом внешности; эта озабоченность приводит к повторяющемуся поведению (проверка в зеркале, ковыряние кожи, поиск косметических процедур) или мысленным действиям (сравнение).

2. История

- Morselli E. (1891) — «dysmorphophobia».
- DSM-III-R (1987) — «Body Dysmorphic Disorder» в рамках соматоформных расстройств.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 — перенесено в категорию обсессивно-компульсивного спектра.

3. Эпидемиология

- Распространённость в общей популяции: 1,7–2,4% (Buhlmann U. et al. Psychiatry Res 2010).
- В клиниках косметической дерматологии и пластической хирургии — 9–15%.
- Пол: примерно одинаково.
- Начало: в среднем 15–16 лет.
- Коморбидность: БДР ~75%, ОКР ~30%, социальная тревога ~37%, употребление ПАВ.
- Суицидальный риск высок: попытка ~24–28%, завершённый суицид в 45 раз выше, чем в популяции (обзоры Phillips K.A.).

4. Этиология и патогенез

- Генетическое совпадение с ОКР.
- Нейробиологически — гиперактивность орбитофронтально-стриатального контура (сходно с ОКР); нарушение зрительной обработки (обзоры Feusner J.D. et al. — пациент чрезмерно фокусируется на деталях, не интегрирует общее изображение).
- Социокультурное — идеализированная внешность в масс-медиа.
- Детская виктимизация со стороны сверстников (травля, буллинг).

5. Клиническая картина

- Обсессивная фокусировка на конкретной части внешности (лицо, кожа, волосы, нос, форма тела).
- Реального дефекта нет или он незаметен/незначителен для других.
- Повторяющееся поведение: рассматривание в зеркало, расчёсывание кожи, сравнение, поиск косметических процедур, одежда/макияж/камуфляж.

- Мыслительные действия: сравнение себя с другими.
- Инсайт часто слабый; иногда на уровне бреда.
- Подтип «мышечная дисморфия» — обсессия «недостаточного развития мышц» у мужчин; приводит к употреблению анаболических стероидов.
- Высокая социальная изоляция, академические и профессиональные нарушения.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Озабоченность дефектом или недостатком внешности, незаметным или незначительным для других.

B. Пациент в какой-либо момент совершал повторяющееся поведение (зеркало, ковыряние кожи, чрезмерная одежда) или умственное действие (сравнение).

C. Озабоченность вызывает значительный дистресс или функциональное нарушение.

D. Озабоченность образом тела не должна достигать критериев расстройства пищевого поведения (анорексия/булимия).

Квалификаторы: с мышечной дисморфией; инсайт (хороший / умеренный — слабый / отсутствует / бред).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — в категории спектра ОКР; квалификатор мышечной дисморфии.
- NICE CG31 — объединённые рекомендации по БДР и ОКР.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (пациент часто не говорит открыто из-за стыда).
2. BDDQ (англ. Body Dysmorphic Disorder Questionnaire) — скрининг.
3. BDD-YBOCS — шкала тяжести.
4. Коморбидность (депрессия, ОКР, социальная тревога, суицидальный риск).
5. Анамнез приёма анаболических стероидов или косметических процедур.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
ОКР (6B20)	Обсессии не ограничиваются внешностью.
Расстройство пищевого поведения (6B8x)	Вес и форма тела являются основными; нарушено пищевое поведение.
Бредовое расстройство (6A24)	Инсайт отсутствует; при BDD часто вариабелен.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Социальная оценка широкая; при BDD фокус на специфической части внешности.
Трихотилломания (6B25.0)	Выдёргивание волос первично; беспокойство о внешности вторично.
Olfactory Reference Disorder (6B22)	На основе запаха.

7. Обследование и оценка

- BDDQ — скрининг (Phillips K.A.).
- BDD-YBOCS — модифицированная шкала ОКР, 12 пунктов.
- C-SSRS — суицидальный риск (высокий).

8. Лечение

1. Психотерапия первой линии: КПТ (адаптированная для BDD, Wilhelm S., Phillips K.A.) — когнитивная реструктуризация + экспозиция + переобучение работе с зеркалом + поведенческие эксперименты. 12–22 сеанса.
2. Фармакотерапия первой линии: СИОЗС в высоких дозах — аналогично ОКР; флуоксетин (40–80 мг), эсциталопрам, сертралин.
3. Кломипрамин — альтернатива.
4. Аугментация — атипичный антипсихотик (особенно на уровне бреда с инсайтом).
5. Лечение длительное; после ремиссии ≥ 1–2 года.
6. Мониторинг суицидального риска.

7. Профилактика косметических процедур — пациент сотрудничает с дерматологом/пластическим хирургом; доказательства: хирургическая процедура не улучшает симптомы BDD, часто создаёт новый фокус (Crerand C.E. et al. Ann Plast Surg 2010;65(1):11–16).

8.1 Методики лечения

1. КПТ для BDD — Вильгельм (Wilhelm S.), Филлипс (Phillips K.A.) — Мануализированный 22-сеансовый протокол — психообразование, когнитивная реструктуризация, зеркальная переподготовка (mirror retraining), поведенческие эксперименты, предотвращение ритуалов (ERP), профилактика рецидивов.
2. Опросник телесного дисморфического расстройства (англ. Body Dysmorphic Disorder Questionnaire, BDDQ) — Филлипс (Phillips K.A.) — Скрининг.
3. BDD-YBOCS — Адаптация Y-BOCS для BDD при ОКР.
4. СИОЗС в высокой дозе — Сходно с ОКР; ответ через 8–12 недель.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG31 — КПТ + высокие дозы СИОЗС первой линии.
- Исследования Phillips K.A. — СИОЗС эффективны при BDD; высокие дозы, длительное применение.

9. Прогноз

- Хроническое течение.
- При адекватном лечении значительное улучшение; ремиссия возможна, но требуется длительное поддерживающее лечение.
- Суицидальный риск отслеживается.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «У пациента с BDD есть „реальный дефект“, косметическая хирургия поможет»

Доказательства: Crerand C.E. Ann Plast Surg 2010 — косметические процедуры не улучшают BDD; большинство пациентов недовольны результатом или развивают новую фокусировку. Хирургам рекомендуется проводить скрининг BDD.

Миф 2: «Пациента с BDD нужно „успокаивать“, хваля его внешность»

Доказательства: похвала или разубеждение (reassurance) дают кратковременное облегчение, но усиливают обсессию; уменьшение семейной аккомодации является компонентом лечения.

Миф 3: «Дисморфическое расстройство тела — это обычная „неуверенность в себе“»

Доказательства: BDD сопровождается функциональными нарушениями и высоким суицидальным риском (попытки 24–28%, в 45 раз выше, чем в популяции); оценивается как клиническое состояние.

Миф 4: «SSRI в дозах для депрессии эффективны при BDD»

Доказательства: Похоже на ОКР — требуются высокие дозы; ответ через 8–12 недель.

Миф 5: «Мышечная дисморфия — не женское расстройство, у мужчин тоже не бывает, это просто фитнес-мотивация»

Доказательства: мышечная дисморфия распространена у мужчин; сопровождается употреблением анаболических стероидов, компульсивными тренировками, социальной изоляцией и депрессией; квалификатор в DSM-5-TR.

Миф 6: «Последовательное обращение к пластическому хирургу за процедурами — это нормально»

Доказательства: последовательные процедуры — признак BDD; хирург должен провести скрининг BDD и направить к психиатру.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B21 Body dysmorphic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG31. 2005, 2019 surveillance.
4. Phillips K.A. The Broken Mirror: Understanding and Treating Body Dysmorphic Disorder. Oxford Univ Press; 2005.
5. Wilhelm S., Phillips K.A., Steketee G. Cognitive-Behavioral Therapy for Body Dysmorphic Disorder: A Treatment Manual. Guilford Press; 2013.
6. Buhlmann U. et al. Updates on the prevalence of body dysmorphic disorder: a population-based survey. Psychiatry Res 2010;178(1):171–175.

7. Crerand C.E., Menard W., Phillips K.A. Surgical and minimally invasive cosmetic procedures among persons with body dysmorphic disorder. Ann Plast Surg 2010;65(1):11–16.
8. Feusner J.D., Townsend J., Bystritsky A., Bookheimer S. Visual information processing of faces in body dysmorphic disorder. Arch Gen Psychiatry 2007;64(12):1417–1425.

МКБ-11 **6B22**	**6B22 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ ЗАПАХОМ (ORS)** **Olfactory reference disorder**
МКБ-10 F45.8	Другие соматоформные расстройства
DSM-5-TR F42.8	Другое уточнённое обсессивно-компульсивное и связанное расстройство (обонятельный референтный синдром)

1. Определение и нозология

Патологическая озабоченность собственным запахом (ORS) (МКБ-11: 6B22 Olfactory Reference Disorder; DSM-5-TR: F42.8 Other Specified Obsessive-Compulsive and Related Disorder) — расстройство, характеризующееся навязчивой убеждённостью пациента в распространении нереального или чрезмерно преувеличенного неприятного запаха от его тела. Пациент считает, что другие осуждают или стыдят его, проявляет компульсивное мытьё, использование дезодорантов, поведение социального избегания.

2. История

- Pryse-Phillips W. (1971) — термин «olfactory reference syndrome».
- DSM-IV — отдельной категории не было (Бредовое расстройство как соматический подтип).
- DSM-5 (2013) — спектр ОКР отмечен как взаимосвязанное расстройство; однако отдельный код не присвоен.

- МКБ-11 (2019) — впервые официальная диагностическая категория (6B22).

3. Эпидемиология

- Распространённость: точные эпидемиологические данные ограничены; по клиническим отчётам и обзорам редко, но недостаточно диагностируется (Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011).
- Начало: ранняя взрослость (в среднем 20–25 лет).
- Пол: примерно одинаково.
- Коморбидность: БДР, социальная тревога, ОКР, BDD, высокий суицидальный риск (суицидальные мысли ~68%, попытки ~32% — Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011, n=20).

4. Этиология и патогенез

- Генетическое и нейробиологическое совпадение с ОКР и BDD.
- Инсайт вариабелен — иногда на уровне бреда.
- Социокультурные факторы — социальная стигма в отношении запаха тела.

5. Клиническая картина

- Навязчивая озабоченность запахом тела (рот, ноги, подмышки, гениталии, общее тело) или запахом дыхания.
- «Неверное считывание» реакций других (идеи отношения) — кашель, почёсывание носа, открывание окна интерпретируются как «результат запаха».
- Компульсивное поведение — частое мытьё, смена одежды, использование дезодоранта, духов, гигиена полости рта, жевание резинки, интенсивная чистка зубов.
- Социальное избегание — избегание работы и школы, социальная изоляция.
- Компенсаторное поведение — дистанцирование от других.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (МКБ-11)

A. Стойкая озабоченность тем, что от тела пациента исходит неприятный запах или неприятный запах изо рта — для других либо незаметный, либо незначительный.

B. Пациент совершает повторяющиеся действия (мытьё, маскировка запаха, проверка кожи) или умственные действия (сравнение себя с другими) в ответ на навязчивую идею.

C. Озабоченность вызывает значительный дистресс или функциональное нарушение.

D. Исключение вещества или медицинского состояния (реальный галитоз, гипергидроз, триметиламинурия, метаболические заболевания с запахом вещества)

Квалификатор инсайта: хороший / умеренно-слабый / отсутствует / на уровне бреда.

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 — официальность как отдельной категории.
- DSM-5-TR — в рамках «Other specified obsessive-compulsive and related disorder».

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Медицинское и оториноларингологическое обследование — исключение истинного галитоза, синусита, гипергидроза, желудочно-кишечных заболеваний.
3. Триметиламинурия (ТМАУ) — тест на триметиламин в моче (редкое генетическое метаболическое заболевание, «синдром рыбного запаха»).
4. Оценка уровня инсайта.
5. Коморбидность и риск суицида (высокий!).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Истинный галитоз / гипергидроз / ТМАУ	Объективно подтверждено.

Состояние	**Отличительный признак**
BDD (6B21)	Связано с внешностью.
ОКР (6B20)	Множественные обсессии.
Бредовое расстройство (6A24) — соматическое	Инсайт отсутствует; клинические проявления совпадают.
Шизофрения	Другие психотические симптомы.
Социальное тревожное расстройство (6B04)	Страх социальной оценки широкий.

7. Обследование и оценка

- Медицинское обследование — стоматологическое, ЛОР, желудочно-кишечное.
- Тест на ТМАУ (триметиламин мочи).
- Шкала — не специфическая; адаптированное использование Y-BOCS.
- C-SSRS (высокий суицидальный риск).

8. Лечение

1. КПТ — подход, адаптированный для ОКР/Дисморфофобии; экспозиция (прекращение проверочного поведения, возвращение в социальные ситуации), когнитивная реструктуризация.
2. СИОЗС в высокой дозе — сходно с ОКР.
3. Аугментация — атипичный антипсихотик (на уровне бреда с инсайтом).
4. Социальная реабилитация.
5. Мониторинг суицидального риска.

8.1 Методики лечения

1. КПТ (адаптированная для ОКР/Дисморфофобии) — Экспозиция + предотвращение ритуалов + когнитивная реструктуризация.
2. СИОЗС в высокой дозе — Сходно с ОКР; 8–12 недель.

9. Прогноз

Доказательная база ограничена. Улучшение при СИОЗС + КПТ; отслеживается суицидальный риск.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациент действительно может плохо пахнуть — без предварительного медицинского обследования нельзя ставить психиатрический диагноз»

Доказательства: верно — медицинские причины (галитоз, гипергидроз, TMAU) должны быть обязательно исключены; но если медицинской причины нет, а навязчивая озабоченность сохраняется, клиническое состояние — обонятельное референтное расстройство (ORS).

Миф 2: «Тщательное мытьё и использование дезодоранта решат проблему»

Доказательства: компульсивное поведение приносит кратковременное облегчение, но усиливает расстройство; увеличивается раздражение кожи, социальная дезадаптация.

Миф 3: «У пациента простая проблема с самооценкой»

Доказательства: клиническое нарушение; высокий риск суицида (суицидальные мысли ~68%, попытки ~32%); требуется медицинское вмешательство.

Миф 4: «Только антипсихотик эффективен, так как это бред»

Доказательства: инсайт вариабелен; высокие дозы СИОЗС + КПТ — первая линия; антипсихотическая аугментация только при уровне бреда.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B22 Olfactory reference disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Phillips K.A., Menard W. Olfactory reference syndrome: demographic and clinical features of imagined body odor. Gen Hosp Psychiatry 2011;33(4):398–406.
4. Pryse-Phillips W. An olfactory reference syndrome. Acta Psychiatr Scand 1971;47(4):484–509.

МКБ-11 **6B23**	**6B23 ИПОХОНДРИЯ** **Hypochondriasis**
МКБ-10 F45.2	Ипохондрическое расстройство
DSM-5-TR F45.21	Расстройство тревоги о болезни

1. Определение и нозология

Ипохондрия (МКБ-11: 6B23 Hypochondriasis; DSM-5-TR: F45.21 Illness Anxiety Disorder — новое название, отделено от соматического симптоматического расстройства) — стойкая озабоченность и тревога по поводу наличия или развития серьёзного медицинского заболевания. Пациент демонстрирует повторяющиеся медицинские обследования (клинические визиты, поиск в интернете «Dr. Google», консультации друзей) или, наоборот, избегающее медицинское поведение.

DSM-5 (2013) — диагноз ипохондрии разделён на две новые категории:

- Somatic Symptom Disorder (F45.1) — имеются соматические жалобы;
- Illness Anxiety Disorder (F45.21) — соматические симптомы минимальны или отсутствуют, доминирует тревога.

МКБ-11 (2019) — ипохондрия включена в спектр ОКР (отдельно от соматоформных расстройств); этот концептуальный переход отражает доказательную базу (нейробиология и ответ на лечение, сходные с ОКР).

2. История

- Греческая медицина — «hypochondrium» (подреберье) — древняя гуморальная теория.
- DSM-III (1980) — в категории соматоформных расстройств.
- DSM-5 (2013) — разделение illness anxiety disorder и somatic symptom disorder.
- МКБ-11 (2019) — переход в категорию спектра ОКР.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1–6% (Bleichhardt G., Hiller W. Br J Health Psychol 2007).
- У пациентов первичной медицинской помощи: ~3–10%.
- Пол: примерно одинаково.
- Начало: ранний-средний взрослый возраст.
- Коморбидность: БДР, ГТР, ОКР, паническое расстройство.

4. Этиология и патогенез

- Генетическое совпадение с ОКР и тревожными расстройствами.
- Опыт детской травмы или медицинских заболеваний.
- Когнитивные — катастрофизация телесных ощущений; селективное внимание; «поиск медицинской информации» (киберхондрия).
- Моделирование — высокая восприимчивость к болезни в семье.

5. Клиническая картина

- Страх развития серьёзного заболевания (рак, сердечный приступ, различные хронические болезни).
- Интерпретация нормальных телесных ощущений (сердцебиение, головная боль, вялость кишечника) как маркеров серьёзного заболевания.
- Поведенческие модели (биполярные):
    - Care-seeking — повторные медицинские осмотры, множественные обращения к врачам («doctor shopping»), поиск в интернете (киберхондрия), осмотры тела.
    - Care-avoiding — избегание медицинских осмотров (страх услышать доказательства), больницы, медицинских приборов.
- Медицинское успокоение даёт кратковременное облегчение, затем тревога возвращается.
- Функциональное нарушение — прогулы работы, социальная изоляция.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

А. Стойкая озабоченность тем, что имеется или развивается серьёзное заболевание.

B. Соматические симптомы минимальны или отсутствуют; если присутствуют, озабоченность не соответствует тяжести.

C. Высокая тревога, связанная со здоровьем.

D. Пациент демонстрирует чрезмерное поведение, связанное со здоровьем (проверка) или избегание болезни.

E. Продолжительность ≥ 6 месяцев (DSM-5-TR); типичное содержание заболевания может меняться со временем.

F. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (БДР, паническое, ГТР, ОКР, BDD, соматическое бредовое).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — Illness Anxiety Disorder (F45.21); подтипы care-seeking и care-avoiding.
- МКБ-11 — в категории спектра ОКР (6B23); новое место, отличное от классического соматоформного.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Медицинская оценка — исключение реального заболевания (но следует избегать чрезмерного тестирования).
3. Шкала — Whiteley Index, SHAI (англ. Short Health Anxiety Inventory).
4. Скрининг коморбидности.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Соматическое симптоматическое расстройство (6C20)	Соматические жалобы доминируют.
Реальное соматическое заболевание	Клиническое и лабораторное подтверждение.
ОКР (6B20)	Множественные обсессии; заболевание не ограничено.
ГТР (6B00)	Множественные сферы беспокойства.
Паническое расстройство (6B01)	Страх «сердечного приступа» во время приступа.

Состояние	Отличительный признак
Бредовое расстройство (6A24) — соматическое	Инсайт отсутствует.
Большое депрессивное расстройство — соматический фокус	Доминирует аффективный компонент.

7. Обследование и оценка

- Индекс Уайтли (14 пунктов), SHAI.
- Соматическое обследование — однократно полное, затем не повторяется.
- PHQ-9, GAD-7 — коморбидность.

8. Лечение

1. КПТ первой линии — когнитивная реструктуризация (катастрофизация), предотвращение проверки тела и поиска reassurance (экспозиция + предотвращение ритуалов), тренировка внимания. Эффект: мета-анализ Cooper K. et al. Behav Res Ther 2017.
2. СИОЗС — при среднетяжёлых/тяжёлых случаях или коморбидной депрессии/ГТР.
3. Модель одного врача (single physician) — пациент работает только с одним врачом первичной медицинской помощи; избегание множественных обследований и «doctor shopping».
4. Лимит reassurance — врач не предоставляет чрезмерных доказательств в ответ на тревогу; краткое, последовательное сообщение.
5. Майндфулнес-основанный подход адъюнкт.

8.1 Методики лечения

1. КПТ для ипохондрии — Салковскис (Salkovskis P.), Варвик (Warwick H.) — Когнитивная модель — центральное место занимает «катастрофизация» телесных ощущений. Вмешательство: психообразование, исследование альтернативных объяснений, поведенческие эксперименты с проверкой тела и поиском reassurance, экспозиция. 12–16 сеансов.
2. Индекс Уайтли (англ. Whiteley Index) — 14-пунктовая шкала тревоги о болезни — золотой стандарт скрининга.

3. Краткий опросник тревоги о здоровье (SHAI — Short Health Anxiety Inventory) — Salkovskis — 18 пунктов; клинические и популяционные исследования.
4. Модель одного врача (single physician approach) — Пациент работает только с одним врачом; все жалобы управляются через этого врача; предотвращаются множественные обследования и противоречивые мнения.

8.2 Различия между источниками

- Cooper K. et al. Behav Res Ther 2017 мета-анализ — КПТ значимый эффект; средний размер эффекта.
- Greeven A. et al. Am J Psychiatry 2007 РКИ — КПТ и пароксетин оба превосходят плацебо.

9. Прогноз

- Значительное улучшение у большинства пациентов при КПТ или СИОЗС.
- Хронификация без лечения; постоянное использование медицинских ресурсов.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациент симулирует болезнь, играет»

Доказательства: ипохондрия — клиническое психиатрическое расстройство; тревога пациента реальна; это не «игра» или симуляция. Отличается от имитированного расстройства (6D50).

Миф 2: «Чем больше медицинских обследований проведено, тем спокойнее пациент»

Доказательства: Повторная проверка даёт кратковременное облегчение, затем тревога возвращается; развивается «зависимость от проверки». Рекомендуется модель одного врача и ограничение проверок.

Миф 3: «Заверение („ты здоров“) — средство лечения»

Доказательства: Повторное заверение усиливает расстройство — пациент продолжает искать доказательства. Структурированный ответ врача: однократная оценка, затем краткое стандартное сообщение.

Миф 4: «Поиск в интернете помогает пациенту самообразовываться»

Доказательства: «Киберхондрия» — интернет-поиск усиливает тревогу, увеличивает катастрофизацию; рекомендуется ограничение или структурирование.

Миф 5: «Ипохондрия возникает только у пожилых пациентов»

Доказательства: начало в раннем-среднем взрослом возрасте; возрастной диапазон широк.

Миф 6: «Эффективны только антидепрессанты, терапия бесполезна»

Доказательства: Greeven 2007 — КПТ и пароксетин оба превосходят плацебо; КПТ первой линии (долгосрочный эффект по сравнению с СИОЗС).

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B23 Hypochondriasis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Cooper K. et al. Cognitive behaviour therapy for health anxiety: a systematic review and meta-analysis. Behav Res Ther 2017;90:8–20.
4. Greeven A. et al. Cognitive behavior therapy and paroxetine in the treatment of hypochondriasis: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007;164(1):91–99.
5. Salkovskis P.M., Rimes K.A., Warwick H.M. The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychol Med 2002;32(5):843–853.
6. Bleichhardt G., Hiller W. Hypochondriasis and health anxiety in the German population. Br J Health Psychol 2007;12(Pt 4):511–523.

МКБ-11 **6B24**	**6B24** **ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПИТЕЛЬСТВО (ХОРДИНГ)** **Hoarding disorder**
МКБ-10 F63.8	Другие расстройства привычек и влечений

МКБ-11 **6B24**	**6B24** **ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПИТЕЛЬСТВО (ХОРДИНГ)** **Hoarding disorder**
DSM-5-TR F42.3	Патологическое накопительство

1. Определение и нозология

Патологическое накопительство (МКБ-11: 6B24; DSM-5-TR: F42.3 Расстройство накопления) — стойкая потребность в приобретении или сохранении вещей и трудности с их выбрасыванием, что приводит к загромождению жилого пространства (до степени, когда комнаты не могут использоваться по функциональному назначению). В категории спектра ОКР.

2. История

- Frost R.O., Hartl T.L. (1996) — когнитивно-поведенческая модель накопительства.
- DSM-IV — отмечался как подтип ОКР.
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 — официально закреплено как отдельная диагностическая категория (доказательная база — различные клинические проявления, течение, ответ на лечение).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 2–6% (Samuels J.F. et al. Behav Res Ther 2008).
- У пожилых людей распространённость выше (~6%).
- Пол: примерно одинаково; в клинических выборках преобладают женщины.
- Начало: подростковый возраст (в среднем 11–15 лет); тяжесть нарастает с возрастом.
- Коморбидность: БДР ~50%, ОКР ~20%, ГТР, социальная тревога, СДВГ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50%.
- Нейробиологически — нарушение фронтостриатального контура; модели активации, отличные от ОКР (обзоры Tolin D.F. et al.).
- Когнитивные дефициты — категоризация, принятие решений, внимание (модель Frost & Hartl).
- Эмоциональная привязанность к объектам; утрата — травма.
- У пожилых людей — триггер когнитивного снижения.

5. Клиническая картина

- Постоянные трудности с приобретением (покупка, безвозмездное получение, дарение) или хранением предметов.
- Мысль о выбрасывании или отпускании предметов вызывает значительный дистресс.
- Навязчивое накопление вещей и занятие жилого пространства приводят к тому, что комнаты не могут использоваться по функциональному назначению (спальня для сна, кухня для приготовления пищи и т.д.).
- Иногда «животное накопление» — массовое содержание животных.
- Инсайт часто слабый — пациент не признаёт проблему.
- Риски для здоровья и безопасности — пожар, инфекции, падения, социальная изоляция, выселение из дома.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Стойкие трудности с выбрасыванием или расставанием с приобретёнными предметами, независимо от их ценности.

B. Эта трудность обусловлена устойчивой потребностью сохранять вещи и дистрессом при попытке их выбросить.

C. Накопление загромождает жилое пространство и существенно нарушает целевое использование комнат.

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения (включая опасную среду для себя, семьи, других)

E. Исключение медицинского состояния (повреждение головного мозга, деменция).

F. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (ОКР «навязчивости», БДР «недостаток энергии», бредовые идеи психотического расстройства, аутизм «ограниченные интересы»).

Квалификатор: с excessive acquisition; инсайт (хороший / средний — слабый / отсутствует).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — отдельная категория; квалификатор инсайта.
- «Скопление животных» — хотя и не является отдельным спецификатором, это клинически признанный вариант; требуется сотрудничество с ветеринарными службами и органами общественного здравоохранения.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Визит на дом или фото-доказательство — состояние жилого помещения (англ. Clutter Image Rating).
3. Шкала — Saving Inventory-Revised (SI-R).
4. Коморбидность и когнитивная оценка (исключение деменции у пожилых — MMSE/MoCA).
5. Оценка риска для безопасности и здоровья.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ОКР (6B20)	Классические обсессии (чистота, симметрия); при накоплении — предметы имеют эмоциональную ценность.
MDD (6A70/6A71)	Неуборка вследствие «отсутствия энергии»; отсутствие активного приобретения вещей.
Деменция	Доминирует когнитивное снижение; впоследствии развившееся накопление.

Состояние	Отличительный признак
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Ограниченные интересы и привязанность к предметам; также присутствует социально-коммуникативный дефицит.
Шизофрения / бред	Содержание бреда (опасность, значение).
Синдром Диогена (у пожилых)	Нарушение самообслуживания + накопительство; социальная изоляция; частая коморбидность с деменцией.

7. Обследование и оценка

- SI-R (англ. Saving Inventory-Revised), CIR (англ. Clutter Image Rating).
- Медицинское и когнитивное обследование (MMSE/MoCA у пожилых).
- Оценка безопасности.

8. Лечение

1. КПТ при навязчивом накопительстве (Frost R.O., Tolin D.F., Steketee G.) — первая линия; мануализированный 26-сеансовый протокол — повышение мотивации, когнитивная реструктуризация, тренировка принятия решений, упражнения по сортировке и выбрасыванию, домашние визиты. Доказательства: Tolin D.F. et al. Depress Anxiety 2015 мета-анализ (12 выборок, n=232) — симптомы значимо уменьшаются, но более чем у половины пациентов трудности сохраняются и после лечения.
2. СИОЗС — доказательная база ограничена; препараты, эффективные при ОКР, дают более слабый ответ при накопительстве. В адъювантной роли.
3. Когнитивная ремедиация — тренировка внимания, категоризации, принятия решений.
4. Подход Buoyancy — поддержка внутренней мотивации пациента; риск повторного захламления при принудительной уборке.
5. Общественное вмешательство — общественное здравоохранение, социальная служба, пожарная безопасность.
6. У пожилых людей — скрининг деменции и коморбидное вмешательство.

8.1 Методики лечения

1. КПТ для расстройства накопления (Hoarding) — Steketee G., Frost R.O. — Мануализированные 26 сеансов — мотивационное интервью, тренинг принятия решений, упражнение на сортировку, домашние визиты, когнитивная реструктуризация. IOCDF.
2. Опросник накопления-обновлённый (SI-R — Saving Inventory-Revised) — Frost (Frost R.O.) — 23 пункта; три подшкалы (приобретение, трудности с выбрасыванием, захламление).
3. Шкала оценки захламленности (CIR — Clutter Image Rating) — 9-балльная шкала; оценка степени захламленности комнаты на основе фотографии.
4. Групповая КПТ — Экономически эффективный формат; долгосрочная поддержка.

8.2 Различия между источниками

- Tolin D.F. et al. РКИ — КПТ эффективна; СИОЗС ограничены.
- Обзоры Saxena S. — ответ на СИОЗС слабее, чем при ОКР.

9. Прогноз

- Хроническое течение, тяжесть нарастает с возрастом.
- Значительное улучшение с помощью КПТ, но полная ремиссия редка.
- Коморбидная деменция — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Навязчивое собирательство — это просто черта „коллекционера“ или лень»

Доказательства: патологическое накопительство — когнитивно-поведенческая модель Frost & Hartl; отдельная нейробиологическая модель; функциональные нарушения и риск для здоровья. В отличие от коллекционирования, предметы не систематизированы и загромождают жилое пространство.

Миф 2: «Принудительная уборка дома пациента решит проблему»

Доказательства: принудительная уборка без согласия пациента приводит к выраженному дистрессу, травме и повторному захламлению в течение 12 месяцев. Рекомендуется постепенная сортировка с участием пациента.

Миф 3: «Навязчивое накопление — подтип обычного ОКР, достаточно СИОЗС»

Доказательства: DSM-5 и МКБ-11 — отдельная категория; ответ на СИОЗС слабее, чем при ОКР; КПТ с мануализированным протоколом — первая линия.

Миф 4: «Чрезмерное содержание животных „с благими намерениями“ полезно для животных»

Доказательства: «Накапливание животных» — приводит к плохой гигиене, питанию, медицинскому уходу за животными; множественная гибель животных, тяжёлое состояние выживших; требуется вмешательство ветеринарных органов и органов общественного здравоохранения.

Миф 5: «Навязчивое собирательство у пожилых — это „нормальное старение“»

Доказательства: У пожилых накопительство может быть маркером деменции (особенно лобно-височной); требуется когнитивная оценка.

Миф 6: «После однократной очистки проблема решается»

Доказательства: патологическое накопительство — хроническое расстройство; требует длительного лечения и поддержки сообщества.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B24 Hoarding disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Frost R.O., Hartl T.L. A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Behav Res Ther 1996;34(4):341–350.
4. Steketee G., Frost R.O. Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide. Oxford Univ Press; 2014.
5. Tolin D.F., Frost R.O., Steketee G. et al. Cognitive behavioral therapy for hoarding disorder: a meta-analysis. Depress Anxiety 2015;32(3):158–166.
6. Samuels J.F. et al. Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample. Behav Res Ther 2008;46(7):836–844.
7. Saxena S. Pharmacotherapy of compulsive hoarding. J Clin Psychol 2011;67(5):477–484.

МКБ-11 **6B25**	**6B25 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСНО НАПРАВЛЕННЫЕ СТЕРЕОТИПИИ** **Body-focused repetitive behaviour disorders**
МКБ-10 F63.3	Трихотилломания
DSM-5-TR F63.3 / F42.4	Трихотилломания (расстройство выдёргивания волос)

1. Определение и нозология

Патологические телесно направленные стереотипии (МКБ-11: 6B25 Расстройства с повторяющимися действиями, направленными на тело) — группа расстройств, характеризующихся повторяющимся вмешательством пациента в собственное тело (волосы, кожа, ногти). Основные подтипы:

- 6B25.0 — Трихотилломания (расстройство выдёргивания волос);
- 6B25.1 — Экскориация / Дерматилломания (расстройство сдирания кожи);
- 6B25.Y Другое уточнённое (кусание ногтей — онихофагия, кусание губ, кусание щёк).

В DSM-5-TR трихотилломания (F63.3) и экскориация (L98.1) кодируются отдельно, но в категории спектра ОКР.

2. История

- Hallopeau F.H. (1889) — термин «трихотилломания».
- DSM-III-R (1987) — трихотилломания как расстройство контроля импульсов.
- DSM-5 (2013) — перенесён в категорию спектра ОКР; экскориация добавлена как отдельный диагноз.
- МКБ-11 (2019) — как объединённая категория (зонтик 6B25).

3. Эпидемиология

- Трихотилломания: пожизненная распространённость 0,5–2%; в клинической форме у женщин 4:1.
- Экскориация: 1,4–5,4%; выше у женщин.
- Начало: подростковый возраст (10–13 лет).
- Коморбидность: БДР, тревога, ОКР, BDD, СДВГ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 30–40%; семейный анамнез распространён.
- Генетика — SAPAP3 (SLITRK1) — фенотип гипергруминга у мышей.
- Нейробиологически — кортико-стриато-таламо-кортикальная дисрегуляция, сходная с ОКР, но с другим профилем.
- Поведенческие механизмы: стрессовая реакция, «automatic» (автоматический, бессознательный) и «focused» (целенаправленный, с интенсивным вниманием) подтипы.

5. Клиническая картина

Трихотилломания (6B25.0)

- Выдёргивание волос — обычно с головы, бровей, ресниц; иногда с других частей тела.
- Видимая потеря волос.
- «Пред-выдергивательное напряжение» или «пост-выдергивательное облегчение» — присутствуют не у всех пациентов.
- Трихофагия (поедание выдернутых волос) — у 10–20% пациентов; «трихобезоар» — желудочно-кишечная непроходимость может потребовать хирургического вмешательства.

Экскориация / дерматилломания (6B25.1)

- Расчёсывание кожи — лицо, руки, поврежденные участки кожи (угри, место укуса насекомого).
- Травма, корка, следы.
- Инфекция, рубец, косметические последствия.

Общие характеристики

- Пациент предпринимает повторные безуспешные попытки прекратить поведение.
- Социальная изоляция из-за стыда (ношение парика, прикрывание рта/рук).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Выдёргивание волос (при трихотилломании) или расчёсывание кожи (при экскориации) — видимая потеря волос или повреждение кожи.

B. Пациент предпринимает повторные попытки прекратить или уменьшить поведение.

C. Поведение вызывает значительный дистресс или функциональное нарушение.

D. Исключение медицинского состояния (очаговая алопеция, дерматологическое заболевание) или другого психического расстройства (мотивация внешностью при BDD; бред при психозе; индуцированное веществом).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — Трихотилломания (F63.3) и экскориация (L98.1) отдельно.
- МКБ-11 — общая категория 6B25; под-спецификаторы.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (пациент часто не говорит открыто из-за стыда).
2. Дерматологическое обследование — исключение других причин выпадения волос и повреждения кожи (alopecia areata, tinea capitis, экзема).
3. Шкала — Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale (MGH-HPS), Skin Picking Scale.
4. Скрининг коморбидности.
5. Скрининг трихофагии — при наличии желудочно-кишечных симптомов.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Alopecia areata	Аутоиммунный; границы четкие, «exclamation mark hairs»; поведение выдёргивания волос отсутствует.
Tinea capitis	Грибковая инфекция; исследование КОН.
BDD (6B21)	Обсессия, связанная с внешностью; расчёсывание кожи с косметической целью.
ОКР (6B20)	Множественные обсессии; поведение, связанное с волосами и кожей, не является доминирующим.
Стереотипное двигательное расстройство (6A06)	Ритмичные повторяющиеся движения; специфического вмешательства в отношении тела нет.
Искусственное расстройство (6D50)	Мотивация поиска медицинских доказательств.
Психотический бред (ощущение паразитов — Экбом)	Содержание бреда.

7. Обследование и оценка

- MGH-HPS (трихотилломания), Skin Picking Scale-Revised.
- Дерматологическое обследование.
- УЗИ желудка при трихофагии.

8. Лечение

1. Habit Reversal Training (HRT) — терапия первой линии — awareness training, competing response (напр., сжатие кулака), мотивация, социальная поддержка. Доказательства: Bloch M.H. et al. Biol Psychiatry 2007 мета-анализ.
2. ACT (Терапия принятия и ответственности) — направлена на эмоциональный компонент.
3. Comprehensive Behavioral Treatment (ComB, Mansueto) — HRT + мультимодальное поведенческое вмешательство.

4. N-ацетилцистеин (NAC) — доказательная база развивается; Grant J.E. et al. Arch Gen Psychiatry 2009 РКИ — эффективность при трихотилломании.
5. СИОЗС — доказательная база ограничена; препараты, эффективные при ОКР, дают слабый ответ при трихотилломании; кломипрамин относительно предпочтительнее.
6. Атипичный антипсихотик адъюнкт — при рефрактерном случае.
7. Дерматологический уход — лечение травм и инфекций.

8.1 Методики лечения

1. Тренинг замещения привычки (англ. Habit Reversal Training, HRT) — Азрин (Azrin N.H.), Нанн (Nunn R.G.) — Пять основных компонентов — awareness training, competing response, мотивация, социальная поддержка, генерализация. Золотой стандарт при телесно-ориентированных повторяющихся поведениях.
2. Комплексное поведенческое лечение (ComB — Comprehensive Behavioral Treatment) — Мансуэто (Mansueto C.S.) — Модель SCAMP — персонализированный подход по сенсорной, когнитивной, аффективной, моторной и пространственной модальностям.
3. Терапия принятия и ответственности (англ. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) — Фокус на эмоциональный компонент; Woods D.W. et al. Behav Res Ther 2006 РКИ.
4. NAC — N-ацетилцистеин — Глутаматергический модулятор; 1200–2400 мг/сут; Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009.
5. Шкала выдёргивания волос Массачусетской больницы общего профиля (англ. Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale, MGH-HPS) — 7 пунктов; частота, интенсивность.

8.2 Различия между источниками

- Bloch M.H. Biol Psychiatry 2007 мета-анализ — HRT наиболее доказана при трихотилломании.
- Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009 — NAC 1200–2400 мг/сут эффективность.

9. Прогноз

- Хроническое течение, «waxing and waning».
- Значительное улучшение на фоне HRT; важно лечение коморбидности.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Выдёргивание волос и расчёсывание кожи — это „вредная привычка“, а не серьёзное расстройство»

Доказательства: клиническое нарушение; функциональные нарушения, социальная изоляция, риски инфекции и трихобезоара (хирургического).

Миф 2: «Пациент может прекратить по собственной воле»

Доказательства: пациент повторно пытается и терпит неудачу — это основной признак расстройства; требуется HRT или фармакотерапия.

Миф 3: «СИОЗС эффективны при трихотилломании (как при ОКР)»

Доказательства: ответ на СИОЗС слабее, чем при ОКР; HRT (тренинг замещения привычки) — первая линия; NAC — адъювант; кломипрамин относительно предпочтительнее СИОЗС.

Миф 4: «Скрытие волос (парик, макияж) — это решение»

Доказательства: Косметический камуфляж краткосрочный; требуется вмешательство в основное поведение.

Миф 5: «Только гипноз или глубокая психоаналитическая терапия устраняют основную причину поведения»

Доказательства: доказательная база ограничена; поведенческие подходы на основе HRT превосходят.

Миф 6: «Самоповреждение кожи — это реакция на „акне“ или косметическую проблему»

Доказательства: клиническое нарушение — пациент не может контролировать поведение, на коже образуются рубцы и инфекция; требуется клиническое вмешательство.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B25 Body-focused repetitive behaviour disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Bloch M.H. et al. Systematic review: pharmacological and behavioral treatment for trichotillomania. Biol Psychiatry 2007;62(8):839–846.

4. Grant J.E. et al. N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 2009;66(7):756–763.
5. Woods D.W., Wetterneck C.T., Flessner C.A. A controlled evaluation of acceptance and commitment therapy plus habit reversal for trichotillomania. Behav Res Ther 2006;44(5):639–656.
6. Mansueto C.S., Goldfinger Golomb R., Thomas A.M., Stemberger R.M.T. A comprehensive model for behavioral treatment of trichotillomania. Cogn Behav Pract 1999;6(1):23–43.
7. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.

6B40–6B4Z СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ

Disorders specifically associated with stress

МКБ-11 **6B40**	**6B40 ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (ПТСР)** **Post traumatic stress disorder**
МКБ-10 F43.1	Посттравматическое стрессовое расстройство
DSM-5-TR F43.10	Посттравматическое стрессовое расстройство

1. Определение и нозология

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР; МКБ-11: 6B40; DSM-5-TR: F43.10) — расстройство, развивающееся после личного переживания или непосредственного наблюдения смерти или угрозы смерти, серьёзной травмы или сексуального насилия, характеризующееся тремя основными доменами симптомов: повторное переживание (интрузивные), избегание, стойкое чувство угрозы (МКБ-11) / Когнитивно-аффективные изменения и гипервозбуждение (DSM-5-TR).

2. История

- «Shell shock» (Первая мировая война), «combat fatigue» (Вторая мировая).
- DSM-III (1980) — «Posttraumatic Stress Disorder» — на основе исследований ветеранов Вьетнама.
- DSM-5 (2013) — отделено от тревожных расстройств и перенесено в категорию «Расстройства, связанные с травмой и стрессом»; критерий А сужен (только конкретные виды травмы).

- МКБ-11 (2019) — более компактная диагностическая концепция; Комплексное ПТСР (6B41) формализовано как отдельная категория.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 3,9% (англ. WHO World Mental Health), в США ~6,8%.
- Пол: у женщин в 2 раза выше (в связи с риском сексуального насилия).
- Риск в зависимости от типа травмы: сексуальное насилие ~50% ПТСР, физическое нападение ~25%, авария ~10%, стихийное бедствие ~5%.
- Коморбидность: БДР ~50%, ГТР, паническое расстройство, употребление ПАВ, ПРЛ, комплексное ПТСР.
- Суицидальный риск повышен.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 30–40%.
- Нейробиологически — гиперактивность миндалевидного тела, нарушение префронтально-амигдалярной регуляции, уменьшение объёма гиппокампа, дисрегуляция оси HPA (парадоксально низкий кортизол).
- Характеристики травмы — тяжесть, длительность, организованное другими насилие (intentional), возникновение в детском возрасте.
- Факторы риска — предшествующая травма, предшествующий психиатрический анамнез, отсутствие социальной поддержки, женский пол, перитравматическая диссоциация.
- Защитный — социальная поддержка, поиск посттравматического смысла.

5. Клиническая картина

Три основных домена (МКБ-11)

- Повторное переживание — интрузивные воспоминания, флешбэки, кошмары; острая дистресс-реакция и соматические реакции на триггеры.
- Избегание — избегание мыслей, чувств, напоминаний, ситуаций, связанных с травмой.
- Стойкое чувство угрозы (гипервозбуждение) — гипервигильность, лёгкая стартл-реакция, нарушение сна, раздражительность.

DSM-5-TR дополнительный домен — когнитивно-аффективные изменения

- Негативные убеждения (о себе, других, мире)
- Ангедония, социальная изоляция.
- Притупление чувств, стойкое негативное настроение.

Длительность

Симптомы ≥ 1 месяца; начало может быть отсрочено после травмы (отсроченное начало > 6 месяцев).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Воздействие травматического события (личное, свидетель, информация о смерти/травме близких, повторное воздействие травматической информации в профессиональном контексте).

B. Повторное переживание (интрузивные воспоминания, флешбэки, ночные кошмары).

C. Избегание напоминаний о травме.

D. МКБ-11: постоянное чувство угрозы; DSM-5-TR: когнитивно-аффективные изменения + гипервозбуждение.

E. Длительность ≥ 1 месяц.

F. Значительный дистресс или функциональные нарушения

G. Исключение вещества или медицинского состояния

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR: 4 домена симптомов (интрузии, избегание, когнитивно-аффективный, гипервозбуждение); диссоциативный подтип-квалификатор (деперсонализация/дереализация); отсроченное начало.
- МКБ-11 (6B40): 3 домена симптомов (более компактно); комплексное ПТСР — отдельная категория (6B41).
- NICE NG116 (англ. 2018, Post-traumatic stress disorder): диагностика структурированным интервью (CAPS-5).
- VA/DoD 2023: золотой стандарт диагностики — CAPS-5; скрининг PCL-5 в первичной медицинской помощи.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + анамнез травмы.
2. CAPS-5 (англ. Clinician-Administered PTSD Scale) — золотой стандарт структурированного интервью.
3. PCL-5 (англ. PTSD Checklist) — самооценочный скрининг, 20 пунктов.
4. Коморбидность (БДР, ГТР, ПАВ, ПРЛ, комплексное ПТСР).
5. Суицидальный риск (C-SSRS).
6. Медицинское обследование и исключение черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Острое стрессовое расстройство (сходно с 6B40, DSM-5: ASD)	От 3 дней до 1 месяца.
Комплексное ПТСР (6B41)	Нарушение самоорганизации (аффект, самость, отношения).
Расстройство адаптации (6B43)	Травма не соответствует критерию А.
MDD (6A70/6A71)	Аффективные симптомы; интрузивные симптомы и избегание отсутствуют.
Паническое расстройство (6B01)	Приступ непредсказуем.
ПРЛ (6D10.x)	Стойкая модель личности; импульсивность и отношения.
Диссоциативные расстройства (6B6x)	Диссоциация доминантная; при ПТСР может быть квалификатором диссоциативного подтипа.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ)	Неврологические находки; когнитивный дефицит.

7. Обследование и оценка

- CAPS-5 — золотой стандарт.
- PCL-5 (20 пунктов) — скрининг.
- PHQ-9, GAD-7, C-SSRS — коморбидность.

- История травмы (LEC-5 — Life Events Checklist).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (VA/DoD 2023 · APA 2017 · консенсус NICE NG116)

1. Первая линия: травма-фокусированная психотерапия — индивидуальный формат:
    - Prolonged Exposure (PE, Foa E.B.) — in vivo и имагинальная экспозиция к травматическому воспоминанию.
    - Cognitive Processing Therapy (CPT, Resick P.A.) — когнитивная реструктуризация; 12 сеансов.
    - EMDR (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Shapiro F.) — билатеральная стимуляция + переработка травматического воспоминания.
    - Травма-фокусированная КПТ (TF-CBT, Cohen J.) — у детей и подростков.
2. Фармакотерапия первой линии: СИОЗС (сертралин и пароксетин — одобрены FDA для ПТСР), СИОЗСН (венлафаксин).
3. Вторая линия: миртазапин, нефазодон (риск для печени — с осторожностью).
4. Для кошмаров — празозин (α1-антагонист) — доказательная база спорна (Raskind 2003 — положительный, 2018 PACT trial — нейтральный); индивидуальный ответ.
5. Адъюнкт — атипичный антипсихотик (при рефрактерности); бензодиазепины противопоказаны при длительном применении (ухудшают течение ПТСР).
6. ЭСТ — при рефрактерной тяжёлой коморбидной депрессии.
7. Длительность лечения — психотерапия 12–16 сеансов; фармакотерапия ≥ 12 месяцев после ремиссии.

8.2 Методики лечения

1. Пролонгированная экспозиция (PE — Prolonged Exposure) — Фоа (Foa E.B.) — Имагинальная экспозиция к травматическому воспоминанию (повторяющееся, последовательное описание) + экспозиция in vivo (к избегаемым ситуациям). 10–15 сеансов. Доказательства: РКИ Foa E.B. et al.; золотой стандарт эффективности в мета-анализах.

2. Когнитивная процессуальная терапия (англ. Cognitive Processing Therapy, CPT) — Ресик (Resick P.A.) — Когнитивная реструктуризация — «застревающие точки» о травме (безопасность, доверие, сила, самооценка, близость). 12 сеансов. РКИ Resick P.A. et al.
3. Десенсибилизация и переработка движениями глаз (англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) — Шапиро (Shapiro F.) — Переработка травматического воспоминания с билатеральной стимуляцией (движение глаз, аудио или тактильная). 8-фазный протокол. Доказательства: Bisson J.I. et al. Cochrane 2013 — сравнительный эффект с КПТ.
4. Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия (англ. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-CBT) — Коэн (Cohen J.), Маннарино (Mannarino A.) — для детей и подростков 3–18 лет; протокол PRACTICE (Психообразование, Релаксация, Аффективная модуляция, Когнитивное совладание, Травматическое повествование, In vivo, Совместные сессии, Повышение безопасности).
5. Шкала ПТСР, применяемая клиницистом (англ. Clinician-Administered PTSD Scale, CAPS-5) — структурированное интервью из 30 пунктов; золотой стандарт.
6. Контрольный список ПТСР (PCL-5 — PTSD Checklist) — 20-пунктовая самооценка; скрининг и наблюдение.

8.3 Различия между источниками

- VA/DoD 2023 Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder: травма-фокусированная психотерапия — первая линия (настоятельная рекомендация); фармакотерапия — альтернатива первой линии; комбинация психотерапии и фармакотерапии не рекомендуется рутинно; бензодиазепины противопоказаны.
- APA 2017 PTSD Guideline: CPT, PE, когнитивная терапия и травма-фокусированная КПТ — настоятельная рекомендация; EMDR — условная. VA/DoD 2023 и ISTSS 2018 относят EMDR к высшему уровню наравне с CPT и PE.
- NICE NG116 (2018): травма-фокусированная КПТ или EMDR; СИОЗС — вторая линия.
- ISTSS 2018: международные рекомендации.
- Critical Incident Stress Debriefing (CISD) — Cochrane (Rose S. et al. 2002) и NICE открыто не рекомендуют; некоторые исследования показывают повышение риска ПТСР.

9. Прогноз

- Значительное улучшение у большинства пациентов при травма-фокусированной психотерапии.
- Хронификация без раннего вмешательства.
- Коморбидное БДР, употребление ПАВ — маркеры плохого прогноза.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ПТСР бывает только у ветеранов войны»

Доказательства: ПТСР может развиться после любого травматического события — сексуальное насилие (~50% развитие), физическое нападение, аварии, стихийные бедствия, медицинские процедуры. У ветеранов распространённость высокая, но в популяции также широко распространено.

Миф 2: «CISD (англ. Critical Incident Stress Debriefing) предотвращает ПТСР после травмы»

Доказательства: Cochrane (Rose S. et al. 2002) — CISD не снижает риск ПТСР, в некоторых исследованиях увеличивает. NICE и VA/DoD открыто не рекомендуют. В качестве раннего вмешательства рекомендуются «настороженное ожидание», а травма-фокусированная КПТ — только для пациентов с симптомами.

Миф 3: «Пациент не должен говорить о травме, „раскрытие“ вредно»

Доказательства: доказательные травма-фокусированные терапии (PE, CPT, EMDR) работают именно с травматическим воспоминанием; эффективны в соответствующей структурированной форме. Избегание усиливает ПТСР.

Миф 4: «Бензодиазепины — хорошее лечение ПТСР»

Доказательства: VA/DoD 2023, APA, NICE — бензодиазепины не рекомендуются; ухудшают течение ПТСР, препятствуют когнитивной обработке, обладают потенциалом зависимости.

Миф 5: «Забыть травматические воспоминания — главная цель»

Доказательства: цель — не забывчивость, а способность функционировать с воспоминанием; эмоциональная реакция снижается, но воспоминание остаётся. Пациент может говорить о травме без дистресса.

Миф 6: «Каннабис (КБД) излечивает ПТСР»

Доказательства: VA/DoD — каннабис не рекомендуется; имеются предварительные исследования, но недостаточно для клинических рекомендаций; ТГК может ухудшать течение ПТСР.

Миф 7: «MDMA-ассистированная терапия является официальным лечением»

Доказательства: MDMA-ассистированная психотерапия находится на стадии исследования; заявка на одобрение FDA в 2024 году отклонена (требуется повторное исследование); не входит в стандартную клиническую практику.

Миф 8: «Доказательная база EMDR слаба — это просто эффект плацебо»

Доказательства: Bisson J.I. Cochrane 2013, VA/DoD 2023 и ISTSS 2018 — EMDR настоятельно рекомендован, эффективность сопоставима с CPT и PE. Исключение — APA 2017 и 2025, где EMDR отнесён к условным.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B40 Post traumatic stress disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Department of Veterans Affairs / Department of Defense. Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder. 2023.
4. APA. Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD. 2017.
5. NICE NG116. Post-traumatic stress disorder. 2018.
6. Bisson J.I., Roberts N.P., Andrew M. et al. Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(12):CD003388.
7. Foa E.B., Hembree E.A., Rothbaum B.O. Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Oxford Univ Press; 2007.
8. Resick P.A., Monson C.M., Chard K.M. Cognitive Processing Therapy for PTSD: A Comprehensive Manual. Guilford Press; 2017.
9. Rose S., Bisson J., Churchill R., Wessely S. Psychological debriefing for preventing post-traumatic stress disorder. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD000560.
10. Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy: Basic Principles, Protocols, and Procedures. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2018.

11. Cohen J.A., Mannarino A.P., Deblinger E. Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2017.
12. Raskind M.A., Peskind E.R., Chow B. et al. Trial of prazosin for post-traumatic stress disorder in military veterans. N Engl J Med 2018;378(6):507–517.

МКБ-11 **6B41**	**6B41 ОСЛОЖНЕННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (К-ПТСР)** **Complex post traumatic stress disorder**
МКБ-10 F43.1	Посттравматическое стрессовое расстройство
DSM-5-TR F43.10	Посттравматическое стрессовое расстройство (отдельной категории в DSM-5-TR нет)

1. Определение и нозология

Комплексное ПТСР (МКБ-11: 6B41 Complex Post-Traumatic Stress Disorder) — расстройство, развивающееся в ответ на длительную или повторяющуюся травму, которой трудно или невозможно избежать (длительное насилие, физическое или сексуальное насилие в детстве, война, пытки, торговля людьми). К трём симптоматическим доменам ПТСР (повторное переживание, избегание, стойкое чувство угрозы) добавляется «нарушение самоорганизации» (DSO): нарушение регуляции аффекта, негативная самооценка, трудности в отношениях.

МКБ-11 — впервые добавлен как официальная диагностическая категория; в DSM-5-TR отдельной категории К-ПТСР нет (диссоциативный подтип ПТСР-квалификатор охватывает некоторые особенности).

2. История

- Herman J.L. (1992) — концепция «Комплексного ПТСР» (книга «Trauma and Recovery»); «Расстройство экстремального стресса, не уточнённое иначе» (DESNOS) — не было включено в DSM-IV.
- МКБ-11 (2019) — официальный код 6B41; отделение от ПТСР основано на доказательной базе (обзоры Cloitre M. et al.).

3. Эпидемиология

- Распространённость: среди пациентов, подвергшихся травме в первичной медицинской помощи, 1–8% (обзоры Brewin C.R. et al.).
- Особенно высока у пациентов с историей жестокого обращения в детстве.
- Коморбидность: БДР, ГТР, диссоциативные расстройства, ПРЛ (клиническое перекрытие), употребление ПАВ, расстройства пищевого поведения.

4. Этиология и патогенез

- Тип травмы — длительная, повторяющаяся, организованная другими (межличностная), трудность избегания.
- Травма, произошедшая в детстве, — широкое влияние на развитие личности.
- Нейробиологически — сходно с ПТСР, но более распространённая дисрегуляция HPA, диссоциация, нарушение аффективной регуляции.

5. Клиническая картина

Три основных домена ПТСР

- Повторное переживание (интрузии).
- Избегание.
- Стойкое чувство угрозы.

Нарушение самоорганизации (DSO) — основное дополнение к К-ПТСР

- Нарушение аффективной регуляции — эмоциональная лабильность, интенсивные реакции, эмоциональное оцепенение.
- Негативная самооценка — стойкое чувство стыда, вины, никчёмности.
- Трудности в отношениях — избегание близких отношений, стойкое нарушение привязанности.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (МКБ-11)

A. Воздействие длительной или повторяющейся травмы.

B. Существуют три основных домена ПТСР.

C. Три домена нарушения самоорганизации (DSO):

1. Нарушение аффективной регуляции;
2. Негативная самооценка;
3. Трудности в отношениях.

D. Значительные функциональные нарушения

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 — отдельная категория; требуется дополнительное ДСО.
- DSM-5-TR — К-ПТСР отдельно не выделяется; ПТСР с квалификатором «with dissociative features» охватывает некоторые особенности.
- ISTSS 2019 Complex PTSD Guidelines — рекомендует поэтапный подход.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + анамнез травмы (длительной, повторяющейся).
2. ITQ (англ. International Trauma Questionnaire — Cloitre M.) — разработан для дифференциации ПТСР и К-ПТСР.
3. Коморбидность (особенно ПРЛ, диссоциативные расстройства).
4. Оценка риска суицида и самоповреждения.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ПТСР (6B40)	Компонент DSO отсутствует.

Состояние	Отличительный признак
ПРЛ (6D10.x)	Клиническое перекрытие значимо; при ПРЛ доминируют импульсивность, нарушение идентичности и хроническая суицидальность; при К-ПТСР — симптомы, развившиеся на основе травмы.
Диссоциативные расстройства (6B6x)	Доминирует диссоциация.
MDD (6A70/6A71)	Аффективные симптомы; травма и ДСО отсутствуют.

7. Обследование и оценка

- ITQ (англ. International Trauma Questionnaire) — золотой стандарт.
- PCL-5 + дополнительные шкалы DSO.
- Скрининг ПРЛ (англ. McLean Screening Instrument for BPD).
- Суицид и самоповреждение (C-SSRS).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ISTSS 2019)

1. Фазовый подход (phase-based):
    - Фаза 1 — стабилизация: безопасность, навыки эмоциональной регуляции, стратегии совладания, психообразование.
    - Фаза 2 — переработка травматических воспоминаний: доказательные методы для ПТСР (PE, CPT, EMDR), но более длительные и устойчивые.
    - Фаза 3 — реинтеграция: восстановление отношений, улучшение качества жизни.
2. Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR — Cloitre M.) — вмешательство фазы 1 до проработки травматических воспоминаний.
3. Травма-фокусированная КПТ и EMDR — в адаптированной форме.
4. DBT-PTSD (Bohus M.) — при коморбидных состояниях с ПРЛ.
5. СИОЗС адъюнктивно — коморбидная депрессия и тревога.
6. Длительность лечения значительная (1–2 года и более).

7. Преемственность клинициста и терапевтический альянс критически важны.

8.2 Методики лечения

1. Тренинг навыков аффективной и межличностной регуляции (англ. Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation, STAIR) — Клуатр (Cloitre M.) — Фаза 1 — развитие эмоциональной регуляции и межличностных навыков; затем обработка травматических воспоминаний с помощью Narrative Story Telling (NST). 16–24 сеанса.
2. Диалектическая поведенческая терапия — ПТСР (DBT-PTSD) — Bohus (Bohus M.), Linehan (Linehan M.) — Принципы DBT + компоненты, сфокусированные на травме; особенно при коморбидных состояниях с ПРЛ.
3. Нарративная экспозиционная терапия (англ. Narrative Exposure Therapy, NET) — Шауэр (Schauer M.), Нойнер (Neuner F.), Эльберт (Elbert T.) — Пациент последовательно излагает историю жизни, прорабатываются травматические эпизоды; эффективность у беженцев и жертв пыток.
4. EMDR, CPT, PE — адаптированы — В рамках более длительного, фазового подхода.
5. Международный опросник травмы (англ. International Trauma Questionnaire, ITQ) — Клуатр (Cloitre M.) — Специфический валидированный инструмент для дифференциации ПТСР и К-ПТСР.

8.3 Различия между источниками

- ISTSS 2019 — Рекомендации по комплексному ПТСР: поэтапный подход.
- Обзоры Cloitre M. et al. — STAIR + Narrative Exposure Therapy эффективны.
- Bohus M. DBT-PTSD — доказательная база РКИ развивается.

9. Прогноз

- Хроническое течение; однако значительное улучшение при поэтапном подходе.
- Коморбидное ПРЛ, диссоциативные расстройства, употребление ПАВ — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Комплексное ПТСР — это просто новое название пограничного расстройства личности»

Доказательства: клиническое перекрытие значимо, но МКБ-11 К-ПТСР основано на травме; ПРЛ — отдельное расстройство личности. Шкалы ITQ и BPD дифференцируют; большинство пациентов с К-ПТСР не соответствуют критериям ПРЛ.

Миф 2: «После „закрытия“ травмы пациент нормализуется»

Доказательства: Длительная травма влияет на развитие личности; «закрыть» недостаточно; требуется поэтапный подход и длительное лечение.

Миф 3: «Стандартное лечение ПТСР (PE, CPT) одинаково эффективно при К-ПТСР»

Доказательства: ISTSS 2019 — поэтапный подход при К-ПТСР; пациент должен быть стабилизирован для проработки травмы (этап 1); прямая экспозиция может создать риск ретравматизации.

Миф 4: «Только антидепрессант достаточен для комплексного ПТСР»

Доказательства: психотерапия первой линии; фармакотерапия в роли адъюнкта.

Миф 5: «Нужно немедленно заставить пациента говорить о травме»

Доказательства: проработка травмы без стабилизации 1-й фазы может быть вредна; принципы травма-информированной помощи.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B41 Complex post traumatic stress disorder. 2024.
2. Cloitre M., Garvert D.W., Brewin C.R. et al. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. Eur J Psychotraumatol 2013;4:20706.
3. ISTSS Complex PTSD Treatment Guidelines. International Society for Traumatic Stress Studies; 2019.
4. Herman J.L. Trauma and Recovery. Basic Books; 1992.
5. Cloitre M., Koenen K.C., Cohen L.R., Han H. Skills training in affective and interpersonal regulation followed by exposure: a phase-based treatment for PTSD related to childhood abuse. J Consult Clin Psychol 2002;70(5):1067–1074.

6. Bohus M. et al. DBT-PTSD for posttraumatic stress disorder after childhood abuse: RCT. JAMA Psychiatry 2020;77(12):1235–1245.
7. Schauer M., Neuner F., Elbert T. Narrative Exposure Therapy: A Short-Term Treatment for Traumatic Stress Disorders. 2nd ed. Göttingen: Hogrefe, 2011.
8. Linehan M.M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2015.

МКБ-11 **6B42**	**6B42 ЗАТЯЖНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ГОРЯ** **Prolonged grief disorder**
МКБ-10 F43.8	Другие реакции на тяжёлый стресс
DSM-5-TR F43.81	Пролонгированная реакция горя

1. Определение и нозология

Затяжная патологическая реакция горя (МКБ-11: 6B42 Prolonged Grief Disorder; DSM-5-TR: F43.81 — добавлено в 2022 году) — расстройство, характеризующееся длительным, превышающим культурные и религиозные ожидания, горем и озабоченностью, вызывающими значительные функциональные нарушения после утраты близкого человека.

Отличие от нормальной утраты: продолжительность, интенсивность и функциональная нагрузка; клинический диагноз основывается на специфической длительности (МКБ-11: ≥ 6 мес; DSM-5-TR: ≥ 12 мес у взрослых, ≥ 6 мес у детей) и профиле симптомов.

2. История

- Lindemann E. (1944) — исследования динамики острого горя.
- Bowlby J. (1980) — привязанность и горе.
- Prigerson H.G. et al. (1995–2009) — концепция «Complicated Grief» / «Prolonged Grief»; разработка диагностических критериев.
- МКБ-11 (2019) — впервые официальная категория.

- DSM-5-TR (2022) — «Prolonged Grief Disorder» добавлен как официальный диагноз.

3. Эпидемиология

- Развитие после утраты близкого: в общей популяции 7–10%, при внезапной/насильственной смерти 49% (Lundorff M. et al. J Affect Disord 2017 мета-анализ).
- Пол: выше у женщин.
- Факторы риска: утрата в молодом возрасте, внезапная или насильственная смерть, потеря ребёнка, тревожная/амбивалентная привязанность.
- Пандемия COVID-19 увеличила распространённость затяжной реакции горя (Eisma M.C. et al.).

4. Этиология и патогенез

- Теория привязанности — нарушение когнитивной обработки при разлуке с близким привязанным лицом.
- Нейробиологическая — активация цепи вознаграждения, связанная с ностальгией по утраченной привязанности (fMRI-исследования O'Connor M.F.).
- Когнитивные — «застревающие» мысли, отсутствие здоровой интерпретации.

5. Клиническая картина

- Стойкая, интенсивная «ностальгия» или озабоченность утраченным человеком.
- Стойкие симптомы из следующих:
    - Нарушение чувства самости («часть меня умерла»);
    - Затруднение в принятии утраты;
    - Эмоциональная боль, связанная с утратой (печаль, гнев, вина);
    - Утрата смысла жизни;
    - Эмоциональное оцепенение;
    - Избегание социальной деятельности;
    - Трудности в поддержании отношений.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Смерть близкого человека (партнёр, родитель, ребёнок, брат/сестра, близкий друг).

B. Устойчивая и интенсивная тоска или постоянная озабоченность утраченным человеком, продолжающаяся ≥ 6 месяцев (МКБ-11) / ≥ 12 месяцев у взрослых и ≥ 6 месяцев у детей (DSM-5-TR) после утраты.

C. ≥ 3 из следующих симптомов:

1. Нарушение чувства самости;
2. Трудность принятия утраты;
3. Избегание напоминающих стимулов;
4. Интенсивная эмоциональная боль;
5. Трудность возвращения к социальной или иной деятельности;
6. Эмоциональное оцепенение;
7. Утрата смысла жизни;
8. Чувство одиночества и изоляции.

D. Длительность и интенсивность значительно превышают культурные, социальные или религиозные нормы.

E. Значительные функциональные нарушения

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 — длительность ≥ 6 месяцев.
- DSM-5-TR (обновление 2022) — у взрослых ≥ 12 мес., у детей ≥ 6 мес.; как минимум 1 основной симптом (интенсивная ностальгия или озабоченность) + ≥ 3 дополнительных симптома.
- NICE — отдельного руководства по затяжной реакции горя нет; применяются общие принципы управления горем.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — анамнез утраты, профиль симптомов, культурный контекст.
2. Шкала — Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13, Prigerson H.G.).
3. Коморбидность (БДР, ПТСР — необходима дифференциация в контексте утраты).

4. Суицидальный риск (высок у пациентов с горем).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Нормальное горевание	Волнообразное течение; социальное функционирование сохраняется; продолжительность находится в пределах культурной нормы.
MDD (6A70/6A71)	Ангедония, чувство никчёмности, суицидальные мысли, направленные на себя; при скорби содержание преимущественно связано с утратой.
ПТСР (6B40)	Травма и интрузии; при затяжном горе интрузии могут быть позитивными воспоминаниями.
Расстройство адаптации (6B43)	Стрессовый фактор может не быть утратой; более короткая продолжительность.

7. Обследование и оценка

- PG-13 (англ. Prolonged Grief Disorder-13, Prigerson H.G.) и обновление PG-13-R.
- ICG (англ. Inventory of Complicated Grief) — 19 пунктов.
- PHQ-9, C-SSRS — коморбидность.

8. Лечение

1. Первая линия: CGT (Терапия осложнённой утраты — Shear M.K.) — 16 сессий; психообразование, имагинальная и ситуационная экспозиция, реконструкция позитивных воспоминаний, ориентация на будущее. Доказательства: Shear M.K. et al. JAMA 2005 РКИ — превосходит интерперсональную терапию.
2. КПТ, адаптированная для работы с горем — Модель Boelen P.A.; когнитивная реструктуризация + экспозиция.
3. Фармакотерапия: доказательная база ограничена. При коморбидном БДР — СИОЗС. Сравнение CGT + циталопрам (Shear et al. JAMA

Psychiatry 2016) — CGT отдельно и CGT в комбинации с циталопрамом одинаково эффективны; циталопрам отдельно не превосходит плацебо.

4. Семейная и групповая поддержка.
5. Мониторинг суицидального риска.

8.1 Методики лечения

1. Терапия осложнённой утраты (CGT — Complicated Grief Treatment) — Шир (Shear M.K.) — 16-сессионный мануализированный протокол; работа, ориентированная на потерю + работа, ориентированная на восстановление; имагинальная и ситуационная экспозиция, позитивные воспоминания, ориентация на будущее. Доказательства: Shear M.K. et al. JAMA 2005, JAMA Psychiatry 2016 РКИ.
2. Шкала Затяжного Горя (PG-13 — Prolonged Grief-13) — Пригерсон (Prigerson H.G.) — 13-пунктовая шкала; клинический и популяционный скрининг; обновление PG-13-R.
3. Опросник осложнённой утраты (англ. Inventory of Complicated Grief, ICG) — 19 пунктов.

8.2 Различия между источниками

- Обзоры и РКИ Shear M.K. — CGT золотой стандарт.
- Wittouck C. et al. Clin Psychol Rev 2011 мета-анализ — интервенции, специфичные для горя, превосходят универсальную поддержку при затяжном горе.

9. Прогноз

- Значительное улучшение у большинства пациентов при КГТ.
- Без лечения — хронизация и развитие коморбидного БДР/ПТСР.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Горе всегда проходит через „5 стадий“ — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие»

Доказательства: Модель Kübler-Ross — полуакадемическая концепция; систематическая доказательная база отсутствует; горе — нелинейный, индивидуализированный процесс.

Миф 2: «Затяжная реакция горя — патологизированная нормальная печаль, не требующая лечения»

Доказательства: клинический диагноз ставится на основе длительности и функциональных нарушений; доказанные вмешательства приносят значительную пользу.

Миф 3: «Антидепрессант — первая линия при затяжной реакции горя»

Доказательства: Shear JAMA Psychiatry 2016 — CGT первая линия; циталопрам не превосходит плацебо; только при коморбидном MDD СИОЗС.

Миф 4: «Время лечит все раны — нужно просто подождать»

Доказательства: Большинство людей постепенно адаптируются, но у 7–10% развивается затяжное горе; без лечения — хронификация.

Миф 5: «Разговоры о горе вредны для пациента»

Доказательства: доказательные вмешательства (КПТ) работают именно с содержанием горя в структурированной форме; избегание усиливает затяжное горе.

Миф 6: «Социальные ритуалы (пожертвования, поминовение) вредны, отвлекают пациента от приятных воспоминаний»

Доказательства: культурные и религиозные ритуалы поддерживают процесс скорби; культурное уважение — важный компонент клинического вмешательства.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B42 Prolonged grief disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Shear M.K., Frank E., Houck P.R., Reynolds C.F. Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293(21):2601–2608.
4. Shear M.K. et al. Optimizing treatment of complicated grief: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016;73(7):685–694.
5. Prigerson H.G. et al. Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. PLoS Med 2009;6(8):e1000121.
6. Lundorff M. et al. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2017;212:138–149.

7. Wittouck C. et al. The prevention and treatment of complicated grief: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2011;31(1):69–78.
8. Boelen P.A., van den Hout M.A., van den Bout J. A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clin Psychol Sci Pract 2006;13(2):109–128.
9. O'Connor M.F., Wellisch D.K., Stanton A.L. et al. Craving love? Enduring grief activates brain's reward center. Neuroimage 2008;42(2):969–972.
10. Eisma M.C., Boelen P.A., Lenferink L.I.M. Prolonged grief disorder following the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Psychiatry Res 2020;288:113031.

МКБ-11 **6B43**	**6B43 РАССТРОЙСТВО АДАПТАЦИИ** **Adjustment disorder**
МКБ-10 F43.2	Расстройство приспособительных реакций
DSM-5-TR F43.2x	Расстройство адаптации

1. Определение и нозология

Расстройство адаптации (МКБ-11: 6B43 Adjustment Disorder; DSM-5-TR: F43.2x) — клинически значимые эмоциональные или поведенческие симптомы, возникшие в ответ на идентифицируемый стрессор (острый или хронический, индивидуальный или коллективный). Симптомы не достигают полных критериев другого психического расстройства (БДР, ГТР и т.д.).

2. История

- DSM-III (1980) — «Adjustment Disorder» официальный диагноз.
- МКБ-11 — в группе стресс-связанных расстройств; общий профиль симптомов «preoccupation» (озабоченность стрессором) + трудности адаптации.

3. Эпидемиология

- Один из наиболее частых психических диагнозов в первичной медицинской помощи; в клинических популяциях 5–20%.

- Пол и возраст — универсально; в молодом возрасте и в периоды нового стресса более интенсивно.
- Коморбидность: БДР, тревога, употребление ПАВ, суицидальный риск (особенно при краткосрочной острой форме).

4. Этиология и патогенез

- Стрессовый фактор — единичное событие (развод, потеря работы, диагноз болезни, горе) или множественные/постоянные стрессоры.
- Роль личности и копинг-ресурсов — один и тот же стресс вызывает разные реакции у разных людей.
- Социальная поддержка — защитный фактор.

5. Клиническая картина

- Озабоченность стрессовым фактором — повторяющиеся мысли, тревога.
- Трудность адаптации к новой ситуации.
- Эмоциональные симптомы — депрессивное настроение, тревога, раздражительность.
- Поведенческие симптомы — социальная отстранённость, снижение рабочей/школьной успеваемости, рискованное поведение.

DSM-5-TR подтипы

- С депрессивным настроением (F43.21);
- С тревогой (F43.22);
- С депрессивным настроением и смешанной тревогой (F43.23);
- С расстройством поведения (F43.24);
- Эмоциональное и поведенческое расстройство (F43.25);
- Неуточнённое (F43.20).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Реакция на идентифицируемый стрессовый фактор — начало в течение 3 месяцев (DSM-5-TR) / 1 месяца (МКБ-11).

B. Симптомы клинически значимы — дистресс или функциональное нарушение, несоразмерные стрессу.

C. Не достигает критериев другого психического расстройства (БДР, ГТР, ПТСР, комплексное ПТСР, затяжная реакция горя).

D. Не является нормальной реакцией утраты (скорби).

E. Симптомы проходят в течение 6 месяцев после прекращения стрессового фактора (или его последствий) (DSM-5-TR).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — начало в 3 мес.; квалификаторы подтипа.
- МКБ-11 — начало 1 месяц; «preoccupation with the stressor» — основной признак; подтипов нет, но есть дополнительные квалификаторы настроения-тревоги.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — стрессовый фактор, начало симптомов, предшествующий психиатрический анамнез.
2. SCID-5, MINI.
3. Шкала — PHQ-9, GAD-7 тяжесть симптомов.
4. Исключение БДР, ГТР, ПТСР, комплексного ПТСР.
5. Суицидальный риск (C-SSRS) — особенно высок при острой форме.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
MDD (6A70/6A71)	5+ симптомов в течение 2 недель, полный критерий.
ГТР (6B00)	≥ 6 месяцев (DSM); множественные сферы.
ПТСР (6B40)	Травматическое событие + интрузии, избегание, гипервозбуждение.
Затяжное горе (6B42)	≥ 6 месяцев (МКБ-11) / 12 месяцев (DSM-5-TR) после утраты близкого.
Нормальная реакция утраты/стрессовая реакция	Функциональное нарушение отсутствует или соответствует контексту.
Расстройство поведения (6C91)	Стойкая модель, не связана со стрессом.

7. Обследование и оценка

- PHQ-9, GAD-7, C-SSRS.
- Документирование стрессового фактора.

8. Лечение

1. Первая линия: краткосрочная психотерапия — поддерживающее, проблемно-решающее, краткое вмешательство на основе КПТ (8–12 сеансов).
2. Управление стрессом, усиление социальной поддержки, развитие копинг-стратегий.
3. Фармакотерапия — только при тяжёлом течении или коморбидности; СИОЗС краткосрочно; бензодиазепины при острой тревоге 1–2 недели.
4. Мониторинг суицидального риска.
5. Устранение или модификация стрессового фактора (по возможности).

8.1 Методики лечения

1. Краткосрочная терапия решения проблем (англ. Problem-Solving Therapy) — Nezu (Nezu A.M.) — 4–8 сессий; идентификация конкретной проблемы, оценка вариантов решения, поведенческая реализация.
2. Поддерживающая психотерапия — Валидация, эмоциональное выражение, социальная поддержка.
3. КПТ в краткой форме — Когнитивная реструктуризация + поведенческая активация.
4. Управление стрессом и релаксация — Дыхательные упражнения, прогрессивная мышечная релаксация, майндфулнес.

8.2 Различия между источниками

- NICE — отдельного руководства по расстройству адаптации нет; общие принципы тревоги и депрессии.
- ВОЗ mhGAP — поддерживающий подход при острых стрессовых реакциях, «watchful waiting» при лёгких случаях.
- Доказательная база ограничена — резидуальный характер диагноза.

9. Прогноз

- В большинстве случаев ремиссия в течение 6 месяцев.

- В части случаев состояние затягивается или переходит в БДР/ПТСР — рекомендуется наблюдение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Расстройство адаптации — не настоящий диагноз, а просто „трудность жизни“»

Доказательства: клинический диагноз требует функциональных нарушений или острого дистресса; особенно следует оценивать риск суицида.

Миф 2: «Когда стрессовый фактор проходит, диагноз автоматически снимается, лечение не требуется»

Доказательства: некоторые случаи затягиваются или переходят в БДР/ПТСР; краткосрочное вмешательство предотвращает переход.

Миф 3: «Антидепрессант — первая линия при расстройстве адаптации»

Доказательства: психотерапия первой линии; фармакотерапия только в тяжёлых или коморбидных случаях.

Миф 4: «Риск суицида при расстройстве адаптации низок»

Доказательства: Острые стрессовые реакции сопровождаются высоким риском импульсивного суицида; активная оценка.

Миф 5: «Пациент бессилен или имеет „слабый характер“»

Доказательства: реакция является результатом взаимодействия тяжести стресса и копинг-ресурсов; объяснение слабостью характера стигматизирующее и ошибочное.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B43 Adjustment disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maercker A. et al. ICD-11 stress-related disorders. World Psychiatry 2013;12(3):198–206.
4. Casey P. Adjustment disorder: epidemiology, diagnosis and treatment. CNS Drugs 2009;23(11):927–938.
5. Nezu A.M., Nezu C.M., D’Zurilla T.J. Problem-Solving Therapy: A Treatment Manual. New York: Springer, 2013.

МКБ-11 **6B44**	**6B44 РЕАКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИВЯЗАННОСТИ** **Reactive attachment disorder**
МКБ-10 F94.1	Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте
DSM-5-TR F94.1	Реактивное расстройство привязанности

1. Определение и нозология

Реактивное расстройство привязанности (МКБ-11: 6B44; DSM-5-TR: F94.1 Реактивное расстройство привязанности) — нарушение поведения привязанности, развивающееся вследствие тяжёлой психосоциальной депривации или неадекватного ухода на раннем этапе детства; ребёнок не ищет помощи у воспитателя при дистрессе или этот поиск резко снижен.

2. История

- Bowlby J. (1951) — доклад о материнской депривации (ВОЗ).
- Spitz R.A. (1945) — «госпитализм» у институционализированных детей.
- DSM-III (1980) — официальное признание «Reactive Attachment Disorder of Infancy».
- DSM-5 (2013) и МКБ-11 — RAD и Disinhibited Social Engagement Disorder (DSED) как отдельные диагнозы.
- Nelson C.A. et al. Science 2007 — Bucharest Early Intervention Project — влияние институциональной депривации и раннего фостеринга.

3. Эпидемиология

- В общей популяции редко; даже у детей, переживших тяжёлую депривацию, — менее 10% (DSM-5-TR); у институционализированных детей ингибированный (RAD) тип ~5% (Gleason M.M. et al. JAACAP 2011, BEIP). Показатели выше 30% относятся к расстройству социальной расторможенности (6B45), а не к RAD.
- Начало до 5 лет.

- Коморбидность: когнитивные дефициты, нарушения нейроразвития, депрессивные симптомы.

4. Этиология и патогенез

- Тяжёлая психосоциальная депривация — институционализм, множественные смены места, пренебрежение.
- Нарушение взаимодействия между опекуном и ребёнком в критический период до 5 лет.
- Нейробиология системы привязанности — окситоцин, префронтально-амигдалярная цепь.

5. Клиническая картина

- Отсутствие обращения за помощью к ухаживающему лицу при дистрессе или минимальные попытки такого обращения.
- Трудности в принятии утешения.
- Снижение социальных и эмоциональных реакций (отстранение, раздражительность, печаль).
- Снижение позитивного аффекта.
- Отстранённое, гиповигильное поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Стойкое нарушение поведения привязанности — ребёнок в дистрессе не ищет помощи у воспитателя или даёт минимальную реакцию на контакт.

B. Стойкое эмоциональное и социальное нарушение (дефицит положительного аффекта, необъяснимая раздражительность, печаль или страх).

C. Расстройство развилось вследствие раннего тяжёлого нарушения ухода (неглект, многократная смена места, институционализм).

D. Начало до 5 лет.

E. Не объясняется лучше расстройством аутистического спектра.

F. Возраст развития ребёнка не менее 9 месяцев (возможность формирования привязанности).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — RAD форма отстранения; DSED форма расторможенности — отдельный диагноз (6B45).
- МКБ-11 — те же две отдельные категории.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью с опекуном или социальным работником — история ухода (институционализация, смена места, пренебрежение уходом).
2. Структурированное интервью (англ. Disturbances of Attachment Interview, Smyke A.T., Zeanah C.H., DAI).
3. Клиническое наблюдение взаимодействия ребёнка и ухаживающего лица.
4. Исключение расстройства аутистического спектра (M-CHAT-R/F, ADOS).
5. Когнитивная и развитийная оценка.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Социально-коммуникативный дефицит, ограниченно-повторяющееся поведение; поведение привязанности вариабельно.
DSED (6B45)	Неограниченный социальный подход, неадекватное взаимодействие с незнакомыми людьми.
Интеллектуальная инвалидность (6A00)	Общий когнитивный дефицит.
ПТСР (6B40)	Конкретное травматическое событие; интрузии.
Депрессивное расстройство	Аффективный компонент.

7. Обследование и оценка

- DAI (англ. Disturbances of Attachment Interview).
- Процедура «Незнакомая ситуация» (Ainsworth M.) — в контексте исследования.

- Оценка развития (Bayley, Mullen).

8. Лечение

1. Обеспечение стабильной, непрерывной среды ухода — патронаж, усыновление; институциональная среда является противопоказанием.
2. Вмешательства, направленные на взаимодействие ухаживающего лица и ребёнка — Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC, Dozier M.), Child-Parent Psychotherapy (CPP, Lieberman A.).
3. Травма-фокусированный подход — TF-CBT добавляется в контексте травмы.
4. Лечение коморбидных расстройств (депрессия, тревога, СДВГ).
5. Фармакотерапия — специфического одобрения для самого RAD нет; при коморбидных симптомах.
6. Холдинг-терапия, ребёфинг — опасны, запрещены (зарегистрирована детская смерть; заявление APSAC 2006).

8.1 Методики лечения

1. Привязанность и биоповеденческое восстановление (англ. Attachment and Biobehavioral Catch-up, ABC) — Дозье (Dozier M.) — Обучение родителей за 10 сеансов; на дому; укрепление «заботливого» (nurturance) и «синхронного» взаимодействия. Доказательства: Dozier M. et al. Dev Psychopathol 2008;20(3):845–859.
2. Детско-родительская психотерапия (CPP — Child-Parent Psychotherapy) — Либерман (Lieberman A.) — Для RAD на фоне травмы; возраст 0–5 лет; в контексте взаимодействия родитель-ребёнок.
3. Интервью нарушений привязанности (англ. Disturbances of Attachment Interview, DAI) — Смайк (Smyke A.T.), Зина (Zeanah C.H.) — клиническое интервью из 12 пунктов.
4. Стабильный уход и фостеринг — Bucharest Early Intervention Project — значительное улучшение показателей развития у институционализированных детей при раннем патронатном воспитании.

8.2 Различия между источниками

- AACAP Practice Parameter (Zeanah C.H., Chesher T., Boris N.W. JAACAP 2016).
- APSAC (Американское профессиональное общество по проблемам жестокого обращения с детьми) — «терапия удержания» и подобные принудительные методы запрещены.

- Bucharest Early Intervention Project (Nelson Science 2007) — раннее размещение в приёмные семьи значительно улучшает исходы у детей из учреждений.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при ранней стабильной помощи и вмешательстве.
- Длительная институциональная депривация — остаточные когнитивные и эмоциональные дефициты.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «„Холдинг-терапия“ и „ребёфинг“ излечивают RAD»

Доказательства: APSAC 2006 — эти методы не имеют научной основы, вредны; отмечена смерть Candace Newmaker (2000) во время «ребёфинга». AACAP, APSAC — абсолютное противопоказание.

Миф 2: «Усыновлённый ребёнок „исправится“ любовью»

Доказательства: стабильная забота близкого человека важна, но тяжёлое PAC требует структурированного вмешательства (ABC, CPP).

Миф 3: «RAD — это форма аутизма»

Доказательства: RAD основано на психосоциальной депривации; аутизм — нейроонтогенетическое расстройство. При стабильном уходе RAD значительно улучшается, аутизм — нет.

Миф 4: «Пациент „манипулятивен“, требует строгой дисциплины»

Доказательства: Клинические проявления RAD являются следствием нарушения системы привязанности, а не манипуляции; подход, основанный на наказании, усиливает симптомы.

Миф 5: «Только антипсихотики или стимуляторы эффективны при PAC»

Доказательства: Специфического одобренного FDA препарата для RAD нет; изменение среды и психосоциальное вмешательство — первая линия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B44 Reactive attachment disorder. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H., Chesher T., Boris N.W. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(11):990–1003.
4. Nelson C.A., Zeanah C.H., Fox N.A. et al. Cognitive recovery in socially deprived young children: the Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
5. Dozier M. et al. Effects of an attachment-based intervention on the cortisol production of infants and toddlers in foster care. Dev Psychopathol 2008;20(3):845–859.
6. APSAC Task Force Report on Attachment Therapy, Reactive Attachment Disorder, and Attachment Problems. American Professional Society on the Abuse of Children; 2006.
7. Ainsworth M.D.S., Blehar M.C., Waters E., Wall S. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum, 1978.
8. Lieberman A.F., Van Horn P. Psychotherapy with Infants and Young Children: Repairing the Effects of Stress and Trauma on Early Attachment. New York: Guilford Press, 2008.
9. Smyke A.T., Dumitrescu A., Zeanah C.H. Attachment disturbances in young children. I: The continuum of caretaking casualty. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(8):972–982.
10. Gleason M.M., Fox N.A., Drury S. et al. Validity of evidence-derived criteria for reactive attachment disorder: indiscriminately social/disinhibited and emotionally withdrawn/inhibited types. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(3):216–231.

	6B45 РАССТРОЙСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО РАСТОРМОЖЕННОМУ ТИПУ
МКБ-11 **6B45**	**Disinhibited social engagement disorder**
МКБ-10 F94.2	Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу

	6B45 РАССТРОЙСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО РАСТОРМОЖЕННОМУ ТИПУ
МКБ-11 **6B45**	**Disinhibited social engagement disorder**
DSM-5-TR F94.2	Расстройство социальной расторможенности

1. Определение и нозология

Расстройство социализации по расторможенному типу (МКБ-11: 6B45; DSM-5-TR: F94.2 Расторможенное расстройство социальной вовлечённости, DSED) — чрезмерное и неуместное дружелюбие ребёнка с незнакомыми людьми, поведение приближения или ухода без осторожности — вследствие ранней психосоциальной депривации (институционализация, множественные смены места).

Имеет ту же этиологическую основу, что и RAD, но с противоположными клиническими проявлениями — неограниченным подходом вместо отстранённости.

2. История

- DSM-IV (1994) — «Реактивное расстройство привязанности, расторможенный тип».
- DSM-5 (2013) — «Disinhibited Social Engagement Disorder» добавлен как отдельный диагноз.
- МКБ-11 (2019) — параллельно.

3. Эпидемиология

- В общей популяции редко; у институционализированных детей 20%, у детей в приемных семьях 10–15%.
- Начало до 5 лет.

- Значительное снижение при раннем фостеринге (англ. Bucharest Early Intervention Project), но, в отличие от RAD, DSED иногда сохраняется даже в стабильной среде ухода.

4. Этиология и патогенез

- Тяжёлая психосоциальная депривация — то же, что при RAD.
- Множественная ротация ухаживающих в институциональной среде — формирование «промиссуитетной привязанности».

5. Клиническая картина

- Открытое приближение к незнакомым людям, уход с ними без осторожности.
- Неосторожная физическая близость (объятия, сидение).
- Снижение поведения оглядывания на ухаживающее лицо при взаимодействии с незнакомцем.
- Отсутствие восприятия опасности незнакомцев.
- Академические и социальные нарушения.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Неуместно открытое, дружелюбное поведение с незнакомыми людьми — ≥ 2 из следующих:

1. Сниженная или отсутствующая осторожность при приближении к незнакомым людям;
2. Физическая или вербальная близость, не соответствующая культурным нормам или возрасту;
3. Снижение поведения проверки-поиска опекуна в незнакомом месте;
4. Минимальная или отсутствующая осторожность при уходе с незнакомым человеком.

B. Поведение не ограничивается только импульсивностью (СДВГ) — компонент социальной привлекательности очевиден.

C. Раннее тяжёлое нарушение ухода — пренебрежение уходом, множественные смены места, институционализм.

D. Возраст развития ребёнка ≥ 9 месяцев.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаковые критерии; DSED отдельно от RAD.
- Возрастное развитие должно учитываться — у маленьких детей нормальный социальный интерес не следует путать с DSED.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью и наблюдение — взаимодействие ребёнка с незнакомыми людьми.
2. История ухода.
3. DAI (англ. Disturbances of Attachment Interview).
4. Скрининг коморбидности (СДВГ, аутизм).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
RAD (6B44)	Отстранение, отсутствие привязанности; при DSED — открытый подход.
СДВГ (6A05)	Импульсивность, но компонент социальной привлекательности отсутствует.
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Социально-коммуникативный дефицит.
Синдром Уильямса	Генетика; «гиперсоциабельность» + специфические физические особенности.

7. Обследование и оценка

- DAI.
- Наблюдение в незнакомой обстановке.
- Синдром Вильямса — генетический тест (FISH 7q11.23) — при подозрении.

8. Лечение

1. Стабильная среда ухода.

2. Обучение родителей — развитие концепции «безопасной базы» для ребёнка; программы ABC.
3. Обучение соблюдению соответствующей дистанции с незнакомым человеком.
4. Лечение коморбидности (СДВГ).
5. Координация сообщества и школьного персонала — безопасность ребёнка.
6. Специфической фармакотерапии нет; для коморбидных симптомов.

8.1 Методики лечения

1. Привязанность и биоповеденческое восстановление (англ. Attachment and Biobehavioral Catch-up, ABC) — Дозье (Dozier M.) — Также используется для RAD; при DSED — усиление синхронизации опекун-ребёнок.
2. Обучение безопасности — Обучение ребёнка соблюдению дистанции с незнакомыми людьми; подкрепление поведения проверки опекуна.
3. DAI — При дифференциации RAD и DSED.

8.2 Различия между источниками

- AACAP 2016 — те же рекомендации, что и для RAD.
- DSED, в отличие от RAD, может сохраняться и в стабильной среде — долгосрочное наблюдение.

9. Прогноз

- Улучшение при стабильном уходе и вмешательстве; однако DSED иногда сохраняется длительно.
- Во взрослом возрасте могут сохраняться импульсивные отношения, риски эксплуатации.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Открытый, дружелюбный ребёнок — это положительная черта, а не расстройство»

Доказательства: Соответствующая социальная дистанция является признаком стадии развития; при DSED отсутствие границ повышает риск эксплуатации ребёнка.

Миф 2: «DSED быстро проходит при стабильном уходе»

Доказательства: В отличие от RAD, DSED иногда сохраняется и в стабильной среде (Бухарестское исследование); требуется долгосрочное вмешательство.

Миф 3: «ДСРД — это „лёгкая форма“ аутизма»

Доказательства: отдельное расстройство; этиология — психосоциальная депривация; клинические проявления противоположны (при аутизме — социальная отгороженность, при DSED — расторможенный подход).

Миф 4: «Наказанием можно „исправить“ ребёнка»

Доказательства: наказание усиливает расстройство и оказывает травматическое воздействие; рекомендуется подход, основанный на позитивной привязанности.

Миф 5: «Синдром Вильямса и ДРСЭ — одно и то же»

Доказательства: Синдром Вильямса — генетическое расстройство (делеция 7q11.23) со специфическим физическим и когнитивным профилем; хотя присутствует признак «гиперсоциабельности», это отдельное нейробиологическое и этиологическое расстройство.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B45 Disinhibited social engagement disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H. et al. AACAP Practice Parameter. JAACAP 2016;55(11):990–1003.
4. Gleason M.M. et al. Validity of evidence-derived criteria for reactive attachment disorder: indiscriminately social/disinhibited and emotionally withdrawn/inhibited types. JAACAP 2011;50(3):216–231.
5. Nelson C.A. et al. Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
6. Dozier M., Bernard K. Attachment and biobehavioral catch-up: addressing the needs of infants and toddlers exposed to inadequate or problematic caregiving. Curr Opin Psychol 2017;15:111–117.

6B60–6B6Z ДИССОЦИАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Dissociative disorders

МКБ-11 **6B64**	**6B64** **ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ (ДРИ)** **Dissociative identity disorder**
МКБ-10 F44.81	—
DSM-5-TR F44.81	Диссоциативное расстройство идентичности

1. Определение и нозология

Диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ; МКБ-11: 6B64 Диссоциативное расстройство идентичности; DSM-5-TR: F44.81) — тяжёлое диссоциативное расстройство, характеризующееся переключениями между двумя или более различными состояниями личности («идентичностями», «альтерами»). Каждая идентичность имеет относительно устойчивое собственное чувство, паттерны памяти, поведения, аффекта, восприятия и когниции. Одновременно наблюдаются постоянные диссоциативные амнезии (повседневные события, важная личная информация, травма).

ДРИ связано с тяжёлой детской травмой (особенно повторяющимся физическим или сексуальным насилием); образ «split personality» искажён в СМИ и отличается от клинической реальности.

2. История

- 1791 — Eberhardt Gmelin, первое описание случая.
- Janet P. (1880-е годы) — концепция «диссоциации».
- DSM-III (1980) — «Multiple Personality Disorder».

- DSM-IV (1994) — термин «Диссоциативное расстройство идентичности».
- 1980–90-е годы — спор о «ложной памяти»; утверждения об «ятрогенной индукции» в некоторых случаях диагностики.
- ISSTD Treatment Guidelines (Adult Treatment, 3rd Revision 2011) — стандартизировали фазово-ориентированный подход.

3. Эпидемиология

- Распространённость в клинических популяциях: 1–3 %; в общей популяции ~1,5 % (обзор Sar V. ISRN Psychiatry 2011).
- Пол: у женщин в клинических популяциях в 5–9 раз выше.
- Начало: симптомы формируются в детстве, в клинику обращаются часто в 20–40 лет.
- Коморбидность: БДР, ПТСР, комплексное ПТСР, ПРЛ, соматический симптом, расстройства пищевого поведения, употребление ПАВ; риск суицида очень высокий.

4. Этиология и патогенез

- Травматическая модель — повторяющаяся тяжёлая травма в детстве (сексуальное или физическое насилие, пренебрежение уходом, насилие со стороны ухаживающего); 90%+ пациентов имеют травматический анамнез (обзоры Putnam F.W.).
- Нейробиологически — уменьшение объёма гиппокампа и миндалевидного тела; дисрегуляция сети пассивного режима и сети значимости (обзоры Reinders A.A. et al.).
- Привязанность — дезорганизованный стиль привязанности в детстве.
- Ятрогенез / сторонники социально-когнитивной модели — некоторые диагнозы могут быть результатом терапевтической индукции (критика Lilienfeld S.O.); однако большинство исследований поддерживают травматическую модель.

5. Клиническая картина

- Два или более различных состояния идентичности — часть пациентов документирует явные переключения, другие проявляются только через «внутренние голоса», ощущение «потери контроля».
- Стойкие амнезии — повседневные события, личная информация, травматические эпизоды.

- Деперсонализация и дереализация.
- Переключения идентичности в ответ на стресс, триггеры.
- Самоповреждения, попытки суицида, соматические симптомы.
- Комплексные диссоциативные симптомы (диссоциативные приступы, соматоформные).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Два или более различных состояния личности — значительное нарушение чувства себя и агентности, изменения в поведении, аффекте, восприятии, когниции или сенсомоторных функциях.

B. Повторяющиеся амнезии на повседневные события, важную личную информацию и/или травматические события.

C. Значительный дистресс или функциональные нарушения

D. Не является частью широко распространённой культурной или религиозной практики.

E. Исключение вещества или медицинского состояния (напр. судороги)

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — одинаковые критерии; у детей воображаемый спутник исключается, так как является частью нормального развития.
- МКБ-11 — амнезия не обязательна: сказано «обычно бывают эпизоды амнезии», тогда как DSM-5-TR требует её в качестве критерия B. Расстройства транса и одержимости в МКБ-11 — отдельные категории (6B62, 6B63).
- ISSTD Guidelines 2011 — диагноз должен быть подтверждён структурированным интервью (SCID-D).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — анамнез травмы, диссоциативные симптомы.
2. SCID-D (англ. Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders) — золотой стандарт.
3. Шкала — DES (Dissociative Experiences Scale, cut-off ≥ 30, показатель ДРИ ≥ 45); MID (англ. Multidimensional Inventory of Dissociation).
4. Коморбидность (ПТСР, ПРЛ, БДР, ПАВ).

5. Риск суицида и самоповреждения (высокий).
6. Медицинское и неврологическое — исключение приступов, энцефалита (ЭЭГ, МРТ).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность и импульсивность доминируют; клиническое перекрытие значительное, коморбидность высокая.
ПТСР / К-ПТСР (6B40/6B41)	Травматические интрузии и избегание — основные; диссоциация может быть компонентом.
Шизофрения (6A20)	«Голоса» при шизофрении отличаются — как внутренний диалог; не характерны для психоза.
Биполярное расстройство (6A60)	Аффективные эпизоды; диссоциации нет.
Искусственное расстройство (6D50)	Ложь, связанная с медицинской ролью; мотивация получения выгоды.
Приступ (эпилептический или неэпилептический)	ЭЭГ.
«Одержимость» — культурная	Контекст и культурная норма.

7. Обследование и оценка

- SCID-D-R — золотой стандарт структурированного интервью.
- Шкалы DES, MID.
- C-SSRS суицид; оценка самоповреждения.
- ЭЭГ — исключение приступа.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ISSTD 2011)

1. Фазово-ориентированный (трёхфазный) подход:

- Фаза 1 — стабилизация и уменьшение симптомов: безопасность, эмоциональная регуляция, навыки совладания, снижение госпитализаций, управление самоповреждением.
- Фаза 2 — переработка травматических воспоминаний: Адаптированное травма-фокусированное вмешательство.
- Фаза 3 — интеграция и реабилитация: коммуникация между идентичностями, функциональное восстановление, отношения.

2. Специфические психотерапевтические подходы — цитирование Internal Family Systems (Schwartz R.), модифицированная EMDR.
3. Фармакотерапия — специфического одобрения для ДРИ нет; при коморбидных ПТСР, БДР, симптомах тревоги — СИОЗС, празозин (кошмары).
4. Госпитализация — при остром риске самоповреждения или суицида.
5. Мультидисциплинарный подход — психиатр, психолог, социальная поддержка.
6. Длительное лечение (годы); преемственность клинициста и терапевтический альянс критичны.

8.2 Методики лечения

1. Фазово-ориентированное лечение (Phase-Oriented Treatment — ISSTD) — Трехфазный подход; последовательность и стабильность пациента являются основой.
2. Структурированное клиническое интервью для диссоциативных расстройств (англ. Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders, Revised, SCID-D-R) — 277-пунктовое структурированное интервью; золотой стандарт.
3. Шкала диссоциативных переживаний (англ. Dissociative Experiences Scale, DES) — 28 пунктов; скрининг.
4. Многомерный опросник диссоциации (англ. Multidimensional Inventory of Dissociation, MID) — 218 пунктов; подробный диссоциативный профиль.
5. EMDR — модифицированная — Переработка травмы после стабилизации; последовательно и адаптировано к устойчивости пациента.

8.3 Различия между источниками

- ISSTD 2011 — фазово-ориентированный золотой стандарт.

- Травма-основанный подход и предосторожность против ятрогенеза — избегание поиска или индукции «альтеров».

9. Прогноз

- Функциональное восстановление при длительной фазово-ориентированной терапии.
- Отслеживается высокий риск суицида и самоповреждений.
- Лечение коморбидности обязательно.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ДРИ — это „раздвоение личности“, как в СМИ»

Доказательства: образы в кино или на телевидении (драматические переключения, «другие личности») не совпадают с более тонкой клинической картиной у большинства пациентов — доминируют «потеря контроля», внутренние голоса, амнезии.

Миф 2: «DID — это ложь, индуцированная терапевтом»

Доказательства: сильная связь с детской травмой (обзоры Putnam); нейробиологические маркеры (Reinders fMRI); международные исследования согласованы. Однако диагностика должна быть осторожной — важно избегать техник индукции альтеров.

Миф 3: «ДРИ — редкое или вымышленное расстройство»

Доказательства: распространённость 1–3% в клинических популяциях (Sar 2011); состояние недостаточно диагностируется.

Миф 4: «Гипноз или госпитализация — основное лечение»

Доказательства: фазово-ориентированная психотерапия — первая линия; гипноз может использоваться как адъюнкт (с осторожностью); госпитализация — только при остром самоповреждении или суицидальном риске.

Миф 5: «Пациент с ДРИ склонен к совершению насилия»

Доказательства: Пациенты с ДРИ с большей вероятностью становятся жертвами насилия; насилие в отношении других редко. Параллель мифу «люди с шизофренией опасны».

Миф 6: «Объединение всех идентичностей в одну — основная цель»

Доказательства: интеграция является типичной целью, но полного слияния достичь у всех пациентов невозможно; «кооперация» и «функциональная активность» также принимаются как клинический исход.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B64 Dissociative identity disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults, Third Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Sar V. Epidemiology of dissociative disorders: an overview. Epidemiology Research International 2011;2011:404538.
5. Putnam F.W. Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder. Guilford Press; 1989.
6. Reinders A.A.T.S. et al. The psychobiology of authentic and simulated dissociative personality states: the full Monty. J Nerv Ment Dis 2016;204(6):445–457.
7. Steinberg M. Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders, Revised (SCID-D-R). APA Press; 1994.
8. Lilienfeld S.O., Lynn S.J., Kirsch I. et al. Dissociative identity disorder and the sociocognitive model: recalling the lessons of the past. Psychol Bull 1999;125(5):507–523.
9. Schwartz R.C., Sweezy M. Internal Family Systems Therapy. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2020.

МКБ-11 **6B65**	**6B65 ЧАСТИЧНОЕ ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ** **Partial dissociative identity disorder**
МКБ-10 F44.8	Другие диссоциативные [конверсионные] расстройства
DSM-5-TR F44.89	Другое уточнённое диссоциативное расстройство

1. Определение и нозология

Частичное диссоциативное расстройство идентичности (МКБ-11: 6B65 Partial Dissociative Identity Disorder) — сходно с ДРИ (6B64), но отличается тем, что недоминантные идентичности последовательно не контролируют полностью поведение пациента или функцию сознания. Вместо этого они вмешиваются, но не полностью захватывают «executive control».

МКБ-11 — впервые добавлен как официальная диагностическая категория; в DSM-5-TR отдельно отсутствует (может оцениваться в рамках Other Specified Dissociative Disorder).

2. История

- МКБ-11 (2019) — признание как спектра ДРИ, парциальная форма — официальная категория.
- Новая диагностическая рамка для состояний, известных в клинической практике как «DDNOS» или «ДРИ-NOS».

3. Эпидемиология

- Распространённость: точные данные ограничены — предполагается, что чаще, чем ДРИ.
- Развивается на основе травмы.
- Коморбидность, сходная с ДРИ.

4. Этиология и патогенез

То же, что и ДРИ — тяжёлая детская травма, дезорганизованная привязанность, нейробиологические диссоциативные процессы.

5. Клиническая картина

- Два или более различных состояния идентичности.
- Недоминирующие идентичности вмешиваются — внутренние голоса, мысли, чувства, движения — но не полностью захватывают поведение и сознание пациента.
- Доминантная идентичность управляет повседневной деятельностью.
- Менее выраженная амнезия по сравнению с ДРИ.
- Дистресс и функциональное нарушение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (МКБ-11)

A. Два или более различных состояния идентичности.

B. Недоминантные идентичности не захватывают последовательно полный контроль над сознанием и поведением доминантной идентичности, однако присутствуют как интрузивное переживание.

C. Значительный дистресс или функциональные нарушения

D. Исключение вещества или медицинского состояния

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 — отличается от ДРИ «отсутствием полного захвата».
- DSM-5-TR — может оцениваться в рамках Other Specified Dissociative Disorder (F44.89).

6.3 Алгоритм диагностики

То же, что и ДРИ (см. 6B64 §6.3).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ДРИ (6B64)	Недоминантные идентичности последовательно перехватывают контроль над доминантной + амнезия.
ПТСР / К-ПТСР (6B40/6B41)	Травматические интрузии; отдельных идентичностей нет.
ПРЛ (6D10.x)	Эмоциональная лабильность доминирует.
Шизофрения (6A20)	Психотические симптомы.
Транс одержимости (культуральный)	Культурный и религиозный контекст.

7. Обследование и оценка

То же, что и ДРИ (SCID-D-R, DES, MID).

8. Лечение

Для ДРИ адаптируется фазовый (phase-oriented) подход (ISSTD 2011). Принципы лечения, этапы и конкретные методики см. в разделе «Лечение» 6B64 (включая «Методики лечения»).

9. Прогноз

Функциональное восстановление с помощью фазово-ориентированной терапии; сходно с ДРИ.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Парциальное ДРИ — это „лёгкая форма“»

Доказательства: является отдельной диагностической категорией; функциональное нарушение и травматическая нагрузка могут быть сопоставимы с ПТСР.

Миф 2: «Внутренние голоса — всегда психотический симптом»

Доказательства: диссоциативные голоса отличаются от психотических симптомов — внутренний диалог, ощущение «своего», слабый ответ на антипсихотики; SCID-D-R для дифференциации.

Миф 3: «Антипсихотик излечивает „голоса“ при частичном диссоциативном расстройстве идентичности»

Доказательства: диссоциативные голоса не отвечают на антипсихотики; психотерапия первой линии.

Миф 4: «Пациент „играет роль“»

Доказательства: отличие от имитированного расстройства (6D50) — отсутствие внешней мотивации; клиническое обследование дистрессно для пациента.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B65 Partial dissociative identity disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. ISSTD. Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults, Third Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Reinders A.A.T.S. et al. J Nerv Ment Dis 2016;204(6):445–457.

МКБ-11 **6B66**	**6B66 СИНДРОМ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ-ДЕРЕАЛИЗАЦИИ** **Depersonalization-derealization disorder**
МКБ-10 F48.1	Синдром деперсонализации-дереализации
DSM-5-TR F48.1	Расстройство деперсонализации/дереализации

1. Определение и нозология

Синдром деперсонализации-дереализации (МКБ-11: 6B66; DSM-5-TR: F48.1) — диссоциативное расстройство, характеризующееся стойкой или рецидивирующей деперсонализацией (ощущение нахождения вне себя, отстранённости от тела и мыслей) и/или дереализацией (восприятие окружающего как нереального, «как в туманном фильме»). Тестирование реальности сохранено (пациент знает, что переживание нереально).

2. История

- Krishaber M. (1873) — первое описание.
- Dugas L. (1898) — термин «dépersonnalisation».
- DSM-III (1980) — отдельный диагноз.
- DSM-5 (2013) — деперсонализация и дереализация как единая категория.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1–2% в клинической форме; субклинические переживания хотя бы раз у 50% населения.
- Пол: примерно одинаково.
- Начало: подростковый возраст и ранняя взрослость (средний возраст 16 лет).
- Коморбидность: БДР, паническое расстройство, ГТР, ПТСР, ПРЛ.

4. Этиология и патогенез

- Травма и стрессовый триггер (особенно употребление каннабиса, галлюциногенов).
- Нейробиологическая — нарушение префронтально-лимбической регуляции; аномалии сенсорной обработки (обзоры Simeon D.).
- Коморбидная тревога и высокая частота панических атак.

5. Клиническая картина

- Деперсонализация: ощущение наблюдения за собой со стороны, ощущение себя как робота, эмоциональное оцепенение, чувство «моё тело не принадлежит мне».
- Дереализация: Окружающее кажется «тусклым», «как в тусклом фильме» или «искусственным»; изменение восприятия расстояния.
- Проверка реальности сохранена — пациент знает, что переживание нереально.
- Значительный дистресс и функциональные нарушения.
- Типичное течение — непрерывные или рецидивирующие эпизоды.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Стойкие или повторяющиеся переживания деперсонализации и/или дереализации.

B. Проверка реальности сохранена.

C. Значительный дистресс или функциональные нарушения

D. Исключение вещества (каннабис, галлюциноген) или медицинского состояния (припадок, повреждение мозга).

E. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (кратковременное во время панической атаки; на фоне ПТСР; шизофрения).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаковые критерии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.

2. CDS (англ. Cambridge Depersonalisation Scale, Sierra M., Berrios G.E.) — 29 пунктов.
3. Медицинское и неврологическое обследование (исключение приступов, повреждения головного мозга).
4. Токсикологический скрининг.
5. Коморбидность.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Паническая атака	Кратковременный в контексте приступа.
ПТСР (6B40)	На фоне травмы; интрузии.
ДРИ (6B64)	Различные идентичности.
Приступ (эпилептический)	ЭЭГ; постиктальное состояние.
Шизофрения	Проверка реальности нарушена.
Вещество-индуцированное (каннабис, ЛСД)	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- CDS — золотой стандарт.
- ЭЭГ — если необходимо исключить приступ.
- Токсикологический скрининг.

8. Лечение

1. КПТ, адаптированная для деперсонализации; когнитивная реструктуризация + экспозиция. Hunter E.C. et al. Behav Res Ther 2005.
2. СИОЗС — эффективность при коморбидной депрессии и тревоге; доказательная база для самого расстройства ограничена.
3. Ламотриджин адъюнкт — в некоторых исследованиях эффект.
4. На фоне травмы — травма-фокусированный подход.
5. Отказ от употребления каннабиса и галлюциногенов критичен.

8.1 Методики лечения

1. КПТ для деперсонализации — Хантер (Hunter E.C.), Сьерра (Sierra M.) — Когнитивная реструктуризация, экспозиция, техники заземления.
2. Кембриджская шкала деперсонализации (англ. Cambridge Depersonalisation Scale, CDS) — 29 пунктов.
3. Техники заземления (grounding) — 5–4–3–2–1 (5 видимых объектов, 4 звука и т.д.); сенсорное внимание.

8.2 Различия между источниками

- Обзоры Sierra M. — КПТ и СИОЗС адъюнкт.
- Специфического одобренного FDA препарата нет.

9. Прогноз

- Хроническое течение, но значительное улучшение при КПТ.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Деперсонализация — это симптом психоза»

Доказательства: проверка реальности сохранена; отличается от психотического расстройства; антипсихотики неэффективны.

Миф 2: «Деперсонализация преходяща и не требует лечения»

Доказательства: в клинической форме хроническое течение и функциональные нарушения; рекомендуется вмешательство.

Миф 3: «Каннабис улучшает деперсонализацию»

Доказательства: каннабис является триггерным и поддерживающим фактором; отказ критичен.

Миф 4: «Бензодиазепины — основное лечение»

Доказательства: бензодиазепины дают кратковременное облегчение, но риск зависимости и усиления деперсонализации.

Миф 5: «Эффективен только антидепрессант»

Доказательства: КПТ первой линии; СИОЗС при коморбидных симптомах.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B66 Depersonalization-derealization disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Sierra M. Depersonalization: A New Look at a Neglected Syndrome. Cambridge Univ Press; 2009.
4. Hunter E.C.M. et al. Cognitive-behaviour therapy for depersonalisation disorder: an open study. Behav Res Ther 2005;43(9):1121–1130.
5. Simeon D. Depersonalisation disorder: a contemporary overview. CNS Drugs 2004;18(6):343–354.
6. Sierra M., Berrios G.E. The Cambridge Depersonalisation Scale: a new instrument for the measurement of depersonalisation. Psychiatry Res 2000;93(2):153–164.

МКБ-11 **6B60**	**6B60 ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ** **Dissociative neurological symptom disorder**
МКБ-10 F44.4–F44.7	Диссоциативные двигательные и сенсорные расстройства
DSM-5-TR F44.4–F44.7	Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство (конверсионное)

1. Определение и нозология

Диссоциативное расстройство неврологических симптомов (МКБ-11: 6B60 Dissociative Neurological Symptom Disorder; DSM-5-TR: F44.4–F44.7 Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство / Конверсионное расстройство) — нарушение моторных, сенсорных или когнитивных функций, находящихся под произвольным контролем, которое не может быть полностью объяснено неврологическим или медицинским заболеванием. Ранее называлось «конверсионным расстройством» или «истерией».

2. История

- Charcot J.M. (XIX век) — исследования «истерии» в Сальпетриере.
- Freud S. — психоаналитическая модель «конверсии».
- DSM-III (1980) — «Conversion Disorder» в рамках соматоформных расстройств.
- DSM-5 (2013) — «Functional Neurological Symptom Disorder» — акцент на совместной неврологической и психиатрической оценке.
- МКБ-11 (2019) — перенесено в категорию диссоциативных расстройств.

3. Эпидемиология

- В первичной медицинской помощи и неврологических клиниках — 5–10% (обзоры Carson A.J. et al.).
- Пол: у женщин в 2–3 раза выше.
- Начало: взрослость, но также у детей и пожилых.
- Коморбидность: БДР, тревога, травма в анамнезе, соматические заболевания.

4. Этиология и патогенез

- Травматический или стрессовый триггер встречается часто, однако у значительной и варьирующей доли пациентов он не выявляется (0–77% в разных исследованиях; Ludwig L. et al. Lancet Psychiatry 2018, метаанализ) — именно поэтому DSM-5 и МКБ-11 не требуют стрессора для диагноза.
- Нейробиологическая — нарушение сенсомоторной и когнитивной обработки прогнозов; гипотеза predictive coding (Edwards M.J.).
- Термин «функциональный» не означает симуляцию пациентом, а указывает на функциональное нарушение нервной системы.

5. Клиническая картина

Типичные симптомы

- Двигательные: Слабость, паралич, непроизвольные движения (функциональный тремор, дистония), нарушение походки.
- Сенсорные: потеря чувствительности (анестезия), нарушение зрения (функциональная слепота), нарушение слуха.

- Функциональные (психогенные) неэпилептические приступы (PNES): эпизоды, напоминающие приступы, при которых эпилептическая активность на ЭЭГ отсутствует.
- Когнитивные: «Угнетённое» состояние, концентрация, замедленная обработка — «функциональное когнитивное расстройство».

Клинические признаки (positive features).

- Паттерн, отличный от типичного неврологического патогенеза (например, симптом Гувера при двигательной слабости — положительный показатель функционального компонента).
- Отвлекаемость — симптом меняется при переключении внимания на другое.
- Entrainability — тремор подстраивается под другой ритм.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Нарушение одной или нескольких моторных, сенсорных или когнитивных функций.

B. Клинические данные свидетельствуют о несоответствии расстройства известному неврологическому или медицинскому заболеванию (positive clinical features).

C. Симптомы не объясняются лучше другим психическим или медицинским состоянием.

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — диагноз устанавливается на основании «положительных особенностей» (не методом исключения); совместная оценка невролога и психиатра.
- МКБ-11 — в категории диссоциативных расстройств.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Неврологическое обследование — функциональные positive features (Hoover, entrainability, distractibility).
2. Типичное неврологическое состояние исключается — МРТ, ЭЭГ, ЭМГ, люмбальная пункция (по показаниям).

3. При PNES — видео-ЭЭГ-мониторинг является золотым стандартом.
4. Психиатрическая оценка — коморбидная травма, БДР, тревога.
5. Позитивное объяснение диагноза пациенту — «не выдумка, а функциональное нарушение нервной системы».

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Реальное неврологическое заболевание	Клиническое и лабораторное подтверждение.
Искусственное расстройство (6D50)	Сознательная ложь; мотивация выгоды.
Симуляция	Явная выгода (судебная, страховая).
Соматическое симптоматическое расстройство (6C20)	Множественные соматические жалобы; фокус на теле.
Ипохондрия (6B23)	Доминирует тревога по поводу болезни.
Эпилептический припадок	Видео-ЭЭГ.

7. Обследование и оценка

- Неврологическое обследование (positive features).
- Видео-ЭЭГ — при ПНЭС.
- МРТ, лабораторное исключение неврологического заболевания.
- Травма и психиатрическая оценка.

8. Лечение

1. Позитивное объяснение диагноза пациенту — «Функциональное нарушение нервной системы, а не выдумка»; структурированное разъяснение диагноза критически важно для функционального улучшения (обзоры Stone J.).
2. Мультидисциплинарный подход — невролог + психиатр + физиотерапевт.
3. Физиотерапия (при моторных симптомах) — доказанная польза (Nielsen G. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017 РКИ).

4. КПТ — когнитивная реструктуризация; специальные протоколы для ПНЭС (LaFrance W.C. JAMA Psychiatry 2014).
5. На фоне травмы — травма-фокусированный подход.
6. Антиконвульсанты при PNES неэффективны и вредны — правильная постановка диагноза пациенту и отмена антиэпилептика критичны.
7. СИОЗС при коморбидной депрессии/тревоге.

8.1 Методики лечения

1. Презентация позитивного клинического диагноза — Стоун (Stone J.) — Диагноз «rule-in», а не «rule-out»; пациенту объясняются позитивные клинические признаки (например, демонстрируется симптом Гувера).
2. Физиотерапия при ФНР — Специфическое мануальное обучение, тренировка движений; Nielsen G. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017.
3. КПТ для PNES — ЛаФранс (LaFrance W.C.) — Мануализированные 12 сеансов; дневник захвата, когнитивная реструктуризация; LaFrance W.C. et al. JAMA Psychiatry 2014.
4. Видео-ЭЭГ — золотой стандарт диагностики PNES.

8.2 Различия между источниками

- Специфический для FND международный консенсус (Stone J., Carson A., LaFrance W.C.).
- NICE — мультидисциплинарный подход при функциональных симптомах.

9. Прогноз

- Улучшение при ранней правильной диагностике и вмешательстве.
- Поздняя диагностика и полифармация — хронификация.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациент симулирует / „притворяется“»

Доказательства: функциональное расстройство — реальное клиническое состояние — функциональное нарушение нервной системы; подтверждается позитивными клиническими признаками. Отличается от имитированного расстройства и симуляции.

Миф 2: «При ПНЭС необходимы противосудорожные препараты»

Доказательства: антиконвульсанты неэффективны при ПНЭС, вызывают полипрагмазию и побочные эффекты; правильная диагностика и отмена антиэпилептика критичны.

Миф 3: «Функциональное расстройство — это психологическая „слабость“, а не физическая»

Доказательства: функциональное расстройство — биологический процесс нервной системы; требует совместной психиатрической и неврологической оценки.

Миф 4: «Достаточно „сбросить“ пациента психиатру»

Доказательства: невролог и психиатр должны работать совместно; «отбрасывание» пациента нарушает терапевтический альянс и снижает шансы на улучшение.

Миф 5: «Функциональные симптомы не лечатся»

Доказательства: физиотерапия, КПТ, мультидисциплинарный подход демонстрируют значимый эффект.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B60 Dissociative neurological symptom disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Stone J., Carson A. Functional neurological disorders: the neurological assessment as treatment. Pract Neurol 2016;16(1):7–17.
4. Nielsen G. et al. Physiotherapy for functional motor disorders: a consensus recommendation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86(10):1113–1119.
5. LaFrance W.C. et al. Multicenter pilot treatment trial for psychogenic nonepileptic seizures: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2014;71(9):997–1005.
6. Edwards M.J., Adams R.A., Brown H., Pareés I., Friston K.J. A Bayesian account of «hysteria». Brain 2012;135(Pt 11):3495–3512.

МКБ-11 **6B61**	**6B61** **ДИССОЦИАТИВНАЯ АМНЕЗИЯ** **Dissociative amnesia**
МКБ-10 F44.0	Диссоциативная амнезия
DSM-5-TR F44.0	Диссоциативная амнезия

1. Определение и нозология

Диссоциативная амнезия (МКБ-11: 6B61; DSM-5-TR: F44.0) — неспособность вспомнить важную автобиографическую информацию (обычно травматическую или стрессовую), степень которой не объясняется обычной забывчивостью. Медицинская или неврологическая причина отсутствует.

Подтипы: локализованный (конкретный период), селективный (часть периода), генерализованный (вся история жизни), систематический (определённая категория), непрерывный.

Диссоциативная фуга — Как квалификатор диссоциативной амнезии в DSM-5-TR (в DSM-IV был отдельным диагнозом); пациент неожиданно путешествует, создаёт новую идентичность.

2. История

- Janet P. — создатель концепции диссоциации.
- DSM-IV — диссоциативная фуга — отдельный диагноз.
- DSM-5 (2013) — фуга интегрирована как квалификатор.
- Дискуссия о «ложных воспоминаниях» (1990-е годы) — обсуждение терапевтически индуцированных «возвращённых воспоминаний».

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1–2%; выше после общественных бедствий (война, катастрофа).
- Пол: относительно выше у женщин.

- Коморбидность: ПТСР, К-ПТСР, ДРИ, ПРЛ, БДР.

4. Этиология и патогенез

- Травма — реакция на тяжёлое психологическое или физическое событие; гипотеза как «защитный механизм».
- Нейробиологически — нарушение когнитивной обработки в гиппокампе и префронтальной коре.

5. Клиническая картина

- Неспособность вспомнить травматическое или стрессовое событие.
- Локализованная (напр., во время войны), избирательная, генерализованная.
- Диссоциативная фуга — неожиданное путешествие, новая идентичность, обычно длится от нескольких дней до недель.
- Имплицитная память (навыки) сохраняется; эксплицитная память избирательна.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Забывание важной автобиографической информации (обычно травматической), не объяснимое обычной забывчивостью.

B. Значительный дистресс или функциональные нарушения

C. Исключение вещества, медицинского/неврологического состояния (ЧМТ, энцефалит, деменция)

D. Амнезия не объясняется лучше ПТСР, К-ПТСР, соматическим симптомом или другим психическим расстройством.

Квалификатор: with dissociative fugue.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково; квалификатор фуги.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + анамнез травмы.
2. Медицинское и неврологическое обследование — исключение ЧМТ, деменции, энцефалита, приступов.

3. МРТ, ЭЭГ при клиническом подозрении.
4. SCID-D-R.
5. Токсикологический скрининг.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Черепно-мозговая травма (ЧМТ)	Анамнез, МРТ.
Transient global amnesia (TGA)	Острое, менее 24 часов; сосудистая этиология.
Деменция	Стойкое когнитивное снижение.
Приступ (постиктальный)	ЭЭГ.
Вещество-индуцированная амнезия (алкогольный блэкаут)	Анамнез.
Искусственное расстройство / симуляция	Мотивация достижения.
ДРИ (6B64)	Множественные идентичности.

7. Обследование и оценка

- SCID-D-R.
- МРТ, ЭЭГ.
- Нейропсихологический тест (профиль памяти).

8. Лечение

1. Безопасная среда и поддерживающая психотерапия.
2. Травма-фокусированная психотерапия — фазовый подход.
3. При фуге-эпизоде — воссоединение пациента с семьёй и сообществом.
4. Фармакотерапия для коморбидных симптомов; исторически использовались «амобарбиталовое интервью» или гипноз — осторожно из-за риска индуцированных ложных воспоминаний.
5. Длительная психотерапия — переработка травмы.

8.1 Методики лечения

1. Травма-фокусированная фазовая психотерапия — Стабилизация → переработка → реинтеграция.

2. Структурированное клиническое интервью для диссоциативных расстройств (SCID-D-R) — Золотой стандарт в диагностике.
3. Гипноз — с осторожностью — Риск индукции ложных воспоминаний; только обученным клиницистом.

8.2 Различия между источниками

- ISSTD — общее руководство по диссоциативным расстройствам.
- Специфической одобренной FDA фармакотерапии нет.

9. Прогноз

- В острой форме — преимущественно спонтанная ремиссия;
- Долгосрочное вмешательство при хронической форме.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Гипноз — надёжный способ „восстановления воспоминаний“»

Доказательства: воспоминания под гипнозом могут быть дополнены ложными, индуцированными или искажёнными деталями; в судебном контексте следует проявлять особую осторожность (исследования Loftus E.F.).

Миф 2: «Диссоциативная амнезия — это выдумка или „драма“ из фильмов»

Доказательства: клиническое состояние документировано; изучаются нейробиологические основы.

Миф 3: «Пациента „нужно заставлять вспоминать“»

Доказательства: Давление может вызвать травму или дистресс; рекомендуется поддерживающий подход.

Миф 4: «Амобарбиталовое интервью эффективно»

Доказательства: исторически применялось, но в современной практике не рекомендуется из-за риска ложных воспоминаний и побочных эффектов.

Миф 5: «Все травматические воспоминания „реальны“»

Доказательства: некоторые «восстановленные воспоминания» могут быть результатом терапевтической индукции; необходимы осторожный клинический подход и подтверждение источника.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B61 Dissociative amnesia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. ISSTD. Guidelines for Treating DID in Adults, 3rd Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Loftus E.F. The reality of repressed memories. Am Psychol 1993;48(5):518–537.
5. Staniloiu A., Markowitsch H.J. Dissociative amnesia. Lancet Psychiatry 2014;1(3):226–241.

6B80–6B8Z РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Feeding or eating disorders

МКБ-11 **6B80**	**6B80 НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ** **Anorexia Nervosa**
МКБ-10 F50.0	Нервная анорексия
DSM-5-TR F50.0x	Нервная анорексия

1. Определение и нозология

Нервная анорексия (МКБ-11: 6B80; DSM-5-TR: F50.0x) — тяжёлое расстройство пищевого поведения, характеризующееся значительным снижением массы тела вследствие ограничения приёма пищи, резким страхом увеличения веса и нарушением образа тела. Входит в число психиатрических расстройств с самой высокой смертностью.

2. История

- Morton R. (1689) — первое клиническое описание.
- Lasègue C. (1873) и Gull W. (1874) — «anorexia hysterica» и «нервная анорексия».
- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — критерий аменореи отменён (диагноз возможен у мужчин и в пременархальном периоде).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: у женщин 0,9–4%, у мужчин 0,3% (обзоры Smink F.R.).
- Пол: у женщин 10:1; однако у мужчин диагноз часто не ставится.

- Начало: подростковый возраст (14–18 лет); второй пик в среднем возрасте.
- Смертность: пожизненно 5–6%; половина медицинская (кахексия, сердце), половина суицид (Arcelus J. et al. Arch Gen Psychiatry 2011 метаанализ).
- Коморбидность: БДР, ОКР, тревога, ПРЛ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50–60% (обзоры Bulik C.M.).
- Нейробиологически — снижение когнитивной гибкости, дисрегуляция контура вознаграждения, атипичный ответ на голод.
- Социокультурные факторы — идеал худобы; влияние социальных медиа.
- Личность — перфекционизм, тревожность, семейный анамнез расстройства пищевого поведения.

5. Клиническая картина

- Ограничение пищи — калорий, видов продуктов.
- Значительно сниженная масса тела (BMI < 18,5 у взрослых; BMI-перцентиль у детей).
- Резкий страх увеличения веса или устойчивое поведение, направленное на его предотвращение.
- Нарушение образа тела — «чувствую себя толстым» даже при худобе.
- Подтипы:
    - Рестриктивный тип — только ограничение пищи.
    - Тип переедания/очищения — рвота, слабительные, физические упражнения.
- Медицинские осложнения — брадикардия, гипотензия, гипотермия, электролитный дисбаланс, остеопороз, аменорея, лануго, сердечная аритмия, смерть.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

А. Значительно низкая масса тела вследствие ограничения потребления пищи (ИМТ < 18,5 у взрослых; у детей ниже нормы для возраста).

B. Резкий страх увеличения веса или устойчивое поведение, направленное на его предотвращение, даже при низком весе.

C. Нарушение образа тела или неспособность осознать серьёзность текущего веса.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — степень тяжести на основе BMI (лёгкая BMI ≥ 17, средняя 16–16,99, тяжёлая 15–15,99, экстремальная < 15).
- МКБ-11 — иная шкала тяжести: 6B80.0 значительно низкий вес тела (у взрослых ИМТ 18,5–14,0; у детей 5-й–0,3-й перцентиль ИМТ по возрасту), 6B80.1 опасно низкий вес тела (ИМТ < 14,0), 6B80.2 восстановление при нормальном весе — диагноз сохраняется до полного и устойчивого выздоровления. Отдельной категории «атипичная нервная анорексия» в МКБ-11 нет (термин относится к OSFED из DSM-5-TR): случай с нормальным ИМТ — это 6B80.2, а при несоблюдении критериев — 6B8Y, другие уточнённые расстройства пищевого поведения.
- NICE NG69 (Расстройства пищевого поведения, 2017, обновление) — алгоритмы диагностики и лечения.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. EDE-Q (англ. Eating Disorder Examination Questionnaire) или EDE — золотой стандарт.
3. Медицинское обследование — ИМТ, жизненно важные показатели, электролиты, ЭКГ, денситометрия костей.
4. Лабораторно: общий анализ крови, электролиты (особенно K, P, Mg), печень, почки, глюкоза, щитовидная железа.
5. Коморбидность (БДР, ОКР, тревога).
6. Оценка риска рефидинг-синдрома (особенно при ИМТ <13 или длительном минимальном потреблении пищи).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Нервная булимия (6B81)	Нормальный вес; переедание + компенсаторное поведение.

Состояние	Отличительный признак
ARFID (6B83)	Снижение веса, но нарушения образа тела нет.
Соматическое заболевание (рак, гипертиреоз, СРК, болезнь Крона)	Клиническое подтверждение.
БДР (снижение потребления пищи)	Нарушение образа тела отсутствует.
Шизофрения (бред о пище)	Психотическая мысль основная.

7. Обследование и оценка

- EDE-Q, EDE.
- Витальные показатели, ИМТ, история веса.
- Лабораторно: общий анализ крови, электролиты, печень, почки, щитовидная железа, ФСГ/ЛГ, пролактин, витамин D, B12, железо.
- ЭКГ — брадикардия, QTc.
- DEXA — остеопороз.
- C-SSRS — суицидальный риск.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE NG69 · APA 2023)

1. Соматическая стабилизация критична: электролиты, профилактика синдрома возобновления питания (фосфор, магний, тиамин), кардиомониторинг.
2. Показания к госпитализации: BMI < 13, брадикардия < 40, гипокалиемия, ортостатические изменения, риск суицида, неудача в амбулаторных условиях.
3. Психотерапия первой линии:
    - FBT — Family-Based Treatment (Модель Модсли, Lock J., Le Grange D.) — золотой стандарт у детей и подростков; 20 сеансов в 3 фазы.
    - КПТ-У — Усиленная когнитивно-поведенческая терапия (Fairburn C.G.) — первая линия у взрослых; 40 сеансов за 40 недель.
    - MANTRA, SSCM — альтернативы для взрослых.

4. Специфических эффективных препаратов для фармакотерапии АН нет — антидепрессант и антипсихотик при коморбидности; оланзапин в низкой дозе (2,5–10 мг) может способствовать набору веса у некоторых пациентов (Attia E. et al. Am J Psychiatry 2019), но не является основным вмешательством.
5. Нутриция — в группе или индивидуально с диетологом; профилактика синдрома возобновления питания — начальная энергия начинается с низкого уровня, мониторинг фосфора.
6. Лечение длительное (1–2 года и более).

8.2 Методики лечения

1. Семейно-ориентированное лечение / Модель Модсли (англ. Family-Based Treatment, FBT) — Лок (Lock J.), Ле Гранж (Le Grange D.) — 3-фазная 20-сессионная программа: (1) восстановление веса — семья контролирует приём пищи; (2) постепенная передача контроля над едой подростку; (3) подростково-специфические темы. Доказательства: Lock J. et al. Arch Gen Psychiatry 2010 РКИ.
2. Усиленная когнитивно-поведенческая терапия (англ. Enhanced Cognitive Behavioral Therapy, CBT-E) — Фэйрберн (Fairburn C.G.) — Трансдиагностический (совместно AN, BN, BED) подход; 40 сеансов за 40 недель; в центре — чрезмерная значимость тела и веса. cbte.co.
3. Лечение нервной анорексии у взрослых по Модсли (англ. Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults, MANTRA) — Шмидт (Schmidt U.) — Мануализировано для взрослых; фокус на социально-перфекционистских чертах.
4. Специализированное поддерживающее клиническое ведение (англ. Specialist Supportive Clinical Management, SSCM) — Основано на клиническом контроле и психообразовании.
5. Опросник для обследования расстройств пищевого поведения (англ. Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q) — 28 пунктов; начальные показатели и наблюдение.
6. Протокол рефидинга (Maudsley, AED) — Начало по степени риска: при высоком риске 10 ккал/кг/сут, при крайне высоком (ИМТ < 14 или практически полном отсутствии приёма пищи более 15 дней) 5 ккал/кг/сут; наращивание постепенное. Добавки фосфора, магния, калия; тиамин; ежедневный мониторинг электролитов. Более высокая скорость — только в специализированном отделении под плотным наблюдением.

8.3 Различия между источниками

- NICE NG69 (2017) — FBT у детей и подростков; CBT-E у взрослых.
- APA 2023 Practice Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders, 4th ed.
- AED (Академия расстройств пищевого поведения) — стандарты медицинской помощи при синдроме рефидинга.
- NICE — антидепрессанты не рекомендуются рутинно при АН.

9. Прогноз

- 50% ремиссия, 30% остаточные симптомы, 20% хроническое течение.
- Смертность высокая (5–6%).
- Раннее вмешательство (особенно FBT в подростковом возрасте) улучшает прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Анорексия — это нарушение „имиджа“, а не серьёзное медицинское состояние»

Доказательства: Мета-анализ Arcelus 2011 — пожизненная летальность при AN 5–6%; самая высокая среди психиатрических расстройств.

Миф 2: «Пациент может есть по собственной воле — нужно просто потребовать»

Доказательства: АН — это комплексное нейробиологическое и психологическое расстройство; объяснение «произвольный отказ от еды» ошибочно и вредно.

Миф 3: «Антидепрессант — основное лечение нервной анорексии»

Доказательства: NICE NG69 — антидепрессанты не рекомендуются рутинно при АН; могут использоваться при коморбидном БДР (более эффективны после восстановления веса).

Миф 4: «Нервная анорексия бывает только у девочек-подростков»

Доказательства: АН встречается и у мужчин (~10%); может развиться и в среднем возрасте; недовыявление часто.

Миф 5: «После восстановления веса проблема решается»

Доказательства: восстановление веса — важный шаг, но без вмешательства когнитивно-поведенческого компонента рецидив высок; психотерапия критична.

Миф 6: «Рефидинг должен быть быстрым»

Доказательства: быстрый рефидинг-синдром (гипофосфатемия, сердечная недостаточность) возможен; ступенчатый подход и мониторинг электролитов критически важны.

Миф 7: «Пациент перфекционист и высокоэффективен — эту особенность следует сохранить»

Доказательства: перфекционизм является одним из поддерживающих факторов АН; терапия направлена на эту особенность.

11. Источники

1. ВОЗ. МКБ-11. 6B80 Нервная анорексия. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. Eating disorders: recognition and treatment. 2017, 2020 update.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders, 4th ed. 2023.
5. Lock J., Le Grange D., Agras W.S. et al. Randomized clinical trial comparing family-based treatment with adolescent-focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2010;67(10):1025–1032.
6. Fairburn C.G. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Guilford Press; 2008.
7. Arcelus J., Mitchell A.J., Wales J., Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2011;68(7):724–731.
8. Attia E. et al. Olanzapine versus placebo in adult outpatients with anorexia nervosa. Am J Psychiatry 2019;176(6):449–456.
9. Smink F.R., van Hoeken D., Hoek H.W. Epidemiology of eating disorders. Curr Psychiatry Rep 2012;14(4):406–414.
10. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.

11. Schmidt U., Treasure J. Anorexia nervosa: valued and visible. A cognitive-interpersonal maintenance model. Br J Clin Psychol 2006;45(3):343–366.
12. Bulik C.M., Sullivan P.F., Tozzi F. et al. Prevalence, heritability, and prospective risk factors for anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2006;63(3):305–312.

МКБ-11 **6B81**	**6B81 НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ** **Bulimia Nervosa**
МКБ-10 F50.2	Нервная булимия
DSM-5-TR F50.2	Нервная булимия

1. Определение и нозология

Нервная булимия (МКБ-11: 6B81; DSM-5-TR: F50.2) — расстройство пищевого поведения, характеризующееся повторяющимися эпизодами переедания (большое количество пищи за короткое время + чувство потери контроля) и компенсаторным поведением (рвота, слабительные, физические упражнения, голодание). В отличие от анорексии, вес обычно нормальный или избыточный.

2. История

- Russell G.F. (1979) — термин «bulimia nervosa» и первое клиническое описание.
- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — критерий частоты снижен до 1 раза в неделю (в DSM-IV — 2 раза).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: у женщин 1,5–3%, у мужчин 0,5%.
- Начало: подростковый возраст и ранняя взрослость.
- Коморбидность: БДР ~70%, тревога, употребление ПАВ, ПРЛ, анамнез нервной анорексии.
- Суицидальный риск высок.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50–60%.
- Нейробиологическая — серотонинергическая дисрегуляция, дофаминовая система вознаграждения.
- Социокультурное — идеал худобы, история диет.
- Личность — импульсивность, перфекционизм, низкая самооценка.

5. Клиническая картина

- Эпизоды переедания — потеря контроля, скрытность.
- Компенсаторное поведение:
  - Purging — самовызывание рвоты, слабительные, диуретики;
  - Non-purging — голодание, чрезмерные физические нагрузки.
- Озабоченность образом тела и весом.
- Медицинские осложнения: гипокалиемия (рвота), симптом Рассела (мозоли на пальцах), эрозия зубов, гипертрофия околоушных желез, эзофагит, желудочно-кишечные расстройства.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Повторяющиеся эпизоды переедания — большое количество пищи за короткое время (≤ 2 часов) + чувство потери контроля.

B. Повторяющееся неадекватное компенсаторное поведение для предотвращения увеличения веса.

C. Частота: не менее 1 раза в неделю — DSM-5-TR требует ≥ 3 месяцев, МКБ-11 ≥ 1 месяца.

D. Самооценка чрезмерно зависит от веса и формы тела.

E. Не возникает в контексте эпизода нервной анорексии.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — тяжесть по частоте эпизодов (лёгкая 1–3, средняя 4–7, тяжёлая 8–13, крайняя ≥ 14 в неделю).
- МКБ-11 — критерии совпадают, но длительность различается: МКБ-11 требует не менее 1 месяца, DSM-5-TR — 3 месяцев; квалификатор «atypical bulimia nervosa».

- NICE NG69 — диагностика и лечение.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. EDE-Q, EDE.
3. Соматическое: электролиты (K, P, Mg, Cl), печень, почки, ЭКГ (QTc).
4. Стоматологический осмотр (эрозия).
5. Коморбидность и риск суицида.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Нервная анорексия, тип с перееданием/очищением (6B80)	Значительно низкий вес.
BED (6B82)	Компенсаторное поведение отсутствует.
Night Eating Syndrome	Преобладает ночное потребление пищи.
Синдром Клейне — Левина	Гиперсомния + гиперфагия.

7. Обследование и оценка

- EDE-Q.
- Соматическое: электролиты, ЭКГ, стоматологический осмотр.
- C-SSRS.

8. Лечение

1. КПТ-У — первая линия (Fairburn) — 20 сеансов за 20 недель; доказательства: Fairburn C.G. et al. Am J Psychiatry 2009;166(3):311–319.
2. Флуоксетин 60 мг/сут — Одобрение FDA для BN; уменьшает переедание и рвоту.
3. FBT (Lock J., Le Grange D.) — у подростков.
4. ИПТ — альтернатива.
5. Соматическое: коррекция электролитов, рефидинг-синдром, стоматологическая помощь.
6. Бупропион противопоказан (риск судорожных приступов).

8.1 Методики лечения

1. CBT-E (Fairburn) — 20 сессий; трансдиагностический; разрыв цикла переедания-очищения.
2. FBT для BN — Адаптировано для подростков.
3. Интерперсональная терапия (ИПТ / IPT — Interpersonal Therapy) — альтернатива; медленный ответ, но долгосрочный эффект.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG69 — CBT-E первой линии; FBT у подростков.
- APA 2023.

9. Прогноз

- 50–70% ремиссия при CBT-E; важно долгосрочное наблюдение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Булимия — это „неудачная диета“»

Доказательства: клиническое нарушение; типичным триггером является рестриктивная диета.

Миф 2: «Рвота — эффективный метод снижения веса»

Доказательства: рвота предотвращает лишь 30–50% усвоения калорий; серьёзные медицинские осложнения.

Миф 3: «Бупропион как антидепрессант может применяться при НПП»

Доказательства: бупропион при нервной булимии противопоказан — высокий риск судорог.

Миф 4: «При нервной булимии, если вес нормальный, проблемы нет»

Доказательства: медицинские осложнения (электролитные, кардиальные) и психиатрическая нагрузка значительны.

Миф 5: «Достаточно только антидепрессанта»

Доказательства: Комбинация КПТ-У + фармакотерапия превосходит монотерапию.

11. Источники

1. ВОЗ. МКБ-11. 6B81 Нервная булимия. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.
4. APA. Practice Guideline for Eating Disorders, 4th ed. 2023.
5. Fairburn C.G. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Guilford Press; 2008.
6. Russell G. Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa. Psychol Med 1979;9(3):429–448.
7. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.

МКБ-11 **6B82**	**6B82** **ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ (BED)** **Binge eating disorder**
МКБ-10 F50.8	Другие расстройства приёма пищи
DSM-5-TR F50.81	Расстройство переедания

1. Определение и нозология

Патологическое переедание (BED) (МКБ-11: 6B82; DSM-5-TR: F50.81) — повторяющиеся эпизоды переедания (большое количество пищи за короткое время + чувство потери контроля) без компенсаторного поведения. Типично избыточный вес и сопровождается ожирением.

2. История

- Stunkard A.J. (1959) — описание компульсивного переедания в контексте ожирения.
- DSM-IV (1994) — в исследовательской категории.
- DSM-5 (2013) — отдельный официальный диагноз.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 1,9–3,5%; самое частое среди расстройств пищевого поведения.
- Пол: у женщин 1,5–2:1; но у мужчин также значимо.
- Сильная связь с ожирением.
- Коморбидность: БДР, тревога, ПРЛ, употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–50%.
- Нейробиологически — дисрегуляция контура вознаграждения; гипотеза «пищевой зависимости».
- Эмоциональное переедание — стресс как триггер.
- Анамнез ограничительной диеты.

5. Клиническая картина

- Эпизоды переедания — большое количество пищи за короткое время, потеря контроля.
- Типичные особенности: быстрое питание, продолжение при сытости, скрытое питание, последующий стыд, дистресс.
- Компенсаторное поведение отсутствует.
- Увеличение веса и осложнения ожирения (сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, СОАС).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Повторяющиеся эпизоды переедания.

B. Эпизоды связаны как минимум с ≥ 3 из следующих признаков:

1. Быстрое питание;
2. Еда до физического насыщения;
3. Переедание без чувства голода;
4. Скрытое питание (из-за стыда);
5. Последующее отвращение к себе, подавленность или сильное чувство вины.

C. Значительный дистресс

D. Частота: 1 раз в неделю, ≥ 3 месяцев.

E. Не возникает в контексте булимии или анорексии; компенсаторное поведение отсутствует.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — тяжесть по частоте эпизодов.
- МКБ-11 — шкалы тяжести нет: DSM-5-TR градуирует по числу эпизодов (лёгкая 1–3, средняя 4–7, тяжёлая 8–13, крайняя ≥14 в неделю), а МКБ-11 говорит лишь «раз в неделю или чаще на протяжении нескольких месяцев».

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. EDE-Q.
3. Медицинская оценка — скрининг метаболического синдрома (глюкоза, HbA1c, липиды, артериальное давление).
4. Коморбидность.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Булимия (6B81)	Компенсаторное поведение.
Ожирение (без компульсивного переедания)	Признаков эпизодов переедания нет.
Синдром Клейне — Левина	Гиперфагия + гиперсомния.
Синдром Прадера — Вилли	Генетика; гиперфагия вне контроля.

7. Обследование и оценка

- EDE-Q.
- ИМТ, вес, жизненно важные показатели.
- Метаболическая панель.

8. Лечение

1. КПТ-У — первая линия — Значимый эффект при BED; обзоры Wilson G.T. et al.

2. Лиздексамфетамин (Vyvanse) 50–70 мг/сут — Одобрение FDA для BED; значительно снижает частоту переедания (McElroy S.L. JAMA Psychiatry 2015).
3. СИОЗС — при коморбидном БДР; умеренный эффект на частоту переедания.
4. ИПТ — альтернатива.
5. Контроль веса — диета, физическая активность; снижение веса без вмешательства при BED неэффективно.
6. Бариатрическая хирургия — требуется долгосрочное наблюдение (предоперационная оценка BED).

8.1 Методики лечения

1. КПТ-У для ПРП — Прерывание цепи переедания, альтернативный копинг.
2. Лиздексамфетамин — одобрение FDA для BED; начало 30 мг, целевая доза 50–70 мг/сут.
3. ИПТ — Фокус на межличностные проблемы.
4. Руководство по самопомощи КПТ (англ. Guided Self-Help) — Интернет-основанные, книжно-основанные.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG69 — КПТ или направленная самопомощь первой линии.
- APA 2023.
- РКИ McElroy по лиздексамфетамину.

9. Прогноз

- Ремиссия 50–60% при КПТ-У.
- Контроль веса и метаболические осложнения требуют долгосрочного наблюдения.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «BED — это просто ожирение или „переедание“ как черта личности»

Доказательства: клиническое расстройство пищевого поведения; отличительные особенности от эпизода переедания (потеря контроля, еда со стыдом).

Миф 2: «Рестриктивная диета излечивает BED»

Доказательства: ограничительная диета является триггером BED — контроль веса без психологического вмешательства усиливает переедание.

Миф 3: «Бариатрическая хирургия излечивает РПП»

Доказательства: хирургия уменьшает объём желудка, но не меняет когнитивно-поведенческий компонент; у некоторых пациентов развивается «grazing» как новая модель.

Миф 4: «Еда — это „зависимость“ (food addiction), её нужно лечить как наркотик»

Доказательства: «Пищевая зависимость» — концепт, но не принят как клинический диагноз; стандартные вмешательства при расстройствах пищевого поведения имеют преимущество.

Миф 5: «BED требует только антидепрессанта»

Доказательства: Лисдексамфетамин одобрен FDA для КПР; КПТ первой линии.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B82 Binge eating disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.
4. McElroy S.L. et al. Efficacy and safety of lisdexamfetamine for treatment of adults with moderate to severe binge eating disorder. JAMA Psychiatry 2015;72(3):235–246.
5. Wilson G.T., Wilfley D.E., Agras W.S., Bryson S.W. Psychological treatments of binge eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2010;67(1):94–101.

МКБ-11 **6B84**	**6B84 ПИКА** **Pica**
МКБ-10 F98.3	Поедание несъедобного младенцами и детьми
DSM-5-TR F98.3 / F50.89	Пика

1. Определение и нозология

Пика (МКБ-11: 6B84; DSM-5-TR: F98.3) — стойкое (≥ 1 месяц) употребление веществ, не считающихся пищей и не имеющих питательной ценности (глина, волосы, бумага, мыло, металл, камни) — в степени, не соответствующей возрасту развития.

2. История

- «Пика» — от латинского «сорока» (сорока ест всё).
- DSM-III (1980) — как расстройство детского возраста.
- DSM-5 (2013) — диагноз возможен во всех возрастных группах.

3. Эпидемиология

- Распространённость: у детей 4–26%, высокая у лиц с интеллектуальной недостаточностью, у женщин во время беременности 8–65%, при железодефицитной анемии.
- Коморбидность: аутизм, интеллектуальная недостаточность, дефицит железа, мальабсорбция у взрослых.

4. Этиология и патогенез

- Нутритивные дефициты (железо, цинк) — у некоторых пациентов могут также возникать вследствие употребления веществ при пике.
- Нейроонтогенетические расстройства (аутизм, ID).
- Беременность — период физиологической и микронутриентной перестройки.
- Культурное — в некоторых традициях употребление глины (геофагия).

5. Клиническая картина

- Геофагия (глина, земля), трихофагия (волосы), пагофагия (лёд), амилофагия (крахмал), плюмбофагия (краска — риск отравления свинцом).
- Осложнения: кишечная непроходимость (трихобезоар), отравление свинцом, паразитарная инфекция, повреждение зубов, перфорация.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Употребление веществ, не имеющих питательной ценности, в течение ≥ 1 месяца.

B. Поведение не соответствует возрасту развития (≥ 2 года).

C. Не является культурно или социально принятой практикой.

D. Если возникает в контексте другого психического расстройства, медицинского состояния — требуется дополнительный диагноз (особенно при ИР и РАС).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR требует срок не менее 1 месяца; в МКБ-11 критерия срока нет — сказано «настолько стойко или тяжело, что требует клинического внимания». Возраст развития ≈2 года — совпадает.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Интервью + наблюдение.
2. Лабораторные — общий анализ крови, ферритин, железо, уровень свинца, цинк.
3. Визуализация брюшной полости (обструкция).
4. Нейроонтогенетическая оценка.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ОКР (6B20)	Основано на обсессии.
Искусственное расстройство (6D50)	Мотивация достижения.
Анорексия, тип переедания (6B80)	Образ тела.
Культурная пищевая практика	Контекст.

7. Обследование и оценка

- Тесты на железо, свинец, цинк, паразиты.
- Рентгенография брюшной полости / УЗИ.

8. Лечение

1. Коррекция нутритивного дефицита (железо, цинк).
2. Поведенческое вмешательство — обратная привычка, модификация среды, альтернативные стимулы.
3. На фоне интеллектуальной недостаточности и РАС — функциональный анализ поведения и подход на основе ПАП.
4. Медицинское ведение осложнений (отравление свинцом — хелация только по конкретным показаниям).
5. При беременности — нутритивная поддержка.

8.1 Методики лечения

1. Функциональный анализ поведения (FBA) — Идентификация триггеров и подкрепляющих факторов поведения.
2. Модификация среды — Ограничение доступа к непищевым веществам.
3. Нутритивная коррекция — Добавки железа, цинка, витаминов.
4. Вмешательство на основе ПАП — При ИР и РАС.

8.2 Различия между источниками

- AAP — оценка пики у детей и скрининг на свинец.

9. Прогноз

- Ремиссия при помощи нутриционной коррекции и поведенческого вмешательства у детей.
- Может сохраняться на фоне ИР/РАС; долгосрочное наблюдение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пика — это просто исследовательское поведение ребёнка»

Доказательства: Общая часть развития до 2 лет; последующее течение является клиническим и создаёт риск осложнений.

Миф 2: «Отравление свинцом требует хелатирования для всех»

Доказательства: хелация только при подтверждённом высоком уровне (BLL ≥ 45 мкг/дл типично); при низких уровнях коррекция среды первой линии.

Миф 3: «Пика при беременности — это „желание ребёнка“, не требующее вмешательства»

Доказательства: маркер дефицита железа или другого дефицита; рекомендуется нутриционная коррекция.

Миф 4: «Пика у пациента с ИР/РАС „неизбежна“»

Доказательства: поведенческие вмешательства (ABA, FBA) эффективны; объяснение «неизбежности» ведёт к тяжёлым осложнениям, таким как трихобезоар, обструкция.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B84 Pica. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Young S.L. Pica in pregnancy: new ideas about an old condition. Annu Rev Nutr 2010;30:403–422.
4. Hyman S.L. et al. AAP 2020 Clinical Report (ASD). Pediatrics 2020;145(1):e20193447.

МКБ-11 **6B85**	**6B85** **ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ И СРЫГИВАНИЕ** **Rumination-regurgitation disorder**
МКБ-10 F98.21	—
DSM-5-TR F98.21	Руминационное расстройство

1. Определение и нозология

Патологическое пережевывание и срыгивание (МКБ-11: 6B85 Rumination-Regurgitation Disorder; DSM-5-TR: F98.21) — характеризуется произвольным или полупроизвольным возвратом (регургитацией) проглоченной пищи с последующим повторным пережёвыванием, повторным проглатыванием или выплёвыванием. Не объясняется полностью медицинским состоянием (гастроэзофагеальным рефлюксом или другим заболеванием ЖКТ).

2. История

- В древности термин «mericism».
- DSM-IV — как расстройство младенческого и детского возраста.
- DSM-5 (2013) — диагноз во всех возрастных группах.

3. Эпидемиология

- Распространённость: у младенцев и детей редко; у пациентов с интеллектуальной недостаточностью 6–10%; у взрослых (особенно коморбидных с расстройством пищевого поведения) распознаваемость возрастает.
- Коморбидность: ИР, РАС, тревога, НП, ПРП.

4. Этиология и патогенез

- Поведенческое кондиционирование — «постпрандиальная отрыжка» с последующей регургитацией как выученное поведение.
- Стресс и тревога.
- Самостимуляция пищей при ИР/РАС.

5. Клиническая картина

- Регургитация через минуты–часы после приёма пищи.
- Последствия расстройства пищевого поведения: потеря веса, недоедание, нарушение электролитного баланса, эрозия зубов, галитоз.
- Социальные последствия: стыд, социальная изоляция.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Повторная регургитация проглоченной пищи — DSM-5-TR: ≥ 1 месяца; МКБ-11: несколько раз в неделю на протяжении не менее нескольких недель; повторное пережевывание, проглатывание или сплёвывание.

B. Регургитация не связана с медицинским состоянием (например, рефлюкс, пилоростеноз, обструкция пилорического отдела двенадцатиперстной кишки).

C. Не возникает в контексте анорексии, булимии, BED, ARFID.

D. Если возникает на фоне другого психического расстройства (особенно ИР, РАС), значительная тяжесть требует отдельной оценки.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — критерии совпадают; различаются длительность и возрастной порог: DSM-5-TR требует ≥ 1 месяца, МКБ-11 — несколько раз в неделю на протяжении не менее нескольких недель и возраст развития ≥ 2 лет.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Медицинская оценка — исключение ГЭРБ, патологии привратника, гастропареза (верхняя эндоскопия, исследование моторики).
3. Манометрия — подтверждение функциональной регургитации.
4. Вес и нутритивный статус.
5. Скрининг коморбидного расстройства пищевого поведения.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
GERD	Типичный кислотный рефлюкс; pH-мониторинг.
Булимия (6B81)	Произвольная рвота с компенсаторной целью.
Анорексия (6B80)	Страх набора веса.
Gastroparesis	Исследование моторики.
Пилорическая обструкция	Эндоскопия.

7. Обследование и оценка

- Эндоскопия, манометрия, pH-мониторинг.
- Общий анализ крови, электролиты.

8. Лечение

1. Диафрагмальное дыхание — поведенческое вмешательство первой линии (Chitkara D.K. et al. Am J Gastroenterol 2006; эффект 50–70%).
2. Хабит-реверсал — обучение альтернативному поведению.
3. Biofeedback.
4. Управление стрессом и КПТ.

5. Функциональный анализ поведения и ABA при ИР/РАС.
6. Соматическое: при сопутствующей ГЭРБ — первичное вмешательство ингибитором протонной помпы.

8.1 Методики лечения

1. Диафрагмальное дыхание (англ. Diaphragmatic Breathing) — Медленное абдоминальное дыхание в течение 5–10 минут после приёма пищи — предотвращает регургитацию.
2. Тренинг замещения привычки (англ. Habit Reversal Training, HRT) — Развитие альтернативного поведения.
3. Биофидбек (Biofeedback) — Контроль мышц живота.
4. FBA — функциональный анализ поведения (при ИР/РАС) — Анализ триггеров и подкрепляющих факторов поведения.

8.2 Различия между источниками

- Критерии Rome Foundation (функциональные ЖКТ).
- NICE NG69 — общие принципы расстройств пищевого поведения.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при диафрагмальном дыхании и habit reversal.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Руминация — это форма ГЭРБ»

Доказательства: отдельное расстройство; различаются манометрия и клиническая модель.

Миф 2: «Только хирургическое вмешательство (Nissen) решает проблему»

Доказательства: Фундопликация по Ниссену неэффективна и противопоказана при функциональной руминации; поведенческое вмешательство — первая линия.

Миф 3: «Пациент ведёт себя „намеренно“, требует дисциплины»

Доказательства: полупроизвольное поведение, основанное на обусловливании; наказание неэффективно.

Миф 4: «Противорвотные средства эффективны»

Доказательства: антиэметики (напр. ондансетрон) неэффективны при руминации.

Миф 5: «У пациента с ИР/РАС пика не отменяется»

Доказательства: поведенческие вмешательства эффективны; активное вмешательство при нутриционных осложнениях обязательно.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B85 Rumination-regurgitation disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Chitkara D.K., Van Tilburg M., Whitehead W.E., Talley N.J. Teaching diaphragmatic breathing for rumination syndrome. Am J Gastroenterol 2006;101(11):2449–2452.
4. Rome IV Diagnostic Criteria for Disorders of Gut-Brain Interaction. Rome Foundation; 2016.

	6B83 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ (ARFID)
МКБ-11 6B83	**Avoidant-restrictive food intake disorder**
МКБ-10 F98.2	Расстройство приёма пищи в младенческом и детском возрасте
DSM-5-TR F50.82	Расстройство избегающего/ограничительного приёма пищи

1. Определение и нозология

Патологическое избирательно-ограничительное потребление пищи (ARFID; МКБ-11: 6B83; DSM-5-TR: F50.82) — избегание или ограничение приёма

пищи, приводящее к значительной потере веса, дефициту питательных веществ, энтеральному питанию или психосоциальным нарушениям. Отсутствует нарушение образа тела или страх увеличения веса (основное отличие от анорексии).

2. История

- DSM-IV «Расстройство приёма пищи в младенчестве или раннем детстве» — только у детей.
- DSM-5 (2013) — ARFID расширено на все возрастные группы.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 0,3–3,2% (в клиниках расстройств пищевого поведения ~5–14%).
- Пол: примерно одинаково (в отличие от нервной анорексии).
- Начало: преобладает детство и подростковый возраст.
- Коморбидность: расстройство аутистического спектра, тревога, ОКР.

4. Этиология и патогенез

- Сенсорная чувствительность (текстура пищи, запах, внешний вид) — особенно на фоне аутизма.
- Страх удушья или травмы от рвоты.
- Сниженный интерес к еде (low appetite, low food interest).

5. Клиническая картина

Три клинических представления

- Сенсорная чувствительность — «picky eater» — ограниченный набор продуктов, чувствительность к текстуре.
- Сниженный интерес к еде — чувство голода слабое, стимул к еде отсутствует.
- Страх (удушья, рвоты) — избегание после конкретного триггерного события.

Последствия: значительная потеря веса или недостаточная прибавка веса (у детей), нутритивные дефициты (железо, цинк, витамины), зависимость от энтерального питания, социальные нарушения (школьные обеды, еда с товарищами).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Избегание или ограничение приёма пищи, приводящее как минимум к одному из:

1. Значительная потеря веса или недостаточная прибавка веса
2. Значительный нутриционный дефицит
3. Зависимость от энтерального питания или пероральных нутритивных добавок;
4. Значительные психосоциальные нарушения.

B. Расстройство не объясняется имеющимся дефицитом питания или культурной практикой.

C. Не возникает в контексте анорексии или булимии; нарушения образа тела нет.

D. Не объясняется лучше другим медицинским или психическим состоянием (например, аллергия, ОКР).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- NICE NG69 — правила специфического вмешательства при ARFID.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью и анамнез питания.
2. NIAS (англ. Nine Item ARFID Screen) — скрининг.
3. Медицинская оценка — вес, рост, ИМТ, лабораторные показатели дефицита питательных веществ.
4. Скрининг аутизма и ОКР.
5. Исключение аллергии и желудочно-кишечной патологии.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Анорексия (6B80)	Страх образа тела и веса является основным.

Состояние	**Отличительный признак**
Расстройство аутистического спектра (6A02)	Компонент сенсорной чувствительности; ARFID может быть коморбидным с РАС.
ОКР (6B20)	Обсессии загрязнения являются основными; ритуализированное поведение.
Специфическая фобия (6B03)	Конкретный объект; при ARFID — множественные виды пищи.
Аллергия / Болезнь Крона / целиакия	Медицинское подтверждение.

7. Обследование и оценка

- NIAS, EDE-Q.
- Вес, рост, история ИМТ.
- Лабораторно: общий анализ крови, ферритин, цинк, витамин D, B12, фолат.
- Скрининг на аутизм (M-CHAT, ADOS).

8. Лечение

1. Мультидисциплинарный подход: нутрициолог + КПТ-терапевт + пищевой/эрготерапевт.
2. FBT-ARFID — адаптировано Lock J.
3. КПТ-АР — Cognitive Behavioral Therapy for ARFID (Thomas J.J.) — мануализирована.
4. Ступенчатая пищевая экспозиция — постепенное введение новых видов пищи.
5. Элементы сенсорной интеграции (на фоне аутизма).
6. Соматическое: нутриционная коррекция; в тяжёлых случаях — энтеральное питание.
7. СИОЗС при коморбидной тревоге; препарата, одобренного FDA специально для ARFID, нет.

8.1 Методики лечения

1. КПТ для ARFID (англ. CBT for ARFID, CBT-AR) — Томас (Thomas J.J.) — Мануализированные протоколы, соответствующие сенсорному, низкоинтересному и подтипу страха.
2. FBT-ARFID — Фокус на роли семьи в пищевой экспозиции.
3. Ступенчатая пищевая экспозиция — Этапы ознакомления с новой едой: смотреть → трогать → пробовать → глотать.
4. Скрининг ARFID из девяти пунктов (англ. Nine Item ARFID Screen, NIAS) — оценка 3 подтипов.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG69 — ступенчатая пищевая экспозиция.
- Thomas J.J. CBT-AR — новая доказательная база.

9. Прогноз

- При мультидисциплинарном подходе улучшение у большинства пациентов.
- Длительное наблюдение на фоне аутизма и ОКР.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ARFID — это просто „привередливость в еде“»

Доказательства: клинический диагноз требует значительных функциональных нарушений или недостаточности питания.

Миф 2: «Пациента можно заставить есть голодом»

Доказательства: Стратегия голодания при ARFID неэффективна и вредна для детско-родительских отношений; рекомендуется ступенчатая экспозиция.

Миф 3: «Расстройство избегания/ограничения приёма пищи — это „лёгкая форма“ нервной анорексии»

Доказательства: отдельная клиническая единица; нет нарушения образа тела и страха веса; вмешательство отличается.

Миф 4: «АРФИД на фоне аутизма не поддаётся лечению»

Доказательства: сенсорная интеграция и поведенческие подходы эффективны и на фоне аутизма.

Миф 5: «Пациент „перерастёт“»

Доказательства: может продолжаться без лечения; раннее вмешательство предотвращает нутриционные осложнения.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6B83 ARFID. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.
4. Thomas J.J., Eddy K.T. Cognitive-Behavioral Therapy for ARFID. Cambridge University Press; 2018.
5. Zickgraf H.F., Ellis J.M. Initial validation of the Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder Screen (NIAS). Appetite 2018;123:32–42.
6. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.

6C00–6C0Z РАССТРОЙСТВА ЭКСКРЕЦИИ

Elimination disorders

МКБ-11 **6C00**	**6C00 ЭНУРЕЗ** **Enuresis**
МКБ-10 F98.0	Энурез неорганической природы
DSM-5-TR F98.0	Энурез

1. Определение и нозология

Энурез (МКБ-11: 6C00; DSM-5-TR: F98.0) — непроизвольное мочеиспускание, продолжающееся, когда ребёнок достигает возраста развития не менее 5 лет. Частота: не реже 2 раз в неделю в течение ≥ 3 месяцев или значительное функциональное нарушение.

Подтипы (ICCS — International Children's Continence Society 2014):

- Моносимптомный ночной энурез — только ночью, дневные симптомы отсутствуют;
- Немоносимптомный энурез — дополнительные дневные симптомы (императивные позывы, учащение, недержание);
- Первичный — ребёнок никогда не достигал устойчивой сухости в течение 6 месяцев;
- Вторичный — рецидив после сухого периода.

2. История

- В XIX веке в клинической литературе начали отмечать семейное накопление энуреза.
- Mowrer O.H. (1938) — изобрёл сигнализацию pad-and-bell.
- ICCS (1989) — международная стандартизация.
- NICE CG111 (2010) — клиническое руководство по ночному энурезу.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 5 лет — 15–20 %, 7 лет — 5–10 %, 10 лет — 3–5 %, взрослые — 1–2 %.
- Пол: мужчины 2:1.
- Спонтанная ремиссия ~15% в год.
- Коморбидность: СДВГ ~30%, тревога, расстройства поведения, запоры.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 70% (Обзоры Bayoumi R.A.).
- Три основных механизма (моносимптоматический ночной):
    - Незрелость ночной секреции вазопрессина (АДГ) (ночная полиурия);
    - Высокий порог пробуждения;
    - Объём мочевого пузыря меньше возрастной нормы.
- При немоносимптомной форме — связь с гиперактивностью мочевого пузыря, запором.
- Вторичный энурез — стресс, инфекция мочевыводящих путей (ИМП), диабет, психиатрический триггер.

5. Клиническая картина

- Ночное недержание мочи.
- Дневные симптомы (немоносимптоматические): императивные позывы, «удерживающие манёвры» (реверанс Винсента, сжатие ног), учащение, недержание.
- Социально-эмоциональное: стыд, снижение самооценки, избегание социальной активности (кемпинг, ночёвки у друзей).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR / МКБ-11 / ICCS 2014)

A. Повторяющееся недержание мочи (в постели или одежде), произвольное или непроизвольное.

B. Частота: ≥ 2 раз в неделю, ≥ 3 месяцев; или значительный дистресс/функциональное нарушение.

C. Возраст развития ≥ 5 лет.

D. Не полностью объясняется веществом (диуретик) или медицинским состоянием (диабет, ИМП, структурная аномалия).

Квалификаторы: только ночной / только дневной / ночной и дневной; первичный / вторичный; моносимптоматический / немоносимптоматический.

6.2 Различия между источниками

- ICCS 2014 — стандарт терминологии подтипов.
- NICE CG111 — диагностика и алгоритм.
- AAP — педиатрическая оценка.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — начало, частота, дневные симптомы, семейный анамнез.
2. Анализ мочи и посев — исключение ИМП.
3. Дневник мочеиспускания на 3 дня — для дневных симптомов.
4. Оценка запора (Бристольская шкала формы стула).
5. Соматическое: вес, глюкоза, артериальное давление.
6. При подозрении на структурную аномалию — УЗИ мочевыводящих путей; урофлоуметрия при немоносимптомном течении.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
UTI	Посев мочи положительный.
Диабет (тип 1)	Полиурия, полидипсия; глюкоза повышена.
Diabetes insipidus	Удельный вес снижен.
Структурная аномалия (эктопический мочеточник)	Стойкое подтекание; УЗИ.
Нейрогенный мочевой пузырь	Патология спинного мозга.
Запор	Клиническая и Бристольская шкала стула.
Приступ (иктальный энурез)	ЭЭГ.

7. Обследование и оценка

- Анализ мочи, посев.
- Дневник мочеиспускания и запоров.
- УЗИ мочевыводящих путей (при атипичной клинике).
- Коморбидный СДВГ, скрининг тревоги.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ICCS 2020 · NICE CG111)

1. Поведенческое вмешательство:
    - Консервативные рекомендации — уменьшение потребления жидкости перед сном, адекватное потребление воды в течение дня, регулярное мочеиспускание, устранение запора.
    - Позитивное подкрепление (звёздная таблица) — за сухие ночи.
2. Первая линия специфического вмешательства:
    - Энурезный будильник (alarm) — pad-and-bell; возраст ≥ 6 лет, при наличии мотивации; долгосрочный хороший результат; 14 подряд сухих ночей достигают ~50%, остаются сухими при наблюдении ~40% (качество доказательств низкое). Доказательства: Caldwell P.H. Cochrane 2020.
    - Десмопрессин — синтетический аналог АДГ; быстрый эффект, но при отмене высокий рецидив. ≥ 6–7 лет.
3. Вторая линия:
    - Комбинация будильника + десмопрессин;
    - Антихолинергик (оксибутинин) — в контексте немоносимптоматического гиперактивного мочевого пузыря.
4. Рефрактерные случаи: имипрамин (ТЦА) — кардиомониторинг; с осторожностью, токсичность при передозировке.
5. Устранение запора — ПЭГ (полиэтиленгликоль) — первая линия; в контексте немоносимптоматического или коморбидного энкопреза.

8.2 Методики лечения

1. Энурезный будильник (Alarm) — Моуэр (Mowrer) — Ночной сигнализатор или сигнализатор на одежде (датчик влажности); непрерывное применение ≥ 4 недель; типичная длительность 12–16 недель. Кокрановский мета-анализ — наиболее доказанный долгосрочный метод.

2. Десмопрессин — Перорально 0,2–0,4 мг или сублингвально; за 1 час до сна; ограничение жидкости перед сном обязательно (риск гипонатриемии).
3. Дневник мочеиспускания и запоров — 3-дневный; частота, объём, ёмкость мочевого пузыря, дневные симптомы, частота дефекации.
4. Антихолинергический препарат (оксибутинин) — На фоне гиперактивного мочевого пузыря; при наличии дневных симптомов.
5. PEG (Коррекция констипации) — Первая линия; также используется при энкопрезе.

8.3 Различия между источниками

- ICCS 2020 — будильник и десмопрессин первой линии; «wait and see» до 5 лет, затем активное вмешательство.
- NICE CG111 — тот же алгоритм.
- AAP — педиатрические рекомендации.

9. Прогноз

- Спонтанная ремиссия ~15% в год; при вмешательстве ремиссия у большинства пациентов.
- Контроль запора важен.
- Коморбидный СДВГ, тревога — параллельное вмешательство.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «При ночном энурезе электрофорез на область паха и ягодиц стимулирует мочевой центр»

Почему распространено: советская практика физиотерапии; представляется семейными врачами как «безопасная».

Клиническая логика: Если дневное мочеиспускание в норме и расстройство не возникло спонтанно после какого-либо заболевания, причина не в почках, мочевом пузыре или спинном мозге. Патогенез — дисрегуляция АДГ, порог пробуждения и емкость мочевого пузыря — электрофорез на них не влияет.

Доказательства: ICCS 2020, NICE CG111 — ни в одном международном руководстве электрофорез не упоминается. Риск: раздражение кожи, психосексуальная нагрузка.

Реальный клинический шаг: Аларм или десмопрессин.

Миф 2: «Просто пройдёт само, вмешательства не требует»

Доказательства: спонтанная ремиссия ~15% в год, но без лечения затяжное течение создаёт социально-эмоциональную нагрузку; ICCS 2020 рекомендует активное вмешательство с 5+ лет.

Миф 3: «Наказание или оскорбление исправляют ребёнка»

Доказательства: наказание противопоказано; снижение самооценки, риск депрессии; позитивное подкрепление предпочтительнее.

Миф 4: «Ограничение воды перед сном само по себе достаточно»

Доказательства: Адъюнктивная мера; в качестве монотерапии у большинства пациентов неэффективна; требуется специфическое вмешательство.

Миф 5: «Имипрамин или антидепрессант — первая линия»

Доказательства: имипрамин при рефрактерных случаях; кардиальные побочные эффекты и риск передозировки; предпочтительнее аларм и десмопрессин.

Миф 6: «Акупунктура и гомеопатия излечивают энурез»

Доказательства: Обзоры Cochrane — эффект этих комплементарных вмешательств не доказан.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C00 Enuresis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG111. Nocturnal enuresis in children and young people under 19. 2010.
4. Nevéus T. et al. Management and treatment of nocturnal enuresis — an updated standardization document from the International Children's Continence Society. J Pediatr Urol 2020;16(1):10–19.
5. Caldwell P.H., Codarini M., Stewart F. et al. Alarm interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2020; (5):CD002911.
6. Bayoumi R.A., Eapen V., Al-Yahyaee S. et al. The genetic basis of inherited primary nocturnal enuresis: a UAE study. J Psychosom Res 2006;61(3):317–320.

МКБ-11 **6C01**	**6C01 ЭНКОПРЕЗ** **Encopresis**
МКБ-10 F98.1	Энкопрез неорганической природы
DSM-5-TR F98.1	Энкопрез

1. Определение и нозология

Энкопрез (МКБ-11: 6C01; DSM-5-TR: F98.1) — произвольная или непроизвольная дефекация в неподходящих местах (в одежду, на пол), продолжающаяся, когда ребёнок достигает возраста развития не менее 4 лет. Частота: не реже 1 раза в месяц в течение ≥ 3 месяцев.

Подтипы:

- Ретентивный (недержание переполнения) — на основе запоров; ~80% случаев.
- Неретентивный — запоров нет.

2. История

- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- Rome IV — консенсус в рамках функциональных ЖКТ.
- Руководство NASPGHAN/ESPGHAN по функциональному запору (Tabbers M.M. et al. 2014).

3. Эпидемиология

- 1–4% среди детей 4–17 лет; у мальчиков в 3–6 раз выше.
- ~80% — основано на запоре (ретенционное).
- Коморбидность: энурез, СДВГ, тревога, расстройство аутистического спектра.

4. Этиология и патогенез

- Запор — основной механизм (при ретенционном энкопрезе); болезненная дефекация → задержка → ректальное расширение → снижение чувствительности → переполнение.

- Травма, страх, дисциплина в процессе приучения к туалету.
- Диета (низкое содержание клетчатки, дегидратация).
- Поведенческие и эмоциональные факторы — оппозиционные, тревожность.
- В редких случаях — болезнь Гиршпрунга (ректальный аганглиоз), спинальная патология.

5. Клиническая картина

- Фекальное подтекание на одежду (soiling).
- Ретентивный — фекальная масса при пальпации живота; напряжённая прямая кишка; эпизоды массивной дефекации.
- Социально-эмоциональное: стыд, социальная изоляция, избегание школы.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Дефекация в неподходящих местах (одежда, пол), произвольная или непроизвольная.

B. Частота: ≥ 1 раза в месяц, ≥ 3 месяцев.

C. Возраст развития ≥ 4 года.

D. Не полностью объясняется веществом (слабительное) или медицинским состоянием (болезнь Гиршпрунга, анатомическая аномалия, спинальная патология).

Квалификатор: с запором и переполнением / без.

6.2 Различия между источниками

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — руководство по функциональному запору (Rome IV).
- NICE CG99 (2010) — запор у детей и подростков.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — частота дефекации, боль, анамнез приучения к туалету.
2. Пальпация живота — фекальная масса.

3. Ректальное исследование — фекальная импакция (или клиническое подозрение на неё).
4. Дневник дефекации (Бристольская шкала формы стула).
5. Соматическое: щитовидная железа (гипотиреоидный запор), сывороточный кальций, скрининг на целиакию.
6. При атипичной клинике: УЗИ, аноректальная манометрия, аспирационная биопсия (болезнь Гиршпрунга).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Болезнь Гиршпрунга	Врождённый запор; при ректальном исследовании — сужение; биопсия — аганглионоз.
Гипотиреоз	TSH.
Спинальная патология	Неврологические признаки; МРТ.
Целиакия	Anti-tTG.
Структурная аномалия ануса	Физикальное обследование, УЗИ.

7. Обследование и оценка

- Абдоминальное и ректальное обследование.
- Бристольская шкала стула, дневник дефекации.
- ТТГ, кальций, анти-тТГ (антитела к тканевой трансглутаминазе) — избирательно.
- УЗИ, манометрия при атипичном течении.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NASPGHAN/ESPGHAN · NICE CG99)

1. Устранение импакции (disimpaction) — ПЭГ (полиэтиленгликоль) в высокой дозе 3–7 дней; пероральный путь предпочтительнее; клизмы не рекомендуются — травматичны.
2. Поддерживающая терапия (maintenance) — ПЭГ 0,4 г/кг/сут, месяцами-годами; обеспечивает регулярную и безболезненную дефекацию.
3. Поведенческое вмешательство:

- Регулярное время посещения туалета (через 15–20 минут после еды, гастроколический рефлекс);
- Правильная опора для ног (позиция для дефекации);
- Позитивное подкрепление (без наказания).

4. Диета: клетчатка, увеличение потребления воды (умеренный эффект; не заменяет PEG).
5. Психологическая поддержка: снижение возбуждения, обучение семьи.
6. При рефрактерности биофидбэк, мультидисциплинарный подход; хирургия редко (антеградная клизма Malone).

8.2 Методики лечения

1. ПЭГ (полиэтиленгликоль) — Осмотическое слабительное; доза для дезимпакции 1–1,5 г/кг/день × 3 дня; поддерживающая доза 0,4 г/кг/день; месяцы-годы; побочные эффекты минимальны.
2. Время и положение для туалета — Туалет через 15–20 минут после еды на 5–10 минут; опора для ног — сгибание в тазобедренных суставах выпрямляет аноректальный угол и снижает натуживание; при видеоманометрии угол во время дефекации составляет ~100° сидя и ~126° на корточках (Sakakibara R. et al. LUTS 2010).
3. Позитивное подкрепление (Star Chart — звёздная таблица) — Поощрение позитивного поведения вместо наказания.
4. Биофидбек (Biofeedback) — В рефрактерных случаях; тренировка аноректальной координации.

8.3 Различия между источниками

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — PEG — первая линия; клизма травматична и вторая линия.
- NICE CG99 — то же.
- Cochrane (Gordon M. et al. 2016) — ПЭГ превосходит лактулозу.

9. Прогноз

- PEG и поведенческое вмешательство — ремиссия у большинства пациентов (50–80% в течение 1 года).
- Рекомендуется длительное поддерживающее лечение; раннее прекращение создаёт риск рецидива.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Энкопрез — результат психологического „упрямства“ или эмоционального расстройства»

Доказательства: ~80% случаев основаны на запоре; медицинская/поведенческая консультация является первой линией, а не психологическая. Объяснение поведения пациента как «намеренного» ошибочно.

Миф 2: «Наказанием можно исправить ребёнка»

Доказательства: NASPGHAN/ESPGHAN — наказание противопоказано; позитивное подкрепление повышает самооценку и копинг.

Миф 3: «Клизма — вмешательство первой линии»

Доказательства: пероральный ПЭГ предпочтительнее; клизма травматична, вторая линия.

Миф 4: «Изменения в диете достаточно сами по себе»

Доказательства: клетчатка/вода — умеренный адъювантный эффект; коррекция импакции и поддерживающая терапия требуют PEG.

Миф 5: «Энкопрез проходит с возрастом, не требует лечения»

Доказательства: хронизация без лечения, социально-эмоциональное бремя; рекомендуется активное вмешательство.

Миф 6: «Пробиотики излечивают энкопрез»

Доказательства: Cochrane — значимый эффект пробиотиков не доказан.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C01 Encopresis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Tabbers M.M. et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58(2):258–274.
4. NICE CG99. Constipation in children and young people. 2010.
5. Gordon M. et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev 2016;(8):CD009118.

6. Sakakibara R., Tsunoyama K., Hosoi H. et al. Influence of body position on defecation in humans. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms 2010;2(1):16–21.

6C20 ТЕЛЕСНЫЙ ДИСТРЕСС

Disorders of bodily distress or bodily experience

МКБ-11 **6C20**	**6C20 ТЕЛЕСНЫЙ ДИСТРЕСС** **Bodily distress disorder**
МКБ-10 F45.0	Соматизированное расстройство
DSM-5-TR F45.1	Расстройство соматических симптомов

1. Определение и нозология

Телесный дистресс (МКБ-11: 6C20 Bodily Distress Disorder; DSM-5-TR: F45.1 Somatic Symptom Disorder) — психическое расстройство, при котором соматические жалобы (боль, утомляемость, желудочно-кишечные или кардиопульмональные симптомы) вызывают чрезмерную фокусировку, тревогу и поведенческое вмешательство, сопровождающиеся функциональными нарушениями. Клинический диагноз устанавливается не на основании «необъяснимости симптомов», а на основании стойкой озабоченности и дистресса (основное изменение обновления DSM-5-TR).

2. История

- Briquet P. (1859) — «истерия» с множественными соматическими симптомами.
- DSM-III (1980) — группа «Somatoform Disorders».
- DSM-5 (2013) — фундаментальное изменение: требование «медицински необъяснимых симптомов» отменено; реальность соматического симптома не является критерием — диагностический фокус на реакции пациента.
- МКБ-11 (2019) — «Bodily Distress Disorder» — основано на европейской модели телесного дистресса (Fink P., Schröder A.).

3. Эпидемиология

- В первичной медицинской помощи 5–15%.
- Пол: у женщин в 2–3 раза выше.
- Коморбидность: БДР, тревога, паническое расстройство, имитированное расстройство, реальные соматические заболевания.
- Высокое использование медицинских услуг и расходы.

4. Этиология и патогенез

- Биопсихосоциальная модель — биологическая уязвимость + когнитивно-аффективные эмоциональные компоненты + социальное подкрепление.
- История травмы и детских заболеваний.
- Когнитивные — катастрофизация телесных ощущений и гипервигильность.

5. Клиническая картина

- Стойкие соматические симптомы (боль, усталость, желудочно-кишечные, кардиопульмональные).
- ≥ 1 из следующих:
  - Чрезмерные и устойчивые мысли о тяжести симптомов;
  - Высокая тревога, связанная со здоровьем;
  - Чрезмерное время и энергия, затрачиваемые на симптомы.
- Длительность ≥ 6 месяцев.
- Функциональное нарушение.
- «Хождение по врачам», повторные обследования, избегающее поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Один или несколько соматических симптомов, вызывающих у пациента дистресс или функциональные нарушения.

B. ≥ 1 из следующих:

1. Чрезмерные мысли о тяжести симптомов;
2. Высокая тревога, связанная со здоровьем;

3. Чрезмерное время/энергия на симптомы.

C. Длительность ≥ 6 месяцев.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — «with predominant pain» и квалификаторы тяжести.
- МКБ-11 — «Bodily Distress Disorder» — близка к европейской концепции «bodily distress syndrome» (Fink P.); тяжесть (лёгкая, умеренная, тяжёлая).
- Немецкое S3-руководство (Funktionelle Körperbeschwerden, 2018) — биопсихосоциальный подход.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. PHQ-15 (шкала соматических симптомов), SSS-8.
3. Медицинская оценка — исключение соматического заболевания (но избегать чрезмерного тестирования).
4. Коморбидность (БДР, тревога, имитированное расстройство, реальные заболевания).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Ипохондрия (6B23)	Доминирует тревога по поводу болезни; соматические симптомы минимальны.
Реальное соматическое заболевание	Клиническое и лабораторное подтверждение; однако возможно коморбидное соматическое симптоматическое расстройство.
FND (6B60)	Специфические неврологические симптомы; «положительные знаки».
Искусственное расстройство (6D50)	Сознательная ложь; мотивация выгоды.
Симуляция	Явная материальная/юридическая выгода.

Состояние	Отличительный признак
Соматическая форма БДР	Доминируют аффективные симптомы.

7. Обследование и оценка

- PHQ-15, SSS-8, Whiteley Index (перекрытие).
- Однократное комплексное медицинское обследование; затем минимум повторных.
- Шкалы для оценки коморбидности.

8. Лечение

1. Биопсихосоциальный подход и «stepped care» — врач первичной медико-санитарной помощи — центр, психиатр/психолог — адъюнкт.
2. Модель одного врача (single physician approach) — все жалобы управляются через этого врача.
3. КПТ — когнитивная реструктуризация, уменьшение катастрофизации телесных ощущений, поведенческая активация. Доказательства: van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
4. СИОЗС — при коморбидном БДР/тревоге; при доминировании боли — дулоксетин, амитриптилин.
5. Структурированное ограниченное обследование — однократное комплексное обследование пациента, затем ограниченное «reassurance».
6. Майндфулнес, физическая активность, профессиональная реабилитация.

8.1 Методики лечения

1. КПТ при соматических симптомах — Когнитивная реструктуризация + поведенческое вмешательство (снижение избегания, экспозиция). van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
2. Модель одного врача — Структурированный визит; ограниченное количество проверок; последовательное объяснение.
3. PHQ-15, SSS-8 — Шкалы соматических жалоб.
4. Ступенчатая помощь (англ. Stepped Care) — Краткое вмешательство на основе КПТ на уровне первичной медицинской помощи; затем специализированная служба.

8.2 Различия между источниками

- Немецкое S3-руководство — интегрированная помощь на уровне первичной медицинской помощи.
- NICE — отдельного руководства по соматическому симптоматическому расстройству нет; применяются общие принципы.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при КПТ и мультидисциплинарном подходе; хроническое течение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациент „выдумывает“ симптомы»

Доказательства: симптомы реальны для пациента; соматическое расстройство — это клиническое состояние, а не симуляция.

Миф 2: «Слова „ничего нет“ после медицинского обследования успокаивают пациента»

Доказательства: негативное заверение краткосрочно; поддерживает долгосрочную тревогу. Структурированное объяснение и биопсихосоциальная модель предпочтительнее.

Миф 3: «Только если медицинское исследование длится долго, диагноз будет выявлен»

Доказательства: Повторная проверка увеличивает соматическую фиксацию и расходы; однократная комплексная оценка, затем ограничение.

Миф 4: «Соматическое симптоматическое расстройство — это только „болезнь ума“»

Доказательства: биопсихосоциальное расстройство; биологические компоненты (чувствительность, ось кишечник-мозг) реальны.

Миф 5: «Антидепрессант — это „лечение“ соматического симптоматического расстройства»

Доказательства: СИОЗС при коморбидных симптомах; КПТ — первая линия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C20 Bodily distress disorder. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kleinstäuber M. et al. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD010628.
4. Henningsen P. et al. Management of somatic symptom disorder. Dialogues Clin Neurosci 2018;20(1):23–31.
5. Schaefert R. et al. Non-specific, functional, and somatoform bodily complaints. Dtsch Arztebl Int 2012;109(47):803–813.
6. van Dessel N., den Boeft M., van der Wouden J.C. et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD011142.

6C40–6C5Z СВЯЗАННЫЕ С ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Disorders due to substance use or addictive behaviours

МКБ-11 **6C40**	**6C40 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ** **Disorders due to use of alcohol**
МКБ-10 F10	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
DSM-5-TR F10.20	Расстройство употребления алкоголя, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления алкоголя (МКБ-11: 6C40; DSM-5-TR: F10.20 Расстройство употребления алкоголя, AUD) — группа расстройств, характеризующихся нарушением контроля над употреблением алкоголя, продолжением употребления, несмотря на причинение физического или психологического вреда. Подтипы в МКБ-11: вредный паттерн употребления (6C40.1), алкогольная зависимость (6C40.2), интоксикация (6C40.3), синдром отмены (6C40.4), алкоголь-индуцированные делирий, психотические, аффективные, тревожные расстройства.

2. История

- Jellinek E.M. (1960) — «The Disease Concept of Alcoholism» — алкоголизм как болезнь.
- DSM-IV — «Злоупотребление» и «Зависимость» — отдельные категории.

- DSM-5 (2013) — единое «Alcohol Use Disorder» (лёгкая, средняя, тяжёлая степень).
- МКБ-11 — разделение на эпизодическое вредное употребление или паттерн зависимости.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 14–29% (англ. NIAAA NESARC); годовая 5–14%.
- Пол: у мужчин в 2–3 раза выше, но у женщин наблюдается рост.
- Смертность: 3 млн смертей в год в мире (ВОЗ).
- Коморбидность: БДР, тревога, ПТСР, ПРЛ, другое употребление ПАВ, заболевание печени, сердечно-сосудистая патология.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость ~49% (95% ДИ 43–53) (Verhulst B. et al. Psychol Med 2015).
- Нейробиологически — дофаминовый контур вознаграждения, системы ГАМК, глутамата, опиоидов.
- Среда — сверстники, стресс, доступность алкоголя, культурная норма.
- Генетические маркеры — ADH1B, ALDH2 (защитные в азиатской популяции).

5. Клиническая картина

5.1 Синдром зависимости (критерии DSM-5-TR, ≥ 2 из 11)

- Более частое/длительное использование;
- Попытки сокращения безуспешны;
- Большую часть времени тратит на приобретение вещества, его употребление и восстановление;
- Тяга к употреблению (craving);
- Нарушение работы/учебы;
- Продолжение, несмотря на социально-интерперсональную проблему;
- Отказ от важных видов деятельности;
- Использование в опасной ситуации;
- Продолжение, несмотря на физическую/психологическую проблему;

- Толерантность;
- Синдром отмены.

5.2 Интоксикация

- Расторможенность, дизартрия, атаксия, нистагм, когнитивное нарушение.
- Тяжёлая интоксикация — кома, угнетение дыхания, гипогликемия, смерть.

5.3 Синдром отмены (withdrawal)

- Лёгкая: тремор, потливость, тахикардия, тревога, тошнота (через 6–24 часа после последнего употребления).
- Средняя степень: вегетативная гиперактивность, галлюцинации (алкогольный галлюциноз).
- Тяжёлое: delirium tremens (DT) — 48–96 часов; изменения сознания, галлюцинации, вегетативный криз; смертность среди госпитализированных пациентов ~1–4% (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); в исторических сериях без лечения — выше, но точных оценок нет; судороги.

5.4 Осложнения

- Вернике-Корсаков (дефицит B1), алкогольная болезнь печени, кардиомиопатия, полинейропатия, ФАС при беременности.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — ≥ 2 из 11 критериев (лёгкая 2–3, средняя 4–5, тяжёлая ≥ 6); МКБ-11 — паттерн употребления (эпизод употребления с вредными последствиями, паттерн употребления с вредными последствиями, зависимость); «опасное употребление» относится не к 6C4x, а к коду QE10. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- WHO AUDIT (Saunders 1993) — 10-пунктовый скрининг.

- NICE CG115 — диагностика и лечение алкогольных расстройств.
- SAMHSA TIP — международные протоколы.

6.3 Алгоритм диагностики

1. AUDIT, AUDIT-C скрининг на уровне первичной помощи.
2. Клиническое интервью — TLFB (англ. Timeline Followback) паттерн употребления.
3. Лабораторно: ГГТ, АСТ/АЛТ, MCV, CDT (углеводдефицитный трансферрин), общий анализ крови.
4. Коморбидность (БДР, тревога, ПТСР, соматические заболевания).
5. Риск отмены (CIWA-Ar).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Другое употребление психоактивных веществ	Токсикологический скрининг.
БДР с самолечением	Аффективные симптомы первичны.
Биполярное расстройство	Аффективные эпизоды.
Гипертиреоз	TSH.
Судорожное расстройство	ЭЭГ.

7. Обследование и оценка

- AUDIT, CIWA-Ar (тяжесть отмены).
- ГГТ, MCV, CDT, трансаминазы.
- Уровень тиамина.
- ЭКГ, УЗИ сердца (кардиомиопатия).
- Скрининг коморбидности.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG115 · SAMHSA TIP 49 · APA 2018)

1. Детоксикация:
    - Лёгкая (CIWA-Ar <10) — амбулаторно;
    - Умеренно-тяжёлая — стационарно (госпитализация);

- Бензодиазепин (лоразепам, диазепам) — золотой стандарт лечения отмены;
- Тиамин 100–300 мг в/в или в/м × 3–5 дней (профилактика Вернике — ДО введения глюкозы);
- Гидратация, коррекция электролитов.

2. Противорецидивная фармакотерапия:
   - Налтрексон (перорально 50 мг или в/м Вивитрол 380 мг ежемесячно) — первая линия; снижает влечение (cravings).
   - Акампросат (666 мг × 3 раза/день) — первая линия; поддержание абстиненции.
   - Дисульфирам — вторая линия; у мотивированного пациента; аверсивная реакция.
   - Топирамат, габапентин — off-label.
3. Психосоциальное вмешательство: Мотивационное интервью (MI), КПТ, 12-шаговая фасилитация (AA, NA), управление подкреплением (contingency management).
4. SAMHSA — сочетанное расстройство употребления и психиатрическая коморбидность (dual diagnosis).
5. Длительная профилактика рецидивов.

8.2 Методики лечения

1. Мотивационное интервью (MI — Motivational Interviewing) — Миллер (Miller W.R.), Роллник (Rollnick S.) — Повышение готовности к изменению поведения; направлено на «амбивалентность».
2. КПТ для употребления вещества — Распознавание триггеров, управление влечением (cravings), навыки совладания (coping), профилактика рецидивов.
3. Налтрексон, акампросат, дисульфирам — Противорецидивная фармакотерапия.
4. Поддержка программы «12 шагов» (12-Step Facilitation — AA, NA) — Project MATCH РКИ — сравнительная эффективность с КПТ и MI.
5. AUDIT, CIWA-Ar — Скрининг и тяжесть отмены.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG115 (2011).
- APA Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with Alcohol Use Disorder (2018).

- SAMHSA TIP 49 (2009).

9. Прогноз

- При мультимодальном подходе 40–50% длительной ремиссии.
- Коморбидное БДР, ПРЛ, другое ПАВ — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Алкоголизм — это слабость характера»

Доказательства: Jellinek 1960; ВОЗ — расстройство употребления алкоголя является медицинским состоянием; наследственность 50–60%.

Миф 2: «Детоксикация сама по себе — это лечение»

Доказательства: детоксикация — первый шаг; требуется вмешательство для предотвращения рецидива; только детоксикация — 90%+ рецидивов.

Миф 3: «Налтрексон делает алкоголь „неприемлемым“»

Доказательства: налтрексон снижает влечение и уменьшает «reward»-эффект алкоголя; отличается от дисульфирама.

Миф 4: «Пациент должен достичь „rock bottom“ до начала лечения»

Доказательства: раннее вмешательство более эффективно; концепция «rock bottom» не имеет доказательной базы.

Миф 5: «Алкоголь — самое безопасное вещество, не требует лечения»

Доказательства: ВОЗ — алкоголь ежегодно вызывает 2,6 млн смертей (ВОЗ 2024, данные 2019 г.); смертность при ДТ среди госпитализированных пациентов ~1–4% (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); в исторических сериях без лечения — существенно выше.

Миф 6: «Небольшое количество алкоголя безопасно для беременной»

Доказательства: CDC, AAP — любое количество алкоголя при беременности создаёт риск ФАС; «безопасной» дозы нет.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C40 Disorders due to use of alcohol. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. NICE CG115. Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management. 2011.
4. APA. Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with AUD. 2018.
5. SAMHSA. TIP 49: Incorporating Alcohol Pharmacotherapies Into Medical Practice. 2009.
6. Anton R.F. et al. COMBINE trial. JAMA 2006;295(17):2003–2017.
7. Project MATCH Research Group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity. J Stud Alcohol 1997;58(1):7–29.
8. Verhulst B., Neale M.C., Kendler K.S. The heritability of alcohol use disorders: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychol Med 2015;45(5):1061–1072.
9. Schuckit M.A. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med 2014;371(22):2109–2113.
10. Saunders J.B., Aasland O.G., Babor T.F. et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Addiction 1993;88(6):791–804.
11. Miller W.R., Rollnick S. Motivational Interviewing: Helping People Change. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2013.

МКБ-11 **6C43**	**6C43 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ** **Disorders due to use of opioids**
МКБ-10 F11	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов
DSM-5-TR F11.20	Расстройство употребления опиоидов, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления опиоидов (МКБ-11: 6C43; DSM-5-TR: F11.20 Расстройство употребления опиоидов, OUD) — нарушенный контроль над употреблением опиоидов (героин, морфин, оксикодон, фентанил и др.) или

вредный паттерн употребления. Высокая смертность, связанная с медицинскими и криминальными аспектами (передозировка).

2. История

- Dole V.P., Nyswander M. (1965) — первые исследования метадоновой поддерживающей терапии.
- 2010+ — опиоидная эпидемия в США: от рецептурных опиоидов до кризиса передозировок фентанилом.
- ВОЗ, SAMHSA, NICE — опиоидная агонистная поддерживающая терапия (ОАТ) — золотой стандарт.

3. Эпидемиология

- В мире: 40 млн+ пациентов (UNODC); в США ежегодно 80 000+ смертей от передозировки.
- Пол: у мужчин в 2 раза выше.
- Коморбидность: БДР, тревога, ПТСР, ПРЛ, ВИЧ/ВГС, кардиальная патология.
- Смертность: у пациентов с РУО в лечении в 10–20 раз выше по сравнению с популяцией.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50%.
- Нейробиологическая — влияние μ-опиоидной рецепторной системы на дофаминергический цикл вознаграждения.
- Среда — доступность рецептурных опиоидов, социально-экономические факторы.
- Болевые синдромы — переход от прескрипционного начала к зависимости.

5. Клиническая картина

- Синдром зависимости (те же критерии, что и для AUD).
- Интоксикация — миоз, седация, угнетение дыхания, гипотензия, кома.
- Передозировка — дыхательная депрессия является основной причиной смерти; антидот — налоксон.

- Отмена — начало через 8–24 часа (короткого действия), 36–72 часа (длительного действия метадон); ринорея, слезотечение, мидриаз, тревога, тахикардия, спазмы в животе, диарея, газообразование.
- Отмена не опасна для жизни у взрослых (в отличие от алкоголя/седативных), но тяжела у новорождённых (NAS — Neonatal Abstinence Syndrome).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR: та же структура из 11 критериев, что и при AUD (лёгкая/средняя/тяжёлая). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- SAMHSA TIP 63 — Medications for Opioid Use Disorder.
- NICE CG52 — опиоидная зависимость.
- WHO mhGAP.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Токсикологический скрининг (моча).
3. ВИЧ, HCV, сифилис, тест на беременность.
4. Коморбидность и анамнез передозировки.
5. COWS (англ. Clinical Opiate Withdrawal Scale) — тяжесть отмены.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Хроническая боль (без зависимости)	Медицинские показания; паттерн употребления.
Другое употребление психоактивных веществ (седативные, алкоголь)	Токсикологический скрининг.

Состояние	Отличительный признак
Функциональные GI/гусиная кожа (пилоэрекция) (разница в отсечении)	Медицинская оценка.

7. Обследование и оценка

- Токсикологический скрининг.
- Шкала COWS.
- ВИЧ, HCV, HBV, сифилис.
- ЭКГ (перед началом приёма метадона — QTc).
- Тест на беременность.

8. Лечение

8.1 OAT — опиоидная агонистная терапия (золотой стандарт)

1. Метадон (в клинике поддерживающей терапии, под ежедневным контролем) — полный μ-агонист; 60–120 мг/сут; длительный период полувыведения; мониторинг QTc.
2. Бупренорфин/налоксон (Suboxone) — частичный μ-агонист + налоксон; амбулаторное назначение; низкий потенциал передозировки; «индукция» — начинается в состоянии лёгкой абстиненции.
3. OAT значительно снижает смертность (Sordo L. et al. BMJ 2017;357:j1550 мета-анализ) и передачу ВИЧ (MacArthur G.J. et al. BMJ 2012 мета-анализ).
4. OAT превосходит психосоциальное вмешательство в снижении смертности; однако комбинация с психосоциальным вмешательством (МИ, КПТ, управление подкреплением, поддержка сверстников, 12 шагов — см. «Методы лечения») является оптимальной.

8.2 Антагонисты

- Налтрексон (перорально 50 мг или в/м Вивитрол 380 мг ежемесячно) — пациент должен быть абстинентным 7–10 дней до начала; для мотивированных пациентов или при отсутствии формальных программ поддерживающей терапии.

8.3 Ведение передозировки

- Налоксон — в/м или интраназально; широко распространены; программы «take-home» (на базе сообщества) снижают смертность.

8.4 При беременности

- Метадон или бупренорфин — ОАТ продолжается во время беременности; детокс является противопоказанием (риск рецидива зависимости и потери беременности).
- Вмешательство NAS у новорождённого — морфин или метадон.

8.5 Специфические для источников уточнения

- SAMHSA TIP 63 (2021).
- NICE CG52 (опиоидная детоксикация) и CG51 (психосоциальные вмешательства).
- ВОЗ — ОАТ является золотым стандартом, превосходит абстинентно-ориентированный подход.

8.6 Методики лечения

1. Метадоновая поддерживающая терапия (англ. Methadone Maintenance Therapy, ММТ) — Модель Доул-Нисвандера; клинически ориентированная.
2. Бупренорфин/налоксон — Офисный протокол; протокол «Suboxone induction»; благодаря «потолочному» эффекту — меньший потенциал передозировки.
3. Программа выдачи налоксона на дом (Take-Home) — На уровне сообщества; обучение семьи применению антидота.
4. Клиническая шкала отмены опиоидов (англ. Clinical Opiate Withdrawal Scale, COWS) — 11 пунктов; важна при индукции.
5. Налтрексон в/м (Vivitrol) — Ежемесячно; у абстинентного пациента.

9. Прогноз

- Долгосрочная стабилизация и снижение смертности с помощью ОАТ.
- Вмешательство при коморбидности обязательно.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ОАТ (метадон, бупренорфин) заменяет одну наркоманию другой»

Доказательства: ОАТ — это медикаментозное лечение, значительно снижающее смертность, ВИЧ, преступность, социальную дезорганизацию; «чувствительная» анти-ОАТ позиция не имеет доказательной базы. ВОЗ, SAMHSA, NICE — ОАТ является золотым стандартом.

Миф 2: «Детоксикации достаточно, OAT не нужна»

Доказательства: Только детоксикация — 90%+ рецидивов, смертность от передозировки наиболее высока сразу после детоксикации (утрата толерантности). OAT снижает смертность на 50%+.

Миф 3: «Сверхбыстрая опиоидная детоксикация (UROD) эффективна»

Доказательства: UROD сопровождается смертельными случаями и серьёзными побочными эффектами; доказательства эффективности отсутствуют; SAMHSA и NICE не рекомендуют.

Миф 4: «Беременной женщине необходима детоксикация»

Доказательства: детоксикация при беременности противопоказана; OAT (метадон или бупренорфин) сохраняется.

Миф 5: «Ибогаин или аяуаска излечивают опиоидную зависимость»

Доказательства: не доказано; ибогаин сопровождается сердечной аритмией и случаями смерти (предупреждение FDA); не входит в стандартную практику.

Миф 6: «Налтрексон — препарат первой линии при OUD»

Доказательства: SAMHSA TIP 63 — метадон и бупренорфин более эффективны в снижении смертности; налтрексон — у мотивированного абстинентного пациента.

Миф 7: «Программы выдачи налоксона на дом (take-home) поощряют употребление»

Доказательства: Walley A.Y. et al. BMJ 2013 — программы налоксона в сообществе значительно снижают смертность от передозировки; не увеличивают употребление.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C43 Disorders due to use of opioids. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 63: Medications for Opioid Use Disorder. 2021.
4. NICE CG52; NICE CG51.
5. MacArthur G.J. et al. Opioid substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs. BMJ 2012;345:e5945.

6. Sordo L., Barrio G., Bravo M.J. et al. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMJ 2017;357:j1550.
7. Walley A.Y. et al. Opioid overdose rates and implementation of overdose education and nasal naloxone distribution. BMJ 2013;346:f174.

МКБ-11 **6C41**	**6C41 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КАННАБИСА** **Disorders due to use of cannabis**
МКБ-10 F12	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов
DSM-5-TR F12.20	Расстройство употребления каннабиса, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления каннабиса (МКБ-11: 6C41; DSM-5-TR: F12.20) — нарушение контроля над употреблением каннабиса, содержащего ТГК, и/или употребление, причиняющее вред. Синтетические каннабиноиды в МКБ-11 кодируются отдельно (6C42).

2. История

- DSM-III (1980) — Cannabis Dependence — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — «каннабисная абстиненция» добавлена как формальная категория.
- 2010+ — эпидемия высокопотенциального каннабиса и синтетических каннабиноидов («Spice», «K2»).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: у 7–9% потребителей каннабиса развивается зависимость; риск у начинающих в подростковом возрасте 17%.
- Пол: выше у мужчин.

- Коморбидность: риск психоза, тревога, БДР, СДВГ, другое употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50–60%.
- Эндоканнабиноидная система.
- Социальные и культурные факторы; доступность.

5. Клиническая картина

- Синдром зависимости (те же критерии, что и для AUD).
- Интоксикация — покрасневшие глаза, тахикардия, повышение аппетита («мунчис»), нарушение восприятия времени, усиленные ощущения.
- Тяжёлая интоксикация — каннабиноидный гиперэмезис-синдром (синдром рвоты при хроническом употреблении), паника, психоз.
- Отмена (новое в DSM-5): раздражительность, тревога, нарушение сна, снижение аппетита, снижение настроения, соматические жалобы; начинается через 24–72 часа, длится 1–2 недели.
- Синтетические каннабиноиды («Spice», «K2») — более сильные, непредсказуемые; тяжёлая интоксикация, острый психоз, случаи смерти.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — 11 критериев (структура AUD). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- NIDA — принципы лечения расстройства, связанного с употреблением каннабиса.
- ВОЗ mhGAP — оценка на уровне первичного звена.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. CUDIT-R (англ. Cannabis Use Disorders Identification Test-Revised).
3. Токсикологический скрининг (ТГК в моче).
4. Коморбидный психоз, тревога, БДР.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Расстройство, связанное с синтетическими каннабиноидами (6C42)	Более сильный психотический и вегетативный эффект.
Психоз (индуцированный каннабисом или первичный)	Зависит от резидуального состояния после отмены вещества
Функциональные ЖКТ-нарушения (каннабиноидный гиперемезис)	Ремиссия при прекращении употребления.

7. Обследование и оценка

- CUDIT-R.
- Токсикологический скрининг.
- Коморбидность (психоз, тревога, БДР).

8. Лечение

1. Психосоциальное вмешательство первой линии — MI, КПТ, управление подкреплением (contingency management). Доказательства: Davis M.L. et al. Eval Health Prof 2015 мета-анализ.
2. Специфической одобренной FDA фармакотерапии нет. Off-label: N-ацетилцистеин (у подростков Gray K.M. Am J Psychiatry 2012 РКИ положительное — только на платформе управления подкреплением; у взрослых Gray K.M. Drug Alcohol Depend 2017 РКИ отрицательное), габапентин.
3. Коморбидный психоз — антипсихотик; отказ от каннабиса критичен.
4. Интоксикация синтетическими каннабиноидами — поддерживающая терапия, при необходимости атипичный антипсихотик.

8.1 Методики лечения

1. КПТ и мотивационное интервью (МИ) — Управление триггерами, мотивация, изменение поведения.
2. Управление подкреплением (англ. Contingency Management) — Вознаграждение за отрицательные токсикологические тесты.
3. CUDIT-R — скрининг из 8 пунктов.
4. N-ацетилцистеин (NAC) — Ранний положительный результат у подростков не воспроизвёлся (Cochrane 2025 RR 1,17; 95% ДИ 0,73–1,88) — экспериментально; off-label.

8.2 Различия между источниками

- NIDA — КПТ и управление подкреплением (contingency management) первой линии.
- WHO mhGAP.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при психосоциальном вмешательстве.
- Раннее начало употребления — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Каннабис „натурален“ и не вызывает зависимости»

Доказательства: CUD развивается в течение жизни у 7–9% потребителей; у подростков — 17%.

Миф 2: «Синдрома отмены каннабиса не существует»

Доказательства: DSM-5 (2013) — синдром отмены как формальная категория; раздражительность, нарушения сна и аппетита.

Миф 3: «Медицинский каннабис снижает риск психоза»

Доказательства: Marconi 2016 — ТГК повышает риск психоза дозозависимо: при среднем уровне употребления примерно вдвое (ОШ 1,97), у наиболее тяжёлых потребителей — примерно вчетверо (ОШ 3,90); для КБД — предварительные данные, не клиническая рекомендация.

Миф 4: «Каннабис не является „входным наркотиком“»

Доказательства: Концепция «входных ворот» спорна, но последовательный паттерн употребления статистически очевиден; причинность имеет различные объяснения.

Миф 5: «Каннабис с высоким содержанием ТГК безопаснее обычного каннабиса»

Доказательства: Доза ТГК коррелирует с риском психоза, зависимости, когнитивных нарушений; «potency creep» в последние десятилетия.

Миф 6: «Синтетические каннабиноиды („Spice“) безопасны»

Доказательства: синтетические каннабиноиды очень сильны, непредсказуемы; зарегистрированы случаи острого психоза и смерти.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C41 Disorders due to use of cannabis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NIDA. Research Report on Cannabis. 2020.
4. Davis M.L. et al. Behavioral therapies for treatment-seeking cannabis users: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eval Health Prof 2015;38(1):94–114.
5. Gray K.M. et al. A randomized placebo-controlled trial of N-acetylcysteine for cannabis use disorder in adults. Drug Alcohol Depend 2017;177:249–257.
6. Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.
7. Spiga F., Parkhouse T., Tang V.M. et al. Pharmacotherapies for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2025;9(9):CD008940.

МКБ-11 **6C44**	**6C44 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЕДАТИВНЫХ, СНОТВОРНЫХ ИЛИ АНКСИОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** **Disorders due to use of sedatives, hypnotics or anxiolytics**
МКБ-10 F13	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
DSM-5-TR F13.20	Расстройство употребления седативных, снотворных или анксиолитических средств, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления седативных, снотворных или анксиолитических средств (МКБ-11: 6C44; DSM-5-TR: F13.20 Расстройство употребления седативных, снотворных или анксиолитических средств) — нарушенный контроль над употреблением бензодиазепинов, Z-препаратов (золпидем, зопиклон), барбитуратов и других анксиолитиков. В клинической практике часто начинается с медицинского рецепта; распространена «ятрогенная зависимость».

2. История

- 1960-е годы — клиническое применение бензодиазепинов (хлордиазепоксид 1960, диазепам 1963).
- 1980-е годы — признание потенциала зависимости при длительном использовании.
- NICE и APA — рекомендация краткосрочного применения (2–4 недели).

3. Эпидемиология

- Длительное применение бензодиазепинов у пожилых — 10–20%; выявление проблемы низкое.
- Пол: выше у женщин по частоте назначений.
- Коморбидность: употребление алкоголя и опиоидов (опасная комбинация — риск передозировки).

4. Этиология и патогенез

- Ятрогения — долгосрочные рецепты.
- Адаптация к GABA-A рецепторной системе — толерантность и отмена.
- Паттерн самолечения у пациентов с тревогой и нарушением сна.

5. Клиническая картина

- Синдром зависимости — потеря контроля, толерантность, отмена.
- Интоксикация — седация, атаксия, дизартрия, дезингибиция, антероградная амнезия.
- Передозировка — угрожающая жизни дыхательная депрессия в сочетании с опиоидами.
- Отмена — угрожает жизни (как при алкоголе): тремор, тревога, тахикардия, гипертензия; в тяжёлых случаях — судороги и DT-подобный синдром.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — 11 критериев (структура AUD). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- NICE — назначение бензодиазепинов на 2–4 недели; длительное применение требует переоценки.

- Критерии Бирса — избегание бензодиазепинов у пожилых.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + анамнез назначений.
2. Токсикологический скрининг.
3. Коморбидное употребление алкоголя и опиоидов (особенно риск передозировки).
4. Клиническое обследование — признаки отмены.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Расстройство реальной тревоги	Коморбидность; употребление ПАВ симптоматическое.
Употребление алкоголя	Часто коморбидно.
Употребление опиоидов	Коморбидность; риск передозировки высокий.

7. Обследование и оценка

- Токсикологический скрининг.
- Витальные показатели (отмена).

8. Лечение

1. Постепенное снижение дозы (taper) — золотой стандарт: Пересчёт в эквивалентную дозу бензодиазепина длительного действия (диазепам), затем снижение на 10–25% в неделю; всего 6–12 недель (иногда месяцы). Быстрая отмена опасна для жизни.
2. Госпитализация — тяжёлая отмена или коморбидное употребление веществ.
3. Психосоциальное вмешательство — КПТ при тревоге или нарушении сна; это снижает потребность в фармакотерапии.
4. Лечение коморбидных расстройств (тревога, депрессия, сон).
5. Управление рецептами — на уровне первичной медицинской помощи.

8.1 Методики лечения

1. Ashton Manual Taper — Пересчёт в эквивалент диазепама, затем постепенное снижение; поддержка семьи.

2. КПТ при тревоге и нарушениях сна — Альтернатива использованию бензодиазепинов; CBT-I для сна.
3. Токсикологическое наблюдение — В период удержания.

8.2 Различия между источниками

- NICE, BNF — протоколы снижения дозы (taper).
- Ashton Manual — практическое клиническое руководство Heather Ashton (C.H. Ashton); издание 1999 г., пересмотр 2002 г.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при постепенном снижении дозы и КПТ.
- У пожилых людей отмена (препарата) трудна как с медицинской, так и с психологической точки зрения.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Бензодиазепины можно безопасно принимать всю жизнь»

Доказательства: Длительное применение — толерантность, зависимость, когнитивные нарушения, риск падений (у пожилых). NICE — краткосрочное применение.

Миф 2: «Быстрая отмена безопасна»

Доказательства: быстрая отмена сопряжена с риском судорог и смерти; постепенное снижение дозы критически важно.

Миф 3: «Z-препараты (золпидем) не вызывают зависимости»

Доказательства: Z-препараты также вызывают зависимость; AAFP и NICE рекомендуют краткосрочное использование.

Миф 4: «Бензодиазепины + опиоиды безопасны»

Доказательства: FDA black box предупреждение — эта комбинация значительно увеличивает риск угнетения дыхания и смерти.

Миф 5: «Детоксикация достаточна»

Доказательства: После отмены требуется альтернативное лечение (КПТ, управление тревогой).

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C44 Disorders due to sedative, hypnotic, anxiolytic. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE Quick Reference Guide. Benzodiazepines.
4. Ashton C.H. Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw (англ. Ashton Manual). 2002.
5. FDA Drug Safety Communication. Opioid pain or cough medicines combined with benzodiazepines: serious side effects. 2016.

МКБ-11 **6C45**	**6C45 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА** **Disorders due to use of cocaine**
МКБ-10 F14	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина
DSM-5-TR F14.20	Расстройство употребления стимуляторов (кокаин), умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления кокаина (МКБ-11: 6C45; DSM-5-TR: F14.20) — нарушенный контроль над употреблением кокаина или употребление, причиняющее вред. Включает интоксикацию, отмену, вредный паттерн употребления, зависимость, индуцированные психотические и аффективные расстройства.

2. История

- Листья коки используются в Андах тысячелетиями.
- Niemann A. (1860) — выделение кокаина.
- Freud (1884) — «Über Coca» — впоследствии критиковал клинический эффект.
- 1970–80-е годы — эпидемия «крэка» в США.

3. Эпидемиология

- Ежегодно в мире 21 млн потребителей (UNODC).
- Пол: у мужчин в 2 раза выше.
- Коморбидность: алкоголь, опиоиды, БДР, ПРЛ, психоз, сердечно-сосудистая смертность.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–50%.
- Нейробиологически — блокада обратного захвата дофамина → усиление мезолимбического вознаграждения; толерантность и «down-regulation».
- Социокультурное — сверстники, доступность, социально-экономическое.

5. Клиническая картина

- Синдром зависимости (критерии DSM-5-TR).
- Интоксикация — эйфория, гипервигильность, мидриаз, тахикардия, гипертензия, гипертермия; в тяжёлых случаях — параноидный бред, галлюцинации, ажитация, инфаркт миокарда, инсульт, судороги.
- Отмена — «crash» — депрессивное настроение, ангедония, утомляемость, гиперсомния, повышение аппетита, интенсивное влечение; высокий риск суицида.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — 11 критериев (структура AUD). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- SAMHSA TIP 33 — употребление стимуляторов.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + токсикология.
2. ЭКГ, тропонин (особенно при боли в груди).
3. ВИЧ, HCV, сифилис.
4. Коморбидность и риск суицида (высокий в период отмены).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Амфетамин/стимуляторы (6C46)	Токсикологическое дифференцирование.
Маниакальный эпизод	Анамнез употребления веществ и временная связь.
Психоз (индуцированный кокаином и первичный)	Ремиссия после элиминации вещества.
Гипертиреоз, феохромоцитома	Эндокринные тесты.

7. Обследование и оценка

- Токсикологический скрининг.
- ЭКГ, тропонин, кардиологическая оценка.
- HIV, HCV.
- C-SSRS.

8. Лечение

1. Психосоциальное — первая линия:
    - Управление подкреплением — наиболее сильная доказательная база (обзоры Petry N.M.).
    - КПТ;
    - МИ (мотивационное интервьюирование);
    - Community Reinforcement Approach (CRA).
2. Фармакотерапия — специфического одобренного FDA препарата нет. Исследования off-label — дисульфирам, модафинил, топирамат — неоднозначные результаты.
3. Лечение коморбидности.

4. Острая интоксикация — бензодиазепин (лоразепам); кардиомониторинг; антипсихотик при психозе.

8.1 Методики лечения

1. Управление подкреплением (англ. Contingency Management) — Петри (Petry N.M.), Хиггинс (Higgins S.) — Ваучер/вознаграждение за отрицательные токсикологические тесты; доказательная база наиболее сильна для кокаина.
2. КПТ и подход общественного подкрепления (CRA — Community Reinforcement Approach) — Управление триггерами, альтернативные вознаграждающие деятельности.
3. MI — Мотивация к изменению поведения.

8.2 Различия между источниками

- SAMHSA TIP 33 — управление подкреплением как золотой стандарт.
- NIDA — специфической фармакотерапии кокаиновой зависимости нет.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при управлении подкреплением.
- Коморбидное употребление ПАВ и психиатрическое расстройство — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Кокаин — „рекреационное“ вещество, не вызывающее зависимости»

Доказательства: кокаин обладает высоким потенциалом зависимости; сердечно-сосудистая смертность, психоз, социальная дезадаптация.

Миф 2: «Для кокаина существует одобренное FDA лечение»

Доказательства: пока нет; психосоциальное вмешательство — первая линия.

Миф 3: «„Крэш“ кокаина безопасен, лечения не требует»

Доказательства: В период отмены высокий риск суицида; требуется активное наблюдение.

Миф 4: «Крэк и кокаиновый порошок — разные расстройства»

Доказательства: одно и то же вещество (кокаин); путь введения (курение vs интраназальный) изменяет фармакокинетику и скорость развития зависимости.

Миф 5: «Концепция „crack baby“ при беременности — стойкий вред у детей»

Доказательства: последние обзоры — долгосрочные эффекты пренатальной экспозиции кокаина меньше, чем считалось ранее; социально-экономические факторы оказывают более сильное влияние (Frank D.A. JAMA 2001, обзор).

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C45 Disorders due to use of cocaine. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 33: Treatment for Stimulant Use Disorders. 2021 update.
4. NIDA. Research Report: Cocaine. 2016.
5. Petry N.M., Alessi S.M., Olmstead T.A. Contingency management treatment for substance use disorders. Psychol Addict Behav 2017;31(8):897–906.
6. Frank D.A. et al. Growth, development, and behavior in early childhood following prenatal cocaine exposure. JAMA 2001;285(12):1613–1625.
7. Higgins S.T., Budney A.J., Bickel W.K. et al. Incentives improve outcome in outpatient behavioral treatment of cocaine dependence. Arch Gen Psychiatry 1994;51(7):568–576.

МКБ-11 **6C46**	**6C46 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ АМФЕТАМИНЫ, МЕТАМФЕТАМИН ИЛИ МЕТКАТИНОН** **Disorders due to use of stimulants including amphetamines, methamphetamine or methcathinone**
МКБ-10 F15	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
DSM-5-TR F15.20	Расстройство употребления стимуляторов (амфетаминового типа), умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления стимуляторов (МКБ-11: 6C46; DSM-5-TR: F15.20 Расстройство употребления стимуляторов) — расстройства, развивающиеся вследствие употребления амфетамина, метамфетамина, меткатинона и других стимуляторов. Отдельно кодируются: кокаин (6C45), синтетические катиноны, включая мефедрон (6C47), кофеин (6C48), MDMA и родственные вещества, включая MDA (6C4C).

2. История

- Амфетамин впервые синтезирован Edeleano L. в 1887 году; широкое применение во Второй мировой войне.
- 1950–1960-е годы — эпидемия аптечных рецептов.
- Эпидемия метамфетамина с 1990-х годов.

- Эпидемия 2010+ годов: «соли для ванн» (синтетические катиноны). «Крокодил» (дезоморфин) — опиоид, в МКБ-11 кодируется отдельно (6C43).

3. Эпидемиология

- В мире потребители: амфетамин 30 млн+ (UNODC).
- Пол: выше у мужчин.
- Коморбидность: психоз, БДР, тревога, сердечно-сосудистая патология, повреждения кожи (самоповреждения, «метамфетаминовый рот»).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–50%.
- Нейробиологически — высвобождение дофамина и норадреналина и блокада обратного захвата; тяжёлая нейротоксичность (особенно метамфетамин — к дофаминовым нейронам).

5. Клиническая картина

- Интоксикация — эйфория, гипервигильность, мидриаз, тахикардия, гипертензия, гипертермия; в тяжёлых случаях — параноидный психоз, ажитация, инфаркт миокарда, инсульт, судороги, рабдомиолиз.
- Отмена — «crash» — депрессивное настроение, ангедония, утомляемость, гиперсомния, повышение аппетита, интенсивное влечение; высокий риск суицида.
- Хроническое употребление — психоз (параноидный бред, галлюцинации), когнитивный дефицит, «meth mouth» (кариес), расчёсы кожи.
- MDMA (6C4C) — гипонатриемия, гипертермия, серотониновый синдром, нейротоксичность.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR 11 критериев (структура AUD). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при

непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- SAMHSA TIP 33 — употребление стимуляторов.
- NIDA — отчёты об исследованиях метамфетамина.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Токсикологический скрининг.
3. ЭКГ, тропонин.
4. Коморбидность (психоз, БДР, сердечно-сосудистая патология).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Кокаин (6C45)	Токсикологический скрининг.
Маниакальный эпизод	Временная связь с веществом
Шизофрения	Отсутствие ремиссии после элиминации вещества.
Гипертиреоз, феохромоцитома	Эндокринное обследование.

7. Обследование и оценка

- Токсикологический скрининг.
- ЭКГ, тропонин, КФК (рабдомиолиз).
- Осмотр зубов и кожи.
- C-SSRS.

8. Лечение

1. Психосоциальное — первая линия:
    - Управление подкреплением;
    - КПТ;
    - МИ (мотивационное интервьюирование);
    - Matrix Model — мануализированная комплексная программа для амфетаминовой зависимости.

2. Фармакотерапия — специфического одобренного FDA препарата нет; off-label: миртазапин, налтрексон + бупропион (Trivedi M.H. NEJM 2021 — исследование ADAPT-2 комбинация для метамфетамина — умеренный эффект).
3. Острая интоксикация — бензодиазепин для ажитации; антипсихотик при психозе.
4. Коморбидный психоз — параллельное лечение.

8.1 Методики лечения

1. Матричная модель (англ. Matrix Model) — 16-недельная структурированная программа — КПТ + семья + 12 шагов + один врач. Доказательная база для амфетамина/метамфетамина.
2. Управление подкреплением (англ. Contingency Management) — Вознаграждение за отрицательный тест.
3. Налтрексон + бупропион (ADAPT-2) — Первичные РКИ-доказательства при метамфетаминовой зависимости; off-label.

8.2 Различия между источниками

- SAMHSA TIP 33.
- NIDA.
- Trivedi M.H. et al. NEJM 2021 — налтрексон + бупропион: первичная доказательная база при метамфетаминовой зависимости.

9. Прогноз

- При мультимодальном подходе ремиссия 30–50%.
- Коморбидный психоз — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Метамфетамин безопаснее „Спайса“ или других „дизайнерских наркотиков“»

Доказательства: метамфетамин вызывает высокую нейротоксичность, психоз, смертность.

Миф 2: «MDMA как „чистое“ вещество безопасен»

Доказательства: Для MDMA: гипертермия, гипонатриемия, серотониновый синдром; «чистое» вещество типично является смесью (синтетические катиноны, фентанил).

Миф 3: «Детоксикация достаточна для зависимости от стимуляторов»

Доказательства: основа — управление подкреплением и КПТ; одна только детоксикация даёт 90%+ рецидивов.

Миф 4: «Антидепрессанты излечивают зависимость от стимуляторов»

Доказательства: один антидепрессант неэффективен; ADAPT-2 предоставляет предварительные доказательства в пользу комбинации.

Миф 5: «Потребители стимуляторов „продуктивны“, не требуют вмешательства»

Доказательства: иллюзия краткосрочного повышения производительности; долгосрочные когнитивные, психиатрические, сердечные осложнения.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C46 Disorders due to use of stimulants. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 33. 2021.
4. NIDA. Methamphetamine Research Report. 2019.
5. Trivedi M.H. et al. Bupropion and Naltrexone in Methamphetamine Use Disorder. NEJM 2021;384(2):140–153.
6. Rawson R.A. et al. Matrix Model. SAMHSA.

МКБ-11 **6C49**	**6C49 РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ** **Disorders due to use of hallucinogens**
МКБ-10 F16	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов
DSM-5-TR F16.20	Расстройство употребления других галлюциногенов, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления галлюциногенов (МКБ-11: 6C49; DSM-5-TR: F16.20 Расстройство употребления галлюциногенов) — расстройства, связанные с употреблением ЛСД, псилоцибина, мескалина, ДМТ, аяуаски и подобных веществ. Диссоциативные вещества — кетамин и фенциклидин (PCP) — в МКБ-11 кодируются отдельно (6C4D).

2. История

- Hofmann A. (1943) — случайное открытие галлюциногенного действия ЛСД.
- 1950–1960-е годы — клинические исследования (депрессия, шизофрения).
- 1970 — Controlled Substances Act в США, Список I.
- 2020+ — ренессанс исследований псилоцибина и кетамина в «психоделической терапии».

3. Эпидемиология

- Зависимость относительно редка (в отличие от других веществ); типичное употребление эпизодическое.
- Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD) — флешбэк-подобные переживания.

4. Этиология и патогенез

- Воздействие на серотонинергические (5-HT2A) или NMDA (кетамин, PCP) рецепторы.
- Среда, сверстники, экспериментирование.

5. Клиническая картина

- Интоксикация — зрительные галлюцинации, синестезия, нарушение времени, деперсонализация, дереализация, «бэд-трип» (паника, паранойя).
- При тяжёлом течении — психоз, смертельные несчастные случаи.
- «Persisting Perception Disorder» (HPPD) — сохраняющиеся после употребления визуальные феномены (флешбэки).
- Кетамин — диссоциация, «K-hole»; хроническое употребление — синдром мочевого пузыря.

- PCP — агрессивное поведение, аналгезия, дезорганизованное поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — 11 критериев; HPPD — отдельный диагноз (DSM-5). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- NIDA, SAMHSA.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Токсикологическое исследование (ЛСД не входит в стандартные панели).
3. Коморбидный психоз, тревога, БДР.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Шизофрения	Стойкие симптомы.
Расстройство деперсонализации-дереализации (6B66)	Проверка реальности сохранена.
Приступ	ЭЭГ.

7. Обследование и оценка

- Токсикологический скрининг.
- Шкалы для оценки коморбидности.

8. Лечение

1. Острая интоксикация («bad trip») — спокойная обстановка, бензодиазепин (лоразепам); антипсихотик (галоперидол) только при тяжёлом психотическом состоянии; с осторожностью.
2. Зависимость редка; психосоциальное вмешательство (MI, КПТ).
3. HPPD — антипсихотики обычно неэффективны; клоназепам помогает некоторым пациентам; долгосрочное наблюдение.
4. Терапевтические исследования псилоцибина и кетамина (рефрактерная БДР, ПТСР) — используется под контролем в исследовательских протоколах; в стандартной клинической практике утверждённые протоколы пока ограничены (исключение — эскетамин FDA Spravato).

8.1 Методики лечения

1. Управление «Bad trip» (тяжёлым переживанием) — Спокойная обстановка, reassurance, бензодиазепин при необходимости.
2. Клоназепам при HPPD — Off-label; доказательная база мала.
3. Психоделически ассистированная терапия (Psychedelic-assisted therapy — на стадии исследования) — Псилоцибин + психотерапия, кетамин + психотерапия; в протоколах клинических исследований.

8.2 Различия между источниками

- NIDA — ренессанс исследований психоделиков; клинические рекомендации пока не требуют их применения.

9. Прогноз

- У большинства пользователей зависимость не развивается.
- Хроническое течение у пациентов с тяжёлыми психотическими или HPPD-осложнениями.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Галлюциногены не вызывают зависимости и абсолютно безопасны»

Доказательства: физическая зависимость редка, но возможны психологическая зависимость и тяжёлые психотические эпизоды; HPPD — долгосрочное осложнение.

Миф 2: «Псилоцибиновая терапия одобрена для всех депрессий»

Доказательства: все ещё на стадии исследования; полностью не утверждено для стандартной клинической практики. Имеет статус «Прорывной терапии» FDA, но широкие рекомендации пока преждевременны.

Миф 3: «Аяуаска безопасна для религиозных ритуалов»

Доказательства: отмечены случаи серотонинового синдрома (взаимодействие с СИОЗС), психотической декомпенсации.

Миф 4: «Кетамин — это „клубный наркотик“, медицинского применения нет»

Доказательства: кетамин десятилетиями используется как анестетик; интраназальный эскетамин (Spravato) одобрен FDA в 2019 году для тяжёлой рефрактерной депрессии.

Миф 5: «ЛСД-флешбэк — это миф»

Доказательства: HPPD — официальный диагноз DSM-5; у некоторых пациентов стойкие зрительные нарушения.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C49 Disorders due to use of hallucinogens. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NIDA. Hallucinogens DrugFacts. 2019.
4. Halpern J.H., Lerner A.G., Passie T. A review of Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Curr Top Behav Neurosci 2018;36:333–360.
5. Carhart-Harris R.L. et al. Trial of psilocybin versus escitalopram for depression. NEJM 2021;384(15):1402–1411.

МКБ-11 **6C4A**	**6C4A РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА** **Disorders due to use of nicotine**
МКБ-10 F17	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака
DSM-5-TR F17.200	Расстройство употребления табака, умеренное или тяжёлое

1. Определение и нозология

Расстройства вследствие употребления никотина (МКБ-11: 6C4A; DSM-5-TR: F17.200 Расстройство употребления табака) — нарушенный контроль над употреблением сигарет, табачных изделий, электронных сигарет или других никотиновых веществ. Ведущая предотвратимая причина смертности в мире.

2. История

- 1964 — Доклад главного хирурга (США) — признание табака причиной заболеваний.
- DSM-IV — Никотиновая зависимость; DSM-5 — Расстройство употребления табака.
- 2003 — ВОЗ РКБТ (Рамочная конвенция по борьбе против табака).
- 2010+ — эпидемия электронных сигарет, «EVALI» (повреждение лёгких, связанное с использованием электронных сигарет/вейпинга).

3. Эпидемиология

- В мире: 1,3 млрд потребителей; ежегодно 8 млн+ смертей (ВОЗ).
- Пол: выше у мужчин (но наблюдается снижение); у женщин отмечается рост в некоторых регионах.
- Коморбидность: БДР, шизофрения (~60–80% пациентов курят), тревога, другое употребление ПАВ.

- Табак — рак, ХОБЛ, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, перинатальные осложнения.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50%.
- Нейробиологически — связывание никотина с α4β2 никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами; усиление дофаминового вознаграждения.
- Социокультурное, сверстники, маркетинг.

5. Клиническая картина

- Синдром зависимости.
- Отмена — раздражительность, тревога, трудности концентрации, нарушение аппетита, сна, депрессивное настроение; начало в течение 24 часов, пик на 2–3 день, длится 2–4 недели.
- Электронные сигареты — никотиновая зависимость + риск EVALI.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR 11 критериев (структура AUD). МКБ-11, в отличие от единой шкалы DSM-5-TR, использует три отдельные категории: эпизод употребления с вредными последствиями, вредный паттерн употребления и зависимость. Требование МКБ-11 по длительности: вредный паттерн употребления — не менее 12 месяцев при эпизодическом употреблении и не менее 1 месяца при непрерывном; зависимость — не менее 12 месяцев либо не менее 3 месяцев при непрерывном (ежедневном или почти ежедневном) употреблении.

6.2 Различия между источниками

- USPSTF — скрининг употребления табака у всех взрослых пациентов; подход 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) для курящих.
- NICE NG209 («Табак: профилактика начала употребления, содействие отказу и лечение зависимости», 2021).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (5A).
2. Тест Фагерстрёма на никотиновую зависимость (FTND).

3. Мониторинг CO в выдыхаемом воздухе (мотивация).
4. Коморбидная кардиальная и респираторная оценка.

6.4 Дифференциальная диагностика

Дифференциация между множественными табачными изделиями; никотиновая зависимость от электронных сигарет может проявляться в различных формах.

7. Обследование и оценка

- FTND.
- CO в выдыхаемом воздухе.
- Спирометрия (скрининг ХОБЛ).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (USPSTF · NICE NG209 · APA 2010)

1. Модель 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange).
2. Фармакотерапия первой линии:
    - NRT — никотинзаместительная терапия (пластыри, жевательные резинки, леденцы, ингалятор, спрей) — комбинация (длительного + короткого действия) превосходит монотерапию.
    - Варениклин (Chantix) — α4β2 частичный агонист; наиболее эффективный отдельный препарат (Cahill K. Cochrane 2016 мета-анализ).
    - Бупропион SR (Zyban) — дофаминергическое и норадренергическое действие.
3. Поведенческое вмешательство — КПТ, MI, телефонная «quitline» служба; интенсивность увеличивает эффект.
4. Комбинация — фармакотерапия + поведенческая терапия предпочтительнее.
5. Электронные сигареты как средство отказа от табака спорны — в некоторых исследованиях эффективны (Hajek P. NEJM 2019), но долгосрочная безопасность и риск «входных ворот» изучаются; предпочтение отдаётся NRT.
6. Коморбидность (БДР, шизофрения) — отказ от табака не ухудшает психическое состояние, а улучшает его (Taylor G. BMJ 2014 мета-анализ).

8.2 Методики лечения

1. Модель 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) — Ask (спроси), Advise (посоветуй), Assess (оцени), Assist (помоги), Arrange (организуй наблюдение).
2. Комбинация никотинзаместительной терапии (англ. Nicotine Replacement Therapy, NRT) — Пластырь длительного действия + короткого действия (жевательная таблетка, леденец) для «спасения» (rescue).
3. Варениклин — 1 мг × 2/день; 12 недель стандартно.
4. Бупропион SR — 150 мг × 2/день; риск судорог.
5. КПТ и мотивационное интервью (МИ) — Управление триггерами, повышение мотивации.
6. Телефонная линия поддержки (Quitline) — Поддержка на уровне сообщества; широкая доказательная база.

8.3 Различия между источниками

- USPSTF 2021 — рекомендуется вмешательство для всех курящих.
- NICE NG209 — активное вмешательство также при коморбидных психиатрических расстройствах.
- Cahill K. et al. Cochrane 2013 — варениклин наиболее эффективен.

9. Прогноз

- При мультимодальном вмешательстве 6-месячная абстиненция 25–35%.
- Отказ от курения значительно снижает риск смертности и заболеваемости.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Табак не вызывает зависимости, его можно бросить усилием воли»

Доказательства: никотин обладает высоким потенциалом зависимости; частота неудач при самостоятельном отказе высока (~5% через три месяца); фармакотерапия увеличивает эффект в 2–3 раза.

Миф 2: «Увеличение веса при отказе от курения вредно для здоровья»

Доказательства: средняя прибавка веса 4–5 кг, но риск продолжения курения значительно выше; вес можно контролировать.

Миф 3: «Варениклин создаёт риск суицида»

Доказательства: первое предупреждение FDA впоследствии пересмотрено в исследовании EAGLES (Anthenelli R.M. Lancet 2016) — частота психиатрических побочных эффектов достоверно не выше плацебо; предупреждение FDA «boxed warning» снято в 2016 году.

Миф 4: «Психиатрический пациент не может отказаться от табака и не должен этого делать»

Доказательства: Taylor BMJ 2014 — отказ от табака улучшает психиатрические симптомы; отказ эффективен у пациентов с шизофренией, БДР.

Миф 5: «Электронные сигареты безопаснее табака»

Доказательства: по имеющимся данным, электронные сигареты менее вредны, чем сжигаемый табак, но не «безопасны»; риски EVALI, сердечно-сосудистые, респираторные; ворота к никотиновой зависимости у подростков.

Миф 6: «Однократное „прерывание и возврат“ — запрет»

Доказательства: Большинство курильщиков предпринимают 6–11 попыток бросить; рекомендуется план при каждом рецидиве, временном и продолжающемся.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C4A Disorders due to use of nicotine. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. USPSTF. Interventions for tobacco smoking cessation in adults. JAMA 2021;325(3):265–279.
4. NICE NG209. Tobacco. 2021.
5. Cahill K., Stevens S., Perera R., Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD009329.
6. Anthenelli R.M. et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES). Lancet 2016;387(10037):2507–2520.
7. Taylor G. et al. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151.
8. Hajek P. et al. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. NEJM 2019;380(7):629–637.

МКБ-11 **6C50**	**6C50 РАССТРОЙСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСТРАСТИЯ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ** **Gambling disorder**
МКБ-10 F63.0	Патологическое влечение к азартным играм
DSM-5-TR F63.0	Расстройство, связанное с азартными играми

1. Определение и нозология

Расстройство вследствие пристрастия к азартным играм (МКБ-11: 6C50; МКБ-10: F63.0; DSM-5-TR: F63.0) — устойчивый или повторяющийся паттерн игорного поведения с нарушением контроля, приоритетом игры над другими интересами и продолжением вопреки негативным последствиям. Приводит к значимому функциональному нарушению. Расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм выделено в МКБ-11 в отдельную категорию — 6C51.

2. История

- DSM-IV (1994) — «Pathological Gambling» в рамках расстройств контроля импульсов.
- DSM-5 (2013) — «Gambling Disorder» перенесено в категорию расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и зависимостей (сходная нейробиология).
- МКБ-11 (2019) — раздел поведенческих зависимостей расширен: наряду с азартными играми (6C50) отдельной категорией добавлены компьютерные игры (6C51).

3. Эпидемиология

- Gambling Disorder, распространённость в течение жизни: 0,2–5,3% (широкий диапазон).
- Пол: гемблинг чаще у мужчин; при онлайн-гемблинге половые различия уменьшаются.

- Коморбидность: БДР (MDD), тревожные расстройства, употребление других психоактивных веществ, СДВГ (ADHD), ПРЛ (BPD), суицидальный риск.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50–60%.
- Нейробиология — дизрегуляция системы вознаграждения (дофамин), сходная с расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.
- Личность — импульсивность, поиск ощущений (sensation-seeking).

5. Клиническая картина

- Устойчивое/повторяющееся игорное поведение.
- Потеря контроля.
- Нарушения в профессиональной, семейной, социальной и академической сферах.
- «Chasing losses» (при гемблинге) — попытки отыграть проигранное.
- Ложь, финансовые проблемы, скрытность.
- Высокий риск коморбидного БДР (MDD) и суицида.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

Gambling (DSM-5-TR): ≥ 4 из 9 симптомов в течение 12 месяцев:

1. Игра на возрастающие суммы — толерантность;
2. Раздражительность или беспокойство при попытке сократить игру — синдром отмены;
3. Безуспешные попытки сократить игру;
4. Поглощённость мыслями об игре;
5. Игра в состоянии дистресса;
6. «Chasing» после проигрыша;
7. Ложь;
8. Потеря отношений/работы;
9. Зависимость от финансовой помощи (bailout).

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 (6C50) — подтипы: 6C50.0 преимущественно офлайн, 6C50.1 преимущественно онлайн, 6C50.Z неуточнённое. Для диагноза обычно требуется ≥ 12 месяцев; срок может быть сокращён, если выполнены все диагностические требования и симптомы тяжёлые.
- DSM-5-TR — «Gambling Disorder» (F63.0) — единственная поведенческая зависимость в основном тексте; DSM-5 (2013) перенёс её из расстройств контроля импульсов в категорию расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и аддикций. В отличие от 6C51, требования 6C50 допускают наряду с функциональным нарушением и значимый дистресс.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. SOGS (англ. South Oaks Gambling Screen) или PGSI (англ. Problem Gambling Severity Index).
3. Коморбидность: психоактивные вещества, БДР (MDD), суицидальный риск.
4. Оценка финансового положения.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Маниакальный эпизод (расторможенность в азартных играх)	Аффективные симптомы.
ОКР (компульсивные проверки)	Ведущими являются обсессии.
ПРЛ (BPD) (импульсивность)	Устойчивый паттерн во всех сферах.
Социальная игра на деньги (не является проблемой)	Функциональное нарушение отсутствует.

7. Обследование и оценка

- Шкалы для оценки коморбидности.
- C-SSRS — суицидальный риск.

8. Лечение

1. КПТ — первая линия; управление триггерами, поведенческая активация, когнитивное реструктурирование («near miss» и «gambler’s

fallacy»). Cowlishaw S. Cochrane 2012, мета-анализ.

2. Налтрексон, налмефен — доказательная база формируется (обзоры Grant J.E.).
3. СИОЗС — при коморбидном БДР (MDD)/тревожности.
4. Группы самопомощи (Gamblers Anonymous, Gam-Anon) — в качестве адъюванта.
5. Финансовое консультирование — критически важно при гемблинге.

8.1 Методики лечения

1. КПТ при гемблинге — Коррекция когнитивных искажений, экспозиция (снижение реакции на триггеры), решение проблем.
2. Налтрексон off-label — Снижение влечения (крейвинга); 50–150 мг/сут.
3. Группы самопомощи (GA) — 12-шаговая модель.

9. Прогноз

- Ремиссия при КПТ 30–50%.
- Коморбидное БДР (MDD) — неблагоприятный прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Игровая зависимость — это расстройство „характера“»

Доказательства: DSM-5, МКБ-11 — это медицинское/поведенческое расстройство; нейробиологическая и генетическая предрасположенность.

Миф 2: «Пациент выйдет из долгов благодаря „крупному выигрышу“»

Доказательства: «chasing losses» — диагностический признак игровой зависимости; паттерн проигрыша статистически неизбежен.

Миф 3: «Достаточно только финансовой поддержки»

Доказательства: зависимость от финансовой помощи (bailout) — диагностический признак; требуется психосоциальное вмешательство.

Миф 4: «Пациент „перерастёт“ это с возрастом»

Доказательства: требуется активное вмешательство; возможна хронизация.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C50 Gambling disorder. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Cowlishaw S. et al. Psychological therapies for pathological and problem gambling. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD008937.
4. Grant J.E. et al. Pharmacotherapy for gambling disorder. Curr Top Behav Neurosci 2016;26:135–149.

МКБ-11 **6C51**	**6C51 РАССТРОЙСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСТРАСТИЯ К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ** **Gaming disorder**
МКБ-10 —	Эквивалента в МКБ-10 нет
DSM-5-TR —	Расстройство интернет-игр (раздел III — состояние для дальнейшего изучения)

1. Определение и нозология

Расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм (патологический гейминг; код МКБ-11 6C51) определяется Всемирной организацией здравоохранения как паттерн устойчивого или повторяющегося игрового поведения — цифровых или видеоигр, онлайн либо офлайн, — проявляющийся тремя основными признаками:

- нарушение контроля над игрой (начало, частота, интенсивность, длительность, прекращение, контекст);
- возрастающий приоритет игры вплоть до того, что игра начинает преобладать над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;
- продолжение или эскалация игры, несмотря на возникновение негативных последствий.

Паттерн поведения должен быть достаточной степени тяжести, чтобы приводить к значимому нарушению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных важных сферах функционирования. Обратите внимание: МКБ-11 не содержит критерия

дистресса для 6C51. Функциональное нарушение является обязательным элементом, и добавление «выраженного дистресса» как альтернативного пути к постановке диагноза устранило бы именно тот признак, который задаёт этой категории порог. Паттерн обычно очевиден на протяжении периода не менее 12 месяцев, хотя требуемая длительность может быть сокращена, если соблюдены все диагностические требования и симптомы выражены тяжело.

Нозологическое положение

6C51 относится к группировке МКБ-11 «Расстройства вследствие аддиктивного поведения» (6C50–6C5Z) наряду с 6C50 «Расстройство вследствие пристрастия к азартным играм (патологический гэмблинг)». Это единственные две поведенческие зависимости, имеющие собственные категории в МКБ-11; для других претендующих состояний существуют остаточные коды 6C5Y (другое уточнённое) и 6C5Z (неуточнённое). МКБ-11 была единогласно принята 72-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 25 мая 2019 года и вступила в силу 1 января 2022 года.

Подтипы и исключения

- 6C51.0 — расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм, преимущественно онлайн.
- 6C51.1 — расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм, преимущественно офлайн.
- 6C51.Z — расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм, неуточнённое.

В перечень исключений для 6C51 входят опасный гейминг (QE22), биполярное расстройство I типа (6A60) и биполярное расстройство II типа (6A61). Избыточная игра, возникающая исключительно в рамках маниакального или гипоманиакального эпизода, поэтому не кодируется как 6C51.

Подпороговая категория QE22

QE22 «Опасный гейминг» в разделе МКБ-11, посвящённом факторам, влияющим на состояние здоровья, обозначает паттерн игры — онлайн или офлайн, — который заметно повышает риск вредных последствий для физического или психического здоровья самого человека либо окружающих его лиц, но не удовлетворяет диагностическим требованиям расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм. Эта категория существует именно для того, чтобы паттерн, заслуживающий профессионального внимания и консультирования, не приходилось оформлять как диагноз расстройства.

Американская психиатрическая ассоциация не признала гейминг формальным расстройством: интернет-игровое расстройство (IGD) остаётся в разделе III DSM-5-TR, «Состояния, требующие дальнейшего изучения», и оба набора критериев описаны и сопоставлены в разделе 6 настоящей главы.

2. История

Предыстория: интернет-зависимость (1990-е годы)

Концептуальным предшественником была «интернет-зависимость», предложенная в качестве клинической единицы Young, которая адаптировала критерии патологического гемблинга DSM-IV к использованию интернета (Young, 1998). На протяжении 1990-х и 2000-х годов гейминг изучался главным образом внутри этой более широкой рамки интернет-зависимости — смешение, впоследствии признанное крупным источником ошибки измерения и по сей день искажающее систематические обзоры по расстройству вследствие пристрастия к компьютерным играм (Kuss et al., 2017; Colder Carras et al., 2020).

2013 — DSM-5

APA поместила интернет-игровое расстройство в раздел III DSM-5 как состояние, требующее дальнейшего изучения, прямо отказавшись сделать его официальным диагнозом. Этот статус был перенесён без изменений в DSM-5-TR в 2022 году.

2014–2017 — консультации WHO

WHO провела серию совещаний экспертов по общественно-здравоохранительным последствиям избыточного использования интернета, компьютеров, смартфонов и подобных устройств, а также по поведенческим зависимостям. Итоговый документ рабочей группы, сформировавший текст МКБ-11, утверждал, что расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм обнаруживает основные признаки, требуемые от аддиктивного расстройства, и что диагностическая категория необходима для людей, уже обращающихся за лечением (Saunders et al., 2017).

2016–2018 — научная полемика

До завершения работы над МКБ-11 26 учёных опубликовали открытый дискуссионный документ против включения, предупреждая о низком качестве исследований, некритическом заимствовании критериев из области употребления психоактивных веществ и гемблинга, моральной панике и вреде для здоровых геймеров (Aarseth et al., 2017). Частично пересекающаяся группа

затем выступила с доводом, что бремя доказательств для перехода от исследовательского конструкта к формальному расстройству не было выполнено (van Rooij et al., 2018). Клиницисты и исследователи общественного здоровья ответили в том же журнале, защищая включение (Griffiths et al., 2017; Rumpf et al., 2018). Существо этого спора изложено в разделе 10.

2018–2019 — формальное включение

Проект МКБ-11, содержащий 6C51, был опубликован в июне 2018 года; классификация была принята 72-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 25 мая 2019 года и вступила в силу 1 января 2022 года. В 2024 году WHO опубликовала «Клинические описания и диагностические требования» (CDDR) к психическим, поведенческим расстройствам и расстройствам нейроразвития МКБ-11 — операциональное руководство, которым клиницисты теперь пользуются наряду со статьёй MMS.

Политический контекст (неклинические источники)

Ниже приведены правительственные и пресс-сообщения, а не клинические доказательства, и качественной оценки их клинического эффекта выявлено не было.

- Южная Корея. Закон о «блокировке» (ночной комендантский час на игры для несовершеннолетних) был принят 19 мая 2011 года и вступил в силу 20 ноября 2011 года. Правительство объявило о его отмене 25 августа 2021 года; отмена была законодательно оформлена позднее в том же году, и комендантский час прекратил действие с 1 января 2022 года.
- Китай. Согласно уведомлению Государственного управления по делам печати и публикаций от 30 августа 2021 года, пользователи младше 18 лет могут играть в онлайн-игры только с 20:00 до 21:00 по пятницам, в выходные и официальные праздничные дни — примерно три часа в течение обычной недели.
- Англия и Уэльс. Национальный центр по расстройствам вследствие пристрастия к компьютерным играм NHS открылся в Лондоне в октябре 2019 года.

3. Эпидемиология

Объединённая распространённость

Два крупных метаанализа сходятся на глобальном показателе около 3 процентов, который существенно снижается, как только принимается во внимание методологическое качество.

Источник	Основа	Оценка
Stevens et al., 2021	Общемировая объединённая	3,05% (95% ДИ 2,38–3,91)
Stevens et al., 2021	Исследования, отвечающие строгим критериям формирования выборки	1,96% (95% ДИ 0,19–17,12)
Kim et al., 2022	61 исследование, 227 665 участников, 29 стран	3,3% (95% ДИ 2,6–4,0)
Kim et al., 2022	28 исследований с репрезентативными выборками	2,4% (95% ДИ 1,7–3,2)
Kim et al., 2022	После коррекции методом trim-and-fill на публикационное смещение	1,4% (95% ДИ 0,9–1,9)
Przybylski et al., 2017	Четыре опроса, N = 18 932, критерии DSM-5	0,3–1,0%

Доверительный интервал 0,19–17,12 процента у Stevens необходимо всегда указывать вместе с точечной оценкой. Цитирование одного лишь показателя 1,96 процента в абзаце, где каждая другая цифра снабжена интервалом, создаёт ложное впечатление точности — подгруппа со строгим формированием выборки мала, и оценка соответственно нестабильна.

Самые низкие оценки получены Przybylski, Weinstein и Murayama, применившими критерии DSM-5 в четырёх крупных международных когортах (выборки, описанные во вторичных источниках как набранные в Соединённых Штатах, Соединённом Королевстве, Канаде и Германии). Более чем двое из каждых трёх играющих людей не сообщили ни об одном симптоме IGD, а

авторы обнаружили, что связи IGD с физическими, социальными и психическими исходами носят смешанный характер.

Распределение по полу

Преобладание мужского пола — наиболее устойчивая эпидемиологическая находка: 8,5 процента у мужчин против 3,5 процента у женщин (Kim et al., 2022). Обзоры сообщают со ссылкой на метаанализ Su с коллегами, что мужчины чаще женщин демонстрируют расстройство гейминга, тогда как женщины чаще демонстрируют проблемное использование социальных сетей (Musetti et al., 2025).

Возраст

Распространённость наиболее высока у подростков и молодых взрослых; в работе Kim et al. (2022) средний возраст выборки был отрицательно связан с сообщаемой распространённостью — как и объём выборки и качество исследования. В сингапурском панельном исследовании Gentile et al. (2011), в котором 3034 ребёнка из 3, 4, 7 и 8 классов наблюдались в течение двух лет, от 7,6 до 9,9 процента были бы отнесены к патологическим геймерам в любой отдельно взятый момент времени (в резюме обобщено как около 9 процентов).

Два педиатрических обобщения часто цитируются вместе, чего делать не следует: Gentile et al. (2017) сообщают о диапазоне примерно от 1 до 9 процентов в зависимости от возраста, страны и характеристик выборки, тогда как Paulus et al. (2018) сообщают около 2 процентов в репрезентативных выборках детей и подростков и среднюю распространённость 5,5 процента при объединении всех выборок, включая клинические.

Источники гетерогенности

Сообщаемая распространённость различается между исследованиями на порядок величины, и главная причина этого методологическая, а не географическая. В работе Stevens et al. (2021) выбор скринингового инструмента объяснял 77 процентов дисперсии, а подростковые выборки, более низкие пороговые баллы и меньший объём выборки были значимыми предикторами более высокой распространённости. Kim et al. (2022) перечисляют регион среди модераторов, влияющих на гетерогенность; Stevens et al. рассматривали регион исследования как возможный модератор, но не указали его в числе значимых предикторов. Следовательно, региональное различие нельзя утверждать, опираясь на оба метаанализа, и регион остаётся смешанным с инструментом, типом выборки и качеством исследования.

Пробел в региональных данных

В ходе этого поиска не выявлено ни одного рецензируемого исследования распространённости расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм, проведённого в Азербайджане, и не найдено ни одной оценки распространённости для Южного Кавказа на основе МКБ-11. Любой местный показатель должен подаваться как экстраполяция, но никогда — как измеренные данные.

4. Этиология и патогенез

Ни один единый причинный механизм не установлен. В доказательной базе преобладают поперечные исследования; наиболее надёжные из имеющихся данных получены из продольных когорт и из метаанализов факторов риска.

Генетика

Прямых оценок наследуемости расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм по МКБ-11 не существует. Ближайшее по смыслу свидетельство — исследование Нидерландского регистра близнецов с участием 5247 монозиготных и дизиготных близнецов-подростков, в котором 48 процентов индивидуальных различий в компульсивном использовании интернета объяснялись генетическими факторами, с идентичными оценками у мальчиков и девочек, а остальные 52 процента приписывались неразделяемой среде (Vink et al., 2016).

Эту цифру нельзя переносить на расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм. Использованный инструмент, Compulsive Internet Use Scale, представляет собой измерение компульсивного использования интернета из 14 пунктов как единого общего конструкта — утрата контроля, поглощённость, отмена, совладание или изменение настроения, конфликт — и не содержит ни одного пункта, специфичного для гейминга. Время, проведённое за играми, измерялось в том исследовании отдельно и не было тем фенотипом, для которого была получена оценка в 48 процентов.

Теоретическая модель

Наиболее широко используемой интегративной рамкой является модель I-PACE (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution), согласно которой аддиктивное поведение возникает из взаимодействия предрасполагающих личностных переменных, аффективных и когнитивных реакций на внутренние и внешние сигналы, а также исполнительного и тормозного контроля, причём подкрепление со временем смещает поведение от мотивированного

удовольствием к мотивированному компенсацией и привычке (Brand et al., 2016; Brand et al., 2019). Модель теоретически влиятельна, но не валидизирована как диагностический или прогностический инструмент, и ни одно клиническое решение не должно на ней основываться.

Нейробиология

Метаанализ всего мозга по 40 функциональным нейровизуализационным исследованиям с использованием seed-based d mapping показал, что нейральные изменения при интернет-игровом расстройстве зависят от задачи (Zheng et al., 2019):

Парадигма	**Гиперактивация**	**Гипоактивация**
Реактивность на сигналы	Билатеральное предклинье, билатеральная поясная извилина	Островок; **различий в стриатуме нет**
Исполнительный контроль	Правая верхняя височная извилина, билатеральное предклинье, билатеральная поясная извилина, островок	Левая нижняя лобная извилина
Принятие рискованных решений	Левый стриатум, правая нижняя лобная извилина, островок	Левая верхняя лобная извилина, левая нижняя лобная извилина, правая прецентральная извилина

Здесь важны два момента точности. Во-первых, объединённый нулевой результат в парадигмах реактивности на сигналы касается стриатума в целом; анализ всего мозга такого рода не даёт права на утверждение конкретно о вентральном стриатуме. Во-вторых, собственный вывод авторов состоит в том, что исследование подтверждает критическую роль контуров вознаграждения и исполнительного контроля при IGD, но не при всех условиях, — это не опровержение вовлечённости системы вознаграждения. Главное, что клиницист должен отсюда вынести, сформулировано твёрже: лобные находки не являются единообразно «гипофронтальными» (правая нижняя лобная извилина была гиперактивна, тогда как левая — гипоактивна при принятии рискованных решений), находки получены в поперечных исследованиях, и ни

одна нейровизуализационная находка и ни один биомаркер не имеют диагностической ценности.

Факторы риска и защитные факторы — поперечное обобщение

Крупнейшее на сегодня обобщение объединило 1586 эффектов из 253 исследований и 210 557 участников, опубликованных до пандемии COVID-19. Эмпирически надёжных защитных факторов оказалось немного — самооценка, интеллект, удовлетворённость жизнью и образование, — и все они имели заметно меньшие размеры эффекта, чем факторы риска (Ropovik et al., 2023).

Факторы риска и защитные факторы — продольное обобщение

Метаанализ 39 продольных исследований с 37 042 участниками даёт наиболее пригодную для клинического использования структуру (Zhuang et al., 2023).

Область	**Факторы риска**	**Защитные факторы**
Внутриличностные	Время игры r = 0,33; одиночество r = 0,29; расстройство вследствие использования социальных сетей r = 0,24 (95% ДИ 0,03–0,43); агрессия r = 0,23; тревога r = 0,21	Самоконтроль r = −0,27; добросовестность r = −0,25; доброжелательность r = −0,20; самооценка r = −0,19
Межличностные	Связь с девиантными сверстниками r = 0,20; жестокое обращение в семье r = 0,15	Отношения со сверстниками r = −0,23; детско-родительские отношения r = −0,15; социальная поддержка r = −0,14
Средовые	—	Вовлечённость в школьную жизнь r = −0,18

Внутриличностные факторы обладали большей предсказательной силой, чем межличностные или средовые. Широкий доверительный интервал для расстройства вследствие использования социальных сетей следует отметить прежде, чем эта связь будет использована клинически.

Направление причинности

Сингапурское двухлетнее панельное исследование — один из немногих массивов данных, способных высказаться о временной последовательности. Больший объём игры, более низкая социальная компетентность и большая импульсивность, по-видимому, действовали как факторы риска становления патологическим геймером, тогда как депрессия, тревога, социальная фобия и более низкая школьная успеваемость, по-видимому, действовали как исходы патологического гейминга, а не как его причины (Gentile et al., 2011). Собственный осторожный глагол авторов — эти переменные «как будто действовали» в этих ролях — следует сохранять.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Систематический обзор и метаанализ обнаружили умеренную связь между тяжестью симптомов СДВГ и расстройством вследствие пристрастия к компьютерным играм: r = 0,296 для комбинированных симптомов СДВГ, r = 0,306 для невнимательности и r = 0,266 для гиперактивности (Koncz et al., 2023). Это самая устойчивая коморбидная связь в этой области и наиболее результативная мишень скрининга на практике.

Дизайн игр и монетизация

В опросе 7422 геймеров траты на лутбоксы были связаны с тяжестью проблемного гемблинга (η^2 = 0,054) — связь на порядок величины более сильная, чем для других внутриигровых покупок за реальные деньги (η^2 = 0,004), что указывает на специфичность азартно-подобного элемента (Zendle и Cairns, 2018). Дизайн исследования поперечный, и авторы прямо заявляют, что он не позволяет отличить лутбоксы, действующие как «входные ворота» к проблемному гемблингу, от лутбоксов, привлекающих в большей степени тех людей, у кого проблемный гемблинг уже есть.

Конкурирующее психологическое объяснение

Модель компенсаторного использования интернета концептуализирует избыточную игру как совладающую реакцию на неудовлетворённые психосоциальные потребности и неблагоприятные жизненные обстоятельства, а не как первичную зависимость (Kardefelt-Winther, 2014). Это объяснение напрямую конкурирует с аддиктивной моделью, остаётся неразрешённым и имеет практическое следствие: у пациента, чья игра нарастала в такт депрессивному эпизоду или социальному кризису, лечение гейминга в изоляции вряд ли окажется эффективным.

5. Клиническая картина

Основные проявления

Клиническая картина определяется тремя признаками МКБ-11, а не количеством наигранных часов.

Признак МКБ-11	Как он проявляется клинически
Нарушение контроля	Повторяющаяся неспособность остановиться в намеченное время; сессии длиннее запланированных; безуспешные попытки сократить игру; «ещё один матч», растягивающийся на всю ночь
Возрастающий приоритет	Игра вытесняет сон, приёмы пищи, гигиену, учёбу, работу, семейные обязанности и прежде ценимые увлечения
Продолжение вопреки негативным последствиям	Упорство после академической неуспеваемости, потери работы, семейного конфликта, финансовых потерь или документированного вреда здоровью

Сопутствующие признаки

Поглощённость мыслями об игре между сессиями, раздражительность, беспокойство или дисфория при невозможности играть, обман относительно объёма игры и использование игры для облегчения негативного настроения описаны в наборе критериев DSM-5-TR. МКБ-11 намеренно не требует толерантности или отмены, и статус феноменов, подобных отмене, при гейминге остаётся спорным. На практике эти признаки поддерживают диагноз, но не могут его нести.

Функциональные последствия

В клинических обращениях ведущие жалобы обычно предъявляет семья: падение школьной успеваемости, отказ от посещения школы или прогулы, инверсия цикла день — ночь, отдаление от офлайн-сверстников и конфликт, нарастающий вокруг попыток ограничить доступ. Требование

функционального нарушения — это то, что отделяет расстройство от интенсивного увлечения (Billieux et al., 2019).

Сон

Часто сообщается о ночной игре, отсроченном засыпании и укороченном сне. Консенсусная рекомендация Американской академии медицины сна составляет от 8 до 10 часов сна за 24 часа для подростков в возрасте от 13 до 18 лет (Paruthi et al., 2016). Данные, связывающие гейминг с нарушением сна, носят наблюдательный характер, но время сна — один из немногих функциональных показателей, который можно документировать объективно и отслеживать в ходе лечения.

Физическое здоровье

Сообщаемые физические корреляты включают костно-мышечную боль в спине, шее и плечах, травмы от повторяющегося перенапряжения кисти и большого пальца, зрительное напряжение с головной болью и головокружением, а также последствия сидячего образа жизни. Нарративный обзор отмечает, что четверо из каждых десяти киберспортсменов сообщают о боли и что игра более пяти часов в день увеличивала костно-мышечные симптомы среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет (Satish Kumar et al., 2023). Тот же обзор указывает, что исследований крайне мало, что данные разноречивы, что инструменты оценки не валидизированы и что продольных работ у подростков не проводилось. Это область со слабой доказательной базой, и её следует представлять именно так.

Коморбидность

СДВГ обнаруживает наиболее устойчивую связь ($r \approx 0{,}30$; Koncz et al., 2023). О депрессии и тревоге сообщается часто, однако обобщающая литература, лежащая в основе этого впечатления, не выдерживает критической оценки. Так, из семи систематических обзоров расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм с депрессией или тревогой, охватывающих в общей сложности 196 первичных исследований, признаки избирательного представления исходов были найдены во всех семи, лишь один оценивал риск систематической ошибки, а определения экспозиции были непоследовательными — часть включённых исследований использовала меры интернет-зависимости, а не расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм. Ни один не был отнесён к надёжным, и авторы заключили, что систематические обзоры, относящиеся к расстройству вследствие пристрастия к компьютерным играм, не соответствуют

методологическим стандартам (Colder Carras et al., 2020). Коморбидность поэтому следует описывать как часто наблюдаемую, но плохо количественно оценённую, а коморбидное аффективное или тревожное расстройство должно быть оценено и пролечено по собственным основаниям, а не считаться частью расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм.

Онлайн- и офлайн-подтипы

Преимущественно онлайн-форма (6C51.0) — более часто описываемая картина, связанная с многопользовательскими, персистентными и соревновательными играми. Преимущественно офлайн-форма (6C51.1) признана, но изучена гораздо меньше.

Что не входит в клиническую картину

Долгие часы игры у человека, чьи функционирование, сон, отношения и обязанности сохранны, не составляют расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм. Личностно-центрированное исследование, изложенное в недавнем обзоре, выявило подгруппу «увлечённых геймеров», игравших более четырёх часов в день и обнаруживших низкий уровень психологической дезадаптации (Musetti et al., 2025). Различение высокой вовлечённости и патологической вовлечённости существенно для валидности диагноза (Billieux et al., 2019).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

Должно присутствовать всё перечисленное ниже:

- нарушение контроля над игрой — начало, частота, интенсивность, длительность, прекращение и контекст;
- возрастающий приоритет игры, при котором игра начинает преобладать над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;
- продолжение или эскалация игры несмотря на возникновение негативных последствий;
- и паттерн приводит к значимому функциональному нарушению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных важных сферах функционирования.

Длительность: паттерн игрового поведения и прочие признаки обычно очевидны на протяжении периода не менее 12 месяцев, хотя требуемая

длительность может быть сокращена, если соблюдены все диагностические требования и симптомы выражены тяжело. Уточните подтип: 6C51.0 преимущественно онлайн, 6C51.1 преимущественно офлайн, 6C51.Z неуточнённое.

6.2 Насколько надёжен этот диагноз на практике?

Прямую проверку руководящих указаний МКБ-11 провело одно полевое исследование. В Шанхае и провинции Хэбэй 200 геймеров в возрасте от 15 до 18 лет (средний возраст 16,5 года, 85,6 процента мужского пола) были обследованы 21 парой оценщиков, сформированной из семи психиатров. Согласие между оценщиками составило κ = 0,545 (95% ДИ 0,490–0,600) для руководящих указаний МКБ-11 по расстройству вследствие пристрастия к компьютерным играм — умеренное, по собственной классификации авторов, восходящей к Landis и Koch, — и κ = 0,622 (95% ДИ 0,553–0,691) для IGD по DSM-5. Согласие между двумя системами, применёнными к одним и тем же пациентам, составило κ = 0,847 (95% ДИ 0,814–0,880). Клиницисты оценили клиническую применимость руководящих указаний как весьма или чрезвычайно хорошую в 86,0 процента из 400 наборов оценок (Ma et al., 2021).

Прямое сопоставление этих двух каппа-коэффициентов не является сравнением однородных величин и не должно подаваться как чистая демонстрация того, что МКБ-11 — менее надёжная система. Значение для МКБ-11 получено из трёхкатегориального суждения (расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм / опасный гейминг / ни то ни другое), значение для DSM-5 — из двухкатегориального суждения (IGD есть / нет). Трёхкатегориальная каппа структурно занижается расхождениями по промежуточной категории опасного гейминга, у которой нет аналога в DSM-5. К этим цифрам относятся ещё три ограничения: все 200 геймеров были отобраны в одном центре профессионально-технического образования; оценщиков было всего семеро; а конкурентный дизайн с совместной оценкой, применяемый в полевых исследованиях WHO, склонен давать более высокие значения каппы, чем независимое повторное интервью, так что 0,545 — скорее оптимистическая, чем пессимистическая оценка повседневной практики. Репликации нет.

То же исследование опровергает и одно распространённое допущение. При применении к тем же 400 наборам оценок критерии МКБ-11 дали несколько *больше* случаев (86), чем критерии DSM-5 (78), а согласие между системами было почти идеальным. Различия в сообщаемой распространённости между исследованиями поэтому нельзя объяснять просто тем, какому руководству

следует инструмент; сам инструмент, его пороговое значение и выборка значат гораздо больше (см. раздел 3).

6.3 Почему требование 12 месяцев не произвольно

Наличие случая расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм заметно нестабильно во времени. Метаанализ 50 продольных исследований обнаружил категориальную стабильность приблизительно от 43 до 45 процентов через год и от 34 до 38 процентов через два года (Sun et al., 2025), а одногодичное продольное исследование выявило существенное перемещение через диагностический порог в обоих направлениях (Hong et al., 2023). Значительная доля людей, пересекающих порог при однократной оценке, через год окажется ниже него безо всякого лечения. Требование 12 месяцев — это то, что не даёт превратить преходящий эпизод — экзаменационную сессию, потерю работы, тяжёлую утрату, летние каникулы с безлимитным подключением — в психиатрический диагноз. Допустимое сокращение применимо лишь тогда, когда каждое диагностическое требование уже соблюдено и симптомы выражены тяжело; это не лицензия на ранний диагноз по впечатлению.

6.4 Граница с нормой

Интенсивная игра, предпринимаемая ради развития навыка, соревнования или отдыха, при отсутствии нарушения контроля и функционального нарушения расстройством не является. В критериях нет временного порога; количество наигранных часов не является диагностическим признаком. WHO указывает в своих публичных материалах, что расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм затрагивает лишь малую долю людей, вовлечённых в цифровые или видеоигры. Это главная защита от ложноположительной диагностики (Billieux et al., 2019).

6.5 Диагностический алгоритм

- Шаг 1. Установить наличие игрового паттерна и охарактеризовать его: игры, платформа, онлайн или офлайн, структура сессий, экспозиция монетизации, включая лутбоксы.
- Шаг 2. Оценить каждый из трёх основных компонентов по отдельности, опираясь на конкретные поведенческие примеры, а не на самоописание ярлыком.
- Шаг 3. Документировать функциональное нарушение объективно — школьные или рабочие записи, сон, сообщения семьи, утрата прежних

занятий. При отсутствии функционального нарушения рассмотреть вместо этого QE22 «Опасный гейминг».

- Шаг 4. Установить 12-месячные временные рамки либо документировать тяжесть, достаточную для их сокращения.
- Шаг 5. Исключить маниакальный или гипоманиакальный эпизод (6A60, 6A61) как единственный контекст поведения.
- Шаг 6. Систематически проводить скрининг коморбидности: в первую очередь СДВГ, затем депрессивные расстройства, тревога и социальная тревога, употребление психоактивных веществ и расстройства сна.
- Шаг 7. Использовать валидизированный инструмент (GDT, ACSID-11, IGDT-10, IGDS9-SF) только как вспомогательный. Ни один инструмент сам по себе не является диагностическим.

6.6 Сопоставление МКБ-11 и DSM-5-TR

—	**МКБ-11 6C51 Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм**	**DSM-5-TR Интернет-игровое расстройство**
Статус	Формальный диагноз	Раздел III, «Состояния, требующие дальнейшего изучения»
Структура	Три обязательных компонента, все требуются	Девять предложенных критериев, требуется пять или более
Функциональное нарушение	Обязательное, отдельное требование	Содержится в вводной формулировке диагноза (клинически значимое нарушение или дистресс), а не является отдельным дополнительным критерием
Толерантность и отмена	Не включены	Включены в число девяти критериев

—	**МКБ-11 6C51 Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм**	**DSM-5-TR Интернет-игровое расстройство**
Временные рамки	Обычно не менее 12 месяцев; могут быть сокращены при тяжёлом течении	В пределах 12-месячного периода
Охват	Онлайн или офлайн; подтипы кодируются	Сформулировано вокруг онлайн-игр
Подпороговый код	QE22 Опасный гейминг	Отсутствует

Больший акцент, который МКБ-11 делает на функциональном нарушении, обычно трактуется как то, что задаёт ей более высокий диагностический порог (Musetti et al., 2025).

6.7 Диагностическая стабильность на протяжении одного года

В одногодичном продольном исследовании 279 участников — 120 пациентов с проблемным геймингом и 159 геймеров из общей популяции — у 34,7 процента участников произошло изменение диагноза IGD по DSM-5, тогда как число случаев расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм по МКБ-11 возросло до 60,4 процента (Hong et al., 2023). Эти две цифры представляют собой разные величины, и их нельзя противопоставлять друг другу так, будто они однородны: 34,7 процента — это частота изменения диагноза, тогда как 60,4 процента — уровень, до которого выросло число случаев расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм. Авторы прямо указывают, что значимой разницы между объёмами диагностических изменений IGD и GD за год не было, и их интерпретационный вывод осторожен: диагноз расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм *возможно*, более подвержен изменению, чем диагноз IGD. СДВГ имел наивысшее отношение шансов для обоих; точечная оценка, приводимая для расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм, имеет порядок 10^6 с соответственно крайне широким доверительным интервалом и не интерпретируема как размер эффекта, почти наверняка отражая квазиполное разделение в модели.

Клиническое следствие прямое: однократная поперечная оценка устанавливает диагноз на этот момент, а не прогноз, и повторная оценка является частью ведения пациента, а не необязательным дополнением.

6.8 Дифференциальный диагноз

Код	**Состояние**	**Отличительный признак**
QE22	Опасный гейминг	Игра, заметно повышающая риск вреда, но не удовлетворяющая требованиям 6C51 — обычно потому, что отсутствует нарушение контроля или значимое функциональное нарушение. Использовать этот код, когда паттерн заслуживает консультирования, но не диагноза расстройства.
6C50	Расстройство вследствие пристрастия к азартным играм	Центральное поведение — ставки денег или ценностей на исходы с неопределённым результатом. Граница размывается азартно-подобной внутриигровой монетизацией; оценивать оба вида поведения и кодировать оба там, где критерии соблюдены.

Код	**Состояние**	**Отличительный признак**
6A60 / 6A61	Биполярное расстройство I типа / II типа	Формальные исключения МКБ-11. Избыточная игра, возникающая исключительно в рамках маниакального или гипоманиакального эпизода, является симптомом аффективного эпизода.
6A05	Синдром дефицита внимания и гиперактивности	Наиболее сильная и устойчивая коморбидность. Отличать первичный СДВГ с дезорганизованной, плохо регулируемой игрой от независимого расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм; эти два состояния часто сосуществуют, и оба следует кодировать при соблюдении критериев.

Код	**Состояние**	**Отличительный признак**
6A70 / 6A71 / 6A72	Депрессивные расстройства	Игра, используемая преимущественно для бегства от сниженного настроения или его облегчения, может быть вторичным феноменом. Оценивать временную последовательность и то, сохраняется ли связанное с игрой функциональное нарушение после лечения аффективного расстройства.
6B00 / 6B04	Генерализованное тревожное расстройство / Социальное тревожное расстройство	При социальной тревоге избегание движимо страхом негативной оценки; при расстройстве вследствие пристрастия к компьютерным играм движущей силой являются нарушение контроля над игрой и её приоритет как таковые.
6A02	Расстройство аутистического спектра	Интенсивный, узко очерченный интерес может отражать сферу ограниченных интересов, а не аддиктивный процесс. Давний, не нарастающий особый интерес, не приводящий к функциональному нарушению, не является 6C51.

Код	**Состояние**	**Отличительный признак**
6C40–6C4G	Расстройства вследствие употребления психоактивных веществ	Оценивать, сохраняется ли игровой паттерн независимо от употребления психоактивных веществ или интоксикации.
6A20	Шизофрения	Длительная одиночная погружённость может возникать в контексте негативных симптомов, социальной отгороженности или бредовой поглощённости содержанием игры.
6B20	Обсессивно-компульсивное расстройство	Ритуализированное внутриигровое поведение, движимое навязчивыми мыслями и снижением тревоги, эго-дистонно с самого начала — в отличие от паттерна «удовольствие, затем привычка» при расстройстве вследствие пристрастия к компьютерным играм.

Код	Состояние	Отличительный признак
6C5Y / 6C5Z	Другие уточнённые / неуточнённые расстройства вследствие аддиктивного поведения	Для паттернов аддиктивного поведения, сосредоточенных на других онлайн-активностях — социальные сети, покупки-шопинг, использование порнографии, — которые не подпадают ни под определение гейминга, ни под определение гемблинга.
7A00–7A0Z	Расстройства в виде инсомнии	Определить, является ли нарушение сна следствием игрового паттерна или самостоятельным расстройством цикла «сон — бодрствование».

На один дифференциально-диагностический вопрос устоявшегося ответа нет: является ли вообще первичным состоянием игра, возникающая и стихающая вместе с аффективным расстройством или расстройством внимания. Он остаётся признанным приоритетом исследований (Musetti et al., 2025), а у конкретного пациента решается прагматически — надлежащим лечением коморбидного расстройства и наблюдением за тем, разрешается ли вместе с ним связанное с игрой функциональное нарушение.

7. Обследование и оценка

Общий принцип

Не существует ни биологического теста, ни нейровизуализационной находки, способных диагностировать расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм, и ни один диагностический биомаркер не установлен. Диагноз опирается на клиническое интервью; психометрические инструменты

являются лишь средствами скрининга и оценки тяжести, и ни один из них не должен использоваться для постановки или исключения диагноза сам по себе.

Инструменты

Инструмент	**Рамка**	**Структура и подсчёт**	**Валидизация и пороговое значение**
Gaming Disorder Test (GDT) Pontes et al., 2021	МКБ-11	4 пункта, 5-балльная шкала Ликерта, сумма 4–20; выше = тяжелее	Разработан на 236 китайских и 324 британских геймерах, набранных онлайн. Внутренняя согласованность подтверждена метаанализом обобщения надёжности 2024 года по 17 исследованиям на 14 языках (объединённая α = 0,86, 95% ДИ 0,83–0,89). Единого универсально валидизированного диагностического порога нет.

Инструмент	**Рамка**	**Структура и подсчёт**	**Валидизация и пороговое значение**
ACSID-11 Müller et al., 2022	МКБ-11	11 пунктов, применяемых одинаково к геймингу, покупкам-шопингу, использованию порнографии, использованию социальных сетей и онлайн-гемблингу	Разработан на 985 активных пользователях интернета (немецкоязычных). Тайская (2023) и китайская подростковая (2024) валидизации охватывают гейминг; опубликованная на сегодня англоязычная валидизация охватывает Tinder и использование онлайн-порнографии, но не гейминг. Дименсиональный; диагностического порога нет.

Инструмент	**Рамка**	**Структура и подсчёт**	**Валидизация и пороговое значение**
IGDT-10 Király et al., 2017	DSM-5	10 пунктов, операционализирующих девять критериев; диапазон баллов 0–9	Разработан на 4887 онлайн-геймерах (14–64 года, средний возраст 22,2, 92,5% мужского пола). Порог ≥ 5 указывает на вероятное IGD. Скалярная инвариантность измерения по семи языковым выборкам (7193 участника) показана в отдельном исследовании 2019 года.

Инструмент	Рамка	Структура и подсчёт	Валидизация и пороговое значение
IGDS9-SF Pontes and Griffiths, 2015	DSM-5	9 пунктов, 5-балльная шкала; интерпретация на основе критериев (подтверждение по меньшей мере пяти из девяти с наивысшей частотой)	Разработан на 1397 англоязычных геймерах (85,1% мужского пола, средний возраст 27 лет). Систематический обзор 21 исследования по 15 языковым версиям подтвердил одномерную структуру (Poon et al., 2021). Однозначно валидизированного единого порога суммарного балла нет.
AICA-S	Клиническая (зависимость от интернета и компьютерных игр)	Шкала тяжести	Первичная мера исхода в многоцентровом рандомизированном исследовании STICA (d = 1,19 на момент завершения лечения).

Критическая оговорка об инструментах

Оценка очевидной валидности 29 скрининговых инструментов для расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм, включавшая банк из 417 пунктов, независимо оценённых тремя профессиональными экспертами, выявила систематические проблемы охвата, формулировок и чрезмерной патологизации — пункты, улавливающие нормальную

интенсивную вовлечённость (King et al., 2020). Это не теоретическая обеспокоенность: в крупнейшем метаанализе распространённости выбор скринингового инструмента объяснял 77 процентов межисследовательской дисперсии (Stevens et al., 2021). Балл инструмента выше порога — повод для тщательного интервью, но никогда не диагноз.

Рекомендуемый пакет обследования

- Структурированное клиническое интервью по трём компонентам МКБ-11 плюс документированное функциональное нарушение.
- Объективный анамнез со слов семьи или школы — обязателен у несовершеннолетних.
- Один инструмент, соответствующий МКБ-11 (GDT или ACSID-11), для отслеживания тяжести во времени.
- Систематический скрининг коморбидности: сначала СДВГ ($r \approx 0{,}30$), затем депрессивные и тревожные расстройства, употребление психоактивных веществ и социальная тревога.
- Оценка сна с рекомендацией AASM для подростков в 8–10 часов в качестве отправной точки.
- Оценка экспозиции азартно-подобной монетизации (лутбоксы, внутриигровые покупки) и любого сопутствующего игорного поведения.
- Исходные функциональные показатели для последующего наблюдения: посещаемость и успеваемость в школе или на работе, время сна, офлайн-социальные контакты, физическая активность.

8. Лечение

Утверждённой фармакотерапии расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм не существует нигде. Ни один препарат не имеет одобрения FDA по этому показанию, и каждое изучавшееся средство применялось off-label. Ни одного систематического обзора Cochrane, посвящённого расстройству вследствие пристрастия к компьютерным играм, выявлено не было; NICE опубликовал руководство по вреду, связанному с азартными играми (NG248, 28 января 2025 года), но ни одного — по расстройству вследствие пристрастия к компьютерным играм; клинических руководств WFSBP, CANMAT, NIMH, SAMHSA или VA-DoD, специфичных для расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм, выявлено не было. Для формально классифицированного расстройства это существенный

пробел, и он означает, что клиницист работает, опираясь на первичные исследования, а не на руководства.

8.1 Фармакотерапия: что в действительности изучалось

Вся фармакологическая литература была обобщена в систематическом обзоре 12 клинических исследований, сообщающих о 724 участниках. Его ограничения определяют, что из него можно и чего нельзя заключить:

- 98,6 процента участников были мужчинами (684 из 694, для которых пол был указан);
- 100 процентов исследований были проведены в Южной Корее;
- 8 из 12 исследований были открытыми, и лишь четыре исследования в целом были отнесены к низкому риску систематической ошибки.

По всем исследованиям снижение симптомов IGD от начала к завершению лечения составляло от 15,4 до 51,4 процента — диапазон, полностью обусловленный исследованиями бупропиона (Sá et al., 2023).

Средство	**Доля участников**	**Сообщаемое снижение симптомов**
Бупропион (в том числе замедленного высвобождения), 6 статей	26,9% (n = 195)	15,4–51,4%
СИОЗС — флуоксетин, эсциталопрам, пароксетин, 6 статей	23,3% (n = 169)	17,6–24,0%
Метилфенидат, 2 статьи	14,6% (n = 106)	23,7–25,7%
Атомоксетин, 1 статья	5,5% (n = 40)	18,3%

Коморбидность имеет ключевое значение для прочтения этих цифр. Семь из 12 исследований были посвящены преимущественно IGD и охватывали 461 участника (63,6 процента от общего числа); пять из этих семи включали также участников с психиатрической коморбидностью, чаще всего СДВГ и большим депрессивным расстройством, что составляет 298 участников — около 41 процента всей объединённой выборки. Иными словами, существенная доля наблюдаемого улучшения может относиться к коморбидному расстройству, а не к игровому поведению.

Два наиболее информативных отдельных исследования:

- Han and Renshaw (2012). Двенадцатинедельное проспективное рандомизированное двойное слепое исследование (восемь недель активного лечения, четыре недели наблюдения) у 50 мужчин с большим депрессивным расстройством и избыточной онлайн-игрой. Бупропион в сочетании с образовательной программой по использованию интернета снижал баллы Young Internet Addiction Scale и среднее время игры сильнее, чем плацебо с той же образовательной программой. Клинически значимая деталь: в течение четырёхнедельного наблюдения снижение онлайн-игры сохранялось, тогда как депрессивные симптомы возобновлялись.
- Nam et al. (2017). Двенадцатинедельное двойное слепое сравнение бупропиона и эсциталопрама у пациентов с большим депрессивным расстройством и избыточной онлайн-игрой. Обе группы улучшились по депрессивным симптомам и симптомам IGD, но при 30 пациентах в общей сложности (по 15 в каждой ветви) исследование не может подкрепить никакого утверждения о сравнительной эффективности.

Клиническое правило. Фармакотерапия при расстройстве вследствие пристрастия к компьютерным играм в настоящее время направлена на коморбидность — СДВГ, депрессию, — а не на само игровое поведение. Её следует назначать по показанию коморбидного расстройства, при этом игровой исход отслеживают, а не обещают.

8.2 Психотерапия: когнитивно-поведенческая терапия — наиболее подкреплённый вариант

Позицию определяют три обобщения и одно многоцентровое исследование.

- Stevens et al. (2019). Метаанализ 12 независимых исследований КПТ. Эффект «до — после» на симптомы IGD при завершении составил g = 0,92 (95% ДИ 0,50–1,34); депрессия g = 0,80 (0,21–1,38); тревога g = 0,55 (0,17–0,93). Это эффекты «до — после» лечения, а не контролируемые межгрупповые сравнения, и различие имеет значение, поскольку именно эта цифра является заглавной в данной области. Практику же определяет следующая находка: приросты лечения при последующем наблюдении оказались незначимыми по всем четырём исходам — включая симптомы IGD, а не только депрессию и тревогу. Выигрыш от КПТ продемонстрирован в краткосрочной перспективе, а его устойчивость не продемонстрирована.
- Wölfling et al. (2019) — исследование STICA. Наиболее качественные рандомизированные данные: многоцентровое РКИ в четырёх амбулаторных клиниках Германии и Австрии, 143 мужчины рандомизированы в мануализированную краткосрочную КПТ (n = 72)

или контроль в листе ожидания (n = 71). Ремиссия наступила у 69,4 процента группы лечения против 23,9 процента контролей (отношение шансов 10,10, 95% ДИ 3,69–27,65, с поправкой на исходную тяжесть, коморбидность, центр и возраст). Размеры эффекта на момент завершения лечения: d = 1,19 (AICA-S), d = 0,88 (время онлайн в будние дни), d = 0,64 (психосоциальное функционирование), d = 0,67 (депрессия). Доза составила 15 еженедельных групповых сессий плюс до восьми индивидуальных сессий раз в две недели — примерно до 23 сессий на протяжении около четырёх месяцев, и именно это должна обеспечить служба, планирующая воспроизвести этот результат. Ограничения: выборка только мужская, а включение основывалось на интернет-зависимости как первичном диагнозе, а не строго на расстройстве вследствие пристрастия к компьютерным играм по МКБ-11.

- Ock et al. (2025). Метаанализ 18 РКИ нефармакологических вмешательств (1950 участников): объединённое g = −0,82 (95% ДИ от −1,23 до −0,52; I^2 = 90,36%). Психотерапия, главным образом КПТ, показала наибольший эффект (10 исследований, 1036 участников; g = −1,34); поведенческие вмешательства g = −0,38; профилактически ориентированная работа g = −0,33 против лечения g = −1,13; взрослые улучшались сильнее подростков (g = −1,14 против −0,45). Публикационное смещение было статистически подтверждено (Begg p = 0,043; Egger p = 0,002). Ещё один тревожный признак: четыре исследования, отнесённые к низкому риску систематической ошибки, дали наибольший эффект из всех (g = −4,08) — неправдоподобная оценка, указывающая скорее на нестабильную доказательную базу, чем на большой истинный эффект.
- Danielsen et al. (2024). Наиболее консервативное обобщение — 38 исследований, 76 размеров эффекта, 9524 участника — дало умеренную суммарную оценку, причём авторы указывают, что уверенность в этой находке подорвана эффектами малых исследований, возможным публикационным смещением, ограниченным пулом исследований и отсутствием стандартизации.

8.3 Краткосрочное воздержание

Протокол добровольного 84-часового воздержания у 24 взрослых геймеров, из которых 9 дали положительный результат скрининга на IGD, снизил количество часов игры, дезадаптивные игровые когниции и симптомы IGD при полном соблюдении протокола и отсутствии выбывания; к 28-му дню у 75 процентов группы IGD отмечалось клинически значимое улучшение симптомов IGD, а у 63 процентов — надёжное улучшение дезадаптивных

когниций (King et al., 2017). Это небольшое пилотное исследование. Цели воздержания и контролируемого использования никогда не сравнивались в исследовании с достаточной мощностью, и цель лечения следует индивидуализировать, а не предписывать.

8.4 Семейные и развивающие вмешательства

Программа PIPATIC — мануализированная индивидуализированная психотерапия из шести модулей для подростков от 12 до 18 лет, включающая психообразование и мотивацию, стандартное лечение зависимости, адаптированное к IGD, внутриличностный, межличностный, семейный модули и модуль нового образа жизни, проводимая на протяжении шести месяцев в 22 сессиях примерно по 45 минут, — была сопоставлена со стандартной КПТ в двух государственных центрах психического здоровья. Обе группы показали значимое снижение симптомов IGD (Torres-Rodríguez et al., 2018). Решающее ограничение — выборка: 31 подросток в общей сложности в обеих ветвях.

Семейные меры, родительское посредничество, вовлечённость в школьную жизнь и меры, касающиеся образа жизни, широко рекомендуются и согласуются с продольными данными о защитных факторах — качество отношений со сверстниками $r = −0{,}23$, вовлечённость в школьную жизнь $r = −0{,}18$, детско-родительские отношения $r = −0{,}15$, социальная поддержка $r = −0{,}14$ (Zhuang et al., 2023), — однако они не проверялись как самостоятельные вмешательства в рандомизированных исследованиях. Национальные регуляторные меры, такие как комендантский час и недельные лимиты времени для несовершеннолетних, существуют в нескольких странах; качественной оценки их влияния на клинические исходы выявлено не было, а регулирование лутбоксов и микротранзакций остаётся открытым политическим вопросом (Musetti et al., 2025).

8.5 Сводка уровней доказательности

Вмешательство	Уровень	Основание и главное ограничение
КПТ, индивидуальная и групповая (доза STICA: 15 групповых + до 8 индивидуальных сессий)	УМЕРЕННЫЙ	Несколько РКИ плюс одно многоцентровое РКИ; высокая гетерогенность и подтверждённое публикационное смещение; приросты при последующем наблюдении незначимы
Краткое структурированное воздержание	НИЗКИЙ	Единственное пилотное исследование, 24 участника
Семейно-интегрированные подростковые программы	НИЗКИЙ	Небольшое контролируемое исследование, 31 подросток в общей сложности
Фармакотерапия коморбидных СДВГ или депрессии	НИЗКИЙ	12 исследований, 724 участника, 98,6% мужского пола, все южнокорейские, 8 из 12 открытые
Фармакотерапия, направленная на само расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм	НЕДОСТАТОЧНЫЙ	Утверждённых средств нет; нет плацебо-контролируемого исследования достаточной мощности в некоморбидной выборке с диагнозом по МКБ-11
Родительские, школьные и средовые меры	КОСВЕННЫЙ	Подкреплены продольными данными о факторах риска, а не исследованиями

Вмешательство	Уровень	Основание и главное ограничение
Национальные регуляторные ограничения	НЕОЦЕНЁННЫЙ	Качественной оценки клинических исходов не выявлено

9. Прогноз

Прогностические утверждения о расстройстве вследствие пристрастия к компьютерным играм должны ограничиваться горизонтом от одного до двух лет. За его пределами не известно ничего: ни одного исследования с наблюдением длительностью от пяти до десяти лет выявлено не было, нет данных об исходах во взрослом возрасте у лиц с подростковым дебютом расстройства, и нет данных о смертности.

Естественное течение

Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм не является равномерно хроническим состоянием. Метаанализ 50 продольных исследований обнаружил категориальную стабильность приблизительно от 43 до 45 процентов при одногодичном наблюдении и от 34 до 38 процентов при двухлетнем — от трети до половины тех, кто удовлетворял порогу исходно, всё ещё удовлетворяли ему при последующем обследовании, а остальные — нет. Дименсиональная тяжесть симптомов вела себя иначе: корреляции между исходным уровнем и уровнем при наблюдении были положительными и статистически значимыми, указывая на умеренную и высокую преемственность тяжести даже там, где категориальный статус менялся. Стабильность такого порядка сходна с таковой при расстройстве личности и расстройстве вследствие пристрастия к азартным играм и ниже, чем при шизофрении или биполярном расстройстве (Sun et al., 2025). К этим цифрам относятся две оговорки: объединённые выборки состояли преимущественно из подростков, и это данные о нелечёном естественном течении.

Одногодичное продольное исследование 279 участников указывает в том же направлении: у 34,7 процента за год произошло изменение диагноза IGD по DSM-5, тогда как число случаев расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм по МКБ-11 возросло до 60,4 процента, при отсутствии значимой разницы между объёмами диагностических изменений в двух системах (Hong et al., 2023).

Предикторы

Проспективными факторами риска развития патологического гейминга являются больший объём игры, более низкая социальная компетентность и большая импульсивность (Gentile et al., 2011). Метааналитическими продольными предикторами более высоких траекторий симптомов служат время игры (r = 0,33), одиночество (r = 0,29), сопутствующее расстройство вследствие использования социальных сетей (r = 0,24), агрессия (r = 0,23) и тревога (r = 0,21); защитными предикторами — самоконтроль (r = −0,27), добросовестность (r = −0,25), качество отношений со сверстниками (r = −0,23), самооценка (r = −0,19) и вовлечённость в школьную жизнь (r = −0,18) (Zhuang et al., 2023). СДВГ имел наивысшее отношение шансов для изменения диагноза в одногодичном исследовании (Hong et al., 2023).

Предикторы рецидива после успешного лечения не установлены, и валидизированного предиктора не существует, а это означает, что наблюдение после ремиссии нельзя нацелить на подгруппу высокого риска и его следует предлагать в рутинном порядке.

Исходы, относимые к расстройству

В двухлетней сингапурской панели депрессия, тревога, социальная фобия и более низкая школьная успеваемость вели себя как исходы патологического гейминга, а не как его причины. Подростки, переставшие быть патологическими геймерами, в итоге имели более низкие уровни депрессии, тревоги и социальной фобии, чем те, кто остался патологическим геймером (Gentile et al., 2011). Это межгрупповое сравнение, а не документированное внутрииндивидуальное улучшение, и школьная успеваемость не входит в число переменных, по которым сообщалось о различиях между прекратившими и не прекратившими. Это остаётся самым сильным из имеющихся доказательств того, что состояние несёт проспективный вред, а не просто сосуществует с дистрессом.

Прогноз при лечении

В многоцентровом исследовании STICA ремиссия наступила у 69,4 процента пролеченных мужчин против 23,9 процента контролей из листа ожидания (Wölfling et al., 2019). Метаанализ нефармакологических вмешательств показал, что взрослые улучшаются существенно сильнее подростков (g = −1,14 против −0,45), — возрастной градиент, который должен умерять прогностические ожидания у более молодых пациентов (Ock et al., 2025). Против этого свидетельствует метаанализ КПТ, обнаруживший, что приросты лечения при

последующем наблюдении незначимы по всем четырём исходам (Stevens et al., 2019): краткосрочный ответ хорошо документирован, устойчивость — нет.

Кого нет в прогностических данных

Женщины и девушки практически не представлены в литературе по лечению. Единственное многоцентровое рандомизированное исследование включало только мужчин, и 98,6 процента участников всей фармакологической литературы были мужчинами. Никакого утверждения об ответе на лечение или прогнозе у пациенток на основании опубликованных данных сделать нельзя, и это следует говорить пациенткам и их семьям, а не скрывать за цифрами, полученными на мужских выборках.

10. Мифы и заблуждения

Повседневные заблуждения

Миф 1: «Всякий, кто много играет, зависим»

Опровергнуто. МКБ-11 не содержит временного порога; диагноз требует нарушения контроля, вытеснения других жизненных интересов, продолжения вопреки вреду *и* функционального нарушения. WHO указывает, что расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм затрагивает лишь малую долю людей, вовлечённых в цифровые или видеоигры. Личностно-центрированное исследование, изложенное в недавнем обзоре, выявило подгруппу «увлечённых геймеров», играющих более четырёх часов в день, с низким уровнем психологической дезадаптации (Musetti et al., 2025; Billieux et al., 2019).

Миф 2: «Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм затрагивает большую долю геймеров»

Опровергнуто в отношении верхних оценок. Наиболее качественные оценки составляют 2,4 процента в репрезентативных выборках и 1,4 процента после поправки на публикационное смещение (Kim et al., 2022); 1,96 процента (95% ДИ 0,19–17,12) в подгруппе со строгим формированием выборки (Stevens et al., 2021); и от 0,3 до 1,0 процента при использовании критериев DSM-5 в четырёх крупных международных выборках (Przybylski et al., 2017).

Миф 3: «Расстройство определяется фиксированным числом часов в день»

Опровергнуто. МКБ-11 определяет это состояние через контроль, приоритет, упорство вопреки вреду и функциональное нарушение. Время является проспективным фактором риска (r = 0,33; Zhuang et al., 2023), но не критерием, и оно не является ни необходимым, ни достаточным.

Миф 4: «Видеоигры вызывают насилие»

Опровергнуто как каузальное утверждение. Пересмотр резолюции Американской психологической ассоциации от февраля 2020 года гласит, что научных данных, подтверждающих причинную связь между жестокими видеоиграми и насильственным поведением, недостаточно, и прямо предостерегает от приписывания насилия, включая массовые расстрелы, использованию видеоигр. Повторный анализ данных, лежавших в основе отчёта рабочей группы APA 2015 года, обнаружил пренебрежимо малые связи с агрессивным и просоциальным поведением, небольшие связи с агрессивным аффектом и когнициями и более сильные связи с десенсибилизацией; размеры эффектов оказались завышены практиками, не соответствующими наилучшим стандартам, и эффектами ожиданий исследователя, особенно в экспериментальных исследованиях (Ferguson et al., 2020). Находка, касающаяся десенсибилизации, идёт вразрез с общим доводом и приводится здесь именно по этой причине. Насилие и расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм — разные вопросы, и их нельзя смешивать.

Миф 5: «Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм — не что иное, как симптом депрессии или СДВГ»

Отчасти верно и подлинно спорно. Коморбидность высока, и СДВГ обнаруживает наиболее устойчивую связь (r ≈ 0,30; Koncz et al., 2023), а критики утверждают, что расстройство гейминга в значительной мере вторично по отношению к аффективным проблемам и проблемам внимания (van Rooij et al., 2018). Против этого двухлетняя сингапурская панель обнаружила, что депрессия, тревога и социальная фобия ведут себя как исходы патологического гейминга, а не как его причины (Gentile et al., 2011). Оба прочтения должны быть представлены; вопрос не решён.

Миф 6: «Полное воздержание от всех игр — единственная правильная цель лечения»

Не установлено. Краткое добровольное воздержание имеет подкрепление лишь пилотного уровня (King et al., 2017), и ни одно исследование достаточной

мощности не сравнивало воздержание с целями контролируемого использования. Цель лечения следует индивидуализировать.

Миф 7: «Существует лекарство, излечивающее расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм»

Опровергнуто. Ни одно средство не имеет регуляторного одобрения по этому показанию; вся фармакологическая литература состоит из 12 исследований, 724 участников, 98,6 процента мужского пола, все проведены в Южной Корее, 8 из 12 — открытые (Sá et al., 2023). Препараты применяются off-label при коморбидных СДВГ или депрессии.

Миф 8: «Лутбоксы и внутриигровые покупки — безобидное развлечение»

Не подкреплено. У 7422 геймеров траты на лутбоксы были связаны с тяжестью проблемного гемблинга ($\eta^2 = 0{,}054$) — эффект на порядок величины больший, чем для других внутриигровых покупок (Zendle и Cairns, 2018). Данные поперечные и не устанавливают причинности ни в одном из направлений, но связь достаточно устойчива, чтобы оправдать вопрос о ней при каждом обследовании.

Миф 9: «Расстройство вследствие пристрастия к видеоиграм — азиатская проблема»

Преувеличено. Оценки распространённости в выборках из Восточной и Юго-Восточной Азии, как правило, выше, однако в крупнейшем метаанализе скрининговый инструмент объяснял 77 процентов межисследовательской дисперсии, а регион не вошёл в число сообщённых значимых предикторов (Stevens et al., 2021); Kim et al. (2022) перечисляют регион как один из нескольких модераторов. Он смешан с инструментом, типом выборки и качеством исследования, а случаи регистрируются по всему миру.

Миф 10: «Литература о гейминге и депрессии надёжна»

Опровергнуто. Критическая оценка семи систематических обзоров расстройства вследствие пристрастия к компьютерным играм с депрессией или тревогой, охватывающих 196 первичных исследований, обнаружила избирательное представление исходов во всех семи, оценку риска систематической ошибки лишь в одном и непоследовательные определения экспозиции; ни один не был отнесён к надёжным (Colder Carras et al., 2020).

Научная полемика вокруг самой категории

6C51 — наиболее оспариваемый диагноз в группировке аддиктивного поведения МКБ-11. Спор носит академический, а не коммерческий характер, и оба популярных объяснения этого спора — лоббирование со стороны индустрии с одной стороны и чистая моральная паника с другой — ошибочны.

Доводы против включения. В 2017 году 26 учёных опубликовали открытый дискуссионный документ против предложения WHO (Aarseth et al., 2017). Их доводы состояли в том, что исследовательская база низкого качества; что операционализация некритически заимствована из критериев употребления психоактивных веществ и гемблинга; что диагноз рискует патологизировать нормальную, здоровую, интенсивную игру; и что формализация может подпитать моральную панику, стигматизировать обширную рекреационную популяцию и привести к ненужному лечению детей. Частично пересекающаяся группа затем утверждала, что бремя доказательств, требуемое для перехода от исследовательского конструкта к формальному расстройству, очень велико — именно потому, что диагнозы могут использоваться во зло, — и что WHO следует отложить формализацию (van Rooij et al., 2018).

Доводы за включение. Итоговый документ экспертных консультаций WHO утверждал, что расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм обнаруживает основные признаки аддиктивного расстройства и что категория необходима для людей, уже обращающихся за лечением (Saunders et al., 2017). Rumpf с коллегами ответили с клинической и общественно-здравоохранительной позиции: службы помощи таким пациентам уже существовали во многих странах; без категории пациентов невозможно надёжно идентифицировать, службы невозможно планировать и финансировать, а исследования невозможно стандартизировать; риск же гипердиагностики смягчается строгим требованием функционального нарушения в МКБ-11 (Rumpf et al., 2018). Griffiths с коллегами утверждали, что проблемный гейминг доказуемо существует и представляет собой расстройство гейминга (Griffiths et al., 2017).

Позиция WHO. WHO сохранила категорию, представила включение как следствие независимого развития программ лечения идентичных клинических картин во многих частях мира и подчеркнула в своих публичных материалах, что расстройство вследствие пристрастия к компьютерным играм затрагивает лишь малую долю играющих, — явная попытка снять возражение о чрезмерной патологизации.

Позиция индустрии. Вопреки распространённому допущению, индустрия видеоигр выступила против диагноза. Entertainment Software Association публично отвергла аддиктивную трактовку и призвала WHO изменить курс, схожие опасения высказывала и European Games Developer Federation (по сообщению Musetti et al., 2025). Диагноз нельзя приписать лоббированию индустрии, а возражение о моральной панике исходило из академической среды, а не от индустрии.

Что остаётся подлинно нерешённым. Три вещи, каждая из которых меняет то, что клиницист должен говорить пациенту. Согласие между оценщиками для руководящих указаний МКБ-11 проверялось однократно, в одной стране, на одной школьной выборке, и было умеренным (к = 0,545). Категориальное наличие случая нестабильно на протяжении одного года в обеих диагностических системах. А обобщающая литература по самым частым коморбидностям не соответствует принятым методологическим стандартам. Ничто из этого не делает диагноз непригодным; всё это делает уверенный прогноз неоправданным.

11. Источники

1. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: 6C51 Gaming disorder. Geneva: WHO; 2019 (2025–01 release).
2. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: QE22 Hazardous gaming. Geneva: WHO; 2019 (2025–01 release).
3. World Health Organization. Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements for ICD-11 Mental, Behavioural and Neurodevelopmental Disorders (CDDR). Geneva: WHO; 2024.
4. World Health Organization. Addictive behaviours: Gaming disorder — Questions and answers. Geneva: WHO.
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing; 2022. (англ. Internet gaming disorder — Section III, Conditions for Further Study.)
6. American Psychological Association. APA Resolution on Violent Video Games: February 2020 Revision. Washington, DC: APA; 2020.
7. American Psychological Association. APA reaffirms position on violent video games and violent behavior [press release]. 3 March 2020.
8. National Institute for Health and Care Excellence. Gambling-related harms: identification, assessment and management. NICE guideline NG248.

London: NICE; 28 January 2025. (англ. Cited for contrast: no NICE guideline exists for gaming disorder.)

9. Aarseth E, Bean AM, Boonen H, Colder Carras M, Coulson M, Das D, et al. Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. J Behav Addict. 2017;6(3):267–270. doi:10.1556/2006.5.2016.088
10. Billieux J, Flayelle M, Rumpf HJ, Stein DJ. High involvement versus pathological involvement in video games: a crucial distinction for ensuring the validity and utility of gaming disorder. Curr Addict Rep. 2019;6(3):323–330. doi:10.1007/s40429–019–00259-x
11. Brand M, Young KS, Laier C, Wölfling K, Potenza MN. Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders: an Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model. Neurosci Biobehav Rev. 2016;71:252–266. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.08.033
12. Brand M, Wegmann E, Stark R, Müller A, Wölfling K, Robbins TW, Potenza MN. The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. Neurosci Biobehav Rev. 2019;104:1–10. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.06.032
13. Colder Carras M, Shi J, Hard G, Saldanha IJ. Evaluating the quality of evidence for gaming disorder: a summary of systematic reviews of associations between gaming disorder and depression or anxiety. PLoS One. 2020;15(10):e0240032. doi:10.1371/journal.pone.0240032
14. Danielsen PA, Mentzoni RA, Låg T. Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Addict Behav. 2024;149:107887. doi:10.1016/j.addbeh.2023.107887 (PMID 37826910)
15. Ferguson CJ, Copenhaver A, Markey P. Reexamining the findings of the American Psychological Association's 2015 task force on violent media: a meta-analysis. Perspect Psychol Sci. 2020;15(6):1423–1443. doi:10.1177/1745691620927666
16. Gentile DA, Choo H, Liau A, Sim T, Li D, Fung D, Khoo A. Pathological video game use among youths: a two-year longitudinal study. Pediatrics. 2011;127(2):e319–e329. doi:10.1542/peds.2010–1353
17. Gentile DA, Bailey K, Bavelier D, Brockmyer JF, Cash H, Coyne SM, et al. Internet gaming disorder in children and adolescents. Pediatrics. 2017;140(Suppl 2):S81–S85. doi:10.1542/peds.2016–1758H

18. Griffiths MD, Kuss DJ, Lopez-Fernandez O, Pontes HM. Problematic gaming exists and is an example of disordered gaming. J Behav Addict. 2017;6(3):296–301. doi:10.1556/2006.6.2017.037
19. Han DH, Renshaw PF. Bupropion in the treatment of problematic online game play in patients with major depressive disorder. J Psychopharmacol. 2012;26(5):689–696. doi:10.1177/0269881111400647 (PMID 21447539)
20. Hong YN, Hwang H, Starcevic V, Choi TY, Kim TH, Han DH. Which is more stable and specific: DSM-5 internet gaming disorder or ICD-11 gaming disorder? A longitudinal study. Psychiatry Clin Neurosci. 2023;77(4):213–222. doi:10.1111/pcn.13522 (PMID 36562926)
21. Kardefelt-Winther D. A conceptual and methodological critique of internet addiction research: towards a model of compensatory internet use. Comput Human Behav. 2014;31:351–354. doi:10.1016/j.chb.2013.10.059
22. Kim HS, Son G, Roh EB, Ahn WY, Kim J, Shin SH, Chey J, Choi KH. Prevalence of gaming disorder: a meta-analysis. Addict Behav. 2022;126:107183. doi:10.1016/j.addbeh.2021.107183 (PMID 34864436)
23. King DL, Billieux J, Carragher N, Delfabbro PH. Face validity evaluation of screening tools for gaming disorder: scope, language, and overpathologizing issues. J Behav Addict. 2020;9(1):1–13. doi:10.1556/2006.2020.00001 (PMID 32359228)
24. King DL, Kaptsis D, Delfabbro PH, Gradisar M. Effectiveness of brief abstinence for modifying problematic internet gaming cognitions and behaviors. J Clin Psychol. 2017;73(12):1573–1585. doi:10.1002/jclp.22460 (PMID 28152189)
25. Király O, Sleczka P, Pontes HM, Urbán R, Griffiths MD, Demetrovics Z. Validation of the Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) and evaluation of the nine DSM-5 Internet Gaming Disorder criteria. Addict Behav. 2017;64:253–260. doi:10.1016/j.addbeh.2015.11.005
26. Király O, Bőthe B, et al. Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): measurement invariance and cross-cultural validation across seven language-based samples. Psychol Addict Behav. 2019;33(1):91–103. doi:10.1037/adb0000433
27. Koncz P, Demetrovics Z, Takacs ZK, Griffiths MD, Nagy T, Király O. The emerging evidence on the association between symptoms of ADHD and gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2023;106:102343. doi:10.1016/j.cpr.2023.102343 (PMID 37883910)
28. Kuss DJ, Griffiths MD, Pontes HM. Chaos and confusion in DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder. J Behav Addict. 2017;6(2):103–109. doi:10.1556/2006.5.2016.062

29. Ma C, Wang Z, Li C, Lu J, Long J, Li R, Wu Q, Jiang H, Du J, Li R, Wang P, Ma L, Li H, Hui S, Zhao W, Zhong N, Zhao M. The clinical consistency and utility of ICD-11 diagnostic guidelines for gaming disorder: a field study among the Chinese population. Front Psychiatry. 2021;12:781992. doi:10.3389/fpsyt.2021.781992 (англ. PMID 35002801; 781992 is the article number)
30. Müller SM, Wegmann E, Oelker A, Stark R, Müller A, Montag C, Wölfling K, Rumpf HJ, Brand M. Assessment of Criteria for Specific Internet-use Disorders (ACSID-11): introduction of a new screening instrument capturing ICD-11 criteria for gaming disorder and other potential Internet-use disorders. J Behav Addict. 2022;11(2):427–450. doi:10.1556/2006.2022.00013
31. Musetti A, Floros G, Chiappedi M, Stavropoulos V. Gaming disorder in the ICD-11: the state of the game. BMC Psychiatry. 2025;25(1):1114. doi:10.1186/s12888–025–07576–8 (англ. PMID 41272537; 1114 is the article number)
32. Nam B, Bae S, Kim SM, Hong JS, Han DH. Comparing the effects of bupropion and escitalopram on excessive internet game play in patients with major depressive disorder. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15(4):361–368. doi:10.9758/cpn.2017.15.4.361 (PMID 29073748)
33. Ock CM, Lee HS, Chae J, Kim H. Effectiveness of non-pharmacological interventions on gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry Investig. 2025;22(5):490–503. doi:10.30773/pi.2024.0358
34. Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785–786. doi:10.5664/jcsm.5866
35. Paulus FW, Ohmann S, von Gontard A, Popow C. Internet gaming disorder in children and adolescents: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2018;60(7):645–659. doi:10.1111/dmcn.13754
36. Pontes HM, Griffiths MD. Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: development and validation of a short psychometric scale. Comput Human Behav. 2015;45:137–143. doi:10.1016/j.chb.2014.12.006
37. Pontes HM, Schivinski B, Sindermann C, Li M, Becker B, Zhou M, Montag C. Measurement and conceptualization of Gaming Disorder according to the World Health Organization framework: the development of the Gaming Disorder Test. Int J Ment Health Addict. 2021;19(2):508–528. doi:10.1007/s11469–019–00088-z
38. Poon LYJ, Tsang HWH, Chan TYJ, Man SWT, Ng LY, Wong YLE, Lin CY, Chien CW, Griffiths MD, Pontes HM, Pakpour AH. Psychometric

properties of the Internet Gaming Disorder Scale-Short-Form (IGDS9-SF): systematic review. J Med Internet Res. 2021;23(10):e26821. doi:10.2196/26821 (англ. e26821 is the article number)

39. Przybylski AK, Weinstein N, Murayama K. Internet gaming disorder: investigating the clinical relevance of a new phenomenon. Am J Psychiatry. 2017;174(3):230–236. doi:10.1176/appi.ajp.2016.16020224
40. Jahrami H., Husain W., Lin C.-Y. et al. Reliability generalization meta-analysis and psychometric review of the Gaming Disorder Test (GDT): evaluating internal consistency. Addict Behav Rep 2024;20:100563.
41. Ropovik I, Martončik M, Babinčák P, Baník G, Vargová L, Adamkovič M. Risk and protective factors for (internet) gaming disorder: a meta-analysis of pre-COVID studies. Addict Behav. 2023;139:107590. doi:10.1016/j.addbeh.2022.107590 (англ. 107590 is the article number)
42. Rumpf HJ, Achab S, Billieux J, Bowden-Jones H, Carragher N, Demetrovics Z, et al. Including gaming disorder in the ICD-11: the need to do so from a clinical and public health perspective. J Behav Addict. 2018;7(3):556–561. doi:10.1556/2006.7.2018.59
43. Sá RRC, Coelho S, Parmar PK, Johnstone S, Kim HS, Tavares H. A systematic review of pharmacological treatments for Internet Gaming Disorder. Psychiatry Investig. 2023;20(8):696–706. doi:10.30773/pi.2022.0297 (PMID 37559452)
44. Satish Kumar CR, Sharma MK, Amudhan S, Arya S, Mahapatra S, Anand N, et al. Digital gaming, musculoskeletal, and related health hazards among adolescents and young adults. Indian J Psychiatry. 2023;65(6):698–700. doi:10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_818_22
45. Saunders JB, Hao W, Long J, King DL, Mann K, Fauth-Bühler M, et al. Gaming disorder: its delineation as an important condition for diagnosis, management, and prevention. J Behav Addict. 2017;6(3):271–279. doi:10.1556/2006.6.2017.039
46. Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Global prevalence of gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2021;55(6):553–568. doi:10.1177/0004867420962851
47. Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Corrigendum to: Global prevalence of gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2023;57(6):928. doi:10.1177/00048674221137011 (PMID 36433839)
48. Stevens MWR, King DL, Dorstyn D, Delfabbro PH. Cognitive-behavioral therapy for Internet gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Psychother. 2019;26(2):191–203. doi:10.1002/cpp.2341

49. Sun AP, Ho CH, Kuss DJ, Cross CL. The temporal stability of problematic gaming and gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Addict Behav Rep. 2025;21:100592. doi:10.1016/j.abrep.2025.100592 (англ. PMID 40125549; 100592 is the article number)
50. Torres-Rodríguez A, Griffiths MD, Carbonell X, Oberst U. Treatment efficacy of a specialized psychotherapy program for Internet Gaming Disorder. J Behav Addict. 2018;7(4):939–952. doi:10.1556/2006.7.2018.111 (PMID 30427213)
51. van Rooij AJ, Ferguson CJ, Colder Carras M, Kardefelt-Winther D, Shi J, Aarseth E, et al. A weak scientific basis for gaming disorder: let us err on the side of caution. J Behav Addict. 2018;7(1):1–9. doi:10.1556/2006.7.2018.19
52. Vink JM, van Beijsterveldt TCEM, Huppertz C, Bartels M, Boomsma DI. Heritability of compulsive Internet use in adolescents. Addict Biol. 2016;21(2):460–468. doi:10.1111/adb.12218
53. Wölfling K, Müller KW, Dreier M, Ruckes C, Deuster O, Batra A, et al. Efficacy of short-term treatment of internet and computer game addiction: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1018–1025. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1676 (PMID 31290948)
54. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior. 1998;1(3):237–244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237
55. Zendle D, Cairns P. Video game loot boxes are linked to problem gambling: results of a large-scale survey. PLoS One. 2018;13(11):e0206767. doi:10.1371/journal.pone.0206767
56. Zheng H, Hu Y, Wang Z, Wang M, Du X, Dong G. Meta-analyses of the functional neural alterations in subjects with Internet gaming disorder: similarities and differences across different paradigms. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019;94:109656. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109656 (PMID 31145927)
57. Zhuang X, Zhang Y, Tang X, Ng TK, Lin J, Yang X. Longitudinal modifiable risk and protective factors of internet gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. J Behav Addict. 2023;12(2):375–392. doi:10.1556/2006.2023.00017

6C70–6C7Z КОНТРОЛЬ ИМПУЛЬСОВ

Impulse control disorders

МКБ-11 **6C70**	**6C70 ПИРОМАНИЯ** **Pyromania**
МКБ-10 F63.1	Патологическое влечение к поджогам [пиромания]
DSM-5-TR F63.1	Пиромания

1. Определение и нозология

Пиромания (МКБ-11: 6C70; DSM-5-TR: F63.1) — преднамеренное, целенаправленное поведение по поджогу; напряжение или эмоциональное возбуждение перед актом, облегчение или удовольствие после акта. Без финансовой выгоды, мести или идеологической цели; редкое расстройство контроля импульсов.

2. История

- В 1830-х годах Marc — «monomanie incendiaire».
- DSM-III (1980) — в рамках расстройств контроля импульсов.
- МКБ-11 (2019) — в категории расстройств контроля импульсов.

3. Эпидемиология

- Редкое — лишь ~3–10% случаев поджогов соответствуют критериям пиромании (большинство поджогов имеют финансовую мотивацию, месть или другие мотивы).
- Пол: выше у мужчин.
- Начало: подростковый возраст.
- Коморбидность: расстройство поведения, АСРЛ, ИР, СДВГ, другое употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Множественные факторы — нейробиологический контроль импульсов, когнитивный дефицит, семейная дисфункция.
- Коморбидные расстройства типичны.

5. Клиническая картина

- Повторяющиеся умышленные поджоги.
- Перед актом — напряжение/эмоциональное возбуждение.
- Восхищение огнём, атрибутами (пламя, инструменты).
- После акта — удовольствие, облегчение.
- Финансовая выгода, месть, идеологическая цель или психотическое принуждение (бред) отсутствуют.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Неоднократные преднамеренные поджоги.

B. Перед актом — напряжение или эмоциональное возбуждение.

C. Увлечённость огнём, его атрибутикой и контекстом.

D. Выполнение, наблюдение, результат акта доставляют удовольствие.

E. Поджог не обусловлен финансовыми, связанными с местью, идеологическими, социально-политическими или психотическими мотивами.

F. Расстройство поведения, маниакальный эпизод, ASPD не объясняют лучше.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- Редко в клинической практике; большинство поджогов мотивированы.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от семьи/свидетеля.
2. История мотивации — соответствие критериям пиромании.
3. Коморбидность (АСРЛ, расстройство поведения, мания, психоз, ИР, СДВГ).

4. Правовой контекст — судебно-психиатрическая консультация.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Расстройство поведения (6C91)	Множественное антисоциальное поведение.
АСРЛ (Антисоциальное расстройство личности)	Стойкая антисоциальная модель.
Маниакальный эпизод	Связано с аффективным эпизодом.
Психотическая мотивация	Бред (напр., «голоса»); шизофрения, бредовое расстройство.
Месть / финансы / идеология	Не клинический диагноз — судебная тема.

7. Обследование и оценка

- Психиатрическое интервью.
- Интеллектуальная оценка.
- Шкалы импульсивности (англ. Barratt Impulsiveness Scale).
- Структурированная оценка риска в судебном контексте (HCR-20, VRAG).

8. Лечение

1. Доказательная база ограничена (редкое расстройство).
2. КПТ — контроль импульсов, управление триггерами, экспозиция к альтернативному поведению.
3. Лечение коморбидных расстройств (терапевтические ограничения при АСРЛ, поведенческая интервенция при ИР, стимуляторы при СДВГ).
4. СИОЗС — off-label для контроля импульсов.
5. Судебно-психиатрическая координация (госпитализация, судебное решение).

8.1 Методики лечения

1. КПТ для контроля импульсов — Идентификация триггеров, поведенческий заместитель.

2. Лечение коморбидности — Специфическое вмешательство при расстройстве поведения, ИР, СДВГ.
3. Судебная оценка риска — HCR-20, VRAG.

9. Прогноз

- Доказательная база ограничена; коморбидное расстройство и психосоциальная поддержка определяют прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Все поджигатели — пироманы»

Доказательства: Большинство поджогов мотивированы (финансы, месть) — пиромании нет; ~3–10% соответствуют клиническому диагнозу.

Миф 2: «Пиромания — это только детский феномен»

Доказательства: начало обычно в подростковом возрасте, но может продолжаться и во взрослом.

Миф 3: «Существует специфическая эффективная фармакотерапия»

Доказательства: Нет одобрения FDA; СИОЗС off-label, доказательная база ограничена.

Миф 4: «Только правового наказания достаточно»

Доказательства: клиническое вмешательство и лечение коморбидности снижают риск рецидива.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C70 Pyromania. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Burton P.R., McNiel D.E., Binder R.L. Firesetting, arson, pyromania, and the forensic mental health expert. J Am Acad Psychiatry Law 2012;40(3):355–365.

МКБ-11 **6C71**	**6C71 КЛЕПТОМАНИЯ** **Kleptomania**
МКБ-10 F63.2	Патологическое влечение к воровству [клептомания]
DSM-5-TR F63.2	Клептомания

1. Определение и нозология

Клептомания (МКБ-11: 6C71; DSM-5-TR: F63.2) — повторяющийся непреодолимый импульс к краже предметов, не необходимых для личного пользования или финансовой ценности; напряжение перед актом, облегчение или удовольствие после акта.

2. История

- Esquirol (1838) — «kleptomanie».
- DSM-III — расстройства контроля импульсов.
- МКБ-11 — расстройства контроля импульсов.

3. Эпидемиология

- Лишь ~5% случаев магазинных краж соответствуют клептомании (большинство краж мотивированы).
- Пол: выше у женщин (в клинических популяциях).
- Коморбидность: расстройства настроения в разных сериях 45–100%, БДР до ~65%; тревога, ОКР, расстройства пищевого поведения, употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Гипотеза дисрегуляции серотониновой и опиоидной систем (Grant J.E.).
- Коморбидные аффективные расстройства и расстройства импульсивности.

5. Клиническая картина

- Неспособность противостоять акту кражи — предмет, не нужный для личной или финансовой ценности.
- Перед актом — нарастание напряжения.
- После акта — облегчение, удовольствие.
- Кража не обусловлена гневом, местью или психотической мотивацией.
- Предметы обычно впоследствии выбрасываются, раздаются, прячутся; иногда тайком возвращаются.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Повторяющаяся неспособность противостоять импульсу к краже предметов, не нужных для личного пользования и не представляющих материальной ценности.

B. Перед актом — напряжение.

C. После акта — облегчение, удовольствие.

D. Кража не обусловлена мотивацией гнева, мести, бреда или галлюцинаций.

E. Расстройство поведения, маниакальный эпизод, ASPD не объясняют лучше.

6.2 Различия между источниками

DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаковые критерии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. K-SAS (англ. Kleptomania Symptom Assessment Scale) — Grant J.E.
3. Коморбидное БДР, тревога, ОКР, расстройства пищевого поведения.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Обычная кража	Мотивация — выгода, потребность.
АСРЛ	Стойкая антисоциальная модель.

Состояние	Отличительный признак
Маниакальный эпизод	Аффективный контекст.
Расстройство поведения (6C91)	Множественное антисоциальное поведение.
Деменция	Когнитивное снижение.

7. Обследование и оценка

- K-SAS.
- Шкалы для оценки коморбидности.

8. Лечение

1. Налтрексон — Grant J.E. et al. Biol Psychiatry 2009 РКИ — эффективность при клептомании (50–150 мг/сут).
2. КПТ — когнитивная реструктуризация, поведенческая активация, экспозиция и предотвращение ритуалов.
3. СИОЗС — при коморбидном БДР.
4. Мультидисциплинарный подход — юридический контекст.

8.1 Методики лечения

1. Налтрексон — Антагонист опиоидных рецепторов; снижает влечение при клептомании.
2. КПТ для контроля импульсов — Управление триггерами.
3. Шкала оценки симптомов клептомании (англ. Kleptomania Symptom Assessment Scale, K-SAS) — Шкала тяжести.

8.2 Различия между источниками

- Grant J.E. — доказательная база налтрексона.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при применении налтрексона и КПТ.
- Коморбидное БДР (MDD) — неблагоприятный прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Любая повторяющаяся кража — это клептомания»

Доказательства: Большинство краж мотивированы; клептомания редка.

Миф 2: «Пациент может прекратить „по собственной воле“»

Доказательства: расстройство контроля импульсов — неспособность сопротивляться является клинической диагностической особенностью.

Миф 3: «Юридического наказания достаточно»

Доказательства: клиническое вмешательство и лечение коморбидности снижают риск рецидива.

Миф 4: «Специфического лечения нет»

Доказательства: налтрексон — доказательная база (Grant 2009 РКИ); КПТ эффективна.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C71 Kleptomania. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Grant J.E. et al. A double-blind, placebo-controlled study of the opiate antagonist naltrexone in the treatment of kleptomania. Biol Psychiatry 2009;65(7):600–606.

МКБ-11 **6C72**	**6C72 КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ** **Compulsive sexual behaviour disorder**
МКБ-10 F52.7	Повышенное половое влечение
DSM-5-TR —	Эквивалента в DSM-5-TR нет

1. Определение и нозология

Компульсивное расстройство сексуального поведения (МКБ-11: 6C72 Compulsive Sexual Behaviour Disorder) — паттерн стойкой неспособности контролировать интенсивные, повторяющиеся сексуальные импульсы и поведение; вызывает значительный дистресс или функциональное нарушение. В МКБ-11 включено в категорию расстройств контроля импульсов.

В DSM-5-TR отдельного диагноза нет («Гиперсексуальное расстройство» не было включено в DSM-5). Термин «сексуальная зависимость» является спорным в научном сообществе.

2. История

- Krafft-Ebing (1886) — «hyperaesthesia sexualis».
- 1980–90-е годы — концепция «сексуальной зависимости» (Carnes P.) стала популярной, но оставалась спорной в научном сообществе.
- DSM-5 (2013) — «Hypersexual Disorder» не был включён.
- МКБ-11 (2019) — Компульсивное расстройство сексуального поведения (контроль импульсов, не зависимость) добавлено как официальная категория.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 1–6% (широкий диапазон, зависит от измерительных инструментов).
- Пол: выше у мужчин (в клинических популяциях 5:1).
- Коморбидность: БДР, тревога, ПРЛ, употребление ПАВ, ОКР, СДВГ.

4. Этиология и патогенез

- Множественные факторы — импульсивность, компульсивность, когнитивно-эмоциональная дисрегуляция, травма.
- Нейробиологические сходства расстройств употребления психоактивных веществ и ОКР.
- Социокультурное — доступность интернет-порнографии.

5. Клиническая картина

- Чрезмерное количество времени, затрачиваемое на сексуальные фантазии, импульсы, поведение.

- Неудачные попытки уменьшить поведение, несмотря на негативные последствия.
- Использование сексуального поведения для уменьшения дистресса или эмоционального принятия.
- Значительное функциональное нарушение вследствие расстройства контроля сексуального поведения (отношения, работа, здоровье, правовые аспекты).
- Типичные формы — компульсивная мастурбация, множественные сексуальные партнёры, посещение коммерческих сексуальных услуг, проблемное использование порнографии.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (МКБ-11)

A. Устойчивый паттерн неспособности контролировать интенсивные сексуальные импульсы и поведение.

B. ≥ 1 из следующих:

1. Повторяющаяся сексуальная активность приводит к ослаблению других сфер жизни индивида (здоровье, отношения, ответственность);
2. Пациент предпринимал повторные и значительные попытки взять контроль — безуспешно;
3. Поведение продолжается, несмотря на негативные последствия;
4. Поведение продолжается, даже если не приносит значительного удовольствия.

C. Длительность ≥ 6 месяцев.

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения

E. Дистресс, целиком обусловленный морально-религиозным осуждением, критерию не удовлетворяет; требуется функциональное нарушение либо дистресс, не сводящийся к такому осуждению.

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11: расстройства контроля импульсов; термин «сексуальная зависимость» не используется.
- DSM-5-TR: отдельного диагноза нет; в клинической практике входит в «Other Specified Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorder».

- Диагноз не должен ставиться на основании одного лишь морально-религиозного осуждения.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Шкала — CSBI (англ. Compulsive Sexual Behavior Inventory).
3. Коморбидность (БДР, тревога, ПРЛ, ПАВ, ОКР).
4. Скрининг инфекций, передающихся половым путём (ИППП).
5. Правовые и межличностные последствия.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Маниакальный эпизод (гиперсексуальность)	Аффективный контекст.
ПРЛ (BPD) (импульсивность)	Устойчивый паттерн во всех сферах.
ОКР (сексуальные обсессии)	Эго-дистоническая обсессия; ритуал.
Парафильное расстройство (6D3x)	Специфический атипичный сексуальный объект.
Высокий сексуальный интерес (нормальный вариант)	Функциональное нарушение отсутствует.
Только морально-религиозное осуждение	Не является основанием для клинического диагноза.

7. Обследование и оценка

- CSBI.
- Шкалы для оценки коморбидности.
- Скрининг на ИППП.

8. Лечение

1. Психотерапия первой линии — КПТ, АКТ, подход на основе осознанности. Доказательная база развивается.
2. Налтрексон off-label — антагонист опиоидов; в некоторых исследованиях умеренный эффект.
3. СИОЗС — при коморбидном БДР (MDD)/тревожности.

4. Групповая поддержка (S-Anon, SAA) — адъюнкт.
5. Парная терапия — в коморбидном контексте.
6. Специфической одобренной FDA фармакотерапии нет.

8.1 Методики лечения

1. КПТ и терапия принятия и ответственности (ACT) — Управление триггерами, поведение, основанное на ценностях.
2. Налтрексон off-label — Уменьшение влечения (cravings).
3. Опросник компульсивного сексуального поведения (CSBI — Compulsive Sexual Behavior Inventory) — Шкала тяжести.
4. Self-help (SAA, SLAA) — основана на 12 шагах; доказательная база ограничена.

8.2 Различия между источниками

- ВОЗ — МКБ-11 официальная категория.
- APA — в DSM-5-TR отдельного диагноза нет; спорная область.

9. Прогноз

- Значительное улучшение с помощью КПТ и АКТ.
- Лечение коморбидности обязательно.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Сексуальная зависимость — это диагноз, как и зависимость от веществ»

Доказательства: МКБ-11 — расстройство контроля импульсов; концепция «зависимости» спорна, в DSM-5 не принята.

Миф 2: «Высокий сексуальный интерес — признак сексуальной зависимости»

Доказательства: клинический диагноз требует функциональных нарушений и неудачи контроля; просто высокая сексуальная активность не является болезнью.

Миф 3: «Нарушение морально-религиозных норм — основа диагноза»

Доказательства: МКБ-11 — религиозно-духовного кризиса недостаточно; требуется функциональное нарушение или выраженный дистресс.

Миф 4: «Использование порнографии всегда является болезнью»

Доказательства: нормальное и компульсивное употребление различаются; нарушение контроля и функциональная нагрузка являются диагностическими.

Миф 5: «Химическая кастрация (супрессия тестостерона) — стандартное лечение»

Доказательства: этот подход — только при тяжёлых парафилических расстройствах (например, активный риск педофилии) по рекомендации WFSBP; не рекомендуется при генерализованном компульсивном сексуальном поведении.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C72 Compulsive sexual behaviour disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kraus S.W. et al. Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11. World Psychiatry 2018;17(1):109–110.
4. Grubbs J.B., Hoagland K.C., Lee B.N. et al. Sexual addiction 25 years on. Clin Psychol Rev 2020;82:101925.

МКБ-11 **6C73**	**6C73 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЭКСПЛОЗИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (IED)** **Intermittent explosive disorder**
МКБ-10 F63.8	Другие расстройства привычек и влечений
DSM-5-TR F63.81	Интермиттирующее эксплозивное расстройство

1. Определение и нозология

Периодическое эксплозивное расстройство (IED; МКБ-11: 6C73 Интермиттирующее взрывное расстройство; DSM-5-TR: F63.81) — повторяющиеся, неконтролируемые вербальные или физические вспышки агрессии; непропорционально интенсивные по отношению к провоцирующему стимулу. После эпизода — сожаление или стыд.

2. История

- DSM-III (1980) — IED официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — критерии уточнены.
- МКБ-11 (2019) — в рамках расстройств контроля импульсов.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: 4–7% (Kessler R.C. et al. Arch Gen Psychiatry 2006).
- Пол: выше у мужчин.
- Начало: средний подростковый возраст.
- Коморбидность: БДР ~70%, тревога, употребление ПАВ, ПРЛ, АСРЛ.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40%.
- Дисрегуляция серотонина — эффект СИОЗС.
- История травмы и насилия.
- Нарушение регуляции коры-амигдалы.

5. Клиническая картина

- Повторяющиеся вспышки агрессии — вербальные (крик, угрозы) или физические (повреждение предметов, вред другим).
- Вспышка выходит из-под контроля — пациент не может сдержаться.
- Триггер минимальный или незначительный.
- После акта — сожаление, стыд, чувство вины.
- Отношения, работа, правовые последствия.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

А. Один из следующих:

1. Вербальные или физические вспышки агрессии без разрушительного ущерба, ≥ 2 раз в неделю, ≥ 3 месяцев;
2. Три или более разрушительных/повреждающих взрыва в течение 12 месяцев.

B. Агрессия, несоразмерная триггеру.

C. Импульсивный (не спланированный) и не для конкретной цели.

D. Значительный дистресс или функциональные нарушения

E. Хронологический возраст ≥ 6 лет.

F. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (маниакальное, АСРЛ, ПРЛ, расстройство поведения); исключение воздействия вещества.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — критерий A1 (лёгкий) и A2 (деструктивный) раздельно.
- МКБ-11 — нет ни частоты, ни возраста: DSM-5-TR требует деления A1/A2, дважды в неделю три месяца либо три разрушительных эпизода за 12 месяцев и возраст ≥6 лет; в МКБ-11 ничего из этого нет.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информация от семьи.
2. Шкала — OAS (англ. Overt Aggression Scale), BPAQ (англ. Buss-Perry Aggression Questionnaire).
3. Коморбидность и исключение медицинских причин (поражение лобной доли, эпилепсия, гипогликемия).
4. Токсикологический скрининг.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
АСРЛ (антисоциальное расстройство личности)	Планируемая агрессия, отсутствие раскаяния.
ПРЛ	Эмоциональная лабильность и отношения — основные.
Маниакальный эпизод	В контексте аффективного эпизода.
Расстройство поведения (6C91)	Множественное антисоциальное поведение.
ОВР (6C90)	Стойкий оппозиционный компонент; присутствует агрессия, но вспышки не являются основными.

Состояние	**Отличительный признак**
Патология лобной доли	Неврологическое обследование.
Вещество-индуцированная агрессия	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- OAS, BPAQ.
- Медицинское и неврологическое обследование.
- Токсикологический скрининг.
- Шкалы для оценки коморбидности.

8. Лечение

1. Флуоксетин (СИОЗС) — Coccaro E.F. et al. J Clin Psychiatry 2009 РКИ — наиболее доказанная фармакотерапия при ИВР; 20–60 мг/сут.
2. КПТ — управление гневом, когнитивная реструктуризация, поведенческая активация, релаксация. McCloskey M.S. et al. J Consult Clin Psychol 2008.
3. Нормотимики — вальпроат, литий (off-label при рефрактерности).
4. Лечение коморбидного расстройства.
5. При необходимости правовой координации.

8.1 Методики лечения

1. Флуоксетин — СИОЗС; при ИВР доказательная база РКИ Coccaro.
2. КПТ для управления гневом — Идентификация триггеров, когнитивная реструктуризация, тайм-аут, релаксация, решение проблем.
3. Шкала явной агрессии (англ. Overt Aggression Scale, OAS) — Шкала тяжести агрессии.

8.2 Различия между источниками

- Coccaro J Clin Psychiatry 2009 — флуоксетин доказан.
- McCloskey 2008 — эффективность КПТ.

9. Прогноз

- Значительное улучшение при применении флуоксетина и КПТ.
- Коморбидное АСРЛ, употребление ПАВ — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ИВР — это обычная „потеря контроля“»

Доказательства: клинический диагноз на основе частоты и функциональных нарушений.

Миф 2: «Пациент может прекратить „по собственной воле“»

Доказательства: расстройство контроля импульсов — неудачный контроль является клинической особенностью; требуется доказательное лечение (флуоксетин, КПТ).

Миф 3: «Бензодиазепины успокаивают агрессию»

Доказательства: бензодиазепины вызывают парадоксальную дезингибицию; при ИВР противопоказаны или применяются с осторожностью.

Миф 4: «Эффективно только правовое наказание»

Доказательства: только юридическое наказание неэффективно; требуется клиническое лечение.

Миф 5: «Антипсихотик первой линии»

Доказательства: СИОЗС — первая линия; антипсихотик — при рефрактерных случаях.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C73 Intermittent explosive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Coccaro E.F. et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of fluoxetine in patients with intermittent explosive disorder. J Clin Psychiatry 2009;70(5):653–662.
4. McCloskey M.S. et al. Cognitive-behavioral therapy for intermittent explosive disorder. J Consult Clin Psychol 2008;76(5):876–886.
5. Kessler R.C. et al. The prevalence and correlates of DSM-IV intermittent explosive disorder. Arch Gen Psychiatry 2006;63(6):669–678.

6C90–6C9Z ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Disruptive behaviour or dissocial disorders

МКБ-11 **6C91**	**6C91** **ДИССОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Conduct-dissocial disorder**
МКБ-10 F91	Расстройства поведения
DSM-5-TR F91.1	Расстройство поведения, с началом в детском возрасте

1. Определение и нозология

Диссоциальное поведенческое расстройство (МКБ-11: 6C91 Conduct-Dissocial Disorder; DSM-5-TR: F91.1 Conduct Disorder) — стойкий и повторяющийся паттерн нарушения прав других людей или соответствующих возрасту социальных норм. Типично начинается в детстве/подростковом возрасте; во взрослом возрасте может перейти в АСРЛ.

2. История

- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — квалификатор «limited prosocial emotions» (детский маркер психопатических черт).
- NICE CG158 (2017) — антисоциальное поведение детей и подростков.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 12-месячная 2–10%, медиана 4%; у мальчиков выше, чем у девочек (DSM-5-TR).
- Пол: у мужчин в 3 раза выше.

- Начало — детство (до 10 лет, плохой прогноз) или подростковый возраст (10+ лет, хороший прогноз).
- Коморбидность: СДВГ 50%, ОВР, БДР, тревога, употребление ПАВ, расстройства обучения.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–60%.
- Нейробиологически — дисрегуляция миндалевидного тела, префронтальной коры, низкое симпатическое возбуждение.
- Среда — детская травма, строгий родительский опыт, семейная дисфункция, сверстники.
- Пренатально — табак, алкоголь.

5. Клиническая картина

DSM-5-TR 15 симптомов в 4 категориях (≥ 3 симптома за 12 мес.)

- Агрессия — к людям/животным: угрозы, нападение, применение оружия, физическое насилие, сексуальное насилие.
- Повреждение предмета: умышленный поджог, повреждение других предметов.
- Обман/кража: проникновение в жилище, ложь, воровство.
- Серьёзное нарушение правил: опоздания, побеги из дома, прогулы школы (truancy).

Квалификатор «ограниченные просоциальные эмоции» (психопатические черты).

- Отсутствие эмпатии или раскаяния;
- Безразличие к собственной успеваемости;
- Аффективная тупость (англ. callous lack of emotion);
- Поверхностный аффект.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR (≥ 3 симптома из 15 за 12 мес.; как минимум 1 симптом за последние 6 мес.). Степень тяжести: лёгкая, средняя, тяжёлая.

Начало: детский тип (≥ 1 симптом до 10 лет), подростковый тип.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — квалификатор «limited prosocial emotions».
- МКБ-11 — «Conduct-Dissocial Disorder»; по паттернам детей, подростков, взрослых.
- NICE CG158 — диагностика и вмешательство у детей и подростков.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + родитель, учитель.
2. Структурированное интервью (K-SADS).
3. CBCL (англ. Child Behavior Checklist), TRF (англ. Teacher Report Form).
4. ICU (англ. Inventory of Callous-Unemotional Traits) — для психопатических черт.
5. Коморбидность (СДВГ, БДР, ПАВ, нарушения обучения).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ОВР (6C90)	Лёгкие, без серьёзного нарушения закона.
СДВГ (6A05)	Импульсивность и внимание; коморбидность частая.
IED (6C73)	Взрывной характер является основным; стойкой антисоциальной модели нет.
Маниакальный эпизод	Аффективный контекст.
RAD/DSED (6B44/6B45)	Нарушение привязанности с детства.
Индуцированное веществом	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- CBCL, TRF, ICU.
- Скрининг коморбидности.
- Интеллектуальная и академическая оценка.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG158 · AACAP)

1. Обучение родителей (англ. parent training programs) — первая линия для возраста 3–11 лет:
    - Incredible Years (Webster-Stratton);
    - PCIT (англ. Parent-Child Interaction Therapy);
    - Triple P.
2. Для подростков:
    - MST — Мультисистемная терапия (Henggeler S.W.) — охватывает семью, сверстников, школу, сообщество;
    - FFT — Функциональная семейная терапия;
    - MTFC — Многомерная патронатная семья (англ. Multidimensional Treatment Foster Care).
3. Коморбидный СДВГ — стимулятор (также снижает агрессию).
4. Антипсихотик (рисперидон) — off-label при тяжёлой агрессии, с осторожностью; одобрения FDA нет (специфически для детской агрессии).
5. «Scared Straight» и подобные программы контрпродуктивны — Cochrane (Petrosino A. 2013) — они увеличивают антисоциальное поведение.
6. Программы типа «boot camp» («жёсткая любовь») — доказательств нет, вредны.

8.2 Методики лечения

1. Программа «Incredible Years» — Вебстер-Страттон (Webster-Stratton) — групповая программа для родителей детей 3–8 лет; 14–22 сессии.
2. Терапия взаимодействия родителя и ребёнка (англ. Parent-Child Interaction Therapy, PCIT) — 4–7 лет; CDI + PDI.
3. Многосистемная терапия (англ. Multisystemic Therapy, MST) — Домашнее мультисистемное вмешательство для подростков; доказательная база сильна при тяжёлых поведенческих расстройствах.
4. Функциональная семейная терапия (англ. Functional Family Therapy, FFT) — Семейно-ориентированная, 8–30 сеансов.
5. Многомерная патронатная терапия (MTFC — Multidimensional Treatment Foster Care) — Структурированная программа патронатного воспитания; при тяжёлом случае.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG158 (2017).
- AACAP Practice Parameter (Steiner H. 2007).
- Cochrane (Petrosino 2013) — Scared Straight контрпродуктивен.

9. Прогноз

- При детском типе и психопатических чертах — риск ASPD во взрослом возрасте ~40–50%.
- Подростковый тип имеет хороший прогноз.
- Раннее обучение родителей и мультисистемное вмешательство улучшают исходы.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Суровое наказание/дисциплина — самое эффективное вмешательство»

Доказательства: строгое наказание усиливает антисоциальное поведение; доказан позитивный родительский тренинг.

Миф 2: «Программы „Scared Straight“ „исправляют“ подростков»

Доказательства: Petrosino A. Cochrane 2013 — Scared Straight увеличивает антисоциальное поведение (ОШ 1,68; 95% ДИ 1,20–2,36); противопоказано; в СМИ иногда представляется как «эффективный», но мета-анализ показывает негативный эффект.

Миф 3: «Расстройство поведения обязательно переходит в АСРЛ»

Доказательства: ~50% случаев подросткового типа ремиссия; плохой прогноз при детском типе и психопатических чертах.

Миф 4: «Стимулянты усиливают агрессию»

Доказательства: при коморбидном СДВГ стимуляторы снижают агрессию; применяются под контролем поведения и побочных эффектов.

Миф 5: «Boot camp или военная среда излечивают тяжёлое CD»

Доказательства: доказательств нет; в некоторых исследованиях отмечена обратная эффективность.

Миф 6: «Антипсихотик — стандартная первая линия»

Доказательства: обучение родителей и психосоциальные подходы первой линии; рисперидон при тяжёлых рефрактерных случаях off-label.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C91 Conduct-dissocial disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG158. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition and management. 2017.
4. Steiner H., Remsing L. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Conduct Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(1):126–141.
5. Petrosino A. et al. «Scared Straight» and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database Syst Rev 2013; (4):CD002796.
6. Henggeler S.W. Multisystemic Therapy. Guilford Press; 1998.
7. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345–379.

МКБ-11 **6C90**	**6C90 ОППОЗИЦИОННО-ВЫЗЫВАЮЩЕЕ РАССТРОЙСТВО (ОВР)** **Oppositional defiant disorder**
МКБ-10 F91.3	Вызывающее оппозиционное расстройство
DSM-5-TR F91.3	Оппозиционно-вызывающее расстройство

1. Определение и нозология

Оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР; МКБ-11: 6C90 Оппозиционно-вызывающее расстройство; DSM-5-TR: F91.3) — паттерн гневливого/раздражительного настроения, вызывающего/упрямого или

мстительного поведения. В отличие от расстройства поведения (CD), отсутствует посягательство на фундаментальные права других.

2. История

- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — эмоциональный компонент (гнев/раздражительность) выделен отдельно.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 1–11 % (в среднем 3,3 %) у детей дошкольного и школьного возраста (DSM-5-TR).
- Пол: выше у мальчиков препубертатного возраста; после пубертата разница уменьшается.
- Коморбидность: СДВГ ~40–60%, БДР, тревога, переход в CD 30% (при тяжёлом детском типе).

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 50%.
- Среда — строгий родительский опыт, семейная дисфункция.
- Нейробиологически — аффективная регуляция, фронтально-амигдалярный контур.
- Темпераментальные факторы (раздражительность).

5. Клиническая картина

8 симптомов в 3 категориях (≥ 4 симптомов в течение 6 месяцев)

- Гневливое/раздражительное настроение: вспыльчивый; раздражительный; гневливый, недовольный.
- Драчливое/упрямое поведение: споры со взрослыми; неподчинение правилам; преднамеренное раздражение других; обвинение других.
- Мстительное поведение: не менее 2 раз за последние 6 месяцев.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

DSM-5-TR — ≥ 4 симптома из 8 в течение 6 мес.; как минимум в одном контексте (дом, школа, сверстники); как минимум с одним другим лицом в другом контексте.

Возрастной квалификатор: до 5 лет симптомы в большинстве дней в течение 6 месяцев; 5+ лет — ≥ 1 раза в неделю в течение 6 месяцев.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — тяжесть (лёгкая, средняя, тяжёлая) по количеству контекстов.
- NICE CG158 — руководство по антисоциальному поведению детей.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + родитель, учитель.
2. CBCL, TRF, ECBI (англ. Eyberg Child Behavior Inventory).
3. Скрининг коморбидного СДВГ.
4. Различие между Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) и депрессивным расстройством.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
CD (6C91)	Тяжёлое правонарушение.
СДВГ	Внимание/импульсивность; коморбидность часта.
DMDD (DSM-5)	Стойкая раздражительность + тяжёлые вспышки гнева, ≥ 12 месяцев (без бессимптомного периода ≥ 3 месяцев подряд); при одновременном соответствии критериям ODD ставится только диагноз DMDD.
Тревожное расстройство	Тревожный компонент доминирует.
Интеллектуальная недостаточность	Поведенческие нарушения в контексте когнитивного дефицита.

Состояние	Отличительный признак
Соответствующее возрасту «детское сопротивление»	Функциональное нарушение отсутствует.

7. Обследование и оценка

- ECBI, CBCL.
- Коморбидный СДВГ, тревога, БДР.

8. Лечение

1. Обучение родителей — первая линия:
    - PCIT — 2–7 лет;
    - Incredible Years — 3–8 лет;
    - Parent Management Training (Barkley) — 6+ лет;
    - Triple P.
2. Коморбидный СДВГ — стимулятор.
3. СИОЗС — при коморбидной тревоге/депрессии.
4. Школьное вмешательство.
5. Подозрение на жестокое обращение с ребёнком или насилие в семье — защита ребёнка и координация с социальной службой.

8.1 Методики лечения

1. Терапия взаимодействия родителя и ребёнка (PCIT) — Коучинг терапевта в реальном времени.
2. Программа «Incredible Years» — Групповой формат.
3. Triple P — Программа позитивного родительства (англ. Positive Parenting Program) — 5-уровневая система.
4. Тренинг управления родителями (англ. Parent Management Training) — Баркли (Barkley) — Обучение на основе поведенческих принципов.
5. Опросник детского поведения Айберг (ECBI — Eyberg Child Behavior Inventory) — Шкала поведения, оцениваемая родителями.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG158.
- AACAP — обучение родителей.

9. Прогноз

- Большинство пациентов улучшаются при раннем обучении родителей.
- Коморбидный СДВГ, тяжёлый вариант — риск CD/АСРЛ.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ОВР — это обычное „упрямое“ поведение ребёнка»

Доказательства: клинический диагноз на основе функциональных нарушений и частоты; отличается от нормального возрастного варианта.

Миф 2: «Строгая дисциплина исправит ОВР»

Доказательства: строгое наказание усиливает симптомы; доказан позитивный родительский тренинг.

Миф 3: «Антипсихотик — первая линия»

Доказательства: обучение родителей первой линии; антипсихотики в редких рефрактерных случаях.

Миф 4: «ODD всегда переходит в CD»

Доказательства: Переход в CD у 30%; риск выше при детском типе и коморбидности; большинство не переходит в CD.

Миф 5: «Лечить нужно только ребёнка, а не семью»

Доказательства: обучение родителей — центральный компонент; психотерапия только с ребёнком малоэффективна.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6C90 Oppositional defiant disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG158. 2017.
4. AACAP Practice Parameter (Steiner 2007).
5. Eyberg S.M. et al. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with disruptive behavior. J Clin Child Adolesc Psychol 2008;37(1):215–237.
6. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345–379.

6D10–6D1Z РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

Personality disorders and related traits

МКБ-11 **6D10**	**6D10 РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ** **Personality disorder**
МКБ-10 F60.9	Расстройство личности неуточнённое
DSM-5-TR F60.9	Неуточнённое расстройство личности

1. Определение и нозология

Расстройство личности (МКБ-11: 6D10 Personality Disorder; DSM-5-TR: F60.9; 10 категорий) — устойчивый и всепроникающий паттерн в личном и социальном функционировании: в мыслях, чувствах и поведении по отношению к себе и другим. МКБ-11 принципиально перешла к модели «единая категория + степени тяжести + домены черт»; классические 10 отдельных расстройств личности (параноидное, шизоидное, ПРЛ, АСРЛ и др.) как категориальные диагнозы упразднены.

2. История

- DSM-III (1980) — категориальные 11 расстройств личности (кластеры A, B, C).
- DSM-IV (1994), DSM-5-TR (2022) — сохраняется та же категориальная модель; однако в разделе III DSM-5 в исследовательской категории — альтернативная «дименсиональная» модель.
- МКБ-11 (2019) — радикальное изменение: категориальные 10 расстройств отменены, единое расстройство личности (лёгкое, умеренное, тяжёлое + Personality Difficulty) + оценка по 5 доменам черт.

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: ~9% (Lenzenweger M.F. et al. Biol Psychiatry 2007); ПРЛ ~1,4%, АСРЛ ~1%, шизоидное 3%.
- Пол: BPD у женщин в клинических популяциях; ASPD выше у мужчин.
- Начало: подростковый возраст и ранняя взрослость.
- Смертность: при ПРЛ суицид 8–10% пожизненно; при АСРЛ насильственная смерть.
- Коморбидность: БДР, тревога, употребление ПАВ, расстройства пищевого поведения.

4. Этиология и патогенез

- Наследуемость 40–60%.
- Ранняя травма, жестокое обращение в детстве (особенно при ПРЛ).
- Дезорганизованная привязанность.
- Нейробиологически — фронтально-лимбическая регуляция, серотонинергическая дисрегуляция.

5. Клиническая картина

5.1 МКБ-11: 5 доменов признаков

- Негативная аффективность — тревога, депрессия, лабильность.
- Отгороженность (Detachment) — социальная и эмоциональная отстранённость.
- Диссоциальность — отсутствие эмпатии, эгоцентризм.
- Расторможенность — импульсивность, безответственность.
- Ананкастность — перфекционизм, контроль, жёсткие правила.

Модель пограничного расстройства личности — в МКБ-11 представлена как отдельный квалификатор (соответствует ПРЛ, заменяя 10 отдельных категориальных диагнозов).

5.2 DSM-5-TR: 10 категориальных расстройств (кратко)

- Кластер A (странные/эксцентричные): Параноидное, Шизоидное, Шизотипическое.
- Кластер B (драматичные/неустойчивые): Antisocial (ASPD), Borderline (BPD), Histrionic, Narcissistic.

- Кластер C (тревожные/боязливые): Avoidant, Dependent, Obsessive-Compulsive (OCPD).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (МКБ-11)

A. Стойкая и распространённая дисфункция личности — в функциях, относящихся к себе (идентичность, самооценка, саморегуляция) или межличностных (отношения, эмпатия, интимность, ответственность).

B. Длительность — долгосрочная (годы).

C. Не соответствует возрасту развития, культурным нормам, семейной ситуации.

D. Тяжесть: Трудность личности (субклиническая), Лёгкое ЛР, Умеренное ЛР, Тяжёлое ЛР.

E. Квалификаторы домена признаков (выше).

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11: радикальное изменение категориальной системы; требует обучения в клинической практике.
- DSM-5-TR: Сохраняются 10 категориальных диагнозов; Section III — альтернативная модель.
- NICE CG78 (BPD), CG77 (ASPD): Отдельные клинические рекомендации для BPD и ASPD.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + длительный анамнез.
2. SCID-5-PD (категориальная DSM) или ICD-11 PD assessment.
3. Шкалы личности — PID-5 (дименсиональная DSM-5), MMPI-2-RF.
4. Коморбидность (БДР, ПАВ, травма).
5. Риск суицида и насилия.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Изменение в контексте аффективного эпизода	Эпизодическое течение; личность стабильна.

Состояние	Отличительный признак
Индуцированное веществом	Анамнез употребления веществ.
ПТСР / комплексное ПТСР	В контексте травмы; клиническое перекрытие при ПРЛ.
Биполярное расстройство	Аффективные эпизоды.
Медицинское состояние (лобная доля, деменция)	Неврологическое обследование.

7. Обследование и оценка

- SCID-5-PD, PID-5.
- MMPI-2-RF, MCMI-IV.
- Коморбидность и суицид.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG78 (ПРЛ), CG77 (АСРЛ); APA 2024 (ПРЛ, 2-е изд.))

1. Психотерапия — метод первой линии при расстройствах личности.
2. Доказательные подходы для BPD (5):
    - DBT (англ. Dialectical Behavior Therapy, Linehan M.) — эмоциональная регуляция, толерантность к дистрессу, социальные навыки, mindfulness; стандартно 12 месяцев;
    - MBT (англ. Mentalization-Based Treatment, Bateman A., Fonagy P.);
    - Schema Therapy (Young J.)
    - TFP (Transference-Focused Psychotherapy, Kernberg O.)
    - STEPPS (англ. Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving).
3. Для АСРЛ — терапевтическое ограничение; КПТ у структурированного, мотивированного пациента.
4. Фармакотерапия — специфического одобрения для самого расстройства личности нет; при коморбидных симптомах (импульсивность, депрессия, тревога, психозоподобные) — СИОЗС, нормотимики, атипичные антипсихотики в низких дозах.
5. Кризис-менеджмент — DBT skills, краткосрочная госпитализация.

6. Длительное лечение (годы).

8.2 Методики лечения

1. Диалектическая поведенческая терапия (англ. Dialectical Behavior Therapy, DBT) — Linehan M. — 4 модуля (осознанность, толерантность к дистрессу, эмоциональная регуляция, социальные навыки); индивидуально + группа + телефонный коучинг + консультация терапевта. Стандартно 12 месяцев. Доказательства: Linehan M.M. JAMA Psychiatry 2015.
2. Терапия, основанная на ментализации (англ. Mentalization-Based Therapy, MBT) — Бейтман (Bateman A.), Фонаги (Fonagy P.) — Ментализация — распознавание психических состояний своих и других; основана на психодинамических корнях. Bateman A. Am J Psychiatry 2009.
3. Схема-терапия (англ. Schema Therapy) — Янг (Young J.) — Перестройка ранних дезадаптивных схем; долгосрочная психотерапия.
4. Терапия, фокусированная на переносе (TFP — Transference-Focused Psychotherapy) — Кернберг (Kernberg O.) — Проработка примитивных защитных механизмов в контексте переноса.
5. STEPPS — 20-недельная группа; участие также социальной системы пациента с ПРЛ.
6. Структурированное клиническое интервью для расстройств личности (SCID-5-PD) — Категориальный диагноз по DSM-5.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG78 (ПРЛ, 2009) — DBT, MBT и аналогичные структурированные подходы; фармакотерапия не рекомендуется рутинно для самого ПРЛ.
- NICE CG77 (ASPD, 2009).
- APA Practice Guideline for the Treatment of Patients With Borderline Personality Disorder, 2nd ed. (2024) — заменило издание 2001 года.

9. Прогноз

- BPD — 50%+ ремиссия при 10-летнем наблюдении (обзоры Zanarini M.C.).
- АСРЛ — самый плохой прогноз; однако с возрастом агрессия уменьшается.
- Лечение улучшает прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Расстройства личности не лечатся»

Доказательства: DBT, MBT, Schema, TFP — доказательные подходы; большинство пациентов значительно улучшаются; пессимистическая прогностическая позиция устарела.

Миф 2: «Пациенты с BPD манипулятивны и требуют жёстких границ»

Доказательства: Термин «манипулятивный» стигматизирующий и ошибочный; поведение при ПРЛ обусловлено нарушением эмоциональной регуляции; DBT рекомендует баланс валидации и структуры.

Миф 3: «Фармакотерапия излечивает ПРЛ»

Доказательства: NICE CG78 — фармакотерапия не рекомендуется рутинно для самого ПРЛ; психотерапия первой линии.

Миф 4: «АСРЛ не поддаётся лечению»

Доказательства: при тяжёлом АСРЛ вмешательство ограничено, но у мотивированного пациента структурированное лечение может дать улучшение; нигилистическая позиция противопоказана.

Миф 5: «С возрастом расстройство личности стабилизируется и не требует лечения»

Доказательства: Долгосрочное наблюдение — уровень ремиссии ПРЛ 50%+ за 10 лет; лечение ускоряет этот процесс.

Миф 6: «Гипнотерапия, эзотерические вмешательства излечивают расстройства личности»

Доказательства: доказательств нет; рекомендуется доказательная структурированная психотерапия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D10 Personality disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG78. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009.
4. NICE CG77. Antisocial personality disorder: prevention and management. 2009.

5. Linehan M.M. et al. Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: a randomized clinical trial and component analysis. JAMA Psychiatry 2015;72(5):475–482.
6. Bateman A., Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for BPD. Am J Psychiatry 2009;166(12):1355–1364.
7. Zanarini M.C. et al. Prediction of the 10-year course of borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2006;163(5):827–832.
8. Tyrer P., Reed G.M., Crawford M.J. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet 2015;385(9969):717–726.
9. Young J.E., Klosko J.S., Weishaar M.E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. New York: Guilford Press, 2003.
10. Yeomans F.E., Clarkin J.F., Kernberg O.F. Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington: American Psychiatric Publishing, 2015.
11. Lenzenweger M.F., Lane M.C., Loranger A.W., Kessler R.C. DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007;62(6):553–564.

МКБ-11 **6D11**	**6D11 ВЫРАЖЕННЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛИ ОСОБЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ** **Prominent personality traits or patterns**
МКБ-10 —	Эквивалента в МКБ-10 нет
DSM-5-TR F60.3	Пограничное расстройство личности (соответствует только квалификатору 6D11.5 «пограничный паттерн»)

1. Определение и нозология

Выраженные личностные особенности или особые паттерны поведения (МКБ-11: 6D11 Prominent personality traits or patterns) — не самостоятельный

диагноз, а набор квалификаторов: они указывают, какими доменами черт проявляется расстройство личности (6D10) или личностная трудность. Степень тяжести кодируется в 6D10, домены — здесь; 6D11 изолированно не выставляется.

Личностная трудность (Personality difficulty) в МКБ-11 не является психическим расстройством — она находится в главе «Факторы, влияющие на состояние здоровья» под кодом QE50.7. Черты личности создают функциональные затруднения, но не достигают критериев 6D10.

2. История

- МКБ-11 (2019) — отказ от 10 категориальных расстройств личности; вместо них степень тяжести (6D10) и пять доменов черт (6D11.0–6D11.4).
- Отдельно добавлен 6D11.5 «пограничный паттерн» — преемник пограничного расстройства личности МКБ-10 (F60.3); в DSM-5-TR параллель — только размерная модель раздела III.

3. Эпидемиология

Точные эпидемиологические данные ограничены; субклинические личностные черты широко распространены в популяции.

4. Этиология и патогенез

То же, что и 6D10 — генетическое и средовое взаимодействие.

5. Клиническая картина

- 6D11.0 Негативная аффективность — широкий спектр негативных эмоций: тревожность, раздражительность, неуверенность в себе, эмоциональная лабильность.
- 6D11.1 Отгороженность — социальная и эмоциональная дистанция: избегание, ограниченный аффект, отказ от близости.
- 6D11.2 Диссоциальность — пренебрежение правами и чувствами других: эгоцентризм, дефицит эмпатии, эксплуататорство.
- 6D11.3 Расторможенность — импульсивность, невнимательность, безответственность, тяга к немедленному вознаграждению.
- 6D11.4 Ананкастность — перфекционизм, жёсткие правила, эмоциональный и поведенческий контроль.

- 6D11.5 Пограничный паттерн (borderline pattern) — нестабильность отношений, образа себя и аффекта, импульсивность, страх покинутости, самоповреждение и суицидальное поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Диагноз ставится по 6D10 (расстройство личности) или QE50.7 (личностная трудность); 6D11 добавляется только как квалификатор.

B. Отмечаются все домены, выраженные в клинически значимой степени, — их может быть несколько.

C. «Пограничный паттерн» (6D11.5) может отмечаться дополнительно к любому набору доменов.

6.2 Различия между источниками

МКБ-11 — категория, своего рода «клиническое внимание к проблемам личности», похожая на Z-код.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Оценка по 5 доменам.
3. Исключение полного диагноза ПД.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Personality Disorder (6D10)	Значительные функциональные нарушения
Расстройство адаптации (6B43)	Реакция на стрессовый фактор.
Вариант нормальной личности	Функциональных трудностей нет.

7. Обследование и оценка

Шкалы личности (PID-5).

8. Лечение

1. Психотерапия — кратко-среднесрочная; проблемно-фокусированная КПТ или поддерживающая.
2. Управление стрессом и копинг-навыки.
3. Специфическая интервенция при коморбидных симптомах.

8.1 Методики лечения

1. DSM-5 — Личностный опросник (англ. Personality Inventory for DSM-5, PID-5) — Многомерная шкала личности.

9. Прогноз

Улучшение на фоне лечения; риск стабилизации или прогрессирования до полной БП.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Личностная трудность — это не настоящий диагноз»

Доказательства: МКБ-11 — официальный код; обеспечивает клиническое внимание к субклиническим проблемам личности.

Миф 2: «Трудность личности обязательно переходит в РЛ»

Доказательства: у некоторых пациентов развитие, но большинство стабильны или улучшаются.

Миф 3: «Лечить нужно только лекарствами»

Доказательства: психотерапия первой линии; фармакотерапия при коморбидных симптомах.

Миф 4: «Эта категория нужна только для навешивания ярлыка на „тревожных“ пациентов»

Доказательства: МКБ-11 — клинический ответ на функциональную трудность; обеспечивает клиническую поддержку.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D11 Prominent personality traits or patterns. 2024.
2. WHO. ICD-11. QE50.7 Personality difficulty. 2024.
3. Tyrer P. et al. Lancet 2015;385(9969):717–726.

6D30–6D3Z ПАРАФИЛИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Paraphilic disorders

МКБ-11 **6D30**	**6D30** **ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСГИБИЦИОНИЗМ** **Exhibitionistic disorder**
МКБ-10 F65.2	Эксгибиционизм
DSM-5-TR F65.2	Эксгибиционистское расстройство

1. Определение и нозология

Патологический эксгибиционизм (МКБ-11: 6D30 Exhibitionistic Disorder; DSM-5-TR: F65.2) — стойкое или интенсивное сексуальное возбуждение от обнажения гениталий перед не дающими согласия лицами; пациент испытывает значительный дистресс или функциональные нарушения в ответ на эти фантазии, импульсы или поведение, и/или реализует их с реальными лицами.

2. История

- Lasègue C. (1877) — термин «exhibitionnistes».
- DSM-III (1980) — официальный диагноз.
- DSM-5 (2013) — разграничение парафилии (атипичный сексуальный интерес) и парафилического расстройства (клинический дистресс или вред другим).
- WFSBP 2020 (Thibaut F. et al.) — международные рекомендации по парафилическим расстройствам.

3. Эпидемиология

- Распространённость: у мужчин 2–4%; у женщин редко.

- Начало: подростковый возраст и ранняя взрослость.
- Коморбидность: другие парафилии (50–80% пациентов с парафилическим расстройством), АСРЛ, употребление ПАВ, БДР.

4. Этиология и патогенез

- Множественные факторы — биологические, поведенческие (кондиционирование), психосоциальные.
- Коморбидная импульсивность и гиперсексуальность.

5. Клиническая картина

- Повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение при обнажении гениталий перед лицами, не давшими согласия.
- Пациент реализует фантазию, импульс или поведение, или испытывает дистресс.
- Типичный контекст — улица, общественный транспорт.
- Правовые и общественные последствия (сексуальное преступление).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 6 месяцев повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от обнажения гениталий перед лицами без их согласия.

B. Пациент реализовал фантазию/импульсы или испытывает значительный дистресс/функциональное нарушение.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR требует срок 6 месяцев; в МКБ-11 критерия срока нет — сказано «устойчивый, сфокусированный и интенсивный паттерн возбуждения».
- WFSBP 2020 — ступенчатая терапия парафилических расстройств.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Коморбидность (АСРЛ, ПАВ, другие парафилии).
3. Оценка риска (судебный контекст).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Гиперсексуальность	Партнёры, давшие согласие.
Маниакальный эпизод	Аффективный контекст.
Деменция	Дисфункция фронтальной доли с расторможенностью.
Индуцированное веществом	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- Клиническое интервью.
- Шкалы риска (Static-99R для сексуального рецидивизма).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (WFSBP 2020, поэтапно)

1. КПТ и когнитивно-поведенческая интервенция — первая линия; предотвращение рецидива, управление когнитивными искажениями.
2. СИОЗС — в высоких дозах (флуоксетин 40–80 мг); снижает импульсивность и сексуальное влечение.
3. Рефрактерное / тяжёлое состояние — антиандроген (ЦПА — ципротерон, МПА — медроксипрогестерон).
4. В наиболее тяжёлых случаях — агонист ГнРГ (лейпролид, трипторелин) — химическая кастрация; постоянное наблюдение.
5. Медико-правовая координация.

8.2 Методики лечения

1. КПТ (профилактика рецидива) — Управление триггерами, когнитивное искажение.
2. СИОЗС в высокой дозе — Первая линия фармакотерапии.
3. Антиандроген (ЦПА, МПА) — В рефрактерных случаях.
4. Агонист ГнРГ — В наиболее тяжёлом случае.

8.3 Различия между источниками

- WFSBP 2020 — ступенчатый алгоритм.

9. Прогноз

Снижение рецидивов при доказанном лечении; коморбидное АСРЛ и употребление веществ — плохой прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Эксгибиционизм безвреден»

Доказательства: психологическая травма для жертвы; половое преступление; риск развития более тяжёлых парафилий.

Миф 2: «Химическая кастрация — первая линия»

Доказательства: WFSBP 2020 пошаговый — КПТ и СИОЗС в первую очередь; аГнРГ в наиболее тяжёлых случаях.

Миф 3: «Лечение неэффективно»

Доказательства: КПТ и фармакотерапия значительно снижают рецидивы.

Миф 4: «Требуется только правовое наказание»

Доказательства: клиническое вмешательство снижает риск рецидива.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D30 Exhibitionistic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.

МКБ-11 **6D31**	**6D31** **ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ВУАЙЕРИЗМ** **Voyeuristic disorder**
МКБ-10 F65.3	Вуайеризм

МКБ-11 **6D31**	**6D31** **ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ВУАЙЕРИЗМ** **Voyeuristic disorder**
DSM-5-TR F65.3	Вуайеристское расстройство

1. Определение и нозология

Патологический вуайеризм (МКБ-11: 6D31 Voyeuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.3) — устойчивое и интенсивное сексуальное возбуждение от наблюдения за раздеванием, обнажением или сексуальной активностью лиц без их согласия; пациент испытывает дистресс в ответ на эти фантазии или реализует их с лицами без согласия.

2. История

Вуайеризм в клинической литературе описан параллельно с эксгибиционизмом (6D30).

3. Эпидемиология

- Распространённость: точные популяционные данные неизвестны; DSM-5-TR, опираясь на вуайеристские действия в неклинических выборках, указывает максимально возможную пожизненную распространённость ~12% у мужчин и ~4% у женщин (Långström N., Seto M.C. Arch Sex Behav 2006, n=2450). Большинство лиц с вуайеристским поведением не соответствуют критериям расстройства.
- Коморбидные другие парафилические расстройства.
- Интернет-вуайеризм (скрытая камера, «апскёрт») развивается.

4. Этиология и патогенез

Общая этиология парафилических расстройств.

5. Клиническая картина

- Тайное наблюдение за обнажёнными лицами или за сексуальной активностью лиц, не давших согласия.

- Типичный контекст — окна, примерочные, общественные места.
- «Апскёртинг» — современная форма.
- Правовые последствия.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 6 месяцев повторяющееся сексуальное возбуждение от наблюдения за лицами без их согласия.

B. Пациент реализовал фантазию или испытывает дистресс.

C. Возраст ≥ 18 (DSM-5-TR; у подростков нормальное любопытство исключается).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR требует срок 6 месяцев; в МКБ-11 критерия срока нет — сказано «устойчивый, сфокусированный и интенсивный паттерн возбуждения».
- WFSBP 2020.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Коморбидность.
3. Оценка риска.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Подростковое любопытство	Часть нормального развития.
Вуайеризм по обоюдному согласию (порно)	Контекст по обоюдному согласию.
Маниакальный эпизод	Аффективный контекст.

7. Обследование и оценка

- Клиническое интервью.
- Шкалы риска.

8. Лечение

1. WFSBP 2020 пошаговый алгоритм (тот же, что и для 6D30):
    - КПТ для профилактики рецидива;
    - СИОЗС высокая доза;
    - Антиандроген;
    - ГнРГ в наиболее тяжёлом случае.
2. Медико-правовая координация.

8.1 Методики лечения

То же, что и 6D30.

9. Прогноз

Снижение рецидивов при доказанном лечении.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Вуайеризм безвреден, жертва остаётся в неведении»

Доказательства: травма при очевидности жертвы; нарушение согласия — половое преступление.

Миф 2: «Использование порнографии — это вуайеризм»

Доказательства: производство и потребление по согласию — не вуайеризм; клинический диагноз фокусируется на несогласных.

Миф 3: «Только интернет-вуайеризм нов, клинического значения нет»

Доказательства: «Апскёртинг», скрытая камера — сексуальное преступление; требуется клиническое и правовое вмешательство.

Миф 4: «Лечение неэффективно»

Доказательства: КПТ и фармакотерапия эффективны.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D31 Voyeuristic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry

(WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.

4. Långström N., Seto M.C. Exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national population survey. Arch Sex Behav 2006;35(4):427–435.

МКБ-11 **6D32**	**6D32 ПЕДОФИЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО** **Pedophilic disorder**
МКБ-10 F65.4	Педофилия
DSM-5-TR F65.4	Педофильное расстройство

1. Определение и нозология

Педофильное расстройство (МКБ-11: 6D32 Pedophilic Disorder; DSM-5-TR: F65.4) — устойчивое и интенсивное сексуальное возбуждение в отношении препубертатных детей (типично < 13 лет) ≥ 6 месяцев; пациент либо совершил сексуальные действия с детьми в ответ на фантазии, либо испытывает значительный дистресс/функциональное нарушение. Пациент минимум 16 лет и как минимум на 5 лет старше жертвы.

Важно: «Педофильный интерес» (парафилия) и «Педофильное расстройство» (клинический диагноз) различны — диагноз требует функционального нарушения и/или вреда ребёнку.

2. История

- Krafft-Ebing (1886).
- DSM-III (1980).
- WFSBP 2020 — международное руководство по парафилиям.

3. Эпидемиология

- Распространённость — точные данные получить сложно (стигматизированная категория); DSM-5-TR приводит 3–5% как наивысшую возможную оценку среди мужчин; истинное педофильное предпочтение ~1%.

- Пол: почти всегда у мужчин.
- Коморбидность: другие парафилии, АСРЛ, БДР, тревога, употребление ПАВ.

4. Этиология и патогенез

- Биологические — аномалии нейроразвития (обзоры Cantor J.M. — IQ, нейроанатомические различия).
- История детской травмы или сексуального насилия (однако большинство лиц с педофильным расстройством сами не были жертвами; концепция «abused-abuser» является полунаучной).
- Коморбидная импульсивность и гиперсексуальность.

5. Клиническая картина

- Препубертатный возраст — устойчивое и интенсивное сексуальное возбуждение по отношению к детям.
- Пациент реализовал фантазию (сексуальное насилие над ребёнком) или испытывает дистресс/функциональное нарушение.
- Подтипы (DSM-5-TR): только вовлечение детей (exclusive type), как детей, так и взрослых (nonexclusive); мужчины/женщины/оба.
- Правовые последствия (преступление).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 6 месяцев повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение по отношению к детям препубертатного возраста (типично ≤ 13 лет).

B. Пациент реализовал фантазию или испытывает значительный дистресс/функциональное нарушение.

C. Пациент ≥ 16 лет, старше жертвы на ≥ 5 лет.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR требует срок 6 месяцев и возрастное правило (пациент ≥16 лет и старше ребёнка ≥5 лет); в МКБ-11 нет ни срока, ни возрастного критерия — исключено лишь поведение между сверстниками, близкими по возрасту.
- WFSBP 2020.

- Структурированная оценка риска в контексте судебной психиатрии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (признание затруднено; пациент может скрывать).
2. Плетизмография полового члена — исследовательский и судебно-медицинский контекст.
3. Судебная оценка риска (Static-99R, STABLE-2007).
4. Коморбидность.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Вещество-индуцированная расторможенность	Токсикологический скрининг.
Деменция (лобная)	Когнитивное снижение, неврологическое.
Интеллектуальная недостаточность	В контексте когнитивного дефицита.
Гиперсексуальность у взрослых	Педофильный фокус отсутствует.
Гебефилия / эфебофилия	Фокус на пубертатный и постпубертатный периоды; отдельной категории в DSM-5-TR нет.

7. Обследование и оценка

- Судебно-психиатрическое клиническое интервью.
- Static-99R, STABLE-2007.
- Плетизмография полового члена (исследовательский метод).
- Коморбидность.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (WFSBP 2020, поэтапно)

1. КПТ и профилактика рецидива — первая линия; управление триггерами, управление когнитивными искажениями, развитие эмпатии.

2. СИОЗС в высокой дозе — первая фармакотерапия — снижает импульсивность и сексуальное влечение.
3. Антиандроген (ЦПА, МПА) — в умеренно-тяжёлых случаях; либидо и сексуальная активность снижаются.
4. Агонист ГнРГ (лейпролид, трипторелин) — химическая кастрация; при наиболее тяжёлых случаях или высоком риске; постоянное наблюдение (остеопороз, метаболические нарушения).
5. Судебное вмешательство и наблюдение в сообществе параллельно.
6. Мультидисциплинарный подход — психиатр, терапевт, социальная служба, юрист.

8.2 Методики лечения

1. КПТ и профилактика рецидивов (англ. Relapse Prevention) — Управление триггерами и контекстом; когнитивное искажение; тренировка эмпатии.
2. СИОЗС в высокой дозе — Первая линия фармакотерапии.
3. Антиандроген (ЦПА, МПА) — Снижение либидо.
4. Агонист ГнРГ — Химическая кастрация; постоянное наблюдение.
5. Static-99R, STABLE-2007 — Судебная оценка риска.

8.3 Различия между источниками

- WFSBP 2020 — Thibaut et al. — пошаговая фармакотерапия.
- STABLE-2007 — динамические факторы риска.

9. Прогноз

- При доказанном лечении контроль поведения улучшается.
- Коморбидное АСРЛ и употребление ПАВ — плохой прогноз.
- Стойкое наблюдение критично.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Педофильный интерес всегда означает насилие над ребёнком»

Доказательства: «Наличие педофильных фантазий» и «совершение насилия над ребёнком» различны; некоторые пациенты никогда не совершают насилия и обращаются за клинической поддержкой (как программа «Dunkelfeld» в Германии).

Миф 2: «Все совершающие сексуальное насилие над детьми — педофилы»

Доказательства: Большинство совершающих сексуальное насилие над детьми не являются педофилами — насилие ситуационное, с иной мотивацией. Педофильный диагноз требует ≥ 6 месяцев устойчивого сексуального возбуждения.

Миф 3: «Химическая кастрация должна быть обязательной для всех пациентов»

Доказательства: WFSBP 2020 пошаговый подход — аГнРГ в наиболее тяжёлых случаях; КПТ и СИОЗС в первую очередь. Этические и юридические оговорки.

Миф 4: «Однажды педофил — навсегда педофил»

Доказательства: сексуальный интерес может быть стабильным, но контроль поведения может значительно улучшиться с помощью КПТ и фармакотерапии.

Миф 5: «Лечение неэффективно»

Доказательства: WFSBP 2020 и мета-анализы — мультимодальное вмешательство снижает рецидивизм.

Миф 6: «Пациент является „жертвой“ детской травмы»

Доказательства: Концепция «abused-abuser» полностью не поддерживается; большинство пациентов не подвергались насилию в детстве; виктимизация не является основой совершения насилия.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D32 Pedophilic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.
4. Cantor J.M. et al. Cerebral white matter deficiencies in pedophilic men. J Psychiatr Res 2008;42(3):167–183.
5. Beier K.M. et al. Encouraging self-identified pedophiles and hebephiles to seek professional help (англ. Prevention Project Dunkelfeld). Child Abuse Negl 2009;33(8):545–549.

МКБ-11 **6D33**	**6D33 ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ САДИЗМ** **Coercive sexual sadism disorder**
МКБ-10 F65.5	Садомазохизм
DSM-5-TR F65.52	Расстройство сексуального садизма

1. Определение и нозология

Патологический принудительный сексуальный садизм (МКБ-11: 6D33 Coercive Sexual Sadism Disorder; DSM-5-TR: F65.52 Sexual Sadism Disorder) — стойкое и интенсивное сексуальное возбуждение от причинения физических или психологических страданий лицу без его согласия. Пациент реализовал фантазию или испытывает значительный дистресс/функциональное нарушение.

Важное различие: практика БДСМ по согласию (Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism/Masochism) — не клиническое расстройство; МКБ-11 подчёркивает это различие.

2. История

- Krafft-Ebing (1886) — термин садизм от Marquis de Sade.
- DSM-5 (2013) — различие между paraphilia и paraphilic disorder.
- МКБ-11 (2019) — слово «Coercive» подчёркивает важность согласия.
- WFSBP 2020.

3. Эпидемиология

- Редко в клинической популяции; в судебном контексте 5–15% среди образцов сексуальных преступлений.
- Почти всегда у мужчин.

- Высокая коморбидность с АСРЛ, другими парафилическими расстройствами.

4. Этиология и патогенез

- Биологические и психосоциальные факторы; детская травма, антисоциальные черты.
- Гиперсексуальность и импульсивность часто коморбидны.

5. Клиническая картина

- Сексуальное возбуждение от причинения страданий жертве, не давшей согласия.
- Типичный контекст — судебное преступление (изнасилование-садизм).
- При тяжёлом течении — садистские убийства, серьёзные физические травмы.
- Судебный риск высокий.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 6 месяцев устойчивое и интенсивное сексуальное возбуждение от физических или психологических страданий лица без согласия.

B. Пациент реализовал фантазию или испытывает значительный дистресс.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR требует срок 6 месяцев; в МКБ-11 критерия срока нет — сказано «устойчивый, сфокусированный и интенсивный паттерн возбуждения».
- BDSM по обоюдному согласию не является клиническим расстройством.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Судебно-психиатрическое клиническое интервью.
2. Оценка риска (Static-99R, SVR-20).
3. Коморбидные расстройства (АСРЛ, психопатия — PCL-R).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
BDSM по обоюдному согласию	Контекст по обоюдному согласию — не расстройство.
АСРЛ	Насилие без сексуального компонента.
Психопатия	PCL-R; клиническое совпадение.
Индуцированное веществом	Токсикологический скрининг.

7. Обследование и оценка

- Судебно-психиатрическое клиническое интервью.
- PCL-R (англ. Psychopathy Checklist), Static-99R, SVR-20.

8. Лечение

1. WFSBP 2020 пошаговый алгоритм:
    - КПТ и профилактика рецидива;
    - СИОЗС высокая доза;
    - Антиандроген;
    - Агонист ГнРГ в наиболее тяжёлом случае.
2. Под надзором судебной психиатрии; в условиях госпитализации или исполнения наказания.
3. При коморбидной психопатии стандартная психотерапия малоэффективна.

8.1 Методики лечения

1. КПТ и профилактика рецидивов (англ. Relapse Prevention) — Ограниченная эффективность; ограничена в контексте психопатии.
2. СИОЗС + Антиандроген + ГнРГ — WFSBP 2020 пошагово.
3. PCL-R, Static-99R, SVR-20 — Судебная оценка риска.

8.2 Различия между источниками

- WFSBP 2020 — комбинация в тяжёлых случаях (КПТ + антиандроген + аГнРГ).

9. Прогноз

При тяжёлом течении высокий риск рецидива; необходимы мультимодальное вмешательство и постоянное наблюдение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «BDSM = садистическое расстройство»

Доказательства: БДСМ по согласию не является клиническим расстройством; МКБ-11 чётко разграничивает с помощью термина «coercive». APA и другие профессиональные ассоциации не считают БДСМ по согласию патологией.

Миф 2: «Садистическое расстройство не поддаётся лечению»

Доказательства: WFSBP 2020 — мультимодальное вмешательство снижает риск рецидива; при коморбидной психопатии эффект меньше.

Миф 3: «Требуется только юридическое наказание»

Доказательства: клиническое вмешательство рекомендуется в сочетании с правовым контролем.

Миф 4: «Все серийные убийцы на сексуальной почве имеют садистическое расстройство»

Доказательства: Большинство сексуальных преступлений мотивированы АСРЛ или иными мотивами; садистический клинический диагноз требует конкретного паттерна фантазий.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D33 Coercive sexual sadism disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.
4. Hare R.D. Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). 2nd ed. 2003.

МКБ-11 **6D34**	**6D34** **ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОТТЕРИЗМ** **Frotteuristic disorder**
МКБ-10 F65.8	Другие расстройства сексуального предпочтения
DSM-5-TR F65.81	Фроттеристское расстройство

1. Определение и нозология

Патологический фроттеризм (МКБ-11: 6D34 Frotteuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.81) — стойкое и интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения половыми органами о не дающее согласия лицо. Пациент реализовал фантазию или испытывает значительный дистресс/функциональное нарушение. Типичный контекст — переполненный общественный транспорт и толпа.

2. История

- Фроттер — от французского слова, означающего «трущийся».
- DSM-IV (1994) — «Другая уточнённая парафилия»; DSM-5 (2013) — отдельная категория.

3. Эпидемиология

- Распространённость: фроттеристические действия встречаются не более чем у 30% взрослых мужчин; критериям расстройства отвечают 10–14% мужчин, обращающихся амбулаторно по поводу парафилий и гиперсексуальности (DSM-5-TR).
- Коморбидные другие парафилические расстройства.

4. Этиология и патогенез

Общая этиология парафилий; коморбидная гиперсексуальность и импульсивность.

5. Клиническая картина

- Прикосновение к лицу без его согласия в тесных общественных местах (автобус, метро, толпа).
- Пациент убегает — жертва не успевает пожаловаться.
- Правовые последствия (sexual harassment, сексуальное преступление).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. ≥ 6 месяцев устойчивое и интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновений или трения о лицо без согласия.

B. Пациент реализовал фантазию или испытывает значительный дистресс.

6.2 Различия между источниками

DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково; WFSBP 2020.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Оценка риска.
3. Коморбидность.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Случайное прикосновение (в переполненной толпе)	Проблема согласия и отсутствие фантазии.
АСРЛ	Широкая антисоциальная модель.
Маниакальный эпизод	Аффективный контекст.

7. Обследование и оценка

- Судебно-психиатрическое клиническое интервью.
- Шкалы риска.

8. Лечение

1. WFSBP 2020 пошаговый:

- КПТ и профилактика рецидива;
- СИОЗС высокая доза;
- Антиандроген / ГнРГ в тяжёлых случаях.

2. Медико-правовая координация.

8.1 Методики лечения

1. КПТ и СИОЗС + протокол WFSBP 2020 — то же, что 6D30/6D31/6D32, поэтапно.

9. Прогноз

Снижение рецидивов при вмешательстве WFSBP.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Фроттеризм безвреден»

Доказательства: является травмой для жертвы; половое преступление и юридические последствия.

Миф 2: «Просто импульс — не требует клинического вмешательства»

Доказательства: Повторяющийся паттерн требует клинического диагноза.

Миф 3: «Только юридическое наказание»

Доказательства: клиническое вмешательство снижает рецидивы.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D34 Frotteuristic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.

6D50–6D5Z ИМИТИРОВАННЫЕ РАССТРОЙСТВА

Factitious disorders

МКБ-11 **6D50**	**6D50 ИМИТИРОВАННОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕБЕ** **Factitious disorder imposed on self**
МКБ-10 F68.1	Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера [поддельное нарушение]
DSM-5-TR F68.10	Искусственное расстройство, направленное на себя

1. Определение и нозология

Имитированное расстройство применительно к себе (МКБ-11: 6D50; DSM-5-TR: F68.10 Искусственное расстройство, навязанное себе) — намеренное создание пациентом у себя физических или психологических симптомов или повреждений, предъявление этих симптомов другим; отсутствие очевидной внешней выгоды (в этом отличие от симуляции). Основная мотивация пациента — принятие роли больного или признание в качестве пациента.

2. История

- Asher R. (1951) — термин «синдром Мюнхгаузена» (от фантастических историй барона Мюнхгаузена).
- DSM-III (1980) — официальное признание Factitious Disorder.
- DSM-5 (2013) — подтипы «Imposed on Self» и «Imposed on Another».
- Обзоры Eisendrath S.J. — диагностика и клинический подход.

3. Эпидемиология

- Редко в клинической популяции (1–2% госпитализаций); недостаточная выявляемость в клиническом подходе.
- Пол: относительно выше у женщин (на фоне медицинской профессии).
- Коморбидность: ПРЛ, депрессивные расстройства, анамнез травмы.

4. Этиология и патогенез

- Психологическое — глубокая эмоциональная потребность в медицинской роли; детская травма, пренебрежение.
- Близость к медицинской системе (быть медицинским работником).
- BPD часто коморбидно.

5. Клиническая картина

- Частые медицинские обращения и обследования; повторные визиты в клиники («hospital shopping»).
- Множественные хирургические процедуры.
- Умышленное создание симптома или повреждения (кровопускание, вызывание инфекции, отравление лекарством, симуляция соматической жалобы).
- Клиническая картина «невозможна» или атипична; лабораторные результаты противоречат жалобам пациента.
- Пациент может лгать при расспросе; анамнез недостоверен.
- Явная материальная выгода отсутствует (страховая, судебная, работа).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Умышленное создание физических или психологических симптомов или повреждений у себя (индуцирование или фальсификация).

B. Пациент представляет себя больным, раненым.

C. Обманное поведение без явной материальной выгоды.

D. Поведение лучше объясняется другим психическим расстройством (бредовое расстройство, другое психотическое).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- Диагноз сложен — требует доказательств (страховые документы, информация из другой клиники, видео).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое подозрение — атипичные клинические проявления, множественные клиники, «невозможный» симптом.
2. Получение медицинского анамнеза из других клиник (с согласия пациента).
3. Страховые и фармацевтические записи.
4. Наблюдение — способ создания лабораторных образцов.
5. Коморбидные ПРЛ, БДР, анамнез травмы.
6. Правовая и этическая координация.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Реальное соматическое заболевание	Клиническое подтверждение; однако возможен коморбидный фактотиоз (сложные случаи).
Соматическое симптоматическое расстройство (6C20)	Сознательной лжи нет; пациент реально ощущает симптомы.
Конверсионное расстройство (6B60)	Не сознательно; функциональное нарушение нервной системы.
Симуляция	Явная материальная/юридическая выгода (страховая, судебная).
Бредовое расстройство — соматическое	Инсайт отсутствует.

7. Обследование и оценка

- Медицинский анамнез (из других клиник).
- Страховые записи.
- Психиатрическое интервью для коморбидных расстройств.

8. Лечение

1. Неконфронтационный подход (non-confrontational approach — Eisendrath) — диагноз объясняется пациенту в рамках заботы, а не наказания; «ваш дистресс реален, мы можем помочь другим способом».
2. Модель одного врача — все жалобы через этого врача.
3. Ограничение инвазивных процедур и ненужных обследований.
4. Психотерапия — поддерживающая, КПТ; долгосрочное наблюдение.
5. Коморбидное ПРЛ, БДР, лечение травмы.
6. Внезапная конфронтация приводит к уходу пациента из терапии; предпочтителен мягкий и заботливый подход.

8.1 Методики лечения

1. Поддерживающая психотерапия — Забота об эмоциональных потребностях пациента.
2. Мультидисциплинарный подход — Медицинские и психиатрические сопутствующие.

8.2 Различия между источниками

- Eisendrath S.J. — неконфронтационный подход и терапевтический альянс.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Прогноз

- Хроническое течение; продолжается «hospital shopping».
- Длительный терапевтический альянс и лечение коморбидности улучшают прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Пациент — „симулянт“, требуется юридическое наказание»

Доказательства: имитированное расстройство является психиатрическим расстройством — ответ на эмоциональную потребность; рекомендуется неконфронтационный подход и психотерапия.

Миф 2: «Прямое заявление „ты врёшь“ „исправляет“ пациента»

Доказательства: жёсткая конфронтация «отпугивает» пациента и переводит его в другую клинику; мягкий подход формирует терапевтический альянс.

Миф 3: «Имитированное расстройство = расстройство с соматическими симптомами»

Доказательства: имитированное расстройство — осознанная ложь; соматический симптом — реальное ощущение пациента.

Миф 4: «Начатые инвазивные процедуры нужно доводить до конца»

Доказательства: Ненужные инвазивные процедуры вредны; после установления диагноза должны быть ограничены.

Миф 5: «Имитированное расстройство не поддаётся лечению»

Доказательства: доказательная база ограничена, но улучшение возможно при долгосрочном терапевтическом альянсе и мультидисциплинарном уходе.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D50 Factitious disorder imposed on self. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Eisendrath S.J. Factitious physical disorders: treatment without confrontation. Psychosomatics 1989;30(4):383–387.
4. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.
5. Asher R. Munchausen’s syndrome. Lancet 1951;1(6650):339–341.

МКБ-11 **6D51**	**6D51 ИМИТИРОВАННОЕ РАССТРОЙСТВО В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО ЛИЦА** **Factitious disorder imposed on another**
МКБ-10 F68.1	Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера [поддельное нарушение]

	6D51 ИМИТИРОВАННОЕ РАССТРОЙСТВО В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО ЛИЦА
МКБ-11 6D51	**Factitious disorder imposed on another**
DSM-5-TR F68.A	Искусственное расстройство, направленное на другого

1. Определение и нозология

Имитированное расстройство в отношении другого лица (МКБ-11: 6D51 Factitious Disorder Imposed on Another; DSM-5-TR: F68.10) — пациент создаёт или симулирует физические или психологические симптомы у другого лица (обычно у своего ребёнка, пожилого или инвалида, находящегося на попечении); приводит этого человека в больницу как жертву. Первоначально называлось «синдром Мюнхгаузена по доверенности» (Meadow R. 1977).

Диагноз ставится пациенту, а не жертве. Это расстройство одновременно является жестоким обращением с детьми — вмешательство по защите детей и правовая координация обязательны.

2. История

- Meadow R. (1977) — «синдром Мюнхгаузена по доверенности» Lancet.
- DSM-IV (1994) — в исследовательской категории.
- DSM-5 (2013) — официальный диагноз.
- APSAC, AAP — протоколы защиты детей.

3. Эпидемиология

- Редкое — годовая заболеваемость ~2/100 000 детей (обзор Sheridan M.S. Child Abuse Negl 2003); низкая выявляемость.
- Типичный совершающий — биологическая мать (>90%); жертва — ребёнок (типично <5 лет).
- Смертность жертв 6–9% (Sheridan); высокая заболеваемость.

4. Этиология и патогенез

- Психологические потребности виновника — внимание в медицинской роли, отношения, образ «героя».
- Плотность в контексте медицинской профессии.
- В анамнезе виновника — травма или пренебрежение.

5. Клиническая картина

- Симптомы ребёнка возникают только в присутствии матери; улучшаются, когда его укладывают спать и она отсутствует.
- Множественные клиники, атипичные симптомы, «невозможный» медицинский анамнез.
- Мать — медицинский работник или обладает обширными медицинскими знаниями.
- Мать выглядит чрезмерно вежливой и «идеальной сиделкой».
- Типичные методы индукции: лекарственное отравление, механическое перекрытие пищи или дыхательных путей, забор крови, создание инфекции.
- У ребёнка-жертвы: необъяснимые повторяющиеся приступы, апноэ, гипогликемия, инфекция, повреждение кожи.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Умышленное создание у другого (жертвы) физических или психологических симптомов или повреждений.

B. Пациент представляет жертву другим как больного, раненого.

C. Обманное поведение без явной материальной выгоды.

D. Поведение не объясняется лучше другим психическим расстройством.

Диагноз ставится виновнику, а не жертве.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- APSAC, AAP — протоколы защиты детей; это клиническое состояние также относится к категории жестокого обращения с детьми.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое подозрение — атипичный паттерн симптомов, привязанность к матери.
2. Мультидисциплинарная группа: педиатр, психиатр, социальный работник.
3. Получение медицинской документации из других клиник.
4. Проба с разлучением — наблюдение симптомов при отделении матери от пострадавшего.
5. Видеомониторинг (под защитой детей и судебным вмешательством).
6. Токсикологические и биохимические тесты (доказательство приёма).
7. Обращение в органы опеки и правовая координация обязательны.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Реальное соматическое заболевание	Медицинское доказательство.
Чрезмерно тревожный родитель	Преднамеренная индукция отсутствует; выражает медицинские опасения, но не вызывает их.
Реальное жестокое обращение с ребёнком (другая форма)	Физическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение — разная мотивация.
Имитированное расстройство применительно к себе (6D50)	Жертва — он сам.

7. Обследование и оценка

- Педиатрическая клиническая оценка.
- Медицинский анамнез с группой.
- Социальная служба и обращение по защите ребёнка.
- Правовая координация.

8. Лечение

1. Безопасность жертвы — первоочередная задача — разлучение ребёнка с матерью (или ухаживающим лицом).
2. Обращение в органы опеки — правовые протоколы.

3. Психиатрическое лечение пациента (виновника):
    - Психотерапия (долгосрочная);
    - Коморбидные расстройства (ПРЛ, БДР, травма);
    - В контексте медицинской профессии — может рассматриваться запрет на профессию.
4. Семейное вмешательство и оценка защиты сиблингов.
5. Психотерапия ребёнка-жертвы — травматическое вмешательство.

8.1 Методики лечения

1. Обращение по защите детей — Обязательно при подозрении; протоколы APSAC, AAP.
2. Мультидисциплинарная группа — Педиатр + психиатр + социальный работник + судебный эксперт.
3. Тест на разлуку (англ. Separation Test) — Мать отделяется от пострадавшего; симптомы отслеживаются.
4. Видеомониторинг — Под правовым и этическим контролем.

8.2 Различия между источниками

- APSAC — протоколы защиты детей.
- AAP — роль педиатра.
- Координация с правовой системой обязательна.

9. Прогноз

- Для жертвы — высокая смертность (6–9%) и заболеваемость без вмешательства.
- Для виновника — улучшение при психотерапии; долгосрочное наблюдение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Мать на самом деле заботлива, диагноз ошибочен»

Доказательства: клинические особенности (симптомы, связанные с матерью, атипичный медицинский анамнез) требуют серьёзных доказательств; клинического подозрения достаточно для обращения в службу защиты детей.

Миф 2: «Это состояние — не психиатрическая проблема, а просто жестокое обращение с ребёнком»

Доказательства: оба подхода важны — защита ребёнка + психиатрическое лечение виновника.

Миф 3: «Лечение виновника задерживает прекращение вредящей ребёнку помощи»

Доказательства: безопасность жертвы — приоритет номер один; психиатрическое лечение продолжается отдельно.

Миф 4: «Возникает только у матери»

Доказательства: В большинстве случаев — мать, но виновником могут быть и другие лица, ухаживающие за ребёнком: отцы, няни, медицинские работники.

Миф 5: «Конфронтация „лечит“ пациента»

Доказательства: конфронтация может привести к переходу в другую клинику; пациент продолжает; координация с защитой детей и судебными органами обязательна.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D51 Factitious disorder imposed on another. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Meadow R. Munchausen syndrome by proxy. The hinterland of child abuse. Lancet 1977;2(8033):343–345.
4. Sheridan M.S. The deceit continues: an updated literature review of Munchausen Syndrome by Proxy. Child Abuse Negl 2003;27(4):431–451.
5. APSAC Task Force. Munchausen by Proxy: Identification, Intervention, and Case Management. 2018.

6D70–6D8Z НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ (ДЕМЕНЦИЯ)

Neurocognitive disorders

МКБ-11 **6D70**	**6D70 ДЕЛИРИЙ** **Delirium**
МКБ-10 F05	Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
DSM-5-TR F05	Делирий

1. Определение и нозология

Делирий (МКБ-11: 6D70; DSM-5-TR: F05) — острый, флуктуирующий нейропсихиатрический синдром, характеризующийся нарушением внимания и сознания, когнитивным дефицитом (память, ориентация, речь, зрительно-пространственные функции) и расстройствами восприятия (иллюзии, галлюцинации). Развивается в ответ на типичную медицинскую причину (инфекция, лекарства, метаболические, неврологические нарушения).

Это медицинская неотложная ситуация — смертность у госпитализированных пожилых пациентов 25–33%.

2. История

- Гиппократ «phrenitis» — классическое описание делирия.
- Lipowski Z.J. (1980–1990-е годы) — современная концептуализация.
- CAM (Confusion Assessment Method, Inouye S.K. 1990) — золотой стандарт скрининга.

3. Эпидемиология

- Распространённость у госпитализированных пожилых 15–30%; в ОИТ 50–80%; после хирургических вмешательств 15–50%.

- Коморбидность: деменция (делирий на фоне деменции), инфекция, полипрагмазия.
- Смертность и заболеваемость высоки; риск долгосрочного когнитивного снижения.

4. Этиология и патогенез

- Множественные факторы:
  - Инфекции — сепсис, пневмония, ИМП;
  - Лекарства — антихолинергические, опиоиды, бензодиазепины, стероиды;
  - Отмена вещества (алкоголь, бензодиазепин);
  - Метаболические — электролит, глюкоза, аммиак, уремия;
  - Гипоксия, гипоперфузия;
  - Неврологическое — припадок, инсульт, опухоль мозга, энцефалит;
  - Боль, запор, задержка мочи;
  - Среда — сенсорная депривация, нарушение сна (особенно в ОИТ).

5. Клиническая картина

Три моторных подтипа

- Гиперактивный — ажитация, галлюцинации — диагноз поставить легко;
- Гипоактивный — седация, отгороженность — диагноз часто не ставится, похоже на депрессию;
- Смешанный — флуктуация.

Клинические признаки

- Острое начало (часы-дни) и колебания.
- Нарушение внимания.
- Когнитивные дефициты — память, ориентация (время, место, личность).
- Расстройства восприятия — типичны зрительные галлюцинации.
- Нарушение цикла сна-бодрствования.
- Sundowning — ухудшение в вечерние часы.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Нарушение внимания (направление, удержание, переключение) и нарушение сознания.

B. Расстройство развивается в течение короткого времени (часы-дни); изменяется от исходных показателей; колебания в течение дня.

C. Дополнительное когнитивное нарушение (память, ориентация, речь, зрительно-пространственные функции, восприятие).

D. Не полностью объясняется деменцией или другим нейрокогнитивным расстройством.

E. Доказательства — анамнез, осмотр, лабораторные данные указывают, что нарушение является прямым следствием медицинского состояния, интоксикации/отмены вещества или множественной этиологии.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- NICE CG103 — Делирий: профилактика, диагностика, ведение (2010, обновление 2019).

6.3 Алгоритм диагностики

1. CAM (англ. Confusion Assessment Method) — золотой стандарт скрининга.
2. CAM-ICU — для интенсивной терапии.
3. Поиск медицинской причины: общий анализ крови, электролиты (Na, K, Ca, Mg, P), глюкоза, печень, почки, ТТГ, B12, тропонин, ЭКГ, анализ мочи и посев мочи, посев крови, рентген грудной клетки, МРТ/КТ головного мозга, ЭЭГ (при подозрении на приступы), люмбальная пункция (энцефалит/менингит).
4. Пересмотр списка лекарств — антихолинергические, опиоиды, бензодиазепины (критерии Бирса).
5. Токсикологический скрининг.
6. Оценка коморбидной деменции (начальные признаки).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Деменция (6D8x)	Постепенное начало; внимание относительно сохранно.
Депрессия (психомоторное замедление как гипоактивность)	Аффективные симптомы доминируют; внимание относительно сохранно.
Психотический эпизод	Внимание сохранено; начало иное.
Non-convulsive status epilepticus	ЭЭГ.
Энцефалопатия Вернике	Тест на тиамин; классическая триада (офтальмоплегия, атаксия, спутанность сознания).

7. Обследование и оценка

- CAM, CAM-ICU.
- MMSE или MoCA (исходные показатели когнитивной функции).
- Из вышеуказанной медицинской панели.
- ЭЭГ — исключение бессудорожного статуса.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG103)

1. Этиологическое лечение — первый приоритет — коррекция инфекции, метаболических нарушений, лекарств, контекста госпитализации.
2. Модификация среды — сенсорная (очки, слуховой аппарат), дневной свет, ночная темнота, спокойная обстановка, присутствие близких.
3. Постельный уход — гидратация, питание, мочеиспускание и дефекация, движение.
4. Антипсихотик (галоперидол 0,25–2 мг, кветиапин, рисперидон) — только при тяжёлом возбуждении или угрозе пациента для себя/других, краткосрочно, низкая доза. NICE CG103 — антипсихотики рутинно не рекомендуются; доказательная база ограничена (Burry L. Cochrane 2018).

5. Бензодиазепин — только при алкогольном или бензодиазепиновом абстинентном делирии; в остальных случаях противопоказан (усиливает делирий).
6. Профилактика — комплекс ABCDEF в ОИТ (Awakening, Breathing, Coordination, Delirium monitoring, Early mobility, Family).

8.2 Методики лечения

1. Метод оценки спутанности сознания (CAM — Confusion Assessment Method) — Иноуэ (Inouye S.K.) — 4 основных признака: острое начало/колебания + невнимательность + дезорганизованное мышление или изменение сознания.
2. CAM-ICU — Адаптировано для интенсивной терапии; у пациентов на ИВЛ.
3. Больничная программа для пожилых (англ. Hospital Elder Life Program, HELP) — Иноуэ (Inouye S.K.) — Многокомпонентная программа профилактики делирия; доказательная база сильная.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG103 — этиологический и средовой подход первой линии; антипсихотики ограничены.
- SCCM PADIS Guidelines (для ОИТ, 2018).
- Burry L. Cochrane 2018 — антипсихотики не уменьшают продолжительность делирия или смертность.

9. Прогноз

- Госпитальная летальность 25–33 %.
- У выживших — функциональное снижение, долгосрочное когнитивное нарушение, повышенный риск деменции.
- Раннее этиологическое вмешательство улучшает прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Делирий — это „норма для пожилого человека“»

Доказательства: делирий — клиническая неотложная ситуация, летальность высока; требует активного вмешательства.

Миф 2: «Антипсихотик — это лечение делирия»

Доказательства: NICE CG103, Burry Cochrane 2018 — антипсихотики не уменьшают продолжительность делирия и смертность; только при тяжёлом возбуждении.

Миф 3: «Бензодиазепины безопасны для пожилого пациента с ажитацией»

Доказательства: бензодиазепин усиливает делирий; только в случае отмены алкоголя/бензодиазепинов.

Миф 4: «Гипоактивный делирий — это „хорошо“, он не требует вмешательства»

Доказательства: гипоактивный делирий связан с худшей смертностью; проблема недостаточной выявляемости.

Миф 5: «Сон пациента — лучшее при делирии»

Доказательства: рекомендуются дневная активность, присутствие близких, сенсорная стимуляция; программа HELP имеет доказательную базу.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D70 Delirium. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG103. Delirium: prevention, diagnosis and management. 2010, 2019 update.
4. Inouye S.K. et al. Clarifying confusion: the confusion assessment method. Ann Intern Med 1990;113(12):941–948.
5. Burry L. et al. Antipsychotics for treatment of delirium in hospitalised non-ICU patients. Cochrane Database Syst Rev 2018;(6):CD005594.
6. Devlin J.W. et al. SCCM PADIS Guidelines. Crit Care Med 2018;46(9):e825–e873.

МКБ-11 **6D71**	**6D71 ЛЕГКОЕ НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (MCI)** **Mild neurocognitive disorder**
МКБ-10 F06.7	Лёгкое когнитивное расстройство
DSM-5-TR G31.84	Лёгкое нейрокогнитивное расстройство

1. Определение и нозология

Лёгкое нейрокогнитивное расстройство (МКБ-11: 6D71 Mild Neurocognitive Disorder; DSM-5-TR: G31.84) — лёгкое снижение в одной или нескольких когнитивных сферах (память, комплексное внимание, исполнительная функция, речь, зрительно-пространственные навыки, социальное познание); повседневная активность сохранена (хотя компенсация может потребоваться). Типичное название — «Mild Cognitive Impairment» (MCI).

2. История

- Petersen R.C. (1999) — клиническая концептуализация MCI.
- DSM-5 (2013) — категории Major (деменция) и Mild Neurocognitive Disorders.
- AAN (2018) — Practice Guideline for MCI (Petersen).

3. Эпидемиология

- Распространённость 10–20% в возрасте 65+ лет.
- Ежегодно 10–15% MCI переходит в болезнь Альцгеймера.
- Факторы риска: возраст, ApoE4, сердечно-сосудистые.

4. Этиология и патогенез

- Продромальная болезнь Альцгеймера (амнестическое MCI);
- Сосудистый;
- Продромальные тельца Леви;

- Лобно-височная;
- Медицинские (депрессия, щитовидная железа, B12, лекарственные эффекты).

5. Клиническая картина

- Пациент или близкий человек жалуется на когнитивное снижение.
- Лёгкий дефицит по стандартизированным тестам (типично от -1 до -2 SD).
- Повседневная активность сохранена (минимальная компенсация при сложных действиях).
- Подтипы: амнестический (доминирование памяти — высокий риск болезни Альцгеймера), неамнестический (исполнительные или другие домены).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Лёгкое снижение в одной или нескольких когнитивных областях (отмечается пациентом, информантом или клиницистом, а также подтверждается стандартизированным нейропсихологическим тестированием).

B. Повседневная активность сохранена.

C. Не объясняется лучше делирием.

D. Не объясняется лучше другим психическим расстройством (БДР).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — разделение на Major и Mild.
- AAN 2018 — этиологический поиск (болезнь Альцгеймера, сосудистая) и биомаркеры находятся на стадии разработки.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант.
2. MoCA (англ. Montreal Cognitive Assessment), MMSE.
3. Нейропсихологическое тестирование.
4. Лабораторные — B12, фолат, TSH, печёночные, почечные, глюкоза, ВИЧ/сифилис.
5. МРТ головного мозга — сосудистая, атрофия, другая патология.

6. Биомаркеры (при клиническом подозрении) — CSF амилоид-β/тау, ПЭТ-визуализация (продромальная болезнь Альцгеймера).
7. Скрининг депрессии (GDS, PHQ-9).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Деменция (тяжёлое НКР)	Повседневная активность нарушена (требуется помощь в быту).
Нормальные возрастные когнитивные изменения	Нормальная производительность при тестировании.
Депрессия (псевдодеменция)	Аффективные симптомы доминируют; улучшаются на фоне антидепрессантов.
Делирий (6D70)	Острое начало, колебания внимания.
Дефицит B12 или щитовидной железы	Лабораторно: улучшение при коррекции.

7. Обследование и оценка

- MoCA (≤ 25 — патология) — валидированный скрининг для MCI; у MMSE установленного порога для MCI нет, чувствительность к лёгким нарушениям низкая.
- Нейропсихологическая батарея (память, исполнительная функция, речь, зрительно-пространственные функции).
- Лабораторная панель.
- МРТ (рутинно), биомаркеры (выборочно).

8. Лечение

1. Этиологическое лечение — модифицируемые факторы (сердечно-сосудистый риск, B12, щитовидная железа, депрессия, лекарства).
2. Образ жизни — физическая активность (аэробная), средиземноморская диета, когнитивная стимуляция, социальные связи (FINGER trial Lancet 2015 — мультимодальный подход эффективен).
3. Специфического одобрения для фармакотерапии MCI нет. Донепезил и другие AChEI — доказательная база ограничена; рутинно не рекомендуются.

4. Леканемаб, донанемаб — новые антиамилоидные антитела; одобрение FDA (леканемаб 2023, донанемаб 2024) для продромальной болезни Альцгеймера и лёгкой деменции; клинический эффект умеренный, риск инфузионных реакций и ARIA (англ. Amyloid-Related Imaging Abnormalities).
5. Лечение коморбидной депрессии, тревоги (СИОЗС).
6. Мониторинг риска перехода в деменцию.

8.1 Методики лечения

1. Монреальская когнитивная оценка (MoCA — Montreal Cognitive Assessment) — Насреддин (Nasreddine Z.S.) — 30 пунктов; скрининг MCI (порог отсечения 26).
2. Мультимодальное вмешательство FINGER (FINGER — Finnish Geriatric Intervention Study) — Диета + физические упражнения + когнитивный тренинг + управление сосудистыми рисками.
3. Леканемаб, донанемаб — Антиамилоидные антитела; одобрение FDA; мониторинг ARIA (МРТ).

8.2 Различия между источниками

- AAN 2018 — модифицируемые факторы и образ жизни.
- Исследование FINGER (Ngandu Lancet 2015) — мультимодальное вмешательство.
- Леканемаб — CLARITY-AD (van Dyck NEJM 2023); донанемаб — TRAILBLAZER-ALZ 2 (Sims JAMA 2023).

9. Прогноз

- Стабильное состояние 30%, переход в деменцию 10–15%/год, возврат к норме 15–20%.
- Амнестическое MCI — продром болезни Альцгеймера: высокая конверсия.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «MCI обязательно переходит в деменцию»

Доказательства: ежегодно переходит 10–15%; часть остаётся стабильной или улучшается.

Миф 2: «Витамин B и гинкго излечивают умеренные когнитивные нарушения»

Доказательства: Витамины группы B только при дефиците; гинкго Cochrane (Birks 2009) — доказательства эффективности слабые.

Миф 3: «Ингибиторы ацетилхолинэстеразы — стандартное лечение умеренных когнитивных нарушений»

Доказательства: AAN 2018 — доказательная база недостаточна; рутинное применение не рекомендуется.

Миф 4: «Леканемаб излечивает MCI/болезнь Альцгеймера»

Доказательства: замедляет прогрессирование болезни примерно на 25%; ARIA и инфузионные реакции; не является «излечением».

Миф 5: «Когнитивное снижение неизбежно с возрастом»

Доказательства: сердечно-сосудистый риск, физическая активность, социальные связи — модифицируемые факторы.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D71 Mild neurocognitive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Petersen R.C. et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment. Neurology 2018;90(3):126–135.
4. Ngandu T. et al. A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet 2015;385(9984):2255–2263.
5. van Dyck C.H. et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. NEJM 2023;388(1):9–21.
6. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005;53(4):695–699.
7. Birks J., Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD003120.

МКБ-11 **6D72**	**6D72** **АМНЕСТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО** **Amnestic disorder**
МКБ-10 F04	Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
DSM-5-TR F02.8x	Тяжёлое нейрокогнитивное расстройство вследствие другого медицинского состояния (амнестическая форма)

1. Определение и нозология

Амнестическое расстройство (МКБ-11: 6D72 Amnestic Disorder; DSM-5-TR: F04 и аналогичные) — значительное нарушение усвоения и воспроизведения новой информации; другие когнитивные домены относительно сохранны. Вследствие медицинского состояния (Вернике-Корсакова, травма мозга, энцефалит, аноксия), воздействия вещества или других причин.

2. История

- Корсаков С. (1887) — описание алкоголь-ассоциированной амнезии.
- Scoville W.B., Milner B. (1957) — случай H.M. (амнезия после билатеральной резекции медиальных височных структур).

3. Эпидемиология

- Синдром Корсакова — у 12–25% хронических тяжёлых потребителей алкоголя.
- Амнезия после черепно-мозговой травмы — у 30–50% пациентов.
- Транзиторная глобальная амнезия (TGA) — распространённость в возрасте 65+ лет 5–25/100 000/год.

4. Этиология и патогенез

- Вернике-Корсаков — дефицит тиамина (B1) (алкоголь, недоедание).

- Черепно-мозговая травма (ЧМТ).
- Гипоксия/аноксия — остановка сердца, угарный газ.
- Герпетический энцефалит.
- Аутоиммунный энцефалит (анти-NMDA, анти-LGI1).
- Транзиторная глобальная амнезия (TGA) — подозрение на сосудистую этиологию.
- Вещество (алкогольный блэкаут, бензодиазепин).
- Инсульт (особенно двусторонний таламический или гиппокампальный).

5. Клиническая картина

- Антероградная амнезия — нарушение усвоения новой информации (основная характеристика).
- Ретроградная амнезия — память на прошлое (до травмы; «закон Рибо» — более новые воспоминания утрачиваются раньше).
- Конфабуляция — при синдроме Корсакова пациент заполняет пробелы памяти вымыслами.
- Другие когнитивные домены относительно сохранны (интеллект, речь, зрительно-пространственные функции).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Нарушение усвоения новой информации или нарушение воспроизведения ранее усвоенной информации.

B. Нарушение памяти вызывает значительные функциональные нарушения.

C. Возникает не исключительно в контексте делирия или другого НКР.

D. Доказательства — анамнез, осмотр, лабораторные данные указывают, что нарушение памяти обусловлено специфической причиной (медицинское состояние, вещество).

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR — интегрировано в структуру Major и Mild NCD; амнестический подтип.
- МКБ-11 — отдельная категория.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант.
2. Нейропсихологический тест — память (WMS-IV, RAVLT, Wechsler Logical Memory).
3. МРТ головного мозга — билатеральная гиппокампальная, медиальная височная, таламическая патология.
4. Уровень тиамина (B1) или эмпирическое введение тиамина (подозрение на Корсаковский синдром).
5. Токсикологический скрининг.
6. Панель на аутоиммунный энцефалит (при атипичном течении).
7. ЭЭГ.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Альцгеймеровская деменция	Множественные когнитивные домены, постепенное начало.
Делирий (6D70)	Колебания внимания.
Диссоциативная амнезия (6B61)	В контексте травмы; селективная память на прошлое; медицинской причины нет.
Искусственное расстройство / симуляция	Атипичная картина, вторичная выгода.
TGA	Острое, менее 24 часов; полное восстановление.

7. Обследование и оценка

- WMS-IV (англ. Wechsler Memory Scale), RAVLT.
- МРТ головного мозга.
- Тиамин, B12.
- Токсикологический скрининг.

8. Лечение

1. Этиологическое лечение — тиамин (Вернике-Корсаков — 500 мг в/в × 3 раза/сут × 3 дня, затем 250 мг в/м/сут × 3–5 дней; длительный пероральный тиамин при отмене алкоголя).
2. Аутоиммунный энцефалит — иммунотерапия (стероиды, IVIG, плазмаферез, ритуксимаб).
3. Герпетический энцефалит — ацикловир.
4. Компенсаторные стратегии (внешние средства памяти, структурирование распорядка дня).
5. Лечение употребления психоактивных веществ (алкоголя).
6. Реабилитация — когнитивная реабилитация (Wilson B.A.).

8.1 Методики лечения

1. Профилактика и лечение Вернике-Корсакова — Тиамин IV/IM в высоких дозах; введение ДО глюкозы критически важно (глюкоза при дефиците тиамина усиливает энцефалопатию Вернике).
2. Когнитивная реабилитация (англ. Cognitive Rehabilitation) — Вилсон (Wilson B.A.) — Внешние средства памяти (журнал, напоминания телефона), обучение стратегиям.
3. Иммунотерапия (аутоиммунный энцефалит) — Протокол Graus 2016.

8.2 Различия между источниками

- Вернике-Корсаков — протокол тиамина Королевского колледжа врачей.
- Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 — аутоиммунный энцефалит.

9. Прогноз

- TGA — полное восстановление.
- Корсаков — типичен остаточный дефицит; острое вмешательство при Вернике тиамином критично.
- ЧМТ — частичное восстановление с реабилитацией.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Амнезию можно „восстановить“ с помощью гипноза»

Доказательства: гипноз создаёт ложные воспоминания; при органической амнезии неэффективен.

Миф 2: «Перорального тиамина достаточно при Вернике»

Доказательства: пероральная абсорбция недостаточна; требуются высокие дозы в/в или в/м.

Миф 3: «Глюкоза „лечит“ Вернике»

Доказательства: глюкоза при дефиците тиамина усиливает энцефалопатию Вернике; тиамин вводить предварительно.

Миф 4: «Вся амнезия временна»

Доказательства: Корсаков, ЧМТ-основанная амнезия типично хроническая; реабилитация даёт улучшение, но полное восстановление редко.

Миф 5: «Конфабуляция — это ложь»

Доказательства: конфабуляция при синдроме Корсакова — нейробиологический феномен, а не осознанная ложь.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D72 Amnestic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Royal College of Physicians. Wernicke’s encephalopathy and Korsakoff’s syndrome. 2014.
4. Graus F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
5. Wilson B.A. Neuropsychological Rehabilitation. Wiley; 2009.

МКБ-11 **6D80**	**6D80 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА** **Dementia due to Alzheimer disease**
МКБ-10 F00	Деменция при болезни Альцгеймера
DSM-5-TR G30.9 + F02.8x	Тяжёлое нейрокогнитивное расстройство вследствие болезни Альцгеймера

1. Определение и нозология

Деменция вследствие болезни Альцгеймера (МКБ-11: 6D80; DSM-5-TR: G30.9 + F02.8x Большое нейрокогнитивное расстройство вследствие болезни Альцгеймера) — прогрессирующее и непрерывное когнитивное снижение, в начале эпизодическая память, затем множественные когнитивные домены и значительное нарушение повседневной деятельности. Наиболее частая причина деменций (60–70%).

2. История

- Alzheimer A. (1906) — первое клиническое и патоморфологическое описание.
- Амилоидная гипотеза (Hardy J., Higgins G.A. Science 1992).
- NICE NG97 (2018) — клиническое руководство по деменции.
- FDA — адуканумаб (2021, спорно), леканемаб (2023), донанемаб (2024) — антиамилоидные антитела.

3. Эпидемиология

- В мире 55 млн+ пациентов с деменцией (ВОЗ 2023); 60–70% — болезнь Альцгеймера.
- Распространённость по возрасту: 65 лет 5%, 80+ лет 25%+.
- Пол: выше у женщин (связано с ожидаемой продолжительностью жизни).
- Коморбидность: сердечно-сосудистая патология, депрессия, тревога, BPSD (поведенческие и психологические симптомы деменции).

4. Этиология и патогенез

- Семейная болезнь Альцгеймера (1%): мутации APP, PSEN1, PSEN2 (раннее начало, доминантный тип).
- Спорадическая (99%) — множественные гены (ApoE4 — самый сильный фактор риска; LOAD GWAS локусы).
- Модифицируемые факторы (Lancet Commission 2024) — наряду с возрастом, ApoE4: низкий уровень образования, потеря слуха, гипертензия, ожирение, курение, депрессия, физическая пассивность, социальная изоляция, диабет, загрязнение воздуха, алкоголь, ЧМТ, потеря зрения, высокий ЛПНП.

- Патогенез — амилоид-β бляшки + тау-нейрофибриллярные клубки + нейровоспаление.

5. Клиническая картина

- Типичное начало — снижение эпизодической памяти (трудности сохранения новой информации).
- Этапы:
    - Ранние — трудности с памятью, аномия, ориентировка;
    - Умеренная — зрительно-пространственные, исполнительные функции, повседневная активность с поддержкой;
    - Поздняя — речь резко ограничена, утрата узнавания близких, ограничение подвижности, трудности питания и глотания.
- BPSD — ажитация, агрессия, бред (особенно кражи), галлюцинации, депрессия, тревога, нарушение сна, сандаунинг.
- Атипичные формы: posterior cortical atrophy (визуально-пространственный доминант), logopenic primary progressive aphasia (речевой доминант).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Критерии Major NCD (значительное снижение в ≥ 1 когнитивной области + нарушение повседневной деятельности).

B. Клиническая характеристика соответствует болезни Альцгеймера (постепенное, непрерывное снижение, преимущественно память).

C. Вероятная БА — генетическая мутация и/или 3 элемента (память + 1+ когнитивная сфера, устойчивое снижение, отсутствие другой причины).

D. Possible AD — критерии не полностью соблюдены, но атипичная клиника или коморбидность.

6.2 Различия между источниками

- NIA-AA Research Framework (Jack C.R. 2018) — биомаркерная диагностика (ATN — амилоид, тау, нейродегенерация).
- NICE NG97 — основано на клинической диагностике; биомаркеры выборочно.
- AAN — диагностические инструменты.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант.
2. MoCA, MMSE, ACE-III.
3. Нейропсихологическая батарея.
4. Лабораторные — B12, фолат, TSH, печёночные, почечные, глюкоза, ВИЧ/сифилис (исключение медицинской причины).
5. МРТ головного мозга (атрофия, сосудистые изменения, другая патология).
6. Биомаркеры (селективные, при клиническом подозрении):
    - CSF амилоид-β42 (снижен), tau (повышен);
    - Amyloid PET, tau PET;
    - Биомаркеры крови (p-tau217, GFAP) — находятся в стадии разработки.
7. Скрининг коморбидной депрессии (GDS).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Сосудистая деменция (6D81)	Поэтапное снижение, фокусные неврологические признаки, сосудистая МРТ.
Тельца Леви (6D82)	Зрительные галлюцинации, паркинсонизм, расстройство поведения в REM-сне.
Лобно-височная деменция (6D83)	Доминирование личности/поведения или речи; более раннее начало.
Делирий (6D70)	Острое, колеблющееся внимание.
Депрессивная псевдодеменция	Аффективное, улучшение на фоне антидепрессантов.
Нормотензивная гидроцефалия (НТГ)	Классическая триада (походка, мочеиспускание, когнитивные нарушения).
Соматические причины (B12, щитовидная железа, нейросифилис, ВИЧ)	Лабораторное обследование.

7. Обследование и оценка

- MoCA, MMSE, ACE-III, нейропсихологическое тестирование.
- Лабораторная панель.
- МРТ, биомаркеры.
- Шкалы BPSD (NPI — Neuropsychiatric Inventory).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE NG97 · AAN · APA)

1. AChEI (донепезил, галантамин, ривастигмин) — при лёгкой-умеренной болезни Альцгеймера; умеренно замедляет когнитивное снижение. Донепезил 5–10 мг (затем 23 мг), ривастигмин пластырь.
2. Мемантин (антагонист NMDA) — для умеренной и тяжёлой болезни Альцгеймера; комбинация с AChEI.
3. Антиамилоидные антитела (леканемаб, донанемаб) — одобрение FDA для ранней симптоматической БА (леканемаб 2023, донанемаб 2024); замедляет прогрессирование болезни ~25%; высокий риск ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities — отёк, микрокровоизлияния в мозг) (особенно у гомозигот ApoE4); необходим МРТ-мониторинг; инфузионно. Клиническая польза спорна.
4. Ведение BPSD:
    - Первая линия — нефармакологическая (среда, социальная поддержка, физическая активность, музыкотерапия);
    - Рефрактерное состояние — атипичный антипсихотик (рисперидон, кветиапин) в низкой дозе, краткосрочно; FDA black box — антипсихотики повышают смертность (инсульт, сердечно-сосудистые) у пожилых пациентов с деменцией.
    - СИОЗС — при коморбидной депрессии/тревоге;
    - Тразодон — при нарушении сна;
    - Бензодиазепин — противопоказан (падения, когнитивное ухудшение).
5. Поддержка ухаживающего лица и психообразование — критический компонент.
6. Образ жизни — физическая активность, когнитивная стимуляция, социальные связи.
7. Предварительные распоряжения (advance directives) — планирование ухода и принятия решений.

8.2 Методики лечения

1. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChEI — Acetylcholinesterase Inhibitors) — Донепезил, Галантамин, Ривастигмин — ингибируют ацетилхолинэстеразу; повышают синаптический ацетилхолин. NICE NG97.
2. Мемантин — Антагонист NMDA-рецепторов; снижает эксайтотоксичность.
3. Леканемаб, донанемаб — Антиамилоидные моноклональные антитела; для ранней БА; мониторинг ARIA.
4. Нефармакологическое лечение BPSD — Терапия валидацией (англ. Validation therapy), музыкотерапия, терапия воспоминаниями (англ. reminiscence therapy), ABC-анализ.
5. Мультимодальное вмешательство FINGER (FINGER — Finnish Geriatric Intervention Study) — Для профилактики.
6. Поддержка ухаживающего лица (англ. Carer Support) — Психообразование, передышка, юридическое и финансовое планирование.

8.3 Различия между источниками

- NICE NG97 (2018) — AChEI при лёгкой-умеренной; мемантин при умеренной-тяжёлой; комбинация выборочно.
- Livingston G. и др. Комиссия Lancet 2024 — 14 модифицируемых факторов риска.
- FDA: леканемаб 2023, донанемаб 2024 — для ранней БА; мониторинг ARIA.
- APA — правила применения антипсихотиков у пожилых.

9. Прогноз

- Средняя ожидаемая продолжительность жизни после постановки диагноза 8–10 лет.
- Быстрое течение, семейный анамнез, носительство ApoE4.
- Коморбидная сердечно-сосудистая смертность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Болезнь Альцгеймера — это нормальное старение»

Доказательства: Болезнь Альцгеймера — это заболевание; нормальное старение может протекать без когнитивного снижения; до 45% случаев деменции связаны с модифицируемыми факторами (Lancet Commission 2024).

Миф 2: «Деменция неизбежна, профилактика невозможна»

Доказательства: Lancet Commission 2024 — управление модифицируемыми факторами может отсрочить до 45% потенциальных случаев деменции.

Миф 3: «Леканемаб излечивает болезнь Альцгеймера»

Доказательства: снижает скорость клинического снижения примерно на 25% (умеренный эффект); ARIA и риски инфузий значительны; не является «излечением».

Миф 4: «Антипсихотики безопасны для пожилых пациентов с деменцией»

Доказательства: FDA black box — антипсихотики повышают смертность у пожилых пациентов с деменцией (инсульт, сердечно-сосудистые); только при тяжёлой ажитации/психозе, краткосрочно.

Миф 5: «Гинкго билоба — профилактика деменции»

Доказательства: Cochrane (Birks J. 2009) — гинкго не демонстрирует доказанного эффекта при деменции.

Миф 6: «Кокосовое масло излечивает болезнь Альцгеймера»

Доказательства: клинических доказательств нет; это утверждение из популярных СМИ, а не клиническая рекомендация.

Миф 7: «Пациенту не нужно сообщать диагноз деменции»

Доказательства: NICE — пациент имеет право на диагноз; важны раннее принятие решений и предварительные распоряжения.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D80 Dementia due to Alzheimer disease. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG97. Dementia: assessment, management and support. 2018.

4. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet 2024;404(10452):572–628.
5. Jack C.R. et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. Alzheimer's Dement 2018;14(4):535–562.
6. van Dyck C.H. et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. NEJM 2023;388(1):9–21.
7. Sims J.R. et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease (TRAILBLAZER-ALZ 2). JAMA 2023;330(6):512–527.
8. FDA Black Box Warning — antipsychotics in elderly with dementia. 2005.
9. Birks J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD003120.

МКБ-11 **6D81**	**6D81 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ** **Dementia due to cerebrovascular disease**
МКБ-10 F01	Сосудистая деменция
DSM-5-TR F01.5x	Тяжёлое сосудистое нейрокогнитивное расстройство

1. Определение и нозология

Деменция вследствие цереброваскулярного заболевания (МКБ-11: 6D81; DSM-5-TR: F01.5x и аналогичные) — когнитивное снижение и нарушение повседневной деятельности, развивающиеся вследствие сосудистого поражения головного мозга (инсульт, поражение мелких сосудов, гипоперфузия). Вторая по частоте причина деменции (~15–20%).

2. История

- Binswanger O. (1894) — классическое описание субкортикальной сосудистой деменции.
- NINDS-AIREN (1993) — международные диагностические критерии.

- VASCOG (2014) — обновлённый консенсус (англ. Vascular Cognitive Disorders).

3. Эпидемиология

- 15–20% случаев деменции; во многих случаях смешанная с болезнью Альцгеймера.
- Распространённость увеличивается с возрастом.
- Факторы риска: гипертензия, диабет, гиперлипидемия, фибрилляция предсердий, курение, анамнез инсульта.

4. Этиология и патогенез

- Инсульт крупного сосуда (мультиинфарктная деменция).
- Болезнь мелких сосудов (субкортикальный лейкоареоз, лакунарные инфаркты — Бинсвангера).
- Стратегический инфаркт (таламический, гиппокампальный).
- Гипоперфузия (системная гипотензия, остановка сердца).
- CADASIL (аутосомно-доминантная субкортикальная деменция, NOTCH3).

5. Клиническая картина

- «Ступенчатое» снижение (в отличие от постепенного снижения при болезни Альцгеймера).
- Исполнительная функция, скорость обработки, внимание — доминируют, память относительно сохранна (отличие от болезни Альцгеймера).
- Очаговые неврологические признаки — гемипарез, дизартрия, экстрапирамидные нарушения, дефект поля зрения.
- Расстройства настроения (сосудистая депрессия), апатия, абулия — часто.
- Постуральные нарушения (походка, равновесие).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (NINDS-AIREN, VASCOG)

A. Достижение критериев Major NCD.

B. Клинические особенности соответствуют сосудистой этиологии: либо (1) ступенчатое снижение + анамнез инсульта, либо (2) доминирование исполнительной функции и скорости обработки.

C. При нейровизуализации — признаки сосудистой патологии: инфаркты, лейкоареоз, микрокровоизлияния.

D. Временная связь между когнитивным снижением и сосудистым событием (вероятная сосудистая деменция).

6.2 Различия между источниками

- VASCOG 2014 (Sachdev P. et al. Alzheimer Dis Assoc Disord) — зонтичный термин Vascular Cognitive Impairment.
- NICE NG97 — управление сосудистыми факторами риска.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант.
2. MoCA (обратить внимание на подшкалы исполнительных функций).
3. Неврологическое обследование — очаговые симптомы.
4. МРТ головного мозга (FLAIR — лейкоареоз, DWI — острые инфаркты, T2/SWI — микрокровоизлияния).
5. Сердечно-сосудистая оценка — артериальное давление, ЭКГ (фибрилляция предсердий), холтер, каротидное УЗИ, эхо.
6. Лабораторные — HbA1c, липиды, коагуляция, гипергомоцистеинемия.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Болезнь Альцгеймера (6D80)	Постепенное, доминирует память.
Смешанная деменция (болезнь Альцгеймера + сосудистая деменция)	В большинстве случаев; клиническое сочетание.
Тельца Леви (6D82)	Зрительные галлюцинации, паркинсонизм.
Лобно-височная деменция (6D83)	Доминирование личности/поведения.
Гидроцефалия нормального давления	Триада (нарушение походки, недержание мочи, когнитивное снижение).

Состояние	Отличительный признак
Депрессивная псевдодеменция	Аффективное, улучшение на фоне антидепрессантов.

7. Обследование и оценка

- MoCA, нейропсихологическое тестирование.
- МРТ, сердечно-сосудистое обследование.
- Лабораторная панель.

8. Лечение

1. Управление факторами сосудистого риска — первая линия:
    - Гипертензия (целевое САД <140, иногда <130);
    - Контроль диабета HbA1c;
    - Статин (липидный);
    - Антиагрегант (аспирин) или антикоагулянт (фибрилляция предсердий — DOAC);
    - Отказ от курения;
    - Физическая активность, диета.
2. AChEI и мемантин — ограниченная доказательная база при сосудистой деменции, но могут быть эффективны при смешанной деменции; NICE NG97 — рассматриваются при смешанной форме.
3. Ведение BPSD — в первую очередь нефармакологическое; антипсихотики ограничены (тот же FDA black box для болезни Альцгеймера).
4. Депрессия (васкулярная депрессия) — СИОЗС.
5. Реабилитация после инсульта — физио-, эрго-, логопедия.

8.1 Методики лечения

1. Управление сосудистым риском — Гипертензия, диабет, липиды, фибрилляция предсердий, курение.
2. AChEI/Мемантин при смешанной деменции — Донепезил, ривастигмин off-label при чистой сосудистой деменции (VaD); могут рассматриваться при смешанной форме.
3. Реабилитация после инсульта (англ. Stroke Rehabilitation) — Мультидисциплинарный.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG97 — управление сосудистым риском.
- Профилактика инсульта AHA/ASA.

9. Прогноз

- Управление факторами риска снижает темп прогрессирования.
- История инсульта и коморбидность определяют прогноз.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Сосудистая деменция полностью отличается от болезни Альцгеймера»

Доказательства: В большинстве случаев деменции — смешанная патология (Альцгеймер + СД); клиническая дифференциация иногда затруднена.

Миф 2: «Специфического лечения сосудистой деменции не существует»

Доказательства: контроль сосудистых факторов риска — вмешательство первой линии; профилактика особенно эффективна.

Миф 3: «Аспирин для профилактики деменции»

Доказательства: Исследование ASPREE (McNeil J.J. NEJM 2018) — первичная профилактика аспирином не показала доказательств как профилактика деменции; только в специфических показаниях для профилактики инсульта.

Миф 4: «Витамины и гомоцистеин — профилактика сосудистой деменции»

Доказательства: доказательства профилактики когнитивных нарушений витаминами, снижающими гомоцистеин, слабы.

Миф 5: «Ступенчатое снижение обязательно для диагностики сосудистой деменции»

Доказательства: постепенное снижение типично для мелкососудистой VaD; ступенчатое только при мультиинфарктной форме.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D81 Vascular dementia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. NICE NG97. 2018.
4. Sachdev P. et al. Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement. Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28(3):206–218.
5. McNeil J.J. et al. Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly (ASPREE). NEJM 2018;379(16):1499–1508.
6. Livingston G. et al. Lancet Commission 2024.

МКБ-11 **6D82**	**6D82 ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ (DLB)** **Dementia due to Lewy body disease**
МКБ-10 F02.8	Деменция при других уточнённых болезнях, классифицированных в других рубриках
DSM-5-TR G31.83 + F02.8x	Тяжёлое или лёгкое нейрокогнитивное расстройство с тельцами Леви

1. Определение и нозология

Деменция вследствие болезни с тельцами Леви (DLB; МКБ-11: 6D82; DSM-5-TR: G31.83 + F02.8x) — деменция, развивающаяся вследствие патологии α-синуклеина; классическая триада — когнитивные флуктуации, зрительные галлюцинации, паркинсонизм. Составляет 5–15% деменций.

Деменция при болезни Паркинсона (PDD) — та же патология, но деменция развивается не менее чем через 1 год после паркинсонизма; DLB и PDD составляют единый клинический спектр.

2. История

- Lewy F. (1912) — описание телец Леви при болезни Паркинсона.
- McKeith I. (1996, обновление 2017) — консенсусные критерии DLB.

3. Эпидемиология

- 5–15% случаев деменции; относительно выше у мужчин.
- Распространённость увеличивается в возрасте 65+.
- Коморбидность: депрессия, бред, расстройство поведения в REM-сне.

4. Этиология и патогенез

- Агрегация α-синуклеина — тельца Леви в коре и substantia nigra.
- Гены SNCA, LRRK2, GBA — фактор риска.

5. Клиническая картина

Четыре основных клинических признака (McKeith 2017)

- Когнитивные флуктуации — изменчивость внимания и бодрствования (часы-дни).
- Зрительные галлюцинации — полностью сформированные, повторяющиеся (образы людей, животных); пациент может быть относительно толерантен к галлюцинациям.
- Расстройство поведения в фазе быстрого сна (RBD) — может начаться за годы до когнитивного снижения.
- Паркинсонизм — один или более кардинальных признаков: брадикинезия, тремор покоя или ригидность (тремор обычно легче, чем при болезни Паркинсона).

Индикативные биомаркеры

- DAT-SPECT/ПЭТ (123I-FP-CIT) — снижение захвата переносчика дофамина в базальных ганглиях.
- Сцинтиграфия миокарда с 123I-МИБГ — патологически низкий захват.
- Полисомнография — подтверждение REM-сна без атонии.

Поддерживающие клинические признаки

- Тяжёлая чувствительность к антипсихотикам — реакция, подобная злокачественному нейролептическому синдрому (в диагностический алгоритм не входит).
- Постуральная неустойчивость, повторные падения, синкопе, тяжёлая вегетативная дисфункция, гиперсомния, гипосмия, систематизированный бред, апатия, тревога, депрессия.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (McKeith 2017)

Probable DLB: 2+ основных клинических признака (независимо от биомаркеров), либо 1 основной признак + 1 или более индикативных биомаркеров. Диагноз не может основываться только на биомаркерах.

Possible DLB: только 1 основной клинический признак без индикативных биомаркеров; либо 1 или более индикативных биомаркеров при отсутствии основных клинических признаков.

6.2 Различия между источниками

- McKeith I. et al. Neurology 2017 — диагностический консенсус.
- DAT-SPECT или сцинтиграфия миокарда с 123I-МИБГ — индикативные биомаркеры (не поддерживающие).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант (особенно RBD).
2. MoCA, MMSE, нейропсихологическое (доминируют зрительно-пространственные и исполнительные функции).
3. Неврологическое обследование.
4. МРТ головного мозга (меньшая гиппокампальная атрофия, чем при болезни Альцгеймера).
5. DAT-SPECT (при показаниях).
6. Полисомнография — подтверждение RBD.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Болезнь Альцгеймера (6D80)	Доминируют нарушения памяти, зрительные галлюцинации минимальны.
Деменция при болезни Паркинсона (PDD)	Деменция развивается через ≥ 1 год после паркинсонизма (правило 1 года).
Сосудистая деменция (6D81)	История инсульта, МРТ.
Делирий (6D70)	Острое начало; флуктуации схожи.

Состояние	Отличительный признак
Шизофрения с поздним началом	Деменция отсутствует.

7. Обследование и оценка

- MoCA, нейропсихологическое тестирование.
- Полисомнография (RBD).
- DAT-SPECT.
- МРТ головного мозга.

8. Лечение

1. AChEI (ривастигмин, донепезил) — Особенно эффективен при DLB (кортикальное снижение ацетилхолина более выражено, чем при болезни Альцгеймера); ривастигмин, РКИ McKeith I. Lancet 2000.
2. Мемантин — при среднетяжёлой и тяжёлой степени.
3. Паркинсонизм — леводопа с осторожностью; может усиливать психотические симптомы.
4. При зрительных галлюцинациях: нефармакологические меры в первую очередь. При рефрактерности кветиапин или клозапин в низкой дозе; типичные антипсихотики (галоперидол) и рисперидон противопоказаны — тяжёлая реакция нейролептической гиперчувствительности.
5. RBD — мелатонин (3–12 мг на ночь) или клоназепам (низкая доза).
6. При BPSD нефармакологические меры в первую очередь.
7. FDA black box антипсихотиков у пожилых пациентов с деменцией.

8.1 Методики лечения

1. Ривастигмин (AChEI) — Особенно эффективен при DLB; пластырь и пероральная форма.
2. Кветиапин/клозапин (рефрактерный психоз) — Низкая доза; клозапин наиболее безопасен, но требует мониторинга.
3. Мелатонин при RBD — 3–12 мг на ночь.
4. DAT-SPECT — Индикативный диагностический биомаркер.

8.2 Различия между источниками

- McKeith I. Lancet 2000 — ривастигмин при DLB.
- NICE NG97 — ривастигмин или донепезил при DLB.

- Чувствительность к антипсихотикам — обзоры McKeith I.

9. Прогноз

- Средняя ожидаемая продолжительность жизни 5–8 лет после диагноза; иногда короче, чем при болезни Альцгеймера.
- Антипсихотическая реакция — критическое осложнение.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «DLB — это лишь подтип болезни Альцгеймера»

Доказательства: отдельная патологическая и клиническая единица; α-синуклеин vs амилоид-β/тау; критическое различие — чувствительность к антипсихотикам.

Миф 2: «Галоперидол безопасен при DLB»

Доказательства: галоперидол и рисперидон противопоказаны — нейролептический злокачественный синдром-подобная реакция, высокий риск летальности.

Миф 3: «Зрительные галлюцинации всегда требуют лечения»

Доказательства: некоторые пациенты толерантны к галлюцинациям; если они не вызывают дистресс — иной подход.

Миф 4: «Леводопа полностью излечивает паркинсонизм при DLB»

Доказательства: Ответ на леводопу меньше, чем при болезни Паркинсона; может усиливать психотические симптомы; требуется баланс.

Миф 5: «RBD — незначимый симптом»

Доказательства: RBD является продромом α-синуклеинопатии (DLB, болезнь Паркинсона, MCA) — риск развития в будущем 80%+ в течение 10–15 лет.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D82 Dementia due to Lewy body disease. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. McKeith I.G. et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report. Neurology 2017;89(1):88–100.

4. McKeith I. et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356(9247):2031–2036.
5. NICE NG97. 2018.

МКБ-11 **6D83**	**6D83 ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ (FTD)** **Frontotemporal dementia**
МКБ-10 F02.0	Деменция при болезни Пика
DSM-5-TR G31.09 + F02.8x	Тяжёлое или лёгкое нейрокогнитивное расстройство вследствие лобно-височной долевой дегенерации

1. Определение и нозология

Лобно-височная деменция (FTD; МКБ-11: 6D83; DSM-5-TR: G31.09 + F02.8x) — деменция, развивающаяся вследствие атрофии лобных и/или височных долей; типичное начало в возрасте 45–65 лет (наиболее частая из деменций с ранним началом). Три клинических варианта: bvFTD (поведенческий вариант) и две формы PPA (первичная прогрессирующая афазия — семантическая и небеглая).

2. История

- Pick A. (1892) — «Болезнь Пика» — описание лобно-височной атрофии.
- Neary D. et al. (1998) — Клинические консенсусные критерии FTD.
- Rascovsky K. et al. (2011) — обновлённые критерии bvFTD.

3. Эпидемиология

- 5–10% случаев деменции до 65 лет; после 65 лет доминирует болезнь Альцгеймера.
- Пол: равное соотношение.

- Семейный анамнез более 40%.
- Коморбидность: БАС (Боковой Амиотрофический Склероз) — спектр ЛБД-БАС (мутация C9orf72).

4. Этиология и патогенез

- Генетические (40%) — мутации C9orf72 (наиболее частые), MAPT, GRN.
- Патологические — тау (тельца Пика, MAPT), TDP-43 (TDP-43A, B, C, D, GRN, C9orf72), белки FUS.

5. Клиническая картина

bvFTD (поведенческий вариант, ~60% FTD)

- Раннее изменение личности — апатия, расторможенность, социально неадекватное поведение, утрата эмпатии.
- Стереотипное поведение (ритуалистическое).
- Гипероральное поведение (изменение пищевых предпочтений, «сладкоежка»).
- Исполнительная функция значительно нарушена; память и зрительно-пространственные функции на начальном этапе относительно сохранены.

PPA — Primary Progressive Aphasia

- Non-fluent variant (nfvPPA) — трудности с грамматикой, замедленная речь, апраксия речи.
- Semantic variant (svPPA) — потеря смысла слов, агнозия; беглая, но пустая речь.
- Логопенический — связанный с болезнью Альцгеймера, отдельно.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (Rascovsky 2011 bvFTD; Gorno-Tempini 2011 PPA)

bvFTD (Probable): ≥ 3 из 6 поведенческих симптомов (расторможенность, апатия, потеря эмпатии, стереотипное поведение, гипероральность, исполнительная дисфункция) + функциональное нарушение + нейровизуализационная поддержка.

PPA: основной дефицит речи; подвариант на основе клинической и нейровизуализационной картины.

6.2 Различия между источниками

- Rascovsky K. et al. Brain 2011 — bvFTD.
- Gorno-Tempini M.L. et al. Neurology 2011 — ППА.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + информант (изменение поведения).
2. Нейропсихологическая батарея (исполнительная функция, речь).
3. МРТ головного мозга — фронтальная и/или височная атрофия.
4. ФДГ-ПЭТ — гипометаболизм.
5. Генетический тест (семейный анамнез).
6. Скрининг БАС (клинический или электромиография).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Болезнь Альцгеймера (6D80)	Доминируют нарушения памяти, позднее начало.
Шизофрения с поздним началом	Атрофия отсутствует.
Мания, депрессия	Аффективные эпизоды.
Биполярное расстройство	Аффективная цикличность.
Расстройство личности	Стойкое, многолетнее; при FTD изменение — новое.
Опухоль головного мозга	МРТ.

7. Обследование и оценка

- FAB (англ. Frontal Assessment Battery), нейропсихологическое тестирование.
- МРТ, ФДГ-ПЭТ.
- Генетическое тестирование.
- Скрининг на БАС.

8. Лечение

1. Специфического болезнь-модифицирующего препарата нет — патогистологическое лечение пока не подтверждено (клинические исследования продолжаются).
2. AChEI — неэффективны при FTD или вредны (могут ухудшить поведение), тогда как при болезни Альцгеймера они эффективны.
3. СИОЗС — для поведенческих симптомов при лобно-височной деменции (дезингибиция, компульсивность, депрессия); некоторые доказательства.
4. Тразодон — при ажитации; исследования Lebert F. et al.
5. Атипичный антипсихотик — только при тяжёлом поведенческом расстройстве, краткосрочно, по правилу FDA black box.
6. Поддержка ухаживающего лица и психообразование критичны (поведенческие симптомы тяжелы для семьи).
7. Нутритивная поддержка (контроль гиперорального поведения).
8. Правовое и финансовое планирование.

8.1 Методики лечения

1. СИОЗС при bvFTD — Циталопрам, сертралин — поведенческие симптомы.
2. Тразодон — Ажитация, сон.
3. Нефармакологические методы — Модификация среды, структура, обучение ухаживающего персонала.
4. Логопедическая терапия (англ. Speech-Language Therapy, SLT) — Для PPA; компенсаторные стратегии.
5. Генетическая консультация — Для членов семьи.

8.2 Различия между источниками

- NICE NG97 — не рекомендует AChEI при FTD.
- Lebert F. et al. Dement Geriatr Cogn Disord 2004 — тразодон.

9. Прогноз

- Средняя ожидаемая продолжительность жизни после постановки диагноза 6–11 лет; FTD-ALS короче (3 года).
- Быстрое снижение при некоторых мутациях.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «FTD — это подтип болезни Альцгеймера»

Доказательства: отдельная патологическая и клиническая единица; патологии тау, TDP-43, FUS; AChEI неэффективны.

Миф 2: «AChEI можно применять при всех деменциях»

Доказательства: При FTD AChEI неэффективны или вредны; NICE NG97 не рекомендует.

Миф 3: «Изменение поведения — исключительно психиатрическая проблема»

Доказательства: раннее начало поведенческих изменений (45–65 лет) должно вызывать подозрение на FTD; нейровизуализация важна.

Миф 4: «Если нет семейного анамнеза, лобно-височная деменция не является генетической»

Доказательства: 40% случаев имеют семейный анамнез; возможны также спорадические случаи; экспансия C9orf72 может быть скрытой.

Миф 5: «Поведение пациента с FTD произвольно»

Доказательства: изменение поведения нейробиологическое — дисфункция лобной доли; нарушен волевой контроль.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6D83 Dementia due to frontotemporal lobar degeneration. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Rascovsky K. et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain 2011;134(Pt 9):2456–2477.
4. Gorno-Tempini M.L. et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology 2011;76(11):1006–1014.
5. NICE NG97. 2018.
6. Lebert F. et al. Frontotemporal dementia: a randomised, controlled trial with trazodone. Dement Geriatr Cogn Disord 2004;17(4):355–359.

6E20–6E2Z ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium

МКБ-11 **6E20**	**6E20 ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ ИЛИ ПОСЛЕРОДОВЫМ ПЕРИОДОМ, БЕЗ ПСИХОТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, without psychotic symptoms**
МКБ-10 F53.0	Лёгкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
DSM-5-TR —	Спецификатор «с перипартальным началом» (отдельной категории в DSM-5-TR нет)

1. Определение и нозология

Послеродовая депрессия (МКБ-11: 6E20 Mental and Behavioural Disorders Associated with Pregnancy, Childbirth or the Puerperium; DSM-5-TR: F32.x / F33.x Major Depressive Disorder with peripartum onset specifier) — большой

депрессивный эпизод, развивающийся после родов (обычно в первые 6 месяцев; по некоторым указаниям — 1 год). Поражает 10–15% женщин.

2. История

- Marcé L.V. (1858) — первое клиническое описание послеродового психоза и депрессии.
- EPDS — Cox J.L. et al. (1987) — Edinburgh Postnatal Depression Scale.
- NICE CG192 (2014, 2018) — антенатальное и постнатальное психическое здоровье.
- FDA — брексанолон (2019), зуранолон (2023) — первые специально одобренные препараты для послеродовой депрессии.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 10–15% (страны с высоким доходом), 20–30% (страны с низким и средним доходом).
- Бэби-блюз — более лёгкое, кратковременное состояние (1–2 недели), встречается у 50–80% женщин; не требует клинического вмешательства.
- Коморбидность: тревога, ОКР, паническое расстройство.
- Факторы риска: предшествующая депрессия, семейный анамнез, депрессия во время беременности, отсутствие поддержки партнёра, социально-экономический стресс.

4. Этиология и патогенез

- Гормональное — резкое падение эстрогена и прогестерона после родов; дисрегуляция аллопрегнанолона.
- Нарушение сна, связанное с уходом за новорождённым.
- Психосоциальный стресс, отношения, социальная поддержка.
- Генетический анамнез и предшествующее аффективное расстройство.

5. Клиническая картина

- Симптомы большого депрессивного эпизода (нарушение сна, снижение аппетита, ангедония, чувство никчёмности, суицидальные мысли).
- Специфические особенности: аффективная дистанция по отношению к младенцу, трудности с привязанностью к ребёнку, убеждённость в неспособности справиться с материнской ролью, интрузивные мысли о

вреде младенцу (эгодистонические — сходны с ОКР; отличаются от послеродового психоза).

- Суицидальный риск и, в редких случаях, детоубийство (выше при послеродовом психозе).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

Критерии большого депрессивного эпизода (DSM-5-TR 5+ симптомов в течение 2 недель; МКБ-11) + перипартальный спецификатор (DSM-5-TR — во время беременности или в течение 4 недель после родов; МКБ-11 — более широкий, до 6 месяцев–1 года).

6.2 Различия между источниками

- NICE CG192 (2014, 2018) — диагностика и лечение.
- ACOG Committee Opinion 757 (2018) — скрининг перинатальной депрессии.
- USPSTF — скрининг у беременных и послеродовых женщин.

6.3 Алгоритм диагностики

1. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale, 10 пунктов) — золотой стандарт скрининга; cut-off ≥ 10 — возможная депрессия (чувствительный порог скрининга), ≥ 13 — вероятная большая депрессия.
2. Клиническое интервью (оценка необходимости госпитализации и суицидального риска).
3. Различие послеродового психоза — при наличии психотических симптомов экстренная госпитализация.
4. Медицинская оценка — щитовидная железа (послеродовой тиреоидит), анемия.
5. Скрининг коморбидной тревоги, ОКР.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Бэби-блюз	≤ 2 недель, лёгкая, не требует клинического вмешательства.

Состояние	**Отличительный признак**
Послеродовой психоз (6E21)	Психотические симптомы; экстренная госпитализация.
Биполярный депрессивный эпизод	Наличие в анамнезе маниакального/гипоманиакального эпизода.
Послеродовой тиреоидит	TSH.
Анемия	Гемоглобин.
Послеродовое ОКР	Эго-дистонические интрузивные мысли о вреде ребёнку; коморбидная послеродовая депрессия.

7. Обследование и оценка

- EPDS, PHQ-9.
- C-SSRS — риск суицида и вреда для младенца.
- ТТГ, гемоглобин.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG192 · ACOG · APA)

1. Лёгкая-умеренная: психотерапия первой линии — КПТ, ИПТ (особенно адаптированная к перинатальному контексту).
2. Умеренно-тяжёлая: психотерапия + СИОЗС. В контексте грудного вскармливания:
    - Сертралин (наименьшее проникновение в грудное молоко) и пароксетин — первая линия;
    - Флуоксетин — длительный период полувыведения, с осторожностью;
    - Циталопрам, эсциталопрам — подходят.
3. Рефрактерная тяжёлая PPD:
    - Brexanolone (Zulresso) — в/в 60-часовая инфузия; одобрение FDA 2019; контроль в клинике по программе REMS; быстрый эффект.
    - Zuranolone (Zurzuvae) — перорально 14 дней; одобрение FDA 2023; более удобно.

4. ЭСТ — психотическая депрессия, высокий суицидальный риск, нарушение приёма пищи, безопасно при беременности.
5. Семейная поддержка, поддержка сверстников (напр. PND helpline).
6. Социальная служба и поддержка привязанности матери и ребёнка.
7. Гигиена сна и вовлечение членов семьи в ночной уход.

8.2 Методики лечения

1. Перинатальная интерперсональная терапия (ИПТ) — Стюарт (Stuart S.), Робертсон (Robertson M.) — Переходы материнской роли, партнёрские отношения, система социальной поддержки.
2. КПТ, адаптированная для перинатального периода — Когнитивные нарушения, поведенческая активация.
3. Brexanolone (Zulresso) — в/в 60 часов; программа REMS; контроль в клинике.
4. Эдинбургская шкала постнатальной депрессии (англ. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) — самооценка из 10 пунктов.
5. ЭСТ — Безопасна при беременности и грудном вскармливании; в тяжёлых рефрактерных случаях.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG192 — сертралин и пароксетин первой линии при грудном вскармливании.
- Louik C. et al. NEJM 2007 · Huybrechts K.F. et al. NEJM 2014 — СИОЗС при беременности и сердечные мальформации (пароксетин с осторожностью).
- Meltzer-Brody S. et al. Lancet 2018 — брексанолон РКИ.

9. Прогноз

- При адекватном лечении ремиссия 70–80%.
- Риск рецидива в последующих беременностях (~25%).
- Без лечения — хронизация и коморбидность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «PPD — это обычная „детская хандра“, временное состояние»

Доказательства: baby blues ≤ 2 недель, лёгкая форма; PPD — клинический депрессивный эпизод, требует вмешательства; может длиться долго.

Миф 2: «Антидепрессанты опасны при грудном вскармливании»

Доказательства: сертралин и пароксетин допустимы при грудном вскармливании; проникновение в молоко минимально; клиническая консультация.

Миф 3: «Мать слаба, она должна „справиться сама“»

Доказательства: PPD — клиническое состояние; существует риск суицида и инфантицида; требует вмешательства.

Миф 4: «Брексанолон излечивает послеродовую депрессию»

Доказательства: даёт быстрый эффект, но стоимость и необходимость контроля в клинике значительны; стандартный подход — СИОЗС + психотерапия.

Миф 5: «PPD не влияет на ребёнка»

Доказательства: PPD влияет на связь мать-младенец, когнитивное и эмоциональное развитие ребёнка; раннее вмешательство важно.

Миф 6: «Навязчивые мысли (навредить младенцу) всегда являются признаком психоза»

Доказательства: при послеродовом ОКР интрузивные мысли эго-дистонны — пациент от них страдает и избегает их; при послеродовом психозе — эго-синтонны и могут переходить в поведение — разное вмешательство.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E20 Mental and behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth and the puerperium. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG192. Antenatal and postnatal mental health. 2014, 2018 update.
4. ACOG Committee Opinion No. 757: Screening for Perinatal Depression. 2018.
5. Cox J.L., Holden J.M., Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987;150:782–786.
6. Meltzer-Brody S. et al. Brexanolone injection in post-partum depression. Lancet 2018;392(10152):1058–1070.
7. Deligiannidis K.M. et al. Effect of zuranolone vs placebo in postpartum depression. JAMA Psychiatry 2021;78(9):951–959.

8. Louik C., Lin A.E., Werler M.M., Hernández-Díaz S., Mitchell A.A. First-trimester use of selective serotonin-reuptake inhibitors and the risk of birth defects. N Engl J Med 2007;356(26):2675–2683.
9. Huybrechts K.F., Palmsten K., Avorn J. et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med 2014;370(25):2397–2407.
10. Stuart S., Robertson M. Interpersonal Psychotherapy: A Clinician's Guide. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2012.

МКБ-11 **6E21**	**6E21 ПСИХИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ ИЛИ ПОСЛЕРОДОВЫМ ПЕРИОДОМ, С ПСИХОТИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, with psychotic symptoms**
МКБ-10 F53.1	Тяжёлые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
DSM-5-TR F23	Краткое психотическое расстройство, с перипартальным началом

1. Определение и нозология

Послеродовой психоз (ПРП; МКБ-11: 6E21; DSM-5-TR: Кратковременное психотическое расстройство или биполярное расстройство I типа со спецификатором послеродового начала) — остро возникший психотический эпизод после родов (обычно в первые 2 недели); галлюцинации, бред, когнитивная дезорганизация, лабильность настроения. Это медицинская неотложная ситуация — высокий риск детоубийства (~4%) и суицида матери.

2. История

- Marcé L.V. (1858) — классическое описание послеродового психоза.
- Bergink V. et al. (2015) — 4-ступенчатый алгоритм лечения.
- NICE CG192 — перипартальные психические состояния.

3. Эпидемиология

- Заболеваемость: 1–2/1000 рождений.
- У женщин с биполярным расстройством в анамнезе — 25–50%; при ПРП в анамнезе — 30%.
- Коморбидность: в большинстве случаев биполярное расстройство как основное.
- Смертность: детоубийство 4%, суицид до 5% (без лечения).

4. Этиология и патогенез

- Гормональное — резкое падение эстрогена и прогестерона после родов.
- Депривация сна.
- Предрасположенность к биполярному расстройству (большинство ПРП — проявление биполярного эпизода).
- Семейный анамнез.

5. Клиническая картина

- Быстрое начало (24–72 часа, типично в первые 2 недели).
- Полиморфные психотические симптомы — бред (особенно о младенце — младенец «дьявол» или «одержимый»; мать «должна избавиться»), галлюцинации.

- Лабильность настроения — маниакальные или депрессивные компоненты.
- Когнитивная дезорганизация, спутанность.
- Тяжёлое нарушение сна.
- Поведение — странное, чрезмерное; нарушение ухода за младенцем.
- Высокий риск: суицид матери, вред младенцу (инфантицид).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

Клинический диагноз: острый психотический эпизод с началом после родов; кодируется в категории биполярного маниакального эпизода или острого психотического расстройства + уточнитель перипартального начала.

6.2 Различия между источниками

- NICE CG192 — неотложное медицинское состояние.
- RCPsych (англ. Royal College of Psychiatrists) — стандарты перинатальной психиатрической помощи.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью — быстрое начало, характер симптомов.
2. Медицинская оценка — исключение послеродовых медицинских состояний (тиреоидит, инфекция, энцефалопатия, эклампсия, дефицит B12).
3. Лабораторные — TSH, общий анализ крови, электролиты, печёночные, почечные, аммиак, глюкоза, маркеры инфекции.
4. МРТ головного мозга и ЭЭГ — при атипичной презентации или неврологических симптомах (аутоиммунный энцефалит — особенно anti-NMDA-R!).
5. Токсикологический скрининг.
6. Оценка риска суицида и детоубийства (C-SSRS, безопасность младенца).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Послеродовая депрессия (6E20)	Психотические симптомы отсутствуют.

Состояние	Отличительный признак
Послеродовое ОКР	Эго-дистонические интрузивные мысли; инсайт сохранён.
Делирий (6D70)	Колебания внимания; медицинская причина (инфекция).
Анти-NMDA-R энцефалит	Атипичный психоз + двигательные симптомы + припадки; CSF антитела; классическая презентация у молодой женщины!
Эклампсия/HELLP	Гипертензия, протеинурия, тромбоцитопения.
Синдром Шихана	Гипопитуитаризм (постгеморрагический).

7. Обследование и оценка

- Клиническая психиатрия и неврология.
- Приведённая выше медицинская панель.
- Антитела к NMDA-R (CSF) — в атипичных случаях.
- C-SSRS, безопасность младенца.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (NICE CG192 · Bergink 2015)

1. Срочная госпитализация обязательна — для матери и ребёнка; по возможности Mother-Baby Unit (совместная госпитализация матери и ребёнка).
2. 4-ступенчатый алгоритм Bergink (Am J Psychiatry 2015):
    - Шаг 1: Бензодиазепин (лоразепам) для острой стабилизации;
    - Шаг 2: Атипичный антипсихотик (оланзапин, кветиапин, рисперидон);
    - Шаг 3: Добавление лития;
    - Шаг 4: ЭСТ при рефрактерных или кататонических особенностях.
3. При биполярном расстройстве в большинстве случаев — литий первой линии. Вальпроат противопоказан женщинам детородного возраста и

допустим только при выполнении условий Программы предотвращения беременности (EMA/MHRA 2018); при биполярном расстройстве во время беременности противопоказан абсолютно.

4. Решение о грудном вскармливании — литий — относительное противопоказание (проникает в молоко); оланзапин и кветиапин относительно безопасны; обсуждение с пациентом и семьёй.
5. Риск рецидива в последующих беременностях высок (~30–40%) — профилактический литий рассматривается в пери- и послеродовом периоде.
6. ЭСТ — безопасна во время беременности и в послеродовом периоде; быстрый эффект.
7. Мультидисциплинарная координация — психиатр, акушер-гинеколог, педиатр, социальный работник.

8.2 Методики лечения

1. 4-ступенчатый алгоритм Бергинка (Bergink) — Бензодиазепин → антипсихотик → литий → ЭСТ.
2. Отделение «Мать и дитя» (MBU — Mother-Baby Unit) — Совместная госпитализация матери и младенца; сохранение привязанности и безопасность.
3. ЭСТ в послеродовом периоде — Безопасен при беременности и грудном вскармливании; быстрый эффект; первая линия при кататонических чертах.
4. Профилактический литий при последующих беременностях — Bergink V. et al. Am J Psychiatry 2012 — профилактика рецидивов в пери- и послеродовом периоде.

8.3 Различия между источниками

- NICE CG192 — рекомендация по Mother-Baby Unit.
- Bergink V. et al. Am J Psychiatry 2015 — доказательная база 4-ступенчатого алгоритма.

9. Прогноз

- При адекватном лечении полное восстановление у большинства пациентов.
- Риск рецидива в последующих беременностях высок (~30–40%).
- Важно долгосрочное ведение биполярного расстройства.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ПРП — это сильное проявление „материнских чувств“»

Доказательства: клиническое психотическое состояние; высокий риск инфантицида и суицида; экстренное вмешательство.

Миф 2: «Достаточно наблюдения в домашних условиях»

Доказательства: NICE CG192 — обязательная госпитализация; предпочтительно MBU.

Миф 3: «Антипсихотики и литий запрещены при грудном вскармливании»

Доказательства: оланзапин и кветиапин относительно безопасны при грудном вскармливании; литий проникает в молоко, но может быть рекомендован при мониторинге ребёнка; индивидуальный баланс.

Миф 4: «При последующей беременности не повторится»

Доказательства: при ПРП в анамнезе рецидив ~30–40% (без профилактики до 44%); профилактический план обязателен.

Миф 5: «Анти-NMDA-рецепторный энцефалит редок, искать не нужно»

Доказательства: атипичный психоз + двигательные симптомы + приступы у молодой женщины — классическая картина анти-NMDA-R энцефалита; тест на антитела принципиально важен.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E21 Puerperal psychosis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG192. 2014/2018.
4. Bergink V. et al. Treatment of psychosis and mania in the postpartum period. Am J Psychiatry 2015;172(2):115–123.
5. Bergink V. et al. Prevention of postpartum psychosis and mania in women at high risk. Am J Psychiatry 2012;169(6):609–615.
6. Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 (autoimmune encephalitis).

6E40 ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Psychological or behavioural factors affecting disorders classified elsewhere

МКБ-11 **6E40**	**6E40 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РАССТРОЙСТВ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ В ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ** **Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere**
МКБ-10 F54	Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках
DSM-5-TR F54	Психологические факторы, влияющие на другие медицинские состояния

1. Определение и нозология

Психологические и поведенческие факторы, влияющие на развитие расстройств или заболеваний, классифицированных в других разделах (МКБ-11: 6E40; DSM-5-TR: F54 Psychological Factors Affecting Other Medical Conditions) — психологические факторы, влияющие на течение соматического

заболевания (депрессия, тревога, приверженность лечению, стресс, убеждения о болезни).

Отличается от имитированного расстройства (6D50) и расстройства с соматическими симптомами (6C20) — здесь имеется подтверждённое медицинское заболевание, но психологические факторы влияют на течение.

2. История

- Alexander F. (1950) — концептуализация «психосоматической медицины».
- Engel G.L. (1977) — «биопсихосоциальная модель».
- Levenson J.L. (2018) — APA Textbook of Psychosomatic Medicine.

3. Эпидемиология

- Универсально — при всех хронических соматических заболеваниях психологические факторы влияют на течение.
- Депрессия при сердечно-сосудистых заболеваниях — 20–40%; диабет — 25%; рак — 15–25%.
- Широкое использование услуг консультативно-связующей (liaison) психиатрии.

4. Этиология и патогенез

Биопсихосоциальное взаимодействие — биологическая предрасположенность + психологические факторы + социальный контекст.

5. Клиническая картина

- Коморбидная депрессия/тревога влияет на течение заболевания (напр., повышение смертности после инфаркта миокарда).
- Нарушение приверженности лечению (комплаенс).
- Ошибочные убеждения о болезни.
- Ухудшение течения болезни из-за стресса.
- Поведенческие факторы (курение, алкоголь, диета, физическая пассивность).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Подтверждённое медицинское заболевание присутствует.

B. Психологические или поведенческие факторы влияют на течение заболевания:

1. Снижает ответ на лечение;
2. Повышает риск для здоровья;
3. Ухудшает патофизиологический процесс;
4. Изменяет потребность в медицинском вмешательстве.

C. Имитированное расстройство или соматический симптом не объясняется лучше другим психическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.
- Модель консультативно-связующей (liaison) психиатрии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Оценка соматического заболевания.
2. Идентификация психологических факторов — депрессия (PHQ-9), тревога (GAD-7), приверженность лечению (Morisky).
3. Поведенческие факторы — курение, алкоголь, диета, физическая активность.
4. Скрининг коморбидных психических расстройств.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Соматическое симптоматическое расстройство (6C20)	Соматическая жалоба доминирует.
Искусственное расстройство (6D50)	Сознательная ложь.
БДР с коморбидным заболеванием	Аффективные симптомы достигают независимых критериев — отдельный диагноз.

7. Обследование и оценка

- PHQ-9, GAD-7, Morisky.
- Болезнь-специфические шкалы (англ. Diabetes Distress Scale, Beck-cardiac, DDS).

8. Лечение

1. Интегрированный мультидисциплинарный подход — соматический специалист + психиатр + психолог.
2. Болезнь-специфическое психосоциальное вмешательство:
    - Кардиальная КПТ (постинфарктная депрессия);
    - Обучение самоконтролю диабета (DSME);
    - Мониторинг онкологического дистресса;
    - Хроническая боль: КПТ и АКТ.
3. Антидепрессант — профиль побочных эффектов, специфичный для заболевания:
    - Кардиальные — сертралин, эсциталопрам;
    - Онкология — миртазапин (польза для сна, аппетита);
    - Хроническая боль — дулоксетин, амитриптилин.
4. Мотивационное интервью — изменение поведения (курение, физическая активность).

8.1 Методики лечения

1. Консультативно-связная (лиазонная) психиатрия — интегрированная служба в медико-хирургических отделениях.
2. КПТ при кардиальной патологии — Ведение пост-ИМ депрессии.
3. Обучение самоконтролю диабета (DSME — Diabetes Self-Management Education) — Тренинг самоконтроля диабета.
4. КПТ и АКТ при хронической боли — Williams Cochrane 2020.

8.2 Различия между источниками

- NICE CG91 — КПТ при депрессии у кардиологических пациентов.
- Levenson J.L. APA Textbook of Psychosomatic Medicine 2018.

9. Прогноз

При интегрированном подходе улучшаются как соматические, так и психологические результаты.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Заболевание имеет исключительно психологическое происхождение»

Доказательства: Биопсихосоциальная модель — психологические факторы оказывают влияние, но сами по себе не вызывают соматическое заболевание.

Миф 2: «Психиатр „избегает“ болезни»

Доказательства: интегративный подход — соматическое и психиатрическое вмешательство параллельно.

Миф 3: «Альтернативная медицина (йога, осознанность) излечивает соматические заболевания»

Доказательства: дополнительные вмешательства являются адъюнктивными; не заменяют стандартное соматическое лечение (онкологическое, кардиологическое).

Миф 4: «Сказать пациенту „ты заболел из-за стресса“ терапевтично»

Доказательства: этот подход является обвинительным и нарушает терапевтические отношения.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E40 Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.
4. NICE NG185. Acute coronary syndromes. 2020.
5. Whooley M.A., Wong J.M. Depression and cardiovascular disorders. Annu Rev Clin Psychol 2013;9:327–354.

6E60–6E6Z ВТОРИЧНАЯ ПСИХИАТРИЯ

Secondary mental or behavioural syndromes

МКБ-11 **6E61**	**6E61 ВТОРИЧНЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ** **Secondary psychotic syndrome**
МКБ-10 F06.2	Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство
DSM-5-TR F06.2	Психотическое расстройство вследствие другого медицинского состояния, с бредом

1. Определение и нозология

Вторичный психотический синдром (МКБ-11: 6E61 Secondary Psychotic Syndrome; DSM-5-TR: F06.2/F06.0 Psychotic Disorder Due to Another Medical Condition) — психотический эпизод, развивающийся в контексте другого медицинского состояния (аутоиммунного, инфекционного, эндокринного, метаболического, неврологического) или вещества. Вмешательство первой линии — лечение, направленное на основную этиологию.

2. История

- Термин «симптоматический психоз» сформировался в XX веке.
- Dalmau J. (2007) — открытие анти-NMDA-R энцефалита; революция в аутоиммунном психозе.
- Graus F. et al. (2016) — клиническое руководство по аутоиммунному энцефалиту.

3. Эпидемиология

- 3–8% всех случаев первого эпизода психоза имеют вторичную этиологию.

- Анти-NMDA-R энцефалит — редкий, но обратимый психоз у молодых женщин; паранеопластический с тератомой.
- Гепатоцеребральная энцефалопатия, волчаночная энцефалопатия.

4. Этиология и патогенез

- Аутоиммунные причины: анти-NMDA-R, анти-LGI1, анти-CASPR2 энцефалит; Хашимото (антитела к ТРО); волчанка (НПСВК).
- Инфекционные: ВИЧ, сифилис, герпетический энцефалит, COVID-19.
- Эндокринные причины: гипер/гипотиреоз, нарушения кортизола (Кушинг, Аддисон), нарушения паращитовидных желез (гиперкальциемия).
- Метаболические причины: Уремия, печёночная энцефалопатия, гипонатриемия, гипо/гипергликемия, дефицит B12, болезнь Вильсона.
- Неврологические причины: опухоль мозга, инсульт, эпилепсия (постиктальная), деменция.
- Вещество-индуцированное: амфетамин, кокаин, каннабис, галлюциноген, отмена алкоголя, стероиды.
- Паранеопластические причины: овариальная тератома (анти-NMDA-R), мелкоклеточный рак лёгкого.

5. Клиническая картина

- Психотические симптомы (бред, галлюцинации, дезорганизованное поведение).
- Атипичные особенности (характерные для аутоиммунного энцефалита):
    - Быстрое начало;
    - Двигательные симптомы (кататонические, дистонии, орофациальная дискинезия);
    - Вегетативное расстройство (гипертензия, тахикардия, гипертермия);
    - Приступы;
    - Нарушение сознания.
- По сравнению с классическим психозом (шизофренией) — атипичная презентация вызывает подозрение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Психотические симптомы.

B. Доказательства медицинского состояния (аутоиммунного, инфекционного, эндокринного, метаболического, неврологического) или воздействия вещества.

C. Психоз не возникает в контексте делирия (но может совпадать с делирием).

D. Не объясняется лучше другим первичным психотическим расстройством.

6.2 Различия между источниками

- Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 — клинический подход к аутоиммунному энцефалиту.
- МКБ-11 — психоз, вызванный веществом, сюда НЕ относится: он рассматривается в главе о веществах (6C40.6 алкоголь, 6C41.6 каннабис и т. д.). 6E61 — только для состояний здоровья вне главы психических расстройств и ставится вместе с диагнозом основного заболевания.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое подозрение — новый психоз, особенно с атипичными особенностями или у молодой женщины.
2. Медицинская оценка:
    - Общий анализ крови, печень/почки, электролиты (Na, Ca), глюкоза, аммиак;
    - ТТГ, антитела к ТПО (Хашимото);
    - Уровень кортизола (Кушинг/Аддисон);
    - ВИЧ, сифилис;
    - АНА, волчаночная панель;
    - B12, фолат, церулоплазмин (Wilson);
    - Токсикологический скрининг.
3. МРТ головного мозга.
4. ЭЭГ — бессудорожный статус, энцефалит.
5. Люмбальная пункция — плеоцитоз, панель антител (anti-NMDA-R, anti-LGI1, anti-CASPR2, паранеопластические).

6. Скрининг опухоли (при положительных паранеопластических антителах — УЗИ яичников, МРТ таза, КТ грудной клетки).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Шизофрения (6A20)	Медицинская причина отсутствует; типичное клиническое течение.
Острое и преходящее психотическое (6A23)	Вторичные причины исключены.
Делирий (6D70)	Колебания внимания; в контексте психоза/делирия.
Вещество-индуцированный психоз	Подтверждение вещества и временная связь
Деменция с психотическими чертами	Когнитивное снижение.

7. Обследование и оценка

- Вышеуказанная лабораторная панель.
- МРТ, ЭЭГ.
- Панель антител в ЦСЖ.
- Скрининг опухоли.

8. Лечение

1. Этиологическое лечение — первая линия:
    - Аутоиммунный энцефалит — IV метилпреднизолон 1 г × 5 дней → IVIG и/или плазмаферез; вторая линия ритуксимаб, циклофосфамид;
    - Паранеопластические — лечение опухоли (овариальная тератома хирургически);
    - Эндокринные — коррекция тиреоидных гормонов, кортизола, кальция;
    - Инфекционные — антибиотик, противовирусные;
    - Метаболические — коррекция нарушения;
    - Лекарственно-индуцированное — отмена подозреваемого препарата.

2. Симптоматическое психиатрическое вмешательство — до получения результата этиологического лечения:
    - Атипичный антипсихотик (кветиапин, оланзапин) — с осторожностью;
    - В случае аутоиммунного энцефалита — типичный антипсихотик (галоперидол) противопоказан — Риск ЗНС и усиление заболевания;
    - Бензодиазепин (лоразепам) — острая ажитация.
3. ЭСТ — альтернатива при рефрактерной кататонии или аутоиммунном энцефалите.

8.1 Методики лечения

1. Иммунотерапия (аутоиммунный энцефалит) — в/в стероиды → ВВИГ → плазмаферез → ритуксимаб/циклофосфамид.
2. Лечение опухоли (паранеопластическое) — Хирургическое или онкологическое лечение.
3. Атипичный антипсихотик — симптоматически — До достижения эффекта этиологического лечения; предпочтительнее кветиапин, оланзапин.
4. ЭСТ при рефрактерности — Эффективен при кататоническом или аутоиммунном энцефалите, не отвечающем на иммунотерапию.

8.2 Различия между источниками

- Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 — протоколы аутоиммунного энцефалита.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Прогноз

- В большинстве случаев отвечает на этиологическое лечение; обратимое состояние.
- Анти-NMDA-R энцефалит — у 75% хорошее восстановление при ранней иммунотерапии.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Первый эпизод психоза — это всегда шизофрения»

Доказательства: 3–8% с вторичной этиологией; атипичные признаки требуют внимания; медицинская оценка обязательна при первом эпизоде психоза.

Миф 2: «Типичный антипсихотик (галоперидол) безопасен при любом психотическом эпизоде»

Доказательства: при подозрении на аутоиммунный энцефалит галоперидол и аналогичные антипсихотики I поколения запрещены — Риск ЗНС, усиление заболевания.

Миф 3: «Анти-NMDA-рецепторный энцефалит редок, не стоит его искать»

Доказательства: атипичный психоз + двигательные симптомы + приступы у молодой женщины — классическая картина анти-NMDA-R; тест на антитела спасает жизнь; обратимое состояние.

Миф 4: «Если медицинская причина не найдена, ставится психиатрический диагноз — искать больше не нужно»

Доказательства: атипичная клиническая картина требует расширенного поиска (ЦСЖ, МРТ, панель паранеопластических маркеров).

Миф 5: «Иммунотерапия не подходит для психиатрических состояний»

Доказательства: при наличии доказательств аутоиммунного энцефалита иммунотерапия первой линии; стандартные антипсихотики неэффективны.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E61 Secondary psychotic syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Graus F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
4. Dalmau J. et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol 2008;7(12):1091–1098.
5. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.

МКБ-11 **6E62**	**6E62 ВТОРИЧНЫЙ АФФЕКТИВНЫЙ СИНДРОМ** **Secondary mood syndrome**
МКБ-10 F06.3	Органические расстройства настроения [аффективные]
DSM-5-TR F06.3x	Депрессивное расстройство вследствие другого медицинского состояния

1. Определение и нозология

Вторичный аффективный синдром (МКБ-11: 6E62 Secondary Mood Syndrome; DSM-5-TR: F06.3x Mood Disorder Due to Another Medical Condition) — депрессивные, маниакальные или смешанные аффективные эпизоды в контексте другого медицинского состояния, воздействия вещества или лекарственного препарата.

2. История

Термин «органическое аффективное расстройство» — XX век; биопсихосоциальная модель в клинической практике.

3. Эпидемиология

- Депрессивные симптомы при хронических соматических заболеваниях широко распространены; часть достигает клинического депрессивного эпизода.
- Стероид-индуцированные расстройства настроения — при высоких дозах преднизолона 5–18% мания/гипомания, депрессия.
- Интерферон-индуцированная депрессия — 20–40% при лечении HCV.
- Постинсультная депрессия — 30%.

4. Этиология и патогенез

- Эндокринные — гипотиреоз (депрессия), гипертиреоз (маниакально-подобное состояние), Кушинг, Аддисон.

- Неврологическое — инсульт (левая лобная — депрессия, правая — мания), болезнь Паркинсона, MS, опухоль мозга, деменция, ЧМТ.
- Вещество/лекарство — стероиды, интерферон, агонисты дофамина, изотретиноин, β-блокатор, антиконвульсант.
- Метаболические — уремия, B12, фолат.
- Инфекционные — ВИЧ, сифилис, COVID.
- Аутоиммунный — волчанка, Хашимото.
- Онкология — рак поджелудочной железы (классическая депрессивная презентация), паранеопластический процесс.

5. Клиническая картина

- Симптомы депрессивного, маниакального, смешанного, гипоманиакального эпизода.
- Временная связь с медицинским состоянием или веществом.
- Особенности, нехарактерные для классического аффективного расстройства (позднее начало, атипичная презентация).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Стойкое расстройство настроения (депрессивное, маническое или смешанное).

B. Доказательства медицинского состояния или воздействия вещества.

C. Не объясняется лучше первичным аффективным расстройством.

D. Не возникает в контексте делирия.

6.2 Различия между источниками

- МКБ-11 — расстройство настроения, вызванное веществом, сюда НЕ относится: оно рассматривается в главе о веществах. 6E62 — только для состояний здоровья вне главы психических расстройств и ставится вместе с диагнозом основного заболевания.
- Протоколы консультативно-связующей психиатрии.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + медицинский анамнез.

2. Медицинская и лабораторная оценка (ТТГ, B12, кортизол, почки, печень).
3. Пересмотр списка лекарств.
4. Визуализация головного мозга (инсульт, рассеянный склероз, опухоль).
5. Токсикологический скрининг.
6. Коморбидные расстройства.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Первичное БДР (6A70/6A71)	Медицинская причина отсутствует.
Первичное биполярное расстройство	Наличие аффективных эпизодов в анамнезе без медицинской причины.
Расстройство адаптации (6B43)	Реакция на стрессовый фактор.
Делирий (6D70)	Колебания внимания.

7. Обследование и оценка

- PHQ-9, MADRS, YMRS.
- Лабораторно: TSH, B12, кортизол, ANA, почки, печень.
- МРТ при атипичном течении.
- C-SSRS.

8. Лечение

1. Этиологическое лечение — коррекция медицинского состояния или лекарственного средства.
2. Симптоматическое психиатрическое лечение:
    - Депрессивный эпизод — СИОЗС (болезнь-специфический выбор; кардиологический — сертралин, эсциталопрам; онкологический — миртазапин);
    - Мания — антипсихотик (кветиапин, оланзапин); при стероид-индуцированном маниакальном состоянии — снижение дозы стероида или антипсихотик;
    - Смешанный или рефрактерный — ЭСТ.
3. Мультидисциплинарная координация.

8.1 Методики лечения

1. СИОЗС Болезнь-Специфичный — Выбор в соответствии с кардиологическим, онкологическим, неврологическим контекстом.
2. ЭСТ — В рефрактерных и тяжёлых случаях.

9. Прогноз

Большинство ремиссий при этиологическом вмешательстве.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Депрессия у пациента с соматическим заболеванием — это „нормально“»

Доказательства: клиническая депрессия ухудшает течение медицинского состояния; требует активного вмешательства.

Миф 2: «Стероид-индуцированная мания проходит сама»

Доказательства: требуется снижение дозы или добавление антипсихотика.

Миф 3: «Антидепрессант — первая линия при гипотиреозе»

Доказательства: коррекция функции щитовидной железы в первую очередь; антидепрессант — при остаточных симптомах.

Миф 4: «Интерфероновая депрессия редка»

Доказательства: 20–40% при интерферонотерапии HCV — требуется активное наблюдение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E62 Secondary mood syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.
4. Robinson R.G., Jorge R.E. Post-stroke depression: a review. Am J Psychiatry 2016;173(3):221–231.

МКБ-11 **6E63**	**6E63 ВТОРИЧНЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ СИНДРОМ** **Secondary anxiety syndrome**
МКБ-10 F06.4	Органическое тревожное расстройство
DSM-5-TR F06.4	Тревожное расстройство вследствие другого медицинского состояния

1. Определение и нозология

Вторичный синдром тревоги (МКБ-11: 6E63 Secondary Anxiety Syndrome; DSM-5-TR: F06.4 Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition) — тревога, паника или обсессивно-подобные симптомы в контексте другого медицинского состояния или воздействия вещества.

2. История

Развитие консультативно-связующей (liaison) психиатрии; официальная категория начиная с DSM-III.

3. Эпидемиология

- Частота тревоги при хронических соматических заболеваниях высока (кардиологические, ХОБЛ, эндокринные).
- При гипертиреозе 60–70% симптомов тревоги.
- Кофеин-, стимулятор-индуцированная тревога.

4. Этиология и патогенез

- Эндокринные — гипертиреоз, феохромоцитома, гипогликемия.
- Кардиальные — аритмия, инфаркт миокарда, пролапс митрального клапана.
- Респираторные — ХОБЛ, астма, тромбоэмболия лёгочной артерии.
- Неврологическое — ЧМТ, болезнь Паркинсона, MS.
- Вещество/лекарство — кофеин, стимулятор, кортикостероид, β-блокатор (парадоксальный), отмена бензодиазепина/алкоголя.

- Вестибулярные расстройства.

5. Клиническая картина

- ГТР, паническая атака, ОКР-подобные симптомы в контексте медицинского состояния.
- Атипичные особенности (позднее начало, фокальные симптомы).

6. Диагноз

Доказательства медицинского состояния + симптомы тревоги + временная связь.

6.1 Источник-специфические уточнения

DSM-5-TR / МКБ-11 — одинаково.

6.2 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. Медицинская оценка — ТТГ, глюкоза, кардиологическое, вестибулярное.
3. Анамнез приёма лекарств и кофеина.
4. Токсикологический скрининг.

6.3 Дифференциальная диагностика

- Первичные тревожные расстройства (6B0x);
- Делирий;
- Расстройство адаптации.

7. Обследование и оценка

- GAD-7, HAM-A.
- ТТГ, глюкоза, ЭКГ.
- Токсикологический скрининг.

8. Лечение

1. Этиологическое лечение.
2. Симптоматически — СИОЗС при остаточной тревоге; бензодиазепин краткосрочно при остром состоянии.
3. Ограничение кофеина.

8.1 Методики лечения

1. Этиологическое вмешательство — Коррекция медицинского состояния.
2. СИОЗС при остаточной тревоге — Для симптомов, сохраняющихся после коррекции медицинского состояния.

9. Прогноз

Значительное улучшение при этиологическом вмешательстве.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Тревога у пациента с соматическим заболеванием — это „нормально“»

Доказательства: клиническая тревога ухудшает течение медицинского состояния; требует вмешательства.

Миф 2: «При гипертиреозе анксиолитики — первая линия»

Доказательства: коррекция функции щитовидной железы в первую очередь; β-блокатор (пропранолол) — симптоматический адъюнкт.

Миф 3: «Кофеин безопасен»

Доказательства: Высокая доза вызывает панику, тревогу, тахикардию; рекомендуется ограничение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 6E63 Secondary anxiety syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.

7A00–7A8Z РАССТРОЙСТВА СНА

Sleep-wake disorders

МКБ-11 **7A00**	**7A00 ХРОНИЧЕСКАЯ ИНСОМНИЯ** **Chronic insomnia**
МКБ-10 F51.0	Бессонница неорганической этиологии
DSM-5-TR F51.01	Инсомния (расстройство бессонницы)

1. Определение и нозология

Хроническая инсомния (МКБ-11: 7A00; DSM-5-TR: F51.01 Insomnia Disorder) — трудности с засыпанием, поддержанием сна и/или ранними пробуждениями; дневные функциональные нарушения. Длительность ≥ 3 месяцев, частота ≥ 3 раз в неделю.

2. История

- DSM-IV — «Первичная бессонница»; DSM-5 (2013) — «Расстройство бессонницы» — различие первичной/вторичной устранено.
- AASM (Американская академия медицины сна) — Клинические практические рекомендации (2021 КПТ-Б, 2017 фармакологическое).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. 2023).
- NICE TA922 (2023).

3. Эпидемиология

- Пожизненная распространённость: хроническая инсомния 10–15%; симптомы инсомнии 30–35%.
- Пол: у женщин в 1,5 раза выше.
- Увеличивается с возрастом.
- Коморбидность: БДР ~50%, тревога, боль, ХОБЛ, циркадные нарушения.

4. Этиология и патогенез

- Модель 3P Spielman — Predisposing (предрасположенность), Precipitating (триггер), Perpetuating (поддерживающий фактор).
- Гипотеза гипераroза — физиологическая и когнитивная стимуляция.
- Поведенческие факторы — нерегулярный график, кофеин, алкоголь, использование экранов, не связанная со сном активность в спальне.

5. Клиническая картина

- Трудности засыпания (инициация сна), поддержания (maintenance), раннее пробуждение (early morning).
- Дневные симптомы: утомляемость, раздражительность, нарушение концентрации, рабочая/академическая недостаточность, соматические (головная боль, ЖКТ).
- Влияние на производительность, риск несчастных случаев.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Трудности со сном (засыпание, поддержание или раннее пробуждение).

B. Несмотря на адекватные возможности для сна.

C. Дневная функциональная недостаточность.

D. Длительность ≥ 3 месяца, ≥ 3 раз в неделю.

E. Не полностью объясняется другим расстройством сна, веществом, медицинским состоянием.

6.2 Различия между источниками

- AASM — КПТ-Б первой линии.
- NICE TA922 (2023) — даридорексант только если КПТ-И не помогла или недоступна; то есть КПТ-И — первая линия.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + дневник сна на 1–2 недели.
2. ИСИ (англ. Insomnia Severity Index), PSQI.
3. Дифференциальный — обструктивное апноэ сна (STOP-BANG), restless legs, циркадные.

4. Коморбидность (БДР, тревога).
5. Полисомнография только в атипичных случаях или при подозрении на другое расстройство сна.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Обструктивное апноэ сна (7A41)	Храп, дневная сонливость; полисомнография.
Циркадианные расстройства (7A60)	Сдвиг графика сна.
Синдром беспокойных ног	Беспокойство в ногах, напоминающее акатизию.
БДР с инсомнией	Доминируют аффективные симптомы.
Гипертиреоз	TSH.

7. Обследование и оценка

- ИСИ, PSQI.
- Дневник сна.
- STOP-BANG (OSA), Epworth Sleepiness Scale.
- TSH, ferritin.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (AASM 2021 · European Insomnia Guideline 2023 · NICE TA922 2023)

1. КПТ-И (когнитивно-поведенческая терапия инсомнии) — первая линия; золотой стандарт при хронической инсомнии; превосходит фармакотерапию по долгосрочной эффективности (мета-анализ Mitchell M.D. BMC Fam Pract 2012). 5 основных компонентов:
    - Контроль стимулов (Bootzin) — кровать только для сна;
    - Ограничение сна (Spielman) — ограничение времени пребывания в постели до времени сна;
    - Когнитивная терапия — катастрофические мысли о сне;
    - Гигиена сна;
    - Тренинг релаксации.

2. Digital CBT-I (Sleepio, SHUTi) — NICE HTG624 (2022): вариант, экономящий средства первичного звена для тех, кому иначе предложили бы гигиену сна или снотворное; прямое сравнение с очной КПТ-И не доказано.
3. Фармакотерапия — краткосрочно (2–4 недели), при отсутствии ответа на КПТ-И или её недоступности:
    - Z-препараты (золпидем, зопиклон, эсзопиклон);
    - Бензодиазепин (темазепам) — риск толерантности, зависимости;
    - Более новые — суворексант, лемборексант (антагонисты орексина) — меньшая зависимость;
    - Доксепин в низкой дозе (3–6 мг);
    - Мелатонин — при циркадном компоненте или у пожилых; рамелтеон (агонист мелатонина).
4. У пожилых людей — критерии Бирса; избегать бензодиазепинов и антигистаминных (дифенгидрамин).
5. Коморбидная депрессия — седативный антидепрессант (миртазапин, тразодон) — при длительном применении следует учитывать побочные эффекты.

8.2 Методики лечения

1. КПТ для бессонницы (англ. Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-I), 5 компонентов — Контроль стимулов, ограничение сна, когнитивная терапия, гигиена сна, релаксация.
2. Цифровая КПТ-И (Digital) — Sleepio, SHUTi — интернет-основанные.
3. Антагонисты орексина — Суворексант, лемборексант — меньший потенциал зависимости.
4. Индекс тяжести бессонницы (ISI — Insomnia Severity Index) — скрининг из 7 пунктов.
5. Дневник сна — 1–2 недели начальные показатели.

8.3 Различия между источниками

- AASM Clinical Practice Guideline for Behavioral and Psychological Treatments (Edinger J.D. 2021).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. J Sleep Res 2023).
- NICE TA922 (2023) — до перехода к лекарству КПТ-И должна быть испробована.

9. Прогноз

- Ответ на КПТ-И 70–80%, ремиссия ~40%; эффект сохраняется долгосрочно.
- Без лечения — хроническое течение и коморбидность (БДР, тревога).

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Снотворные — это основное лечение бессонницы»

Доказательства: AASM 2021 — КПТ-Б первой линии; фармакотерапия — краткосрочный адъюнкт; длительное применение — толерантность, зависимость.

Миф 2: «Алкоголь помогает уснуть»

Доказательства: Алкоголь снижает REM, вызывает пробуждения в середине ночи, приводит к хронической инсомнии.

Миф 3: «Антигистаминные (дифенгидрамин) безопасны у пожилых»

Доказательства: Критерии Бирса — антигистаминные препараты у пожилых: антихолинергический побочный эффект (падения, когнитивное снижение); избегание.

Миф 4: «Валериана, кава — безопасная альтернатива при бессоннице»

Доказательства: валериана — Leach M.J., Page A.T. Sleep Med Rev 2015;24:1–12 — доказательств эффективности недостаточно; кава гепатотоксична.

Миф 5: «8 часов сна необходимы всем»

Доказательства: индивидуальная потребность 6–9 часов; важно дневное функционирование.

Миф 6: «Пробуждение во время сна вредно»

Доказательства: кратковременные пробуждения нормальны; контроль стимулов — если не можете уснуть 20 минут, рекомендуется встать.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 7A00 Insomnia disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. Edinger J.D. et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an AASM clinical practice guideline. J Clin Sleep Med 2021;17(2):255–262.
4. Riemann D. et al. The European Insomnia Guideline 2023. J Sleep Res 2023;32(6):e14035.
5. Mitchell M.D. et al. Comparative effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia: a systematic review. BMC Fam Pract 2012;13:40.
6. Buysse D.J. et al. Efficacy of brief behavioral treatment for chronic insomnia in older adults. Arch Intern Med 2011;171(10):887–895.
7. National Institute for Health and Care Excellence. Sleepio to treat insomnia and insomnia symptoms. HealthTech guidance HTG624. London: NICE; 2022.
8. National Institute for Health and Care Excellence. Daridorexant for treating long-term insomnia. Technology appraisal guidance TA922. London: NICE; 18 October 2023.

МКБ-11 **7A41**	**7A41 ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ ВО СНЕ (OSA)** **Obstructive sleep apnoea**
МКБ-10 G47.3	Апноэ во сне
DSM-5-TR G47.33	Обструктивное апноэ/гипопноэ сна

1. Определение и нозология

Обструктивное апноэ сна (OSA; МКБ-11: 7A41; DSM-5-TR: G47.33) — повторяющаяся полная (апноэ) или частичная (гипопноэ) обструкция верхних дыхательных путей во время сна; дневная сонливость, когнитивные нарушения, повышение сердечно-сосудистой смертности.

2. История

- Gastaut H. (1965) — классическое описание ОСА.
- Sullivan C.E. (1981) — изобрёл CPAP.
- AASM — Параметры практики (обновление).

3. Эпидемиология

- Во взрослой популяции: у мужчин ~13%, у женщин ~6% (среднетяжёлое/тяжёлое СОАС).
- Увеличивается с возрастом и ИМТ.
- Коморбидность: гипертензия (50%), сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, фибрилляция предсердий, диабет.

4. Этиология и патогенез

- Анатомические — жировая ткань в верхних дыхательных путях, маленькая нижняя челюсть, увеличенные миндалины/аденоиды.
- Генетический и семейный анамнез.
- Поза — ухудшается в положении на спине.
- Алкоголь, седативные — ухудшают.

5. Клиническая картина

- Громкий храп, наблюдаемое апноэ, пробуждение с чувством удушья.
- Дневная сонливость (опасная при вождении), утомляемость.
- Утренняя головная боль, сухость во рту.
- Проблемы с концентрацией и памятью.
- Сексуальная дисфункция, депрессивные симптомы.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

Полисомнография (ПСГ) — AHI (англ. Apnea-Hypopnea Index) ≥ 5/час + симптомы; AHI ≥ 15 независимо от симптомов.

6.2 Различия между источниками

- AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing (2017).
- Домашний тест на апноэ сна (HSAT) — подходит при среднетяжёлом и тяжёлом СОАС.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Скрининг STOP-BANG (Snoring, Tiredness, Observed apnea, BP, BMI, Age, Neck, Gender).
2. Epworth Sleepiness Scale.

3. Полисомнография или HSAT.
4. Сердечно-сосудистая оценка.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Инсомния (7A00)	Проблемы засыпания и поддержания сна; храпа нет.
Центральное апноэ сна	Дыхательное усилие отсутствует.
Нарколепсия (7A20)	Каталлексия, MSLT.
RLS	Беспокойство в ногах.

7. Обследование и оценка

- STOP-BANG, Epworth.
- PSG или HSAT.
- ИМТ, окружность шеи.

8. Лечение

1. CPAP — Continuous Positive Airway Pressure — первая линия для среднетяжёлого и тяжёлого СОАС; снижает ИАГ; влияние на сердечно-сосудистую смертность в рандомизированных исследованиях (SAVE, NEJM 2016) не подтверждено.
2. BiPAP — при рефрактерном течении или отсутствии ответа на CPAP.
3. Снижение веса — при лёгкой степени СОАС; бариатрическая хирургия при тяжёлом ожирении.
4. Устройство для выдвижения нижней челюсти (MAD) — лёгкая-умеренная СОАС, отсутствие ответа на CPAP.
5. Постуральная терапия — избегание положения на спине.
6. Хирургия (УПРП, стимуляция подъязычного нерва — Inspire) — в отдельных случаях.
7. Отказ от алкоголя и седативных средств.

8.1 Методики лечения

1. CPAP — Первая линия; приверженность — основная проблема.

2. Устройство для выдвижения нижней челюсти (MAD — Mandibular Advancement Device) — При лёгкой-умеренной СОАС; при отсутствии ответа на CPAP.
3. Стимуляция подъязычного нерва (Inspire) — Новый хирургический вариант; в отдельных случаях.
4. STOP-BANG, Epworth, PSG — Скрининг и диагностика.

8.2 Различия между источниками

- AASM — CPAP стандарт, MAD — селективно.
- NICE NG202 (OSA-COPD-overlap).

9. Прогноз

- CPAP надёжно снижает симптомы, ИАГ и улучшает качество жизни; влияние на сердечно-сосудистую смертность не доказано (наблюдательные исследования — Marin 2005 — связывали с ним снижение смертности, но рандомизированные — SAVE, NEJM 2016 — этого не подтвердили, вероятно, из-за низкой приверженности в испытаниях).
- Без лечения — повышение смертности от инсульта, фибрилляции предсердий, диабета.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «СОАС бывает только у людей с ожирением»

Доказательства: возможно и у пациентов с нормальным весом (анатомические факторы).

Миф 2: «Храп — основной признак обструктивного апноэ сна, больше ничего не требуется»

Доказательства: храп не является единственным доказательством; требуется измерение AHI; без лечения OSA высокая смертность и заболеваемость.

Миф 3: «СИПАП только уменьшает симптомы, не влияя на смертность»

Доказательства: результаты исследований расходятся. Наблюдательные данные (Marin, Lancet 2005) связывали CPAP со снижением смертности, но последующие рандомизированные исследования (SAVE, NEJM 2016) не подтвердили снижения сердечно-сосудистой смертности — вероятно, из-за

низкой приверженности в испытаниях (в среднем ~3,3 ч/ночь при рекомендуемых ~4 ч). CPAP надёжно снижает симптомы и ИАГ, улучшает качество жизни; влияние на смертность остаётся недоказанным.

Миф 4: «Центральное апноэ сна и OSA лечатся одинаково»

Доказательства: различное вмешательство (ASV — адаптивная сервовентиляция при центральном апноэ); дифференциация критична.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 7A41 Obstructive sleep apnoea. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kapur V.K. et al. AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult OSA. J Clin Sleep Med 2017;13(3):479–504.
4. Marin J.M. et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with OSA-hypopnoea with or without treatment with CPAP. Lancet 2005;365(9464):1046–1053.

МКБ-11 **7A60–7A65**	**7A60–7A65 РАССТРОЙСТВА ЦИРКАДНОГО РИТМА СНА-БОДРСТВОВАНИЯ** **Circadian rhythm sleep-wake disorders**
МКБ-10 F51.2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии
DSM-5-TR G47.21	Расстройства циркадианного ритма сна-бодрствования, тип задержки фазы сна

1. Определение и нозология

Циркадные расстройства сна-бодрствования (МКБ-11: 7A60–7A65; DSM-5-TR: G47.21) — несоответствие между внутренним циркадным ритмом и внешним социальным и световым графиком; результатом является бессонница и/или сонливость.

Подтипы: расстройство фазы сна с задержкой (DSWPD), расстройство фазы сна с опережением, нерегулярный ритм сна-бодрствования, не-24-часовой ритм сна-бодрствования (у слепых), расстройство при сменной работе, расстройство при смене часовых поясов.

2. История

- В 1960-х годах Aschoff J. — основы циркадианной биологии.
- AASM (2015) — клиническое практическое руководство по нарушениям циркадного ритма.

3. Эпидемиология

- DSWPD — у подростков и молодых взрослых 7–16%.
- Shift Work Disorder — 10–30% работающих посменно.
- Коморбидность: БДР, тревога, биполярное расстройство, сердечно-сосудистая патология.

4. Этиология и патогенез

- Нарушение эндогенного циркадного ритма (мутации clock-генов редко — Familial Advanced Sleep Phase).
- Среда — световая экспозиция, социальный график.
- DSWPD у подростков — пубертатные гормональные изменения.

5. Клиническая картина

- DSWPD — позднее время сна и пробуждения; несоответствие школе/работе; модель «night owl».
- Advanced — раннее время сна и пробуждения; у пожилых.
- Irregular — эпизоды сна рассеяны в течение дня; при деменции, ИР.
- Non-24-hour — у слепых людей; циркадный ритм не подстраивается под внешний световой сигнал.
- Shift Work — сменная работа; бессонница + дневная сонливость.
- Jet Lag — транзиторное, быстрое изменение часового пояса.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Несоответствие между графиком сна-бодрствования и внутренним циркадным ритмом.

B. Инсомния, сонливость или и то, и другое.

C. Длительность ≥ 3 месяца (исключая джетлаг и сменную работу).

D. Функциональное нарушение.

6.2 Различия между источниками

- AASM 2015 Clinical Practice Guideline.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью + дневник сна на 1–2 недели.
2. Актиграфия 2 недели.
3. Dim Light Melatonin Onset (DLMO) — в контексте исследования.
4. Исключение коморбидных нарушений сна.

6.4 Дифференциальная диагностика

Инсомния, СОАС, депрессивное расстройство, нарколепсия.

7. Обследование и оценка

- Дневник сна, актиграфия.
- Munich Chronotype Questionnaire.

8. Лечение

1. Терапия ярким светом (bright light) — Утром при DSWPD; вечером при Advanced.
2. Экзогенный мелатонин — физиологическая низкая доза (0,3–5 мг); при DSWPD — вечером (время критично); при джетлаге.
3. Хронотерапия — постепенное смещение времени сна.
4. Гигиена сна и поведенческое вмешательство.
5. Сменная работа — стратегический отдых, темная комната, выбор времени приёма кофеина.
6. У незрячих пациентов с не-24-часовым ритмом — тасимелтеон (Hetlioz, одобрен FDA).

8.1 Методики лечения

1. Терапия ярким светом (англ. Bright Light Therapy) — 10 000 люкс × 30–60 мин; время подбирается по циркадному сдвигу.
2. Мелатонин (циркадианные расстройства) — Низкая доза; время критично.
3. Актиграфия (Actigraphy) — 2 недели.
4. Тасимелтеон — Одобрение FDA для Non-24-hour.

9. Прогноз

При интервенции большинство пациентов улучшаются; при хронической форме требуется постоянная стратегия.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Подросток „ленив“, может рано вставать»

Доказательства: DSWPD — нейробиологическая основа циркадной задержки в пубертатном периоде.

Миф 2: «Мелатонин — это снотворное»

Доказательства: Мелатонин регулирует циркадную фазу, гипнотический эффект минимален; выбор времени критичен.

Миф 3: «Лечения бессонницы при сменной работе не существует»

Доказательства: стратегический отдых, светотерапия, мелатонин, выбор времени приёма кофеина улучшают состояние.

Миф 4: «Джетлаг проходит сам собой»

Доказательства: Около 1 дня на 1 час сдвига; ускорение светом + мелатонином.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 7A60–7A65 Circadian rhythm sleep-wake disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Auger R.R. et al. AASM Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders. J Clin Sleep Med 2015;11(10):1199–1236.

МКБ-11 **7A21–7A26**	**7A21–7A26** **ГИПЕРСОМНИЯ** **Hypersomnolence disorders**
МКБ-10 F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии
DSM-5-TR F51.11	Расстройство гиперсомнолентности

1. Определение и нозология

Гиперсомния (МКБ-11: 7A21–7A26; DSM-5-TR: F51.11 Расстройство гиперсомнолентности) — чрезмерная дневная сонливость или эпизоды сна (после ≥ 7 часов ночного сна); функциональное нарушение. В контексте идиопатической гиперсомнии, нарколепсии, других расстройств сна.

2. История

В 1970–80-х годах развилась дифференциация с нарколепсией; клинические рекомендации AASM.

3. Эпидемиология

- Идиопатическая гиперсомния: ~50/100 000.
- Синдром Клейне — Левина — редкий (~1/1 млн); рецидивирующие эпизоды гиперсомнии + нарушение аппетита/сексуальной сферы.
- Коморбидность: депрессивные симптомы, СОАС, нарколепсия.

4. Этиология и патогенез

- Неизвестная (идиопатическая) — гипотеза нейробиологической дисрегуляции.
- Дизрегуляция ГАМК-ергической системы (идиопатическая).
- Вторичная — Клейне — Левина (подозрение на аутоиммунную этиологию), после ЧМТ, РС, депрессивное расстройство.

5. Клиническая картина

- Стойкая дневная сонливость (Excessive Daytime Sleepiness, EDS).

- Длительный ночной сон (≥ 9 часов) недостаточен.
- «Сонное опьянение» — спутанность, дезориентация после пробуждения.
- Дневной сон длительный и невосстанавливающий (отличие от нарколепсии — короткий и восстанавливающий).
- Клейне — Левина — эпизоды гиперсомнии длительностью 1–2 недели + гиперфагия + расторможенное поведение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. Чрезмерная сонливость или длительный сон после достаточного сна (≥ 7 часов).

B. Частота и продолжительность — ≥ 3 раз в неделю, ≥ 3 месяцев.

C. Значительный дистресс или функциональные нарушения

D. Не полностью объясняется другим расстройством сна, веществом, медицинским состоянием.

6.2 Различия между источниками

- AASM — Параметры практики: диагностическая ПСГ и МСЛТ (Множественный тест латентности сна).
- Идиопатическая гиперсомния — средняя латентность сна на MSLT ≤ 8 мин; SOREMP ≤ 1 (отличие от нарколепсии).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью и дневник сна.
2. Epworth Sleepiness Scale.
3. PSG + MSLT (исключение нарколепсии).
4. Медицинская оценка — щитовидная железа, анемия, депрессия, СОАС.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Нарколепсия (7A20)	Каталлексия, SOREMP ≥ 2.
OSA (7A41)	Храп, AHI ↑.
Депрессивное расстройство	Аффективные симптомы.

Состояние	Отличительный признак
Инсомния (7A00)	Недостаточный сон.
Синдром Клейне — Левина	Эпизодическая 1–2-недельная гиперсомния + аппетит.

7. Обследование и оценка

- Epworth, PSG + MSLT.
- Соматическое лабораторное обследование.

8. Лечение

1. Модафинил, армодафинил — первая линия.
2. Стимулянты (метилфенидат, амфетамин) — рефрактерность.
3. Оксибат с низким содержанием натрия (Xywav, FDA 2021) — единственный препарат, одобренный при идиопатической гиперсомнии.
4. Питолисант (FDA 2019) — при нарколепсии; солриамфетол (FDA 2019) — одобрен при нарколепсии и обструктивном апноэ сна; при идиопатической гиперсомнии оба off-label.
5. Гигиена сна и поведенческое вмешательство (запланированный дневной сон).
6. Клейне — Левина — поддерживающая терапия; между эпизодами бессимптомно.

8.1 Методики лечения

1. Модафинил/армодафинил — Стимулирующее бодрствование (wakefulness-promoting); первая линия; побочные эффекты: головная боль, тревога.
2. Множественный тест латентности сна (MSLT — Multiple Sleep Latency Test) — 5 попыток заснуть с интервалом 2 часа; измерение латентности сна.
3. Питолисант и солриамфетол — новые препараты; при рефрактерности.

8.2 Различия между источниками

- AASM Treatment Guidelines (Maski K. et al. 2021).

9. Прогноз

Хроническое; функциональное улучшение при фармакотерапии.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Дневная сонливость — это „лень“»

Доказательства: клиническое состояние; повышение смертности и риска несчастных случаев.

Миф 2: «Кофеин достаточен при гиперсомнии»

Доказательства: кофеин — адъюнкт; требуется модафинил или стимулятор.

Миф 3: «Гиперсомния — только симптом депрессии»

Доказательства: идиопатическая гиперсомния является отдельным расстройством; MSLT проводит дифференциацию.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 7A21–7A26 Hypersomnolence disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maski K. et al. Treatment of central disorders of hypersomnolence: AASM Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2021;17(9):1881–1893.

МКБ-11 **7A20**	**7A20 НАРКОЛЕПСИЯ** **Narcolepsy**
МКБ-10 G47.4	Нарколепсия и катаплексия
DSM-5-TR G47.4xx	Нарколепсия

1. Определение и нозология

Нарколепсия (МКБ-11: 7A20; DSM-5-TR: G47.4xx) — непреодолимые дневные эпизоды сна; два типа: тип 1 (с катаплексией, дефицит орексина-А/гипокретина) и тип 2 (без катаплексии).

2. История

- Gélineau J.B. (1880) — термин нарколепсия.
- Mignot E. et al. (2000) — открытие системы орексина/гипокретина в этиологии нарколепсии.

3. Эпидемиология

- Распространённость: 25–50/100 000.
- Начало: 10–25 лет (бимодальное).
- Коморбидность: СОАС, депрессивные симптомы, ОКР.

4. Этиология и патогенез

- Тип 1 — аутоиммунное поражение orexin-A нейронов (CSF orexin <110 pg/ml); HLA-DQB1*06:02 сильная ассоциация.
- Вакцина H1N1 (Pandemrix, 2009) — рост заболеваемости нарколепсией 1 типа в скандинавских странах (Miller E. BMJ 2013).
- Тип 2 — этиология не до конца ясна.

5. Клиническая картина

Классическая тетрада

- Дневная чрезмерная сонливость (EDS) — неизбежные приступы сна.
- Каталепсия (Тип 1) — внезапная частичная или полная потеря мышечного тонуса при эмоциональном триггере (смех, гнев); сознание сохранено.
- Сонный паралич — неспособность двигаться при переходе ко сну или пробуждении.
- Гипнагогические/гипнопомпические галлюцинации — зрительные/слуховые обманы восприятия при переходе ко сну.

Завершённая тетрада редка; EDS — основной признак.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии

A. EDS ≥ 3 месяцев.

B. MSLT — средняя латентность сна ≤8 мин + ≥2 SOREMP (период сна с началом в REM-фазе); или CSF orexin-A <110 pg/ml.

C. Тип 1 — каталепсия + дефицит орексина; Тип 2 — без каталепсии, орексин в норме.

6.2 Различия между источниками

- ICSD-3 (англ. International Classification of Sleep Disorders) — AASM.
- HLA-типирование и CSF-орексин — в атипичных случаях.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью.
2. PSG (ночной) + MSLT (дневной) — золотой стандарт.
3. CSF орексин — селективно.
4. HLA-DQB1*06:02 — поддерживающий.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Идиопатическая гиперсомния (7A21)	SOREMP < 2.
OSA (7A41)	AHI повышен.
Приступ	Потеря сознания; ЭЭГ.
Обморок	Сердечно-сосудистая причина.
Функциональный/психогенный	Несоответствие типичной клинической картине и результатам ПСГ/МСЛТ.

7. Обследование и оценка

- Epworth.
- PSG + MSLT.
- CSF орексин, HLA-DQB1*06:02.

8. Лечение

1. EDS: модафинил, армодафинил, солриамфетол, питолисант; стимуляторы (метилфенидат, амфетамин) при рефрактерных случаях.
2. Каталепсия: натрия оксибат (Xyrem) — золотой стандарт; новый — кальция/магния/калия/натрия оксибат (Xywav, FDA 2020, с низким

содержанием натрия); СИОЗС/СИОЗСН (венлафаксин, флуоксетин); питолисант.

3. Поведение — запланированный дневной сон (15–20 мин).
4. Ограничение вождения при наличии EDS.

8.1 Методики лечения

1. Натрия оксибат (Xyrem/Xywav) — GHB; 2 дозы на ночь; влияние на каталексию и EDS.
2. Модафинил/армодафинил — Первая линия для EDS.
3. Питолисант — Антагонист H3-рецепторов; EDS и каталексия.
4. СИОЗС/СИОЗСН при каталексии — Венлафаксин, флуоксетин off-label.
5. MSLT — SOREMP ≥ 2 — диагностический признак.

8.2 Различия между источниками

- AASM Treatment Guidelines (Maski 2021).
- Одобрения FDA — питолисант 2019, солриамфетол 2019, Xywav 2020.

9. Прогноз

- Хроническое; функциональное улучшение при фармакотерапии.
- Коморбидность (БДР, СОАС) — вмешательство обязательно.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Нарколепсия — это просто изолированная дневная сонливость»

Доказательства: тетрада (EDS + каталексия + паралич + галлюцинации); дифференцирующий признак — SOREMP на MSLT.

Миф 2: «Каталексия — это припадок»

Доказательства: Сознание сохранено; ЭЭГ без эпилептической активности; эмоциональный триггер.

Миф 3: «Вакцина H1N1 вызывает нарколепсию — следует избегать вакцин»

Доказательства: специфический риск показан для Pandemrix (2009, Скандинавия); другие вакцины безопасны; общее избегание вакцинации не рекомендуется.

Миф 4: «Пациент может управлять автомобилем»

Доказательства: У пациента с нарколепсией и EDS следует ограничить вождение.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. 7A20 Narcolepsy. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maski K. et al. AASM CPG. J Clin Sleep Med 2021;17(9):1881–1893.
4. Miller E. et al. Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine. BMJ 2013;346:f794.
5. Mignot E. et al. The role of cerebrospinal fluid hypocretin measurement in the diagnosis of narcolepsy. Arch Neurol 2002;59(10):1553–1562.

HA00–HA0Z СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Conditions related to sexual health

МКБ-11 **HA01.1**	**HA01.1 ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У МУЖЧИН (ED)** **Male erectile dysfunction**
МКБ-10 F52.2	Недостаточность генитальной реакции
DSM-5-TR F52.21	Эректильное расстройство

1. Определение и нозология

Эректильная дисфункция (ЭД; МКБ-11: HA01.1 Эректильная дисфункция; DSM-5-TR: F52.21) — стойкая трудность в достижении или поддержании эрекции, достаточной для полового акта. Длительность ≥ 6 месяцев, при большинстве попыток.

2. История

- 1998 — силденафил (Виагра) одобрен FDA — революция в лечении ЭД.
- Руководство AUA (англ. American Urological Association) (Burnett 2018, обновление 2024).
- EAU (англ. European Association of Urology) Guidelines.

3. Эпидемиология

- В 40 лет 5–10%, в 70 лет 50%+.
- Факторы риска: диабет, сердечно-сосудистые заболевания (ЭД как их ранний маркер), гипертензия, гиперлипидемия, курение, ожирение, депрессия, антидепрессанты.

4. Этиология и патогенез

- Органическое (~70%) — сосудистое, нейрогенное, эндокринное (гипогонадизм), лекарственно обусловленное.
- Психогенное (~10%) — тревога исполнения, проблемы в отношениях, депрессия.
- Смешанный (~20%).
- Princeton III Consensus (Nehra 2012) — ЭД является ранним маркером сердечно-сосудистых заболеваний, необходима оценка сердечного риска.

5. Клиническая картина

- Трудность достижения или поддержания эрекции.
- Наличие или отсутствие утренних или ночных эрекций (в дифференциации психогенного vs органического).
- Отношения и эмоциональная нагрузка.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (AUA 2018 · EAU)

A. Стойкая трудность достижения и/или поддержания эрекции.

B. Длительность ≥ 6 месяцев, при большинстве попыток.

C. Дистресс или нарушение отношений.

6.2 Различия между источниками

- AUA 2018/2024 и EAU — поэтапный подход.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (сексуальный и медицинский анамнез, отношения).
2. IIEF (англ. International Index of Erectile Function) / SHIM.
3. Лабораторные — утренний тестостерон, глюкоза, HbA1c, липиды, пролактин, тиреоидные.
4. Сердечно-сосудистая оценка.
5. УЗИ полового члена (при подозрении на сосудистую патологию) — селективно.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Гипогонадизм	Тестостерон снижен + симптомы.
Преждевременная эякуляция (HA03)	Время эякуляции.
HSDD	Доминирует снижение желания.
Болезнь Пейрони	Искривление полового члена и боль.

7. Обследование и оценка

- IIEF.
- Медицинское и лабораторное (вышеуказанное).
- Кардиологическая оценка (при необходимости ЭКГ, стресс-тест).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (AUA 2018/2024 · EAU поэтапно)

1. 1-я линия:
    - Образ жизни — отказ от курения, вес, физическая активность, контроль сердечно-сосудистой системы;
    - Ингибиторы PDE5 — силденафил (25–100 мг), тадалафил (5–20 мг при необходимости или 2,5–5 мг ежедневно), варденафил, аванафил; абсолютное противопоказание с нитратами; с осторожностью при применении α-блокаторов.
2. 1-я линия (при гипогонадизме): заместительная терапия тестостероном (TRT) — только при подтверждённом гипогонадизме (≥ 2 утренних измерения с низким уровнем + симптомы); мониторинг PSA и гематокрита.
3. Вторая линия:
    - Интракавернозный алпростадил (PGE1);
    - Интрауретральный алпростадил (MUSE);
    - Вакуумное эректильное устройство.
4. Третья линия: пенильный протез (полужесткий или надувной); высокая удовлетворённость.
5. Психотерапия — при тревоге исполнения; парная терапия.

6. Антидепрессант-индуцированная ЭД — альтернатива бупропион, миртазапин, вортиоксетин; адъюнкт силденафил (Nurnberg JAMA 2003).

8.2 Методики лечения

1. Ингибиторы PDE5 — Ингибитор фосфодиэстеразы 5; абсолютное противопоказание с нитратами.
2. Интракавернозный алпростадил — PGE1; при отсутствии ответа на PDE5.
3. Вакуумное устройство (англ. Vacuum Device) — Неинвазивный; может использоваться при антикоагулянтной терапии.
4. Пенильный протез (англ. Penile Prosthesis) — Рефрактерная ЭД; высокая удовлетворённость.
5. Международный индекс эректильной функции (англ. International Index of Erectile Function, IIEF) — Шкала тяжести.

8.3 Различия между источниками

- Burnett A.L. et al. AUA Guideline. J Urol 2018, обновление 2024.
- Salonia A. et al. EAU Guidelines 2023.

9. Прогноз

Эффективность PDE5 70%; при рефрактерности 2–3-я линия; контроль сердечно-сосудистого риска снижает смертность.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ЭД — нормальная часть старения, не требующая лечения»

Доказательства: ЭД — ранний маркер сердечно-сосудистых заболеваний; активное вмешательство важно.

Миф 2: «Безрецептурные „натуральные“ усилители потенции безопасны»

Доказательства: Предупреждения FDA — во многих «натуральных» препаратах обнаружены недекларированные силденафил/тадалафил — взаимодействие с нитратами, риск смерти.

Миф 3: «Заместительная терапия тестостероном необходима каждому пациенту с ЭД»

Доказательства: AUA — только при подтверждённом гипогонадизме; рутинная ТРТ не рекомендуется.

Миф 4: «Терапия ударной волной (Li-ESWT) — стандартное лечение»

Доказательства: AUA 2024 — на стадии исследования; не является стандартной первой линией.

Миф 5: «Йохимбин — эффективная природная альтернатива»

Доказательства: Ernst E., Pittler M.H. J Urol 1998;159(2):433–436 — небольшой эффект, побочные эффекты: тревога и гипертензия; PDE5 превосходит.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA01.1 Male erectile dysfunction. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Burnett A.L. et al. Erectile Dysfunction: AUA Guideline. J Urol 2018;200(3):633–641.
4. Salonia A. et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2023.
5. Nehra A. et al. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin Proc 2012;87(8):766–778.
6. Yuan J. et al. Comparative effectiveness and safety of oral phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction: a systematic review and network meta-analysis. Eur Urol 2013;63(5):902–912.

МКБ-11 **HA03.0**	**HA03.0 ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ У МУЖЧИН (PE)** **Male early ejaculation**
МКБ-10 F52.4	Преждевременная эякуляция
DSM-5-TR F52.4	Преждевременная (ранняя) эякуляция

1. Определение и нозология

Преждевременная эякуляция (ПЭ; МКБ-11: HA03.0 Преждевременная эякуляция; DSM-5-TR: F52.4) — непреднамеренное наступление эякуляции в течение короткого времени, часто до пенетрации или примерно в течение 1 минуты; потеря контроля и дистресс.

Подтипы: пожизненный (первичный) — с самого начала; приобретённый (вторичный) — развившийся позже; вариабельный и субъективный — классификация ISSM.

2. История

- Semans J.H. (1956) — техника «старт-стоп».
- Masters & Johnson (1970) — поведенческий метод «сжатия» (squeeze).
- ISSM (2014) — Althof S.E. международное диагностическое и лечебное руководство.
- 2009 — дапоксетин — первый одобренный препарат для лечения ПЭ в ЕС.

3. Эпидемиология

- Распространённость у мужчин 20–30% (самоотчет); по строгим критериям ISSM — 4–5%.
- Изменчивость с возрастом мала; во всех возрастных группах.
- Коморбидность: ЭД, тревога, депрессия, напряжение в отношениях.

4. Этиология и патогенез

- Нейробиологическая — серотонинергическая (баланс 5-HT2C, 5-HT1A); генетический компонент (lifelong).
- Психологическое — тревога исполнения, ранний сексуальный опыт, проблемы в отношениях.
- Приобретённая — ЭД, простатит, гипертиреоз, употребление наркотиков.

5. Клиническая картина

- Короткое интравагинальное время задержки эякуляции (IELT) (пожизненное ~1 мин; приобретённое ≤ 3 мин).
- Утрата контроля.

- Дистресс, избегание, напряжённость в отношениях.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (ISSM 2014 · DSM-5-TR)

A. Эякуляция всегда или почти всегда до пенетрации или в течение ~1 мин (lifelong) или клинически значимое снижение времени задержки до ≤ 3 мин (acquired).

B. Неспособность отсрочить все или почти все пенетрации.

C. Негативные личные последствия — дистресс, избегание.

6.2 Различия между источниками

- ISSM (Althof S.E. et al. J Sex Med 2014).
- Руководства AUA и EAU.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (сексуальный анамнез, IELT, контроль, дистресс).
2. PEDT (англ. Premature Ejaculation Diagnostic Tool) — 5 пунктов.
3. Оценка коморбидной ЭД (МИЭФ).
4. Эндокринные и урологические (приобретённая форма).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
ED (HA01)	Трудность поддержания эрекции.
Variable PE	Не является клинической единицей — нормальная вариация.
Subjective PE	IELT в норме, но нарушение восприятия.
Простатит	Тазовая боль; приобретённая преждевременная эякуляция.

7. Обследование и оценка

- PEDT, IIEF.
- IELT (хронометраж — при рекомендации).

- Эндокринные и урологические (подозрение на приобретённую форму).

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ISSM 2014 · AUA · EAU)

1. Поведенческие методы (первая линия или комбинация):
    - Старт-стоп (Semans);
    - Squeeze — сжатие (Masters & Johnson);
    - Упражнения для мышц тазового дна (Pastore A. РКИ 2014).
2. Дапоксетин — короткодействующий СИОЗС; 30–60 мг за 1–3 часа до полового акта; одобрен для ПЭ в ЕС и многих странах. Не одобрен FDA США для ПЭ.
3. СИОЗС off-label ежедневно — пароксетин (10–40 мг) — наибольшая эффективность (Waldinger мета-анализ); сертралин, флуоксетин, циталопрам — альтернативы; возможны сексуальные побочные эффекты.
4. Местные анестетики — лидокаин/прилокаин (EMLA, TEMPE/Fortacin спрей) за 5–10 минут до пенетрации; защита от передачи партнёру (презерватив или вытирание).
5. Трамадол — в селективных случаях (с учётом риска зависимости).
6. Ингибитор PDE5 — только при коморбидной ЭД.
7. Парная терапия и КПТ — при тревоге исполнения.

8.2 Методики лечения

1. Дапоксетин — Краткодействующий СИОЗС; при необходимости; одобрение ЕС.
2. Топический анестетик — Лидокаин/прилокаин (EMLA, Fortacin); за 5–10 минут до полового акта.
3. СИОЗС Ежедневно (off-label) — Пароксетин обладает наибольшей эффективностью.
4. Техники «Старт-Стоп» и «Сжатие» (Squeeze) — Поведенческие методы; отдельно или в комбинации.
5. Упражнения для мышц тазового дна (англ. Pelvic Floor Exercises) — Pastore РКИ — увеличение IELT.

8.3 Различия между источниками

- Althof S.E. et al. ISSM Guideline. J Sex Med 2014.

- Waldinger M.D. et al. Мета-анализ СИОЗС.

9. Прогноз

Дапоксетин и СИОЗС увеличивают IELT в 2–4 раза; комбинация с поведенческой терапией поддерживает долгосрочный эффект.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «ПЭ — это исключительно психологическая проблема»

Доказательства: Пожизненная ПЭ связана с серотонинергической нейробиологией; дапоксетин и СИОЗС подтверждают это.

Миф 2: «Дапоксетин одобрен FDA в США»

Доказательства: Дапоксетин не одобрен FDA США для ПЭ; одобрен в ЕС и многих странах; в США лечится off-label ежедневными СИОЗС.

Миф 3: «Местный анестетик безопасен и не влияет на партнёра»

Доказательства: презерватив или воздержание важны для защиты партнёра от передачи; в противном случае партнёр может испытывать снижение чувствительности.

Миф 4: «Безрецептурные „усилители эрекции“ безопасны»

Доказательства: Предупреждения FDA — во многих «натуральных» препаратах обнаружены недекларированные СИОЗС или анестетические компоненты.

Миф 5: «Поведенческая терапия — это только старый метод»

Доказательства: ISSM рекомендует техники start-stop, squeeze и упражнения для мышц тазового дна; эффективность повышается в комбинации с фармакотерапией.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA03.0 Male early ejaculation. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Althof S.E. et al. An update of the International Society of Sexual Medicine’s guidelines for the diagnosis and treatment of premature ejaculation. J Sex Med 2014;11(6):1392–1422.

4. Waldinger M.D. et al. Relevance of methodological design for the interpretation of efficacy of drug treatment of PE: a systematic review and meta-analysis. Int J Impot Res 2004;16(4):369–381.
5. Pastore A.L. et al. Pelvic floor muscle rehabilitation for patients with lifelong premature ejaculation: a novel therapeutic approach. Ther Adv Urol 2014;6(3):83–88.

МКБ-11 **HA00**	**HA00 СНИЖЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ (HSDD)** **Hypoactive sexual desire dysfunction**
МКБ-10 F52.0	Отсутствие или потеря сексуального влечения
DSM-5-TR F52.0 / F52.22	Мужское расстройство со сниженным сексуальным влечением / женское расстройство сексуального интереса-возбуждения

1. Определение и нозология

Снижение сексуального желания (HSDD; МКБ-11: HA00 Расстройство гипоактивного сексуального желания; DSM-5-TR у женщин Female Sexual Interest/Arousal Disorder F52.22, у мужчин Male Hypoactive Sexual Desire Disorder F52.0) — стойкое снижение или отсутствие сексуальных фантазий и желания вступать в половую связь; сопровождается дистрессом.

Длительность ≥ 6 месяцев; ситуативная или генерализованная; пожизненная или приобретённая.

2. История

- Kaplan H.S. (1977) — включение фазы желания в модель сексуального ответа.
- Basson R. (2000) — циклическая (circular) модель желания-возбуждения у женщин.
- 2015 — одобрение FDA флибансерина; 2019 — одобрение FDA бремеланотида.

- ISSWSH (англ. International Society for the Study of Women's Sexual Health) Process of Care 2018 (Clayton A.H.).

3. Эпидемиология

- У женщин 8–10% с дистрессом (HSDD); у мужчин 14–17%.
- Увеличение с возрастом; перименопауза — период риска.
- Коморбидность: депрессия, применение антидепрессантов (СИОЗС), проблемы в отношениях.

4. Этиология и патогенез

- Биологические — гормональные (тестостерон, эстроген), лекарственно-обусловленные (СИОЗС, ОК, антигипертензивные), хронические заболевания.
- Психологическое — депрессия, тревога, образ тела, история травмы.
- Отношения — конфликт, сексуальная дисфункция партнёра.
- Социокультурное — запрет, неосведомленность.

5. Клиническая картина

- Снижение или отсутствие спонтанных сексуальных фантазий и мыслей.
- Отсутствие собственной инициативы и ответа на инициативу партнёра.
- Дистресс (критический критерий — простого низкого желания недостаточно).

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR · ISSWSH)

A. Стойкое снижение или отсутствие сексуальных фантазий и желания.

B. Длительность ≥ 6 месяцев.

C. Клинически значимый дистресс.

D. Не объясняется лучше другим психическим расстройством, лекарственным средством или медицинским состоянием.

6.2 Различия между источниками

- ISSWSH Process of Care (Clayton A.H. et al. Mayo Clin Proc 2018).

- DSM-5-TR у женщин желание и возбуждение объединены (FSIAD).

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (сексуальный анамнез и анамнез отношений).
2. DSDS (англ. Decreased Sexual Desire Screener) — 5 пунктов для женщин.
3. Гормональная оценка (у мужчин утренний тестостерон; у женщин по показаниям).
4. Анализ лекарств и коморбидности.
5. Скрининг депрессии, тревоги.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Гипогонадизм	Тестостерон снижен + симптомы.
Депрессивное расстройство	Ангедония, расстройство настроения.
СИОЗС-индуцированная	Связанное с лекарствами время.
Аноргазмия (HA02)	Преобладает нарушение оргазма.
Проблема отношений	Ситуативно.

7. Обследование и оценка

- DSDS, FSFI, IIEF.
- Гормональная панель.
- Шкалы депрессии/тревоги.

8. Лечение

8.1 Общие принципы (ISSWSH 2018)

1. Биолого-психолого-социальный подход — мультимодальный в зависимости от этиологии.
2. Психотерапия и парная терапия — КПТ, майндфулнес, sensate focus (Masters & Johnson).
3. Изменение лекарственной терапии — При индуцированной СИОЗС альтернатива бупропион, миртазапин, вортиоксетин.
4. Фармакотерапия у женщин (пременопаузальная HSDD):

- Флибансерин (100 мг на ночь) — одобрение FDA 2015; с алкоголем риск тяжёлой гипотензии и синкопе (FDA в 2019 смягчила чёрную рамку: после 1–2 стандартных порций подождать не менее 2 часов, при 3 и более порциях дозу в этот вечер пропустить);
- Бремеланотид (1,75 мг п/к при необходимости) — одобрение FDA 2019; агонист меланокортина.

5. У женщин в постменопаузе: трансдермальный тестостерон в низкой дозе (off-label, международный консенсус Davis S.R. 2019) — тщательный мониторинг.
6. У мужчин: при подтверждённом гипогонадизме TRT (≥ 2 утренних измерения с низким уровнем + симптомы).
7. Работа над отношениями и коммуникацией критична.

8.2 Методики лечения

1. Флибансерин — Агонист серотониновых 1A / антагонист 2A; ежедневная ночная доза; у женщин в пременопаузе.
2. Бремеланотид — Агонист меланокортиновых рецепторов; п/к по мере необходимости.
3. Тестостерон у женщин (off-label) — Постменопаузальный; низкая доза; мониторинг.
4. КПТ и майндфулнес (осознанность) — Исследования Brotto L.A. — эффективность при женской сексуальной дисфункции.
5. Сенсорный фокус (англ. Sensate Focus) — Техника парной терапии.

8.3 Различия между источниками

- Clayton A.H. et al. ISSWSH Process of Care. Mayo Clin Proc 2018.
- Davis S.R. et al. Global Consensus Position Statement on Testosterone Therapy for Women. J Clin Endocrinol Metab 2019.

9. Прогноз

При мультимодальном подходе большинство пациентов улучшается; при хронической форме требуется постоянная стратегия.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Низкое либидо всегда является расстройством»

Доказательства: дистресс — критический критерий; низкое влечение без дистресса — нормальная вариация, не патология.

Миф 2: «Тестостерон — усилитель либидо для всех женщин»

Доказательства: Davis 2019 консенсус — только постменопаузальная HSDD низкая доза off-label; общее время приёма не является официальной рекомендацией.

Миф 3: «Флибансерин — это „женская Виагра“»

Доказательства: механизм полностью иной (серотонинергический, ЦНС); ежедневное применение; эффект умеренный (сравнение с силденафилом некорректно).

Миф 4: «Дисфункция желания вызвана только психологическими причинами»

Доказательства: СИОЗС, ОК, антигипертензивные и гормональные изменения оказывают сильное влияние; биологическое обследование важно.

Миф 5: «Безрецептурные „афродизиаки“ эффективны»

Доказательства: Cochrane и систематические обзоры — небольшой или нулевой эффект; предупреждения FDA о скрытом компоненте.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA00 Hypoactive sexual desire dysfunction. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Clayton A.H. et al. The International Society for the Study of Women’s Sexual Health Process of Care for Management of HSDD in Women. Mayo Clin Proc 2018;93(4):467–487.
4. Davis S.R. et al. Global Consensus Position Statement on the Use of Testosterone Therapy for Women. J Clin Endocrinol Metab 2019;104(10):4660–4666.
5. Basson R. The female sexual response: a different model. J Sex Marital Ther 2000;26(1):51–65.
6. Brotto L.A. Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire. Vancouver: Greystone Books, 2018.

МКБ-11 **HA02.0**	**HA02.0 АНОРГАЗМИЯ** **Anorgasmia**
МКБ-10 F52.3	Оргазмическая дисфункция
DSM-5-TR F52.31 / F52.32	Женское оргазмическое расстройство / задержанная эякуляция

1. Определение и нозология

Аноргазмия (МКБ-11: HA02.0 Anorgasmia; DSM-5-TR у женщин — Female Orgasmic Disorder F52.31; у мужчин — Delayed Ejaculation F52.32) — стойкая трудность, задержка или отсутствие достижения оргазма после достаточного сексуального возбуждения; или снижение интенсивности оргазма.

Длительность ≥ 6 месяцев; ситуативная или генерализованная; пожизненная или приобретённая.

2. История

- Masters & Johnson (1970) — классическое описание нарушения оргазмической фазы.
- Рекомендации ISSWSH и ISSM.

3. Эпидемиология

- У женщин 5–10% клинически значимая аноргазмия; у мужчин отсроченная эякуляция 1–4%.
- При применении антидепрессантов (SSRI) 30–70% сексуальных побочных эффектов.

4. Этиология и патогенез

- Связанное с лекарствами (СИОЗС, антипсихотики, опиоиды).
- Неврологическая (тазовая хирургия, MS, диабетическая нейропатия).
- Эндокринные причины (гипотиреоз, гиперпролактинемия).
- Психологическое — тревога, травма, недостаток информации.
- Возраст и гормональные изменения.

5. Клиническая картина

- Трудность или отсутствие достижения оргазма.
- Снижение интенсивности оргазма.
- Дистресс, избегание.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR)

A. Задержка, отсутствие или снижение интенсивности оргазма после достаточного сексуального возбуждения — во всех или почти всех случаях (75–100%).

B. Длительность ≥ 6 месяцев.

C. Дистресс.

6.2 Различия между источниками

- ISSM Delayed Ejaculation Guideline.
- ISSWSH — женская оргазмическая дисфункция.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (сексуальный анамнез, оргазм при мастурбации, оргазм с партнёром).
2. FSFI (у женщин) / IIEF (у мужчин).
3. Анализ лекарств и коморбидности.
4. Эндокринное обследование (тестостерон, пролактин, щитовидная железа).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
HSDD (HA00)	Доминирует снижение желания.
Ретроградная эякуляция	Оргазм есть, эякулят в мочевой пузырь.
СИОЗС-индуцированная	Связанное с лекарствами время.
ED (HA01)	Эректильная дисфункция.

7. Обследование и оценка

- FSFI, IIEF.
- Гормональная панель.
- Неврологическое и урологическое (подозрение на приобретённое).

8. Лечение

1. Этиологический подход — ведение лекарственных, эндокринных, неврологических причин.
2. СИОЗС-индуцированная аноргазмия:
    - Медикаментозная замена — альтернативы: бупропион, миртазапин, вортиоксетин;
    - Снижение дозы; «drug holiday» (с осторожностью при СИОЗС);
    - Бупропион адъюнкт;
    - Силденафил адъюнкт у женщин при СИОЗС-индуцированной дисфункции — Nurnberg JAMA 2008 РКИ.
3. Психотерапия и поведенческая — оргазм-ориентированная терапия (Heiman & LoPiccolo); КПТ, майндфулнес (Brotto L.A.).
4. Направленное обучение мастурбации у женщин — направленная мастурбация; вибратор.
5. Задержанная эякуляция у мужчин — психотерапия, модификация паттерна мастурбации; специфической одобренной FDA фармакотерапии нет.
6. Гормональная терапия только при подтверждённом дефиците.

8.1 Методики лечения

1. Бупропион — При аноргазмии, индуцированной СИОЗС, адъюнкт или переход.
2. Направленная мастурбация (англ. Directed Masturbation) — Программа Heiman & LoPiccolo; эффективна при первичной аноргазмии у женщин.
3. Майндфулнес-КПТ (Mindfulness-CBT) — Исследования Brotto; при женской сексуальной дисфункции.

8.2 Различия между источниками

- Nurnberg H.G. et al. JAMA 2008 — силденафил при СИОЗС-индуцированной женской сексуальной дисфункции.
- Исследования осознанности (mindfulness) Brotto L.A.

9. Прогноз

Направленная мастурбация при первичной аноргазмии у женщин эффективна в 60–90% случаев; при СИОЗС-индуцированной форме лекарственная стратегия приводит к улучшению.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Женщина должна достигать оргазма при пенетрации»

Доказательства: Большинство женщин (~70%) требуют клиторальной стимуляции; оргазм только от пенетрации — нормальная вариация, а не анатомическая норма.

Миф 2: «Аноргазмия — признак „фригидности“ у женщин»

Доказательства: аноргазмия часто связана с недостатком информации, техникой, тревогой или лекарствами; не является чертой характера.

Миф 3: «СИОЗС-индуцированная аноргазмия временна и не требует лечения»

Доказательства: является стойким; смена препарата или адъюнктивные стратегии эффективны; продолжающийся дистресс клинически значим.

Миф 4: «Безрецептурные „усилители оргазма“ эффективны»

Доказательства: данные слабы; предупреждения FDA — скрытый компонент.

Миф 5: «Использование вибратора лишает пациента оргазма с партнёром»

Доказательства: Напротив, эффективно при обучении первичной аноргазмии; возможна интеграция в интимные отношения с партнёром.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA02.0 Anorgasmia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Nurnberg H.G. et al. Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction. JAMA 2008;300(4):395–404.
4. Brotto L.A. et al. Psychological and Interpersonal Dimensions of Sexual Function and Dysfunction. J Sex Med 2016;13(4):538–571.
5. Heiman J.R., LoPiccolo J. Becoming Orgasmic. Prentice Hall, 1988.

МКБ-11 **HA20**	**HA20 СЕКСУАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО БОЛЕЗНЕННОЙ ПЕНЕТРАЦИИ (ВАГИНИЗМ)** **Sexual pain-penetration disorder**
МКБ-10 F52.5	Вагинизм неорганического происхождения
DSM-5-TR F52.6	Генитально-тазовая боль/расстройство пенетрации

1. Определение и нозология

Сексуальное расстройство болезненной пенетрации (вагинизм) (МКБ-11: HA20; DSM-5-TR Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder F52.6) — при попытке пенетрации: (a) трудности, (b) генитальная или тазовая боль, (c) страх боли, (d) напряжение мышц тазового дна. Классические вагинизм и диспареуния объединены в этой единице.

Длительность ≥ 6 месяцев; пожизненная или приобретённая.

2. История

- Sims J.M. (1861) — описание вагинизма.
- Masters & Johnson (1970) — напряжение тазового дна.
- DSM-5 (2013) — вагинизм и диспареуния объединены в GPPPD.
- Рекомендации ISSWSH и ACOG.

3. Эпидемиология

- У женщин распространённость 5–17% (в клинических и неклинических выборках).
- Пожизненный вагинизм — у молодых женщин, при первой попытке пенетрации.
- Приобретённая — травма, инфекция, атрофический вагинит, послеоперационное состояние.

4. Этиология и патогенез

- Биологические — атрофический вагинит (постменопаузальный), вульводиния, эндометриоз, инфекция, хирургическая рана.
- Психологическое — сексуальная травма, тревога, запретное воспитание, страх боли.
- Отношения и партнёрские факторы.

5. Клиническая картина

- Рефлекторное напряжение мышц тазового дна во время пенетрации.
- Боль (жгучая, режущая).
- Избегание пенетрации.
- Гинекологическое обследование также затруднено или невозможно.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR)

A. Как минимум один из следующих:

- Затруднение пенетрации.
- Вульвовагинальная или тазовая боль при попытке или во время пенетрации.
- Страх боли в ожидании пенетрации.
- Напряжение мышц тазового дна при попытке пенетрации.

B. Длительность ≥ 6 месяцев.

C. Дистресс.

6.2 Различия между источниками

- ISSWSH и ACOG.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Клиническое интервью (сексуальный анамнез, характеристика боли, травма).
2. Тщательное гинекологическое обследование — с осторожностью, с согласия пациента.
3. Скрининг вульводинии (Q-tip тест).
4. Исключение инфекции, атрофического вагинита, эндометриоза.

5. Оценка состояния тазового дна.

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	Отличительный признак
Вульводиния	Локализованная боль вульвы, положительный Q-тест.
Атрофический вагинит	Постменопаузальный, дефицит эстрогена.
Эндометриоз	Глубокая диспареуния, дисменорея.
Инфекция (кандида, вагиноз)	Отделяемое, микробиологическое исследование.

7. Обследование и оценка

- Гинекологическое обследование.
- Оценка состояния тазового дна.
- FSFI; шкалы боли.

8. Лечение

1. Мультидисциплинарный подход — физиотерапия тазового дна + КПТ + обучение.
2. Физиотерапия тазового дна — биологическая обратная связь, мануальная терапия, дилатационная терапия (постепенное увеличение размера).
3. КПТ и экспозиционная терапия — страх боли и избегание; ter Kuile M.M. РКИ.
4. Сенсорный фокус и парная терапия.
5. Местный анестетик (лидокаин) — при провоцированной вульводинии (Goldstein A.T.).
6. При атрофическом вагините местный эстроген.
7. Ботулинический токсин А — при рефрактерном вагинизме; доказательная база растёт.
8. Антидепрессант/антиконвульсант (амитриптилин, габапентин) — при нейропатическом компоненте.

8.1 Методики лечения

1. Дилатационная (расширяющая) терапия — Постепенное увеличение размера; в сочетании с релаксацией.
2. Физиотерапия тазового дна — Биологическая обратная связь, мануальная терапия.
3. КПТ/экспозиция — Страх боли и избегание.
4. Местный эстроген — При атрофическом вагините.
5. Botox (off-label) — Рефрактерный вагинизм; селективно.

8.2 Различия между источниками

- ter Kuile M.M. et al. CBT vaginismus.
- Goldstein A.T. et al. Консенсус ISSWSH по вульводинии.

9. Прогноз

При мультидисциплинарном подходе прогноз хороший (70–90%); при рефрактерном течении — ботокс или углублённое психологическое вмешательство.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Вагинизм — это эмоциональное отвержение партнёра»

Доказательства: рефлекторное мышечное напряжение — вне сознательного контроля; обвинение вредно.

Миф 2: «Вагинизм неизлечим»

Доказательства: Комбинация КПТ + дилататор + физиотерапия — эффективность 70–90%; РКИ ter Kuile.

Миф 3: «Лечение должно проводиться для увеличения частоты пенетрации»

Доказательства: цель — уменьшить дистресс пациента, вернуть чувство контроля и выбора; это не показатель эффективности.

Миф 4: «Местный анестетик эффективен при всех сексуальных болях»

Доказательства: эффективен при провоцированной вульводинии; при генерализованном вагинизме применение ограничено — основная проблема — мышечное напряжение.

Миф 5: «Превращение попытки проникновения в „принудительное упражнение“ помогает»

Доказательства: Поспешное, болезненное повторение усиливает избегание и страх; постепенная, контролируемая экспозиция эффективна.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA20 Genito-pelvic pain/penetration disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Ter Kuile M.M. et al. Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: a RCT. J Consult Clin Psychol 2013;81(6):1127–1136.
4. Goldstein A.T. et al. Vulvodynia: Assessment and Treatment. J Sex Med 2016;13(4):572–590.
5. Bergeron S. et al. Genital pain in women and men: It can hurt more than your sex life. Sex Med Rev 2020.

МКБ-11 **HA40**	**HA40** **ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ И СЕКСУАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ РАССТРОЙСТВ.** **Aetiological considerations in sexual dysfunctions and sexual pain disorders**
МКБ-10 F52.8	Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью
DSM-5-TR —	—

1. Определение и нозология

Другие сексуальные дисфункции (МКБ-11: HA40) — нарушения сексуальной функции (могут охватывать сферы желания, возбуждения, оргазма, боли), возникающие в контексте другого физического заболевания, лекарств, вещества или психического расстройства. Случаи, не соответствующие специфическим категориям HA01–HA20 или сочетающиеся с ними.

Подтипы (МКБ-11): медицинское состояние, травма либо последствия операции или лучевой терапии (HA40.0); психологические или поведенческие факторы, включая психические расстройства (HA40.1); употребление психоактивного вещества или лекарства (HA40.2); недостаток знаний или опыта (HA40.3); факторы отношений (HA40.4); культуральные факторы (HA40.5); другие уточнённые (HA40.Y).

2. История

- DSM-5 (2013) — формализация «Substance/Medication-Induced Sexual Dysfunction».
- 2000-е годы — широко описана индуцированная СИОЗС сексуальная дисфункция (исследования Montejo A.L.).
- PSSD (англ. Post-SSRI Sexual Dysfunction) — Bahrick A. (2008), подтверждение EMA 2019.

3. Эпидемиология

- Сексуальная дисфункция при применении СИОЗС 30–70%.
- ЭД у мужчин с диабетом 35–75%.
- Высокая распространённость при сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Высокая распространённость при приёме антипсихотиков (особенно рисперидон, палиперидон) — вследствие гиперпролактинемии.

4. Этиология и патогенез

- Лекарства: СИОЗС, СИОЗСН, антипсихотики (D2-блокада, гиперпролактинемия), антигипертензивные (β-блокатор, тиазид), опиоиды, ингибиторы 5α-редуктазы (финастерид — подозрение на постфинастеридный синдром), антиконвульсанты.
- Вещества: алкоголь, опиоиды, хроническое употребление каннабиса, стимуляторы.

- Соматические заболевания: диабет, сердечно-сосудистые, неврологические (РС, болезнь Паркинсона, травма спинного мозга), эндокринные (гипогонадизм, гиперпролактинемия, щитовидная железа), тазовая хирургия и радиотерапия, хроническая почечная недостаточность.
- Психические расстройства: депрессия, тревога, ПТСР, шизофрения.

5. Клиническая картина

- Снижение желания, нарушение возбуждения/эрекции, аноргазмия, боль — в зависимости от этиологии.
- Временная связь — с началом приёма лекарства/вещества.
- PSSD — сексуальная дисфункция, сохраняющаяся после отмены СИОЗС, генитальное онемение.

6. Диагноз

6.1 Единые диагностические критерии (DSM-5-TR)

A. Клинически значимая симптоматика сексуальной дисфункции.

B. Доказательства из анамнеза, физикального обследования или лабораторных результатов: симптомы являются прямым следствием приёма лекарств, веществ или соматического заболевания.

C. Дистресс.

6.2 Различия между источниками

- Montejo A.L. et al. — СИОЗС-индуцированная дисфункция.
- EMA (2019) — включила ПССД в инструкцию СИОЗС.

6.3 Алгоритм диагностики

1. Полный лекарственный и наркологический анамнез.
2. Медицинская и эндокринная оценка (тестостерон, пролактин, глюкоза, HbA1c, липиды, тиреоид).
3. Шкалы сексуальной функции (FSFI, IIEF, ASEX).
4. Скрининг психической коморбидности.
5. Гинекологический осмотр (у женщин).

6.4 Дифференциальная диагностика

Состояние	**Отличительный признак**
Первичные HSDD/ЭД/аноргазмия	Нет доказательств медицинской или лекарственной причины.
Депрессивное расстройство	Ангедония, доминируют симптомы настроения.
PSSD	Стойкая сексуальная дисфункция после отмены СИОЗС.

7. Обследование и оценка

- Гормональная панель, глюкоза, липиды.
- FSFI, IIEF, ASEX (англ. Arizona Sexual Experience Scale).
- При показаниях к гинекологическому или урологическому обследованию.

8. Лечение

1. Этиологический подход — первая линия:
    - Связанное с лекарствами — снижение дозы, медикаментозная замена (бупропион, миртазапин, вортиоксетин, арипипразол — в антидепрессивных или антипсихотических стратегиях);
    - Ведение медицинского состояния (диабет, гипертензия, гипогонадизм).
2. Адъюнктивная фармакотерапия — силденафил (PDE5) при ЭД и СИОЗС-индуцированной женской дисфункции (Nurnberg JAMA 2008); адъюнктивно бупропион.
3. При гиперпролактинемии — смена антипсихотика (арипипразол, кветиапин) или модификация дозы; агонист дофамина только с помощью эндокринолога.
4. Психотерапия и парная терапия — при психогенном компоненте.
5. Обучение пациента и информированное согласие — перед началом приёма антидепрессантов и антипсихотиков важно информировать о сексуальных побочных эффектах.
6. PSSD — специфического подтверждённого лечения нет; клиническая поддержка и наблюдение; исследования продолжаются.

8.1 Методики лечения

1. Медикаментозная замена (англ. Medication Switch) — СИОЗС → бупропион/миртазапин/вортиоксетин; рисперидон → арипипразол.
2. Силденафил адъюнктивно — Дисфункция, индуцированная СИОЗС (мужская и женская); Nurnberg JAMA РКИ.
3. Бупропион адъюнктивно — При расстройствах желания и оргазма.
4. Переход на антипсихотик (арипипразол) — В случае гиперпролактинемии.
5. Обучение пациента (англ. Patient Education) — Информированное согласие; обсуждение долгосрочного риска.

8.2 Различия между источниками

- Montejo A.L. et al. — алгоритмы антидепрессантных сексуальных побочных эффектов.
- EMA 2019 — информация о риске ПССД.
- Рекомендации NICE и APA — управление сексуальными побочными эффектами антидепрессантов.

9. Прогноз

Большинство случаев улучшается при этиологическом лечении и смене препарата; PSSD в редких случаях может сохраняться.

10. Мифы и заблуждения

Миф 1: «Сексуальные побочные эффекты антидепрессантов „временны“ и не требуют вмешательства»

Доказательства: Исследования Montejo — побочные эффекты стойкие (30–70%); требуют активного управления.

Миф 2: «ПССД не является клинической единицей»

Доказательства: EMA 2019 — риск ПССД включён в инструкцию СИОЗС; клинически признанная единица.

Миф 3: «Сексуальная дисфункция от антипсихотиков одинакова для всех»

Доказательства: рисперидон и палиперидон — высокий риск гиперпролактинемии; арипипразол и кветиапин — ниже; переключение эффективно.

Миф 4: «Сексуальная дисфункция, связанная с медицинским заболеванием, является только следствием болезни, вмешательства нет»

Доказательства: при диабетической ЭД ФДЭ5 эффективен; сексуальная функция улучшается при сердечно-сосудистой реабилитации; активное вмешательство обязательно.

Миф 5: «Перед началом приёма антидепрессанта не нужно обсуждать сексуальные побочные эффекты»

Доказательства: информированное согласие является этическим и клиническим требованием; позднее выявленные побочные эффекты приводят к недоверию пациента и снижению приверженности лечению.

11. Источники

1. WHO. ICD-11. HA40 Aetiological considerations in sexual dysfunctions and sexual pain disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Montejo A.L., Llorca G., Izquierdo J.A., Rico-Villademoros F. Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl 3):10–21.
4. EMA. PRAC recommends new product information warnings on sexual dysfunction after SSRI/SNRI treatment. 2019.
5. Nurnberg H.G. et al. Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction. JAMA 2008;300(4):395–404.
6. Bahrick A.S. Persistence of sexual dysfunction side effects after discontinuation of antidepressant medications. Open Psychol J 2008;1:42–50.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СТАНДАРТЫ МОНИТОРИНГА И ОБСЛЕДОВАНИЯ

Это приложение содержит стандартные протоколы мониторинга безопасности психотропной терапии и наблюдения за соматическим состоянием психиатрических пациентов.

A.1. Метаболический мониторинг при антипсихотической терапии

Атипичные антипсихотики – особенно оланзапин, кветиапин, клозапин – повышают риск метаболического синдрома (увеличение веса, дислипидемия, инсулинорезистентность, диабет).

График мониторинга (APA/ADA 2004, консенсус ADA/APA/AACE/NAASO):

Параметр	Начало	4 недели	8 недель	12 недель	Ежеквартально	Ежегодный
Личный/семейный анамнез	✓	—	—	—	—	✓
Вес, окружность талии	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Артериальное давление	✓	—	—	✓	—	✓
Глюкоза натощак	✓	—	—	✓	—	✓

Параметр	Начало	4 недели	8 недель	12 недель	Ежеквартально	Ежегодный
Липидный профиль натощак	✓	—	—	✓	—	✓ (1 раз в 2 года)

Если обнаружена аномалия:

- Увеличение веса ≥7%: рассмотреть замену препарата (арипипразол, зипрасидон – метаболически нейтральные);
- HbA1c ≥6,5% или глюкоза натощак ≥7: консультация диабетолога;
- LDL ≥3,4 ммоль/л: диета, статины.

Специфический мониторинг клозапина (из-за агранулоцитоза):

Длительность	Частота
Первые 6 месяцев	Еженедельно WBC и абсолютные нейтрофилы (ANC)
7–12 мес.	Раз в 2 недели
12+ мес.	Ежемесячно

Показатели ANC:

- ≥2,0 × 10^9/л: норма — продолжайте лечение;
- 1,5–2,0: еженедельное наблюдение;
- 1,0–1,5: Наблюдение каждые 2 дня, консультация гематолога;
- <1,0: препарат отменяется, вмешательство гематолога.

Мониторинг ЭКГ при приеме антипсихотиков:

- Риск удлинения QTc: особенно зипрасидон, галоперидол в/в, ондансетрон в комбинации;
- Начальная ЭКГ у пациентов с факторами риска (сердечное заболевание, нарушение электролитного баланса, >65 лет);
- QTc >500 мс или увеличение >60 мс от исходного уровня — Изменение лекарственной терапии;

- Лекарственные средства, повышающие риск: хлорпромазин, галоперидол (высокий), тиоридазин.

Гиперпролактинемия:

- Рисперидон, амисульприд, палиперидон — высокий риск;
- Симптомы: аменорея, галакторея, сексуальная дисфункция, остеопороз;
- Базальный пролактин; при повторном симптоме.

А.2. Мониторинг лития

Узкое терапевтическое окно — уровень 0,6–1,2 мЭкв/л, >1,5 — токсический уровень.

Параметр	**Начало**	**Каждые 6 месяцев**	**Ежегодный**
Уровень лития	Еженедельно в 1-й месяц, затем каждые 6 месяцев	✓	—
Креатинин, СКФ	✓	✓	—
TSH	✓	✓	—
Электролиты	✓	✓	—
Кальций	✓	—	✓
ЭКГ	✓ (возраст 50+)	—	—
Тест на беременность	Женщина детородного возраста	—	—

Признаки интоксикации литием:

- Тремор (более выраженный);
- Тахикардия;
- Диарея, рвота;
- Медленная, сбивчивая речь;
- Атаксия;
- Конвульсии — при тяжёлых состояниях.

Проверьте уровень при изменении состояния: дегидратация, добавление НПВП, добавление ингибитора АПФ, изменение функции почек.

А.3. Антиконвульсанты (вальпроат, карбамазепин, ламотриджин)

Вальпроат:

Параметр	Начало	Каждые 6 месяцев
Общий анализ крови (тромбоцитопения)	✓	✓
Функция печени (АСТ, АЛТ)	✓	✓
Уровень вальпроата	—	С симптомом или подозрением
Мониторинг признаков панкреатита	—	Каждый визит
Тест на беременность	**КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО у женщины детородного возраста**	**Каждый квартал**

Критично: вальпроат у женщин детородного возраста из-за дефекта нервной трубки и когнитивного повреждения применяется только при эффективной контрацепции, после предварительной оценки других вариантов.

Карбамазепин:

- CBC, печень — исходно, через 1 месяц, ежеквартально;
- Тест HLA-B*1502 у пациентов азиатского происхождения (риск Стивенса-Джонсона);
- Снижение уровня из-за аутоиндукции в первые 4 недели – проверь уровень.

Ламотриджин:

- Медленная титрация — Риск синдрома Стивенса-Джонсона;
- Начало 25 мг в неделю, в течение 4–8 недель до целевой дозы;

- В сочетании с вальпроатом: начальная доза 12,5 мг — вальпроат замедляет метаболизм ламотриджина;
- Если есть кожная реакция – немедленно прекратить.

А.4. Мониторинг СИОЗС и СИОЗСН

- Риск гипонатриемии — особенно у пожилых, принимающих диуретики;
- Базальный Na, через 1 месяц, затем с симптомом;
- Усиление суицидальности особенно при начале до 25 лет — тщательный мониторинг в первые 1–2 месяца;
- Удлинение QTc — эсциталопрам, циталопрам (в высоких дозах);
- Серотониновый синдром (MAOI или триптан и др. в комбинации) – обучение симптомам.

А.5. Применение бензодиазепинов

- Максимальная продолжительность: 2–4 недели;
- При длительном применении зависимость неизбежна;
- Схема снижения дозы (tapering): 25% каждые 2 недели, иногда медленнее;
- Симптомы отдачи (рикошетная тревога, бессонница, тремор) — нормально и временно.

А.6. Мониторинг психотерапии

Показатели качества:

- Продолжительность сеанса, частота;
- Шкалы симптомов пациента (PHQ-9, GAD-7 и т.д.) каждые 4–6 недель;
- Функциональные показатели;
- Оценка терапевтического альянса (англ. Working Alliance Inventory);
- Достижение посторонних целей;
- Признаки рецидива.

Супервизия и обсуждение с коллегой — в сложных случаях, а также по собственному желанию клинициста.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ШКАЛЫ СКРИНИНГА НАРУШЕНИЙ НЕЙРОРАЗВИТИЯ

Правила применения: Эти шкалы не диагностические, а скрининговые инструменты. Положительный результат – показание для специализированной клинической оценки, не является диагнозом. Окончательный диагноз устанавливается посредством клинического интервью, детальной оценки и (при необходимости) стандартизированных диагностических инструментов (ADOS-2, ADI-R, WISC-V и др.).

Лицензионный статус (отказ от ответственности): Шкалы, представленные в этом приложении полным текстом (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV), открыто предоставлены разработчиками для научных исследований и клинического использования. Эта книга — не сборник диагностических тестов, а клиническое руководство: лицензированные инструменты (WISC-V, ADOS-2, Vineland-3 и др., см. В.5) в тексте не воспроизводятся, их получение и использование требует официальной лицензии от правообладателя (Pearson, WPS, MHS и др.) и квалифицированного специалиста.

В.1. M-CHAT-R: Модифицированный скрининговый опросник на аутизм (дети 16–30 месяцев)

Оригинальные авторы: Diana L. Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009.

Оригинальный источник: Robins DL, Fein D, Barton M. M-CHAT-R/F. Self-published, 2009; Pediatrics, 2014; 133: 37–45.

Инструкция

Данная анкета состоит из 20 вопросов о повседневном поведении вашего ребёнка. Заполняется родителем или основным опекуном. На каждый вопрос отвечайте ДА или НЕТ — исходя из того, как ваш ребёнок обычно себя ведёт. Если вы видели такое поведение один-два раза, но в целом ребёнок так не делает, ответьте НЕТ.

Вопросы

№	Вопрос	ДА	Нет
1	Если вы посмотрите на что-то на другом конце комнаты, посмотрит ли туда же ваш ребёнок? (Например, на пролетающий самолет, большое животное или игрушку)	—	—
2	Вы когда-нибудь думали, что ваш ребёнок глухой?	—	—
3	Играет ли ваш ребёнок в воображаемые игры? (Например, пьёт из пустой чашки, разговаривает по телефону, кормит куклу)	—	—
4	Любит ли ваш ребёнок карабкаться на предметы? (Например, лестницу, дерево)	—	—

№	Вопрос	ДА	Нет
5	Совершает ли ваш ребёнок необычные движения ладонями, пальцами или другими частями тела перед глазами?	—	—
6	Указывает ли ваш ребёнок на то, что он хочет? (Например, на игрушку, находящуюся далеко на полке)	—	—
7	Указывает ли ваш ребёнок, чтобы привлечь ваше внимание к чему-то интересному? (Например, на самолет в небе или большую машину)	—	—
8	Проявляет ли ваш ребёнок интерес к другим детям? (Например, смотрит на детей на игровой площадке, пытается к ним присоединиться)	—	—

№	Вопрос	ДА	Нет
9	Делится ли ваш ребёнок с вами, показывая или кладя перед вами что-то (не для помощи, а для того, чтобы поделиться)?	—	—
10	Реагирует ли ваш ребёнок, когда его называют по имени?	—	—
11	Улыбается ли ваш ребёнок вам в ответ, когда вы ему улыбаетесь?	—	—
12	Беспокоят ли вашего ребёнка повседневные звуки? (Например, пылесос, громкая музыка)	—	—
13	Ходит ли ваш ребёнок?	—	—
14	Смотрит ли ваш ребёнок вам в глаза, когда вы одеваете его или играете с ним?	—	—

№	Вопрос	ДА	Нет
15	Подражает ли ваш ребёнок вашим действиям? (Например, когда вы делаете что-то с лицом, он делает то же самое)	—	—
16	Смотрит ли ваш ребёнок на вас, когда слышит что-то, чтобы понять, что происходит?	—	—
17	Ваш ребёнок пытается привлечь ваше внимание? (например, посмотреть на вас, получить похвалу, сказать «смотри!»)	—	—
18	Ваш ребёнок реагирует на понимаемые слова? (например, когда говорят «дай мне мяч» или «возьми книгу»)	—	—

№	Вопрос	ДА	Нет
19	Если происходит что-то новое или странное, смотрит ли ваш ребёнок на ваше лицо, чтобы увидеть вашу реакцию?	—	—
20	Любит ли ваш ребёнок подвижные игры? (Например, прыжки в воздухе, подпрыгивание на коленях)	—	—

Подсчёт баллов

Балл риска = количество ответов «НЕТ», за исключением вопросов 2, 5 и 12 — НЕТ является признаком риска (в этих трёх вопросах ответ ДА считается риском).

То есть:

- В вопросах 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 — Ответ «НЕТ» считается признаком риска.
- В вопросах 2, 5, 12 — Ответ ДА считается признаком риска.

Интерпретация результатов

Балл	Уровень риска	Рекомендация
0–2	Низкий риск	Дополнительная оценка не требуется (при отсутствии других факторов риска); рекомендуется повторный скрининг до 24 месяцев

Балл	Уровень риска	Рекомендация
3–7	Средний риск	**M-CHAT-R/F (Follow-up) требуется** — структурированное интервью для наблюдения; проводится медицинским работником
8–20	Высокий риск	**Требуется срочная диагностическая оценка РАС и направление в программу раннего вмешательства**

Примечание: M-CHAT-R — используется в различных клиниках на азербайджанском языке, однако официальная валидация в азербайджанской популяции ограничена. Вышеуказанный перевод предназначен для клинической практики; в научных исследованиях должен использоваться оригинальный официальный перевод (официальные переводы: https://mchatscreen.com).

B.2. AQ-10: Краткая оценка расстройств аутистического спектра (16 лет+)

Оригинальные авторы: Carrie Allison, Bonnie Auyeung, Simon Baron-Cohen, 2012.

Оригинальный источник: Allison C, Auyeung B, Baron-Cohen S. Toward brief «red flags» for autism screening: the short Autism Spectrum Quotient (AQ-10). *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 2012; 51: 202–212.

Инструкция

Что вы думаете о следующих 10 утверждениях? Для каждого утверждения Полностью согласен, Частично согласен, Частично не согласен, Полностью не согласен выберите один из вариантов.

Вопросы

№	Утверждение
1	Я часто замечаю мелкие звуки, которые другие не замечают
2	Я обычно обращаю больше внимания на общую картину, а не на мелкие детали
3	Мне трудно следить за разговором нескольких людей в социальной ситуации
4	Я часто настолько сосредотачиваюсь на одной теме или занятии, что упускаю другие вещи
5	Я легко понимаю, что другой человек думает или чувствует, когда он что-то говорит
6	Я хорошо умею читать намерения людей
7	Когда читаю историю, мне трудно понять, о чём думают персонажи
8	Мне нравится собирать подробную информацию о занятиях, которыми я занимался ранее (например, марки автомобилей, птицы, поезда)
9	Когда я смотрю на человека, мне трудно понять, что он думает или чувствует
10	Мне трудно знать, как вести себя в социальных ситуациях

Подсчёт баллов

Вопрос	«Полностью согласен / Частично согласен» – 1 балл	«Полностью не согласен / Частично не согласен» – 1 балл
1	✓	—
2	—	✓
3	✓	—
4	✓	—
5	—	✓
6	—	✓
7	✓	—
8	✓	—
9	✓	—
10	✓	—

Общий балл = из 10

Интерпретация результатов

Балл	Рекомендация
0–5	Вероятность диагностической оценки РАС низкая
≥6	**Рекомендуется детальная клиническая оценка РАС**

Примечание: AQ-10 — это краткая версия классического AQ-50. Официально рекомендован NICE CG142 (Великобритания) для скрининга РАС у взрослых в первичном звене. Чувствительность ~77%, специфичность 36–41%. AQ-10 особенно надёжен для «самоскрининга» и должен использоваться вместе с первоначальным клиническим собеседованием.

B.3. ASRS v1.1: Шкала самоотчета для взрослых с СДВГ

Оригинальные авторы: ВОЗ, Рональд С. Кесслер и соавт., Гарвардская медицинская школа, 2005.

Оригинальный источник: Kessler RC, Adler L, Ames M, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). *Psychological Medicine*, 2005; 35: 245–256.

Инструкция

Данная шкала предназначена для скрининга симптомов СДВГ у взрослых. На следующие 6 вопросов – в течение последних 6 месяцев ответьте, основываясь на том, как вы себя чувствуете. Для каждого вопроса Никогда, Редко, Иногда, Часто, Очень часто выберите один из вариантов.

Часть А – Первичный скрининг (6 вопросов)

№	Вопрос	Никогда	Редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Как часто вы испытываете трудности с завершением последних деталей после того, как сложная часть проекта завершена?	—	—	—	—	—

№	Вопрос	Никогда	Редко	Иногда	Часто	Очень часто
2	Как часто вы испытываете трудности с упорядочиванием дел при выполнении работы, требующей организации?	—	—	—	—	—
3	Как часто вы испытываете проблемы с запоминанием встреч или обязательств?	—	—	—	—	—

№	**Вопрос**	**Никогда**	**Редко**	**Иногда**	**Часто**	**Очень часто**
4	Когда у вас есть задача, требующая много размышлений, как часто вы избегаете начинать или откладываете её?	—	—	—	—	—
5	Как часто вы шевелите или потягиваете руки и ноги, когда вам приходится долго сидеть?	—	—	—	—	—
6	Как часто Вы чувствуете себя «двигающимся» или испытываете необходимость что-то делать?	—	—	—	—	—

Расчёт (для Части А)

Ответы в жирных ячейках таблицы — положительный признак.

Вопрос	Ответы, засчитываемые как позитивный признак
1	**Иногда, Часто, Очень часто**
2	**Иногда, Часто, Очень часто**
3	**Иногда, Часто, Очень часто**
4	**Часто, Очень часто**
5	**Часто, Очень часто**
6	**Часто, Очень часто**

Общее количество положительных признаков = _____ / 6

Интерпретация результатов

Количество позитивных признаков	Комментарий
0–3	Симптомы нетипичны для взрослого СДВГ.
≥4	**Симптомы в высокой степени соответствуют взрослому СДВГ. Рекомендуется медицинская оценка.**

Часть В – Расширенный опросник (12 дополнительных вопросов)

Когда Часть А положительна, для использования совместно с клинической оценкой применяются вопросы Части В (12 дополнительных вопросов). Полная версия Части В доступна на официальном сайте разработчиков: https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php

Примечание: ASRS v1.1 – разработана ВОЗ, наиболее часто используемая в мире скрининговая шкала СДВГ у взрослых. После Кесслера во всем мире ASRS-5 (APA, 2013 — по критериям DSM-5, 2017) доработана — более короткая версия из 5 вопросов. Обе версии подходят для скрининга, ASRS v1.1 всё ещё широко используется.

B.4. SNAP-IV: Рейтинговая шкала Свонсона, Нолана и Пелхэма (детский СДВГ)

Оригинальные авторы: James M. Swanson, 1983.

Оригинальный источник: Swanson JM. School-based assessments and interventions for ADD students. Irvine, CA: KC Publishing, 1992.

Инструкция

SNAP-IV – оценка симптомов СДВГ у детей на основе критериев DSM-IV/APA, 1994 и DSM-5/APA, 2013. Заполняется родителем или учителем. Как каждый симптом наблюдался у вашего ребёнка в течение последнего месяца: Нет (0), Немного (1), Сильно (2), Очень сильно (3).

Вопросы (SNAP-IV краткая версия – 26 вопросов)

Подшкала невнимательности (пункты 1–9):

№	Утверждение	0	1	2	3
1	Часто допускает невнимательные ошибки в школьной работе или других занятиях	—	—	—	—

№	Утверждение	0	1	2	3
2	Часто испытывает трудности с удержанием внимания на заданиях или играх	—	—	—	—
3	Часто кажется, что не слушает, когда к нему обращаются напрямую	—	—	—	—
4	Часто не следует инструкциям и не завершает школьную работу, повседневные задания	—	—	—	—
5	Часто испытывает трудности с организацией заданий и занятий	—	—	—	—

№	Утверждение	0	1	2	3
6	Часто избегает, не любит или неохотно выполняет задания, требующие длительных умственных усилий	—	—	—	—
7	Часто теряет вещи, необходимые для заданий или занятий (школьные материалы, карандаши, книги)	—	—	—	—
8	Часто легко отвлекается на внешние стимулы	—	—	—	—
9	Часто забывчив в повседневной деятельности	—	—	—	—

Подшкала гиперактивности-импульсивности (пункты 10–18):

№	Утверждение	0	1	2	3
10	Часто ерзает руками или ногами или крутится на месте	—	—	—	—
11	Часто не сидит на месте, когда нужно сидеть	—	—	—	—
12	Часто чрезмерно бегает или лазает в неподходящих ситуациях	—	—	—	—
13	Часто испытывает трудности при спокойной игре	—	—	—	—
14	Часто ведёт себя «подвижно» или «активно в двигательном плане»	—	—	—	—
15	Часто чрезмерно говорит	—	—	—	—

№	Утверждение	0	1	2	3
16	Часто выпаливает ответы до того, как вопрос закончен	—	—	—	—
17	Часто не может дождаться своей очереди	—	—	—	—
18	Часто прерывает деятельность других (разговор, игру)	—	—	—	—

Подшкала оппозиционно-вызывающего поведения (пункты 19–26):

№	Утверждение	0	1	2	3
19	Часто выходит из себя	—	—	—	—
20	Часто спорит со взрослыми	—	—	—	—
21	Часто противится требованиям или правилам взрослых	—	—	—	—

№	Утверждение	0	1	2	3
22	Часто намеренно раздражает других	—	—	—	—
23	Часто обвиняет других в своих ошибках или плохом поведении	—	—	—	—
24	Часто легко раздражается другими	—	—	—	—
25	Часто раздражителен и резко недоволен	—	—	—	—
26	Часто ведёт себя мстительно или злопамятно	—	—	—	—

Подсчёт баллов

Среднее по каждой субшкале:

- Подшкала невнимательности (1–9): сумма ÷ 9 = _____
- Подшкала гиперактивности-импульсивности (10–18): сумма ÷ 9 = _____
- Подшкала оппозиционно-вызывающего поведения (19–26): сумма ÷ 8 = _____

Интерпретация результатов (средние уровни)

Подшкала	Родитель: положительная граница	Учитель: положительная граница
Невнимательность	≥1,78	≥2,56
Гиперактивность-импульсивность	≥1,44	≥1,78
Оппозиционно-вызывающее поведение	≥1,88	≥2,00

Эти границы основаны на данных Bussing et al., 2008 и предназначены для популяции США. Специальная валидация в азербайджанской популяции не проводилась – результаты следует интерпретировать в клиническом контексте.

Диагностическая интерпретация

Тип презентации СДВГ по критериям DSM:

- Преимущественно невнимательный: Положительна только подшкала невнимательности;
- Преимущественно гиперактивно-импульсивный: Положительна только подшкала гиперактивности;
- Комбинированный: Обе субшкалы положительны.

Положительный результат по подшкале оппозиционно-вызывающего поведения указывает на вероятность коморбидного оппозиционно-вызывающего расстройства (ОВР, МКБ-11 6C90).

Примечание: SNAP-IV – свободно доступен для исследовательского и клинического использования. Полная версия на 90 вопросов, краткая версия на 26 вопросов и версии для учителей доступны для загрузки с официального сайта проф. Свонсона: http://www.shared-care.ca/files/Scoring_for_SNAP_IV_Guide_26-item.pdf

B.5. Основные инструменты оценки интеллекта и адаптивного функционирования (таблица данных)

Перечисленные ниже инструменты лицензированы, поэтому они не могут быть полностью приведены в тексте. Для их получения и использования необходим клинический психолог или квалифицированный специалист.

B.5.1. Оценка интеллекта

Инструмент	Возрастная группа	Издатель	Типичное время
WPPSI-IV (англ. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)	2 года 6 мес. – 7 лет 7 мес.	Pearson	60–90 мин
WISC-V (англ. Wechsler Intelligence Scale for Children)	6–16 лет	Pearson	60–90 мин
WAIS-IV/V (англ. Wechsler Adult Intelligence Scale)	16–90 лет	Pearson	60–90 мин
Stanford-Binet 5	2 года+	Riverside Insights	45–75 мин
Leiter-3 (невербальный)	3–75+ лет	Stoelting	25–40 мин
Raven's Progressive Matrices	5 лет+	Pearson	20–40 мин

B.5.2. Адаптивное поведение

Инструмент	Возрастная группа	Издатель	Тип оценки
Vineland-3 (англ. Vineland Adaptive Behavior Scales)	От рождения до 90+ лет	Pearson	Полуструктурированное интервью с родителем/опекуном
ABAS-3 (англ. Adaptive Behavior Assessment System)	От рождения до 89 лет	WPS	Оценочная форма для родителя/учителя

B.5.3. Диагностические инструменты аутизма

Инструмент	Возрастная группа	Издатель	Типичное время
ADOS-2 (англ. Autism Diagnostic Observation Schedule)	12 мес. – взрослые	WPS	40–60 мин (5 модулей)
ADI-R (англ. Autism Diagnostic Interview – Revised)	2 года – взрослый	WPS	90–150 мин
CARS-2 (англ. Childhood Autism Rating Scale)	2 года+	WPS	15–30 мин
SRS-2 (англ. Social Responsiveness Scale)	2,5 года+	WPS	15–20 мин

B.5.4. Детальная оценка СДВГ

Инструмент	Возрастная группа	Издатель
Conners-3 (англ. Conners Rating Scales)	6–18 лет	MHS
Conners CBRS	6–18 лет	MHS
CAARS (англ. Conners Adult ADHD Rating Scales)	18+ лет	MHS
BRIEF-2 (англ. Behavior Rating Inventory of Executive Function)	5–18 лет	PAR
CPT-3 (англ. Conners Continuous Performance Test)	8 лет+	MHS

Примечание автора

Скрининговые шкалы, представленные в Приложении Б (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV), готовы к непосредственному использованию в клинической работе. Мы благодарим авторов этих шкал и их учреждения — ВОЗ, Гарвардскую медицинскую школу, профессора Саймона Барон-Коэна и соавторов, Диану Робинс, Дебору Фейн, Марианну Бартон и Джеймса Свансона — за большой вклад в современную психиатрию.

Лицензированные диагностические инструменты (ADOS-2, WISC-V, Vineland-3 и другие) не могут быть воспроизведены в этой книге полностью. Их применение требует специальной подготовки и официально приобретённой лицензии. Клиницистам следует получать эти инструменты непосредственно у авторизованных издателей (Pearson, WPS, MHS или эквивалентных дистрибьюторов в своей юрисдикции).

Примечание о переводе и локальной валидации. Представленные в этой книге переводы на азербайджанский язык являются рабочей клинической версией. Они ещё не прошли формальную психометрическую валидацию для азербайджанской популяции. Для научных публикаций и валидационных исследований следует обращаться к официальным издателям за

авторизованными переводами. Разработка популяционных нормативных данных для Азербайджана остаётся важным приоритетом будущей работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ С

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

В неотложной ситуации времени нет: решение измеряется минутами и почти всегда принимается на неполных данных. Это приложение написано именно для таких минут — короткие перечни того, что нужно сделать, а не рассуждения. Они не заменяют клинического мышления; они страхуют от шага, который в спешке легко пропустить.

С.1. Активный суицидальный риск

Оценка суицидального риска — это разговор, а не анкета. Спрашивать нужно прямо: вопрос не «внушает» мысль, а чаще всего впервые даёт пациенту возможность сказать о ней вслух. Слушать следует прежде всего то, насколько намерение обрело конкретность.

Первичная оценка:

- Есть ли суицидальные мысли? План? Средства?
- Конкретность плана: если пациент называет время, место и способ, риск резко возрастает; общее «иногда я хочу умереть» — это другой уровень;
- Предыдущие попытки — самый сильный предиктор;
- Интоксикация веществом — снижение ингибиции;
- Протективные факторы — семейные, религиозные убеждения, будущие планы.

Признаки высокого риска:

- Конкретный план и лёгкий доступ к средству;
- Недавнее изменение обстоятельств (утрата, тяжёлое заболевание);
- Одиночество и хроническая боль;
- Психоз или тяжёлая депрессия;
- Ранняя фаза выхода из депрессии — энергия возвращается, а настроение остаётся сниженным;
- Взрослый мужчина, инвалидность, алкоголь.

Управление:

Низко-средний риск:

- План безопасности — письменный;
- Снижение доступности средств (удаление оружия, лекарства в малых количествах);
- Частое амбулаторное наблюдение (повторный приём в течение 24–48 часов);
- Номер кризисной линии;
- Участие семьи (с согласия).

Высокий риск:

- Госпитализация (добровольно или принудительно);
- Пристальное наблюдение — при очень высоком риске один к одному;
- Удаление опасных предметов (режущие предметы, верёвка, доступ к окну);
- Контролируемый приём лекарств.

Принудительная госпитализация в контексте Азербайджана:

- Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи»;
- Для принудительной госпитализации решение двух психиатров и юридическая процедура;
- Судебное решение после 72 часов экстренного наблюдения;

C.2. Делирий тременс и отмена алкоголя

Симптомы:

- Тремор — руки, затем общее;
- Тревога, ажитация;
- Галлюцинации — зрительные и тактильные («насекомые под кожей»);
- Дезориентация;
- Вегетативная гиперактивность — тахикардия, давление, потливость, лихорадка;
- Судорожные приступы (~5–10%).

Лечение (в условиях ОИТ или ПИТ):

- Бензодиазепин — диазепам 10–20 мг в/в или в/м каждые 15–20 мин до достижения седации; затем поддерживающий режим;
- Альтернатива: лоразепам (при дисфункции печени);
- Тиамин 100–300 мг в/в — Профилактика энцефалопатии Вернике. До введения глюкозы.
- Восстановление жидкости и электролитов;
- Магния сульфат, калий – чаще всего снижены;
- Смертность: без лечения 15–20%, при адекватном лечении <1%.

Шкала CIWA-Ar — для мониторинга.

С.3. Серотониновый синдром

Причина: СИОЗС + ИМАО, СИОЗС + триптан, СИОЗС + трамадол, СИОЗС + линезолид, СИОЗС + метиленовый синий и др.

Симптомы:

- Изменение психики — ажитация, спутанность сознания;
- Вегетативные проявления — тахикардия, гипертония, гипертермия, потливость;
- Нервно-мышечные проявления — тремор, гиперрефлексия, клонус (нижние конечности – специфический признак).

Лечение:

- Немедленная отмена причинного препарата;
- Поддержка — жидкости, электролиты, охлаждение;
- В тяжёлых случаях ципрогептадин 12 мг начально, 2 мг каждый час, максимум 32 мг/сут;
- Инвазивное вмешательство (интубация) при тяжёлой гипертермии.

С.4. Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

Причина: антипсихотики (особенно высокопотентные, галоперидол), острое начало или увеличение дозы.

Симптомы (4 основных):

1. Мышечная ригидность («железная труба»);
2. Гипертермия (38–42°C);
3. Вегетативная лабильность (высокое артериальное давление, тахикардия, потливость);
4. Изменение психического состояния (спутанность → ступор → кома).

Лабораторно: Резкое повышение КФК (>1000), миоглобинурия, лейкоцитоз, повышенные ALT/AST.

Лечение (ОИТ):

- Немедленная отмена антипсихотика;
- Бред;
- Жидкости (риск рабдомиолиза и острой почечной недостаточности);
- Дантролен 1–2,5 мг/кг в/в – уменьшает мышечную ригидность;
- Бромокриптин 2,5–5 мг каждые 8 часов – агонист дофамина;
- ЭСТ при отсутствии ответа на терапию.

Смертность: 5–20% при адекватном лечении.

С.5. Острая дистония

Причина: начало приёма антипсихотика, особенно сильных антагонистов D2.

Симптомы:

- Острые мышечные спазмы — шеи (кривошея), языка, глаз (окулогирный криз), определённый спазм пищевода;
- Угроза жизни – ларингоспазм.

Лечение:

- Дифенгидрамин 50 мг в/м или в/в – облегчение через 15 минут;
- Бензтропин 1–2 мг в/м/в/в;
- Снижение дозы или замена антипсихотика;
- Профилактические антихолинергические средства у пациентов с риском.

С.6. Острая мания и психомоторное возбуждение

Управление:

- Предпочтительно перорально: галоперидол 2–5 мг + лоразепам 1–2 мг;

- В/м по показаниям: галоперидол 5 мг + лоразепам 2 мг (50/50 шприц) или оланзапин в/м 10 мг;

- Безопасная среда — спокойная, свободная от стимулов обстановка;
- Вербальная деэскалация — первый шаг;
- Лекарства:
- Недобровольная госпитализация по указанию;
- Физическое стеснение — только как крайняя мера, при угрозе жизни и на короткое время.

С.7. Острый психоз

Протокол, аналогичный вышеуказанному. Дифференциал: органические причины, интоксикация веществами, послеродовой психоз, ЗНС.

С.8. Кататония

Симптомы:

- Ступор, мутизм;
- Каталепсия («флексибильность воска»);
- Негативизм;
- Манерности, стереотипии;
- Эхолалия, эхопраксия.

Лечение первой линии:

- Лоразепам 1–2 мг в/в или в/м — проба — Значимый ответ в течение 1–2 часов → диагноз и лечение кататонии;
- При получении ответа — довести до дозы 4–24 мг/сут;
- Без ответа — ЕСТ: вторая линия, очень эффективна;
- Избегать антипсихотиков: в острой фазе могут спровоцировать развитие ЗНС.

Ищи причину: органические (энцефалит, эпилепсия), расстройства настроения, шизофрения, аутизм, некоторые вещества.

ПРИЛОЖЕНИЕ D

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)

Это приложение — практическое руководство по психиатрическим аспектам оценки годности к военной службе в Азербайджанской Республике.

D.1. Правовая основа

- «О военной службе» Закон Азербайджанской Республики;
- Положение о военно-врачебной экспертизе;
- Министерства обороны нормативные акты;
- Таблица болезней — делится на две части: легкие/тяжёлые степени, группы A-D.

D.2. Структура психиатрической оценки

Основная экспертиза:

- Жалобы и анамнез (пациент и близкие родственники);
- Предыдущие медицинские документы;
- Клиническое интервью и оценка психического статуса;
- Экспериментально-психологическое обследование (ЭПМ) – психологом;
- Лабораторные и инструментальные исследования при необходимости;
- Дифференциальный диагноз, оценка степени тяжести заболевания;
- Результат.

Типичные психологические тесты (EPM):

- MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) – профиль личности;
- Прогрессивные матрицы Равена — интеллект;
- Тесты Лурии — память, внимание;
- Шкала интеллекта Векслера (WAIS);

- Тест Роршаха — проективный метод (современная надёжность спорна);
- Шкалы Бека, Гамильтона — настроение.

D.3. Психиатрические расстройства и оценка годности к военной службе

Классификация по группам (адаптация – на основе местных нормативных актов):

Группа A – полностью годен к службе

Психиатрический анамнез отсутствует или имеются незначительные преходящие проблемы.

Группа B – ограниченно пригоден

- Легкие черты личности (не достигающие порога расстройства);
- Временные расстройства адаптации;
- Легкие расстройства сна;
- Невротические расстройства в стадии ремиссии.

Группа V — ограничен во время службы

- Умеренные психические расстройства в случае частичной ремиссии;
- Определённые расстройства личности;
- Перенесенное ПТСР, компенсированное;
- Умеренная нейрокогнитивная дисфункция.

Группа Q – не годен к службе

- Спектр шизофрении;
- Биполярное расстройство;
- Тяжёлая депрессия;
- Активное ПТСР/комплексное ПТСР (ветераны Карабахской войны — отдельная программа лечения);
- Расстройства употребления вещества;
- Тяжёлые расстройства личности;
- Умственная отсталость;

- Тяжёлые формы расстройства аутистического спектра;
- Расстройства с активным суицидальным риском;
- Парафилические расстройства (тяжёлые, активные).

D.4. Послеродовая травма и оценка ветеранов

У ветеранов Карабахской войны:

- Комплексное ПТСР: высокая распространённость — травма-ориентированное вмешательство;
- Употребление алкоголя и психоактивных веществ — коморбидно;
- Депрессия, риск суицида;
- Нарушение семейной функции;
- Моральный вред — этический конфликт во время боевых действий (убийство, свидетельствование);
- Ожог и повторная травматизация — факторы риска.

Специфические программы реабилитации:

- Терапия травмы с подтверждённой эффективностью (PE, CPT, EMDR);
- Групповая терапия для ветеранов;
- Семейная терапия;
- Препарат (СИОЗС/СИОЗСН);
- Социальная реабилитация (работа, образование).

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

СВЯЗАННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Краткое описание неврологических заболеваний, важных для клинической практики на стыке психиатрии и неврологии.

Е.1. Эпилепсия (G40) и психиатрические проявления

Эпилептические синдромы и психиатрия:

- Межприступные изменения личности (синдром Гешвинда – гиперрелигиозность, гиперграфия, «вязкость»);

- Интериктальный психоз – длительная височная эпилепсия;

- Постиктальный психоз – психотические эпизоды в течение 24–72 часов после приступа;

- Иктальная тревога и диссоциативные переживания;

- Височная эпилепсия (TLE) — наиболее частая психиатрическая коморбидность:
- Абсансная эпилепсия — проблема внимания, дифференциальная диагностика с СДВГ;
- Ювенильная миоклоническая эпилепсия — высокая коморбидная тревога, импульсивность.

Психогенные (неэпилептические) приступы (PNES) – диссоциативное расстройство неврологических симптомов (6B64.4):

- Видео-ЭЭГ — золотой стандарт дифференциальной диагностики;
- PNES — часто коморбидны с эпилепсией, 10–30%;
- Лечение: КПТ-ПНЭС, медленная отмена антиконвульсантов.

Психиатрические побочные эффекты антиэпилептиков:

- Леветирацетам: агрессия, раздражительность, депрессия;
- Фенобарбитал, примидон: депрессия, когнитивное замедление;
- Топирамат: Когнитивная дисфункция, депрессия;

- Ламотриджин: снова стабилизирует настроение.

E.2. Головная боль и психиатрическая коморбидность

- Мигрень — риск депрессии в 2–4 раза выше; тревожные расстройства;
- Кластерная головная боль — депрессия, риск суицида;
- Хроническая ежедневная головная боль — злоупотребление анальгетиками (МОН) – частая коморбидность с расстройством настроения;
- Хроническая головная боль напряжения — связана с интенсивным стрессом, тревогой.

Управление:

- СИОЗС/СИОЗСН улучшают многие типы головной боли;
- ТСА (амитриптилин) — исторический стандарт для профилактической мигрени;
- Топирамат, вальпроат профилактически;
- КПТ эффективна при хронической головной боли;
- Избегать употребления опиоидов и чрезмерного использования анальгетиков.

E.3. Цереброваскулярные заболевания (инсульт)

- Постинсультная депрессия: 30–40% в первый год;
- Постинсультная мания: редко, при повреждениях правой лобной доли или таламуса;
- Псевдобульбарный аффект (патологический смех/плач): комбинация декстрометорфан-хинидин является подтверждённым лечением;
- Сосудистое когнитивное расстройство/деменция: классификация под кодом 6D81;
- Реабилитация: ведущую роль играет мультидисциплинарная психиатрическая команда.

E.4. Болезнь Паркинсона

- Депрессия: 30–50%;
- Тревога: 30–40%;

- Импульсивное расстройство контроля, индуцированное агонистами дофамина: 13–36%;
- Психоз при болезни Паркинсона: Преимущественно зрительные галлюцинации; индуцированные леводопой;
- Деменция при болезни Паркинсона: 6D85;
- Расстройство поведения в фазе быстрого сна: Ранний маркер для болезни Паркинсона.

Особенности лечения:

- Применение антипсихотиков при болезни Паркинсона: кветиапин, клозапин (Минимальная блокада D2);
- Галоперидол, рисперидон — ухудшают моторные симптомы;
- СИОЗС для депрессии;
- Пимавансерин — Одобрен в США для психоза при болезни Паркинсона.

Е.5. Рассеянный склероз (РС)

- Депрессия: 30–50%;
- Тревога: 30%;
- Симптомы, сходные с биполярным расстройством: 5–10%;
- Псевдобульбарный аффект;
- Когнитивная дисфункция — в большинстве случаев заболевания;
- Оцепенение и утомляемость — тесная связь с депрессией, сложная дифференциальная диагностика.

Терапия интерфероном-бета ухудшает депрессию – активный мониторинг.

Е.6. Черепно-мозговая травма (ЧМТ)

- Постконтузионный синдром: головная боль, головокружение, проблемы с памятью, изменения настроения;
- Хроническая травматическая энцефалопатия (CTE): Повторные травмы, спорт (бокс, американский футбол);
- ПТСР + ЧМТ — очень часто коморбидны;
- Изменение личности (6E68) – при фронтальных поражениях.

E.7. Деменция (подробно в Разделе 17)

- 6D80 Альцгеймер;
- 6D81 Сосудистый;
- 6D82 Телец Леви;
- 6D83 Лобно-височная;
- 6D84 Связанное с веществом;
- 6D85 С болезнью Паркинсона;
- 6D86 Поведенческие/психологические расстройства при деменции (BPSD).

E.8. Судороги, двигательные расстройства и психиатрия

- Синдром Туретта (8A05.00) — В МКБ-11 в разделе неврологических заболеваний, но коморбидность с СДВГ и ОКР очень высока;
- Болезнь Вильсона — генетическое нарушение метаболизма меди; частые психиатрические проявления (депрессия, психоз); проверка – церулоплазмин, суточная моча на медь;
- Болезнь Гентингтона — расстройства настроения, ОКР, психоз, моторная хорея.

ОБЩИЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Основные источники МКБ-11 и DSM-5

1. WHO. Клинические описания и диагностические требования для психических, поведенческих расстройств и расстройств нейроразвития МКБ-11 (KTTD). Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2024. ISBN: 9789240077263.
2. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR). APA Publishing; 2022.
3. First MB, Reed GM, Hyman SE, Saxena S. The development of the ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines for Mental and Behavioural Disorders. *World Psychiatry*, 2015; 14: 82–90.
4. Reed GM, et al. Инновации и изменения в классификации психических, поведенческих расстройств и расстройств нейроразвития МКБ-11. *World Psychiatry*, 2019; 18: 3–19.

Учебники клинической психиатрии.

1. Popov Yu.V., Vid V.D. Современная клиническая психиатрия. 2-е издание. Санкт-Петербург: Речь, 2006.
2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. *Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry.* 11th ed. Wolters Kluwer; 2023.
3. Gelder MG, Andreasen NC, Lopez-Ibor JJ, Geddes JR (eds). *New Oxford Textbook of Psychiatry.* 3rd ed. Oxford UP; 2020.
4. Cowen P, Harrison P, Burns T. *Shorter Oxford Textbook of Psychiatry.* 7-е изд. Oxford UP; 2018.

Источники на азербайджанском языке

1. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики. Нормативные документы по обследованию и лечению психически больных.
2. «О психиатрической помощи» Закон Азербайджанской Республики (2001, с изменениями).

Практические клинические руководства (guidelines)

1. NICE (UK) Clinical Guidelines – по психиатрическим состояниям: CG31 ОКР, CG78 ПРЛ, CG90 Депрессия, CG113 ГТР, CG115 Алкоголь, CG158 Расстройства поведения, NG69 Расстройства пищевого поведения, NG116 ПТСР, CG111 Энурез.
2. Руководства APA по клинической практике – шизофрения, БАР, БДР, расстройства пищевого поведения, болезнь Альцгеймера.
3. Рекомендации WFSBP — биполярное расстройство, шизофрения, ОКР, ПТСР, парафилические расстройства.
4. ISTSS (англ. International Society for Traumatic Stress Studies). *PTSD Prevention and Treatment Guidelines.* 3rd ed. 2019.
5. CANMAT/ISBD. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments / International Society for Bipolar Disorders Treatment Guidelines. 2018, 2023.
6. AACAP Practice Parameters – психиатрические расстройства у детей и подростков.

Основные рецензируемые журналы

1. *American Journal of Psychiatry* (APA)
2. *World Psychiatry* (WPA)
3. *Lancet Psychiatry*
4. *JAMA Psychiatry*
5. *British Journal of Psychiatry*
6. *Psychological Medicine*
7. *Journal of Clinical Psychiatry*
8. *European Psychiatry*

Онлайн-ресурсы

1. МКБ-11: https://icd.who.int
2. MGH Center for Women’s Mental Health: https://womensmentalhealth.org
3. Cochrane Library: систематические психиатрические обзоры
4. UpToDate Psychiatry — клинический справочный ресурс
5. Psychiatry Online (англ. APA Publishing) — учебники, правила
6. Columbia Suicide Severity Rating Scale: https://cssrs.columbia.edu

Кянан Рагимов

Баку, 2026

ragimoff.org

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Практический синтез для клиницистов.

Основные клинические уроки, полученные из всех глав книги:

Диагноз всегда второй шаг, а не первый

Перед постановкой диагноза психического расстройства обязательно:

- Исключите медицинские причины — особенно при начале в возрасте 40–50 лет, остром начале, атипичном профиле, соматических симптомах, изменениях гормонального цикла;
- Проверьте употребление вещества — в 30% случаев скрытый компонент психоактивных веществ;
- Активно спрашивайте о травме — комплексное ПТСР и расстройства личности часто оказываются её следствием, но без целенаправленного скрининга не выявляются.

МКБ-11 принцип «первичное vs вторичное» — основная рамка для клинициста.

Психотерапия – первый выбор в большинстве случаев

Центральное послание эпохи МКБ-11: эффективность психотерапии подтверждена, она как минимум не уступает фармакотерапии, а при многих расстройствах превосходит:

- При лёгкой-умеренной депрессии — КПТ, ИПТ наравне с СИОЗС;
- При тревожных расстройствах — КПТ 1-я линия;
- При ОКР — ЭРП обязательна; СИОЗС дополнительно;
- При ПТСР — ТФ-КПТ, ДПДГ 1-я линия;
- При расстройствах личности — DBT, МПТ, ТФП – эффективнее фармакотерапии;
- При расстройствах пищевого поведения — КПТ-Р, СТ;
- При детских расстройствах поведения — программы обучения родителей.

Фармакотерапия во многих случаях — адъюнкт: помогает пациенту повысить и сохранить эффективность психотерапии.

Принцип минимальной эффективной дозы

- Начало низкое, повышать медленно;
- Достижение строго минимальной эффективной дозы;
- Избегайте полипрагмазии — особенно у пожилых, при коморбидности, расстройствах личности;
- Отмена или снижение дозы препарата требует знаний — СИОЗС нельзя отменять резко, бензодиазепины следует отменять постепенно.

Работа с культурой и контекстом

В контексте Азербайджана:

- Соматическая презентация очень распространена — в первичном звене депрессия, тревога требуют активного скрининга;
- Стигма и конфиденциальность — визит к психиатру скрывается; работа на базе первичного звена или терапевта эффективна;
- Семейная система сильна: участие родственников в лечении — большой ресурс;
- Религиозные и культурные убеждения — следует учитывать, но не превращать в патологию;
- Ветераны Карабахской войны — ПТСР, К-ПТСР, высокая потребность в травма-ориентированном вмешательстве.

Скрининг должен быть стандартным в первичном звене здравоохранения

Перечисленные инструменты должны рутинно применяться в том же звене:

- PHQ-9 — депрессия (при каждом медицинском визите);
- GAD-7 — тревога;
- AUDIT — употребление алкоголя;
- EPDS — перинатальные женщины;
- C-SSRS — суицидальный риск.

Нужно перевести и валидировать инструменты на азербайджанском языке.

Оценка суицидального риска

Активный опрос на каждом психиатрическом приеме:

- Были ли в последнее время мысли о смерти или о том, чтобы покончить с собой?
- Конкретный план, средство?
- Предыдущие попытки?

Факторы риска:

- Предыдущие попытки (самый сильный предиктор);
- Наличие суицида в анамнезе семьи;
- Насколько план близок и насколько конкретен;
- Доступность средств;
- Употребление вещества, депрессия, ПРЛ, психоз;
- Острый стрессор, утрата.

Интервенция:

- План безопасности;
- Снижение доступности средств;
- Тщательный мониторинг;
- Показания к госпитализации;
- Оценка по шкале C-SSRS.

Коморбидность — правило, а не исключение

При психических расстройствах коморбидность — норма:

- Депрессия + тревога — 60% коморбидность;
- ПТСР + депрессия — 50%+;
- Расстройство личности + депрессия/тревога/ПАВ — 80%+;
- Аутизм + СДВГ — 50%;
- Расстройство пищевого поведения + депрессия + травма — типичная триада.

План лечения должен охватывать все коморбидности — лечение основного расстройства в изоляции часто недостаточно.

Возраст и стадия развития обязательно должны учитываться

- Психическое расстройство у ребёнка — родитель и контекст важны; лекарств мало, психотерапия и семейно-ориентированный подход важнее;
- Подросток — развитие идентичности, раннее вмешательство критично;
- Взрослые — работа, семья, социальное функционирование;
- Пожилые — коморбидные соматические заболевания, полипрагмазия, когнитивные нарушения; деменция vs депрессия — особое внимание.

Мультидисциплинарная команда – основа эффективной клинической работы

В сложных случаях:

- Психиатр;
- Психолог / психотерапевт;
- Социальный работник;
- Врач-терапевт (коморбидности);
- Члены семьи (с согласия);
- Лица в школе / на работе (у ребёнка).

Развитие этой структуры в Азербайджане — стратегический приоритет.

Этические и правовые рамки

Каждый клиницист должен знать:

- Конфиденциальность и её границы (опасность для других, защита детей);
- Информированное согласие;
- Правовая основа принудительной госпитализации;
- Уведомление о жестоком обращении с ребёнком/пожилым;
- Основы судебно-психиатрической оценки;
- Важность документирования.

Внимание к своему здоровью

Психиатрическая работа — это профессия с высокой эмоциональной нагрузкой. Выгорание (burnout), вторичная травма, эмпатическая усталость — реальные риски для клинициста.

- Супервизия и коллегиальная консультация;
- Личная психотерапия;
- Здоровый образ жизни;
- Осознание предела – вы не можете спасти всех пациентов.

Стойкое обучение и развитие.

МКБ-11 останется стабильной на десятилетия, но:

- Стандарты лечения обновляются каждые 3–5 лет;
- Появляются новые лекарства, новые психотерапевтические протоколы;
- Регулярное отслеживание правил таких организаций, как AACAP, APA, NICE, WFSBP, ISTSS;
- Рецензируемые журналы: Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry, American Journal of Psychiatry, World Psychiatry.

Цель книги: Улучшить качество психиатрической помощи в Азербайджане, в помощь пациентам и их семьям, в профессиональное развитие. Если читатель извлек пользу из этой книги, цель будет считаться достигнутой.

Желаю вам здорового лечения, профессионального роста и пользы для ваших пациентов.

Кянан Рагимов

Баку, 2026